

Zusammenfassende Dokumentation

über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie:
§ 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten
biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken

Vom 4. Dezember 2025

Inhalt

A.	Tragende Gründe und Beschluss	2
B.	Bewertungsverfahren	3
1.	Bewertungsgrundlagen	3
2.	Bewertungsentscheidung	3
C.	Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens	4
1.	Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens.....	6
1.1	Schriftliches Stellungnahmeverfahren	6
1.2	Mündliche Anhörung.....	6
2.	Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen.....	7
2.1	Übersicht der eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen	7
2.2	Übersicht der Anmeldung zur mündlichen Anhörung	9
3.	Auswertung der Stellungnahmen.....	18
3.1	Einwände zum Absatz 1.....	18
3.2	Einwände zum Absatz 2.....	89
3.3	Einwände zum Absatz 3.....	97
3.4	Einwände zum Absatz 4.....	123
3.5	Einwände zum Absatz 5.....	144
3.6	Weitere Einwände	149
3.7	Stellungnahmen nicht stellungnahmeberechtigter Organisationen.....	237
4.	Wortprotokoll der mündlichen Anhörung	238
D.	Anhang der Zusammenfassenden Dokumentation	260

A. Tragende Gründe und Beschluss

werden ergänzt!

B. Bewertungsverfahren

1. Bewertungsgrundlagen

Nach dem am 15. August 2019 in Kraft getretenen Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) gibt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) gemäß § 129 Absatz 1a Satz 3 SGB V in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 für die ärztliche Verordnung Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit. In einem weiteren Schritt gibt der G-BA gemäß § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 ebenfalls Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken.

Mit dem am 12. November 2022 in Kraft getretenen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) wurde der Regelungsauftrag an den G-BA gemäß § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V durch Einfügen eines Satzes 6 konkretisiert. Demnach sollte der G-BA zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben, danach auch für die weiteren biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel.

Zur Umsetzung des Regelungsauftrags erhält der G-BA nach § 129 Absatz 1a Satz 7 SGB V auf Verlangen Einsicht in die Zulassungsunterlagen bei der zuständigen Bundesoberbehörde.

2. Bewertungsentscheidung

Der Unterausschuss Arzneimittel hat mit Beschluss vom 11. Juni 2025 das Stellungnahmeverfahren zur Änderung der AM-RL eingeleitet. Gegenstand war die Ergänzung eines § 40c in Abschnitt M der AM-RL zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags in § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V, wonach der G-BA Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken geben soll.

Mit § 40c werden die Vorgaben zur Ersetzung durch ein im Wesentlichen gleiches Fertigarzneimittel durch Apotheken gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Sätze 2 bis 7 und Absatz 1a Satz 5 SGB V für die Gruppe der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel konkretisiert.

C. Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens

Gemäß § 92 Absatz 3a SGB V ist den Sachverständigen der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis sowie den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer, den betroffenen pharmazeutischen Unternehmern, den Berufsvertretungen der Apotheker und den maßgeblichen Dachverbänden der Ärztesellschaften der besonderen Therapierichtungen auf Bundesebene Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Der maßgeblichen Spitzenorganisation der Medizinprodukte-Hersteller wird beschränkt auf Richtlinienänderungen bezogen auf sonstige in die Arzneimittelversorgung einbezogene Leistungen nach § 31 SGB V Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Folgende Organisationen wurden angeschrieben:

Organisation	Straße	Ort
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI)	Friedrichstr. 148	10117 Berlin
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (vfa)	Hausvogteiplatz 13	10117 Berlin
Bundesverband der Arzneimittel-Importeure e. V. (BAI)	EurimPark 8	83416 Saaldorf-Surheim
Pharma Deutschland e. V.	Friedrichstr. 134	10117 Berlin
Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland e. V. (BIO Deutschland e. V.)	Am Weidendamm 1a	10117 Berlin
Die Arzneimittel-Importeure e. V.	Im Holzhau 8	66663 Merzig
Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed)	Reinhardtstraße 29b	10117 Berlin
Pro Generika e. V.	Unter den Linden 32 - 34	10117 Berlin
Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft (AkdÄ)	Herbert-Lewin-Platz 1	10623 Berlin
Arzneimittelkommission der Deutschen Zahnärzteschaft (AK-Z) c/o Bundeszahnärztekammer	Chausseestr. 13	10115 Berlin
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA)	Heidestr. 7	10557 Berlin
Deutscher Zentralverein Homöopathischer Ärzte e. V.	Axel-Springer-Str. 54b	10117 Berlin
Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte e. V.	Herzog-Heinrich-Str. 18	80336 München
Gesellschaft für Phytotherapie e. V.	Postfach 10 08 88	18055 Rostock

Die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens wurde auf den Internetseiten des G-BA unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/7255/> veröffentlicht.

(siehe D. Anhang der Zusammenfassenden Dokumentation)

1. Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens

1.1 Schriftliches Stellungnahmeverfahren

(siehe D. Anhang der Zusammenfassenden Dokumentation)

1.2 Mündliche Anhörung

Mit Datum vom 10. Oktober 2025 wurden die pharmazeutischen Unternehmer/ Organisationen, die berechtigt sind, zu einem Beschluss des G-BA Stellung zu nehmen und eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben, zu der mündlichen Anhörung eingeladen.

(siehe D. Anhang der Zusammenfassenden Dokumentation)

2. Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen

2.1 Übersicht der eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen

Organisation	Eingangsdatum
AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG	11.07.2025
Alexion Pharma Germany GmbH	14.07.2025
Amgen GmbH	11.07.2025
Bayer Vital GmbH	14.07.2025
Biocon Biologics Germany GmbH	14.07.2025
Biogen GmbH	11.07.2025
Celltrion Healthcare Deutschland GmbH	14.07.2025
Formycon AG	11.07.2025
Fresenius Kabi Deutschland GmbH	14.07.2025
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG	14.07.2025
Hexal AG	14.07.2025
Lilly Deutschland GmbH	10.07.2025
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.	11.07.2025
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	14.07.2025
Merck Healthcare Germany GmbH	14.07.2025
MSD Sharp & Dohme GmbH	09.07.2025
Novartis Pharma GmbH	14.07.2025
Novo Nordisk Pharma GmbH	14.07.2025
Pfizer Pharma GmbH	15.07.2025
ratiopharm GmbH	10.07.2025
Roche Pharma AG	11.07.2025
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	14.07.2025
STADAPHARM GmbH	14.07.2025
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA), Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK)	07.07.2025
Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e. V. (ADKA)	14.07.2025
Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen e. V. (BDOC)	09.07.2025

Organisation	Eingangsdatum
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI)	12.07.2025
Pharma Deutschland e. V.	14.07.2025
Pro Generika e. V.	14.07.2025
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (vfa)	14.07.2025
Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker e. V. (VZA)	14.07.2025
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ)	14.07.2025
Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG), gemeinsam mit - Hautnetz Deutschland e. V. - Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD)	15.07.2025
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e. V. (DGRh)	10.07.2025
Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen (DGVS), gemeinsam mit - Kompetenznetz Darmerkrankungen e. V. - Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands (bng)	13.07.2025, 14.07.2025
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ)	14.07.2025
Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR)	14.07.2025
Krankheitsbezogenes Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKNMS)	30.06.2025
Psoriasis-Praxisnetz Süd-West e. V.	10.07.2025

2.2 Übersicht der Anmeldung zur mündlichen Anhörung

Organisation	Teilnehmer
AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG	Stefan Rath Wilma Erhardt
Alexion Pharma Germany GmbH	Dr. Helena Salmen Sibylle Aurig-Schramm
Amgen GmbH	Hatice Camdere Andrea Friederich
Bayer Vital GmbH	Bastian Roskamp Laura Mauss
Biocon Biologics Germany GmbH	Karl-Thilo Ganz Thomas Koch
Biogen GmbH	Walter Röhrer Katharina Weiß
Celltrion Healthcare Deutschland GmbH	Thomas Berthold Claudia Woitschell
Formycon AG	Dr. Brigitte Freudensprung Dr. Andreas Seidl
Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Helmut D. Kogler Dr. Carsten Schmidt-Rimpler
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG	Dr. Florian Matthias Karl Juliane Seidel
Hexal AG	Dr. Christopher Kirsch Dr. Markus Müller
Lilly Deutschland GmbH	Cornelia Baudisch Lisa Pfarr
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.	Volker Bahr
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	Maike Kahl Dr. Dr. Richard Ammer
Merck Healthcare Germany GmbH	Susanne Kirst Nicole Giesl
MSD Sharp & Dohme GmbH	Luise Kadow Edith Frénoy
Novartis Pharma GmbH	Mathias Stark Fabian Liegmann
Novo Nordisk Pharma GmbH	Dr. Yasmin Kretzschmar Dr. Stefanie Meckes-Ferber

Organisation	Teilnehmer
Pfizer Pharma GmbH	Julia Christina Schubert Julia Wörner
ratiopharm GmbH	Alexander Brosch Mareike Radke
Roche Pharma AG	Dr. Anne-Eve Roske
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Steffen Gebhardt Dr. Klaus Bornholdt
STADAPHARM GmbH	Dominic Fister Ruben Numrich
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA), Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK)	Dr. André Said
Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e.V. (ADKA)	Max Kretzschmar Christopher Jürgens
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI)	Christine Lietz
Pharma Deutschland e.V.	Petra ten Haaf
Pro Generika e.V.	Bork Bretthauer Frank Wittkemper
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)	Eike Melchior
Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker e.V. (VZA)	Oliver Feth Christiane Müller
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ)	Prof. Bernd Mühlbauer
Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) Hautnetz Deutschland e.V.	Prof. Matthias Augustin Dr. Ralph von Kiedrowski
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e.V. (DGRh)	Prof. Christoph Fiehn
Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen (DGVS) Kompetenznetz Darmerkrankungen e.V.	Prof. Britta Siegmund
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ)	Prof. Anja Strangfeld
Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR)	Dr. Andreas Urban

Organisation	Teilnehmer
Krankheitsbezogenes Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKNMS)	Prof. Ralf Gold
Psoriasis-Praxisnetz Süd-West e.V.	Prof. Christian Termeer

2.2.1 Zusammenfassende Angaben der Offenlegungserklärungen

Organisation, Name	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6
AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG; Stefan Rath	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Wilma Erhardt	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Alexion Pharma Germany GmbH, Dr. Helena Salmen	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Alexion Pharma Germany GmbH, Sibylle Aurig-Schramm	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amgen GmbH, Hatice Camdere	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Amgen GmbH, Andrea Friederich	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Bayer Vital GmbH, Bastian Roskamp	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bayer Vital GmbH, Laura Mauss	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Biocon Biologics Germany GmbH, Karl-Thilo Ganz	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Biocon Biologics Germany GmbH, Thomas Koch	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Biogen GmbH, Walter Röhrer	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Biogen GmbH, Katharina Weiß	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja

Organisation, Name	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6
Celltrion Healthcare Deutschland GmbH, Thomas Berthold	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Celltrion Healthcare Deutschland GmbH, Claudia Woitschell	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Formycon AG, Dr. Brigitte Freudensprung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Formycon AG, Dr. Andreas Seidl	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Helmut D. Kogler	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Dr. Carsten Schmidt- Rimpler	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Dr. Florian Matthias Karl	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Juliane Seidel	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Hexal AG, Dr. Christopher Kirsch	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Hexal AG, Dr. Markus Müller	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lilly Deutschland GmbH, Cornelia Baudisch	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Volker Bahr	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja

Organisation, Name	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Maike Kahl	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Dr. Dr. Richard Ammer	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Merck Healthcare Germany GmbH, Susanne Kirst	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Merck Healthcare Germany GmbH, Nicole Giesl	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSD Sharp & Dohme GmbH, Luise Kadow	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSD Sharp & Dohme GmbH, Edith Frénoy	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Novartis Pharma GmbH, Mathias Stark	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Novartis Pharma GmbH, Fabian Liegmann	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Novo Nordisk Pharma GmbH, Dr. Yasmin Kretzschmar	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Novo Nordisk Pharma GmbH, Dr. Stefanie Meckes- Ferber	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Pfizer Pharma GmbH, Julia Christina Schubert	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pfizer Pharma GmbH, Julia Wörner	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Organisation, Name	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6
ratiopharm GmbH, Alexander Brosch	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
ratiopharm GmbH, Mareike Radke	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Roche Pharma AG, Dr. Anne-Eve Roske	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Steffen Gebhardt	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Dr. Klaus Bornholdt	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
STADAPHARM GmbH, Dominic Fister	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
STADAPHARM GmbH, Ruben Numrich	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA), Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK), Dr. André Said	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V., Max Kretzschmar	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V., Christopher Jürgens	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein

Organisation, Name	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V., Christine Lietz	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pharma Deutschland e.V., Petra ten Haaf	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pro Generika e.V., Bork Bretthauer	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pro Generika e.V., Frank Wittkemper	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V., Eike Melchior	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker e.V., Oliver Feth	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker e.V., Christiane Müller	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) Hautnetz Deutschland e.V., Dr. Ralph von Kiedrowski	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e.V. (DGRh), Prof. Christoph Fiehn	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein

Organisation, Name	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6
Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankunge n (DGVS) Kompetenznetz Darmerkrankungen e.V., Prof. Britta Siegmund	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Deutsches Rheuma- Forschungszentrum Berlin (DRFZ), Prof. Anja Strangfeld	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR), Dr. Andreas Urban	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Krankheitsbezogenes Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKNMS), Prof. Ralf Gold	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Psoriasis-Praxisnetz Süd- West e.V., Prof. Christian Termeer	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein

3. Auswertung der Stellungnahmen

3.1 Einwände zum Absatz 1

3.1.1 Klarstellung zur „Preisgünstigkeit“

AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG (AbbVie)

Dem in diesem Abschnitt verwendeten Begriff „preisgünstig“ fehlt eine klare Definition bzw. der klarstellende Verweis auf § 40a Absatz 2 AM-RL, wonach als preisgünstige biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel vorrangig solche Arzneimittel gelten, für die eine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V mit Wirkung für die jeweilige Krankenkasse der oder des Versicherten besteht.

Daher sollte der erste Satz des Absatzes konsequenterweise wie folgt abgeändert werden: „Die Apotheken sind bei der Abgabe verordneter biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel an Versicherte zur Ersetzung durch ein preisgünstiges Arzneimittel verpflichtet. § 40a Absatz 2 gilt entsprechend.“

Novo Nordisk Pharma GmbH (Novo Nordisk)

Novo Nordisk merkt an dieser Stelle an, dass sich der Regelungsauftrag des G-BA allein auf die für die Austauschverpflichtung relevante Vorfrage, ob ein biotechnologisch hergestelltes Fertigarzneimittel gegen ein anderes Referenzarzneimittel auf Apothekenebene medizinisch-pharmazeutisch austauschbar ist, bezieht. Ob dagegen ein vom G-BA als austauschbar befundenes Arzneimittel tatsächlich durch die Apotheken auszutauschen ist und eine entsprechende Austauschpflicht besteht, richtet sich gemäß § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V allein nach den Vorschriften des § 129 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, Sätze 2 – 7 SGB V. Danach sind die Apotheken allein nach Maßgabe des Rahmenvertrags nach § 129 Absatz 2 SGB V zum Austausch verpflichtet. Die Entscheidungskompetenz über die medizinische und klinische Austauschbarkeit biologischer Arzneimittel liegt aus Sicht von Novo Nordisk allein bei den therapieverantwortlichen verordnenden Ärzt:innen. Auch in den Tragenden Gründen des Beschlussentwurfs schreibt der G-BA, dass es Sache der Rahmenvertragspartner nach § 129 Absatz 2 SGB V ist, Bestimmungen zur Auswahl eines preisgünstigen Arzneimittels zu regeln (Tragende Gründe, Seite 7). Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Vorgaben sieht Novo Nordisk die vom G-BA in § 40c (neu) AM-RL definierte Pflicht der Apotheken zur Ersetzung als kritisch. Dies liegt in der alleinigen Zuständigkeit der Rahmenvertragspartner nach § 129 Absatz 2 SGB V.

Der Begriff „preisgünstig“ ist aus Sicht von Novo Nordisk in Bezug auf die Arzneimittelabgabe in der Apotheke keine hinreichende Formulierung. Die Substitutionsverpflichtung der Apotheke bezieht sich auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit gemäß § 12 SGB V.

Der genannte Punkt zur Regelung der „Preisgünstigkeit“ ist sowohl zu Absatz 1 als auch zu Absatz 2 anzumerken.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (Sanofi)

Die gewählte Formulierung in §40c (1) bedarf einer Klarstellung, dass namentlich verordnete biotechnologisch hergestellte (Referenz)-Arzneimittel mit einem gültigen Rabattvertrag (gem. §§ 130a Abs. 8 bzw. 130c SGB V) von den Apotheken nicht verpflichtend substituiert werden müssen, da die Abgabefolge gem. Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V von der Apotheke frei gewählt werden kann.

Bewertung:

Der Begriff der „Preisgünstigkeit“ wird in § 129 SGB V durch den Gesetzgeber definiert sowie die Befugnis zur Bestimmung des Näheren gemäß § 129 Absatz 2 SGB V auf die Vertragspartner des Rahmenvertrages übertragen. Die Verweisnorm des § 129 Absatz 1

Satz 12 SGB V führt zur entsprechenden Anwendung der dort genannten Regelungen zur Preisgünstigkeit auch auf die Umstellung und den Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln. Die Übernahme dieser gesetzlichen Regelungen in Absatz 1 und Absatz 2 dient daher nur der Klarstellung, dass diese Regelungen neben den von Seiten des Gemeinsamen Bundesausschusses definierten Kriterien zur Austauschbarkeit von Biologika Berücksichtigung finden müssen. Siehe auch Bewertung zum Einwand 3.2.1.

3.1.2 Unzureichende Regelung zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen

Biocon Biologics Germany GmbH (Biocon)

Obwohl keine klinisch relevanten Unterschiede bezüglich Wirksamkeit, Sicherheitsprofil und Verträglichkeit zwischen dem Wirkstoff im Referenzprodukt einerseits und seinen Biosimilars andererseits zu finden sind, gibt es dennoch tiefgreifende Unterschiede zwischen den verschiedenen Darreichungsformen der Biosimilars und ihrer Referenzprodukte. Diese sind von Bedeutung für die Behandlungs- und Verwaltungsentscheidung des Arztes und müssen bei der Wahl des Präparats immer in Betracht gezogen werden. Dies betrifft vor allem die Applikationsform (Pen oder Spritze) in Bezug auf die Anwendung, Funktionsweise und Handhabung (z. B. bezüglich Form, Griffestigkeit, Auslöse- und Injektionsmechanismus etc.). Ob dem Patienten je nach Präparat ein 2-Schritt-Pen, ein 3-Schritt-Pen oder eine Fertigspritze zur Verfügung steht, kann beträchtlichen Einfluss auf die korrekte Handhabung und Therapieadhärenz haben. Letztere setzt eine genaue Kenntnis des jeweiligen Präparats und dessen fehlerfreie Anwendung voraus. Nicht hinreichende Informationen können die Therapieadhärenz negativ beeinflussen [1].

Ärzte haben gute Gründe, sich für eine Verschreibung von Pen oder Spritze zu entscheiden. Gerade Unterschiede in der Komplexität des Auslösemechanismus oder der Griffestigkeit sind für Patienten mit manuellen Einschränkungen von außerordentlicher Bedeutung [2]. Insbesondere dieser letztere Punkt kann einen wesentlichen Einfluss auf die Anwendbarkeit der Präparate haben.

Kommunikation und Schulung des Patienten und die damit verbundene genaue Kenntnis der Präparate ist Voraussetzung für jede Ein- und Umstellung und beeinflusst die Entscheidung, welches verfügbare Präparat eingesetzt werden kann. Bereits geringe Änderungen bei der Anwendung eines Arzneimittels können Konsequenzen für die Kontrolle der Erkrankung haben und können nur im Rahmen eines ärztlichen Gesprächs herausgearbeitet und für jeden Patienten individuell bewertet werden. Zahlreiche Fachgesellschaften weisen daher auf die Notwendigkeit und Bedeutung einer Aufklärung und klaren Kommunikation des Verschreibers mit seinen Patienten hin [3, 4, 5].

Auch sollte die Entscheidung zur Umstellung vom Referenzpräparat zu einem Biosimilar, oder von einem Biosimilar auf ein anderes Biosimilar, im Idealfall gemeinsam mit dem Patienten getroffen werden [6]. So sieht die gemeinsam von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), der Europäischen Kommission und dem Europäischen Patientenforum (EPF) erstellte Patienteninformation zu Biosimilars bei der Umstellung eine Informationspflicht und intensive

1 Salaffi F et al. (2020): Adherence to subcutaneous anti-TNFalpha agents in patients with rheumatoid arthritis is largely influenced by pain and skin sensations at the injection site. *Int J Rheum Dis*;23(4):480-7.

2 Meyer SE et al. (2022): Technische Alltagshilfen in der Rheumatologie – Was ist sinnvoll, was ist bewiesen, welche Perspektiven gibt es? *Aktuelle Rheumatologie*;47(01):33-42.

3 Danese S et al. (2017): ECCO Position Statement on the Use of Biosimilars for Inflammatory Bowel Disease - An Update. *J Crohns Colitis*;11(1):26-34.

4 British Association of Dermatologists (2017): Position Statement on Biosimilars.

5 Medicines for Europe (2020): Positioning statements on physician-led switching for biosimilars medicines. <https://www.medicinesforeurope.com/docs/M-Biosimilars-Overview-of-positions-on-physician-led-switching.pdf>

6 Kay J et al. (2018): Consensus-based recommendations for the use of biosimilars to treat rheumatological diseases. *Ann Rheum Dis*;77(2):165-74.

Einbindung der Patienten vor [7].

Eine korrekt durchgeführte Substitution der Präparate ohne jedwede Einschränkung der Darreichungsform wäre mit einem enorm erhöhten Informations- und Beratungsaufwand in den Apotheken verbunden, den auch die Apotheken ohne vorausgehende intensive Befassung mit den unterschiedlichen Applikationssystemen nicht leisten können. Wenn die Substitution außerdem zu einer erneuten Verordnung mit Setzen des aut-idem-Kreuzes führen würde, gerade weil der Patient mit der Umstellung nicht zurechtkommt, wäre dies außerdem mit unnötigen zusätzlichen Kosten (nicht verwendbares Arzneimittel; weiterer Arztbesuch) verbunden.

Biogen GmbH (Biogen)

Auch Unterschiede in den Injektionshilfen (Devices) müssen berücksichtigt werden. Die Präferenzen für die Art des Injektionssystems, z. B. Fertigspritzen oder Autoinjektoren/Pens, variieren von Patient zu Patient. Für Menschen mit Nadelangst ist ein Autoinjektor hilfreich, da die Nadel dabei nicht sichtbar ist [8, 9]. Ein möglicher Austausch zwischen diesen Injektionssystemen ist noch nicht bewertet, jedoch aus unserer Sicht dringend nicht zu empfehlen. Der G-BA wird hier aufgefordert zeitnah verbindliche Hinweise zur Austauschbarkeit von Injektionssystemen in Anlage VII AM-RL zu formulieren.

Tatsächlich können Geräteeigenschaften bei der Selbstinjektion von Biologika/Biosimilars ein Unterscheidungsmerkmal darstellen, das über den erwarteten Vorteil geringerer Kosten und besserer Verfügbarkeit hinausgeht. Dies kann zusätzliches Vertrauen bei Ärzten und Patienten schaffen, insbesondere beim Wechsel von einem Produkt zum anderen [9]. In diesem Zusammenhang gelten einfache Handhabung, Geräteeigenschaften, Sicherheit und Rückmeldemechanismen als wichtige Faktoren für die Patientenzufriedenheit. Eine höhere Zufriedenheit kann wiederum die Therapietreue sowie Persistenz verbessern und letztlich zu besseren Behandlungsergebnissen führen. Langfristig gut eingestellte Patienten mit niedriger Krankheitslast tragen wesentlich dazu bei, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken.

Diese Aspekte sind auch in Ländern relevant, in denen eine automatische Substitution geprüft oder erlaubt ist – etwa in Schweden oder Finnland. Dort bewertet die finnische Arzneimittelbehörde, ob produktspezifische Eigenschaften, besonders gerätebezogene Merkmale, einen automatischen Wechsel erschweren oder ein Risiko für die Patientensicherheit darstellen könnten, insbesondere bei mehreren Wechseln in kurzer Zeit [8, 10].

7 Europäische Kommission (EC) (2016): Was ich wissen sollte zu Biosimilars. Informationen für Patienten – Konsensusinformationsdokument.

8 Swedish Medicines Agency (2024): „Analyze switch and, by extension, interchangeability of biological drugs in pharmacies - Final report.“

9 Allocati E et al. (2022): Switching Among Biosimilars: A Review of Clinical Evidence. Front Pharmacol;13:917814.

10 Lyles CA et al. (2025): Current trends in biosimilar uptake and special focus on automatic substitution – a symposium report.

[...] Diese Faktoren unterscheiden sich zwischen den verschiedenen auf dem Markt befindlichen Etanercept- und Adalimumab-Produkten [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Abbildung 1 bis Abbildung 3].

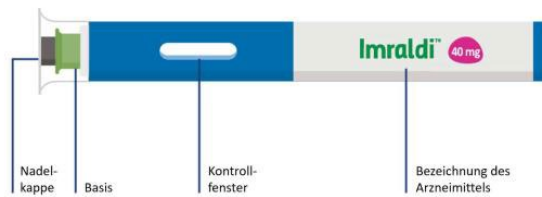


Abbildung 1: Imraldi® Fertigpen [11]

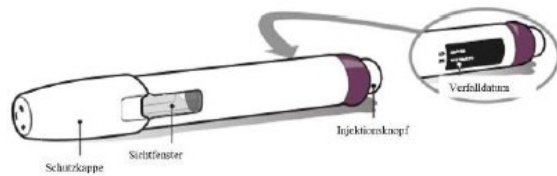


Abbildung 2: Amsparity® Fertigpen [12]

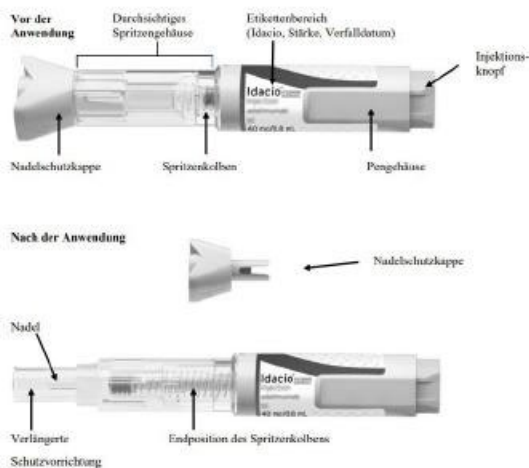


Abbildung 3: Idacio® Fertigpen [21]

Celltrion Healthcare Deutschland GmbH (Celltrion)

Neben der Übereinstimmung sämtlicher Anwendungsgebiete ist auch die Applikationsform ausschlaggebend für den Behandlungserfolg eines Patienten. In der Regel werden die Patienten bei Neueinstellung auf ein Präparat durch ärztliches Fachpersonal in der Anwendung des Applikationssystems geschult. Dabei wird auf die Besonderheiten des jeweiligen Systems eingegangen. Bei der Auswahl dessen kann der Arzt patientenindividuelle Kriterien nutzen, um das beste System auszuwählen. Denn neben der Nadellänge spielen auch Merkmale wie das Injektionsvolumen, die Injektionsgeschwindigkeit, aber auch Formulierungseigenschaften eine bedeutende Rolle [24].

Erfolgt im Rahmen der Abgabe des Arzneimittels in der Apotheke eine Substitution muss zwingend auch eine Schulung des Patienten auf dieses System erfolgen. Eine falsche

11 Imraldi: EPAR – Product information.

12 Amsparity: EPAR – Product information.

13 Amgevita: EPAR – Product information.

14 Benepali: EPAR – Product information.

15 Enbrel: EPAR – Product information.

16 Erelzi: EPAR – Product information.

17 Hukyndra: EPAR – Product information.

18 Hulio: EPAR – Product information.

19 Humira: EPAR – Product information.

20 Hyrimoz: EPAR – Product information.

21 Idacio: EPAR – Product information.

22 Nepexto: EPAR – Product information.

23 Yuflyma: EPAR – Product information.

24 Usach I et al. (2019): Subcutaneous Injection of Drugs: Literature Review of Factors Influencing Pain Sensation at the Injection Site. *Advances in Therapy*;36(11):2986-96.

Anwendung oder Unkenntnis beispielsweise über den Auslösmechanismus (selbstausschützend durch Druck auf die Haut oder auslösend durch Drehen oder Drücken eines Knopfes) kann Unsicherheiten oder gar Anwendungsfehler hervorrufen, die die Compliance des Patienten verringern.

Obwohl aktuell eine Ausweitung der automatischen Substitution auf Biosimilars vorbereitet wird, hat der G-BA bislang keine Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen gemäß § 129 Abs. 1a SGB V erlassen. Dabei verpflichtet der Gesetzgeber den G-BA ausdrücklich zur unverzüglichen Erstellung solcher Hinweise – also rechtlich gesehen zum Handeln ohne schuldhaftes Zögern, sobald ein entsprechender Regelungsbedarf besteht.

Ein solcher Bedarf liegt hier zweifelsfrei vor, da die vorgesehene Biosimilar-Substitution zwangsläufig Konstellationen mit unterschiedlichen Applikationssystemen betrifft, etwa Fertigpen und Fertigspritze, deren therapeutische Vergleichbarkeit zu bewerten ist. Beide Darreichungsformen enthalten typischerweise eine Injektionslösung (engl. solution for injection – ILO) und gehören damit zur gleichen EDQM-Grundform. Dennoch werden sie in der EDQM-Systematik als unterschiedliche Combined Terms geführt, da das Applikationssystem (Spritze vs. Pen) als unterscheidendes Merkmal gewertet wird. Diese Differenzierung ist in der praktischen Arzneimittelversorgung schwer handhabbar, da Apotheker ohne verbindliche Hinweise eigenständig beurteilen müssen, ob eine Austauschbarkeit vorliegt.

Die bestehende Fassung der Anlage VIIa bietet hierfür keine ausreichende Grundlage. In diesem Fall ist die Pflicht zur zeitnahen Erstellung entsprechender Hinweise nicht optional, sondern integraler Bestandteil der gesetzlichen Substitutionsregelung. Das bisherige Ausbleiben einer Reaktion durch den G-BA steht daher im Widerspruch zur klaren gesetzlichen Handlungsaufforderung nach § 129 Abs. 1a SGB V.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH (Fresenius Kabi)

Im Rahmen der geplanten Einführung der automatischen Substitution von Biosimilars fehlt bislang ein zentraler Aspekt: Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat noch keine Hinweise zur Austauschbarkeit unterschiedlicher Darreichungsformen veröffentlicht, obwohl der Gesetzgeber ihn gemäß § 129 Abs. 1a SGB V ausdrücklich dazu verpflichtet.

Gerade im Hinblick auf die Sicherheit der Patienten ist dieses Versäumnis problematisch. Die automatische Substitution betreffe häufig Präparate mit unterschiedlichen Applikationssystemen, etwa Fertigspritzen und Fertigpens. Diese Systeme unterscheiden sich in der Anwendung deutlich. Insbesondere für ältere, chronisch kranke und motorisch eingeschränkte Menschen kann dies eine große Herausforderung bedeuten und es besteht die Gefahr, dass Patienten mit einem neuen Applikationssystem konfrontiert werden, das sie nicht sicher anwenden können. Dies kann zu Anwendungsfehlern, Therapieabbrüchen oder einer verringerten Therapietreue führen.

Ohne klare Vorgaben des G-BA stehen Apotheken vor einem Dilemma: Sie müssen selbst entscheiden, ob ein Austausch zulässig und vertretbar ist – und tragen dabei die Verantwortung. Die aktuelle Rechtslage bietet dafür keine verlässliche Grundlage. Um die Sicherheit der Versorgung zu gewährleisten, braucht es daher dringend verbindliche Hinweise des G-BA. Diese sind kein optionales Instrument, sondern eine gesetzlich vorgeschriebene Voraussetzung der Substitutionsregelung. Das bisherige Ausbleiben entsprechender Vorgaben widerspricht dem klar formulierten gesetzlichen Auftrag – und gefährdet letztlich die Sicherheit der Patienten.

Hexal AG/Sandoz Deutschland (Hexal)

Der automatische Austausch biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel in der Apotheke soll unter anderem nur möglich sein, wenn die Darreichungsform des abgegebenen Arzneimittels entweder gleich oder austauschbar gemäß § 40 Abs. 1 AM-RL in Verbindung mit § 129 Abs. 1a Satz 1 SGB V zum verordneten Arzneimittel ist.

Eine Darreichungsform gilt gemäß § 9 Abs. 3 des aktuell geltenden Rahmenvertrags nach § 129 Abs. 2 SGB V als **gleich**, wenn sie mit identischer Bezeichnung in den Preis- und Produktinformationen gemeldet ist (IFA-Kürzel). Zusätzlich sind die in Anlage 1 des Rahmenvertrags genannten wirkstoffidentischen biotechnologisch hergestellten Arzneimittel (Bioidenticals) mit gleicher Darreichungsform laut Punkt 3 der Fachinformation unabhängig von der im Preis- und Produktverzeichnis gemeldeten Darreichungsform miteinander austauschbar.

Austauschbare Darreichungsformen für Arzneimittel zur Injektion/Infusion werden in der Anlage VII Teil A Tabelle 2 der AM-RL definiert, auf die der Gesetzgeber als auch der G-BA selbst an dieser Stelle in seiner Beschlussfassung verweist. Aktuell enthält die Anlage VII Teil A keinerlei biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel.

Bei einem Start der automatischen Substitution mit den im Beschlussentwurf zum § 40c AM-RL vorgegebenen Kriterien würden in der aktuellen Marktsituation Produktgruppen und Darreichungsformen als miteinander austauschbar definiert werden, die unter keinen Umständen einer automatischen Substitution unterliegen sollten, wie z.B. eine Fertigspritze und ein Fertigpen. Zugleich wären Produkte mit potenziell vergleichbaren Darreichungsformen ohne Listung in der Anlage VII Teil A Tabelle 2 aufgrund unterschiedlicher IFA-Kürzel nicht miteinander austauschbar. Drittens fehlt eine Regelung für den Umgang mit Bioidenticals, da diese aktuell unabhängig vom IFA-Kürzel austauschbar sind, solange die Darreichungsform laut Punkt 3 der Fachinformation gleich ist.

Bei **Ustekinumab** sind gemäß Lauer-Taxe beispielsweise für die 90 mg Wirkstärke die Darreichungsformen **Injektionslösung in einer Fertigspritze** und **Injektionslösung in einem Fertigpen** im Markt verfügbar:

Tabelle 1: Übersicht Präparate Ustekinumab 90 mg N1; exkl. PIPs, Stand 01.07.2025

Pharmazeutisches Unternehmen	Produktname	IFA-Kürzel
Accord Healthcare GmbH	IMULDOSA 90 mg Inj.-Lsg.i.e.Fertigspritze	ILO
Amgen GmbH	WEZENLA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen	PEN
Amgen GmbH	WEZENLA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze	ILO
Biocon Biologics Germany GmbH	YESINTEK 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr.	ILO
Celltrion Healthcare Deutschland GmbH	STEQEYMA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr.	ILO
Fresenius Kabi Deutschland GmbH	OTULFI 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze	ILO
Hexal AG	PYZCHIVA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen	ILO
Hexal AG	PYZCHIVA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze	ILO
JANSSEN-CILAG GmbH	STELARA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr.	ILO
JANSSEN-CILAG GmbH	STELARA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen	ILO
ratiopharm GmbH	FYMSKINA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspritze	ILO
STADAPHARM GmbH	UZPRUVO 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigspr.	ILO

Ausgehend vom IFA-Kürzel wären PYZCHIVA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen und STELARA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen mit den anderen Präparaten in Form einer Fertigspritze fälschlicherweise austauschbar. Das Präparat WEZENLA 90 mg Injektionslösung i.e.Fertigpen allerdings hätte keine Austauschbarkeit zu den beiden anderen Präparaten in Form eines Fertigpens.

Zu erwähnen ist weiterhin, dass sowohl die sogenannten „Standard Terms“ des EDQM als auch die von der IFA für die Bezeichnung in den Preis- und Produktinformationen zur Verfügung gestellten Darreichungsformen-Kürzel über die Zeit einer Veränderlichkeit unterliegen, so dass allein schon deswegen zu bestimmten Betrachtungszeiträumen allein aus den Meldedaten aus

der Lauer-Taxe keine Rückschlüsse auf eine sachgerechte Austauschbarkeit von Darreichungsformen gezogen werden können.

Die therapeutische Vergleichbarkeit ist insbesondere nicht gegeben, wenn aufgrund z.B. desselben IFA-Kürzels „ILO“ in der Apotheke eine Fertigspritze mit einem Pen ausgetauscht wird, da ein solcher Wechsel in höchstem Maße therapierelevant sein kann. So kann ein Patient aufgrund z.B. einer fehlenden Beweglichkeit im Daumen bei einer rheumatischen Erkrankung schlichtweg nicht in der Lage sein, eine Fertigspritze zu applizieren. Der Arzt hat in diesem Fall auch keinerlei Kenntnis von einem entsprechenden Wechsel der Darreichungsform in der Apotheke. Bei Therapieversagen können dabei auch haftungsrechtliche Implikationen entstehen, die mit Blick auf eine notwendige Rechtssicherheit in der Umsetzung des Beschlusses ungeklärt bleiben. Eine solche Regelungunklarheit bei derart therapiemaßgeblichen Fragestellungen darf durch den vorliegenden G-BA Beschluss nicht billigend in Kauf genommen werden.

Im aktuellen Beschlussentwurf fehlt daher eine eindeutige und trennscharfe Regelung zur Austauschbarkeit der einzelnen Produkte im Hinblick auf die Darreichungsform. Der generelle Verweis auf die Anlage VIIa ist völlig unzureichend, um eine klare Regelung zur Austauschbarkeit zu schaffen, da diese Anlage nur auf die maßgeblichen Zulassungszusammenhänge referenziert. Vielmehr braucht es gemäß gesetzlichem Auftrag eine **wirkstoffbezogene Listung austauschbarer Darreichungsformen in der Anlage VII Teil A Tabelle 2 als Voraussetzung** dafür, dass biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel dem Regelungsbereich der automatischen Substitution in der Apotheke rechts- und therapiesicher unterworfen werden können. Insofern muss an dieser Stelle auch die gemeldete Bezeichnung der Darreichungsform in den Preis- und Produktinformationen als pauschales Differenzierungsmerkmal für die „gleiche“ Darreichungsform zurückgenommen werden. Vielmehr muss die Bestimmung einer „gleichen oder austauschbaren“ Darreichungsform allein über eine Regelung in der Anlage VII Teil A Tabelle 2 unter Berücksichtigung der „Combined Terms“ erfolgen.

Der besonderen Bedeutung dieser „Combined Terms“ trägt der G-BA für parenterale Arzneimittel auch an anderer Stelle explizit Rechnung. Verwiesen wird hier u.a. auch auf ein Stellungnahmeverfahren aus dem Jahr 2022 [zur Änderung der AM-RL: Austauschbarkeit von parenteral anzuwendenden Arzneimitteln]. Auch bei parenteralen Biologika liegt gemäß Abschnitt 3 der Fachinformation und der zugrundeliegenden „Standard Terms“ des EDQM regelhaft ein sogenannter „Combined Term“ als Darreichungsform vor. Sofern sich diese „Combined Terms“ in der Fachinformation oder bzgl. der gemeldeten Bezeichnung in den Verzeichnisdiensten unterscheiden, bedarf es seitens des G-BA einer Prüfung, ob in geplanten Austauschgruppen von Arzneimitteln Unterschiede in den pharmakokinetischen Eigenschaften für die Therapie bedeutsam sind.

Eingangs wurde bereits vermerkt, dass der Austausch von biologischen Fertigarzneimitteln unter Berücksichtigung der **therapeutischen Vergleichbarkeit** geregelt werden muss. Diesem Anspruch kann nur gerecht werden, wenn durch den G-BA eine entsprechende Klarstellung in den Anlagen VII bzw. VIIa für die gegenständlichen Arzneimittel und auch zukünftigen Biosimilars im Sinne einer **wirkstoff- und produktspezifischen Positivliste** erfolgt, bevor der jeweilige Wirkstoff in der Apotheke anhand der beschlussgegenständlichen aut idem Kriterien substituierbar wird. Gemäß 4. Kapitel § 50 Absatz 2 Verfo sind die Anknüpfungspunkte für die Bewertung der therapeutischen Vergleichbarkeit von austauschbaren Darreichungsformen der gleiche Applikationsort, der gleiche Applikationsweg, die gleiche Anwendungsform und die gleiche Applikationshäufigkeit, wobei ergänzend zwischen Darreichungsformen in Einzeldosis- oder Mehrfachdosisbehältnissen unterschieden wird. Über die Bewertung zur Listung in die Anlage VII kann und muss produktspezifischen Besonderheiten von im Markt befindlichen Arzneimitteln individuell Rechnung getragen werden, um einen sicheren und therapeutisch vergleichbaren Austausch zu ermöglichen.

[...] Die korrekte Anwendung des jeweiligen Applikationssystems – neben der Erklärung, warum der Patient ein anderes Produkt erhält – nimmt einen wesentlichen Part bei der Vermeidung von Nocebo-Effekten und zur Wahrung der Patienten- und Therapiesicherheit ein. Daher ist der behandelnde Arzt bzw. ärztliches Hilfspersonal gemäß § 40a AM-RL dazu verpflichtet, eine Einweisung und Schulung zur Handhabung des verordneten Arzneimittels durchzuführen. Die Schulung wird bedeutungslos, wenn in der Apotheke ein potenziell austauschbares Arzneimittel abgegeben wird, dessen Handhabung wesentliche Unterschiede aufweist.

Eine Änderung im Applikationssystem infolge einer Substitution in der Apotheke birgt zum einen Risiken mit Blick auf die Patientensicherheit und -akzeptanz, sowie zum anderen Gefahren im Hinblick auf den therapeutischen Erfolg, der bedingt durch eine fehlerhafte Applikation und eine damit einhergehende inadäquate Wirkung des Arzneimittels deutlich verringert sein kann. Die Gefahr, dass es in der Apotheke trotz der Bestimmung des § 20 Abs. 2 Apothekenbetriebsordnung nicht zu einer eigentlich erforderlichen Beratung hinsichtlich der Anwendung eines für den Patienten neuen Devices (Applikationssystems) kommt, erscheint uns sehr real. Unter Umständen erkennt der Patient das Arzneimittel in der Apotheke gar nicht als neues, bisher noch nicht von ihm verwendetes Arzneimittel. Oder er geht nicht davon aus, dass er Probleme mit der Anwendung haben könne und lehnt ein entsprechendes Beratungsangebot ab. Zeitnot, mangelnde Vertraulichkeit – es lassen sich viele Gründe vorstellen, die einer eigentlich erforderlichen intensiven Anwendungsberatung in der Apotheke entgegenstehen. Des Weiteren lässt sich durchaus bezweifeln, dass eine Einweisung und Schulung des Patienten durch den Apotheker mit Blick auf die ärztlichen Aufklärungspflichten nach dem Patientenrechtegesetz überhaupt ausreichend sind. Das bezieht sich insbesondere auf die therapeutische Sicherungsaufklärung nach § 630c Abs. 2 BGB; diese muss durch den Arzt durchgeführt werden und kann nicht an den Apotheker delegiert werden. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die funktionellen Besonderheiten des Applikationssystems für einen schwer erkrankten, möglicherweise multimorbiden Patienten keine Trivialität darstellen und kein bloßes Komfortmerkmal sind. Ein unqualifizierter Austausch riskiert in besonderem Maße den Therapieerfolg, weil die starke Bindung an das vertraute Applikationssystem im Falle der Disruption in besonderem Maße einen Nocebo-Effekt triggern kann.

Die folgende Tabelle gibt einen nicht abschließenden, beispielhaften Überblick zu signifikanten Unterschieden in der Handhabung verschiedener Adalimumab-Fertigpens.

Tabelle 2: Anwendung 40mg Adalimumab im Fertigpen [21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]

Präparat	Farbe Injektionslösung	Kappe entfernen	2-Klick Injektionskontrolle Anfang und Ende Injektion	Startknopf
Amgevita®	klar und farblos bis leicht gelblich	gerade abziehen	Ja	Ja (Haut zusammendrücken)
Amsparity®	farblos bis sehr hellbraun	abdrehen	Ja	Ja
Hukyndra®	klar und farblos	gerade abziehen	Ja	Nein (Haut zusammendrücken)

25 AMGEVITA: Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand Mai 2024.

26 Amsparity: Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand Januar 2025.

27 Hukyndra: Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand November 2021.

28 Hulio: Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand November 2021.

29 Humira: Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand April 2021.

30 Hyrimoz: Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand Dezember 2024.

31 Imraldi: Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand März 2025.

32 Yuflyma: Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand 2024.

Präparat	Farbe Injektionslösung	Kappe entfernen	2-Klick Injektionskontrolle Anfang und Ende Injektion	Startknopf
Hulio®	klar und farblos	gerade abziehen	Ja	Ja (Haut zusammen-drücken)
Humira®	klar und farblos	gerade abziehen	Nein	Ja (Haut zusammen-drücken)
Hyrimoz®	klar und farblos bis leicht gelblich	abdrehen	Ja	Nein
Idacio®	klar und farblos	gerade abziehen (Warnung: kein abdrehen)	Nein	Ja
Imraldi®	klar und farblos bis blassbraun	gerade abziehen	Ja	Nein
Yuflyma®	klar und farblos bis schwach braun (gelb nicht mehr verwenden)	gerade abziehen	Ja	Nein

Novartis Pharma GmbH (Novartis)

Novartis sieht die Möglichkeit einer Abgabe eines Biosimilars mit einer unterschiedlichen Darreichungsform als das Original als kritisch an. Die zugelassenen Originale wurden auf die Bedürfnisse in der Handhabung der spezifischen Patientenpopulation hin entwickelt. Bei einem Wechsel hin zu einem Biosimilar mit einer anderen Darreichungsform kann die auf die spezifische Patientenpopulation abgestimmte Darreichungsform mitunter nicht mehr garantiert werden. Als Beispiel sind hier Patienten mit Psoriasis-Arthritis zu nennen, deren Finger gegebenenfalls von der Erkrankung betroffen sind und die möglicherweise Probleme bei der Handhabung einer anderen Darreichungsform haben.

Ferner kann es gerade bei besonders vulnerablen Patientenkollektiven mit hoher Sensitivität gegenüber allergenen Reizen auch zu schweren anaphylaktischen Ereignissen kommen, sollte nicht das gewohnte Device verwendet werden (Beispiel: Zusammensetzung des Gummi-Nadelstopfens).

[...] Gerade bei immer wiederkehrenden Umstellungen sieht Novartis ein hohes Verwechslungsrisiko, wie am Beispiel von Xolair® zu sehen ist: Die Applikatoren von Xolair® 75 mg und Omlyclo® 150 mg (in Blau) sind visuell sehr ähnlich ([33, 34]; Abbildung 4). Dies kann potenziell zu gefährlichen Verwechslungen mit Folge einer möglichen Überdosierung führen.

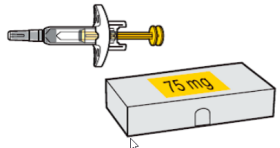
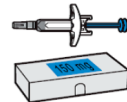
Xolair®	Omlyclo®
Dosis Für die Dosis benötigte Spritzen 75 mg 1 blau (75 mg)  150 mg 1 lila (150 mg) 	Diese Dosisstärke: 75 mg/0,5 ml (gelber Spritzenkolben)  Andere Dosisstärke: 150 mg/1 ml (blauer Spritzenkolben) 

Abbildung 4: Vergleich der Applikatoren von Xolair® und Omlyclo® [33, 34]

33 Fachinformation Xolair. Stand Mai 2025.

34 Fachinformation Omlyclo. Stand April 2025.

[...] Erfolgte bisher eine Umstellung auf ein Arzneimittel mit einer anderen Darreichungsform, war diese angeleitet durch den Arzt. Die Arztpraxis hat den Patienten oder seine Betreuungspersonen im Rahmen der Umstellung zum Beispiel in der korrekten Injektionstechnik geschult, um Vertrauen in die Applikationsart zu generieren und mögliche Anwendungsfehler zu vermeiden. Diese Schulung darf bei einer für Arzt und Patient plötzlich erfolgten Umstellung auf Grund wirtschaftlicher Aspekte in der Apotheke nicht wegfallen. Mögliche Risiken bestehen zum Beispiel bei einem automatischen Austausch in der Apotheke von Pen vs. Fertigspritze und umgekehrt. Aufgrund der Unterschiede in Handhabung oder Injektionstiefe kann ein Wechsel zu suboptimaler Wirkstoffzufuhr oder injektionsbedingten Nebenwirkungen führen. Dies kann einen erheblichen negativen Effekt auf die Akzeptanz der Therapie haben sowie zu Compliance-Problemen führen. Selbst bei einer Umstellung von Fertigspritze auf Fertigspritze kann es sich um unterschiedliche Devices handeln: Die Fertigspritzen von Xolair® und Omlyclo® sind nicht baugleich und bedürfen daher bei einem Wechsel einer Devicebezogenen Schulung der Injektionstechnik [33, 34]. Eine Veränderung in der Applikationsart ohne das spezifische Wissen über den Patienten kann auch bedeuten, dass ein Patient mit Nadelphobie plötzlich ein Device ausgehändigt bekommt, welches er sich selbst als Injektion geben muss. Das neue Arzneimittel kann zu Angstreaktionen führen, die eine (Selbst-)Injektion unmöglich machen. Nach Abgabe an den Patienten ist ein Umtausch in der Apotheke ausgeschlossen und in der Folge könnte eine Unterbrechung der Therapie und damit einhergehend eine Unterversorgung mit dem Wirkstoff drohen.

Novo Nordisk

Novo Nordisk sieht insbesondere im sensiblen Gebiet der Therapie mit biologischen Arzneimitteln, welche durch Patient:innen selbst angewendet bzw. injiziert werden, eine besondere Relevanz der Applikationshilfe und der Darreichungsform in Bezug auf die Arzneimitteltherapiesicherheit. Dies ist im vorliegenden Beschluss zu § 40c (neu) durch den G-BA vollkommen außer Acht gelassen. Bekannte Arzneimittel und die vertraute technische Handhabung des jeweiligen Arzneimittels sind für Patient:innen von besonderer Relevanz.

Ein Beispiel ist hier der Wirkstoff Insulin Aspart, welcher mit dem Originalprodukt NovoRapid® in unterschiedlichen Darreichungsformen und Applikationsformen zur Verfügung steht und gemäß Anlage VIIa AM-RL durch die bezugnehmenden Produkte Insulin Aspart Sanofi® und Kirsty® austauschbar sein soll [35, 36, 37]. Novo Nordisk sieht in diesem Austausch wesentliche mögliche Arzneimittelrisiken.

Einerseits passen beispielweise die zur Befüllung der wiederverwendbaren Pens geeigneten Patronen nur in den Pen des jeweiligen Herstellers. Würde es an dieser Stelle also zu einem automatischen Austausch der Patronen in der Apotheke kommen, nachdem die Patient:innen bereits den Pen des jeweils anderen Herstellers nutzen, kann das Insulin in der Patrone im schlimmsten Fall im erforderlichen Moment nicht verwendet werden. Auch bei Neu-Verordnung des benötigten Pens müssen mögliche Unterschiede in den Dosierungsschritten der Pens beachtet werden, die insbesondere für die Insulin-Therapie bei Kindern wichtig sind (nicht alle Injektionshilfen bieten die Möglichkeit halber Dosisschritte). Es sollte auch der kognitive Zustand älterer und multimorbider Patient:innen berücksichtigt werden, die häufig mit ihrer Arzneimitteltherapie auf sich allein gestellt sind und von einem wechselnden Aussehen der ihnen bekannten Arzneimittel überfordert sein können.

[...] Gemäß 4. Kapitel § 50 Absatz 2 Verfo liegen folgende Kriterien für eine therapeutische Vergleichbarkeit von austauschbaren Darreichungsformen vor: Gleicher Applikationsort, gleicher Applikationsweg, gleiche Anwendungsform, gleiche Applikationshäufigkeit. Insbesondere die gleiche Anwendungsform ist im Bereich der Biopharmazeutika, die durch den

35 Fachinformation Insulin aspart Sanofi. Stand Dezember 2022.

36 Fachinformation NovoRapid. Stand September 2020.

37 Fachinformation Kirsty. Stand November 2023.

Patient:innen selbst angewendet werden, als ausschlaggebend für den Therapieerfolg anzusehen.

Laut aktuell gültigem Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V in der Fassung vom 01.01.2025 sind gemäß § 9 Absatz 3 lt. d) Darreichungsformen gleich, wenn diese mit identischer Bezeichnung in den Verzeichnisdiensten nach § 2 Absatz 3 geführt sind und laut G-BA gemäß § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V austauschbar. An dieser Stelle verweist Novo Nordisk auf das vom G-BA eingestellte Verfahren zu „§ 40 Absatz 1a – Zur Austauschbarkeit von Arzneimitteln zur intravasalen Anwendung“. Laut Tragenden Gründen wurde der Combined Term, der die Darreichungsform mit Behältnisangabe in Abschnitt 1 der Fachinformation beschreibt, bei der Klassifizierung im Verzeichnisdienst als Basis zur Austauschbarkeit nicht berücksichtigt. Novo Nordisk sieht den Combined Term im Hinblick auf nicht durch ärztliches Personal zu applizierende Arzneimittel als grundlegendes weiteres Kriterium für eine Austauschbarkeit eines solchen Fertigarzneimittels an.

Der Bewertung des G-BAs der Stellungnahmen bezüglich der fehlenden Berücksichtigung von Produkteigenschaften im Verfahren zu § 40b (alt) ist zu entnehmen, dass der G-BA „vor dem Hintergrund, dass parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln im Regelfall nicht direkt an den Patienten oder die Patientin abgegeben bzw. unmittelbar ärztlich angewendet werden [...] die Relevanz u. a. der äußeren Form oder des Applikationsmechanismus in Bezug auf die therapeutische Vergleichbarkeit in den Hintergrund“ gerückt sieht. Im Umkehrschluss kommt Novo Nordisk zu der Annahme, dass im Falle der Applikation bzw. Injektion durch Patient:innen selbst, die Relevanz der äußeren Form und des Applikationsmechanismus gegeben ist.

Pfizer Pharma GmbH (Pfizer)

[...] Etanercept wird parenteral in Form subkutaner Selbstinjektionen appliziert. Unterschiedliche Applikatoren wie z.B. Pens oder Fertigspritzen haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, und die Wahl der richtigen Form hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der spezifischen Erkrankung, der Schwere der Symptome, der Verträglichkeit des Patienten und der Präferenz des Patienten. Enbrel® ist u.a. mit dem innovativen Autoinjektor (SMARTCLIC) verfügbar, der speziell auf die Bedürfnisse von Patienten mit eingeschränkter Handfunktion oder Applikationsschwierigkeiten zugeschnitten ist und dementsprechend von Ärzten patientenindividuell verordnet wird [15, 38, 39]. Ein Austausch des Enbrel® Autoinjektors in der Apotheke kann somit zu Nachteilen für den Patienten führen. Zudem belegt eine Studie zum Wirkstoff Golimumab, dass die Adhärenzrate bei Autoinjektoren höher ist als bei Fertigspritzen und gerade Patienten, denen die Applikation schwerfällt, deutliche Vorteile bietet. In der Studie (n=91) zeigte sich, dass 94,5 % der Patienten die Anwendung des Autoinjektors als sehr einfach oder einfach empfanden. Bei der Fertigspritze lag dieser Wert bei 73,6 %. Mäßiges oder stärkeres Unbehagen trat bei 20,9 % der Patienten bei Anwendung der Fertigspritze auf, beim Autoinjektor hingegen nur bei 5,5 %. Schwerwiegendes Unbehagen oder Beschwerden, die eine weitere Anwendung ausschließen, wurden bei 8,8 % der Patienten mit Fertigspritze berichtet – beim Autoinjektor hingegen gar nicht [40].

[...] Wir möchten darauf hinweisen, dass bei Genotropin® bestimmte Besonderheiten bestehen, die der Austauschbarkeit gegen das Biosimilar Omnitrope® entgegenstehen:

- *Genotropin® wird zur Eigenanwendung sowohl als Fertigspritze zur Einmalinjektion vertrieben als auch in einzelnen Ampullen, die mithilfe des Genotropin®-Pens injiziert werden müssen. Diese Injektionshilfe ist **ausschließlich für die Applikation der***

38 Boeri M et al. (2019): From drug-delivery device to disease management tool: a study of preferences for enhanced features in next-generation self-injection devices. Patient Prefer Adherence;13:1093-110.

39 Van den Bemt BJF et al. (2019): A portfolio of biologic self-injection devices in rheumatology: how patient involvement in device design can improve treatment experience. Drug Deliv.;26(1):384-92.

40 Vermeire S et al. (2018): Preference for a prefilled syringe or an auto-injection device for delivering golimumab in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis: a randomized crossover study. Patient Prefer Adherence;12:1193-202.

Genotropin®-Ampullen geeignet und vorgesehen, d. h. es können keine anderen Produkte von Mitbewerbern verwendet werden. Der Pen ist zur Mehrfachverwendung vorgesehen und hat eine Haltbarkeit von durchschnittlich 2–3 Jahren. Die Injektions-Pens der anderen Hersteller sind unterschiedlich. Das betrifft die Handhabung, die Technologie, die Lagerung und die Injektion selbst. Das Zweikammerpatronen-System von Genotropin® lässt sich in anderen Pens nicht verwenden und vice versa.

- Bei Erstverschreibung von Somatropin-Präparaten ist eine Schulung der Patienten oder der Betreuungspersonen durch den verschreibenden Arzt auf den Applikator üblich [41]. Bei einem Austausch in der Apotheke würde diese Schulung fehlen, was das Risiko für eine fehlerhafte Anwendung erhöht.
- Neben der Inkompatibilität von Applikatoren ist bei unseren Genotropin-MiniQuick®-Fertigspritzen die Dosis festgelegt. Gerade Patienten mit einer sprachlichen oder geistigen Benachteiligung haben hier eine Sicherheit einer vom Arzt verordneten Dosierungseinstellung, die bei anderen Applikatoren so nicht gegeben ist. Auch Allergiker haben die Möglichkeit, mit dem MiniQuick® und der Zweikammerpatrone ganz ohne Konservierungsstoffe auszukommen, was bei anderen Präparaten nicht der Fall ist [42].

ratiopharm GmbH (Ratiopharm)

Der automatische Austausch ist insbesondere im Hinblick auf Arzneimittel zur Selbstinjektion kritisch zu sehen, da die Handhabung von Fertigspritzen oder Pens sich unterscheidet und der Patient entsprechend eingewiesen werden muss. Erhält er in der Apotheke ein Präparat von einem anderen Hersteller als dem, für den er eine Einweisung in der Praxis erhalten hat, kann es zu Handhabungsfehlern kommen, die die Therapie beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann das Medikament durch einen Handhabungsfehler unbrauchbar werden (z. B. vorzeitiges Auslösen des Schutzmechanismus einer Fertigspritze) und eine Neuverordnung nötig werden.

Sanofi

Ein weiterer Aspekt ist, dass ein Austausch von Insulin-Patronen gegen Insulin-Fertigpens aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, da die Schlüsselung der jeweiligen Insulin-Darreichungsform (Durchstechflasche, Patrone, Fertigpens) in der Lauer-Taxe - gemäß den Regularien der IFA GmbH - durch die jeweilige Fachinformation vorgegeben ist, die wiederum in den allermeisten Fällen nicht differenziert ist. Ein solcher Austausch ist aufgrund der Änderung der Darreichungsform für Patient:innen nicht sachgerecht. Darüber hinaus führt eine Substitution von Insulinpatronen durch Fertigpens zu einer Vergrößerung des ökologischen Fußabdruckes, der nicht erstrebenswert ist. Auch zur Vermeidung dieser Problematik regt Sanofi die Bildung einer Substitutionsausschlußliste für biotechnologisch hergestellte Arzneimittel und die subsequeunte Aufnahme von Insulinen auf diese Liste an.

STADAPHARM GmbH (Stadapharm)

[...] Darüber hinaus bestehen relevante Unterschiede in den Gerätesystemen zur Applikation: Während einige Präparate ausschließlich als Einwegpens angeboten werden, beruhen andere auf wiederverwendbaren Pens, bei denen lediglich die Wirkstoffkartuschen ausgetauscht werden. Im Rahmen einer automatischen Substitution kann dies dazu führen, dass Patientinnen und Patienten lediglich Kartuschen erhalten, ohne über das notwendige Applikationsgerät zu verfügen. Dies birgt das Risiko eines abrupten Therapieabbruchs und stellt insbesondere bei chronischen Erkrankungen eine erhebliche Gefährdung der Versorgungskontinuität dar.

Diese Faktoren beeinflussen nicht nur die Handhabung, sondern auch das Schmerzempfinden und die Verträglichkeit – insbesondere bei langfristiger Selbstmedikation durch Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen.

41 Genotropin: Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand Mai 2024.

42 Fachinformation Genotropin MiniQuick. Stand Mai 2024.

Die G-BA-Auswertung zeigt, dass solche Unterschiede nicht nur theoretischer Natur sind, sondern in der Praxis zu Problemen bei der Umstellung führen können. Dies betrifft insbesondere vulnerable Gruppen wie ältere Menschen, Patienten mit motorischen Einschränkungen oder kognitiven Beeinträchtigungen.

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA), Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK)

Darüber hinaus handelt es sich hierbei mehrheitlich um parenteral anzuwendende Arzneimittel, bei denen von einer erhöhten Sensibilität der häufig schwer kranken Patientinnen und Patienten auszugehen ist. Bereits kleine Änderungen in der Art der Applikation können zu massiver Verunsicherung bei den Patienten bis hin zur fehlenden Therapietreue (Non-Adhärenz) führen.

[...] Darüber hinaus begrüßen wird die Klarstellung, dass das abzugebende Fertigarzneimittel mindestens für die Applikationsarten des verordneten Fertigarzneimittels zugelassen sein muss. Wir erkennen jedoch in dem Verweis der tragenden Gründe, wonach z. B. jeweilige Unterschiede in der Formulierung des Arzneimittels (Hilfsstoffe), der Darreichungsform (Pulver und Lösungsmittel anstatt einer fertigen Injektionslösung) oder des Verabreichungsweges (Spritze versus Pen) gestattet seien, wenn diese keinen Einfluss auf die Sicherheit und keinerlei Einfluss auf die Wirksamkeit im Rahmen der Zulassung gezeigt hätten, die Belange des hier zu regelnden Austauschs nur unzureichend berücksichtigt. Sofern es sich nun um den Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken handelt, halten wir die genannten Punkte aufgrund potenzieller Risiken für die Patienten- und Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) für äußerst relevant. Aufgrund bestehender Unterschiede, nicht nur in der Beschaffenheit und Zusammensetzung (verschiedene Hilfsstoffe bergen das Potential möglicher Unverträglichkeiten), sondern auch in der Handhabung (wie Applikationshilfen, Lagerbedingungen, Spritzenentsorgung) der Biosimilars, kann deren Substitution zu Verunsicherung und Vertrauensverlust der Patienten bis hin zur Therapieverweigerung führen und birgt die große Gefahr von vermehrten Medikationsfehlern.

Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V.

[...] Gleichzeitig weist die ADKA darauf hin, dass innerhalb einer identischen Applikationsart – zum Beispiel bei subkutaner Anwendung – unterschiedliche konkrete Darreichungsformen (z. B. Fertigpen vs. Fertigspritze, unterschiedliche Injektionshilfen, abweichende Handhabungsschritte) durchaus zulässig sein können. Diese Unterschiede sind relevant und können bei Patientinnen und Patienten insbesondere mit eingeschränkter Feinmotorik oder kognitiven Einschränkungen zu Anwendungsproblemen führen. Dies birgt potenzielle Risiken für die korrekte Anwendung, die Therapietreue und letztlich den Behandlungserfolg.

Die ADKA fordert daher, dass sowohl Gleichheit in der Darreichungsform als auch die indikationsbezogene Übereinstimmung als zwingende Kriterien für einen etwaigen Austausch zu berücksichtigen sind.

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V (BPI)

Es ist darauf hinzuweisen, dass Biosimilars mit den spezifischen Darreichungsformen mit Blick auf deren Austauschbarkeit aktuell in der Anlage VII (aut idem) noch nicht enthalten sind.

Pharma Deutschland e.V.

[...] Zum Beispiel ist die Darreichungsform entscheidend, da bei einer Selbstapplikation – gleicher Applikationsweg – durch den Patienten entscheidend ist, ob das Arzneimittel in Form eines Vials oder eines Fertigpens oder einer Fertigspritze vorliegt. Bei einem Vial wäre hierfür eine zusätzliche Hilfsmittelverordnung notwendig. Zudem ist aus den Preis- und Produktinformationen nach § 131 Absatz 4 SGB V (sog. Lauertaxe) für den Apotheker nicht ersichtlich, ob es sich bei der Darreichungsform „ILO“ um einen Fertigpen oder eine Fertigspritze handelt, was hinsichtlich des Erkrankungsbild des Patienten entscheidend für die

Selbstanwendung durch den Patienten sein kann. Generell gilt, dass für Patienten ein vergleichbares Verabreichungssystem für eine risikoarme, Medikationsfehler vermeidende, Austauschbarkeit relevant ist, denn Verabreichungssysteme könnten sich unterscheiden, selbst zwischen Fertigpens.

Die Anlage VII Teil A ist wirkstoffgeregelt und gibt keinen Hinweis auf die zugelassenen Darreichungsformen oder Indikationen. Es ist zwingend erforderlich, dass die Substitution in der Apotheke erst erfolgen kann, wenn die Austauschbarkeit der Fertigarzneimittel hinsichtlich ihrer Darreichungsformen zusätzlich gemäß § 40 Absatz 1 AM-RL i. V. m. § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V in Anlage VII Teil A geregelt werden soll.

Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (vfa)

Darüber hinaus sollte die Austauschbarkeit nicht nur an die Darreichungsform und Applikationsart geknüpft sein, sondern weitere relevante Unterschiede berücksichtigen und in erforderlichem Maße weiter differenzieren, z.B. ob es sich bei der Darreichungsform um eine Injektionslösung aus einer Durchstechflasche, einem Pen oder aus einer Fertigspritze handelt. Ein Austausch wäre in diesen Fällen aufgrund möglicher Fehlanwendungen zu unterlassen.

Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker e. V. (VZA)

In den Tragenden Gründen wird auf S. 3 u.a. dazu ausgeführt, welche Unterschiede bei Biosimilars für die Zulassung bezogen auf ein Referenzarzneimittel noch akzeptabel seien. Dort werden u.a. unterschiedliche Hilfsstoffe oder auch unterschiedliche Verabreichungswege (Spritze versus Pen) etc. genannt. Angesichts dessen, dass entsprechende Unterschiede für die Patienten Verträglichkeits- und Handhabungsrisiken mit sich bringen können, muss vom G-BA verbindlich entschieden werden, ob die Apotheke bei entsprechenden Unterschieden austauschen darf oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist der G-BA-seitig geplante Verweis auf die Anlage VIIa nicht ansatzweise ausreichend (näher dazu auch noch zu Absatz 3 Satz 2, Anlage VII).

Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG), gemeinsam mit Hautnetz Deutschland e. V. und Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD)

Die Patientenführung der schwer immunkranken Patienten und ihre Einstellung auf hochwertige Immuntherapeutika ist ein sensibler Vorgang, bei dem Änderungen in der Applikationsweise nachteilig sind, zu Verunsicherungen und zu reduzierter Adhärenz führen können. Die Unterzeichnenden, die zusammen mehrere Tausend Patienten mit Biosimilars behandeln, können von den regelhaft auftretenden Schwierigkeiten bei der Umsetzung auf andere Präparate berichten. Probleme der Adhärenz werden ebenfalls beobachtet, selbst bei Wechseln zwischen verschiedenen Applikationsformen (Pen vs. Fertigspritze oder sogar Pen vs. anderem Pen).

Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e.V. (DGRh)

[...] Hierbei ist zu beachten, dass Biosimilars im Gegensatz zu Generika unterschiedliche Handelsnamen tragen – der Wirkstoff wird auf der Packung jeweils nur wenig prominent genannt – und dass sich die Applikationsgeräte („devices“, also Pens bzw. Fertigspritzen) in Gestaltung und Funktionsweise unterscheiden. Während Fertigspritzen relativ unkompliziert austauschbar sein dürften, ist bei den sehr unterschiedlichen Pens zu befürchten, dass Probleme bei der Handhabung auftreten werden, wenn nicht gleichzeitig eine Standardisierung der Pens erfolgt. Zudem werden vermutlich lokale Reaktionen auf verschiedene Zusatzstoffe der Biosimilars häufiger auftreten und zu vermehrten akuten Arztbesuchen führen.

Bewertung:

Die vorgebrachten Einwände, in der Regelung würden notwendige Vorgaben hinsichtlich einer Austauschbarkeit biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel in Bezug auf

die Darreichungsform fehlen, werden vor dem Hintergrund, dass der G-BA in § 40c Absatz 1 die bereits in § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V angelegte Systematik mit Berücksichtigung „gleicher“ und „austauschbarer“ Darreichungsformen auf den Bereich der Biologika überträgt, nicht geteilt.

Um „gleiche“ Darreichungsformen handelt es sich gemäß geltendem Rahmenvertrag in der Fassung vom 1. August 2025 bei identischer Bezeichnung der Darreichungsformen im Preis- und Produktverzeichnis nach § 131 Absatz 4 SGB V. Therapeutisch vergleichbare und damit „austauschbare“ Darreichungsformen werden in Anlage VII Teil A zur AM-RL (Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen (aut idem) gemäß § 129 Abs. 1a Satz 1 SGB V) aufgenommen.

Soweit in den Stellungnahmen geäußert wird, dass auch bei Meldung der identischen Darreichungsform-Bezeichnung im Preis- und Produktverzeichnis nach § 131 Absatz 4 SGB V verschiedene Behältnisse (wie z. B. Durchstechflasche, Patrone, Fertigpen, Fertigspritze) zugrunde liegen könnten und somit nach dem Kriterium der gleichen Darreichungsform nach § 129 Absatz 1 SGB V gegenseitig austauschbar wären, hält der G-BA eine solche Austauschbarkeit der Behältnisse durch Apotheken im Zuge einer Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel für nicht sachgerecht. Aus diesem Grund wird in Absatz 1 eine Regelung ergänzt, dass bei gleicher Darreichungsform eine Ersetzung nur möglich ist, wenn das in der Fachinformation angegebene Behältnis zwischen verordnetem und abzugebendem Arzneimittel übereinstimmt. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass auch bei einer Ersetzung durch Apotheken die im Rahmen der ärztlichen Therapieentscheidung getroffene Auswahl der Darreichungsform erhalten bleibt. Der G-BA folgt damit auch den Vorgaben aus dem Gesetzesauftrag nach § 129 Absatz 1a SGB V, eine Austauschbarkeit nur „unter Berücksichtigung der therapeutischen Vergleichbarkeit“ zwischen verordnetem und abzugebendem Biologikum vorzusehen.

Die Bedenken hinsichtlich möglicher Anwendungsprobleme der Versicherten bei abweichenden Applikationsmechanismen bzw. Handhabungen unterschiedlicher Devices können zwar für den medizinisch begründeten Einzelfall nachvollzogen werden, werden aber in Bezug auf die grundsätzliche Möglichkeit einer Austauschbarkeit biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel nicht geteilt. Denn die Kenntnis über die korrekte Handhabung oder Funktionsweise eines Devices ist auch unabhängig von einer Umstellungs- oder Ersetzungssituation relevant. Da bei einer Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel aus Sicht des G-BA Information und Beratung insbesondere zu substitutionsbedingt relevanten Aspekten bei der Abgabe in der Apotheke einen wichtigen Teil darstellen, um einerseits die Therapieadhärenz zu fördern sowie Verunsicherung, Anwendungsfehler oder subjektive Effekte wie einen möglichen Nocebo-Effekt zu reduzieren, wurde die Regelung in § 40c Absatz 4 zur Hervorhebung der gesetzlichen Rahmenvorgaben sowie des Beratungsbedarfs bei Biologika-Verordnungen aufgenommen.

Soweit trotz erfolgter Aufklärung, Schulung und Beratung durch die Apotheke eine patientenindividuelle Gefährdung des Therapieerfolgs durch Nicht-Adhärenz oder Anwendungsfehler nicht vermieden werden kann, kann ein Absehen von einer Ersetzung durch die Apotheke ebenso gerechtfertigt sein wie bei patientenindividuell relevanten Abweichungen der Arzneimittel hinsichtlich der Injektionsvolumina (z. B. Schmerzen bei größeren Volumina), der Handhabung (z. B. eingeschränkte Feinmotorik) trotz übereinstimmender Behältnisse und der Packungsausstattung (z. B. vorherige Rekonstitution der Injektionslösung). Die Möglichkeit der Apotheke von einer Ersetzung abzusehen, ergibt sich dabei aus § 40c Absatz 5. Siehe auch Bewertung der Einwände zum Absatz 5. Zur Berücksichtigung weiterer Produkteigenschaften und der therapeutischen Vergleichbarkeit siehe auch Bewertung zu Einwand 3.1.6.

In Bezug auf die Einwände zu (noch) fehlenden Hinweisen zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen in der Anlage VII Teil A Tabelle 2 zur AM-RL für biotechnologisch

hergestellte biologische Fertigarzneimittel ist zu entgegnen, dass gemäß gesetzlichem Rahmen eine Ersetzung eines biotechnologisch hergestellten Fertigarzneimittels durch die Apotheke bislang grundsätzlich ausgeschlossen ist. Insofern wird der G-BA nach Inkrafttreten der Regelungen in § 40c AM-RL ein Stellungnahmeverfahren zur Änderung der Anlage VII zur AM-RL aufgrund von Hinweisen zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen für biotechnologisch hergestellte biologische Fertigarzneimittel einleiten, da sich erst danach für diesen Bereich erstmalig die Möglichkeit und für Apotheken eine Befugnis zur Ersetzung ergeben kann.

3.1.3 Berücksichtigung der „Applikationsart“

Fresenius Kabi

Die Übereinstimmung der Applikationsarten des auszutauschenden Arzneimittels mit mindestens denen des verordneten Arzneimittels sehen wir in Bezug auf die Versorgungssicherheit als Grundvoraussetzung für einen Austausch in der Apotheke an und begrüßen die entsprechende Formulierung in den tragenden Gründen zu Ihrem Beschluss.

Hexal

[...] Die Möglichkeit der einzubeziehenden Organisationen, aussagekräftige Stellungnahmen abzugeben, ist naturgemäß davon abhängig, dass der Inhalt des zu kommentierenden Beschlusses – samt der diesen tragenden Gründe – ausreichend klar und deutlich gefasst ist. Das ist vorliegend nicht vollumfänglich der Fall. Absatz 1 Satz 3 des neu in die AM-RL einzufügenden § 40c lautet wie folgt: „Das abzugebende Arzneimittel muss mindestens für die Applikationsarten des verordneten Arzneimittels (...) zugelassen sein.“

Der Begriff der „Applikationsart“ ist jedoch nicht definiert und seine konkrete Bedeutung ergibt sich auch nicht eindeutig aus den dem Beschlussentwurf zum neu geplanten § 40c AM-RL beigefügten tragenden Gründen.

*Zunächst wird darauf hingewiesen, dass „unterschiedliche Applikationsorte (z. B. systemisch, topisch), unterschiedliche Applikationswege (z. B. oral, parenteral) und unterschiedliche Applikationshäufigkeiten (z. B. begründet durch die Freisetzungskinetik)“ zum jetzigen Zeitpunkt bei Referenzarzneimittel und Biosimilar nicht zu erwarten seien [Hervorhebung durch die Verf.]. Sofern jedoch **dennoch** Zulassungen für unterschiedliche Applikationsarten vorliegen, soll bei einer Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel durch Apotheken darüber hinaus gewährleistet sein, dass das abzugebende Arzneimittel mindestens für die Applikationsarten des verordneten Arzneimittels zugelassen ist.*

Dies könnte die Interpretation nahelegen, dass nur dann eine jeweils gleiche zugelassene Applikationsart vorliegt, wenn jeweils sowohl der Applikationsort als auch der Applikationsweg als auch die Applikationshäufigkeit identisch sind.

Ebenso erscheint es jedoch gut denkbar, den Begriff der Applikationsart so zu verstehen, wie er in der – den ins Stellungnahmeverfahren einzubeziehenden Kreisen wohlbekannten – Lauer-Taxe der IFA GmbH verwendet wird. Dort ist bei einem Biologikum, das per Fertigspritze injiziert wird, etwa unter dem Begriff „Applikation“ angegeben:

- *Applikationsform: flüssig*
- *Applikationsweg: invasiv*
- *Applikationsart: zum Injizieren*
- *Applikationsort: Unterhaut*

Bei diesem Verständnis wäre der Begriff der Applikationsart somit deutlich enger gefasst.

Somit bleibt es dabei, dass der beschlussgegenständliche und für das Verständnis des neu einzufügenden § 40c AM-RL wesentliche Begriff der „Applikationsart“ nicht ausreichend klar bestimmt ist. Es muss deshalb damit gerechnet werden, dass den Stellungnahmen der zu

Beteiligten kein einheitliches Verständnis der Voraussetzungen des § 40c zugrunde liegt. Damit werden Beteiligungsrechte Dritter unterlaufen, was bereits für sich genommen zur Rechtswidrigkeit des Beschlusses führt, wenn nicht nach einer Klarstellung erneut Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben wird.

Ohne eine klare Definition des Begriffs Applikationsart in § 40c AM-RL hingegen dürfte somit die daraus resultierende Unklarheit über wesentliche Voraussetzungen der Norm einen Verstoß gegen den verfassungsrechtlich in Art. 103 Grundgesetz verankerten Bestimmtheitsgrundsatz darstellen und zur Rechtswidrigkeit des Beschlusses führen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass in Anlage VIIa Angaben zu Applikationsarten aufgenommen werden, da die Anlage VIIa gemäß den Tragenden Gründen zum geplanten § 40c AM-RL keinen abschließenden Charakter hat.

Anzumerken ist weiter, dass der Apotheker mit den spezifischen Therapiesituationen eines Patienten nicht vertraut und folglich außer Stande ist, an dieser Stelle eine fachkundige und patientenindividuelle Beratung unter Würdigung dieser therapierelevanten Aspekte zu leisten. Ohne explizite Zustimmung des Patienten kann der Apotheker diese Informationen auch nicht in Erfahrung bringen. Der G-BA selbst hat unlängst in seiner Stellungnahme zum ALBVVG auf diese Problematik aufmerksam gemacht und eine dahingehende Klarstellung in der AMVV gefordert:

„Im Zusammenhang mit dem Austausch von Arzneimitteln wird in Ergänzung zu den Änderungen in § 129 SGB V auch eine Änderung der Verordnung über die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln (Arzneimittelverschreibungsverordnung – AMVV) dahingehend vorgeschlagen, dass bei parenteral anzuwendenden Arzneimitteln die ärztlich vorgesehene Applikationsart durch ein entsprechendes Kürzel auf der Verschreibung anzugeben ist. Nicht nur in Bezug auf die Austauschbarkeit von Biologika, sondern generell ergibt sich aus der Angabe der Darreichungsform bei parenteral anzuwendenden Arzneimitteln, anders als bei anderen Darreichungsformen, die tatsächliche Applikationsform des jeweiligen Arzneimittels nicht immer zweifelsfrei. [...] Demgegenüber finden sich Parenteralia im Markt, die als Injektionslösung gleichzeitig zur subkutanen, intramuskulären als auch intravenösen Anwendung zugelassen sind (z. B. eignet sich „Methotrexat AL Injektionslösung“ nur für die intramuskuläre oder subkutane Injektion, während „Lantarel Injektionslösung“ intramuskulär, intravenös oder subkutan injiziert werden kann). Die fehlende Kenntnis über die bei diesen Injektabilia ärztlicherseits bei der Verordnung vorgesehene Applikationsart behindert somit die durch die Apotheke zu gewährleistende Information von Patientinnen und Patienten über die sachgerechte Anwendung dieser Arzneimittel.“

Der G-BA formuliert hiermit von sich aus eine relevante Substitutionshürde in der Apotheke und eine regulatorische Anforderung, für die der aktuelle Beschluss keine Abhilfe schafft. Der Apotheker kann wie beschrieben die Applikationsart, für die das verordnete Arzneimittel eingesetzt werden soll, nicht kennen. Hinzu kommt, dass sich die gewählte Applikationsart bei mehreren zugelassen Möglichkeiten im Therapieverlauf auch ändern kann.

ABDA, AMK

Darüber hinaus begrüßen wird die Klarstellung, dass das abzugebende Fertigarzneimittel mindestens für die Applikationsarten des verordneten Fertigarzneimittels zugelassen sein muss. Wir erkennen jedoch in dem Verweis der tragenden Gründe, wonach z. B. jeweilige Unterschiede in der Formulierung des Arzneimittels (Hilfsstoffe), der Darreichungsform (Pulver und Lösungsmittel anstatt einer fertigen Injektionslösung) oder des Verabreichungsweges (Spritze versus Pen) gestattet seien, wenn diese keinen Einfluss auf die Sicherheit und keinerlei Einfluss auf die Wirksamkeit im Rahmen der Zulassung gezeigt hätten, die Belange des hier zu regelnden Austauschs nur unzureichend berücksichtigt. Sofern es sich nun um den Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken handelt, halten wir die genannten Punkte aufgrund potenzieller Risiken für die Patienten- und

Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) für äußerst relevant. Aufgrund bestehender Unterschiede, nicht nur in der Beschaffenheit und Zusammensetzung (verschiedene Hilfsstoffe bergen das Potential möglicher Unverträglichkeiten), sondern auch in der Handhabung (wie Applikationshilfen, Lagerbedingungen, Spritzenentsorgung) der Biosimilars, kann deren Substitution zu Verunsicherung und Vertrauensverlust der Patienten bis hin zur Therapieverweigerung führen und birgt die große Gefahr von vermehrten Medikationsfehlern.

ADKA

Die ADKA begrüßt die Anforderung, dass die Applikationsart des abzugebenden Arzneimittels der des verordneten Präparats entsprechen muss. Dies stellt sicher, dass keine grundlegenden Änderungen im Verabreichungsweg erfolgen, die die Handhabung oder das Verständnis der Therapie beeinträchtigen könnten.

Pro Generika e. V. / AG Pro Biosimilars (Pro Generika)

Wir begrüßen ausdrücklich die in den tragenden Gründen formulierte Klarstellung, dass ein Austausch durch Apotheken nur erfolgen darf, wenn das abzugebende Arzneimittel mindestens für die Applikationsarten des verordneten Arzneimittels zugelassen ist. Diese Regelung ist aus Sicht der Versorgungssicherheit und im Hinblick auf die arzneimittelrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen zwingend erforderlich.

Bewertung:

Die Stellungnehmenden begrüßen die Regelung zur notwendigen Übereinstimmung der zugelassenen Applikationsarten zwischen verordnetem und abzugebendem Fertigarzneimittel.

Soweit in einer Stellungnahme eingewendet wird, dass diese Regelung mangels Definition des Begriffs „Applikationsart“ nicht der verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheit entspreche, wird diesem Einwand nicht gefolgt. Der Begriff „Applikationsart“ wurde in Bezug auf die Austauschbarkeit von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln bereits mit den Beschlüssen vom 19. November 2021 und 15. Juni 2023 zur Erstfassung der Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) und zur Ergänzung des § 40b (neu) in der AM-RL sowie mit Beschluss vom 18. August 2022 zur Austauschbarkeit von parenteral anzuwendenden Arzneimitteln eingeführt. Dabei wird jeweils bzgl. der Applikationsart z. B. die „orale Applikation“, „subkutane Applikation“, „intravenöse Applikation“ oder „intravitreale Applikation“ unterschieden. Es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in den Zusammenfassenden Dokumentationen zu den entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/5132/>, <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/> und <https://www.g-ba.de/beschluesse/5583/>).

3.1.4 Übereinstimmung der Anwendungsgebiete

3.1.4.1 Unterstützung von Position A

3.1.4.2 Unterstützung von Position B1 + B2

Alexion Pharma Germany GmbH (Alexion)

Wir widersprechen der in Position A formulierten Auffassung, wonach für den Austausch lediglich die Übereinstimmung eines Anwendungsgebietes der Biosimilars mit dem Referenzarzneimittel ausreichen soll. Für eine Austauschbarkeit ist unseres Erachtens erforderlich, dass das Biosimilar, wie in der Position B1+ B2 erläutert, mindestens über alle für das verordnete Fertigarzneimittel zugelassenen Anwendungsgebiete verfügen muss. Außerdem empfehlen auch die EMA und HMA einen Austausch von Biosimilars und dem Referenzarzneimittel nur dann, wenn die Fachinformationen hinsichtlich der Anwendungs-

bedingungen vollständig übereinstimmen [43].

[...] Nach § 40a Abs. 3 AM-RL gilt zudem für ärztlich veranlasste Umstellungen und den Austausch von Therapien: „Voraussetzung für Umstellungen nach Absatz 1 Satz 2 ist, dass das verordnete biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel über eine Zulassung für die Indikation verfügt, für die es eingesetzt werden soll“. Damit die Therapieverantwortung im sensiblen Bereich des Einsatzes biologischer Arzneimittel in der Verantwortung der behandelnden Ärzt:in bleibt, ist es erforderlich, dass dieselben Regelungen für Ärzt:innen und Apotheker:innen gelten.

Da den Apotheker:innen in der Regel die genaue Indikation der Patient:innen nicht bekannt ist, sollte für einen Austausch auf Apothekenebene mindestens gelten, dass das austauschbare Arzneimittel für sämtliche Indikationen wie das ursprünglich verordnete Arzneimittel zugelassen ist. Nur unter dieser Voraussetzung kann ein unbeabsichtigter Off-Label-Use und die damit verbundene Notwendigkeit zur entsprechenden Patient:innenaufklärung sicher verhindert werden.

Alexion schließt sich der Argumentation der Position B1 + B2 an, wonach – anders als bei Generika – bei der Zulassung von Biosimilars, keine uneingeschränkte Übertragung der Indikationen (Extrapolation) auf weitere Anwendungsgebiete erfolgt. Es wird wie in den tragenden Gründen ausgeführt, jeweils pro Arzneimittel geprüft, inwiefern Unterlagen zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vorgewiesen werden müssen [44]. Für eine Extrapolation sind stets eine fundierte wissenschaftliche Begründung sowie gegebenenfalls ergänzende Daten notwendig.

Vor dem Hintergrund der dargelegten Argumente ist die in Position A vertretene Auffassung klar abzulehnen. Alexion plädiert nachdrücklich für die Annahme der von den Positionen B1 + B2 vorgebrachten Empfehlungen und eine einheitliche Regelung gemäß AM-RL §40b.

Amgen

Amgen lehnt die Position A ab und unterstützt den in Position B1 + B2 formulierten Regelungsvorschlag. Eine ähnliche Formulierung hatte bereits Eingang in § 40b der AM-RL gefunden und sollte mit Blick auf die im dortigen Stellungsnahmeverfahren erfolgte Diskussion entsprechend auch für § 40c verwendet werden.

Bei der Formulierung von Abs. 1 des § 40c der AM-RL ist dringend zu bedenken, dass nicht alle Biosimilars zu jedem Zeitpunkt alle Indikationen des Referenzprodukts abdecken. Dies kann bei einer automatischen Substitution des Referenzprodukts dazu führen, dass das Biosimilar off-label angewendet wird. Die Off-label-Anwendung wiederum kann haftungsrechtliche Folgen für die Apotheke bedeuten, da keine zulassungskonforme Verwendung des Arzneimittels vorliegt.

Eine fehlende vollständige Deckungsgleichheit der Anwendungsgebiete von Referenzarzneimitteln und Biosimilars kann z. B. wegen patentrechtlicher Einschränkungen auftreten oder weil unterschiedliche klinische Rahmenbedingungen eine Extrapolation der Daten nicht zulässt (u.a. rheumatoide Arthritis) [45, 46]. So waren z. B. nach der Zulassung von Biosimilars des Wirkstoffs Bevacizumab verschiedene Kombinationstherapien für die Anwendungsgebiete Brustkrebs, NSCLC (nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom) und Ovarialkarzinom zunächst

43 Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA): Q&A on the Statement on the scientific rationale supporting interchangeability of biosimilar medicines in the EU (Rev. 1), Apr 2023.

44 Richtlinie 2001/83/EG

45 EMA: Biosimilar Medicines: marketing authorisation. 2022. <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/marketing-authorisation/biosimilar-medicines-marketing-authorisation>

46 EMA und EC (2019): Biosimilars in der EU. Leitfaden für medizinische Fachkräfte. https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf

weiterhin nur durch das Originalprodukt [47] abgedeckt. Die Abdeckung durch Biosimilars erfolgte erst später bzw. nur partiell. Ein weiteres Beispiel ist der Wirkstoff Ustekinumab. Der Originator Stelara® besitzt eine Zulassung für die Anwendungsgebiete Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen ab 6 Jahren, sowie Psoriasis Arthritis, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bei Erwachsenen [48]. Dies wird nicht vollumfänglich durch Biosimilars abgedeckt: Weder WEZENLA®, Otulfi®, Steqeyma® noch Imuldosa® besitzen aktuell eine Zulassung für die Colitis ulcerosa, zudem ist Imuldosa® nicht für die pädiatrische Plaque-Psoriasis zugelassen [49, 50, 51, 52]. Insgesamt ist dies aus Sicht des Patentschutzes als auch haftungsrechtlich (off-label) nicht tragbar.

Gleichzeitig können auch unterschiedliche Dosisstärken bzw. spezielle Dosiergeräte zur Anwendung zugelassen sein, z. B. ist dies seit Zulassung der Biosimilars von Adalimumab für pädiatrische Anwendungsgebiete der Fall – hier deckt das Biosimilar Idacio [21] nicht die Wirkstärken des Originators Humira® [19] ab. Ein weiteres Beispiel ist Eylea® [53], hier ist die Behandlung einer Frühgeborenen-Retinopathie mittels eines speziellen Dosiergeräts notwendig (sog. Picleo), welche nicht durch die derzeit zugelassenen Biosimilars abgedeckt ist [54].

Ist die fragliche Indikation in der Gebrauchsinformationen nicht aufgelistet (off-label), kann dies bei den betroffenen Patient:innen zu Unsicherheit und unter Umständen zu einer schlechteren Therapieadhärenz im Vergleich zum ursprünglich verschriebenen Referenzprodukt führen. Dies ist vermeidbar, wenn das abzugebende Arzneimittel mindestens für die Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels zugelassen ist.

Weiterhin können bezüglich der Arzneimitteltherapiesicherheit bei der Substitution Probleme auftreten, wenn eine vollständige Deckungsgleichheit der Anwendungsgebiete zwischen verschriebenem und abgegebenem Arzneimittel nicht gewährleistet ist. Da die abgebende Apotheke die konkrete Indikation des verordneten Arzneimittels nicht kennt, kann bei der Substitution eines Referenzarzneimittels durch ein Biosimilar aktuell nicht abgeglichen werden, ob die konkrete Indikation durch das Biosimilar abgedeckt ist. Um die Arzneimitteltherapiesicherheit zu gewährleisten, sollten die zugelassenen Indikationen des abzugebenden Arzneimittels mit denen des verordneten Arzneimittels daher vollständig identisch sein. Ein entsprechendes Vorgehen wird auch von der EMA empfohlen, da nur so sichergestellt werden kann, dass eine belastbare Prüfung der Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit vorliegt [43]. Darüber hinaus bleibt bei einer vollständigen Deckungsgleichheit der Anwendungsgebiete zwischen Referenzarzneimittel und Biosimilar die Therapieentscheidung sowie die Verantwortung für die Therapie in den Händen der Ärzteschaft.

Gleichzeitig ist nur bei einer vollständigen Deckungsgleichheit der Anwendungsgebiete ausgeschlossen, dass die Apotheke unwillentlich und unwissentlich ein Arzneimittel abgibt, das für die konkrete Indikation nicht zugelassen ist.

Celltrion

Im vorliegenden Entwurf der Arzneimittel-Richtlinie legt der G-BA die gesetzliche Vorgabe zur automatischen Substitution biologischer Arzneimittel durch Apotheken als eine wechselseitige Austauschbarkeit sämtlicher biotechnologisch hergestellter Arzneimittel mit Bezug auf dasselbe Referenzprodukt aus – einschließlich des Austauschs von Biosimilar zu Biosimilar

47 Fachinformation Avastin. Stand April 2025.

48 Fachinformation STELARA. Stand März 2025.

49 Fachinformation WEZENLA. Stand Mai 2025.

50 Fachinformation Steqeyma. Stand Januar 2025.

51 Fachinformation IMULDOSA. Stand Juni 2025.

52 Fachinformation Otulfi. Stand Mai 2025.

53 Fachinformation Eylea. Stand Dezember 2024.

54 EMA: Pavblu (Aflibercept) – Übersicht über Pavblu und warum es in der EU zugelassen ist. https://www.ema.europa.eu/de/documents/overview/pavblu-epar-medicine-overview_de.pdf

sowie vom Biosimilar zurück zum Referenzpräparat. Gerade im Hinblick auf die unterschiedlichen Indikationsgebiete, in denen biologische Arzneimittel verordnet werden, muss von dieser allgemeinen Austauschbarkeit Abstand genommen werden.

Beispielhaft weisen wir in diesem Zusammenhang auf die Therapie der Hidradenitis suppurativa (HS), auch bekannt als Acne inversa, hin. „Es handelt sich hierbei um eine chronisch rezidivierende, entzündliche, potenziell mutilierende Hauterkrankung des terminalen Haartaldrüsenapparats, die sich mit schmerzhaften, entzündlichen Läsionen in den apokrinen drüsenreichen Körperregionen manifestiert, insbesondere in der axillären sowie der Inguinal- und Anogenitalregion. Abhängig vom Schweregrad der Erkrankungen wird zwischen milder, mittelschwerer und schwerer HS/AI unterschieden [55].“

Im Jahr 2015 wurde Adalimumab (Humira®) für die Behandlung der mittelschweren bis schweren aktiven Hidradenitis suppurativa (HS) bei Erwachsenen und, ab 2017 auch, für Jugendliche ab einem Alter von 12 Jahren, die unzureichend auf eine konventionelle systemische HS-Therapie ansprechen, zugelassen [17]. Mit dem Patentschutzende für Adalimumab im Jahr 2018 sind in Europa in den folgenden Jahren Biosimilars auf den Markt gekommen. „Deren Einsatz hat in den letzten Jahren als Alternative zum Originalpräparat bei der Behandlung von mittelschwerer bis schwerer HS/AI zugenommen [55].“

Die Vergleichbarkeit der Biosimilars zu ihrem Referenzarzneimittel sowie die Nicht-Vergleichbarkeit mit Generika sind hinlänglich bekannt. Vor dem Hintergrund unserer anschließenden Argumentation, fassen wir hier wohlweislich noch einmal die Fakten zusammen: Im Gegensatz zu Generika, die exakte Nachbildungen des Originalpräparats mit 80 bis 125% enthaltener Wirkstoffmenge des Originators darstellen, weisen Biosimilars sowohl untereinander als auch im Vergleich zum Originalpräparat minimale Unterschiede auf. Dies liegt vor allem am komplexen Herstellprozess und dem Einsatz lebender Zellen im Herstellungsprozess. Geringfügige Unterschiede zwischen einem Biosimilar und seinem Referenzprodukt sind unvermeidlich. Diese Unterschiede liegen allerdings auch zwischen den Chargen eines Produktes vor, zum Beispiel des Originalproduktes. Sie sind therapeutisch nicht relevant. Die Qualität des Arzneimittels unterliegt strengen und kontinuierlichen Kontrollen.

Die Autorengruppe Kirsten et.al. hat auf Grundlage von Daten des Deutschen HSBest-Registers in einer retrospektiven Studie die Umstellung von Adalimumab-Originalpräparat (ADAO) auf ein Adalimumab-Biosimilar (ABP501) untersucht. Näher betrachtet wurden der Krankheitsschweregrad und das Auftreten von unerwünschten Ereignissen bei 94 Patienten mit HS/AI, die von Adalimumab-Originalpräparat auf Adalimumab-Biosimilar umgestellt wurden [56]. Diese Studie ist die erste, die patientenbezogene und versorgungsreale Daten hinsichtlich einer Umstellung und deren Effekte auf den Krankheitsverlauf untersucht. „Our study results suggest that patients who underwent treatment switching to ABP501 experienced a marked risk of LoR regarding an increase of tunnels after their reduction under ADAO and AEs. In the study population, 20.2% of patients experienced LoR after switching; 7.4% experienced LoR in combination with AEs; and 5.3% of patients experienced AEs without LoR [56].“

Neben dieser Studie hat sich auch die Gruppe Montero-Vilchez et al. mit der Thematik der Umstellung von Original-Präparat auf ein Adalimumab-Biosimilar beschäftigt. Sie kommen in ihren Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen. „In a relatively small cohort of 17 patients, a loss of HiSCR occurred in 5 patients (29.4%) after switching to the biosimilar. At the same time, 6 patients (35.3%) experienced side effects such as pain at the injection site, dizziness and nausea. One clinical trial observed similar effectiveness and tolerability between originator

55 Deutsche Dermatologische Gesellschaft e.V. (DDG): S2k-Leitlinie Therapie der Hidradenitis suppurativa / Acne inversa (ICD-10 Ziffer: L73.2). 2024.

56 Kirsten N et al. (2022): Switching from Adalimumab Originator to Biosimilar in Patients with Hidradenitis Suppurativa Results in Losses of Response-Data from the German HS Registry HSBest. Life (Basel);12(10).

adalimumab and biosimilar SB5 in 11 patients [57].“

Die Ergebnisse der genannten Studien haben aufgrund ihrer Bedeutung für die Therapie der HS/AI-Patienten Eingang in die aktuelle S2K-Leitlinie gefunden. Die Leitlinien-Autoren kommen darin zu der Empfehlung, dass „die sorgfältige Einbeziehung pharmako-ökonomischer Maßnahmen mit einer gründlichen Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses einer nichtmedizinischen Umstellung von Originalpräparaten auf Biosimilars [...] unerlässlich ist, [...]“. Aus diesem Grund wird eine „Umstellung von HS/AI-Patienten, [...], auf ein Adalimumab-Biosimilar nicht empfohlen [55].“

Wir möchten vor diesem Hintergrund ausdrücklich darauf hinweisen, dass die vom Gesetzgeber geforderte Berücksichtigung der therapeutischen Vergleichbarkeit der zu reglementierenden Arzneimittel im Beschlussentwurf an keiner Stelle erkennbar ist. Vielmehr wird in § 40c Absatz 3 AM-RL von einer grundsätzlich vorhandenen Austauschfähigkeit von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln ausgegangen. Dies kann jedoch nur und ausschließlich auf Ebene des Arztes erfolgen, eine Substitution auf Ebene des Apothekers kann den Behandlungs- und Therapieerfolg in Frage stellen, da die Kenntnis zur ärztlich begründeten Indikation, nicht vorliegt. Daher kann bei der automatischen Substitution nicht geprüft werden, ob das Ersatzarzneimittel für die konkret intendierte Anwendung zugelassen ist. Ohne eine vollständige Übereinstimmung der zugelassenen Anwendungsbereiche besteht die reale Gefahr einer Abgabe außerhalb des Zulassungsrahmens – mit entsprechenden haftungsrechtlichen Risiken.

Die in den tragenden Gründen formulierte Klarstellung, dass ein Austausch, wenn er auf Apothekebene stattfindet, nur dann erfolgen darf, wenn das abzugebende Arzneimittel mindestens für die Applikationsarten des verordneten Arzneimittels sowie mindestens für die Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels (Position B1 + B2) zugelassen sein muss, halten wir daher für zwingend erforderlich.

Fresenius Kabi

Ein Austausch von Biosimilars in der Apotheke darf nur erfolgen, wenn das abgegebene Arzneimittel auch für alle Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels zugelassen ist. Andernfalls besteht das Risiko, dass Arzneimittel außerhalb ihres Zulassungsrahmens abgegeben werden – mit komplett unklaren haftungsrechtlichen Folgen. Da Apotheken keine Kenntnis über die ärztlich intendierte Indikation haben, ist eine sichere Prüfung ohne vollständige Zulassungsidentität unmöglich und wäre in der Umsetzung rechtlich unzulässig.

Auch aus Sicht der Patientensicherheit ist eine solche Übereinstimmung unerlässlich: Wenn die verordnete Indikation nicht in der Packungsbeilage des abgegebenen Arzneimittels erscheint, kann dies zu Verunsicherung und schlimmstenfalls zum Therapieabbruch führen – insbesondere bei chronisch Erkrankten. Solche Effekte sind bei der Substitution von Fertigarzneimitteln zur Selbstanwendung relevanter als bei ärztlich verabreichten Parenteralia, bei denen Patienten keinen direkten Kontakt zur Fachinformation haben.

Zudem erfolgt eine Indikationserweiterung bei Biosimilars nicht automatisch, sondern kann nur auf Antrag von der EMA erteilt werden, durch eine nachgelagerte Marktzugangsberechtigung durch die EU-Kommission. Eine Substitution ohne vollständige Zulassungsdeckung würde diese wissenschaftlich begründete Prüfung umgehen, was weder rechtlich zulässig noch medizinisch vertretbar ist.

Hexal

Wir sprechen uns klar für die Position B1+B2 aus, nach der im § 40c Abs. 1 AM-RL das abgegebene Arzneimittel für mindestens die Anwendungsgebiete zugelassen sein muss wie

57 Montero-Vilchez T et al. (2022): Switching from Adalimumab Originator to Biosimilar: Clinical Experience in Patients with Hidradenitis Suppurativa. Journal of Clinical Medicine;11(4).

das verordnete Arzneimittel. Bereits in den §§ 40a und 40b der AM-RL ist ein eindeutiger Indikationsbezug vorgesehen. So heißt es in § 40a Abs. 3 Satz 1 AM-RL: „Voraussetzung für Umstellungen nach Absatz 1 Satz 2 ist, dass das verordnete biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel über eine Zulassung für die Indikation verfügt, für die es eingesetzt werden soll.“ Ebenso heißt es in § 40b Abs. 1 Satz 2 AM-RL: „Das zu verarbeitende Fertigarzneimittel muss mindestens für die Applikationsarten des verordneten Fertigarzneimittels sowie mindestens für die Anwendungsgebiete des verordneten Fertigarzneimittels zugelassen sein.“

Auf einer nachgelagerten Ordnungsebene im § 40c AM-RL darf die Regelungsbefugnis nicht größer ausfallen als im vorgelagerten § 40a AM-RL, um die Regelungskonsistenz an sich nicht zu konterkarieren. Dies wirft vielfältige haftungsrechtliche Fragen auf. So wären auf Grundlage der Position A in der Apotheke Situationen denkbar, in denen in Unkenntnis der zugrundeliegenden Zulassungssituation (der Apotheker hat bzgl. der Indikationshinterlegung keine Prüfpflicht) eine Off-Label-Abgabe befördert wird.

Es ist kaum nachvollziehbar, dass der Arzt in § 40a Abs. 3 Satz 1 AM-RL an eine zulassungskonforme Verordnung gebunden wird, um dann den Apotheker ggf. dazu zu verpflichten oder es ihm zumindest zu ermöglichen, ein anderes als das verordnete Produkt außerhalb der zugelassenen Indikation abzugeben – in der Regel ohne Wissen des Apothekers, dem die Indikation in der Regel nicht bekannt sein dürfte.

Diese Eingrenzung im Auswahlbereich der potenziell austauschbaren Arzneimittel ist praxisrelevant, da im Rahmen der Zulassung von Biosimilars die Biosimilarität standardmäßig in einer sensitiven Indikation überprüft wird. Ist das Biosimilar im Hinblick auf seine analytischen, präklinischen und klinischen Eigenschaften äquivalent zum Referenzarzneimittel, kann eine Extrapolation auf andere Indikationen erfolgen. Die Extrapolation folgt jedoch nicht einem Automatismus, sondern basiert auf einer wissenschaftlichen Prüfung und Bewertung anhand eines Zulassungsdossiers, das explizit für jede Indikation des Referenzarzneimittels eingereicht werden muss, wenn die entsprechende Indikation angestrebt wird. Somit sind nicht automatisch alle Biosimilars einer INN in den gleichen Anwendungsgebieten zugelassen wie das Referenzarzneimittel bzw. wie ein anderes Biosimilar mit dem gleichen Wirkstoff.

In Bezug auf die besonderen Zulassungsvoraussetzungen von Biosimilars im Vergleich zu Generika machen wir uns die in den Tragenden Gründen nachzulesende und sehr überzeugende Begründung der Positionen B1 und B2 zu eigen. Eine Extrapolation ist nur statthaft, wenn es sich in den extrapolierten Indikationen um den gleichen Wirkmechanismus handelt (MoA). Ist ein anderer MoA gegeben bzw. möglich, so muss eine zusätzliche Phase-III-Studie durchgeführt werden. Beispielhaft zu nennen ist an dieser Stelle das Molekül Rituximab. Basierend auf der Phase-III-Studie zum Follikulären Lymphom konnte keine Extrapolation, vergleichbar zu den weiteren hämato-onkologischen Indikationen, erfolgen. Es musste für die Erteilung der Indikation Rheumatoide Arthritis (RA) eine explizite Studie mit RA-Patienten erfolgen. Dies gilt allgemein für jedes Biosimilar-Entwicklungsprogramm falls bei den zur Zulassung eingereichten Indikationen potenzielle Unterschiede bei den Wirkmechanismen (MoA) vorliegen könnten.

Im Übrigen wird auch in der juristischen Kommentarliteratur die Auffassung vertreten, dass es für einen Austausch auf Apothekenebene nicht per se ausreichen kann, dass die auszutauschenden technologisch hergestellten Biologika lediglich eine gemeinsame Indikation aufweisen. So etwa Krauskopf und Weiß zu § 129 SGB V, die wie folgt argumentieren:

„Nach Abs 1a S 3 hat der GBA bei der Hinweiserteilung insbesondere die therapeutische Vergleichbarkeit von Referenzarzneimitteln und ihren Biosimilars zu berücksichtigen. IE darf ein positiver Hinweis daher nur erteilt werden, wenn sich Referenzarzneimittel und Biosimilar ohne Beeinträchtigung von Therapiewirksamkeit und -sicherheit austauschen lassen. In den Fällen, in denen ein Biosimilar nicht für sämtliche Indikationen des Referenzarzneimittels zugelassen ist, muss der GBA durch Rezeption vorhandener

medizinischer Erkenntnisse insbesondere klären, ob eine Extrapolation im og Sinne möglich ist. Ist eine Extrapolation nicht für alle Indikationsbereiche möglich, darf er keinen positiven Hinweis erteilen, da andernfalls wegen Abs 1 S 12 iVm Abs 1 S 2 (Unbeachtlichkeit von Unterschieden im formalen Zulassungsumfang von verordnetem Arzneimittel und Substitut) die Möglichkeit besteht, dass Apotheker ein Biosimilar außerhalb seines zugelassenen Anwendungsbereichs abgeben und hiermit Therapierisiken einhergehen.“ [58]

Sofern – etwa aufgrund eines bestehenden Patentschutzes – das tatsächlich abgegebene Produkt die der Verordnung zugrunde liegenden Indikationen nicht enthält, sind sicherheitsrelevante Informationen in der Fachinformation bzw. Packungsbeilage für den Patienten ggf. nicht enthalten. Mitunter fehlen dem Apotheker und auch dem Patienten therapierelevante Informationen zur Dosierung oder auch zum Nebenwirkungsprofil, wenn das abgegebene Arzneimittel nicht über die Indikation verfügt, für die es eigentlich ärztlich verordnet worden ist. Dieser Umstand kann den sogenannten Nocebo-Effekt unter Therapie massiv forcieren und mitunter zu Fehldosierungen führen. Insbesondere bei pädiatrischen Indikationen wird er zudem zu hoher Unsicherheit und Aufklärungsbedarf in der Therapie führen. Gemäß den o.g. Ausführungen kann der Apotheker diesem Bedarf an dieser Stelle keine Abhilfe schaffen.

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. (Medac)

Ferner fordert medac folgerichtig den Gemeinsamen Bundesausschuss auf, dass bei einer Ersetzung eines biotechnologisch hergestellten biologischen verordneten Arzneimittels dieses Arzneimittel zusätzlich zu den Anforderungen gemäß §40(1) AM-RL i.V.m. §129(1a) SGB V mindestens mit allen Anwendungsgebieten des verordneten Arzneimittels übereinstimmt.

[...] Die Vorgaben zur wirtschaftlichen Verordnung von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln auf Arztebene wurden in §40a in der Arzneimittel-Richtlinie im November 2020 implementiert. Hier ist in Absatz 3 vorgegeben, dass Ein- und Umstellungen bei biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln nur dann erfolgen dürfen, wenn das verordnete biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel über eine Zulassung für die Indikation verfügt, für die es eingesetzt werden soll. Es wäre daher ein Widerspruch zu §40a(3) AM-RL, wenn in der Apotheke ein für die Indikation nicht zugelassenes Arzneimittel abgegeben würde.

MSD Sharp & Dohme GmbH

Als Unternehmen, das sich der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln zur Behandlung von Patienten verpflichtet hat, unterstützt MSD die Argumentation, die den Tragenden Gründen der Position B2 zugrunde liegt. Die nachfolgenden Argumente sind entscheidend, um der Position A, die besagt, dass das abzugebende Arzneimittel nur für ein gleiches Anwendungsgebiet zugelassen sein muss, mit Nachdruck entgegenzutreten:

1. Empfehlungen der EMA und HMA zur Austauschbarkeit von Biosimilars

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die Arzneimittelbehörden (Heads of Medicines Agencies, HMA) haben klare Richtlinien formuliert, die die Austauschbarkeit von Biosimilars nur unter der Bedingung empfehlen, dass diese die gleichen Anwendungsbedingungen gemäß ihren Fachinformationen aufweisen.

Vor diesem Hintergrund sollten insbesondere in Therapiegebieten mit freier Kombination von Biologika und weiteren Substanzen, wie z. B. Chemotherapeutika, auch für Biosimilars klinische Studiendaten vorliegen.

Dies ist entscheidend, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die therapeutischen Ergebnisse konsistent bleiben. Ein Austausch, der nicht auf diesen Richtlinien basiert, könnte potenziell die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Behandlung

beeinträchtigen und das Vertrauen in biotechnologisch hergestellte Arzneimittel untergraben.

2. Unkenntnis der Apotheker über die für die Verordnung ausschlaggebende Indikation des verordneten Medikaments

Der Apotheker ist in der Regel nicht über die spezifische verordnungsbedingte Indikation des verordneten Medikaments informiert. Diese Unkenntnis kann zu einem Austausch von Arzneimitteln führen, der nicht den individuellen Bedürfnissen des Patienten entspricht und der möglicherweise die Behandlungsergebnisse negativ beeinflusst, insbesondere wenn es zu mehrfachen Therapiewechsels kommt. Um die Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten, sollte für eine Austauschbarkeit als Mindestanforderung eine Zulassung im selben Anwendungsgebiet sichergestellt sein. Soweit eine Kenntnis der verordnungsbedingten Indikation nicht sichergestellt ist, kann in der Apotheke eine solche Prüfung der Austauschbarkeit nicht gewährleistet werden.

3. Fehlende Transparenz und Nachvollziehbarkeit für den behandelten Arzt

- A. Wenn ein Austausch von Arzneimitteln durch den Apotheker ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erfolgt, wird die Möglichkeit, die Therapie optimal auf die Bedürfnisse des Patienten abzustimmen, erheblich eingeschränkt. Der behandelnde Arzt hat das umfassendste Verständnis für die Krankengeschichte und die spezifischen Anforderungen des Patienten. Zudem können im Falle eines Austauschs ohne Wissen des Arztes unerwünschte Arzneimittelwirkungen nicht mehr eindeutig einem Arzneimittel zugeordnet werden. Mit Markteintritt von Biosimilars ist aktuell eine eindeutige Produktverordnung vom Arzt vorzunehmen. Sollte ein Austausch oder ein mehrmaliger Austausch auf eine vergleichbare Substanz stattfinden, könnten Informationslücken in Bezug auf Verträglichkeit und Wirksamkeit entstehen. Ebenso ist die notwendige Informationsweitergabe an z. B. Krebsregister nicht adäquat gewährleistet.

Novo Nordisk

Novo Nordisk spricht sich für die Position B1 + B2 aus und lehnt die Position A ab. An dieser Stelle verweist Novo Nordisk außerdem auf die Zusammenfassende Dokumentation vom 15. Juni 2023 sowie § 40b Absatz 1 Satz 2 AM-RL bezüglich der Übereinstimmung der Anwendungsgebiete des verordneten und auszutauschenden biologischen Fertigarzneimittels. Im Hinblick darauf, dass in dem durch § 40c (neu) angestrebten Fall erneut Position A zur Wahl steht, weist Novo Nordisk klar auf die Ablehnung dieser hin. Aus Sicht von Novo Nordisk sollte hier mindestens eine übereinstimmende und eindeutige Regelung zur Deckungsgleichheit der Anwendungsgebiete beim Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln nach § 40b (alt) und § 40c (neu) bestehen.

Novo Nordisk gibt zu bedenken, dass nicht grundsätzlich von einer deckungsgleichen Übereinstimmung der Anwendungsgebiete von Biosimilars ausgegangen werden kann. Die Vermeidung eines ungewollten Off-Label-Einsatzes eines biologischen Arzneimittels sollte in jedem Fall forciert werden. Die Therapieverantwortung liegt und sollte auch zukünftig bei den verordnenden Ärzt:innen liegen. Für den ärztlichen Austausch gilt gemäß § 40 Absatz 3 der AM-RL: „Voraussetzung für Umstellungen nach Absatz 1 Satz 2 ist, dass das verordnete biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel über eine Zulassung für die Indikation verfügt, für die es eingesetzt werden soll.“. Diese Regelung muss auch für die Apotheke gelten. Erschwerend kommt hinzu, dass die zugrundeliegende Indikation eines verordneten Arzneimittels der Apotheke in den meisten Fällen nicht bekannt ist. Eine mit den verordnenden Ärzt:innen nicht besprochene Off-Label-Anwendung kann bei Patient:innen zu Verwirrung und großen Unsicherheiten bezüglich des Arzneimittels führen, die im schlimmsten Fall in einer Unterbrechung oder einem Abbruch der Therapie oder einer fehlerhaften Anwendung resultieren, zumal Patient:innen bei Off-label-Anwendungen keine Anweisungen hierzu in der Gebrauchsinformation finden können. Zur Gewährleistung der Arzneimitteltherapiesicherheit

sollte sichergestellt werden, dass auszutauschende biologische Arzneimittel eine Deckungsgleichheit ihrer Anwendungsgebiete aufweisen. Dieses Vorgehen wird auch von der EMA empfohlen [59].

Außerdem kann es bei einem Off-Label-Einsatz zwangsweise zu Verletzungen des Patentschutzes durch die austauschenden Apotheker:innen kommen.

Novo Nordisk weist außerdem darauf hin, dass die EMA eine Extrapolation auf nicht zugelassene Anwendungsgebiete bei Biosimilars im Gegensatz zu Generika nicht uneingeschränkt als gegeben ansieht [46].

Nach Auffassung von Novo Nordisk sollte ein Austausch ausgeschlossen sein, wenn die Zulassung einer oder mehrerer Indikationen eines biologischen Fertigarzneimittels lediglich auf der Extrapolation vorgelegter Daten beruht.

Pfizer

[...] Eine zentrale Frage des vorliegenden Beschlusses ist, welche Voraussetzungen an die vom Gemeinsamen Bundesausschuss vorzunehmende Feststellung der Austauschbarkeit eines biologischen Referenzarzneimittels zu Biosimilars zu stellen sind. Wie sich aus § 129 Abs. 1a Satz 3 SGB V („unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit“) sowie § 129 Abs. 1a Satz 6 SGB V („Einsicht in die Zulassungsunterlagen“) ergibt, sollen jedenfalls **auch therapeutische wie zulassungsrechtliche Aspekte** eine Rolle spielen. Welche Rolle sie im Einzelnen spielen, ist eine Frage der Ausgestaltung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss:

- Die in dem Beschluss vorgesehene Position A zu § 40c (neu) Abs. 1 sieht vor, dass ein Austausch bereits dann möglich sein soll, wenn das jeweilige Biosimilar „für ein gleiches Anwendungsgebiet“ wie das biologische Referenzarzneimittel zugelassen ist. Dies wird damit begründet, dass dies einerseits von § 129 Abs. 1 Satz 2 SGB V verlangt werde, andererseits auch aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit keine weitergehenden Anforderungen erfüllt sein müssten.
- Dagegen sieht die Position B1 + B2 vor, dass das jeweilige Referenzarzneimittel nur gegen ein Biosimilar ausgetauscht werden kann, das mindestens für alle zugelassenen Anwendungsgebiete des Referenzarzneimittels zugelassen ist. Dies wird auch aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit für erforderlich gehalten (Tragende Gründe, Seite 4 f.). Hierzu wird auf die einschlägigen zulassungsrechtlichen Vorschriften verwiesen, die für die Zulassung indikationsspezifische Nachweise verlangen.

Das der Position A zugrundeliegende Argument, ein Austausch von biologischen Arzneimitteln müsse gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 SGB V bei Übereinstimmung von bereits einem gleichen Anwendungsgebiet zulässig sein, hält einer rechtlichen Prüfung nicht stand. Diese Position erkennt, dass nur solche biologischen Referenzarzneimittel der Substitution auf Apothekenebene unterliegen, bei denen die Austauschbarkeit vom Gemeinsamen Bundesausschuss **zuvor positiv festgestellt wurde**. Nach welchen Kriterien diese vorab zu treffende Feststellung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss zu erfolgen hat, wird jedoch gerade nicht gesetzlich näher spezifiziert. Insofern kann der Gemeinsame Bundesausschuss aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit die Feststellung der Austauschbarkeit selbstverständlich davon abhängig machen, dass die zugelassenen Anwendungsgebiete identisch sein müssen.

Angesichts der Besonderheiten bei biologischen Arzneimitteln halten wir es sogar für zwingend erforderlich (wie von der Position B1 + B2 vorgeschlagen), dass eine **vollständige Übereinstimmung der jeweils zugelassenen Anwendungsgebiete** vorliegt. Während bei generischen Arzneimitteln das Fehlen von Anwendungsgebieten im Vergleich zum Referenzarzneimittel „nur“ auf patentrechtlichen Gründen beruht, kann dies bei Biosimilars

59 EMA: Statement on the scientific rationale supporting interchangeability of biosimilar medicines in the EU, Apr 2023.

darüber hinaus auch dadurch begründet sein, dass nicht für jede einzelne Indikation des Referenzarzneimittels eine umfangreiche, aussagekräftige wissenschaftliche Begründung für die Extrapolation oder keine zusätzlichen Daten zum erforderlichen Nachweis der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vorgelegt wurden. Ohne einen solchen Nachweis ist es jedoch von vornherein nicht gerechtfertigt, dass Apotheken eigenverantwortlich das verordnete Referenzarzneimittel gegen ein Biosimilar austauschen sollen.

Im Übrigen besteht selbst bei dem in den Tragenden Gründen genannten Fall, in dem allein aufgrund patentrechtlicher Einschränkungen Indikationsunterschiede bestehen, ein **rechtliches Problem**. So hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 1. Dezember 2015 (Az.: VIII – Verg 20/15) [60] rechtskräftig entschieden, dass das SGB V und insbesondere die in § 129 SGB V enthaltene Regelungen zur Aut-idem Substitution **patentrechtskonform auszulegen und anzuwenden sind**. Wörtlich heißt es in dieser Entscheidung wie folgt:

„Das **SGB V, insbesondere dessen § 129 Abs. 1, steht** entgegen der Ansicht der Beschwerde **nicht über dem Patentrecht**, sondern hat dieses zu respektieren, zumal dem Patentrecht als geistigem Eigentum nach Art. 14 Abs. 1 GG ein grundrechtlicher Schutz zuzuerkennen ist. Aufgrund dessen **ist § 129 Abs. 1 SGB V im Licht des Art. 14 Abs. 1 GG auszulegen und ist das Patentrecht darin zu integrieren**, ohne dass, wie die Beschwerde meint, davon zu sprechen ist, dadurch werde, keineswegs auch in der Absicht des Senats liegend, eine Anwendung des § 129 Abs. 1 SGB V verworfen – was nach Art. 100 Abs. 1 GG allerdings eine Vorlage der Sache an das Bundesverfassungsgericht erforderte.“ (OLG Düsseldorf, a.a.O., Rn. 33, zitiert nach juris; Hervorhebung durch die Verf.)

Im Lichte dieser Rechtsprechung wird man daher zur Vermeidung eines rechtswidrigen Austausches – wie von der Position B1 + B2 vorgeschlagen – eine **vollständige Übereinstimmung der Anwendungsgebiete verlangen müssen**. Alles andere wäre sowohl patentrechtlich als auch verfassungsrechtlich unzulässig.

[...] Aus unserer Sicht dürfte über die Position B1 + B2 hinausgehend auch erforderlich sein, dass in denjenigen Fällen, in denen die zugelassenen Anwendungsgebiete des Biosimilars mit denjenigen des biologischen Referenzarzneimittels identisch sind, gleichwohl ein Austausch ausgeschlossen ist, wenn die Zulassung bestimmter Indikationen **lediglich auf einer Extrapolation von vorgelegten Daten** beruht:

Zwar ist nach den einschlägigen Guidelines der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) in bestimmten Fällen vorgesehen, dass der Wirksamkeits- und Unbedenklichkeitsnachweis für eine Indikation des Referenzarzneimittels auch im Wege der Extrapolation auf andere Indikationen erstreckt werden kann [61]. Danach ist eine Extrapolation von Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit aus der jeweils „sensitivsten“ Indikation des Referenzarzneimittels auf andere Indikationen des Referenzarzneimittels akzeptabel, wobei die Extrapolation den identischen Wirkmechanismus innerhalb der initialen und der extrapolierten Indikationen voraussetzt (z. B. Vermittlung der therapeutischen Wirkung über den gleichen Rezeptor, die gleichen Bindungsstellen, in gleichen Geweben).

Es handelt sich hierbei jedoch **allein um die zulassungsrechtliche Perspektive**. Mit anderen Worten geht es hierbei um den sicheren Verkehr mit Arzneimitteln, und betrifft damit vor allem die gefahrenabwehrrechtliche Regulierung des Vertriebsverhaltens von pharmazeutischen Unternehmen. Sie beantwortet damit jedoch allenfalls die Frage, welche Präparate therapeutisch gleichwertig und in der Regel **durch die Ärzte** austauschbar sind. Hiervon unberührt bleibt jedoch die Frage, wann eine automatische Substitution **auf Apothekenebene** vertretbar erscheint, wie von der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) betont wurde.

60 OLG Düsseldorf: Beschluss vom 01.12.2015, Aktenzeichen VII-Verg 20/15. 2015. https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2015/VII_Verg_20_15_Beschluss_20151201.html

61 EMA: Guideline on similar biological medicinal products. Rev 1, 2014.

Eine Übereinstimmung der zugelassenen Anwendungsgebiete stellt damit **allenfalls ein Indiz für eine potenziell zulässige Substitution auf Apothekenebene** dar. Sofern eine oder mehrere Indikationen des jeweiligen Biosimilars im Wege der Extrapolation von klinischen Daten zugelassen wurden, fehlt es jedoch aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit an einer Rechtfertigung für einen automatischen Austausch auf Apothekenebene [62]. Es bedarf vielmehr klinischer Daten für die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit **aller jeweiligen Indikationen**, damit es gerechtfertigt ist, biologische Arzneimittel, die lediglich wirkstoffähnlich sind, den wirkstoffgleichen Generika auf Apothekenebene gleich zu stellen. Alles andere wäre aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit nicht vertretbar.

Ob derartige klinische Daten vorliegen, ergibt sich aus den öffentlich zugänglichen produktspezifischen Bewertungsberichten (EPAR) des Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), die auf den Internetseiten der EMA abrufbar sind.

Roche Pharma AG (Roche)

Ein Austausch des Referenzarzneimittels darf nur erfolgen, wenn die Biosimilars für die gleichen Anwendungsgebiete in gleicher Applikations- und Darreichungsform zugelassen sind. Die Aufnahme eines Biosimilars auf die Liste der automatisch zu substituierenden Arzneimittel bei unterschiedlichen Anwendungsgebieten ist abzulehnen (zu Absatz 1 Position B1 + B2).

ABDA, AMK

Hinsichtlich der Pflicht zur Ersetzung des verordneten Arzneimittels durch ein wirkstoffgleiches, preisgünstiges Arzneimittel, welches in Wirkstärke und Packungsgröße identisch ist und die gleiche oder eine austauschbare Darreichungsform gemäß § 40 Absatz 1 AM-RL i. V. m. § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V besitzt, hält es die ABDA für dringend geboten, dass dieses Arzneimittel mindestens mit allen Anwendungsgebieten des verordneten Arzneimittels übereinstimmt (vgl. Position B1 und B2).

Sollte die Zulassung eines abzugebenden Biosimilars in einer Indikation oder mehreren spezifischen, patientenindividuell maßgeblichen Indikationen nicht mit dem verordneten Biologikum übereinstimmen, führt dies unweigerlich zur Verunsicherung der Betroffenen, mit der Gefahr für die Therapietreue (Adhärenz), dem Risiko von Anwendungsfehlern und damit der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) oder weiterer unerwünschter Effekte, z. B. Nocebo-Effekt.

Unter der Prämisse, dass das abzugebende Arzneimittel in nur einem Anwendungsgebiet mit dem verordneten Arzneimittel übereinstimmt (Position A), benötigt der Apotheker/die Apothekerin die ausschlaggebende Indikation, die jedoch nicht der (elektronisch) vorliegenden Verordnung entnommen werden kann. Den genannten Risiken für die Patienten- und Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) können die Apotheken somit auch nicht im Rahmen einer angemessenen Beratungsleistung begegnen. Hierzu bedürfte es eines rechtssicheren und konsequenten Informationsaustauschs notwendiger erkrankungsspezifischer Aspekte zwischen Verordner und abgebender Apotheke.

Des Weiteren stimmen wir den Ausführungen der Position B1 und B2 in den tragenden Gründen zu, wonach der Komplexität und den Besonderheiten der Biologika entsprechend, zusätzliche Erfordernisse zur Vorlage toxikologischer, präklinischer und klinischer Daten im Rahmen der Biosimilar-Zulassung erforderlich sind und demnach nicht von einer bedingungslosen Genehmigung der Extrapolation der Indikationserweiterungen auszugehen ist. Abweichend von dem in § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V für den Regelfall festgelegten Grundsatz ist daher für Biologika nach Maßgabe des Auftrags an den Richtliniengeber einzuschränkend anzuordnen, dass ein Austausch nur für solche Arzneimittel ermöglicht wird, die mindestens für dieselben Anwendungsgebiete zugelassen sind. Nur in diesem Fall liegt eine

62 EMA: Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. Rev 1, 2014.

entsprechende Prüfung der Sicherheitsdaten durch die Zulassungsbehörde vor.

BPI

In §40b der Arzneimittel-Richtlinie ist bereits geregelt, dass ein Austausch auf Apothekerebene für parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten nur dann zulässig ist, wenn das abzugebende biotechnologisch hergestellte biologische Fertigarzneimittel mindestens für dieselben Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels zugelassen ist. Die Gründe für diese Festlegung gelten hier ebenso. Eine Diskussion, ob es ausreicht, dass ein in der Apotheke substituiertes abzugebendes biotechnologisch hergestelltes biologisches Fertigarzneimittel für ein gleiches Anwendungsgebiet des verordneten Arzneimittels zugelassen sein muss (Position A), ist an dieser Stelle unverständlich und unnötig.

Das Erfordernis der Übereinstimmung der zugelassenen Anwendungsgebiete bei der Substitution (Position B1 und B2) ergibt sich insbesondere aus folgenden Gründen:

Arzneimittelsicherheit: Biosimilars unterliegen im Gegensatz zu Generika aus Gründen des Gesundheitsschutzes erheblich strengeren Zulassungsanforderungen, insbesondere wegen Unterschieden bei Herstellung und Ausgangsstoffen. Die EU-Richtlinie 2001/83/EG fordert für Biosimilars im Einzelfall zusätzliche präklinische und klinische Daten – besonders dann, wenn mehrere Indikationen vorliegen. Die Zulassungsbehörde muss im Einzelfall prüfen, ob Daten aus einer Indikation auf andere übertragen (extrapoliert) werden dürfen. Die EMA-Guidelines erlauben eine Extrapolation nur mit wissenschaftlich fundierter Begründung und betonen Fälle, in denen zusätzliche Daten erforderlich sind (z. B. bei mehreren Wirkorten oder verschiedenen Wirkmechanismen).

Interpendenz mit ärztlichen Verordnungsgrundlagen: Die Vorgaben zur wirtschaftlichen Verordnung von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln auf Arzzebene wurden in § 40a in der Arzneimittel-Richtlinie im November 2020 implementiert. Hier ist in Absatz 3 vorgegeben, dass Ein- und Umstellungen bei biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln nur dann erfolgen dürfen, wenn das verordnete biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel über eine Zulassung für die Indikation verfügt, für die es eingesetzt werden soll. Dies würde konterkariert, wenn in der Apotheke ein für die Indikation nicht zugelassenes Arzneimittel abgegeben würde.

Ärztliche Aufklärungspflicht und haftungsrechtliche Risiken bei Substitution, insbesondere nicht zugelassener Indikationen: Die im vorliegenden Beschlussentwurf vorgesehene Möglichkeit des automatischen Austauschs biologischer Arzneimittel in Apotheken wirft erhebliche haftungsrechtliche und medizinethische Fragen auf, insbesondere im Zusammenhang mit der Indikationstreue.

Ein zentraler Grundsatz der Arzneimitteltherapie ist, dass die abgegebenen Präparate für die konkrete Erkrankung des Patienten zugelassen sein müssen. Im Fall der Substitution durch ein Biosimilar, dessen Zulassung sich nicht auf alle Indikationen des Referenzprodukts erstreckt – etwa, weil keine wissenschaftlich anerkannte Extrapolation vorliegt –, liegt ein Off-Label-Use vor. Rechtlich ist dies nur unter strengen Voraussetzungen zulässig, insbesondere:

- *ausdrückliche und dokumentierte Zustimmung des Patienten nach umfassender ärztlicher Aufklärung (§§630d 630e BGB),*
- *medizinische Vertretbarkeit des Einsatzes und*
- *Kenntnis des Arztes über das konkret abgegebene Arzneimittel.*

Im Fall eines automatisierten Austauschs in der Apotheke entfällt jedoch regelmäßig die Möglichkeit des Arztes, seiner gesetzlichen Aufklärungspflicht nachzukommen. Der Patient wird unter Umständen mit einem Arzneimittel behandelt, für dessen Anwendung in der konkreten Indikation keine Zulassung vorliegt, ohne dass er darüber informiert wurde. Dies stellt ein erhebliches juristisches Risiko dar – sowohl für den Arzt, der ohne sein Wissen in eine potenziell haftungsauslösende Therapieentscheidung einbezogen wird, als auch für den

Patienten, dem ein rechtlich und medizinisch nicht abgesicherter Wirkstoff verabreicht wird.

Die Option des Aut-idem-Ausschlusses stößt schließlich auf faktische Grenzen. Denn im Rahmen der derzeitigen gesetzlichen und rahmenvertraglichen Vorgaben kann nicht gewährleistet werden, dass Ärztinnen und Ärzte keine Nachteile in Bezug auf Wirtschaftlichkeitsprüfungen befürchten müssen, wenn sie den Austausch durch das Setzen des aut idem-Kreuzes bei der Verordnung von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln (Original/Referenzprodukts oder im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologische Arzneimittels) ausschließen.

Die automatische Substitution durch die Apotheke konterkariert grundsätzlich das Regelungsziel des §40a der AM-RL und bietet für die Behandelnden nur eine unzureichende Möglichkeit, Haftungsrisiken zu minimieren. Es ist zumindest unbedingt erforderlich, dass ausschließlich solche Biologika ausgetauscht werden dürfen, die in allen relevanten Indikationen (einschließlich der konkret beim Patienten vorliegenden Erkrankung) zugelassen sind. Ohne diese Absicherung entsteht eine untragbare rechtliche Grauzone, die Patientensicherheit gefährdet und ärztliche Verantwortung delegitimiert.

Pharma Deutschland

Bezüglich der Anwendungsgebiete ist in Absatz 1 aus Sicht von Pharma Deutschland zwingend der Positionen B1 und B2 zu folgen, da das abzugebende Arzneimittel mindestens für alle Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels zugelassen sein muss. Eine anderslautende Regelung stellt einerseits die Haftung des pharmazeutischen Unternehmers andererseits die Haftung des Verordners in Bezug auf einen durch die Substitution in der Apotheke erfolgten Off-Label-Use in Frage, insbesondere wenn noch ein erweiterter Unterlagenschutz bezüglich einzelner Anwendungsgebiete beim verordneten Fertigarzneimittel bestehen. Zudem ist die Besonderheit biotechnologisch hergestellten Biologika insbesondere hinsichtlich der gültigen Zulassungsbedingungen auch rechtlich gesehen zu berücksichtigen. Die rechtliche Ableitung der in Position A aufgeführten Argumente überzeugen insofern nicht, da § 129 Absatz 1a SGB V ähnlich der Regelung zur Substitutionsausschlussliste eine Spezielle ist. § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V gilt ausschließlich „für im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel, für die der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 eine Austauschbarkeit in Bezug auf ein biologisches Referenzarzneimittel festgestellt hat.“

Pro Generika

*[...] Die Notwendigkeit einer übereinstimmenden Zulassung erstreckt sich allerdings deutlich über die Applikationsform hinaus. Zurecht fordern die Positionen B1 + B2, dass ein Austausch von Biosimilars in der Apotheke nur dann erfolgen darf, wenn das substituierte Arzneimittel für **sämtliche** Anwendungsgebiete des Referenzprodukts zugelassen ist.*

Die Zulassung eines Arzneimittels nach § 21 AMG erfolgt stets indikations- und applikationsspezifisch und stellt die rechtliche Grundlage für eine zulässige Anwendung dar. Diese Zweckbindung wirkt auch auf die Abgabe durch Apotheken an Patienten, da sie ein Inverkehrbringen im Sinne des § 4 Abs. 17 AMG darstellt und somit der Zulassungspflicht unterliegt.

Eine ärztlich begründete Indikation ist der Apotheke im Rahmen der Arzneimittelabgabe nicht bekannt. Daher kann bei der automatischen Substitution nicht geprüft werden, ob das Ersatzarzneimittel für die konkret intendierte Anwendung zugelassen ist. Ohne eine vollständige Übereinstimmung der zugelassenen Anwendungsbereiche besteht die reale Gefahr einer Abgabe außerhalb des Zulassungsrahmens – mit entsprechenden haftungsrechtlichen Risiken. Die Forderung nach einer Substitution ohne Zulassungsidentität ist daher unverantwortlich, die Umsetzung wäre rechtlich unzulässig.

Dieser Befund wird auch durch die geltende Regelung des § 40a Abs. 3 der Arzneimittel-Richtlinie gestützt. Dort ist ausdrücklich festgelegt, dass bei einer ärztlich vorgenommenen Ein-

oder Umstellung auf ein biotechnologisch hergestelltes biologisches Fertigarzneimittel Voraussetzung ist, dass dieses für die betroffene Indikation zugelassen ist. Es wäre in höchstem Maße widersprüchlich, wenn der Arzt an diese Vorgabe gebunden wäre, der Apotheker hingegen durch das Substitutionsgebot verpflichtet sein könnte, ein Arzneimittel abzugeben, das für die konkrete Indikation nicht zugelassen ist. Die Folge wären Konstellationen, in denen eine ärztlich begründete Therapieumstellung rechtlich unzulässig wäre, die Apotheke aber zur Substitution im Rahmen eines Rabattvertrags verpflichtet wäre – mit der Konsequenz einer zulassungsüberschreitenden Arzneimittelanwendung und den damit verbundenen aber im Detail völlig ungeklärten haftungsrechtlichen Konsequenzen.

Hinzu kommt ein versorgungsrelevanter Aspekt: Weicht die zugelassene Indikationsbreite des abgegebenen Arzneimittels von derjenigen des verordneten ab, ist dies über die Gebrauchsinformation auch für Patienten sichtbar. Wenn dort die eigene Erkrankung nicht genannt wird, obwohl diese zuvor Gegenstand der ärztlichen Verordnung war, kann dies Vertrauen und Therapietreue untergraben. Solche Nocebo-Effekte sind insbesondere bei chronisch erkrankten Patientengruppen mit biotechnologischen Therapien nicht auszuschließen. Dieser Zusammenhang unterscheidet sich grundlegend von parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung, bei denen Patienten regelmäßig keinen direkten Kontakt zu den jeweiligen Fachinformationen haben. Im Verfahren zu § 40b SGB V („Parenteralia-Beschluss“) blieb dieser Aspekt deshalb im Hintergrund – eine Übertragbarkeit auf die Substitution von Fertigarzneimitteln besteht indes nicht.

Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang, dass hinsichtlich einer Zulassungserweiterung regelhaft keine automatische Extrapolation erfolgt. Vielmehr erfolgt eine Einzelfallprüfung durch die Zulassungsbehörde in Form eines gezielten und wissenschaftlich begründeten Verfahrens, das je nach vorliegender Evidenz auch in einer Ablehnung oder Einschränkung der Extrapolation münden kann. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es eben keine bedingungslose Genehmigung der Extrapolation seitens der EMA gibt, hat der G-BA bereits im Verfahren zur Austauschbarkeit von Parenteralia festgestellt: Eine Substitution ist nur zulässig, wenn eine vollständige Übereinstimmung der zugelassenen Indikationsgebiete vorliegt.

Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass die Position A weiterhin an einer Austauschbarkeit festhält, auch wenn das substituierende Arzneimittel nicht für alle Indikationsgebiete zugelassen ist und somit eine Umgehung der arzneimittelrechtlich vorgesehenen Einzelfallprüfung anregt.

Nicht zuletzt hat auch das Bundessozialgericht (BSG) mit seinem Urteil B 1 KR 37/00 R deutlich gemacht, dass eine Verordnung außerhalb der zugelassenen Anwendungsgebiete nur unter engen Voraussetzungen zulässig ist [63]. Diese rechtlichen Anforderungen werden im Kontext der Substitution biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel regelhaft nicht erfüllt.

vfa

Position A sieht vor, dass für die Austauschbarkeit eines Arzneimittels lediglich ein gleiches Anwendungsgebiet zugelassen sein muss. Das sieht der vfa sehr kritisch, da es Unterschiede in den zugelassenen Anwendungsgebieten zwischen Referenzarzneimitteln und Biosimilars sowie zwischen den Biosimilars untereinander geben kann. Diese Unterschiede sind zum einen darauf zurückzuführen, dass ein Biosimilar-Hersteller nicht alle Indikationen des Referenzproduktes per Extrapolation bei der europäischen Zulassungsagentur EMA beantragt bzw. beantragen muss. Zum anderen sind auch unterschiedlich lange Patentlaufzeiten für die verschiedenen Indikationen zu berücksichtigen, sodass ein Austausch in der Apotheke – wenn nur ein Anwendungsgebiet übereinstimmen muss – zu nicht tolerierbaren Patentrechtsverletzungen führen kann. Davon völlig unbenommen haben die Apotheker:innen keine Kenntnis über die

spezifische verordnungsbedingte Indikation. Diese ist nicht auf dem Rezept vermerkt und Patient:innen sind in der Apotheke nicht zur Auskunft darüber verpflichtet. Dies kann auch dazu führen, dass ein Biopharmazeutikum ausgetauscht wird und dann das Austauschpräparat in einem nicht zugelassenen Anwendungsgebiet, also off-label, eingesetzt wird. Aufgrund der damit einhergehenden Risiken für Patient:innen müssen diese Fälle dringend vermieden werden. Ein Austausch darf demnach nur erfolgen, wenn das substituierende Arzneimittel – wie in Position B1 + B2 nachvollziehbar gefordert – mindestens für alle zugelassenen Anwendungsgebiete des verordneten Produktes zugelassen ist. Den Apotheken fehlt schlichtweg die Information über die verordnete Indikation – eine sichere Substitution ist daher nicht möglich.

VZA

In Bezug auf Satz 3 ist der Position B 1 + B 2 zuzustimmen. Position A ist zu verwerfen.

Das Arzneimittelzulassungsrecht für Biologika gebietet es, dass das abzugebende Biosimilar mindestens für die Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels zugelassen ist. Dafür sprechen die in den Tragenden Gründen vorgebrachten zulassungsrechtlichen Argumente sowie Bedenken hinsichtlich der Arzneimitteltherapiesicherheit. Das Zulassungsverfahren der EMA kennt keine automatische, bedingungslose Genehmigung der Extrapolation.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass Apotheken andernfalls zu patentrechtlichen Verstößen angehalten würden (vgl. Gaßner, PharmR 2021, 53 ff., Deckers/Püschel, A&R 2022, 288 ff. und Beschlüsse des OLG Düsseldorf zur Relevanz von Patentrechten als Eigentumsrecht, Beschluss v. 01.12.2015, VII-Verg 20/15, Rn. 32; Beschluss v. 21.04.2021, VII-Verg 1/20). Dem sollte der G-BA durch untergesetzliche Normgebung nicht Vorschub leisten.

Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ)

Mit dem neuen § 40c Absatz 1 soll klargestellt werden, dass auch für die Ersetzung wirkstoffgleicher biologischer Arzneimittel durch Apotheken Voraussetzung ist, dass das abzugebende Arzneimittel mit dem verordneten in Wirkstärke und Packungsgröße identisch ist sowie die gleiche oder eine austauschbare Darreichungsform gemäß § 40 Absatz 1 AM-RL i. V. m. § 129 Absatz 1a SGB V besitzt. Weiterhin ist zu entscheiden, ob das verordnete und das abgegebene Arzneimittel für ein gleiches Anwendungsgebiet ODER das abgegebene Arzneimittel mindestens für die Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels zugelassen ist.

Die AkdÄ weist darauf hin, dass ein Biosimilar in der Regel für alle Indikationen des Referenzprodukts zugelassen ist, aber in Ausnahmefällen auch weniger Indikationen oder Anwendungsarten haben kann, z. B. wegen patentrechtlicher Einschränkungen in manchen EU-Ländern. Auch können Indikationen fehlen, da die erforderliche Dosisstärke nicht verfügbar ist (z. B. pädiatrische Indikationen). Allerdings war bis dato kaum ein Biosimilar in der EU zum Zeitpunkt seiner Zulassung für alle Indikationen des Referenzarzneimittels zugelassen. Auch zwischen einzelnen Biosimilars zum selben Referenzarzneimittel bestehen z. T. erhebliche Unterschiede bezüglich der zugelassenen Indikationen [64].

Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt die Markteinführung in der Regel zeitnah nach der Zulassung. Ein Biosimilar würde nach dem neuen § 40c AM-RL sofort für die automatische Substitution zur Verfügung stehen, sobald es auf dem deutschen Arzneimittelmarkt verfügbar ist. Dies würde bedeuten, dass Patienten, die seit Jahren ein Referenzarzneimittel bzw. ein Biosimilar erhalten, ein anderes Biosimilar bekommen könnten, bei dem die jeweilige Erkrankung des Patienten nicht einmal in der Gebrauchsinformation des Arzneimittels erwähnt ist. Es ist sicherlich nachvollziehbar, dass ein Patient mit z. B. rheumatoider Arthritis verunsichert wäre, wenn das Arzneimittel, das er in der Apotheke als Austauschpräparat

bekommt, z. B. nur bei chronischer lymphatischer Leukämie zugelassen ist (z. B. bei Rituximab-Biosimilars). Um etwaige Verunsicherung und die damit verbundenen Adhärenzprobleme und Nocebo-Effekte zu vermeiden, muss das Arzneimittel, das abgegeben wird, mindestens für die Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels zugelassen sein.

Dabei geht es nicht um die Frage, ob ein Biosimilar zum Zeitpunkt der Abgabe/des Austausches in der Apotheke in der nicht zugelassenen Indikation wirksam oder sicher ist. Auch wenn die Arzneimittelsicherheit als gegeben anzunehmen ist, würde die Arzneimitteltherapiesicherheit kompromittiert werden, wenn Patienten biologische Arzneimittel erhalten, die nicht für ihre Erkrankung zugelassen sind.

Auch wenn das Verfahren zur Erweiterung der Anwendungsgebiete von Biosimilars formal arzneimittelrechtlich dem auch für Generika einschlägigen Verfahren entspricht, kann daraus nicht geschlussfolgert werden, dass es angemessen sei, in der Folge auch für Biosimilars die gesetzliche Regelung des § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V anzuwenden. Biosimilars sind – wie mehrfach von der AkdÄ ausgeführt [65] – keine Generika. Somit ist es aus Sicht der AkdÄ weder zweckmäßig noch zulässig Regelungen, die bei Generika Anwendung finden, undifferenziert auf Biosimilars zu übertragen, ohne ihre Folgen für die Arzneimitteltherapiesicherheit, die Therapietreue und das Patientenwohl zu hinterfragen.

Die initial aus patentrechtlichen Gründen nicht zugelassenen Indikationen des Referenzarzneimittels werden für die jeweiligen Biosimilars nachträglich erweitert, wenn der (Verwendungs-)Patentschutz ausgelaufen ist. Mit solchen nachträglichen Erweiterungen um zusätzliche Anwendungsgebiete würde das jeweilige Biosimilar automatisch austauschbar in allen Indikationen des Referenzarzneimittels werden. Gleichzeitig wäre die Gefahr für die bereits erwähnten Adhärenz- und Nocebo-Probleme, die bei Biologika/Biosimilars per se auftreten können, zumindest nicht erhöht.

Nocebo-Effekte umfassen negative Reaktionen auf pharmakologisch inerte Interventionen im Forschungssetting und negative Effekte bei aktiven Behandlungen in der klinischen Forschung oder in der Praxis, einschließlich neuer oder sich verschlechternder Symptome und Nebenwirkungen, die nicht auf die pharmakologische Wirkung der Behandlung selbst zurückzuführen sind, sondern auf der Basis von Wissen und Erwartungen des Patienten und des behandelnden Arztes über die schädlichen Auswirkungen einer Therapie entstehen. Zahlreiche persönliche, psychosoziale, neurobiologische und kontextuelle/umweltbezogene Faktoren tragen zur Entstehung von Nocebo-Effekten bei, die die Lebensqualität und die Therapieadhärenz beeinträchtigen können. In klinischen Studien wurden sog. Nocebo-Effekte durch die Umstellung der Therapie mit einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar berichtet [66, 67, 68, 69]. Sie treten in offenen Studien häufiger als in doppelblinden Studien auf und führen zu frühzeitigen Therapieabbrüchen aufgrund von häufig nicht objektivierbarem Wirkverlust oder Nebenwirkungen.

Aus Sicht der AkdÄ wäre Position B1+B2 eine gute Lösung, um die Akzeptanz von Biosimilars bei den Patienten zu verbessern und dabei das Risiko für Nocebo-Effekte nicht zu erhöhen.

Die AkdÄ schließt sich der Position B1+B2 an. Position A wird abgelehnt.

DGRh

65 AkdÄ: Leitfaden Biosimilars. 2. Auflage, Version 1.0. Januar 2021.

66 Boone NW et al. (2018): The nocebo effect challenges the non-medical infliximab switch in practice. Eur J Clin Pharmacol;74(5):655-61.

67 Odinet JS et al. (2018): The Biosimilar Nocebo Effect? A Systematic Review of Double-Blinded Versus Open-Label Studies. J Manag Care Spec Pharm;24(10):952-9.

68 Kravvariti E et al. (2018): Nocebos in rheumatology: emerging concepts and their implications for clinical practice. Nat Rev Rheumatol; 14(12): 727-740.

69 Tweehuysen L et al. (2018): Subjective Complaints as the Main Reason for Biosimilar Discontinuation After Open-Label Transition From Reference Infliximab to Biosimilar Infliximab. Arthritis Rheumatol;70(1):60-8.

Durch die Apotheken darf selbstverständlich nur auf ein Biosimilar gewechselt werden, welches für die verordnete Indikation in der entsprechenden Dosierung zugelassen ist. Ein versehentlicher Wechsel in eine Off-Label-Situation – mit allen damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen für die verordnenden Ärztinnen und Ärzte – muss unter allen Umständen ausgeschlossen werden.

[...] Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte stimmt die DGRh aber dem Austausch biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel durch Apotheken grundsätzlich zu.

Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen (DGVS), gemeinsam mit Kompetenznetz Darmerkrankungen e.V. und Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands (bng)

Hier ist unbedingt der Position B1 + B2 zuzustimmen, da nur Arzneimittel hier abgegeben werden dürften, die auch für das entsprechende Anwendungsgebiet zugelassen sind.

3.1.5 Weitere Einwände

AbbVie

Position A („Das abzugebende Arzneimittel muss mindestens für die Applikationsarten des verordneten Arzneimittels sowie für ein gleiches Anwendungsgebiet zugelassen sein.“) ist abzulehnen, da sie die Patientensicherheit gefährdet. Zwischen dem Originalprodukt und dessen Biosimilars, sowie zwischen den Biosimilars selbst untereinander können Unterschiede in den zugelassenen Anwendungsgebieten bestehen. In so einem Fall könnte es beim Austausch in der Apotheke zum off-label-Einsatz des Biologikums kommen. Zudem können sich Original und Biosimilars aus regulatorischer Sicht voneinander unterscheiden. Biosimilars stehen oft unter stärkerer Überwachung als das Original, zu erkennen am „schwarzen Dreieck“.

Biogen

Da die Wirkstoffe bei Biosimilars lediglich im Wesentlichen, nicht jedoch vollständig identisch sind, wäre eine automatische Substitution auf Basis von Position A nicht vertretbar. Vielmehr stellt eine Zulassung in mindestens denselben Anwendungsgebieten, wie von Position B1 + B2 dargelegt, eine zwingende Mindestvoraussetzung für eine Substitution dar.

Lilly Deutschland GmbH (Lilly)

Die Therapiehoheit des Arztes ist ein wesentliches Element in der Ausübung und Verantwortlichkeit seiner ärztlichen Tätigkeit und sollte einzig und allein bei diesem verankert sein. Die Therapieentscheidung des Arztes sollte grundsätzlich primär auf medizinischen Gründen beruhen. Erst sekundär sollten administrative und wirtschaftliche Aspekte in die Entscheidung für oder gegen eine gewisse Therapie einbezogen werden. Insbesondere infolge einer automatischen Umstellung eines gut eingestellten Patienten von einem biologisch hergestellten Arzneimittel auf ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel, ohne vorliegende medizinische Gründe, wird der Fokus vielmehr auf die Wirtschaftlichkeit gelegt und verlagert die beim Arzt verankerte Verantwortlichkeit der Therapieauswahl weitreichend auf Apotheken und dessen Fachpersonal, denen patientenindividuelle und erkrankungsspezifische Aspekte in der Regel unbekannt sind.

Bei der Ersteinstellung eines Patienten auf eine neue Therapie können dem behandelnden Arzt vereinzelt patientenindividuelle und bzw. oder erkrankungsspezifische Aspekte, die eine Berechtigung zum Ausschluss der Substitution über ein „aut idem“-Kreuz darstellen, unbekannt sein und sich erst im späteren Verlauf der Therapie ergeben. Dadurch kann sich eine aus ärztlicher Sicht patientenindividuelle Gefährdung des Therapieerfolgs durch eine Ersetzung des Arzneimittels in der Apotheke erst nach der Ersteinstellung ergeben, wodurch der Patient im Folgenden von einem eigentlich verzichtbaren Therapiewechsel betroffen ist. Dies stellt aus der

Sicht von Lilly eine unnötige Gefährdung der Therapieadhärenz und letztlich der Patientensicherheit dar. Das zusätzliche Eingreifen der Apotheke in die Therapie eines Patienten kann gegebenenfalls einen Nocebo-Effekt hervorrufen und damit das therapeutische Ziel gefährden. Dieser Effekt kann im Verlauf der Therapie noch verstärkt werden, wenn die folgende Verschreibung durch ein weiteres Biosimilar ausgetauscht wird. Eine Abgabe eines Biosimilars an den Patienten, welches schlussfolgernd in Bezug auf die Position A zudem weniger Indikationen als das Originalarzneimittel aufweist, kann zudem verstärkt Verunsicherungen beim Patienten auslösen und dessen Therapieadhärenz weitreichend negativ beeinflussen. Vielmehr sollte in diesem Zusammenhang zumindest zwingend gegeben sein, dass das ausgetauschte biologische Arzneimittel mindestens für die Anwendungsgebiete des ursprünglich verordneten Arzneimittels zugelassen ist (Position B1 + B2).

Novartis

Ein Bezug zur genauen Zulassung und zum gleichen übereinstimmenden Anwendungsgebiet eines Biologikums, für das es verordnet werden soll, gilt bei der ärztlichen Verschreibung nach § 40a, Absatz 3 der Arzneimittel-Richtlinie zur ärztlichen Umstellung und Austausch von Therapien: „Voraussetzung für Umstellungen nach Absatz 1 Satz 2 ist, dass das verordnete biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel über eine Zulassung für die Indikation verfügt, für die es eingesetzt werden soll“. Dieser Bezug darf auf Apothekenebene nicht umgangen werden können.

Im Zulassungsverfahren von Biosimilars wird in der Regel der Nachweis der Wirksamkeit in einer Indikation als ausreichend für die Erteilung der Zulassung in allen Indikationen des Referenzarzneimittels angesehen. Sobald die Vergleichbarkeit zum Referenzarzneimittel vorliegt, verzichtet die EMA auf zusätzliche Studien [65]. Dieses Zulassungsverfahren, ähnlich dem von Generika, sieht Novartis nicht als ausreichende Grundlage für eine risikofreie automatische Substitution für Indikationen ohne nachgewiesene Evidenz und darauf basierender Zulassung (für die in Rede stehende Indikation).

Dies zeigt auch folgendes konkretes Beispiel für Omlyclo® im Anwendungsgebiet Asthma (Biosimilar zu dem Novartis-Arzneimittel Xolair®). Xolair® (Wirkstoff: Omalizumab) ist zugelassen als Zusatztherapie für die Behandlung von schwerem allergischem Asthma, von schwerer chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen und von chronischer spontaner Urtikaria gemäß den Angaben der Fachinformation [33]. Bei der Behandlung von schwerem, IgE-vermitteltem allergischem Asthma richtet sich Xolair® damit an ein besonders vulnerables Patientenkollektiv mit hoher Sensitivität gegenüber allergenen Reizen und einem erhöhten Risiko für anaphylaktische Ereignisse [70, 71].

Die Zulassung von Omlyclo® basiert ausschließlich auf klinischen Studien zur chronischen spontanen Urtikaria, nicht jedoch auf Daten zum Einsatz bei schwerem allergischem Asthma [72, 73]. Somit fehlt die Evidenz zur Wirksamkeit und Sicherheit bei genau jener Indikation, in der das Risiko für anaphylaktische Reaktionen besonders hoch ist [72]. Biosimilars zu Omalizumab wie Omlyclo® sind zwar strukturell sehr ähnlich, jedoch auf Basis der Proteinstruktur nicht identisch – insbesondere hinsichtlich der Glykosylierungsmuster [72]. Diese Unterschiede könnten bei hochsensiblen Patienten immunologische Reaktionen bis hin zu lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schocks auslösen [73].

ADKA

Die ADKA begrüßt grundsätzlich, dass im Rahmen der geplanten Regelung zur Substitution

70 DuToit G et al. (2024): Identifying patients at risk of anaphylaxis. World Allergy Organ J;17(6):100904.

71 Mikhail I et al. (2021): Fatal Anaphylaxis: Epidemiology and Risk Factors. Curr Allergy Asthma Rep;21(4):28.

72 Omlyclo: EPAR.

73 Jourdain H et al. (2023): Severe Hypersensitivity Reactions at Biosimilar versus Originator Rituximab Treatment Initiation, Switch and Over Time: A Cohort Study on the French National Health Data System. BioDrugs;37(3):397-407.

biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel in Apotheken klare Kriterien zur Austauschbarkeit formuliert werden.

Allerdings weist die ADKA darauf hin, dass der Austausch eines Biologikums nur dann patientensicher erfolgen kann, wenn die zugelassene Indikation des abzugebenden Arzneimittels auch mit der tatsächlichen, patientenindividuellen Indikation übereinstimmt. Es genügt nicht, dass das Präparat formal für „ein gleiches Anwendungsgebiet“ zugelassen ist. Entscheidend ist, dass die konkrete Indikation der Patientin oder des Patienten von der Zulassung des substituierten Arzneimittels abgedeckt ist.

Eine fehlende Indikationsübereinstimmung kann bei Patientinnen und Patienten zu Verunsicherung führen, die Adhärenz gefährden und Nocebo-Effekte auslösen – mit potenziell negativen Auswirkungen auf den Therapieerfolg. Dies gilt insbesondere im sensiblen Bereich der Biologikatherapie, in dem viele Betroffene bereits eine lange Krankheitsgeschichte, komplexe Therapieverläufe und ein hohes Informationsbedürfnis mitbringen.

Bewertung zu den Einwänden 3.1.4.1 bis 3.1.5:

Die Stellungnehmenden lehnen die Position A ab, da damit die Patientensicherheit gefährdet werde und Patienten verunsichert würden. Aus Sicht der Stellungnehmenden bestünden sowohl zwischen Referenzarzneimittel und dessen Biosimilars als auch zwischen Biosimilars untereinander Unterschiede in den zugelassenen Anwendungsgebieten. Im Unterschied zu generischen Arzneimitteln, bei denen fehlende Anwendungsgebiete allein auf patentrechtliche Gründe (z. B. Einschränkungen in manchen EU-Ländern oder pädiatrische Anwendungsgebiete mit abweichenden Wirkstärken) zurückzuführen wären, könne dies bei Biologika auch im Fehlen einer aussagekräftigen wissenschaftlichen Begründung für die Extrapolation oder sogar der kompletten Daten zum erforderlichen Nachweis der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit begründet sein.

Unter der Regelung gemäß Position A käme es beim Austausch in der Apotheke zu einem Off-Label-Einsatz, da nicht sichergestellt sei, dass das überschneidende Anwendungsgebiet das des betroffenen Patienten ist. Eine Stellungnehmerin sieht darin zwar grundsätzlich keine Probleme hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit, erwartet aber stattdessen, dass die nicht vorhandene Deckungsgleichheit der Anwendungsgebiete zwischen verordnetem und abgegebenem Arzneimittel zu einer Verunsicherung der Patienten führe.

Unterschiedlich lange Patentlaufzeiten verschiedener Indikationen seien bei der Regelung der Position A mit Blick auf Patentrechtsverletzungen zu berücksichtigen. Dazu siehe Bewertung zum Einwand 3.6.7.

Es wird betont, dass der in Position A vorgenommene Verweis auf die Spruchpraxis der EMA sowie die Annahme einer regelhaften Genehmigung von Änderungen nicht geeignet sei, die Notwendigkeit einer behördlichen Entscheidung der EMA zu umgehen.

Eine Stellungnehmerin fordert zudem, dass ein Austausch durch Apotheken für ein Arzneimittel erst möglich sein dürfe, wenn die beanspruchten Indikationen nicht nur auf einer Extrapolation basierten, sondern auch tatsächlich vergleichende klinische Daten für die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vorlägen.

Die Stellungnehmenden weisen darauf hin, dass die Berücksichtigung der zugelassenen Indikation schon auf ärztlicher Ebene Voraussetzung für eine Umstellung sei und nun auf Ebene der Apotheke – insbesondere nachdem für die Ersetzung von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln zur Herstellung parenteraler Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bereits eine vergleichbare Regelung bestünde – nicht davon abgewichen werden könne. Grundsätzlich fehle der Apotheke die Information (z. B. über die Verordnung) über die konkrete Indikation der Patientin bzw. des Patienten, um darauf basierend die Anwendungsgebiete abgleichen zu können. Im Falle einer Abweichung der zugelassenen Anwendungsgebiete zwischen den Fertigarzneimitteln würden ggf. auch

sicherheitsrelevante Informationen in der Fach- bzw. Gebrauchsinformation fehlen, so dass eine angemessene Beratung durch Apotheken erheblich eingeschränkt sei. Es wird ausgeführt, dass die Identität der Anwendungsgebiete zwischen verordnetem und abgegebenem Arzneimittel die ärztliche Therapieentscheidung und -verantwortung stärken und eine mögliche Haftung für Apotheken ausschließen würde. Dazu siehe Bewertung zu den Einwänden in 3.6.2 und 3.6.7. Ein rechtssicherer und konsequenter Informationsaustausch erkrankungsspezifischer Aspekte zwischen Verordner und abgebender Apotheke wird hierzu als notwendig erachtet. Dazu siehe Bewertung zu Absatz 4 und zu den Einwänden in 3.6.8.

Grundsätzlich muss ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG [44] (Biosimilar) die gleiche Dosierung und den gleichen Verabreichungsweg wie das Referenzarzneimittel aufweisen („The posology and route of administration of the biosimilar must be the same as those of the reference medicinal product“). Darüber hinaus sind unter Berücksichtigung der aktuell geltenden „Guideline on similar biological medicinal products“ [61] und den darin enthaltenen Grundsätzen zur Zulassung nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG Unterschiede nur gestattet, wenn sie keinen negativen Einfluss auf die Sicherheit und keinerlei Einfluss auf die Wirksamkeit haben.

Dass auch bei biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln die zugelassenen Anwendungsgebiete zwischen Referenzarzneimittel und dessen Biosimilars oder zwischen Biosimilars (mit gleichem Referenzarzneimittel) untereinander abweichen können, wird nicht in Frage gestellt. Diese Unterschiede können zwar darauf zurückzuführen sein, dass z. B. entsprechende Daten vom pharmazeutischen Unternehmer nicht vorgelegt wurden, beruhen in der Regel aber – wie bei generischen Arzneimitteln – auf patentrechtlichen Überlegungen der pharmazeutischen Unternehmer.

Denn im arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren besteht ausdrücklich die Möglichkeit, die Biosimilar-Zulassung zunächst nur für patentfreie Anwendungsgebiete zu beantragen und nachträglich um weitere Anwendungsgebiete des Referenzarzneimittels zu erweitern, wenn der (Verwendungs-)Patentschutz ausläuft. Ausweislich der Hinweise der EMA [74] in „Procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products applications“, Frage 2.9 „*How can I update the product information of my similar biological medicinal product after expiry of the patent of the reference medicinal product?*“ handelt es sich bei der Angleichung der zugelassenen Anwendungsgebiete des Biosimilars an die zugelassenen Anwendungsgebiete des Referenzarzneimittels um eine geringfügige Änderung des Typs IB nach Verordnung (EU) Nr. 1234/2008 [75]. Diese Klassifizierung erfolgt nach Buchstabe C.I.2.a der „Leitlinien zu den verschiedenen Kategorien von Änderungen“ [76] in Fällen, in denen das Referenzarzneimittel eine zusätzliche Indikation erhält und das Biosimilar diese zusätzliche Indikation ebenfalls erhalten soll, sofern dazu keine zusätzlichen Daten erforderlich sind. Es müssen jedoch keine zusätzlichen Daten vorgelegt werden, weil die Vergleichbarkeitsprüfung des Biosimilars mit dem Referenzarzneimittel gemäß Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG auf der Grundlage ergänzender Daten bereits durchgeführt worden ist. Verfahrensrechtlich hat die zuständige Behörde nach Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1234/2008 die Befugnis innerhalb von 30 Tagen nach Bestätigung des Erhalts einer gültigen Mitteilung einen negativen Bescheid zu übermitteln, wofür es jedoch in dem Fall der Hinzufügung eines neuen Anwendungsgebiets des Referenzarzneimittels zum

74 EMA: European Medicines Agency procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products applications. 2025. https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/european-medicines-agency-procedural-advice-users-centralised-procedure-similar-biological-medicinal-products-applications_en.pdf

75 EC: Verordnung (EG) Nr. 1234/2008. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1234-20250101>

76 EC: Leitlinien zu den verschiedenen Kategorien von Änderungen (2013/C 223/01): [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0802\(04\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0802(04)&from=EN)

bereits zugelassenen Biosimilar keinen Anlass gibt. Im Verfahren ist somit regelhaft von einer Genehmigung der Änderung auszugehen. Dies bestätigt auch die Entscheidungspraxis, in der in keinem Fall eine negative Entscheidung der Zulassungsbehörde über eine Angleichung der Anwendungsgebiete erfolgt ist. Das Verfahren zur Erweiterung der Anwendungsgebiete ist somit arzneimittelrechtlich dem für Generika einschlägigen Verfahren im Wesentlichen angenähert.

Dies spiegelt sich auch in dem im April 2023 publizierten gemeinsamen „Statement on the scientific rationale supporting interchangeability of biosimilar medicines in the EU“ [59] der EMA mit dem Netzwerk der „Heads of Medicines Agencies“ (HMA) wider, wonach für ein in der EU zugelassenes Biosimilar und sein Referenzarzneimittel grundsätzlich eine Austauschbarkeit gegeben ist. Auch Biosimilars, die bezugnehmend auf das gleiche Referenzarzneimittel zugelassen sind, sind untereinander austauschbar. In den Q&A zu diesem Statement weist die EMA in der Antwort auf die Frage 4 *„Does the statement of interchangeability apply to biosimilars that do not have all the indications of the reference or another biosimilar medicine?“* [43] auf die wissenschaftlich basierte Austauschbarkeit der Biosimilars hin, obwohl sie nicht in allen Anwendungsgebieten des Referenzproduktes zugelassen sind. Ebenso gilt diese Austauschbarkeit, wenn das Biosimilar bei mehr zugelassenen Anwendungsgebieten eingesetzt werden kann als das Referenzprodukt. Somit besteht auf europäischer Ebene der wissenschaftliche Kerngedanke, dass in der EU zugelassene Biosimilars sowohl mit ihrem Referenzarzneimittel als auch untereinander unter dem Aspekt der Arzneimitteltherapiesicherheit ohne weitere Bedenken austauschbar sind, solange sie analog den Angaben in ihren Fachinformationen angewendet werden.

Aktuelle Überlegungen der EMA im „Reflection paper on a tailored clinical approach in biosimilar development“ [77] vom 1. April 2025 zeigen, dass von Seiten der EMA bereits im Zulassungsverfahren eine Abkehr von der Betrachtung von Anwendungsgebieten und klinischen Daten hin zu einer im Wesentlichen analytischen Betrachtung der pharmakologischen Wirkweise und Rezeptorbindung von Referenzarzneimittel und Biosimilar für ausreichend erachtet werden könnte. In ihrer Presseerklärung vom 1. April 2025 [78] führt die EMA aus: „Building on extensive experience with biosimilar medicines and advances in analytical methods, the draft reflection paper suggests that demonstrated structural and functional comparability, together with comparative data on how the body interacts with the medicines (pharmacokinetic data), may be sufficient to demonstrate similarity with the reference medicine. This could potentially reduce the need for extensive clinical efficacy studies. Waiving certain clinical data requirements would simplify the development and evaluation process while maintaining the highest standards of safety and efficacy“.

Angesichts dieser sinkenden Bedeutung der Betrachtung von Anwendungsgebieten bereits auf europäischer Zulassungsebene ist die Forderung nach vollständig übereinstimmenden Anwendungsgebieten zwischen Referenzarzneimittel und Biosimilar, wie sie noch bei Schaffung der Regelung des § 40b AM-RL für die Ersetzung bei parenteralen Zubereitungen aus biotechnologisch hergestellten Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung auf Apothekenebene für erforderlich erachtet wurde, nicht mehr zeitgemäß.

Die Reduzierung der Voraussetzung auf ein übereinstimmendes Anwendungsgebiet ist ebenfalls durch den Gesetzesauftrag in § 129 Absatz 1a SGB V gedeckt. Denn die Verweisnorm des § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V verweist in vollem Umfang – und ohne Einschränkung für Biologika – auf die Regelung des § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V, der als Voraussetzung für die

77 Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). Reflection paper on a tailored clinical approach in biosimilar development (Draft). 2025. https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/reflection-paper-tailored-clinical-approach-biosimilar-development_en.pdf (Zugriff am 12.11.2025)

78 Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). News – Streamlining development and assessment of biosimilar medicines. 2025. <https://www.ema.europa.eu/en/news/streamlining-development-assessment-biosimilar-medicines> (Zugriff am 12.11.2025)

Ersetzung auf Apothekenebene nur die Zulassung für „ein gleiches Anwendungsgebiet“ normiert.

Eine Abweichung von der Regelung des § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V, dass mindestens ein gleiches Anwendungsgebiet für den Austausch erforderlich ist, ist daher mittlerweile nicht mehr, auch nicht aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit, geboten. Eine Regelung, wie sie Position B1 + B2 vorsieht, würde stattdessen einen Austausch verhindern, weil letztlich patentrechtliche Gründe zu Abweichungen im Indikationsspektrum führen. In der Gesamtschau ist es daher angemessen, in der Folge auch für Biosimilars die gesetzliche Regelung des § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V anzuwenden.

Soweit eingewendet wird, dass es dadurch bei einem Austausch durch Apotheken zur Verunsicherung der Patienten kommen könne, ist entgegenzuhalten, dass diese durch adäquate Aufklärung und Beratung vermieden oder gemindert werden kann und nicht dazu führen muss, den Austausch zu unterlassen. Darüber hinaus wird durch die Identität der Applikationsarten sowie durch die Schaffung der Voraussetzung gleicher Behältnisse nach Fachinformation bei verordnetem und abzugebendem Biologikum in Absatz 1 das Risiko von Anwendungsfehlern im Interesse des Patientenschutzes minimiert.

Kann der Arzt oder die Ärztin Risiken für den Patienten oder die Patientin im Zusammenhang mit einer Arzneimittelsubstitution nicht ausschließen, besteht eine berufsrechtliche Verpflichtung, Gefahren durch Aufklärung oder Ausschluss der Substitution abzuwehren. Die Verpflichtung zur Aufklärung besteht schon nach § 630c, ggf. § 630e BGB und der Berufsordnung und obliegt der Ärztin oder dem Arzt entsprechend der bereits etablierten aut-idem-Regelungen. Die weitergehende Prüfung der Sachgerechtigkeit einer Ersetzung durch die Apotheke im Einzelfall bleibt hiervon unberührt.

Nach Inkrafttreten der Regelung des § 40c AM-RL wird auch die Regelung des § 40b AM-RL entsprechend aktualisiert werden.

3.1.6 Berücksichtigung weiterer Produkteigenschaften und therapeutischer Vergleichbarkeit

AbbVie

Eine Recherche zur Unbedenklichkeit von Biologika-Umstellungen in Apotheken kam zu dem Ergebnis, dass zu diesem Untersuchungsgegenstand keine evidenzbasierten Informationen vorliegen. In aktuellen Übersichtsarbeiten findet man jedoch wiederkehrende prinzipielle Hinweise, dass auch nur geringste Variationen der Aminosäuresequenz in einem Biologikum ein vollkommen neuartiges Epitop generieren und damit eine ungewollte Immunantwort provozieren können. Hinzu kommen posttranslationale Veränderungen des Biologikums wie bspw. durch Glykosylierung, die auf der Basis einer auch nur geringfügig veränderten Aminosäurestruktur die Immunogenität des therapeutischen Wirkstoffs dramatisch beeinflussen können [79]. Dass dieser Effekt insbesondere bei einem multiplen Wechsel der biosimilaren Wirkstoffe potenziert und dadurch neben der Abschwächung der Wirkung ggfs. auch eine höhere Nebenwirkungsinzidenz hervorgerufen wird, lässt die automatische Substitution von Biologika in der Apotheke kritisch erscheinen.

Biocon

[...] Verschiedene Pens/Spritzen zur Applikation: Patienten werden in den Arztpraxen bei Verordnung des Arzneimittels auf den Pen / die Spritze von dem Präparat trainiert, das sie in der Praxis verschrieben bekommen. Diese Applikationsgeräte können sich zum Teil erheblich unterscheiden, beispielsweise wenn es sich um einen 2-Schritt- oder 3-Schritt-Pen handelt. Ein Patient, der auf Ersteren geschult ist, schließt die Injektion nicht ab, wenn er wie gewohnt nach dem zweiten Schritt aufhört. Der Apotheker muss hier den Patienten bei einer Substitution

79 Jarab AS et al. (2025): Biosimilars and immunogenicity: a matter of concern? Expert Opin Drug Saf;24(5):519-27.

genau darauf schulen, was nicht nur zeitintensiv ist, sondern auch von dem Apotheker erkannt und in Zusammenarbeit und Einverständnis mit dem Patienten umgesetzt werden muss.

Unterschiedliche sonstige Bestandteile: zur pH-Einstellung der Lösung werden von den Herstellern verschiedene Puffersysteme angewendet. Citrat-haltige Arzneimittel können bei einer subkutan-Gabe zu zum Teil schmerzhaften Hautirritationen an der Einspritzstelle führen. Hier ist bei einer Substitution in der Apotheke fraglich, ob der Apotheker die Überempfindlichkeit des Patienten kennt und eine entsprechende Anamnese zeitaufwendig und liegt in der Verantwortung des Arztes.

Allergische Reaktionen: manche Formulierungen von Biosimilars enthalten Latex, was bei entsprechend empfindlichen Patienten zu allergischen Reaktionen führen kann. Möglichen Symptome sind: Symptome: Juckreiz, Rötungen, Quaddeln, Schwellungen der Haut, am gesamten Körper möglich, Symptome entstehen sofort oder zeitverzögert, teilweise, wenn auch selten können lebensbedrohliche allergische Reaktion (anaphylaktischer Schock) erfolgen. Auch hier stellt sich die Frage, ob der Apotheker den genauen Status des Patienten kennt bzw. in der Lage ist eine entsprechende Anamnese, die an sich in der ärztlichen Verantwortung liegt, vorzunehmen?

Die Haltbarkeiten von Biosimilars außerhalb des Kühlschranks variieren zum Teil erheblich. Bei Adalimumab beispielsweise zwischen 14 und 30 Tage. Somit besteht die Gefahr, dass ein Patient im Falle einer Substitution ein abgelaufenes Präparat anwendet, dessen Therapiesicherheit nach Ablauf nicht mehr gewährleistet werden kann. Auch dies muss der Apotheker erkennen und darauf explizit hinweisen.

Biogen

Produktbezogene Unterschiede bestehen nicht nur zwischen verschiedenen Biologika, sondern auch zwischen zugelassenen Biosimilars mit demselben Referenzarzneimittel. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei Biosimilars nicht um identische Wirkstoffe handelt. Vielmehr sind sie dem Referenzprodukt lediglich ähnlich („similar“), was im Rahmen der regulatorischen Anforderungen im Sinne des Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG als ausreichend für eine vergleichbare Wirksamkeit und Sicherheit gilt. Darüber hinaus sind weitere Unterschiede bei den sonstigen Bestandteilen zu finden, was Unterschiede in der Pufferung, dem pH-Wert und der Osmolalität mit sich bringt. Auch weitere Hilfsstoffe, wie z. B. Citrat oder Phosphate können variieren. Zudem kann, wie etwa zwischen hoch- und niedrigkonzentrierten Lösungen, das verabreichte Volumen unterschiedlich sein.

Für Wirkstoffe wie Adalimumab und Etanercept stehen mittlerweile verschiedene subkutane Formulierungen zur Verfügung, die sich auf die Patientenerfahrung und -präferenz auswirken können [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. Für Natalizumab, existiert das Produkt TYSABRI in zwei verschiedenen Darreichungsformen: intravenöse und subkutane Verabreichungsform. Nur für die intravenöse Verabreichung ist ein Natalizumab-Biosimilar verfügbar [80, 81].

80 Tyruko: EPAR.

81 Tysabri: EPAR.

[...] Bei subkutan verabreichten Biologika/Biosimilars ist Schmerz an der Injektionsstelle eine der Hauptursachen für Therapieabbrüche [1] und gescheiterte Umstellungen. Dieser Schmerz ist multifaktoriell bedingt [1, 9, 24, 82]: durch bestimmte Hilfsstoffe (insbesondere Citrat [83, 84]), das Injektionsvolumen, die Injektionsgeschwindigkeit (abhängig vom Gerät), die Nadeldicke, mögliche Allergene (z. B. Latex), den Gerätetyp sowie die Injektionstechnik. [...] Ein Präparatewechsel kann daher Schmerzen verursachen, die zuvor nicht vorhanden waren und so die Therapieadhärenz gefährden. Vor allem, wenn dieser durch automatische Substitution und ohne vorherige Abklärung mit dem behandelnden Arzt entsteht. Zudem besteht bei Patienten mit Allergien die Gefahr, dass durch eine automatische Substitution ohne ärztliche Kontrolle ein Präparat mit potenziell allergenen Hilfsstoffen abgegeben wird – mit möglicherweise gravierenden Folgen für die Patientensicherheit.

Zudem ist auch die korrekte Lagerung, Haltbarkeit und Bestandsführung von Biologika/Biosimilars entscheidend. Unterschiede zwischen Produkten können deren sachgemäße Anwendung beeinflussen. So müssen viele Biologika wie z. B. Etanercept und Adalimumab gekühlt gelagert werden, können aber je nach Produkt unterschiedlich lange (von 14 Tagen bis zu 8 Wochen) bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$ oder $\leq 30^{\circ}\text{C}$) aufbewahrt werden [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. Ein Präparatewechsel mit abweichender Lagerdauer kann jedoch zu einer fehlerhaften Lagerung durch den Patienten führen und dadurch die Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigen. Mit Inkrafttreten von § 40c (neu) muss folglich auch sichergestellt werden, dass jeder Patient zukünftig bei der Abgabe eines Arzneimittels auf eine korrekte Lagerung hingewiesen wird.

Neben der grundsätzlichen Bewertung der Austauschbarkeit von Biologika/Biosimilars muss bei bestimmten Biologika-Therapien – wie im Fall des monoklonalen Antikörpers Natalizumab – das individuelle Risikoprofil der Patienten besonders berücksichtigt werden. Die Therapie mit Natalizumab ist mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer progressiven multifokalen Leukenzephalopathie (PML) assoziiert – einer seltenen, aber potenziell tödlichen opportunistischen Infektion des zentralen Nervensystems [85]. Dieses Risiko erfordert ein engmaschiges und differenziertes Risikomanagement, das über die Standardüberwachung hinausgeht.

Die damit einhergehenden regulatorischen Anforderungen, machen eine automatische Substitution in der Apotheke faktisch unmöglich. Für TYSABRI und dem Natalizumab-Biosimilar bestehen jeweils verpflichtende Auflagen zur Patienteneinwilligung und -aufklärung, die bei Therapiebeginn, nach 2 Jahren sowie beim Absetzen der Behandlung dokumentiert werden müssen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Angehörige der Heilberufe, die Natalizumab verschreiben und zur Anwendung bringen, die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen. Diese Dokumentation ist an spezifische Formulare für jedes Natalizumab-Arzneimittel gebunden und Teil der behördlichen Zulassungsaufgabe. Auch die Aushändigung und Mitführung eines Patientenpasses für das jeweils verordnete Natalizumab-Arzneimittel ist verpflichtend. Eine automatische Substitution würde diese Prozesse unterlaufen und könnte dazu führen, dass Patienten ohne gültige Einwilligung oder mit unpassender Risikoüberwachung behandelt werden [80, 81, 85, 86].

Zusätzlich basiert das Risikomanagement bei TYSABRI auf einem hochspezifischen Testsystem

82 Corominas H et al. (2023): Healthcare Professional (HCP) and Patient Usability Evaluation and Preferences of Two Auto-injector Devices for Self-Injection of Biosimilars, SB4 and SB5: A Literature Review. Clin Drug Investig;43(8):579-93.

83 Yang YL et al. (2021): Citric Acid in Drug Formulations Causes Pain by Potentiating Acid-Sensing Ion Channel 1. J Neurosci;41(21):4596-606.

84 Junker S et al. (2023): A Systematic Literature Review of Injection Site Pain Perception in Adult Patients Treated with Citrate-Free and Citrate-Containing Biologic Agents. Cur Rheumatol Rev.

85 Tysabri. Leitfaden zur Verringerung von Arzneimittel- und Anwendungsrisiken – Angehörige der Heilberufe. Version 23. 2025.

86 Tyruko. Arzt-Information und Management-Leitlinien – Angehörige der Heilberufe. Version 1.0. 2023.

(STRATIFY JCV™), das zur Einschätzung des individuellen PML-Risikos eingesetzt wird. Beim zugelassenen Natalizumab-Biosimilar hingegen kommt ein anderer Test (ImmunoWell™) zum Einsatz, der zu abweichenden Ergebnissen führen kann. Studien und Fallberichte zeigen, dass Patienten, die zuvor mithilfe von STRATIFY JCV™ stabil waren und jahrelang als JCV-seronegativ klassifiziert wurden, im ImmunoWell™-Test mit einer geringeren Spezifität als positiv oder grenzwertig positiv eingestuft wurden. Dies kann infolgedessen zu unnötigen Therapieabbrüchen, zusätzlichen MRT-Untersuchungen, vermehrten Ambulanzbesuchen und einem Wechsel zurück zum Referenzpräparat oder auf eine komplett andere DMT (disease modifying therapy) führen – mit erheblichen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität, Lebensqualität, „burden of therapy“, die Therapietreue bzw. -persistenz und die psychische Belastung der Patienten [80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92].

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die automatische Substitution von TYSABRI in der Apotheke birgt erhebliche Risiken für die Patientensicherheit, unterläuft bestehende regulatorische Vorgaben und gefährdet die Qualität der Versorgungsforschung. Infolgedessen kann der behandelnde Facharzt den behördlichen Auflagen nicht mehr gerecht werden. Die Verantwortung für Therapieentscheidungen und das Risikomanagement muss daher zwingend beim behandelnden Facharzt verbleiben. Vor diesem Hintergrund fordert die Biogen GmbH ausdrücklich, dass TYSABRI (Natalizumab i.v.) aufgrund seiner besonderen Sicherheitsanforderungen und regulatorischen Auflagen explizit von der automatischen Substitution ausgeschlossen werden muss.

Hexal

Die Molekül-Modifikationen alfa und zeta bei Epoetin zeigen in der klinischen Praxis unterschiedliche Effektivitäten nominal gleicher Dosierungen. Reichel et al. haben in einer retrospektiven Analyse zur Ermittlung klinischer Einflussfaktoren auf die Dosierung von Epoetin-Biosimilars Behandlungsdaten von über 14.000 Hämodialyse-Patienten erhoben [93, 94]. Die Patientenkohorte umfasste 11.463 Patienten (81,3%) unter Epoetin alfa und 2.641 Patienten (18,7%) unter Epoetin zeta. Als relevante Parameter wurden Entzündungen (CRP), der Dialysezugang (Katheter), Eisenmedikation, Mangelernährung (niedriges S-Albumin), geringe Eisenspeicher (TSAT) und ein niedriger Hb-Wert sowie die Art des Erythropoietin-Biosimilars (alfa oder zeta) als unabhängige Einflussfaktoren für höhere Epoetin-Dosierungen ermittelt. Hierbei lagen bei Epoetin zeta signifikant höhere Dosen vor als bei Epoetin alfa. Die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zu einer höheren Epoetin Dosisgruppe war signifikant höher unter Epoetin zeta: 20,6% bei der Dosierungsgruppe 5.000 – 10.000 IE/ Woche und 25,2% bei der Dosierungsgruppe > 10.000 IE/ Woche.

Dies zeigt, dass ein bedenkenloser Austausch zwischen unterschiedlichen Epoetin-Modifikationen keinesfalls erfolgen darf. Auch wenn der G-BA dieses Argument im Verfahren

87 Gelissen LMY et al. (2025): Accuracy of New John Cunningham Virus Antibody Assay in Natalizumab-Treated Patients With Multiple Sclerosis. JAMA Neurol;82(5):523-5.

88 Ziemssen T et al. (2025): Diagnostic uncertainty in the era of biosimilar natalizumab-The case for harmonizing anti-JCV antibody testing. Mult Scler;31(7):751-3.

89 Vukusic S et al. (2025): Beyond the switch to the biosimilar of natalizumab: What is the impact of changing the JCV test? Mult Scler;31(7):877-81.

90 Inojosa H et al. (2025): Challenges and implications of anti-JCV antibody serology variability among different assays in natalizumab treatment: A call for standardization and transparency in clinical practice. Mult Scler;31(3):376-7.

91 Zanghi A et al. (2025): Comparing STRATIFY JCV™ DxSelect™ and IMMUNOWELL™ JCV IgG Tests in RRMS to Assess PML Risk. Curr Neuroparmacol;23(10):1294-300.

92 Varley J et al. (2025): A comparison of JC virus assay performance provided with originator and biosimilar natalizumab. Mult Scler;31(7):882-5.

93 Reichel H et al. (2018): Predictors of Renal Anemia and Epoetin Biosimilar Therapy in German Hemodialysis Patients. Nephrology Dialysis Transplantation;33(suppl_1):i464-i5.

94 Reichel H et al. (2017): Predictors of epoetin biosimilar dosing in German hemodialysis patients. Poster presentation, 9. Kongress für Nephrologie, Mannheim, Germany, September 2017.

zur Arzneimittel-Richtlinie: Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln – § 40a abgewehrt hat, ist es im Kontext eines automatisierten Austauschs in der Apotheke hochrelevant.

Die Apotheke kann, anders als der Arzt, nicht beurteilen, ob einer der oben genannten Parameter beim rein wirtschaftlich begründeten automatischen Austausch ein Risiko für den Patienten darstellt. Ein Austausch zwischen verschiedenen Modifikationen von Epoetin verbietet sich daher. Dies macht einmal mehr deutlich, dass der simple Verweis auf pauschalisierende aut idem Kriterien bei diesen komplexen Therapien unzulässig ist und der G-BA wie vom Gesetzgeber gefordert eine explizite Evaluation der therapeutischen Vergleichbarkeit auf Wirkstoffbasis zur Grundlage seiner Entscheidung machen muss.

Aus den genannten Gründen sollte ebenso bei neu zugelassenen Biosimilars die erforderliche Prüfung der therapeutischen Vergleichbarkeit keine sofortige, automatische Substitution in der Apotheke erlauben.

Dies erscheint nur angemessen, gerade vor dem Hintergrund der mit einer aut idem Substitution verbundenen Risiken für die zukünftige Entwicklung von Biosimilars und die längerfristige ausreichende und wirtschaftliche Versorgung mit Biologika. Wegen weiterer Details hierzu verweisen wir auf unsere Stellungnahmen vom (i) 19. Mai 2022 zum Verfahren zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie: § 40b (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln durch Apotheken und (ii) vom 16. Januar 2023 zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): § 40b (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken bei parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung.

[...] Unterschiedliche Biologika-Präparate einer INN können sich in ihren Haltbarkeiten und Lagerungs- sowie Transportbedingungen unterscheiden (siehe exemplarisch Tabelle 3 und Tabelle 4). Unterschiede in Aufbewahrungsfristen und -bedingungen sind hinsichtlich des bestimmungsgemäßen Gebrauchs dem Patienten zu vermitteln [11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 48, 49, 50, 51, 52, 95, 96, 97, 98, 99]. Andernfalls können Wirksamkeit und Sicherheit in der Anwendung beeinträchtigt sein.

Biologika sind Proteinwirkstoffe und daher kühlpflichtig, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Das ist auch in den einschlägigen Fachinformationen hinterlegt – nach einer Aufbewahrung bei Raumtemperatur (z. B. auf dem Weg von der Apotheke nach Hause) dürfen Adalimumab-Präparate nicht zurück in den Kühlkreislauf gegeben werden, da dies Auswirkungen auf die Produktstabilität hat [11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23].

Kann das Präparat auf dem Transport nicht adäquat gekühlt werden, entstehen potenzielle Risiken bezüglich der weiteren Verwendbarkeit. Das Problem verschärft sich, wenn der Patient eine Haltbarkeit bei Raumtemperatur von beispielsweise 28 oder 30 Tagen gewohnt ist und in der Apotheke ein Präparat erhält, dass bei Raumtemperatur nur noch 14 Tage haltbar ist. Beim Wirkstoff Ustekinumab sind die Unterschiede in den Lager- und Transportbedingungen sogar weitreichender, als dass einzelne Produkte nach einer gewissen Zeit außerhalb des Kühlschranks einmalig in den Kühlschrank zurückgelegt werden können und dann die allgemeine Haltbarkeit weiterhin gültig ist. Bei anderen Produkten ist dies ausdrücklich untersagt und die Haltbarkeit beschränkt sich auf die angegebene Zeit zur Aufbewahrung bei Raumtemperatur.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick zu den unterschiedlichen Haltbarkeiten vor allem in Bezug auf die Aufbewahrung bei Raumtemperatur (RT) für die Wirkstoffe Adalimumab

95 Fachinformation Fymiskina. Stand Mai 2025.

96 Fachinformation Pyzchiva. Stand Mai 2025.

97 Pyzchiva: EPAR.

98 Fachinformation Uzpruvo. Stand Mai 2025.

99 Fachinformation Yesintek. Stand Februar 2025.

und Ustekinumab.

Tabelle 3: Auflistung von Haltbarkeits- und Aufbewahrungsdaten der auf dem dt. Markt erhältlichen Adalimumab-Präparate; Stand 01.07.2025 [11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23]

Präparat	Haltbarkeit	Aufbewahrung bei RT (25°C)
Amgevita®	36 Monate	14 Tage
Amsparity®	36 Monate	30 Tage (bis 30°C)
Hukyndra®	36 Monate	30 Tage
Hulio®	36 Monate	56 Tage (8 Wochen)
Humira®	24 Monate	14 Tage
Hyrimoz®	24 Monate	42 Tage
Idacio®	24 Monate	28 Tage
Imraldi®	30 Monate	31 Tage
Yuflyma®	36 Monate	31 Tage

Tabelle 4: Auflistung von Haltbarkeits- und Aufbewahrungsdaten der auf dem dt. Markt erhältlichen Ustekinumab-Präparate in 45mg oder 90mg; Stand 01.07.2025 [48, 49, 50, 51, 52, 95, 96, 97, 98, 99]

Präparat	Haltbarkeit	Aufbewahrung bei RT (30°C)	Zurücklegen in den Kühlschrank möglich
Fymiskina® (Fertigspritze)	36 Monate	30 Tage	Nein
Imuldosa® (Fertigspritze)	24 Monate	30 Tage	Nein
Otulfi® (Fertigspritze)	36 Monate	30 Tage	Nein
Pyzchiva® (Fertigspritze)	42 Monate	35 Tage	Ja (einmalig)
Pyzchiva® (Fertigpen)	42 Monate	35 Tage	Ja (einmalig)
Stelara® (Fertigspritze)	36 Monate	30 Tage	Nein
Stelara® (Fertigpen)	36 Monate	30 Tage	Nein
Steqeyma® (Fertigspritze)	36 Monate	31 Tage	Nein
Uzpruvo® (Fertigspritze)	36 Monate	30 Tage	Nein
Wezenla® (Fertigspritze)	36 Monate	30 Tage	Nein
Wezenla® (Fertigpen)	36 Monate	30 Tage	Nein
Yesintek® (Fertigspritze)	36 Monate	30 Tage	Nein

Besonders der Hilfsstoff Sorbitol ist in diesem Zusammenhang zu betrachten. Dieser Hilfsstoff ist beim Präparat Hulio®, jedoch nicht bei den anderen Adalimumab-Biosimilars enthalten [11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23]. Der Zusatz von Sorbitol ist insbesondere für Patienten mit einer hereditären Fructose-Intoleranz von Bedeutung, die diesen Hilfsstoff und damit auch das entsprechende Arzneimittel nicht anwenden dürfen. Ein Warnhinweis ist in den einschlägigen Fachinformationen aufgeführt. Hier ist das Wissen des Arztes bzgl. dieser patientenindivid. genetischen Prädisposition für die korrekte Verordnung unabdingbar [18].

Lilly

Lilly weist im Weiteren ausdrücklich darauf hin, dass betreffend unserer Produkte in der Indikation Diabetes mellitus unter den Markennamen Humalog® und Huminsulin®, in den Fachinformationen hinsichtlich der Umstellung eines Patienten auf einen anderen Insulintyp

oder ein Insulin eines anderen Herstellers angezeigt ist, dass eine Umstellung unter strenger ärztlicher Aufsicht erfolgen muss. Jede Änderung hinsichtlich Stärke, Marke (Hersteller), Insulintyp (Normal/löslich, Basal [NPH]/Isophan, etc.), Art des Insulins (tierisches Insulin, Humaninsulin, Humaninsulin-Analogon) und/oder Herstellungsmethode (rekombinante DNA-Technologie bzw. tierisches Insulin) kann eine Veränderung des Insulinbedarfs nach sich ziehen [100, 101].

In der Fachinformation zu Lyumjev® wird darauf hingewiesen, dass ein Wechsel des Insulins, der Insulinkonzentration, des Herstellers, der Art sowie der Verabreichungsmethode die glykämische Kontrolle beeinflussen kann und zu Hypoglykämien oder Hyperglykämien führen kann. Derartige Änderungen sollten nur mit Vorsicht unter engmaschiger Kontrolle durch medizinisches Personal und mit vermehrten Glucosemessungen durchgeführt werden. Für Patienten mit Typ 2-Diabetes mellitus sind gegebenenfalls Dosisanpassungen bei antidiabetischer Begleitmedikation erforderlich. Bei Patienten mit Nieren- oder Leberfunktionsstörungen sollte die Glucoseüberwachung intensiviert und die Dosierung individuell angepasst werden [102].

Ange­sicht der notwendigen Veränderung des Insulinbedarfs, der antidiabetischen Begleitmedikation und des hohen Risikos für Patienten, eine Hypo- oder Hyperglykämie auf ein Arzneimittel eines anderen Herstellers mit gegebenenfalls anderer Stärke, Insulintyp oder -art und Herstellungsmethode zu erleiden, erachtet es Lilly im Sinne der Patienten- und Arzneimittelsicherheit als nicht angemessen, Insuline in die Substitution in Apotheken einzuschließen und fordert im Weiteren eine Streichung der Insuline von der Liste der zu substituierenden Arzneimittel in Anlage VIIa zum Abschnitt M der Arzneimittel-Richtlinie.

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG (Medice)

Im Zulassungsverfahren von SB309 (Epoetin zeta) wurden eine Reihe von deutlichen Unterschieden zwischen dem Testprodukt und dem Referenzarzneimittel Erypo® aufgezeigt, die im Rahmen der Scientific Discussion [103] dokumentiert und diskutiert wurden. Entsprechende Unterschiede wurden im Zulassungsverfahren von HX575 nicht dokumentiert (für eine Übersicht siehe Tabelle 5).

Darüber hinaus wurde auch im „Real-World-Setting“ Unterschiede im Dosisbedarf zwischen Erypo und Epoetin zeta beobachtet. Eine retrospektive, nicht-interventionelle Analyse zur Ermittlung klinischer Einflussfaktoren auf die Dosierung von Biosimilars hat Behandlungsdaten von über 14.000 Hämodialysepatient:innen aus 165 dem Verband Deutscher Nierenzentren (DN) e.V. angehörenden Dialysezentren erhoben (Datenbank QuaNT) [93, 94]. Die Patientenkohorte bestand aus 11.463 Patient:innen (81.3 %) unter Epoetin alfa und 2.641 Patient:innen (18.7 %) unter Epoetin zeta. Als Outcome konnten Entzündungen (CRP), der Dialysezugang (Katheter), Eisenmedikation, Mangelernährung (niedriges S-Albumin), geringe Eisenspeicher (TSAT) und niedriger Hb-Wert sowie die Art des Erythropoietin-Biosimilars (alfa oder zeta) als unabhängige Einflussfaktoren für höhere Epoetin-Dosierungen ermittelt werden. Hierbei lagen bei Epoetin zeta signifikant höhere Dosen vor als bei Epoetin alfa Biosimilar. Die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zu einer höheren Epoetin Dosisgruppe war unter Epoetin zeta signifikant erhöht: 20.6 % für die Dosisgruppe 5.000 – 10.000 IE/Woche und 25.2 % für die Dosisgruppe > 10.000 IE/Woche.

100 Fachinformation HUMALOG. Stand August 2022.

101 Fachinformation Huminsulin. Stand November 2023.

102 Fachinformation Lyumjev. Stand Januar 2025.

103 Retacrit: EPAR – Scientific Discussion.

Tabelle 5: Zusammenfassung der Studiendatenlage zu Unterschieden zwischen Epoetin zeta (SB309) und Erypo (Epoetin alfa) bzw. dem Epoetin alfa Biosimilar HX575 und Erypo.

	Epoetin alfa Biosimilar Abseamed (HX575) [104]	Epoetin zeta (SB309) [93, 94, 103]
Präklinische Pharmakodynamik: Rezeptorbindungsstudien	Keine dokumentierten Unterschiede zw. Erypo und HX575.	Unterschiedliche Rezeptorbindungsspezifitäten im normozytären Mausmodell zwischen Erypo und SB309 (Studien #176 und #177).
Toxikologische Untersuchungen: Immunogenität	Keine dokumentierten Unterschiede in der Immunogenität zw. HX575 und Erypo.	8 von 16 Hunden entwickelten nach SB309 s.c.-Gabe Erythropoietin-Antikörper, während dies nur bei einem von 8 Hunden nach Erypo-Gabe der Fall war (Studie 0242).
Klinische Pharmakokinetik: Bioverfügbarkeit nach i.v.- und s.c. Gabe	Vergleichbare PK-Profile für i.v.- und s.c.-Gabe bei HX575 und Erypo in insgesamt 6 Studien.	Studie 411-54-05-05: Nach i.v.-Gabe war die Bioverfügbarkeit (AUC_{0-last}) von SB309 signifikant geringer als von Erypo (Punktschätzer 0,80; 90% Konfidenzintervall 0,76-0,84). Studie 411-54-03-09: Nach s.c.-Gabe war die Bioverfügbarkeit (C_{max}) von SB309 signifikant geringer als von Erypo (Punktschätzer 0,82; 90% Konfidenzintervall 0,75-0,90).
Klinische Phase-III Pivotalstudie zur i.v.-Gabe in Hämodialysepatienten (Dosistitrationsstudie)	Beide RCT-Pivotal-Studien zu HX575 haben eine vergleichbare klinische Wirksamkeit zu Erypo dargestellt.	Studie 411-54-04-05: RCT bei n=609 HD-Patienten. Die Dosierung von Epoetin zeta war etwa 10% höher als unter Epoetin alfa (182.20 ± 118.11 IU/kg/Woche versus 166.14 ± 109.85 IU/kg/Woche; Abb. 1). Die Hb-Konzentrationen waren vergleichbar (SB309 $11,61 \pm 1,27$ g/dl, Erypo $11,63 \pm 1,37$ g/dl).
Klinische Phase-III Pivotalstudie zur i.v.-Gabe in Hämodialysepatienten (Erhaltungstherapiestudie)	Beide RCT-Pivotal-Studien zu HX575 haben eine vergleichbare klinische Wirksamkeit zu Erypo dargestellt.	Studie 411-54-04-04: Randomisierte Cross-over-Studie von SB309 und Erypo in n=313 HD-Patienten. Unter SB309 wurde ein Dosismehrbedarf von 10-15% und eine Abnahme der Hb-Konzentration von 5% beschrieben (siehe Abbildung 5). Erklärt wurde diese Abweichung durch Unterschiede hinsichtlich Bioaktivität und Protein-gehalt zwischen Test- und Referenzmedikation, trotz gleicher nominaler Dosis und trotzdem alle Prüfpräparate innerhalb der durch Ph. Eur. definierten Grenzen von 80-125% lagen.
Studien nach Marktzulassung [93, 94]	Keine Hinweise hinsichtlich Unterschieden in Wirksamkeit und Verträglichkeit zw. HX575 und Erypo.	Unter Epoetin alfa 8% niedriger Dosisbedarf im Vergleich zu Epoetin zeta (Regressionskoeffizient -0,0597; 95% KI -0,11319, -0,00615; p=0,029).

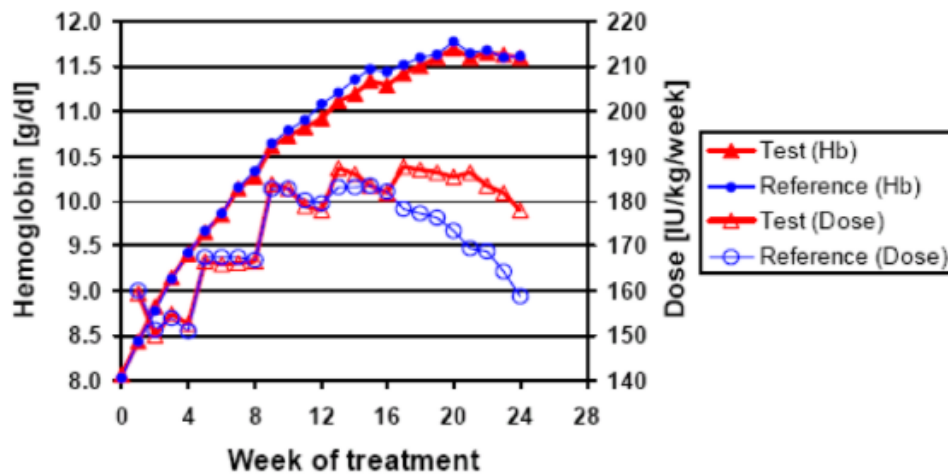


Abbildung 5: RCT zur Dosiseinstellung (Studie 411-54-04-05) von SB309 (Test, rot) versus Erypo (Reference, blau). Dargestellt sind die mittleren Hb-Konzentrationen und die mittleren Wochendosierungen [103].

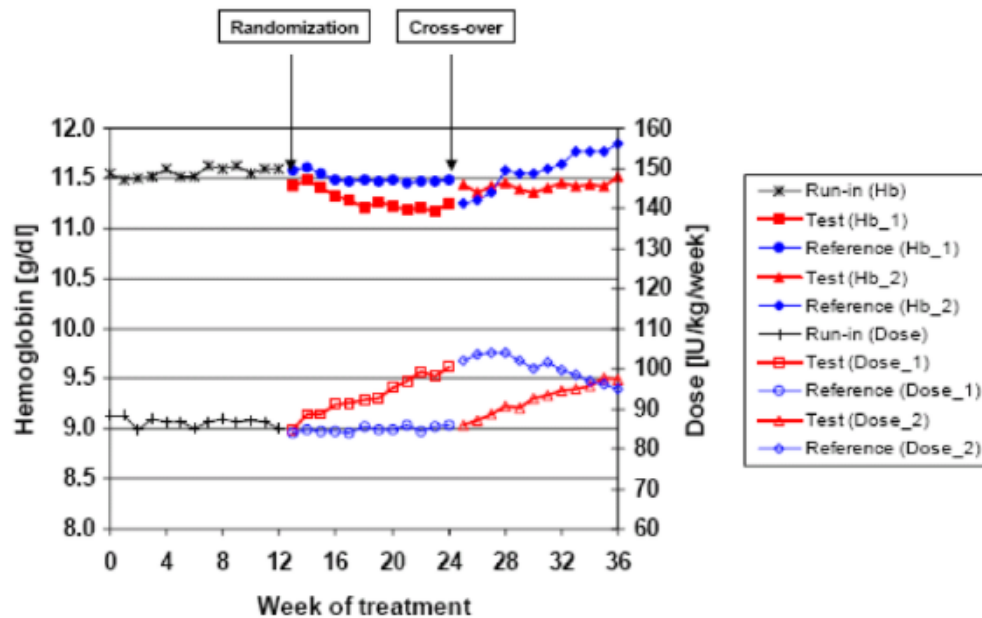


Abbildung 6: RCT zur Dosiseinstellung (Studie 411-54-04-04) von SB309 (Test, rot) versus Erypo (Reference, blau). Dargestellt sind die mittleren Hb-Konzentrationen und die mittleren Wochendosierungen [93, 94].

Tabelle 6: Retrospektive Analyse der QuasyNet Datenbank des Verbandes Deutscher Nierenzentren e.V.. Analysiert wurden die Daten von n=11.463 Hämodialyse Patienten unter Epoetin alfa Behandlung und n=2.641 Hämodialyse Patienten unter Epoetin zeta Behandlung. Die Epoetin alfa Dosis betrug im Mittel 8.025 IE/Woche und die Epoetin zeta Dosis 8.634 IE/Woche [93, 94].

		Whole group (n=14.104)			Epoetin alfa (n=11.463)			Epoetin zeta (n=2.641)		
		n (%)	Mean ± SD	Median	n (%)	Mean ± SD	Median	n (%)	Mean ± SD	Median
Gender	female	8.435 (59.8)			6.852 (59.8)			1.583 (59.9)		
	male	5.669 (40.2)			4.611 (40.2)			1.058 (40.1)		
Age	years	14.104	69.7 ± 13.9	73.0	11.463	69.7 ± 13.9	73.0	2.641	69.8 ± 13.9	73.0
BMI		14.010	27.0 ± 5.9	26.2	11.379	27.0 ± 5.9	26.2	2.631	27.0 ± 5.9	26.1
Vintage	days	14.104	1.451 ± 1.680	866	11.463	1.480 ± 1.708	898	2.641	1.325 ± 1.544	716
RRT type	HD	11.777 (83.9)			9.450 (88.6)			2.327 (93.4)		
	HDF	1.320 (7.8)			1.164 (10.9)			166 (6.3)		
	HF	55 (0.4)			46 (0.4)			9 (0.4)		
Treatment time min/week		14.104	762.8 ± 151.4	750	11.463	765 ± 153	750	2.641	753 ± 143	737
Epoetin dose IE/week		14.104	8.139 ± 6.303	6000	11.463	8.025 ± 6.362	6.000	2.641	8.634 ± 6.014	8.000
Epoetin application	i.v.	12.433 (93.4)			10.424 (96.7)			2.009 (79.3)		
	s.c.	877 (6.6)			354 (3.3)			523 (20.7)		
Iron medication		10.172 (72.1%)			8.169 (71.4)			1.985 (75.1)		
ACEI therapy		2.088 (14.8%)			1.733 (15.1)			355 (13.4)		
ARB therapy		1.728 (12.3%)			1.377 (12.0)			351 (13.3)		
Ferritin	µg/l	10.989	619 ± 492	507	8.759	629 ± 501	513	2.230	582 ± 455	474
Transferrin saturation	%	9.079	25.3 ± 12.0	23.0	7.440	25.7 ± 12.4	23.0	1.639	23.7 ± 10.8	21.5
S-Albumin	g/dl	12.940	37.6 ± 4.9	38.0	10.438	37.6 ± 4.9	38.0	2.502	37.5 ± 4.9	38.0
PO4	mmol/l	14.060	1.71 ± 0.53	1.65	11.427	1.70 ± 0.53	1.65	2.633	1.74 ± 0.52	1.68
Total Ca	mmol/l	13.534	2.23 ± 0.19	2.22	11.064	2.23 ± 0.19	2.23	2.470	2.21 ± 0.19	2.21
iPTH	pg/ml	11.174	252 ± 256	184	8.986	253 ± 260	184	2.188	248 ± 243	181
MCV	fl	6.484	95.6 ± 6.6	95.3	5.138	95.5 ± 6.7	95.2	1.346	95.6 ± 6.6	95.5
Hb	g/dl	13.973	11.2 ± 1.3	11.2	11.372	11.2 ± 1.3	11.2	2.601	11.2 ± 1.3	11.2
Hkt	%	11.735	34.4 ± 4.2	34.4	9.412	34.4 ± 4.2	34.3	2.323	34.3 ± 4.2	34.2
spKt/V		14.104	1.53 ± 0.46	1.50	11.463	1.54 ± 0.47	1.50	2.641	1.46 ± 0.40	1.40
CRP	negative	3.561 (34.8)			2.770 (34.4)			791 (36.5)		
	positive	6.662 (65.2)			5.283 (65.6)			1.379 (63.5)		

BMI Body mass index, CRP C-reaktives Protein, ESA Erythropoese-stimulierendes Agens, DM Diabetes mellitus, Hb Hämoglobin, iPTH intaktes Parathormon, I.E: internationale Einheit, S-Albumin Serum-Albumin, TSAT Transferrinsättigung, spKt/V Single-Pool Kt/V.

Tabelle 7: Retrospektive Analyse der QuasyNet Datenbank des Verbandes Deutscher Nierenzentren e.V.. Analysiert wurden die Daten von n=11.463 Hämodialyse Patienten unter Epoetin alfa Behandlung und n=2.641 Hämodialyse Patienten unter Epoetin zeta Behandlung. Unter Epoetin alfa wurde ein um 8% niedriger Dosisbedarf im Vergleich zu Epoetin zeta beobachtet (Regressionskoeffizient -0,0597; 95% KI -0,11319, -0,00615; p=0,029) [93, 94].

Tabelle 2.

Faktoren, die unabhängig mit der ln-transformierten Epoetin-Dosis assoziiert sind (n = 3.543)

Abhängige Variable: ln-transformierte Epoetin-Dosis	Regressions- koeffizient	p-Wert	95 % Konfidenzintervall	
			Unteres Limit	Oberes Limit
(konstant)	11,043504	0,000	10,683906	11,403102
Alter	-0,007222	0,000	-0,008907	-0,005537
BMI	-0,007784	0,000	-0,011862	-0,003706
spKt/V	-0,151273	0,000	-0,204015	-0,098531
Gefäßzugang	0,156380	0,000	0,104738	0,208022
DM vs. kein DM	-0,060276	0,016	-0,109454	-0,011098
Eisenmedikation	0,136986	0,000	0,078676	0,195296
Ferritin	0,000076	0,006	0,000022	0,000131
Transferrinsättigung	-0,009440	0,000	-0,011718	-0,007162
CRP	0,151661	0,000	0,102631	0,200691
Albumin	-0,023771	0,000	-0,028945	-0,018598
iPTH	-0,000122	0,008	-0,000212	-0,000031
Hb	-0,048020	0,000	-0,066013	-0,030027
Epoetin-Typ (alfa vs. zeta)	-0,059667	0,029	-0,113190	-0,006145

BMI Body mass index, CRP C-reaktives Protein, ESA Erythropoese-stimulierendes Agens, DM Diabetes mellitus, Hb Hämoglobin, iPTH intaktes Parathormon, I.E: internationale Einheit, S-Albumin Serum-Albumin, TSAT Transferrinsättigung, spKt/V Single-Pool Kt/V.

Wir lehnen die automatische Substitution zwischen Epoetin alfa und Epoetin zeta durch Apotheken aus den geschilderten Gründen ab (keine Bioäquivalenz bewiesen). Die Risiken stehen in keinem Verhältnis, zumal sich eine mögliche Kosteneinsparung nicht begründen lässt.

[...] Im Review [105] werden 5 Jahre nach Markteinführung von den Autoren Mikhail et al. die Daten aus der klinischen Praxis zu den Biosimilars Epoetin alfa (Abseamed® (Medice Arzneimittel Pütter, Iserlohn); Binocrit® (Sandoz GmbH, Kundl, Österreich); Epoetin alfa Hexal® (Hexal Biotech, Holzkirchen)) und Epoetin zeta (Retacrit® (Hospira, Lake Forest, USA); Silapo® (Stada, Bad Vilbel)) im Kontext zu den zur Zulassung eingereichten konfirmatorischen klinischen Studien diskutiert. Vergleichbare pharmakokinetische Profile (PK) der Biosimilars mit dem Referenzprodukt (Eprex®, Erypo®, Janssen-Cilag, New York, USA) sind nicht ausreichend für die Annahme einer ebenso gegebenen Vergleichbarkeit in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit der biotechnologisch hergestellten Arzneimittel. Obwohl die von der EMA geforderten Bioäquivalenzendpunkte der Biosimilars gegenüber dem Referenzprodukt erreicht wurden, zeigten diese Studien jedoch Limitationen hinsichtlich Studiendesign und -durchführung. Äquivalenzgrenzen sollten daher präziser definiert und eingehalten werden. Während Zielbereiche für Hämoglobinbereiche gesetzt und für eine Biovergleichbarkeit von Epoetinen eingehalten werden, geschieht dies für die Dosisbereiche der Epoetine nicht, bzw. nicht angemessen oder werden nicht eingehalten. Beispielhaft wird für SB309 der vordefinierte, aber nicht erreichte Dosisakzeptanzbereich angeführt, der in der Erhaltungsstudie einen Post-hoc Korrekturfaktor erforderte, um die Parameter in den angestrebten Bereich zu bringen. Trotz dieser Korrektur war für SB309 die Dosis annähernd 10 % höher als für Epoetin alfa.

Für die Autoren sind die Durchführung von Langzeit-Post-Marketing-Sicherheitsstudien (PMS, PASS) und entsprechende Risk Management Pläne von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung eines besseren Verständnisses der Langzeitsicherheitsprofile der zugelassenen biosimilaren Epoetine.

Diese Untersuchungen sollten, neben dem Wechsel vom Referenzprodukt auf ein Biosimilar Epoetin, auch Umstellungen zwischen Biosimilars umfassen und als Wechsel des klinischen Managements gesehen werden. Verordnende Ärzte/Ärztinnen sollten sich daher über die klinischen Auswirkungen des Wechsels zwischen biotechnologisch hergestellten Biosimilar-Epoetinen bewusst sein. Um eine seitens des Arztes/Ärztin nicht intendierte Substitution durch Apotheken zu vermeiden, wird die Verordnung des zur Therapie gewählten Epoetins auf Basis des Markennamens (brand name) empfohlen, damit einerseits eine effektive Pharmakovigilanz und andererseits, dass der Patient/Patientin das spezifizierte Biosimilar Epoetin erhält, sichergestellt ist. Diese Zielsetzung wurde in Leitlinien und der Gesetzgebung verschiedener europäischer Länder veröffentlicht und befürwortete die Vermeidung automatischer Substitution.

Über ein Jahrzehnt später nach Publikation dieses Reviews hat sich die Evidenzlage, insbesondere zur Umstellung von Biosimilar Epoetinen untereinander, kaum verändert. Dennoch wird in dem „Statement on the scientific rationale supporting Interchangeability of biosimilar medicines in the EU“ des Netzwerkes „Heads of Medicines Agencies“ (HMA, April 2023) auf die wissenschaftliche Austauschbarkeit hingewiesen, aber in keinerlei Weise belegt. In Kenntnis und im Bewusstsein, dass fundamentale Unterschiede nicht nur bei generischen, sondern auch bei biosimilaren Wirkstoffen bestehen, veröffentlichte die EMA Leitlinien, die die Bedeutung des Patienten/der Patientin und des Arztes/der Ärztin bei der Entscheidung zur Medikamentenverordnung und -wechsel anerkannten. Diese stellten heraus, dass bei Fragen zur Umstellung von einem auf ein anderes biotechnologisch hergestelltes Medikament der Patient/in mit seinem Arzt/seiner Ärztin und dem Apotheker/der Apothekerin sprechen sollte. Insbesondere bei chronisch erkrankten Patienten ist bei automatischer Substitution von häufigeren Umstellungen des Biosimilars auszugehen und das erhöht zusätzlich die Belastung

105 Mikhail A et al. (2013): Epoetin biosimilars in Europe: five years on. Adv Ther;30(1):28-40.

für den Patienten und das Risiko für die Patientensicherheit.

Auf Basis der vorgenannten bestehenden Unterschiede zwischen Biosimilars hinsichtlich Herstellung, Glykosylierungsprofil, Langzeitsicherheit und -verträglichkeit ist Evidenz zur Fragestellung der Austauschbarkeit untereinander erforderlich. Eine automatische Substitution biotechnologisch hergestellter Biosimilars kann daher nicht unterstützt und die Verordner sollten bei einer Umstellung umfänglich in den Prozess einbezogen werden. Zudem sind adäquate Maßnahmen zur Pharmakovigilanz, welche gestatten, unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen dem verantwortlichen Biosimilar zuzuordnen, zu ergreifen.

[...] Bei Arzneimitteln zur Injektion kann es neben möglicherweise abweichender Injektionsvolumina außerdem einen relevanten Unterschied machen, ob eine Spritze mit einem integrierten Nadelschutzsystem ausgerüstet ist und somit die Gefahr von Nadelstichverletzungen reduziert wird. Das betrifft sowohl die Eigenanwendung als auch den Schutz des medizinischen Personals vor Stichverletzungen und somit Infektionsgefahr, wenn das Arzneimittel z.B. im Rahmen der Dialyse verabreicht wird.

[...] Wir bitten den G-BA um Berücksichtigung unserer Argumente und darum, den wirkstoffübergreifenden Austausch zwischen den Biosimilars von Epoetin alfa und Epoetin zeta nicht zuzulassen.

Bei einem solchen Austausch würde mit einer grundsätzlichen Vorgabe der Substitution gebrochen, dass die Wirkstoffbezeichnung identisch sein muss. Gerade in der Eigenanwendung durch den Patienten kann dies zu einer großen Verunsicherung führen.

Die Konstellation zwischen Epoetin alfa und zeta und ihrem identischen Referenzarzneimittel ist auf der Anlage VIIa einzigartig [35] und sollte nicht als Kollateralschaden unter eine allgemeine Austauschregelung fallen, die zu keinem nennenswerten Kostenvorteil führt. Das Einsparpotenzial ist so gering, dass hier nicht ohne Not eine Verschlechterung des Gesundheitszustands der Patienten mit den entsprechenden Folgekosten in Kauf genommen werden sollte.

Merck Healthcare Germany GmbH (Merck)

Bei den zum Wirkstoff Follitropin alfa zugelassenem Originalarzneimittel GONAL-F®, sowie den verfügbaren Biosimilars Bemfola® und Ovaleap® handelt es sich um Arzneimittel zur Selbstapplikation. Das ärztliche Personal schult die Patienten in der Anwendung des verordneten Präparats unter Zuhilfenahme von Vorführ-Pens. Dies ist obligat, da sich die verschiedenen Injektionspens in ihrer Handhabung bezüglich der Dosiseinstellung, des Auslösemechanismus und des Einlegens der Ampullen deutlich unterscheiden.

Abschnitt ‚4.2 Dosierung und Art der Anwendung‘ der Fachinformationen von GONAL-f® sowie zu Bemfola® und Ovaleap® geben demnach eine klare Vorgabe zur Anwendung: „Die Behandlung mit GONAL-f [Follitropin alfa] sollte unter der Aufsicht eines Arztes eingeleitet werden, der in der Behandlung von Fertilitätsstörungen erfahren ist.“ bzw. „Art der Anwendung: Die erste Injektion von GONAL-f [Ovaleap / Bemfola] sollte unter direkter ärztlicher Aufsicht erfolgen.“

Ein Austausch auf Apothekenebene steht dem entgegen, da die Apotheke nicht einschätzen kann, ob es sich um eine Erstanwendung oder Folgeanwendung handelt. Der Arzt schult den Patienten in aller Regel bei Erstverschreibung auf die Handhabung des entsprechenden Injektionspens. Bei Austausch in der Apotheke könnte die Erstanwendung des ausgetauschten Medikaments somit ohne ärztliche Aufsicht entgegen den Regelungen in der Fachinformation erfolgen. Regulatorisch obliegt die Schulungs- und Aufsichtspflicht der Erstanwendung eindeutig dem behandelnden Arzt und nicht dem Apotheker. Die gesetzliche Regelung zu Information und Beratung in Apotheken nach §20 der Apothekenbetriebsordnung greift demnach in diesem Fall nicht. Zudem kann nicht regelhaft davon ausgegangen werden, dass der behandelnde Arzt ein aut-idem Kreuz setzt. Position B2 folgend würde der verordnende Arzt über das konkret ausgehändigte Präparat informiert werden und sollte der

Schulungspflicht gemäß Vorgabe in der Fachinformation nachkommen. Dies ist nach Aushändigung und womöglich bereits erfolgter Selbstapplikation zu spät und gefährdet den Therapieerfolg sowie die Patientensicherheit.

Oftmals sind reproduktionsmedizinische Zentren weit vom Wohnort des Patientenpaares und der ausliefernden Apotheke entfernt. Dies bedeutet, dass ein zusätzlicher Besuch beim Arzt, um die Schulung des ausgetauschten Medikaments zu erhalten, nicht nur die Patienten belastet, sondern auch weitere Ressourcen der Praxis bindet. Dabei ist es entscheidend, dass die Therapie an einem bestimmten Zyklustag beginnt. Ein verspäteter Zugang zu den notwendigen Medikamenten, aufgrund den logistischen Herausforderungen, könnte die gesamten Behandlungszyklus gefährden und den Therapieerfolg erheblich beeinträchtigen. Daher ist es unerlässlich, dass die Verantwortung für die Wahl des Arzneimittels und die damit verbundene Schulung beim behandelnden Arzt bleibt, um sowohl die Effizienz der Behandlung als auch die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.

Eine Ausnahmeregelung ist für Kurzzeittherapien erforderlich. Die erneute Schulung auf ein anderes Device bindet bei Kurzzeittherapien unverhältnismäßig viele Ressourcen. Bei Dauertherapien besteht zwar auch Schulungsbedarf, dieses bindet jedoch, relativ zu den Gesamtkosten, wenige Ressourcen. Das folgende Fallbeispiel verdeutlicht, dass die regulatorisch vorgegebene Schulungs- und Aufklärungspflicht des Arztes durch die vorgesehene Regelung unterminiert werden könnte.

Fallbeispiel:

- Ärztlicher Therapieplan: GONAL-f® 75 IE/d für 6 Tage, danach Ultraschallkontrolle und erneute Verordnung je nach Befund.
- 1. Verordnung: 1x450 IE GONAL-f® (1xN1); das aut-idem Kreuz wurde gesetzt.
- Die Apotheke nimmt keinen Austausch vor und gibt 1x450 IE GONAL-f® (1xN1) ab.
- 2. Verordnung nach Ultraschallkontrolle - Erhöhung der Dosis auf 150 IE/d für weitere 3 Tage; Verschreibung von 1x450 IE GONAL-f® (1xN1); kein aut-idem Kreuz gesetzt.
- Die Apotheke nimmt einen Austausch gegen Ovaleap® 450 IE (1xN1) vor.

Hieraus ergibt sich die folgende Problematik:

Die Apotheke kennt den ärztlichen Therapieplan nicht und weiß nicht, ob es sich um eine Erstanwendung oder Folgeverschreibung handelt bzw. wieviel Wirkstoff die Patientin täglich applizieren soll. Die Patientin wird innerhalb eines Zyklus mit zwei verschiedenen Präparaten behandelt und ist auf die neue Applikationshilfe nicht geschult. Bei der Folgeverschreibung handelt es sich um eine Erstanwendung von Ovaleap®, welche entgegen den Vorgaben in der Fachinformation nicht unter ärztlicher Aufsicht stattfinden würde. Eine Information an den behandelnden Arzt nach Aushändigung des Präparats und womöglich bereits erfolgter Selbstapplikation ist zu spät und gefährdet den Therapieerfolg sowie die Patientensicherheit.

Um dieser regulatorischen Vorgabe Folge zu leisten, den Therapieerfolg sowie die Patientensicherheit sicherzustellen, ist eine Austauschbarkeit auf Apothekenebene für Arzneimittel zur Selbstapplikation und Kurzzeitanwendung, deren Einleitung der Therapie unter ärztlicher Aufsicht gemäß Fachinformation (Abschnitt 4.2 Dosierung und Art der Anwendung) vorgeschrieben ist, zu streichen.

Merck schlägt deshalb folgende Anpassung des Absatz 1 vor:

„Die Pflicht zur Ersetzung des verordneten Arzneimittels gilt nicht, soweit der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin die Ersetzung des Arzneimittels ausgeschlossen hat. Ebenfalls gilt die Pflicht zur Ersetzung des verordneten Arzneimittels nicht, wenn es sich um ein Arzneimittel zur Selbstapplikation und Kurzzeitanwendung, deren Einleitung der Therapie unter ärztlicher Aufsicht gemäß Fachinformation (Abschnitt 4.2 Dosierung und Art der Anwendung) vorgeschrieben ist, handelt.“

[...] Die vorliegende Evidenz zu Follitropin alfa zeigt deutlich, warum ein behandelnder Arzt aus medizinischer Sicht das Originalpräparat bevorzugen könnte. Eine im Jahr 2021 publizierte Meta-Analyse zeigt eine signifikant höhere Schwangerschafts- und Lebendgeburtenrate unter GONAL-f® gegenüber den Biosimilars [106]. Dieser signifikante Unterschied zwischen den Präparaten bedeutet rechnerisch, dass jedes 6. Baby, welches unter GONAL-f® geboren wurde, unter einer Biosimilar – Therapie nicht geboren wäre. Diese Ergebnisse werden durch eine im Jahr 2025 publizierte Meta-Analyse und anhand Registerdaten aus Frankreich erneut bestätigt [107, 108].

Diese divergierenden klinischen Resultate zwischen dem Referenzarzneimittel und den Biosimilars beim Wirkstoff Follitropin alfa lassen sich durch Unterschiede im ausgewählten Zellklon, im Herstellungsprozess und somit im Glykolisierungsmuster sowie in den biologischen Prozessen erklären. Das Glykolisierungsmuster von GONAL-f® entspricht dem natürlichen Glykolisierungsmuster des Follitropin alfa einer jungen Frau in der Mitte des Zyklus [109, 110, 111, 112, 113].

Die vorliegende Evidenz deutet daher darauf hin, dass eine Kinderwunschtherapie unter GONAL-f® im Gegensatz zu den Biosimilars potenziell weniger Therapiezyklen benötigt, um zu einer erfolgreichen Schwangerschaft und Lebendgeburt zu führen. Da das Kinderwunschpaar einen großen Anteil der Kosten selbst trägt, würde ein Austausch auf Apothekenebene potenziell zu Mehrkosten für das Kinderwunschpaar und damit auch der Krankenkassen führen.

[...] Der G-BA führt in den tragenden Gründen zu Absatz 1 des vorliegenden Beschlusses aus, dass basierend auf der Zulassung des Biosimilars gemäß Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG, die gleiche Dosierung und der gleiche Verabreichungsweg wie das Referenzarzneimittel aufweisen sollte. Unterschiede bei der Zulassung sind nur gestattet, wenn sie keinen negativen Einfluss auf die Wirksamkeit haben (z.B. Unterschiede bei Hilfsstoffen, Pulver vs. fertige Injektionslösung, Spritze vs. Pen). Unterschiedliche Applikationsorte, Applikationswege und Applikationshäufigkeiten seien demnach nicht zu erwarten. Die Regelung des G-BA sieht weiterhin vor, dass bei einem Austausch die verordnete Wirkstärke und Packungsgröße identisch ist.

Dem ist entgegenzusetzen, dass bei einem Austausch der Follitropin alfa Präparate, mit gleicher Wirkstärke und Packungsgröße eine unterschiedliche Applikationshäufigkeit zu erwarten wäre. Dies ist auf die unterschiedlichen Anwendungsarten von Multidosis-Pens (GONAL-f® oder Ovaleap®) bzw. Monodosis-Pen (Bemfola®) zurückzuführen.

Der Injektionspen von GONAL-f® existiert mit einer Dosis von 150 IE, 300 IE, 450 IE oder 900 IE. Der Pen ist auf eine Mehrfach-Anwendung mit einstellbarer Dosierung ausgelegt (Multidosis-Pen), es können also mehrere Dosen mit demselben Pen verabreicht werden. Zudem handelt

106 Chua SJ et al. (2021): Biosimilar recombinant follitropin alfa preparations versus the reference product (Gonal-F(R)) in couples undergoing assisted reproductive technology treatment: a systematic review and meta-analysis. *Reprod Biol Endocrinol*;19(1):51.

107 Borget I et al. (2025): A Cost-Effectiveness Analysis of Gonadotropins Used for Ovarian Stimulation during Assisted Reproductive Technology Based on Data from the French Nationwide Claims Database (SNDS). *Gynecol Obstet Invest*;90(3):211-25.

108 Kiose KI et al. (2025): Biosimilars versus the originator of follitropin alfa for ovarian stimulation in ART: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod*;40(2):343-59.

109 Orvieto R et al. (2016): Biosimilar FSH preparations- are they identical twins or just siblings? *Reprod Biol Endocrinol*;14(1):32.

110 Santi D et al. (2014): Biosimilar recombinant follicle stimulating hormones in infertility treatment. *Expert Opin Biol Ther*;14(10):1399-409.

111 Mastrangeli R et al. (2017): In-vivo biological activity and glycosylation analysis of a biosimilar recombinant human follicle-stimulating hormone product (Bemfola) compared with its reference medicinal product (GONAL-f). *PLoS One*;12(9):e0184139.

112 Fachinformation GONAL-f. Stand Januar 2025.

113 Bemfola: EPAR – Product Information.

es sich bei GONAL-f® um einen Pen, der sofort einsatzbereit ist („ready-to-use“). Beim Ovaleap®-Pen handelt es sich zwar ebenfalls um einen Multidosis-Pen und ist in den Wirkstärken 300 IE, 450 IE oder 900 IE verfügbar, jedoch muss die Patientin bei jedem Behandlungszyklus vor dem Gebrauch erneut eine Wirkstoffkartusche einsetzen.

Bemfola® hingegen ist in den Dosen von 75 IE, 150 IE, 225 IE, 300 IE und 450 IE verfügbar und nur als Monodosis-Pen verwendbar. Die Dosis kann bei Bedarf angepasst, der Pen jedoch nur einmal verwendet werden. Anschließend wird der Pen zusammen mit dem restlichen Wirkstoffinhalt entsorgt.

Das folgende Fallbeispiel zeigt, dass ein Austausch zwischen Multidosis-Pen und Monodosis-Pen unter Berücksichtigung der Abgabe der gleichen Wirkstärke und Packungsgröße nicht möglich ist, um dem ärztlichen Therapieplan zu befolgen.

Fallbeispiel:

- Ärztliche Therapieplan: GONAL-f® 75 IE/d für 6 Tage
- Verordnung: 1x450 IE GONAL-f® (1xN1)
- Die Apotheke nimmt einen Austausch gegen Bemfola® 450 IE (1xN1) vor.

Hieraus ergibt sich die folgende Problematik:

Die Apotheke ist gemäß der hier diskutierten Regelung verpflichtet, einen Austausch gegen ein Biosimilar mit identischer Wirkstärke und Packungsgröße vorzunehmen. In diesem Zusammenhang würde der Apotheker, aufgrund Unkenntnis der verordneten täglichen Dosierung einen Austausch gegen einen Monodosis-Pen vornehmen, welcher inkompatibel mit dem Therapieplan ist. Die Apotheke orientiert sich hierbei an Anlage VIIa und geht davon aus, dass die regulatorischen Hintergründe bei der Aufführung der Referenzarzneimitteln und dazugehörigen Biosimilar hinreichend dargestellt sind. Da der Arzt einem Austausch nicht ausdrücklich widersprochen hat, bzw. kein Rabattvertrag vorliegt, würde nun in der Apotheke ein Austausch von 450 IE GONAL-f® (1xN1) gegen 450 Bemfola® (1xN1) stattfinden. Die Patientin kann nun zwar die Dosis des Bemfola® Pens auf 75 IE einstellen, muss anschließend den Pen mit dem restlichen Wirkstoffinhalt jedoch entsorgen, da es sich um einen Monodosis-Pen handelt. Demnach kann die Patientin den Anweisungen des Arztes nicht folgen und verfügt über keinen Wirkstoff mehr für Tag 2 bis 6.

Diesem Umstand zufolge haben die Arzneimittelbehörden von Finnland und Norwegen, welche die Biosimilar-Substitution auf Apothekenebene bereits umsetzen, Gonal-f® von dem Austausch ausgeschlossen. Die norwegische Arzneimittelbehörde „Statens legemiddelverk“ äußert sich hierzu wie folgt (Übersetzung): „Nach einer umfassenden Bewertung hat das Arzneimittelverzeichnis entschieden, dass Bemfola und Gonal-f nicht medizinisch gleichwertig sind. Die oben genannten Arzneimittel werden daher nicht in die Austauschliste aufgenommen.“ [114, 115].

Um die Patientensicherheit zu gewährleisten und den Unterschieden in der Applikationshäufigkeit und Handhabung der Multi- vs. Monodosis-Pens zu gewährleisten, ist eine Klarstellung in Anlage VIIa erforderlich. Der G-BA führt bereits aus, dass sofern dennoch abweichende Applikationsarten zugelassen sind, dies in Anlage VIIa jeweils mit einem entsprechenden Klammerzusatz sowie in getrennten Zeilen aufgeführt wird. Die von Merck vorgebrachte Forderung (Punkt 1 der Stellungnahme), Arzneimittel zur Selbstapplikation und Kurzzeitanwendung, deren Einleitung der Therapie unter ärztlicher Aufsicht gemäß Fachinformation vorgeschrieben ist, zu streichen, bleibt hiervon unberührt. Eine Anpassung der Anlage VIIa ist dennoch notwendig, da auch die Regelungen von §40a der Arzneimittel-Richtlinie auf diese Anlage verweisen.

114 Statens legemiddelverk: Beslutning om opptak på byttelisten for follitropin alfa. 2022.

115 Fimea: List of substitutable medicinal products. 2025.
https://fimea.fi/en/databases_and_registries/substitutable_medicinal_products

Merck schlägt die folgende Anpassung und Vermerk als Fußnote in Anlage VIIa vor.

Wirkstoff	Original-/Referenzarzneimittel	im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel, Zulassung nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilars)
1	2	3
[...]		
Follitropin	GONAL-f (Follitropin alfa) (Applikation mit Multidosis-Pen) ¹	Ovaleap (Follitropin alfa) (Applikation mit Multidosis-Pen) ²
		Bemfola (Follitropin alfa) (Applikation mit Monodosis Pen) ³
	Puregon (Follitropin beta)	
	Rekovelte (Follitropin delta)	
[...]		
1 Die Angaben in Abschnitt 4.2 Dosierung und Art der Anwendung der Fachinformation sind bei Erstanwendung zu beachten. 2 Die Angaben in Abschnitt 4.2 Dosierung und Art der Anwendung der Fachinformation sind bei Erstanwendung zu beachten. 3 Die Angaben in Abschnitt 4.2 Dosierung und Art der Anwendung der Fachinformation sind bei Erstanwendung zu beachten.		

Pfizer

Der Gemeinsame Bundesausschuss muss sich schließlich davon überzeugen, dass es bei dem biologischen Referenzarzneimittel bzw. den jeweiligen Biosimilars keine sonstigen medizinisch-therapeutischen Gründe gibt, die einer regelhaften Substitution entgegenstehen können. Trotz identischer Anwendungsgebiete und klinischer Belege für alle diese Anwendungsgebiete kann es produktspezifische, populationsspezifische oder erkrankungs-spezifische Gründe geben, die im Allgemeinen einer automatischen Substitution entgegenstehen. Es ist die Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses, im Rahmen der Feststellung der Austauschbarkeit auch zu prüfen, ob derartige Gründe vorliegen.

[...] So ist vollkommen unbekannt, welche Konsequenzen die **bestehenden und nachweislichen Unterschiede der Aminosäuresequenz** bei Benepali® und Erelzi® untereinander und vom Referenzarzneimittel Enbrel® auf eine Mehrfachumstellung von Patienten haben:

Im EPAR von Benepali® wird in Kapitel 2.2.3 beschrieben, dass die N-terminale Aminosäuresequenz von Benepali® und Enbrel® identisch sind. Die C-terminalen Aminosäuresequenzen von Benepali® und Enbrel® sind jedoch unterschiedlich (Benepali® enthält einen höheren Anteil einer Variante, deren C-terminales Lysin abgespalten ist; S. 16 Abs. 3 im EPAR) [116].

Ein Vergleich der terminalen Sequenzen von Enbrel® und Erelzi® zeigt Unterschiede sowohl am N-Terminus als auch am C-Terminus. Es wurden Varianten der N-terminalen Sequenz (TNF-alpha-Bindungsdomäne) identifiziert, in denen die N-terminalen Aminosäuren Leucin oder Leucin-Prolin fehlen (S. 19 und S. 20 des EPAR) [117]. Der C-Terminus enthält, wie bei Benepali®, eine Variante, deren C-terminales Lysin abgespalten ist (siehe S. 20 und S. 76 Abs. 2 des EPAR) [117].

116 Benepali: EPAR.

117 Erelzi: EPAR.

LPAQVAFTPY APEPGSTCRL REYYDQTAQM CCSKCSPGQH AKVFCTKTS D TVCDSCEDST
 YTQLWNWVPE CLSCGSRCSS DQVETQACTR EQNRICTCRP GWYCALSKE GCRLCAPLRK
 CRPGFGVARP GTETSDVVCK PCAPGTFST TSSTDICRPH QICNVVAIPG NASMDAVCTS
 TSPTSRMAPG AVHLPQPVST RSQHTQPTPE PSTAPSTSFL LPMGPSPPAE GSTGDEPKSC
 DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD
 GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK
 GQPREPQVYT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDS
 DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK

Abbildung 7: Aminosäuresequenz von Etanercept. Rot markierte Aminosäuren fehlen in den Varianten von Benepali®/Erelzi®. Blau hinterlegte Sequenz: Fc-Domäne des humanen IgG1 [118]

Es steht zwar nicht fest, ob die Varianten der terminalen Aminosäuresequenzen pharmakologische oder klinische Eigenschaften der Arzneimittel in bestimmten oder in allen Anwendungsgebieten beeinflussen (oder nicht). Eben diese bestehende Unsicherheit müsste jedoch in der Anlage VIIa deutlich zum Ausdruck kommen, um eine medizinisch-wissenschaftliche Entscheidung der Ärzte und Apotheker zu ermöglichen.

Neben der Unterscheidung der Wirkstoffe auf molekularer Ebene in der Glykosylierung und Tertiärstruktur sind zwischen Enbrel® und den zugelassenen Biosimilars ebenfalls klinische bzw. klinisch relevante Unterschiede festzustellen, die eine regelhafte Austauschbarkeit untereinander anzweifeln lassen:

Mit der Zulassung eines Biosimilars durch die Zulassungsbehörde werden die Qualität, die Sicherheit und die Wirksamkeit des Wirkstoffs im Vergleich zum Referenzarzneimittel überprüft. Gleichzeitig ist die Datenlage zur Sicherheit der Biosimilars durch die natürlicherweise limitierte Anzahl an Zulassungsstudien und klinischer Erfahrung begrenzt. Dies wird auch von Seiten der EMA, trotz Attestierung einer vergleichbaren Sicherheit, anerkannt und spiegelt sich in den Auflagen zur Beobachtung, Etablierung eines Risiko-Management-Plans und dem Nachreichen weiterer Daten nach erfolgter Zulassung wider. Hintergrund ist, dass die Datenlage zur Sicherheit für seltene sowie zeitlich bedingte Nebenwirkungen nicht in den Zulassungsstudien abgebildet werden kann.

Dementsprechend besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein relevanter Unterschied zwischen den Biosimilars und dem Referenzarzneimittel, der in der klinischen Praxis von Relevanz ist. Enbrel® als Referenzarzneimittel wird seit 25 Jahren eingesetzt und wurde in über 530 klinischen Studien untersucht. Diese fundierte Erfahrung wird durch kontinuierliche 10-Jahres-Sicherheitsdaten gestützt. Aus diesen Daten geht ein gut charakterisiertes Sicherheitsprofil hervor, worauf sich der Patient und der behandelnde Arzt verlassen können. Demgegenüber stehen die begrenzten Sicherheitsdaten aus den Zulassungsstudien für Erelzi® mit einem Zeitraum von lediglich 52 Wochen [117] und für Benepali® mit einem Zeitraum von bis zu 2 Jahren [116].

Betrachtet man die im EPAR vorgelegten Sicherheitsdaten von Erelzi®, sticht hervor, dass folgende Sicherheitsereignisse im Vergleich zu Enbrel® erhöht waren: Neoplasien (6 Fälle unter Erelzi®, 1 Fall unter Enbrel®), Pilzinfektionen (4 Fälle unter Erelzi®, 0 Fälle unter Enbrel®) – Sicherheitsereignisse, die zum einen auf die immunsuppressive Natur zurückzuführen sind, zum anderen aber auch zeitlich sensitiv sind und in Langzeitsicherheitsdaten erfasst werden müssen, um diese Unterschiede besser zu charakterisieren. Numerisch war in den vorgelegten Daten des EPARs von Benepali® die Rate an Malignomen erhöht im Vergleich zu Enbrel®. Auch die erhöhte Rate an unerwünschten Ereignissen im Bereich hepatobiliäre Erkrankungen (17 Fälle unter Benepali® bei 0 Ereignissen unter Enbrel®) bestärkt die Auffassung, dass es, um eine Signifikanz dieser Ereignisse und die damit verbundenen Bedenken auszuräumen, der

118 Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG). DRUG: Etanercept. https://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?D00742

Erhebung von Langzeitdaten bedarf, die erst in den nächsten Jahren durch Daten aus Registern sowie ggf. Langzeitverlängerungsstudien vorgelegt werden können. Gerade aufgrund der unterschiedlichen Aminosäuresequenzen können Langzeitsicherheitsdaten des Referenzarzneimittel nicht für die Biosimilars extrapoliert werden.

Vor dem Hintergrund dieser Unklarheiten in Bezug auf die Langzeitsicherheit und seltene unerwünschte Ereignisse kann von einer regelhaften Vergleichbarkeit der Biosimilars zu dem Referenzarzneimittel nicht ausgegangen werden, was auch in der Anlage VIIa zum Ausdruck kommen muss.

Das Fehlen von Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit von Biosimilars in unterschiedlichen Patientenpopulationen spiegelt sich auch in der Praxis wider, wo Referenzarzneimittel und Biosimilars unterschiedlich eingesetzt werden. Nach einer Publikation von Strangfeld et al. von Daten aus dem deutschen Biologika-Register RABBIT auf dem European-League-Against-Rheumatism (EULAR)-Kongress 2018 zeigt sich, dass Enbrel® häufiger bei Patienten mit mehr relevanten Komorbiditäten eingesetzt wird [119].

Biosimilars sind aufgrund von geringfügigen Unterschieden in den Sekundär- und Tertiärstrukturen in der Regel nicht identisch. Aus diesem Grund ist eine vergleichbare therapeutische Aktivität von Referenzarzneimittel und Biosimilar selbst auf Basis einer identischen Primärstruktur nicht notwendigerweise gegeben. Kleinste Veränderungen im Herstellungsprozess und der Handhabung der Zelllinien können sich auf die pharmazeutische Qualität und damit auf Sicherheit und Wirksamkeit der Arzneimittel auswirken. Gleichzeitig sind unterschiedliche pharmazeutische Hilfsstoffe, Applikationssysteme und Lagerungsvorschriften zu beachten. Jede einzelne Charge eines biopharmazeutischen Arzneimittels ist das Resultat einer prozessimmanenten Variabilität der Herstellung und daher zwangsläufig heterogen in den Grenzen der pharmazeutischen Spezifikationen der einzelnen Produkte. Aufgrund der Bedingungen von Zulassungsstudien der Biosimilars (u. a. Stichprobengröße, Studiendauer) ist keine absolute Sicherheit der Vergleichbarkeit von Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit von Enbrel® mit den anderen Etanercept-Präparaten gegeben. Therapierelevante Unterschiede können trotz des Vorliegens der arzneimittelrechtlichen Zulassung bestehen.

Dass geringfügige Veränderungen in der Formulierung von biotechnologisch hergestellten Proteinen dramatische Veränderungen in Bezug auf die Verträglichkeit auslösen können, ist hinlänglich bekannt. So wurde im Jahr 1998 die Formulierung des ersten EPO-Produkts Eprex® verändert, dabei wurde lediglich der Hilfsstoff humanes Serumalbumin gegen die Hilfsstoffe Polysorbat 80 und Glycin ausgetauscht. Dies führte jedoch bei mehr als 200 Patienten zur Bildung von neutralisierenden Antikörpern, die das endogene Erythropoetin neutralisierten. In der Folge entwickelten die Patienten eine schwerwiegende PRCA (pure red cell aplasia) [120].

Obwohl Benepali® von der EMA als Biosimilar von Enbrel® eingestuft worden ist, weist der European Public Assessment Report doch auf pharmakologische Unterschiede hin, die bei der Anlage VIIa zu berücksichtigen sind.

So wird etwa unter Kapitel 2.2.3. Finished Medicinal Product/Pharmaceutical Development (S. 13) Folgendes ausgeführt: „Considering that Benepali® is developed as a biosimilar of Enbrel®, the formulation would be expected to be very close to the originator formulation. This is the case, however some differences have been implemented as a result of the formulation development studies. These include the exclusion of L-arginine hydrochloride in the formulation” [116].

119 Strangfeld A et al. (2018): Retention rates for Etanercept: comparing the original with a biosimilar. European-League-Against-Rheumatism (EULAR)-Kongress. https://biologika-register.de/wp-content/uploads/2018/09/P63_Biosimilars_EULAR_2018.pdf

120 Boven K et al. (2005): The increased incidence of pure red cell aplasia with an Eprex formulation in uncoated rubber stopper syringes. Kidney Int;67(6):2346-53.

Tabelle 8: Hilfsstoffe der Etanercept-haltigen Arzneimittel.

	Liste der sonstigen Bestandteile	Art und Inhalt des Behältnisses
Enbrel®	Sucrose Natriumchlorid, Argininhydrochlorid Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat Wasser für Injektionszwecke	Klarglas-Spritze (Glastyp I) mit Edelstahlkanüle, <u>Kautschuk</u> -Verschlusskappe und Kunststoffkolben
Benepali®	Sucrose Natriumchlorid Natriumdihydrogenphosphat 1 H ₂ O Dinatriumhydrogenphosphat 7 H ₂ O Wasser für Injektionszwecke	Klarglas-Fertigspritze (Glastyp I) mit Edelstahlkanüle, <u>Gummi</u> -Kanülenschutz und Gummikolben mit 0,98 ml Lösung
Nepexto®	Natriumcitrat (Ph.Eur.) Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat Glycin Sucrose Natriumchlorid Wasser für Injektionszwecke	Klarglas-Spritze (Glastyp1) mit 27-Gauge-Edelstahlkanüle, Kanülenschutz und FluroTec-beschichtetem Brombutylgummi-Stopfen mit 0,5 ml Lösung
Erelzi®	<u>Zitronensäure</u> <u>Natriumcitrat</u> (Ph.Eur.) Natriumchlorid <u>Sucrose</u> <u>Lysinhydrochlorid</u> Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung) Salzsäure (zur pH-Wert Einstellung) Wasser für Injektionszwecke	Klare Spritze aus Typ-I-Glas mit einer 1,27 cm langen 27-Gauge-Edelstahlkanüle, einem Nadelschutzsystem mit Fingerauflage <u>Gummi</u> -Nadelschutzkappe und Kunststoffkolben, die 0,5 ml oder 1,0 ml Lösung enthält
Quellen: Fachinformationen [14, 15, 16, 22]		

In Kapitel 2.2.3. *Finished Medicinal Product/Biosimilarity* (S. 15 - 17) finden sich viele weitere Hinweise auf pharmakologische Unterschiede zwischen Enbrel® und Benepali®.

Auch in Bezug auf Erelzi® stellt der Assessment Report zum Teil bedeutende Unterschiede zu Enbrel® fest, die bei der Anlage IIIa zu berücksichtigen sind, u. a. in Kapitel 2.2.4 „Biosimilarity“ (S. 17–18), in Kapitel 2.3.2 „Pharmacology“ (S. 25) und in Kapitel 2.3.6 „Discussion on non-clinical aspects“ (S. 30) [117].

Auch die Angaben der Fachinformationen in Kapitel 6.4 „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung“ und Kapitel 6.6 „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung“ unterscheiden sich (siehe Tabelle 9). So soll der Patient bei Enbrel® und Erelzi® nach Entnahme aus dem Kühlschrank 15–30 Minuten warten, bis er sich eine Dosis verabreicht, bei Benepali® und Nepexto® aber ca. 30 Minuten.

Bei einem Patienten, der es gewohnt ist, sich Enbrel® oder Erelzi® nach 15 Minuten zu spritzen, bestünde das Risiko, dass er sich Benepali® nach der Hälfte der empfohlenen Zeit verabreicht. Auch dies ist bei der Anlage VIIa zu berücksichtigen.

Tabelle 9: Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Etanercept-haltige Arzneimittel (Fachinformationen).

	Enbrel® 25 mg/ 50 mg Injektionslösung in Fertigspritze	Nepexto® 25 mg/ 50 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze bzw. 50 mg im Fertigpen	Benepali® 25 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze	Erelzi® 25mg /50mg Injektionslösung in einer Fertigspritze bzw. 50 mg im Fertigpen
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung	Im Kühlschrank lagern (2°C bis 8°C). Nicht einfrieren. Enbrel kann für einen einmaligen Zeitraum von bis zu 4 Wochen bei Temperaturen bis maximal 25 °C aufbewahrt werden. Danach darf es nicht wieder gekühlt werden. Enbrel muss vernichtet werden, wenn es nicht innerhalb von 4 Wochen nach Entnahme aus der Kühlung verwendet wird. Die Fertigspritzen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.	Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Nicht einfrieren. Die Fertigspritzen oder Fertigpens im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Nepexto kann für einen einmaligen Zeitraum von bis zu 4 Wochen bei Temperaturen bis maximal 25 °C aufbewahrt werden. Danach darf es nicht wieder gekühlt werden. Nepexto muss entsorgt werden, wenn es nicht innerhalb von 4 Wochen nach Entnahme aus der Kühlung verwendet wird.	Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Nicht einfrieren. Die Fertigspritzen/ Fertigpens im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Nachdem Sie eine Spritze oder einen Pen aus dem Kühlschrank genommen haben, warten Sie ca. 30 Minuten, damit die Benepali-Lösung in der Spritze oder dem Pen Raumtemperatur erreichen kann. Erwärmen Sie Benepali nicht auf andere Art und Weise. Danach wird die sofortige Verwendung empfohlen. Benepali kann für einen einmaligen Zeitraum von bis zu 4 Wochen bei Temperaturen bis maximal 25 °C aufbewahrt werden. Danach darf es nicht wieder gekühlt werden. Benepali muss entsorgt werden, wenn es nicht innerhalb von 4 Wochen nach Entnahme aus der Kühlung verwendet wird.	Im Kühlschrank lagern (2°C bis 8°C). Nicht einfrieren. Die Fertigspritzen und Fertigpens im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Nachdem die Fertigspritze bzw. der Fertigpen aus dem Kühlschrank genommen wurde, ca. 15 bis 30 Minuten warten, damit die Erelzi-Lösung Raumtemperatur erreichen kann. Erelzi nicht auf andere Art und Weise erwärmen. Danach wird die sofortige Verwendung empfohlen. Erelzi kann für einen einmaligen Zeitraum von bis zu 4 Wochen bei Temperaturen bis maximal 25 °C aufbewahrt werden. Danach darf es nicht wieder gekühlt werden. Erelzi muss vernichtet werden, wenn es nicht innerhalb von 4 Wochen nach Entnahme aus der Kühlung verwendet wird.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung	Vor der Injektion sollte die Enbrel-Einweg-Fertigspritze Raumtemperatur erreicht haben (ca. 15 bis 30 Minuten). Die Verschlusskappe sollte bis zum	Vor der Injektion sollte die Nepexto-Einweg-Fertigspritze Raumtemperatur erreicht haben (etwa 30 Minuten). Die Lösung darf nicht auf andere	Vor der Injektion sollte die Benepali-Einweg-Fertigspritze Raumtemperatur erreicht haben (ca. 30 Minuten). Der Kanülenschutz sollte bis zum Erreichen	Vor der Injektion sollte die Erelzi-Einweg-Fertigspritze Raumtemperatur erreicht haben (ca. 15 bis 30 Minuten). Die Nadelschutzkappe

	Enbrel® 25 mg/ 50 mg Injektionslösung in Fertigspritze	Nepexto® 25 mg/ 50 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze bzw. 50 mg im Fertigpen	Benepali® 25 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze	Erelzi® 25mg /50mg Injektionslösung in einer Fertigspritze bzw. 50 mg im Fertigpen
	Erreichen der Raumtemperatur nicht von der Fertigspritze entfernt werden. Die Lösung muss klar bis leicht opaleszent, farblos bis blassgelb oder blassbraun sein und kann kleine lichtdurchlässige oder weiße Proteinpartikel enthalten.	Weise erwärmt werden. Anschließend ist sofortige Anwendung empfohlen. Der Kanülenschutz sollte bis zum Erreichen der Raumtemperatur nicht von der Fertigspritze entfernt werden. Die Lösung muss klar bis opaleszent, farblos bis gelb sein und kann kleine lichtdurchlässige oder weiße Proteinpartikel enthalten.	der Raumtemperatur nicht von der Fertigspritze entfernt werden. Die Lösung muss klar bis leicht opaleszent, farblos oder blassgelb sein und kann kleine lichtdurchlässige oder weiße Proteinpartikel enthalten.	sollte bis zum Erreichen der Raumtemperatur nicht von der Fertigspritze entfernt werden. Die Lösung muss klar bis leicht opaleszent, farblos bis leicht gelblich sein und kann kleine lichtdurchlässige oder weiße Proteinpartikel enthalten.
Quellen: Fachinformationen [14, 15, 16, 22]				

[...] Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich gegen die vorgesehen Austauschbarkeit der Darreichungsformen. So ist Enbrel® der einzige Etanercept-haltige TNF-alpha-Inhibitor, der auch in Form eines Pulvers zur Herstellung einer Injektionslösung zugelassen ist und bietet für Patienten, die auf Stoffe in Lösung wie z.B. in Fertigspritzen oder Pens reagieren, die einzige Möglichkeit Etanercept zu erhalten [15].

[...] Ein weiteres Beispiel ist unser Präparat Amsparity® mit dem Wirkstoff Adalimumab. Dieses Präparat ist zugelassen u. a. für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis, Psoriasis und der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen M. Crohn und Colitis ulcerosa [12].

Obwohl alle zugelassenen Adalimumab-Biosimilars eine vergleichbare Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität zum Referenzarzneimittel aufweisen, bestehen relevante Unterschiede in Formulierung, Applikation und Handhabung, die eine pauschale Austauschbarkeit ausschließen. Dies wird auch durch die Analyse von Abitbol et al. (2023) [121] unterstrichen, die eine Vielzahl produktbezogener Unterschiede zwischen den Biosimilars dokumentiert:

1. **Citratfreiheit:** Amsparity® ist – im Gegensatz zu einigen anderen Biosimilars – citratfrei formuliert. Citrat wird häufig als Pufferstoff eingesetzt, kann jedoch bei subkutaner Injektion das Schmerzempfinden an der Injektionsstelle erhöhen [Abitbol et al., 2023, S. 6, 121]. Ein Wechsel von einem citratfreien zu einem citrathaltigen Produkt kann somit die Injektionsverträglichkeit verschlechtern und die Therapietreue beeinträchtigen.
2. **Nadelgröße:** Amsparity® verwendet 29G-Nadeln, während andere Biosimilars teilweise dickere 27G-Nadeln einsetzen. Größere Nadeldurchmesser können mit einem erhöhten Schmerzempfinden einhergehen. Für schmerzempfindliche oder nadelängstliche Patienten kann dies ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl des geeigneten Adalimumab-Präparats sein.
3. **Latexfreiheit:** Amsparity® ist latexfrei, während einige andere Biosimilars Bestandteile aus

121 Abitbol V et al. (2023): Navigating adalimumab biosimilars: an expert opinion. J Comp Eff Res;12(11):e230117.

Naturkautschuklatex enthalten. Für Patienten mit Latexallergie stellt letzteres eine klare Kontraindikation dar. Ein unkritischer Austausch kann hier zu schwerwiegenden allergischen Reaktionen führen.

4. **Aufbewahrung:** Eine Amsparity®-Fertigspritze darf – anders als einige andere Biosimilars – bis zu 30 Tage bei Temperaturen bis maximal 30 °C gelagert werden. Diese verlängerte Haltbarkeit ist insbesondere für reisende Patienten oder solche ohne durchgängige Kühlung Lagerung von hoher praktischer Relevanz.

Diese Unterschiede verdeutlichen, dass die Auswahl eines geeigneten Adalimumab-Präparats – ob Referenzarzneimittel oder Biosimilar – patientenindividuell erfolgen sollte. Eine generelle Austauschbarkeit kann die Therapieerfahrung und -adhärenz negativ beeinflussen. Die differenzierte Bewertung der jeweiligen Produkteigenschaften ist daher essenziell für eine sichere und effektive Versorgung.

[...] Die Hilfsstoffe der einzelnen Präparate unterscheiden sich hinsichtlich der Konservierungsmittel, Tenside und Puffersysteme. Erwähnenswert ist hier insbesondere Omnitrope® (5 mg/1,5 ml) mit dem Konservierungsmittel Benzylalkohol und damit der Anwendungsbeschränkung bei Kindern < 3 Jahre, sowie bei Patienten mit einer Leber- oder Nierenerkrankung, aufgrund eines erhöhten Risikos für schwere allergische Reaktionen [122].

Roche

Die Aussage, dass Unterschiede in der Formulierung des Arzneimittels (z. B. Hilfsstoffe) keinen negativen Einfluss auf Sicherheit und Wirksamkeit haben, ist kritisch zu hinterfragen. Der Einfluss von Hilfsstoffen auf die Patientensicherheit ist nicht ausreichend untersucht. Hier sind die Positionen B1 und B2 maßgeblich.

Sanofi

Während die meisten Patient:innen, denen biotechnologisch hergestellte Arzneimittel verschrieben werden, in der Regel nur **eins** selbst anwenden, gibt es eine Besonderheit im Bereich der Insuline. Insulinpflichtige Patient:innen mit einer ICT (intensivierte konventionelle Therapie) erhalten **zwei** dieser Arzneimittel parallel, zumeist in unterschiedlichen Fertigpens: kurzwirksames und langwirksames Insulin. Meist unterscheiden Patient:innen diese anhand von Form und Farbe. Es kommt schon unter heutigen Bedingungen immer wieder vor, dass Patient:innen diese beiden Pens verwechseln, was zu einer schweren Hypoglykämie, ggf. mit Einweisung in die Notaufnahme, führen kann [123]. Dieses Sicherheitsrisiko wird durch die (wiederholte) Substitution auf Apothekenebene deutlich verstärkt, da die Patient:innen mit den immer wieder substituierten Insulin-Fertigpens nicht vertraut sind. Diese Problematik betrifft über 500.000 Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 1 und Typ 2.

Auch einer weiteren Problematik wird der Entwurf des §40c AM-RL nicht gerecht: Es gibt Biopharmazeutika, die zu ihrer Applikation auf spezifische Medizinprodukte angewiesen sind – sowohl aufgrund der Zulassung als auch aufgrund technischer Spezifikationen. Ein verbreitetes Beispiel hierfür sind Insulinpatronen, die in der Regel nur mit bestimmten Insulinpens (Hilfsmittelverzeichnis des GKV-SV Produktgruppe 30, Untergruppe: 30.29.02 – Insulinpens) verwendet werden können und dürfen [35, 124, 125, 126]. Bei einem Austausch solcher Insulinpatronen kommt entweder der Patient in die Situation, dass der vorhandene Insulinpen nicht mehr für das ausgetauschte Insulin passt bzw. damit nicht verwendet werden darf oder es muss als Folge des Austauschs ein passender Insulinpen verschrieben/abgegeben werden. Ersteres gefährdet die Patientensicherheit und -versorgung, während Letzteres

122 Omnitrope. Gebrauchsinformation – Information für den Patienten. Stand Januar 2024.

123 Geller AI et al. (2021): Outpatient insulin-related adverse events due to mix-up errors: Findings from two national surveillance systems, United States, 2012–2017. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*;30(5):573-81.

124 Fachinformation Lantus. Stand Juli 2020.

125 Fachinformation Apidra. Stand Juli 2020.

126 Fachinformation Insulin lispro Sanofi. Stand Juli 2020.

unwirtschaftlich ist, da die Kosten eines neuen Pens die möglichen Einsparungen durch den Austausch nicht nur zunichtemachen, sondern ggf. sogar zu Mehrkosten führen würden. Diese Problematik betrifft über 100.000 Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 1 und Typ 2. Zur Vermeidung dieser Problematik regt Sanofi die Bildung einer Substitutionsausschlussliste für biotechnologisch hergestellte Arzneimittel und die subsequeunte Aufnahme von Insulinpatronen auf diese Liste an.

Stadapharm

Ein weiterer medizinisch relevanter Risikofaktor liegt in den unterschiedlichen Applikationsformen und Exzipientien der verschiedenen Biosimilars. Diese Unterschiede umfassen Injektionsvolumina, Nadeldurchmesser, Formulierungen mit oder ohne Citrat sowie die Verfügbarkeit von Fertigpens oder Fertigspritzen.

[...] Ein bedeutender medizinischer Aspekt ist das Risiko immunologischer Reaktionen bei Präparatewechsel [66, 67]. Auch wenn die EMA im Rahmen der Zulassung umfassende Prüfungen zur Immunogenität verlangt, können sich bei Wechseln zwischen verschiedenen Präparaten Unterschiede im Sicherheitsprofil zeigen. Es besteht die Möglichkeit, dass durch geringfügige strukturelle Abweichungen im Protein oder durch andere Hilfsstoffe unerwünschte Immunantworten ausgelöst werden.

Besonders kritisch ist hierbei die potenzielle Bildung neutralisierender Antikörper, die nicht nur die Wirksamkeit des aktuellen Medikaments beeinträchtigen können, sondern auch die gesamte Wirkstoffklasse unbrauchbar machen. Dies ist insbesondere bei der Behandlung mit TNF-alpha-Hemmern von klinischer Relevanz.

vfa

[...] Auch ein Wechsel des Devices ist mit möglichen Risiken verbunden. Gerade bei besonders vulnerablen Patientenkollektiven mit hoher Sensitivität gegenüber allergenen Reizen kann es mitunter auch zu anaphylaktischen Ereignissen kommen, sollte nicht das gewohnte Device verwendet werden, beispielsweise aufgrund einer veränderten Zusammensetzung des Gummistopfens. Auch Arzneimittel mit variabler und multipler Dosierung sind anfälliger für Fehlanwendung und sollten daher nicht substituiert werden. Um diesen vielfältigen Problematiken Sorge zu tragen, stellt die Bildung einer Substitutionsausschlussliste für Biopharmazeutika aus Sicht des vfa eine gangbare Lösung dar. Um die Unbedenklichkeit einer Substitution möglichst sicherzustellen, ist auch der Ansatz denkbar, Präparate erst nach eingehender Prüfung als geeignet für eine mögliche Substitution zu listen – unter Berücksichtigung der genannten relevanten Aspekte.

AkdÄ

[...] Weiterhin wird [...] darauf hingewiesen, dass sich die einzelnen Arzneimittel hinsichtlich der Injektionsvolumina, der Handhabung und der Packungsausstattung unterscheiden können und deswegen zu befürchten sei, dass mehrfache Therapiewechsel auch aus diesen Gründen Anwendungsfehler und Nicht-Adhärenz begünstigen könnten.

Auf die Probleme der unterschiedlichen Handhabung der einzelnen Arzneimittel, die von den Patienten selbstständig subkutan appliziert werden, hat die AkdÄ mehrfach hingewiesen. Die Applikation erfolgt mit einem Applikationssystem („Device“), das sich von Produkt zu Produkt unterscheidet. Damit weisen wirkstoffgleichen Biologika – Referenzarzneimittel und die jeweiligen Biosimilars – eine teilweise andere Handhabung des „Device“ zur Selbstapplikation auf. Die Handhabung muss dem Patienten in diesen Fällen in der Apotheke anhand geeigneter Maßnahmen wie z. B. Demonstrationsgeräten gezeigt und erklärt werden. Dabei ist unerheblich, ob ein Referenzarzneimittel gegen ein Biosimilar ausgetauscht wird oder wirkstoffgleiche Biosimilars untereinander. Solange der Arzt nicht weiß, welches Arzneimittel in der Apotheke abgegeben wird, kann diese Aufgabe nicht im Rahmen der ärztlichen Beratung erfolgen.

Dass unterschiedliche Injektionsvolumina klinisch relevante Unterschiede bedingen können, ist aus Sicht der AkdÄ unplausibel. Schließlich werden im Rahmen der klinischen Prüfungen, die für die Zulassung von Biosimilars erforderlich sind, die jeweiligen Fertigarzneimittel – Biosimilar sowie Referenzarzneimittel – im direkten Vergleich zueinander evaluiert und zeigen keine klinisch relevanten Unterschiede bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit.

DDG, gemeinsam mit Hautnetz Deutschland e. V. und BVDD

Die Wirkungen der Biosimilars resultieren nicht nur aus dem unmittelbaren Proteinanteil, sondern sie leiten sich auch aus den Begleitstoffen ab. Diese wirken sich nach klinischer Erfahrung mit Blick auf die Verträglichkeit nach Injektion maßgeblich aus, etwa aufgrund eines z.T. vorhandenen Zitrats-Anteils. Aus allergologischer und dermatologischer Sicht muss daher widersprochen werden, dass der freie Wechsel zwischen den Biosimilars sicher ohne relevante neu auftretende Nebenwirkungen bleibt.

Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR)

Im Rahmen der Untersuchung fand nur ein Wechsel statt von einem citratfreien Originator zu einem anderen citratfreien Biosimilar. Citrat wird als Puffer zur Stabilisierung des Medikamentes eingesetzt, führt jedoch zu einem erhöhten Injektionsschmerz und zu einer stärkeren lokalen Reaktion mit Brennen und Schmerzen. Dieses Problem stellte sich sowohl in der Untersuchung von Thiele, 2021 [127] als auch in der aktuellen Übersicht dar.

*Die Biosimilar sind nicht homogen citratfrei. Es ergeben sich noch weitere **Hilfsstoffvariabilitäten**, so z. B. kann der Säuregrad (pH-Wert) differieren, die verwendete Säure (Essigsäure in Amgevita® und Yufluma®, Zitronensäure in Hyrimoz® und Imraldi®) sein, wobei einige Präparate keine Säuren enthalten und damit nicht „brennen“ oder auch andere bedeutsame Stabilisatoren betreffen. Sorbitol z. B. könnte bei Menschen mit Überempfindlichkeit Probleme verursachen.*

Auch unterscheiden sich die Medikamente mit identischen Inhaltsstoff auch hinsichtlich Volumens, Nadellänge und Nadelschliff, Art der Anwendung, wodurch die Akzeptanz der Medikamente unterschiedlich ausfallen kann.

Krankheitsbezogenes Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKNMS)

Die Sicherheitskriterien des hochwirksamen MS-Therapeutikums Natalizumab, das bei falscher Handhabung potenziell gefährlich ist, sind äußerst relevant. Die ursprüngliche Herstellerfirma Biogen hat etwa Mitte des letzten Jahrzehnts den Anti-JCV-Antikörpertest (STRATIFY JCV) entwickelt, wodurch es gelang das Risiko dieser immer noch schwerst behandelbaren Erkrankung durch engmaschige Überwachungsverfahren deutlich zu senken. Durch die Einführung und Zulassung des Biosimilars Tyruko ist in Deutschland eine neue Situation entstanden. Die publizierten Ergebnisse haben eine vergleichbare Wirksamkeit nahegelegt, was ich hier auch nicht bezweifeln möchte. Allerdings hat der verantwortliche Vertreter Sandoz mit seinen Generikafirmen hier einen eigenen Test entwickelt, der als sogenannter ImmunoWELL Test bezeichnet wird, der leider nicht die Gütequalität des oben zitierten STRATIFY-Testes erreicht. In führenden neurologischen Journalen wie JAMA Neurology, Gelissen 2025 [87], Multiple Sclerosis Ziemssen 2025 [88] sowie Vukusic Multiple Sclerosis 2025 [89] sehen Sie, dass beim direkten Vergleich am selben Patientenkollektiv der sogenannte ImmunoWELL Test bis zu 50 % positive Patientenergebnisse liefert, die zur Absetzung und Einstellung der Patienten/innen auf andere Medikationen führen würden. Im Vergleich dazu hat der parallel durchgeführte STRATIFY-Test nur 25 % positive und switchbedürftige Patienten gezeigt. Ab den genannten Grenzwerten der jeweiligen Teste beanspruchen diese für sich, dass das PML-Risiko so stark steigt, dass die Patienten umgestellt werden müssen.

127 Thiele F et al. (2021): Efficacy and Safety of Etanercept Biosimilars Compared With the Originator for Treatment of Juvenile Arthritis: A Prospective Observational Study. ACR Open Rheumatol;3(11):779-87.

Aus wissenschaftlicher Sicht interpretiere ich die Ergebnisse so, dass mit dem ImmunoWELL Test, der in Rumänien durchgeführt wird, bei der Hälfte der Patienten/innen folglich falsch positive Ergebnisse erzielt werden, die Umstellung auf andere Therapeutika erforderlich wäre und ggf. für die Patienten weniger aktive Therapien mit Schubrisiko nach sich ziehen würde. Dies kann nicht im Interesse der Allgemeinheit sein und insbesondere nicht unserer MS-Patienten/innen. Natürlich soll bei verlässlich hoch positivem Titer die Umstellung raschestmöglich auf z. B. Anti-CD20-Therapeutika erfolgen, aber nicht bei falsch positiven Testen.

[...] Ein Medikament, das wie das Natalizumab neben hoher Wirksamkeit auch schwere Risiken potenziell mit sich bringt, was Dokumentation und Patientenpass verpflichtend mit beinhaltet, sollte auch auf der Ebene dieser Tests absolute Sicherheit für die Patienten gewährleisten, und nicht aufgrund falsch positiver Ergebnisse zu einer unnötigen Umstellung führen. So verunsichern wir unsere mittlerweile 280.000 MS-Patienten in der Bundesrepublik Deutschland. Auch die Folgekosten für das Gesundheitssystem mit zusätzlichen kernspintomographischen Untersuchungen, häufigen Ambulanzbesuchen und Therapiewechsel mit neuen Sicherheitsüberprüfungen sollte bei solchen Entscheidungen mitberücksichtigt werden.

Psoriasis-Praxisnetz Süd-West e. V.

Bei biologischen Medikamenten handelt es sich um eine hochkomplexe, firmenspezifische Produktion von Antikörpern. Jeder Hersteller hat aber eine Reihe von Freiheiten z.B. bei den verwendeten Zusatz- und Konservierungsstoffen und bei der Auswahl des Applikationsgeräts, sodass es zu deutlichen Unterschieden in der Anwendung kommt.

*Eine derartige Verunsicherung des Patienten, welches Produkt er als nächstes in der Apotheke bekommt, ist aus unserer Sicht kritisch für die Akzeptanz. Biologische Therapien kommen aufgrund der Kosten nur bei sehr schwer betroffenen Patienten und erfolglosen Vorthapien zum Einsatz, d.h. Patient*innen haben schon einige Therapien durchlaufen, um diese Behandlung der höchsten Therapiestufe zu erhalten. Die positive Wertschätzung der Behandlung wird durch das beliebige Austauschen sicher verschlechtert; Ein solcher Nocebo-Effekt spart am Ende keine Kosten, sondern erhöht diese bei einer zügigen Um- und Neueinstellung auf ein teureres Originalpräparat einer anderen Substanzklasse.*

Wir möchten in diesem Zusammenhang auf die im Januar 2022 aktualisierte Leitlinie zur Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Schuppenflechte hinweisen, die bei schweren Verläufen die systemische Behandlung mit dem TNF alpha Inhibitor Adalimumab als „first line“ Erstlinientherapie aufgrund des hohen Erfahrungsgrades und Zulassungsstatus empfiehlt. Der oben beschriebene Aspekt trifft ganz besonders bei der Injektionstherapie von Kindern- und Jugendlichen bzw. der Aufklärung deren Eltern zu. Das oben beschriebene Ustekinumab besitzt ebenfalls eine Kinderzulassung und stellt mit einer Injektion alle 12 Wochen die nächste Empfehlung eines zukünftigen Leitlinienupdates dar (<https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/013-094.html>).

Bewertung:

Die Stellungnehmenden führen aus, dass neben dem Zulassungsstatus noch weitere medizinisch-therapeutische Gesichtspunkte zu berücksichtigen wären. Unterschiede bei den Arzneimitteln könnten hinsichtlich der Formulierung bzw. Verwendung unterschiedlicher Hilfsstoffe (z. B. Konservierungsmittel, Tenside, Puffersysteme) oder des Aussehens sowie bei den Injektionsvolumina (bei hoch- und niedrigkonzentrierten Lösungen) bestehen. Als mögliche Folgen dieser Abweichungen werden in den Stellungnahmen beispielhaft injektionsassoziierte Schmerzen, Brennen an der Einstichstelle oder am Beispiel eines Erythropoetin-haltigen Arzneimittels schwerwiegende Nebenwirkungen wie eine PRCA (pure red cell aplasia) geäußert. Außerdem könnten mit bestimmten Zusätzen in den Arzneimitteln (z. B. Sorbitol, Latex) auch Anwendungsbeschränkungen für bestimmte Personengruppen

(z. B. mit Intoleranzen) einhergehen. In einigen Stellungnahmen wird zudem ausgeführt, dass sich die Lager- und Transportbedingungen sowie die Haltbarkeit der Biologika unterscheiden würden und es somit zu einer Fehlanwendung oder Anwendung außerhalb des Empfehlungsrahmens kommen könne.

Die Zusammensetzung der Arzneimittel hinsichtlich ihrer Hilfsstoffe ist per se kein Kriterium, das zur Bewertung der therapeutischen Vergleichbarkeit herangezogen werden kann, da schwere Unverträglichkeiten gegenüber Hilfsstoffen, Patientenpräferenzen und Adhärenzprobleme patientenindividuell sind und bei jeder Arzneimitteltherapie auftreten können. Unterschiede zwischen Biosimilar und Referenzarzneimittel – z. B. in der Formulierung des Arzneimittels (Hilfsstoffe) – sind bei der Zulassung zudem grundsätzlich nur gestattet, wenn sie keinen negativen Einfluss auf die Sicherheit und keinerlei Einfluss auf die Wirksamkeit haben [61]. In Bezug auf schwerwiegende Nebenwirkungen bei Erythropoetin-haltigen Arzneimitteln ergeben sich aus der vorgelegten Studie Boven et al. [120] im Übrigen keine Hinweise auf generelle Auswirkungen auf die Immunogenität ausgehend von den Hilfsstoffen selbst. Vielmehr kam es durch eine Interaktion des verwendeten Gummikolbens mit dem Polysorbat 80 zu Auswaschungen in das Produkt, da kein Schutz durch einen Überzug gegeben war, und in Folge zu teils schwerwiegenden immunogenen Reaktionen. Die Verwendung inadäquater Packmittel ist ein grundsätzliches Problem und keines, das aus der Umstellung von Biologika oder deren Ersetzung durch Apotheken resultiert.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass sich der Produktaufbau hinsichtlich der Schutzvorrichtungen (z. B. integriertes Nadelschutzsystem) oder der Dosierbarkeit (Monodosis- vs. Multidosispens) unterscheiden könne. Bei einer Substitution gleicher Packungsgrößen der Mono- und Multidosispens – mangels Kenntnis des konkreten ärztlichen Therapieplans – könne es zu einem unnötigen Verwurf kommen. Unterschiedliche Devices würden eine spezifische Anwendung bedingen, welche bereits in der Praxis anhand konkreter Vorführ-Devices geschult werde. Eine erneute Schulung auf die Anwendung eines anderen Devices bzw. eine zusätzlich notwendige Verordnung könne – insbesondere bei einer Kurzzeittherapie – höhere Therapiekosten und einen zusätzlichen Aufwand bei Ärzten, Apotheken und Versicherten erzeugen.

Hinsichtlich des Einwands zu Mono- und Multidosispens ist zu entgegnen, dass ärztliche Verordnungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) eine Dosierung enthalten müssen. Dies gilt nicht, wenn dem Patienten ein Medikationsplan, der das verschriebene Arzneimittel umfasst, oder eine entsprechende schriftliche Dosierungsanweisung einer verschreibenden Person vorliegt und wenn die verschreibende Person dies in der Verschreibung kenntlich gemacht hat [...]. Aus diesen Mindestangaben der Verordnung ist demnach für die Apotheke der ärztliche Therapieplan in Bezug auf die erforderliche Applikationshäufigkeit ersichtlich und im Weiteren für die Beurteilung der Eignung zur Ersetzung eines potentiell abzugebenden Fertigarzneimittels in Bezug auf die erforderliche „Reichweite“ bei gleicher Packungsgröße heranzuziehen. Unklarheiten können ggf. durch Nachfrage bei den Versicherten beseitigt werden bzw. ist gemäß § 17 Absatz 5 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) bei Unklarheiten in der Verordnung durch Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin eine Klärung herbeizuführen.

Die Bedenken hinsichtlich möglicher Anwendungsprobleme der Versicherten bei abweichenden Applikationsmechanismen bzw. Handhabungen unterschiedlicher Devices können zwar für den medizinisch begründeten Einzelfall nachvollzogen werden, werden aber in Bezug auf die grundsätzliche Möglichkeit einer Austauschbarkeit biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel nicht geteilt. Denn die Kenntnis über die korrekte Handhabung oder Funktionsweise eines Devices ist auch unabhängig von einer Umstellungs- oder Ersetzungssituation relevant. Siehe ergänzend auch Bewertung zum Einwand 3.1.2.

Diese Einwände sprechen nicht per se gegen eine Ersetzung von Biologika, die zugrunde liegenden Besonderheiten sind bei der Arzneimittelverordnung sowie bei der Abgabe durch

die Apotheke zu berücksichtigen. Die Vermeidung von Fehlern bei der Applikation, die auch unabhängig von einer Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel auftreten können, ist ein wichtiger Teil der ärztlichen Therapie und auch der Beratung in der Apotheke. Die Notwendigkeit von Schulungen zur korrekten Anwendung und ihre Überprüfung wird nicht infrage gestellt. Generelle Ausschlüsse von der Ersetzungspflicht lassen sich hieraus allerdings nicht ableiten, da insofern keine therapeutischen Unterschiede bestehen.

Gemäß den Regelungen in § 40 Absatz 3, § 40a Absatz 5 sowie § 40c Absatz 1 AM-RL muss die Erwägung, von einer Umstellung/Ersetzung abzusehen, immer medizinisch bzw. therapeutisch begründbar sein. Arzneimittel, die über das Maß des Notwendigen hinausgehen oder unwirtschaftlich sind, weil sie gegenüber gleich geeigneten, ausreichenden und erforderlichen Mitteln teurer sind, sind aus dem Leistungskatalog der GKV grundsätzlich ausgeschlossen; dies ergibt sich bereits aus den allgemeinen Anforderungen des Wirtschaftlichkeitsgebots. Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit bedingt im Sinne des Minimalprinzips den Beleg, dass bei Existenz verschiedener gleich zweckmäßiger und notwendiger Behandlungsmöglichkeiten die Kosten für den gleichen zu erwartenden Erfolg geringer oder zumindest nicht höher sind. Daraus folgt, dass Annehmlichkeiten oder Gewohnheiten beispielsweise in der Arzneimittelanwendung keinen Sachgrund darstellen, von den Vorgaben des Wirtschaftlichkeitsgebots abzuweichen.

Ungeachtet der konkreten Verordnungsentscheidung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes für oder gegen die Ermöglichung einer Ersetzung des Arzneimittels, ist allerdings auch die Apotheke zur Beachtung von Sicherheitsanforderungen aufgrund der Fach- und Gebrauchsinformationen verpflichtet. In diesem Rahmen können sich auch für die Apotheke bestimmte patientenindividuelle Aspekte als relevant darstellen, die für die Ärztin oder den Arzt in Unkenntnis des konkreten, abzugebenden biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittels noch nicht berücksichtigt werden konnten. Patientenindividuell relevante Abweichungen der Arzneimittel hinsichtlich der Injektionsvolumina (z. B. Schmerzen bei größeren Volumina), der Handhabung (z. B. eingeschränkte Feinmotorik) und der Packungsausstattung (z. B. vorherige Rekonstitution der Injektionslösung) können beispielsweise einer Ersetzung entgegenstehen, soweit durch die Apotheke eine patientenindividuelle Gefährdung des Therapieerfolgs durch Nicht-Adhärenz oder Anwendungsfehler nicht vermieden werden kann. Grundsätzlich können bei entsprechender Kenntnis aber auch in der Vergangenheit aufgetretene Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Allergien der oder des Versicherten (z. B. Stammkunden mit Medikationshistorie) von der Apotheke Berücksichtigung finden.

Soweit bei einzelnen Versicherten trotz erfolgter Aufklärung, Schulung und Beratung durch die Apotheke dennoch eine Gefährdung des Therapieerfolgs durch Nicht-Adhärenz oder Anwendungsfehler nicht vermieden werden kann, soll mit dem Hinweis in Absatz 5 explizit klargestellt werden, dass dann ein Absehen von einer Ersetzung durch die Apotheke gemäß § 17 Absatz 5 ApBetrO gerechtfertigt ist.

Bei Vorliegen patientenindividueller Aspekte, die gegen eine Ersetzung sprechen, liegt es zunächst in der Verantwortung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes, nach ihrer/seiner ärztlichen Einschätzung zu entscheiden, ob er gemäß § 40c Absatz 1 im Einzelfall aus medizinischen Gründen die Ersetzung durch die Apotheke ausschließt. Die weitergehende Prüfung der Sachgerechtigkeit einer Ersetzung durch die Apotheke im Einzelfall bleibt hiervon unberührt. Die Möglichkeit der Apotheke von einer Ersetzung abzusehen ergibt sich dabei aus § 40c Absatz 5. Siehe ergänzend auch Bewertung zum Einwand 3.1.7 und der Einwände zum Absatz 5.

In Stellungnahmen wird außerdem darauf hingewiesen, dass auch Arzneimittel als Biosimilars zugelassen würden, die sich in den terminalen Aminosäuresequenzen von ihrem Referenzarzneimittel unterscheiden. So gebe es beispielsweise Abweichungen in der N-

und/oder C-terminalen Sequenz zwischen dem Etanercept-Referenzarzneimittel Enbrel und den bezugnehmend zugelassenen Biosimilars (Benepali, Erelzi, Nepexto). Zwischen diesen Arzneimitteln bestünden unterschiedliche Datenlagen in Bezug auf die Langzeitsicherheit und es sei unklar, ob die Abweichungen der Sequenzen Auswirkungen auf die pharmakologischen und klinischen Eigenschaften der Arzneimittel hätten.

Bei der Zulassung von Biosimilars nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG gelten Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit sowie ein vergleichbares Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil im Verhältnis zu dem Referenzarzneimittel als belegt. In den Zulassungsverfahren zu Erelzi, Benepali und Nepexto wurde auch die Variabilität in den terminalen Aminosäuresequenzen und deren Auswirkungen auf die pharmakologische Vergleichbarkeit gegenüber Enbrel geprüft. In Bezug auf die Variationen am C-Terminus wird im EPAR zu Benepali [116] ausgeführt, dass auch das Referenzarzneimittel Enbrel zwei Formen von C-terminalen Peptiden aufweist (Variation mit oder ohne Lysin-Rest). Die Heterogenität der C-terminalen Aminosäuren sei ein bekanntes Merkmal therapeutischer monoklonaler Antikörper, wobei über die C-terminale Lysin-Variation bereits bekannt sei, dass diese keinen Einfluss auf das pharmakokinetische Profil habe [116]. Bei Benepali [116], Erelzi [117] und Nepexto [128] sei der Anteil an Peptiden mit der Lysin-Variation zwar geringer als bei Enbrel, die Zulassungsbehörde kommt im Verfahren zu Benepali auf Basis von TNF- α -Bindungsfunktionstests aber zu dem Schluss, dass der Anteil an C-terminalem Lysin keinen Einfluss auf die TNF- α -Bindungsaktivität habe [116]. Nepexto und Erelzi weisen zusätzlich Variationen am N-Terminus auf (Trunkierung um einen Leucin- bzw. Leucin- und Prolin-Rest). In den jeweiligen Zulassungsverfahren wurde festgestellt, dass aufgrund der Variabilität der C- und N-Termini keine Auswirkungen auf die Funktionalität von Etanercept zu erwarten seien. Konkrete Untersuchungen, welche einer therapeutischen Vergleichbarkeit der Etanercept-haltigen Arzneimittel aufgrund des regulatorischen Zusammenhangs entgegenstehen und eine Ausnahme vom Ersetzungsgebot rechtfertigen, werden nicht vorgelegt. Dem Einwand wird insoweit nicht gefolgt.

Weitere Stellungnehmende weisen zudem auf Unterschiede zwischen den Proteinvarianten Epoetin alfa und Epoetin zeta hin und lehnen eine Ersetzung durch Apotheken mit der Begründung unzureichender Bioäquivalenz zwischen Epoetin alfa- und Epoetin zeta-haltigen Arzneimitteln ab.

Bei Epoetin alfa und Epoetin zeta handelt es sich um Glykoproteine, die sich hinsichtlich ihrer Glykosylierung unterscheiden. Die Zulassungsbehörde hat hier eine Zulassung eines Biosimilars mit Referenzierung auf ein Arzneimittel mit abweichender Bezeichnung der Proteinvariante erteilt. Dies führt zu der Konstellation, dass sowohl ein Epoetin alfa-haltiges Biosimilar als auch ein Epoetin zeta-haltiges Biosimilar mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel mit dem Wirkstoff Epoetin alfa zugelassen sind. Für Arzneimittel sowohl mit dem Wirkstoff Epoetin alfa als auch Epoetin zeta hat die Zulassungsbehörde festgestellt, dass sie ein vergleichbares Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil aufweisen wie das Epoetin alfa-haltige Referenzarzneimittel [103, 104]. Zu der Studie Reichel et al. [93, 94] liegen zwei Kongressposter vor. Aus diesen leitet der Stellungnehmer ab, dass höhere Dosierungen von Epoetin zeta notwendig wären als von Epoetin alfa. Eine Beurteilung der methodischen Qualität der Studien kann vor dem Hintergrund fehlender Informationen nicht erfolgen und ein Unterschied hinsichtlich patientenrelevanter Endpunkte oder der notwendigen Dosierung nicht abgeleitet werden. Darüber hinaus hat sich bereits die Zulassungsbehörde im Zulassungsverfahren zu Retacrit kritisch mit den Unterschieden im Dosisbedarf von Retacrit im Vergleich zum Referenzarzneimittel Erypo auseinandergesetzt [103]. Der Unterschied wird, wie seitens der Stellungnehmenden ausgeführt, auf einen geringeren Proteingehalt und eine damit einhergehende geringere Bioaktivität von Retacrit zurückgeführt. Während Batches des

Arzneimittels Erypo einen durchschnittlichen Proteingehalt von 9 % oberhalb der Menge gemäß Zulassung aufwiesen, liege dieser bei Retacrit im Durchschnitt nur 1 % oberhalb der zugelassenen Menge. Die Bioaktivität von Erypo liege in Folge 15 % oberhalb der angegebenen Aktivität, aber noch innerhalb der in der European Pharmacopoeia des European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (EDQM) für Erythropoietin definierten Grenzen von 80 - 125 %. Auch die Bioaktivität von Retacrit liege innerhalb des Bereichs. Um eine klinisch relevante Dosisdifferenz vom Referenzarzneimittel zu bestimmen, wurde im Zulassungsverfahren die für Epoetin alfa nachgewiesene minimale klinisch wirksame Dosis von 15 IE/kg dreimal wöchentlich herangezogen. Hieraus ergebe sich ein Äquivalenzbereich von ± 45 IE/kg/Woche für den klinischen relevanten Dosisunterschied [103]. Die Grenzen des 95 %-Konfidenzintervalls von Retacrit lägen innerhalb dieses Bereichs und die geringere Dosis zeige in der untersuchten Studienpopulation keine Auswirkungen auf die klinische Wirksamkeit [103]. Folglich bestehen gemäß den aktuellen Fachinformationen keine Unterschiede hinsichtlich der Dosierung von Epoetin alfa- und Epoetin zeta-haltigen Arzneimitteln [129, 130, 131, 132, 133, 134]. Dem Einwand wird nicht gefolgt. Aufgrund der durch die Zulassung festgestellten Vergleichbarkeit ist eine Ersetzung zwischen Epoetin alfa- und Epoetin zeta-haltigen Arzneimitteln sachgerecht.

Eine Stellungnehmerin fordert, dass Hormonpräparate in der Reproduktionsmedizin von der Ersetzung durch Apotheken ausgenommen werden sollten, da Studiendaten belegen würden, dass es einen signifikanten Unterschied in der Schwangerschafts- und Lebendgeburtenrate zwischen Originalpräparat und den bezugnehmenden Biosimilars gebe.

Dem ist zu entgegnen, dass die Zulassungsbehörde für die Follitropin alfa-haltigen Biosimilars Ovaleap und Bemfola im jeweiligen Zulassungsverfahren zu dem Ergebnis gekommen ist, dass diese mit GONAL-f jeweils ein vergleichbares Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil aufweisen [113, 135]. Von der Stellungnehmerin wird zudem die Metaanalyse Chua [106] vorgelegt. In der Metaanalyse erfolgt die Zusammenfassung der Ergebnisse von Studien, in denen unterschiedliche Biosimilars mit GONAL-f verglichen werden. Die darin vorgenommenen Analysen zu den Biosimilars Primapur und Follitrope bleiben unberücksichtigt, da die beiden Arzneimittel nicht für den deutschen Markt zugelassen sind. Die Metaanalyse über alle einbezogenen Biosimilars hinweg wird insofern nicht durch den G-BA berücksichtigt.

Zu dem Biosimilar Ovaleap wurde von den Autoren der Metaanalyse Chua [106] eine Studie identifiziert, in der Ovaleap mit GONAL-f verglichen wurde; dabei handelt es sich um die der Biosimilar-Zulassung durch die EMA zugrunde liegende Studie Strowitzki [136]. In dem in der Publikation Chua [106] untersuchten primären Endpunkt Lebendgeburt bestehen bei der Studie Strowitzki [136] keine signifikanten Unterschiede zwischen Ovaleap und GONAL-f. Bei den sekundären Endpunkten besteht gemäß der Analyse der Autoren ein signifikanter Unterschied nur bei der Dauer der ovariellen Stimulation (9,3 vs 9,7 Tage), der allerdings als nicht klinisch relevant anzusehen ist. In der Studie Strowitzki [136] selbst bestehen bei den Schwangerschaftsraten teils große Unterschiede zwischen den verschiedenen Studienländern (mit Ovaleap 20,4 % in Polen vs 35,9 % in Ungarn, mit Gonal-f 16,7 % in Belgien + Deutschland

129 Fachinformation Erypo. Stand September 2024.

130 Fachinformation Abseamed. Stand Oktober 2023.

131 Fachinformation Binocrit. Stand November 2023.

132 Fachinformation Epoetin alfa HEXAL. Stand November 2023.

133 Fachinformation Retacrit. Stand Juli 2023.

134 Fachinformation SILAPO. Stand November 2020.

135 Ovaleap: EPAR.

136 Strowitzki T et al. (2016): Safety and efficacy of Ovaleap® (recombinant human follicle-stimulating hormone) for up to 3 cycles in infertile women using assisted reproductive technology: a phase 3 open-label follow-up to Main Study. *Reprod Biol Endocrinol*;14(1):31.

vs 44,7 % in Ungarn). Die Beeinflussbarkeit der Schwangerschaftsraten durch zahlreiche Faktoren wie unterschiedliche Gesetzgebungen, Praktiken und Empfehlungen wird entsprechend auch in der Auswertung der Studie Strowitzki [136] diskutiert.

Zu dem Biosimilar Bemfola wurden von den Autoren der Metaanalyse Chua [106] zwei Studien identifiziert, in denen Bemfola mit GONAL-f verglichen wurde; darunter die der Biosimilar-Zulassung durch die EMA zugrunde liegende Studie Rettenbacher [137] und eine bislang unveröffentlichte Studie [138]. In dem in der Publikation Chua [106] untersuchten primären Endpunkt Lebendgeburt bestehen in den einzelnen Studien ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen Bemfola und GONAL-f. In der metaanalytischen Auswertung wird jedoch ein signifikanter Unterschied im primären Endpunkt Lebendgeburt zugunsten von Gonal-f festgestellt. Dieser signifikante Unterschied besteht allerdings nicht mehr, wenn in der Sensitivitätsanalyse die unveröffentlichte Studie [138] ausgeschlossen wird. Denn bezüglich der Risk of Bias-Analyse kommen die Autoren der Metaanalyse Chua [106] bei der unveröffentlichten Studie [138] zum Ergebnis, dass die Evidenz für die Endpunkte als „moderate“ einzustufen sei, da keine Angaben zur verdeckten Zuteilung (Allocation Concealment) sowie der Randomisierungsmethode vorliegen. Die Studie Rettenbacher [137] und die bislang unveröffentlichte Studie [138] unterscheiden sich unter anderem auch hinsichtlich ihrer Ein- und Ausschlusskriterien. Da jedoch nur zwei Studien in die Metaanalyse Chua [106] einbezogen wurden, bleibt nach Ausschluss der unveröffentlichten Studie [138] nur die Studie Rettenbacher [137] übrig.

In den Studien Rettenbacher [137] und Strowitzki [136] wurden Lebendgeburten jeweils nur als sekundärer Endpunkt erfasst und diese waren überdies jeweils nicht ausreichend gepowert, um Unterschiede bei Lebendgeburten zeigen zu können. Zusammenfassend sind die Ergebnisse der Metaanalyse Chua [106] zu den Endpunkten Lebendgeburten und Schwangerschaftsrate unter Berücksichtigung der genannten Unsicherheiten nicht ausreichend, um klinisch relevante Unterschiede zwischen Bemfola und Ovaleap und GONAL-f sicher ableiten zu können.

In der zweiten vorgelegten Metaanalyse von Borget et al. [107] werden dieselben Studien zum Vergleich zwischen GONAL-f und Bemfola [137, 138] bzw. GONAL-f und Ovaleap [136] ausgewertet und darüber hinaus keine zusätzlichen Studien gegenüber der für den deutschen Markt zugelassenen Biosimilars identifiziert. Aus der Metaanalyse Borget ergeben sich somit keine zusätzlichen Erkenntnisse.

Weiterhin wird die Kosteneffektivitätsanalyse von Kiose et al. [108] vorgelegt, die auf Real-World-Daten der Versicherten im französischen Gesundheitssystem (French national health system main database) basiert. Zwar wird für den Originator von Follitropin alfa (GONAL-f) eine um 1,5 % höhere Lebendgeburtenrate und eine um 1,7 % höhere kumulative Lebendgeburtenrate berichtet als für die in Frankreich erstattungsfähigen Biosimilars, jedoch wurde keine statistische Testung auf Überlegenheit durchgeführt. Da auch keine Gruppenbeschreibung zu demografischen bzw. für die Behandlung relevanten Charakteristika vorliegt, kann die Strukturgleichheit der Gruppen nicht nachvollzogen werden, was insbesondere aufgrund der fehlenden Randomisierung für die Bewertung der Ergebnisse essenziell wäre. Infolgedessen bleibt unklar, ob die beobachteten Unterschiede zwischen den Gruppen durch Strukturungleichheiten oder Störgrößeneinflüsse beeinflusst oder verursacht sein könnten. Unabhängig davon geht der G-BA im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeitsbewertung von Arzneimitteln grundsätzlich von einem Vergleich der Kosten gemessen am Apothekenabgabepreis, sowie ggf. die den Krankenkassen tatsächlich entstehenden (direkten) Kosten aus. Nach 4. Kapitel § 10 Absatz 1 Verfo sind aufgrund der

137 Rettenbacher M et al. (2015): A multi-centre phase 3 study comparing efficacy and safety of Bemfola® versus Gonal-f® in women undergoing ovarian stimulation for IVF. Reprod Biomed Online;30(5):504-13.

138 Fertility Biotech AG (2012): Phase III Study Comparing Efficacy and Safety of AFOLIA vs GONAL-f® RFF in Women (35 to 42) Undergoing IVF. U.S. National Library of Medicine; Report No.: NCT01687712.

Fach- und Gebrauchsinformation bestehende regelhafte Unterschiede bei der notwendigen Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung oder bei der Verordnung sonstiger Leistungen und die damit verbundenen Kostenunterschiede zu berücksichtigen. Eine weitergehende Kosteneffektivität unter Einbeziehung indirekter Kosten, wie sie die Studie Kiose et al. untersucht, bleiben insofern regelhaft außer Betracht.

Insgesamt werden mit den bereitgestellten Studien keine relevanten und methodisch adäquat nachgewiesenen Unterschiede, welche einer therapeutischen Vergleichbarkeit aufgrund des regulatorischen Zusammenhangs entgegenstehen und eine Ausnahme vom Ersetzungsgebot rechtfertigen, vorgelegt. Dem Einwand wird insoweit nicht gefolgt.

Des weiteren wird in einer Stellungnahme vorgebracht, dass gemäß den Fachinformationen einiger Insulin-haltiger Arzneimittel [100, 101, 102] Umstellungen auf einen anderen Insulintyp oder ein Insulin eines anderen Herstellers unter strenger ärztlicher Aufsicht erfolgen müssten, da jede Änderung hinsichtlich Stärke, Marke, Insulintyp, Art des Insulins und/oder Herstellungsmethode eine Veränderung des Insulinbedarfs nach sich ziehen könne. Auch zu Follitropin alfa-haltigen Arzneimitteln wird in einer weiteren Stellungnahme angemerkt, dass gemäß Fachinformation eine Behandlung unter der Aufsicht eines Arztes eingeleitet werden bzw. die erste Injektion unter direkter ärztlicher Aufsicht erfolgen sollte. Eine Substitution Insulin- und Follitropin alfa-haltiger Arzneimittel durch Apotheken wird vor diesem Hintergrund von den Stellungnehmern jeweils kritisch gesehen. Auf den Einwand hinsichtlich Insulin-haltiger Arzneimittel ist zu entgegnen, dass zu den beiden (Referenz-)Arzneimitteln Lyumjev und Huminsulin bislang keine Biosimilars zugelassen sind. Die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander sowie der Wechsel des Insulintyps oder der Art des Insulins ist grundsätzlich nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung und wird auch durch die Anlage VIIa nicht weiter konkretisiert.

Im EPAR von Insulin lispro Sanofi [139] wird beschrieben, dass die Wirksamkeit und das Auftreten von Nebenwirkungen zum Referenzarzneimittel Humalog vergleichbar sei (S. 80, Nummer 3.6.2, 5. Absatz: *Demonstration of similar glycaemic control with similar insulin doses within the Phase III studies supports the favourable outcome of the pivotal clamp study. In addition, no relevant differences were noted in the incidence of adverse events, including hypoglycaemic events.*). Die EMA kommt im EPAR zu dem Schluss, dass keine Aspekte vorliegen, die der Zulassung von Insulin lispro Sanofi als Biosimilar von Humalog entgegenstehen. Konkrete Untersuchungen, welche einer therapeutischen Vergleichbarkeit aufgrund des regulatorischen Zusammenhangs entgegenstehen und eine Ausnahme vom Ersetzungsgebot rechtfertigen, werden nicht vorgelegt. Dem Einwand wird insoweit nicht gefolgt. Aufgrund der durch die Zulassung festgestellten Vergleichbarkeit ist eine Ersetzung zwischen bezugnehmend zugelassenen Insulin-haltigen Arzneimitteln sachgerecht.

In Bezug auf den Einwand hinsichtlich Follitropin alfa-haltiger Arzneimittel ist zu entgegnen, dass sich diese Vorgaben zur Anwendung in den Fachinformationen sämtlicher, marktverfügbarer Follitropin alfa-haltiger Fertigarzneimittel finden. Diese sprechen jedoch nicht per se gegen eine Ersetzung, da die zugrunde liegenden Besonderheiten sowohl bei der Arzneimittelverordnung als auch bei der Abgabe durch die Apotheke zu berücksichtigen sind. Generelle Ausschlüsse von der Ersetzungspflicht lassen sich aus diesem Einwand nicht ableiten, da insofern keine therapeutischen Unterschiede bestehen.

Darüber hinaus wird von Stellungnehmenden geäußert, dass bei Natalizumab-haltigen Arzneimitteln die Dokumentation der Patienteneinwilligung und -aufklärung sowie das Aushändigen und Mitführen eines Patientenpasses verpflichtend sei und im Rahmen des

139 Insulin lispro Sanofi: EPAR.

Risikomanagements Tests zur Einschätzung des individuellen PML-Risikos zum Einsatz kämen. Für die zugelassenen Natalizumab-haltigen Arzneimittel wären derzeit jeweils eigene Tests, allerdings mit abweichender Spezifität verfügbar. Von einer Ersetzung Natalizumab-haltiger Arzneimittel durch Apotheken müsse daher abgesehen werden.

Diese Einwände sprechen nicht per se gegen eine Ersetzung von Biologika, die zugrunde liegenden Besonderheiten sind bei der Arzneimittelverordnung sowie bei der Abgabe durch die Apotheke zu berücksichtigen. Die behördlichen Vorgaben zur Dokumentation der Patienteneinwilligung und -aufklärung sowie das Aushändigen eines entsprechenden Patientenpasses sind durch die Praxis und die Apotheke zu berücksichtigen. In Bezug auf die Testsysteme ist zudem festzustellen, dass die Fachinformationen der beiden derzeit zugelassenen Natalizumab-haltigen Arzneimittel (Tysabri und Tyruko [140, 141]) „für die Ermittlung des Risikoniveaus der Behandlung [einen] Test auf Anti-JCV-Antikörper“ ohne konkreten Produktbezug empfehlen. Die Arzt-Informationen und Management-Leitlinien verweisen ebenfalls lediglich darauf, dass der Test mit einer geeigneten, validierten Testmethode erfolgen sollte [85, 86]. Im Leitfaden zu Tyruko [86] wird neben dem ImmunoWELL™ JCV IgG-Test auch der STRATIFY JCV™ DXSELECT™ genannt und auf die Berücksichtigung abweichender Index-Werte hingewiesen („Ein Vergleich zwischen dem STRATIFY JCV® DxSelect® und dem ImmunoWELL™ JCV IgG-Test zeigt eine mögliche Abweichung von bis zu 0,1 bei den Indexwerten [...].“). Soweit in der mündlichen Anhörung vom 11. November 2025 die Forderung erhoben wurde, den STRATIFY JCV™ DXSELECT™ für alle Biologika nutzbar zu machen, entspricht dies aktuell nicht der obengenannten Auffassung der Zulassungsbehörde. Generelle Ausschlüsse von der Ersetzungspflicht lassen sich aus diesen Einwänden nicht ableiten, da insofern keine therapeutischen Unterschiede bestehen.

Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits in den Stellungnahmeverfahren zu den Beschlüssen zur Ergänzung der AM-RL um § 40a (vom 20. August 2020) und § 40b (vom 15. Juni 2023) sowie zu dem Beschluss vom 19. November 2021 zur Erstfassung der Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) zur AM-RL befasst; es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in den Zusammenfassenden Dokumentationen zu den entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/4430/>, <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/> und <https://www.g-ba.de/beschluesse/5132/>).

3.1.7 Möglichkeit(en) des Ausschlusses der Ersetzung durch den Arzt

AbbVie

Das Recht für Ärzte, die automatische Substitution durch Setzen des „aut-idem-Kreuzes“ zu unterbinden, ist zweifellos zu unterstützen. Schließlich obliegt die Entscheidung über die passende Arzneimitteltherapie dem Arzt. Durch die Option, die automatische Substitution zu unterbinden, wird dem Einschnitt in die ärztliche Therapiefreiheit zumindest bedingt entgegengewirkt.

Novo Nordisk

Grundsätzlich begrüßt Novo Nordisk die Möglichkeit zum Ausschluss einer Ersetzung durch verordnende Ärzt:innen. Die Ausgestaltung der Verfahren zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit nach § 106 SGB V fällt jedoch nicht in die Regelungszuständigkeit des G-BA. Novo Nordisk sieht an dieser Stelle einen unverhältnismäßig großen Mehraufwand für die verordnenden Ärzt:innen, um die individuelle Patient:innen-Sicherheit und Therapieadhärenz sicherzustellen. Es kommt hier zu einer Überlagerung der patienten- und arzt-spezifischen Therapieentscheidung durch ökonomische Steuerungsinstrumente gegenüber den Ärzt:innen.

140 Fachinformation Tysabri. Stand Mai 2025.

141 Fachinformation Tyruko. Stand Januar 2025.

Roche

Es ist essentiell, dass der behandelnde Arzt weiterhin das Recht behält, die Abgabe eines bestimmten Arzneimittels durch die „aut idem“-Regelung sicherzustellen.

DDG, gemeinsam mit Hautnetz Deutschland e. V. und BVDD

Das von Vertretern angeführte Argument einer stets möglichen Aut idem-Regelung ist in der Praxis aus Sicht der Versorgungsforschung wenig zutreffend, da Aut idem-Vorgänge erfahrungsgemäß in der Versorgung oftmals vergessen oder bewusst unterlassen werden, weil eine Auffälligkeit in der Aut idem-Regelung zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen und weiteren Prüfungen durch die Prüfeinrichtungen Anlass gaben. Diese Auffälligkeiten führen wegen des erheblichen administrativen Aufwands und möglicher negativer Folgen für die versorgenden Praxen nicht selten zur Unterlassung entsprechender Verordnungen. Eine derartige Einschränkung der Versorgungsqualität darf nicht eintreten.

DGVS, gemeinsam mit Kompetenznetz Darmerkrankungen e. V. und bng

Wenn hier ausdrücklich bemerkt wird, dass die Anwendung des aut-idem Kreuzes diese mögliche Substitution in der Apotheke verhindern könnte, ist dies nicht zielführend, denn daraus können sich gravierende Probleme für den behandelnden Arzt entwickeln.

- *Ein wirtschaftlicher Regress (nach § 106b SGB V) für den Arzt kann entstehen, wenn durch das Aut-idem-Kreuz höhere Kosten verursacht werden, die nicht medizinisch gerechtfertigt sind.*
- *Wann ist das Kreuz ohne Regressrisiko möglich? Nur bei medizinisch begründeten Einzelfällen: z. B. bei Allergien gegen Hilfsstoffe, bei nachgewiesenen Unverträglichkeiten oder notwendige Therapiekontinuität (z. B. bei Psychopharmaka)*
- *Das Setzen des Aut-idem-Kreuzes bedeutet, dass der Arzt bewusst auf eine Einsparmöglichkeit verzichtet. Ohne medizinische Begründung kann das als unwirtschaftlich gewertet werden und zu Regressforderungen führen.*
- *Das aut-idem Kreuz kann aber nicht eingesetzt werden, um irgendwie schwierig zu definierende Umstände unter Berücksichtigung des Patientenwunsches abzufangen und auszugleichen. Das aut-idem Kreuz kann nur mit dokumentierter medizinischer Indikation gesetzt werden, um Regressrisiken zu vermeiden.*

Bewertung:

Die allgemeinen Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit, insbesondere die Auswahl eines preisgünstigen Arzneimittels durch Apotheken, gelten auch für biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel, es sei denn der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin hat die Ersetzung des Arzneimittels ausgeschlossen.

Gemäß den Regelungen in § 40 Absatz 3, § 40a Absatz 5 sowie § 40c Absatz 1 AM-RL muss die Erwägung, von einer Umstellung/Ersetzung abzusehen, immer medizinisch bzw. therapeutisch begründbar sein. Arzneimittel, die über das Maß des Notwendigen hinausgehen oder unwirtschaftlich sind, weil sie gegenüber gleich geeigneten, ausreichenden und erforderlichen Mitteln teurer sind, sind aus dem Leistungskatalog der GKV grundsätzlich ausgeschlossen; dies ergibt sich bereits aus den allgemeinen Anforderungen des Wirtschaftlichkeitsgebots. Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit bedingt im Sinne des Minimalprinzips den Beleg, dass bei Existenz verschiedener gleich zweckmäßiger und notwendiger Behandlungsmöglichkeiten die Kosten für den gleichen zu erwartenden Erfolg geringer oder zumindest nicht höher sind. Daraus folgt, dass Annehmlichkeiten oder Gewohnheiten beispielsweise in der Arzneimittelanwendung keinen Sachgrund darstellen, von den Vorgaben des Wirtschaftlichkeitsgebots abzuweichen.

Unter Berücksichtigung der konkreten Patientensituation kann ein Ausschluss einer Ersetzung durch Apotheken insofern gerechtfertigt sein, wenn der aus wirtschaftlichen Gründen zu erwägende Austausch für die jeweilige Patientin oder den jeweiligen Patienten aus

medizinischen und therapeutischen Gründen nicht zumutbar ist. Abhängig von der konkreten Behandlungssituation können unter Würdigung patientenindividueller und erkrankungs-spezifischer Aspekte (z. B. Handhabung eines anderen Devices) medizinische Gründe oder eine besondere Therapiesituation dagegensprechen. Allein das zahlenmäßige Ausmaß der mit einem „aut idem“-Kreuz ausgestellten Verordnungen in einem Therapiegebiet stellt die Berechtigung zum Ausschluss der Substitution nicht per se in Frage. Der G-BA hat grundsätzlich davon auszugehen, dass mit einer zutreffenden medizinischen Begründung gesetzte „aut idem“-Kreuze im Ergebnis ohne Beanstandung bleiben. Zur Ausgestaltung der Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 SGB V wird an die Vertragspartner verwiesen; diese unterliegt nicht der Regelungszuständigkeit des G-BA.

3.2 Einwände zum Absatz 2

3.2.1 Regelung zur „Preisgünstigkeit“

AbbVie

Grundsätzlich begrüßen wir die explizite Nennung der Preisgünstigkeit durch Rabattverträge nach §130a Absatz 8 SGB V und deren Berücksichtigung bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit im Sinne des §12 SGB V. Die aktuelle Formulierung in diesem Absatz hätte jedoch zur Folge, dass im Arzneimittel-Rahmenvertrag (§ 129 Absatz 5 SGB V) restriktivere Regelungen zur automatischen Substitution festgelegt werden könnten als vom G-BA selbst mit § 40c Arzneimittel-Richtlinie vorgesehen. Da die Arzneimittel-Richtlinie höherrangig gegenüber dem Arzneimittel-Rahmenvertrag ist, sollte der folgende Halbsatz konsequenterweise gestrichen werden: „..., soweit hierzu in Verträgen nach § 129 Absatz 5 SGB V nichts anderes vereinbart ist.“

Neben der Ausnahme von rabattierten Arzneimitteln müssen konsequenterweise auch festbetragsgeregelte Arzneimittel als Ausnahmen definiert werden. Schließlich tragen sowohl rabattierte als auch festbetragsgeregelte Arzneimittel zu Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem (und damit zum Ziel des Gesetzgebers) bei.

Biocon

Die pauschale Gleichsetzung von Wirtschaftlichkeit mit dem Abschluss eines Rabattvertrages geht fehl. Mit der Regelung des GSAV soll der Einsatz von Biosimilars gerade gefördert werden und nicht der Einsatz rabattierter Arzneimittel. Dies wird in der Gesetzesbegründung deutlich, wenn es heißt „zur Förderung der Verordnung und Abgabe von Biosimilars werden in § 129 SGB V Regelungen zur Austauschbarkeit und zur Festlegung von Wirtschaftlichkeitszielen in den Arznei- und Heilmittelvereinbarungen nach § 84 SGB V geschaffen“.

Die pauschale Gleichsetzung von Wirtschaftlichkeit führt mit dem Abschluss eines Rabattvertrages zu einer verheerenden Dezimierung der Biosimilar-Wettbewerber, die nicht mehr bereit sind, Biosimilar-Präparate neu einzuführen. Das bestehende System mit massiven Kosteneinsparungen und Lieferstabilität wird mit dem jetzigen G-BA-Beschluss zerstört, unter der fehlerhaften Prämisse, dass die gleichen Wettbewerber am Markt erhalten bleiben und daher die Kosten weiter gesenkt werden können. Wie bereits bei den Generika gesehen, ist dies aber nicht der Fall und es folgen die gleichen, nachteiligen Konsequenzen wie seinerzeit bei den Generika.

Biogen

Bei Auslösung einer Substitution durch Rabattverträge können Präparatewechsel in der Apotheke sowohl beim Wechsel der Vertragspartner als auch innerhalb laufender Verträge erfolgen, wie etwa im Fall von Mehrfachzuschlägen.

Zusätzlich erlaubt die sogenannte Günstigstenregel gemäß § 129 Abs. 1 SGB V einen Austausch, sobald sich die Preisverhältnisse in der Lauer-Taxe ändern, was im Zwei-Wochen-Rhythmus geschehen kann. Dies kann zu einer hohen Frequenz von Präparatewechseln führen,

ohne dass der behandelnde Arzt eingebunden ist.

Gerade bei chronischen Erkrankungen, bei denen Biologika/Biosimilars wie Etanercept, Adalimumab oder Infliximab eingesetzt werden, ist die Therapiedauer häufig auf mindestens 3 Jahre angelegt [142]. Gleichzeitig laufen Rabattverträge in der Regel nur über 2 Jahre. In Kombination mit quartalsweisen Verordnungen kann dies dazu führen, dass Patienten über ihre gesamte Therapiedauer bis zu zwölf Präparatewechsel ohne ärztliche Begleitung erfahren. Diese Häufigkeit wurde bislang nicht systematisch untersucht und stellt ein bislang nicht bewertetes Risiko für die Therapietreue und -sicherheit dar.

Zudem zeigen mehrere internationalen Studien zur Langzeittherapie mit Natalizumab bei Multipler Sklerose, dass ein erheblicher Anteil der Patienten die Therapie über mehrere Jahre fortführt. Nach erneuter PML-Risiko Bewertung auch wesentlich länger als 2 Jahre. In der Real-World-Langzeitbeobachtung über 15 Jahre brachen 63,2 % der Patienten die Behandlung mit Natalizumab ab. Die Gründe für einen Abbruch waren meist medizinischer Natur (z. B. JCV-Status und PML-Risiko) [143, 144]. Eine weitere Real-World-Studie aus dem finnischen MS-Register bestätigt dies: Die mediane Behandlungsdauer betrug 7,8 Jahre bei JCV-negativen Patienten und nur 2,1 Jahre bei JCV-positiven Patienten [145]. Ein durch Rabattverträge ausgelöster, nicht medizinisch indizierter Wechsel, könnte hier das Risiko für Therapieabbrüche erhöhen.

Die aktualisierten Leitlinien der European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) von 2025 zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen betonen, dass eine Weiterführung der Therapie mit gegebenenfalls reduzierter Dosis einer vollständigen Beendigung vorzuziehen ist [145]. Ein Präparatewechsel in dieser sensiblen Phase kann daher erhebliche Auswirkungen auf die Therapieentscheidung und das individuelle Risikomanagement haben.

Lilly

Lilly versteht § 40c (2) dahingehend, dass die Pflicht zur Ersetzung des verordneten Arzneimittels entfällt, soweit eine Vereinbarung nach § 130 a Absatz 8 SGB V mit Wirkung für die Krankenkasse besteht. Auf Grundlage der bereits bestehenden Rabattverträge für unsere Produkte Humalog®, Lyumjev® und Abasaglar® lassen sich im Folgenden keine weiteren Einsparungen generieren, sodass es aus Sicht von Lilly sinnvoll ist, die betreffenden Produkte von der Liste der zu substituierenden Arzneimittel in der Anlage VIIa zum Abschnitt M der Arzneimittel-Richtlinie zu streichen. Infolgedessen kann mehr Klarheit für Apotheken geschaffen werden, welche Arzneimittel substituiert werden müssen und welche Arzneimittel von der Substitution durch Rabattverträge ausgeschlossen sind. Folglich kann das Risiko gesenkt werden, dass Apotheker fälschlicherweise Produkte mit einem bestehenden Rabattvertrag substituieren.

[...] Insbesondere sollten biologisch hergestellte Referenzarzneimittel und Biosimilars, für die Rabattverträge zwischen pharmazeutischen Unternehmen und den Gesetzlichen Krankenkassen nach § 130a Absatz 8 SGB V bestehen und solche Produkte, die unter die Festbetragsregelungen im Sinne von § 35 Abs. 5 SGB V fallen, grundsätzlich von einer automatischen Ersetzung durch Apotheken ausgenommen sein.

142 Soubrier M et al. (2018): Retention rates of adalimumab, etanercept and infliximab as first-line biotherapy agent for rheumatoid arthritis patients in daily practice - Auvergne experience. Int J Rheum Dis;21(11):1924-32.

143 Butzkueven H et al. (2020): Long-term safety and effectiveness of natalizumab treatment in clinical practice: 10 years of real-world data from the Tysabri Observational Program (TOP). J Neurol Neurosurg Psychiatry;91(6):660-8.

144 Trojano M et al.: TYSABRI Observational Program: Long-term Safety and Effectiveness in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis over 15 Years. European Academy of Neurology – 9th Congress, 2023.

145 Verkkoniemi-Ahola A et al. (2023): Real-world treatment outcomes and safety of natalizumab in Finnish multiple sclerosis patients. Mult Scler J Exp Transl Clin;9(4):20552173231204466.

Medice

In Absatz 2 wird geregelt, dass die Ersetzung nach Absatz 1 vorrangig durch ein Arzneimittel vorzunehmen ist, für das eine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V mit Wirkung für die Krankenkasse besteht, soweit hierzu in Verträgen nach § 129 Absatz 5 SGB V nichts anderes vereinbart ist.

Wir sprechen uns für die Aufnahme einer weiteren Regelung aus, die besagt, dass keine Ersetzung vorzunehmen ist, sofern für das verordnete Arzneimittel selbst eine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V mit Wirkung für die Krankenkasse besteht und keine Gründe vorliegen, die eine Belieferung mit dem verordneten Arzneimittel verhindern (Lieferunfähigkeit, Akutversorgung, Notdienst o.ä.).

Durch diese ergänzende Regelung sinkt das Risiko, dass es zu den befürchteten negativen Folgen eines Austauschs kommt (wie Anwendungsfehler, Nicht-Adhärenz, Nocebo-Effekte), weil „ohne Not“ ein alternatives ebenfalls rabattiertes Arzneimittel abgegeben wird. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Kosten aus, die in einer solchen Konstellation, ebenfalls unnötigerweise, durch Aufklärung, Dokumentation oder Information des behandelnden Arztes/ der behandelnden Ärztin unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen anfallen würden.

Novartis

Novartis stimmt zu, dass im Falle einer (von Novartis allerdings abgelehnten) Substitution durch den Apotheker vorrangig ein Rabattvertragsarzneimittel abzugeben ist. Allerdings hängt die Wirtschaftlichkeit des abgegebenen Arzneimittels nicht von der Rechtsgrundlage des Rabattvertrags ab. Rabattverträge auf der Grundlage von § 130c SGB V sind ebenso wirtschaftlich und vorrangig zu berücksichtigen wie Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V. Im Bereich biologischer Arzneimittel sind Rabattverträge nach § 130c SGB V zudem von noch größerer wirtschaftlicher Bedeutung als solche nach § 130a Abs. 8 SGB V, weil biologische Arzneimittel typischerweise ein AMNOG-Verfahren durchlaufen haben.

In § 40c Abs. 2 (und konsequenterweise entsprechend auch in §§ 40a und 40b Abs. 2 AM-RL) sind nach der Angabe „§ 130a Absatz 8“ jeweils die Worte „oder § 130c“ einzufügen.

Novartis versteht die Regelung in der zur Stellungnahme gestellten Fassung eines § 40c Abs. 2 AM-RL dahingehend, dass in dem Fall, dass für mehrere biotechnologisch hergestellte biologische Fertigarzneimittel Rabattverträge abgeschlossen wurden, diese – mangels Kenntnis des Apothekers von der Rabatthöhe – als gleichermaßen wirtschaftlich zu bewerten sind und deshalb der Apotheker zwischen den Rabattvertragsarzneimitteln frei wählen kann. Diese Konsequenz sollte explizit in § 40c Abs. 2 AM-RL geregelt oder aber zur Klarstellung zumindest in den Tragenden Gründen festgehalten werden.

Novo Nordisk

[...] Es kommt außerdem hinzu, dass die Formulierung in § 40c Absatz 2 (neu) impliziert, dass das verordnete biologische Referenzarzneimittel stets auszutauschen ist, und zwar durch ein Arzneimittel, für das ein Rabattvertrag nach § 130a Absatz 8 SGB V existiert, nicht eindeutig ist. Denn an dieser Stelle ist, nicht eindeutig benannt, dass dies nicht der Fall ist, wenn für das verordnete Referenzarzneimittel selbst ein Rabattvertrag nach § 130a Absatz 8 SGB V besteht. Diese Sichtweise würde der durch die Vertragspartner des Rahmenvertrags nach § 129 Absatz 2 SGB V getroffenen Regelung widersprechen. So heißt es in § 11 Absatz 1 Satz 3 dieses Rahmenvertrags, dass die Apotheken unter mehreren rabattbegünstigten Fertigarzneimitteln wählen kann. Dies ist auch in der Sache nachvollziehbar, da es keinen sachlichen Grund gibt, das jeweils verordnete Referenzarzneimittel trotz Rabattvertrags im Wettbewerb zu benachteiligen.

Pfizer

Soweit in dem vorgeschlagenen § 40c Abs. 2 (neu) vorgesehen ist, dass das verordnete Referenzarzneimittel stets gegen ein Biosimilar bei Vorliegen eines Rabattvertrags zu ersetzen ist, ist dies **nicht gesetzeskonform**:

[...] Der Regelungsauftrag des Gemeinsamen Bundesausschuss bezieht sich allein auf die für die Austauschverpflichtung relevante Vorfrage, ob ein biotechnologisch hergestelltes Fertigarzneimittel gegen ein anderes Referenzarzneimittel auf Apothekenebene medizinisch-pharmazeutisch **austauschbar** ist. Ob dagegen ein vom Gemeinsamen Bundesausschuss als austauschbar befundenes Arzneimittel tatsächlich durch die Apotheken zu ersetzen ist, richtet sich gemäß § 129 Abs. 1 Satz 12 SGB V allein nach den Vorschriften des § 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Sätze 2-7 SGB V. Danach sind die Apotheken allein **nach Maßgabe des Rahmenvertrags nach § 129 Abs. 2 SGB V zum Austausch verpflichtet**. Es sind also allein die Rahmenvertragspartner, die die Austausch- und Ersetzungspflichten regeln.

Es kommt hinzu, dass § 40c Abs. 2 (neu) den Eindruck erweckt, dass das verordnete biologische Referenzarzneimittel stets auszutauschen ist, und zwar durch ein Arzneimittel, für das ein Rabattvertrag nach § 130a Abs. 8 SGB V existiert. Offenbar soll dabei keine Rolle spielen, ob auch **für das verordnete Referenzarzneimittel selbst ein Rabattvertrag** nach § 130a Abs. 8 SGB V besteht. Diese Sichtweise widerspricht erkennbar der durch die Vertragspartner des Rahmenvertrags nach § 129 Abs. 2 SGB V getroffenen Regelung. So heißt es in § 11 Abs. 1 Satz 3 dieses Rahmenvertrags, dass die Apotheken **unter mehreren rabattbegünstigten Fertigarzneimitteln wählen** kann. Dies ist auch in der Sache nachvollziehbar, da es keinen sachlichen Grund gibt, das jeweils verordnete Referenzarzneimittel trotz Rabattvertrags im Wettbewerb zu benachteiligen.

Vor diesem Hintergrund ist § 40c Abs. 2 (neu) dahingehend anzupassen, dass die Pflicht zur Ersetzung des verordneten Biologikums nicht greift, wenn u. a. ein Arzneimittel verordnet wurde, für das eine Vereinbarung nach § 130a Abs. 8 SGB V besteht.

Roche

Bei bestehenden Rabatt- und/oder Selektivverträgen für das Originalpräparat sollte keine Substitution erfolgen.

[...] Der in §40c Absatz 2 enthaltene Satz „Im Regelfall wird dies ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilar) sein“ sollte gestrichen werden.

Diese Formulierung stellt eine unzulässige Einflussnahme dar, da die Wirtschaftlichkeit bereits über Vereinbarungen nach §130a Absatz 8 SGB V hergestellt wird. Besteht keine solche Vereinbarung, sollte ein preisgünstiges Arzneimittel abgegeben werden, wobei die Auswahlkriterien transparent und nachvollziehbar sein müssen.

Sanofi

[...] Rabattverträge stellen Wirtschaftlichkeit her, insofern ist ein Austausch zwischen verschiedenen Rabattvertragsartikeln hier weder sinnvoll noch angezeigt. Diese Klarstellung ist durch die Formulierung in Absatz (2), Satz 1 nicht hinreichend gegeben. Eine solche Klarstellung würde auch zu einer Vereinheitlichung mit §40a AM-RL beitragen.

ABDA, AMK

Die Regelung in Absatz 2 Satz 2 betreffend regen wir zur Klarstellung an, dass die Ersetzung durch ein preisgünstiges Arzneimittel nur „nach Maßgabe der Bestimmungen des Rahmenvertrages nach § 129 Absatz 2 erfolgt.“ Dies wird in den tragenden Gründen entsprechend ausgeführt. Rechtswirkung entfaltet diese Formulierung aber erst dann, wenn sie im Richtlinienentwurf selbst aufgeführt ist.

BPI

Der Beschlussentwurf thematisiert in §40c Abs. 2 die Anwendung von Rabattverträgen im Kontext des Apothekenaustauschs von Biologika. Damit nimmt man auch die langfristigen marktstrukturellen Folgen und die damit verbundenen industriepolitischen Risiken in Kauf.

Pharma Deutschland

Mit Blick auf die Argumentation der Position A in Absatz 1 erscheint eine explizite Nennung von Wirtschaftlichkeitskriterien in Absatz 2 redundant. Denn nach § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V sollen bereits Regelungen nach den Sätzen 2 bis 7 für im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel gelten. Die Konkretisierung der Wirtschaftlichkeit ist nicht Regelungsauftrag des § 129 Absatz 1a SGB V. Dieser begrenzt sich auf „Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken“. Korrekterweise müsste zudem von einer Austauschbarkeit statt von einer Ersetzung gesprochen werden (vgl. Anlage VII Teil B). In diesem Zusammenhang erschließt sich auch nicht, wie in regionalen Verträgen nach § 129 Absatz 5 SGB V anderes vereinbart werden könnte, dass die Wirtschaftlichkeit von Verträgen nach § 130a Absatz 8 SGB V beeinflussen würde.

vfa

Darüber hinaus sollte der Beschlussentwurf grundsätzlich und konsistent zu den gesetzlichen Regelungen in § 129 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB V überarbeitet werden. Einzelne Formulierungen suggerieren eine Pflicht zur Ersetzung bzw. einen Automatismus zum Austausch in der Apotheke, was den im Beschlussentwurf dargestellten notwendigen Voraussetzungen nicht gerecht wird. Namentlich verordnete biotechnologisch hergestellte (Referenz)-Arzneimittel mit einem Rabattvertrag müssen von den Apotheken nicht verpflichtend substituiert werden, da die Abgabefolge gemäß Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V von der Apotheke frei gewählt werden kann. Rabattverträge stellen die Wirtschaftlichkeit her, insofern ist ein Austausch zwischen verschiedenen Rabattvertragsarzneimitteln nicht angezeigt.

[...] Die Formulierung in den Tragenden Gründen, dass in den Fällen, in denen keine Vereinbarung nach § 130a Abs. 8 SGB V besteht, ein preisgünstiges, abzugebendes Arzneimittel im Regelfall ein Biosimilar sei, ist aus Sicht des vfa irreführend und sollte daher gestrichen werden. Für den Fall, dass eine solche Vereinbarung nicht besteht, sollte ein preisgünstiges Arzneimittel abgegeben werden, wobei die Auswahlkriterien transparent und nachvollziehbar sein müssen.

Überdies sei angemerkt, dass die Wirtschaftlichkeit des abgegebenen Arzneimittels nicht von der Rechtsgrundlage des Vertrages abhängt. Verträge auf der Grundlage von § 130c Abs. 1 SGB V sollten ebenso vorrangig berücksichtigt werden wie Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V. Der vfa möchte daher anregen, diesen Aspekt bei der Anpassung (gesetzlicher und) untergesetzlicher Regelungen in § 40c Abs. 2 (konsequenterweise entsprechend auch in §§ 40a und 40b Abs. 2 AM-RL) zu berücksichtigen.

VZA

In Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 soll geregelt werden, dass Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V vorrangig zu berücksichtigen sind. Einer solchen Regelung bedarf es in § 40c AM-RL nicht, da sich die Berücksichtigung aus § 129 Abs. 1 S. 12 iVm S. 5 SGB V ohnehin – insbesondere korrekt mit Bezug auf die Regelungen im Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V – ergibt.

AkdÄ

Die vorgelegte Änderung der AM-RL stellt einen weitgehenden Eingriff in die Behandlung mit Biologika dar, da sie über die bestehende Ausnahme von § 40b AM-RL für parenteral zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung vorgesehene Biosimilars hinaus eine verpflichtende Substitution durch Apotheken nach dem Vorbild der Generika nunmehr für alle Biosimilars

implementiert. Dabei geht es nicht nur um die Umstellung von Patienten von Referenzarzneimitteln auf Biosimilars, um verfügbare Einsparungen für die solidarisch finanzierte gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu realisieren. Es wird vielmehr eine rechtliche Basis geschaffen, um auch mehrfache Umstellungen von einem Biosimilar auf ein anderes je nach Rabattverträgen nach § 130a SGB V zu ermöglichen.

Die AkdÄ weist darauf hin, dass Vereinbarungen nach § 130a Absatz 8 SGB V (sog. Rabattverträge) nur für einen bestimmten Zeitraum geschlossen werden und sich entsprechend ändern können. Dies impliziert, dass Patienten ggf. mehrfach umgestellt werden müssen, um die Wirtschaftlichkeit der Verordnung zu gewährleisten. Auch wenn diese Vorgehensweise als medizinisch unbedenklich angenommen wird, können solche multiplen Umstellungen die Adhärenz sowie die Arzneimitteltherapiesicherheit negativ beeinflussen.

[...] Es wird geregelt, dass entweder ein nach § 130a SGB V rabattiertes Arzneimittel abgegeben wird oder, wenn noch keine Rabattverträge bestehen, ein preisgünstiges Arzneimittel. Nach dem § 12 des Rahmenvertrags nach § 129 Absatz 2 SGB V muss im zweiten Fall eines der vier preisgünstigsten Fertigarzneimittel abgegeben werden. Beim Preisvergleich müssen das Wirtschaftlichkeitsgebot sowie alle gesetzlichen Rabatte beachtet werden. Sind diese vier günstigsten Fertigarzneimittel nicht lieferbar, hat die Apotheke das nächstpreisgünstige, verfügbare Fertigarzneimittel abzugeben. Bei der Auswahl darf das abzugebende Fertigarzneimittel nicht teurer als das verordnete sein.

Mit dieser Regelung würde eine automatische Substitution für Biologika und Biosimilars nach dem Vorbild der Generika eingeführt werden. Solange für eine Krankenkasse keine Rabattvereinbarung nach § 130a SGB V besteht, würde der Patient eines der vier preisgünstigsten Fertigarzneimittel erhalten, wobei hierbei anzunehmen ist, dass es sich dabei um ein Biosimilar handeln wird.

Die AkdÄ weist darauf hin, dass diese Regelung die Auswahl des abzugebenden biologischen Arzneimittels ausrichtet nach den im Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V vereinbarten Vorgaben zur Abgabe von Arzneimitteln zu Lasten der GKV.

[...] Wenn der Arzt ein biologisches Arzneimittel verordnet hat, für das eine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V mit Wirkung für die Krankenkasse (= „Rabattpartner“ der Krankenkasse, rabattiertes Arzneimittel) besteht, sollte aus Sicht der AkdÄ ein Austausch in der Apotheke unterbleiben. Mit einer Verordnung eines rabattierten Arzneimittels stellt der Arzt die Wirtschaftlichkeit seiner Verordnung sicher. Ein Austausch in diesem Fall würde ohne erkennbaren Nutzen die Patienten und ihre Therapietreue negativ beeinflussen. Von einem Austausch bei Verordnung eines rabattierten Arzneimittels könnte lediglich die abgebende Apotheke profitieren, die bei einem höheren Verkaufspreis eines Arzneimittels eine höhere Gewinnmarge (3 % des Einkaufspreises nach § 3 AMPreisV) erzielen würde. Dies darf nicht auf Kosten der Adhärenz und Arzneimitteltherapiesicherheit erfolgen und sollte daher explizit in der AM-RL geregelt werden.

GKJR

Bei Verordnung eines Biosimilars/Originators eines Arzneimittels mit Festpreis ist der automatische Austausch durch Apotheken nicht zulässig.

3.2.2 Wahlrecht der Versicherten

AbbVie

Das Wahlrecht der Patienten ist grundsätzlich zu unterstützen. Dies kann zur Aufrechterhaltung der Therapieadhärenz führen, wenn ein Patient weiterhin sein vertrautes Arzneimittel verwenden möchte. Durch die entstehende finanzielle Belastung, die der Patient selbst zu tragen hat, ist allerdings zu bezweifeln, dass von dieser Option häufig Gebrauch gemacht werden wird. Die grundsätzliche Gefahr der abnehmenden Therapieadhärenz kann durch das Wahlrecht daher nicht vollständig gemindert werden.

Merck

Merck begrüßt die Ausführungen des G-BA in den tragenden Gründen zu Absatz 2: „Es wird zudem klargestellt, dass die Möglichkeit für Versicherte gemäß § 129 Absatz 1 Satz 6 SGB V gegen Kostenerstattung auch ein anderes Arzneimittel abweichend zu den Absätzen 1 bis 3 zu erhalten, unberührt bleibt.“ Da die Therapiewahl bereits ab dem ersten Therapiezyklus entscheidend für den Therapieerfolg und das Kinderwunschpaar nur einen gesetzlichen Anspruch auf 50% Erstattung der Kosten hat, sollte die Wahl des Arzneimittels prinzipiell bei der Kinderwunschtherapie von einem Austausch auf Apothekenebene gänzlich ausgeschlossen werden.

Merck schlägt deshalb die folgende Spezifizierung des Absatz 2 vorzunehmen:

„Das Wahlrecht der Versicherten gemäß § 129 Absatz 1 Satz 6 SGB V gilt entsprechend. Insbesondere in Fällen, in denen die Patienten nur einen gesetzlichen Anspruch von 50% der Kosten nach § 27a (3) SGB V hat, obliegt dem Arzt die Wahl des Arzneimittels. Von einem Austausch auf Apothekenebene ist in diesen Fällen abzusehen.“

Pharma Deutschland

Die Nennung des Wahlrechts nach § 129 Absatz 1 Satz 6 SGB V ist im Verhältnis zum § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V nicht sachlogisch. Denn, wenn die Position B1 + B2 in Absatz 1 gelten würde, würde dies dem Wortlaut des § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V i. V. m. § 129 Absatz 1 Satz 6 SGB V entgegenstehen.

vfa

In den Tragenden Gründen wird ausgeführt, dass die Wahlmöglichkeit, gemäß § 129 Abs. 1 Satz 6 SGB V gegen Kostenerstattung auch ein anderes Arzneimittel abweichend zu den Absätzen 1 bis 3 zu erhalten, unberührt bleibt. Da nicht regelhaft davon ausgegangen werden kann, dass Versicherte über dieses Wahlrecht aufgeklärt sind, sollte in der Apotheke verpflichtend hierauf aufmerksam gemacht werden und der Abs. 2 um diese Pflicht entsprechend ergänzt werden.

VZA

Einer solchen Regelung bedarf es in § 40c AM-RL nicht. [...] Gleiches gilt für das Wahlrecht des Versicherten in Absatz 2 Satz 3, der seinerseits nur auf die gesetzliche Regelung in § 129 Abs. 1 S. 6 SGB V verweist.

Bewertung zu den Einwänden 3.2.1 bis 3.2.2:

Nach dem am 15. August 2019 in Kraft getretenen Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) hat der G-BA gemäß § 129 Absatz 1a Satz 3 SGB V Hinweise für die ärztliche Verordnung zur Austauschbarkeit von biotechnologisch hergestellten biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit sowie gemäß § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken zu geben. Damit soll i. V. m. § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V für biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften ein eigener Regelungsrahmen zur Austauschbarkeit durch den G-BA festgelegt werden, der für die übrigen Arzneimittel nicht besteht. Ziel des GSAV ist aber gleichwohl eine wirtschaftliche Versorgung mit Biologika. Zum Gesetzesauftrag siehe auch Bewertung zum Einwand 3.6.1.

Mit § 40c werden die Vorgaben des § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und den Sätzen 2 bis 7 SGB V zur Ersetzung von Fertigarzneimitteln durch Apotheken gemäß § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V für die Gruppe der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel konkretisiert. Gemäß § 129 Absatz 1 Satz 3 SGB V ist die „Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches

Arzneimittel vorzunehmen, für das eine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 mit Wirkung für die Krankenkasse besteht, soweit hierzu in Verträgen nach Absatz 5 nichts anderes vereinbart ist“. Arzneimittel, für die eine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V mit Wirkung für die jeweilige Krankenkasse der Versicherten besteht, sollen demnach im Sinne einer wirtschaftlichen Abgabe vorrangig berücksichtigt werden. In den Verträgen nach § 129 Absatz 5 SGB V kann abweichend vom Rahmenvertrag vereinbart werden, dass die Apotheke – sofern keine Rabattverträge nach § 130a Absatz 8 SGB V bestehen – die Ersetzung wirkstoffgleicher Arzneimittel so vorzunehmen hat, dass der Krankenkasse Kosten nur in Höhe eines zu vereinbarenden durchschnittlichen Betrags je Arzneimittel entstehen. Diese ergänzenden Verträge sind zwischen den Krankenkassen oder deren Verbänden und der für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen maßgeblichen Organisation der Apotheker auf Landesebene zu treffen.

Bislang ist gemäß gesetzlichem Rahmen eine Ersetzung eines biotechnologisch hergestellten Fertigarzneimittels – bis auf Fertigarzneimittel bei parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung – durch die Apotheke grundsätzlich ausgeschlossen. Durch die Regelungen des G-BA in § 40c AM-RL kann sich für diesen Bereich insofern für Apotheken erstmalig eine Befugnis zur Ersetzung ergeben. Der G-BA überträgt in Absatz 2 die bereits in § 129 Absatz 1 Satz 3 SGB V angelegte Systematik mit Berücksichtigung der Vereinbarungen nach § 130a Absatz 8 SGB V und § 129 Absatz 5 SGB V auf den Bereich der Biologika. Ein Vergleich der Arzneimittelkosten erübrigt sich in diesen Fällen, da die Wirtschaftlichkeit insofern über diese Vereinbarungen mit Wirkung für die jeweilige Krankenkasse der Versicherten hergestellt wird; die Regelung führt zudem zu Verfahrensvereinfachung und Rechtssicherheit für Apotheken.

Rabattverträge sind neben einer wirtschaftlichen Auswahl des abzugebenden Arzneimittels auf Basis des Apothekenverkaufspreises durch die Apotheke ein eigenständiges Element zur Schöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven auf Produktebene. Der G-BA ist zwar nicht in die Rabattvertragsverhandlungen eingebunden und hat keine Kenntnisse über die verhandelten Vertragsbedingungen; die Vorgaben des § 130a Absatz 8 SGB V stellen jedoch einen Bestandteil der gesetzlichen Vorgaben für eine wirtschaftliche Arzneimittelversorgung mit biotechnologisch hergestellten Fertigarzneimitteln dar und können vom G-BA in seinen Richtlinien berücksichtigt werden.

Krankenkassen sind ebenso wie die weiteren Systembeteiligten in der gesetzlichen Krankenversicherung an das Wirtschaftlichkeitsgebot gebunden, so dass die Annahme des G-BA, ein entsprechender Rabattvertrag realisiert diese Wirtschaftlichkeitsreserven in Bezug auf die den Krankenkassen tatsächlich entstehenden Kosten, gesetzlich verankert und damit gerechtfertigt ist.

Es ist zudem nicht von einem permanenten Wechsel zwischen verschiedenen Arzneimitteln auszugehen, da die entsprechenden Verträge nach § 130a Absatz 8 SGB V für eine Dauer von zwei Jahren geschlossen werden sollen. In den Vereinbarungen sind zudem die Vielfalt der Anbieter und die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Versicherten zu berücksichtigen. Von diesen Grundsätzen soll auch bei sog. Open House Verträgen nicht abgewichen werden; diese sehen zudem keine Eingrenzung der Anbieter vor und definieren lediglich Teilnahmebedingungen. Bei Open-House-Verträgen hängt sowohl die Teilnahme wie auch die Dauer der Vertragspartnerschaft maßgeblich von den sich beteiligenden pharmazeutischen Unternehmen ab. Die Vertragsinhalte vereinbaren die Vertragsparteien (Krankenkassen oder ihre Verbände – pharmazeutische Unternehmer) und unterliegen damit nicht der Regelungszuständigkeit des G-BA.

Des Weiteren werden von den Stellungnehmern neben den Vereinbarungen nach § 130a Absatz 8 SGB V auch die Vereinbarungen nach § 130c SGB V und festbetragsregelte Arzneimittel für wirtschaftlich erachtet.

Zutreffend ist, dass in der Arzneimittelversorgung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung generell verschiedene Instrumente zur Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebots auf verschiedenen Ebenen ineinandergreifen und auf diese Weise insgesamt zur Realisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven beitragen. Bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken zu geben, orientiert sich der G-BA an den in § 129 SGB V von Gesetzes wegen vorgesehenen Instrumenten zur Versorgungssteuerung und überträgt die dort angelegte Systematik in § 40c Absatz 2 AM-RL auf den Bereich der Biologika. Darüber hinaus sind auch in diesem Bereich die weiteren, von Gesetzes wegen vorgesehenen Instrumente zur Versorgungssteuerung zu berücksichtigen; siehe dazu auch Bewertung zum Einwand 3.6.5.

Von einigen Stellungnehmern wird sich dafür ausgesprochen, dass verordnete rabattierte Biologika generell nicht durch Apotheken ausgetauscht werden sollten. Zugleich werden in den Stellungnahmen unterschiedliche Gründe (z. B. Lieferunfähigkeit, Akutversorgung, Notdienst, freie Wahl der Apotheken unter Rabattvertragspartnern) angeführt, die einer solchen Regelung entgegenstehen könnten. Weitere Regelungen zur Frage der Preisgünstigkeit wären allerdings entweder durch den Gesetzgeber oder auf der Grundlage von § 129 Absatz 2 SGB V zu schaffen. Besteht keine entsprechende Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V, soll ein preisgünstiges Arzneimittel nach Maßgabe des Rahmenvertrages auf der Grundlage von § 129 Absatz 2 SGB V abgegeben werden.

Die eingeräumte Möglichkeit des Wahlrechts der Versicherten wird grundsätzlich begrüßt. Es wird eingewendet, dass von einer Nutzung aufgrund der finanziellen Belastung nur selten auszugehen sei und eine Pflicht zur Aufklärung über dieses Wahlrecht in der Apotheke aufgenommen werden sollte.

Bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags gemäß § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V, Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken zu geben, übernimmt der G-BA die durch § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V von Gesetzes wegen vorgesehene entsprechende Anwendung des § 129 Absatz 1 Satz 6 SGB V. Es besteht für Versicherte derselbe gesetzliche Anspruch auf Erhalt von Arzneimitteln gegen Kostenerstattung wie im Bereich der generischen Arzneimittel.

Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits im Stellungnahmeverfahren zum Beschluss vom 15. Juni 2023 zur Ergänzung des § 40b (neu) in der AM-RL befasst. Es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in der Zusammenfassenden Dokumentation zum entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/>).

3.3 Einwände zum Absatz 3

3.3.1 Unterstützung von Position A + B1

AkdÄ

Es wird geregelt, dass der Austausch in der Apotheke zwischen einem Referenzarzneimittel und einem seiner Biosimilars erfolgen kann bzw. zwischen einem Biosimilar und dem jeweiligen Referenzarzneimittel bzw. zwischen Biosimilars, die bei ihrer Zulassung auf dasselbe Referenzarzneimittel Bezug nehmen. Die möglichen Abgabekonstellationen sind folgend tabellarisch dargestellt:

Verordnetes Arzneimittel	Abzugebendes Arzneimittel nach Maßgabe des § 40c Absätze 1-2 AM-RL *
Referenzarzneimittel A	Biosimilar B oder Biosimilar C
Biosimilar B**	Referenzarzneimittel A oder Biosimilar C
Biosimilar C**	Biosimilar B oder Referenzarzneimittel A
* Ein rabattiertes Arzneimittel nach § 130a SGB V oder eines der vier günstigsten Arzneimittel auf dem Markt **Biosimilar B und Biosimilar C sind als Biosimilars zum Referenzarzneimittel A im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG zugelassen.	

Nach Position B2 soll der Austausch eines Biosimilars gegen ein anderes Biosimilar, auch wenn beide als Biosimilars zum selben Referenzarzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG zugelassen wurden, erst dann erlaubt sein, wenn Evidenz vorliegt, die die Unbedenklichkeit der Umstellung untereinander belegt.

Es ist richtig, dass Umstellungen von einem Biosimilar auf ein anderes Biosimilar zum selben Referenzarzneimittel nicht in Studien untersucht wurden. Die Forderung, Evidenz zu solchen Umstellungen in klinischen Studien zu generieren, ist allerdings in der klinischen Realität nicht umzusetzen. Folgende Punkte sprechen zudem dafür, dass bei solchen Umstellungen keine negativen Einflüsse auf Wirksamkeit und Sicherheit zu erwarten sind:

- Da jedes Biosimilar bei seiner Zulassung eine biologische, chemische, pharmakologische, toxikologische und therapeutische Vergleichbarkeit (Biosimilarität) mit einem Referenzarzneimittel belegen muss, und zwar in mindestens einer sensitiven Indikation und Patientenpopulation, ist davon auszugehen, dass Biosimilars zum selben Referenzarzneimittel weitestgehend vergleichbare biologische, chemische, pharmakologische, toxikologische und therapeutische Eigenschaften aufweisen.*
- Der mehrfache Therapiewechsel von einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar ist mittlerweile gut untersucht worden. Studien haben diesbezüglich keine Hinweise auf umstellungsbedingte Probleme bezüglich der Wirksamkeit oder Sicherheit inkl. Immunogenität erbracht [146, 147, 148, 149, 150].*
- Der Produktionsprozess biologischer Arzneimittel basiert auf DNA-Technologie und Hybridomatechniken. Daher können Änderungen des Herstellungsprozesses, z. B. produzierende Zelllinie, Kulturmedium oder Kulturbedingungen zu Arzneimittelmolekülen führen, die Änderungen in der Tertiärstruktur, in den Isoformen, in den Nukleinsäurevarianten und auch in der Glykosylierung aufweisen. Die Qualität und Eigenschaften biologischer Arzneimittel können sich dementsprechend aufgrund von Modifikationen des Herstellungsprozesses nach der Erstzulassung verändern. In wissenschaftlichen Publikationen wurde gezeigt, dass im Durchschnitt etwa zwei Änderungen des Produktionsprozesses pro Jahr und Biologikum erfolgen. Diese Änderungen können als eine Art „Umstellungen“ betrachtet werden und bringen damit zusätzliche Evidenz dafür, dass auch mehrfache Umstellungen i. d. R. unproblematisch ablaufen.*

146 Gerdes S et al. (2018): Multiple switches between GP2015, an etanercept biosimilar, with originator product do not impact efficacy, safety and immunogenicity in patients with chronic plaque-type psoriasis: 30-week results from the phase 3, confirmatory EGALITY study. J Eur Acad Dermatol Venereol;32(3):420-7.

147 Blauvelt A et al. (2018): Phase III randomized study of the proposed adalimumab biosimilar GP2017 in psoriasis: impact of multiple switches. Br J Dermatol;179(3):623-31.

148 Macaluso FS et al. (2021): The SPOSIB SB2 Sicilian Cohort: Safety and Effectiveness of Infliximab Biosimilar SB2 in Inflammatory Bowel Diseases, Including Multiple Switches. Inflamm Bowel Dis;27(2):182-9.

149 Cohen SB et al. (2018): Extension Study of PF-05280586, a Potential Rituximab Biosimilar, Versus Rituximab in Subjects With Active Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken);70(11):1598-606.

150 Genovese MC et al. (2019): FKB327, an adalimumab biosimilar, versus the reference product: results of a randomized, Phase III, double-blind study, and its open-label extension. Arthritis Res Ther;21(1):281.

- *Biologische Arzneimittel weisen eine chargenspezifische, inhärente Mikrovariabilität aufgrund biotechnologischer Herstellungsprozesse auf [46]. Selbst Patienten, die jahrelang mit „demselben“ Biologikum behandelt wurden, haben demnach mit der Applikation einer anderen Charge desselben Arzneimittels eine Umstellung auf „im Wesentlichen gleiche Biologika“ erlebt.*

Dass der mehrfache Therapiewechsel die Adhärenz gefährden und Nocebo-Effekte bedingen kann, ist bekannt. Dass dies aber insbesondere beim Therapiewechsel von Biosimilars untereinander der Fall sein soll, ist weder wissenschaftlich belegt noch zu erwarten. Es werden keine Studien dazu vorgelegt und auch keine weiteren hierfür relevanten Quellen.

[...] Auch wenn die Forderung nach weiterer Evidenz zur Umstellung zwischen einzelnen wirkstoffgleichen Biosimilars aus Patientensicht möglicherweise nachvollziehbar erscheint, dürfen damit keine wissenschaftlich unbegründeten Zweifel bzw. Bedenken ausgesprochen werden, die insbesondere Patienten verunsichern. Ärzte und Apotheker müssen hierbei entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag die Patienten ausführlich über biologische Arzneimittel und ihre besonderen Eigenschaften informieren und beraten.

Die AkdÄ schließt sich der Position A + B1 an. Position B2 wird abgelehnt.

Bewertung:

Insofern stützt die Stellungnahme die Position, dass die Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel nicht nur zwischen Referenzarzneimittel und den im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilars) – und umgekehrt –, sondern auch zwischen Biosimilars untereinander erfolgen kann, sofern diese mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind.

Bei der Zulassung von Biosimilars nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG gelten Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit als belegt. Speziell im Verhältnis von Biosimilars untereinander und zu ihren Referenzarzneimitteln bewertet der G-BA die Ersetzung unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit. Grundlage hierfür sind im Wesentlichen die Bewertungsgrundlagen der zuständigen Zulassungsbehörden, wonach für die Zulassung eines Biosimilars dieses ein jeweils vergleichbares Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil im Verhältnis zu dem Referenzarzneimittel aufweisen muss.

Sind verschiedene biotechnologisch hergestellte Arzneimittel mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen, ist davon auszugehen, dass mit Blick auf die Anforderungen zur Zulassung eines Biosimilars im Verhältnis zu einem Referenzarzneimittel durch die Inbezugnahme desselben Referenzarzneimittels eine hinreichende Vergleichbarkeit auch der Biosimilars gegeben ist. Dieses Verständnis des G-BA wird nicht zuletzt durch das Statement der EMA zur Interchangeability [59] gestützt.

Nach der Zulassung kann es auch innerhalb eines Arzneimittels zu Änderungen kommen (Mikroheterogenität durch z. B. Änderungen in der Herstellung wie Wechsel der Zelllinie für die Produktion), die jeweils durch die zuständige Zulassungsbehörde geprüft und freigegeben werden. Bei größeren Änderungen kann sich ein ähnliches Verhältnis zwischen neuer und vorhergehender Version des Referenzarzneimittels wie zwischen Biosimilar und Referenzarzneimittel ergeben, so dass es, wie die Stellungnehmerin schreibt, auch bei Weiterverordnung zu „Umstellungen“ kommen kann. Über diese „Umstellungen“ werden die Patienten nicht informiert. Die EMA beschreibt in ihrem Leitfaden für medizinische Fachkräfte [46] die bei Biologika bestehende Mikroheterogenität und kommt zu dem Schluss, dass durch die Kontrollen der Zulassungsbehörden die Variabilität zwischen Chargen gering ist und Sicherheit und Wirksamkeit nicht beeinträchtigt sind. Daraus lässt sich aus Sicht des G-BA in Analogie die Sicherheit bei Ersetzungen zwischen Biosimilars untereinander ableiten.

Die Prüfung der Sachgerechtigkeit einer Ersetzung im Einzelfall bleibt hiervon unberührt. Die Möglichkeit der Apotheke von einer Ersetzung abzusehen ergibt sich dabei aus § 40c Absatz 5. Siehe auch Bewertung der Einwände zum Absatz 5.

Siehe auch Bewertung zu den weiteren Einwänden 3.1.7, 3.6.1 und 3.6.3.

3.3.2 Unterstützung von Position B2

AbbVie

Konkret auf den Beschlussentwurf beziehend ist Position A+B1 abzulehnen und Position B2 zu unterstützen. Es fehlt weiterhin an Evidenz, die die Sicherheit beim mehrfachen Wechsel zwischen Biosimilars belegt – besonders beim Austausch in der Apotheke. Biosimilars sind auf ein jeweiliges Referenzarzneimittel zugelassen. In den jeweiligen Zulassungsstudien belegen sie ihre Sicherheit und Wirksamkeit gegenüber dem Referenzarzneimittel. Zulassungsstudien sind allerdings keine Umstellungsstudien. Zur Feststellung der Unbedenklichkeit der automatischen Substitution in der Apotheke, bedarf es daher entsprechender Umstellungsstudien für die jeweiligen Biologika.

Mehrfache Umstellungen zwischen Biologika bergen weiterhin das Risiko, die Arzneimitteltherapiesicherheit, die Therapieadhärenz und das allgemeine Patientenwohl zu gefährden.

Amgen

Amgen lehnt die Positionen A + B1 jeweils ab und unterstützt die in den Positionen B2 formulierten Regelungsvorschläge.

Eine Substitution eines Arzneimittels durch ein anderes sollte grundsätzlich nur dann erfolgen, wenn belastbare und ausreichende Evidenz vorliegt, dass durch die Substitution der Therapieerfolg nicht beeinflusst wird und keine nachteiligen Effekte entstehen. Dies ist bereits bei der erstmaligen Substitution eines Arzneimittels zu beachten und gilt weiterhin im Therapieverlauf mit mehrmaligen Verordnungen von Arzneimitteln. Ein mehrfacher Wechsel von Arzneimitteln während der Therapie sowie eine Substitution von Biosimilars untereinander ist aufgrund der mangelnden Evidenzlage kritisch zu sehen. Zudem ist bei einer mehrfach wechselnden Substitution von Arzneimitteln zu erwarten, dass die Therapiehistorie nicht mehr nachvollzogen werden kann und somit Pharmakovigilanzsysteme nicht mehr greifen können. Dies wurde bereits im vorhergehenden Verfahren der Substitution von parenteralen Zubereitungen hervorgehoben und blieb leider bisher unberücksichtigt.

Sollte trotz der dargelegten Bedenken dennoch an einer automatischen Substitution durch die Apotheken festgehalten werden, ist es unerlässlich, Patientensicherheit und Therapieerfolg durch klare Einschränkungen zu schützen: Eine Substitution sollte ausschließlich bei der Erstverordnung erfolgen und danach frühestens alle 6 Monate – unter der Voraussetzung einer ärztlichen Überprüfung.

Zudem wäre es erforderlich, eine automatische Substitution nicht unmittelbar nach Markteintritt von Biosimilars zuzulassen, sondern frühestens nach Ablauf angemessener Schutzfristen von mindestens 1 bis 3 Jahren [...].

Bei der Zulassung von Biosimilars wird ein Vergleich mit dem Referenzarzneimittel durchgeführt, der die vergleichbare therapeutische Wirksamkeit und die sichere Anwendung des Biosimilars überprüft. Eine Vergleichbarkeit verschiedener Biosimilars untereinander ist hingegen nicht Gegenstand der arzneimittelrechtlichen Zulassung. Eine Extrapolation der Ergebnisse von Vergleichen verschiedener Biosimilars mit einem Referenzarzneimittel auf Vergleiche zwischen verschiedenen Biosimilars ist mit deutlichen Unsicherheiten behaftet und

wird kontrovers diskutiert [151].

Biogen

Die zu Absatz 3 dargelegten Aspekte zur begrenzten Evidenzlage bei mehrfachen unbegleiteten Präparatewechsel, den Risiken für Patientensicherheit, Therapietreue und Versorgungsdokumentation sowie die potenziellen Auswirkungen auf Registerdaten und Pharmakovigilanz unterstreichen die Notwendigkeit klarer Kriterien für die Austauschbarkeit. Vor diesem Hintergrund wird Position B2 ausdrücklich gestützt: Bei mehrfacher Ersetzung zwischen Biosimilar und Biologikum aus nicht-medizinischen Gründen muss Evidenz für die Unbedenklichkeit vorliegen. Alternativ ist die Ersetzung zwischen Biosimilars nur dann zuzulassen, wenn das Biosimilar auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen ist und belastbare Evidenz die Unbedenklichkeit der ein- oder mehrmaligen Ersetzung untereinander belegt.

Fresenius Kabi

[...] Der Forderung der „Position B2“ nach Evidenz für die Unbedenklichkeit des Austausches schließen wir uns somit an. Der Vergleich mit anderen evidenzbasierten Bewertungsverfahren des G-BA – etwa im Rahmen der Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V oder bei Richtlinienentscheidungen zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren – verdeutlicht, dass auch die Bewertung der Austauschbarkeit biotechnologischer Arzneimittel denselben methodischen Anforderungen genügen muss. Eine pauschale Feststellung der Austauschbarkeit ohne belastbare Evidenz zur Unbedenklichkeit mehrfacher Substitution würde den Bewertungsstandard unterlaufen, den sich der G-BA in seiner Verfahrensordnung selbst gesetzt hat. Dort heißt es in § 5 Absatz 2 ausdrücklich, der G-BA „ermittelt den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin“. Dieser Maßstab gilt ausnahmslos – auch für die Bewertung der Austauschbarkeit –, und er erfordert insbesondere bei mehrfach möglichen Produktwechseln eine fundierte Beurteilung der therapeutischen Vergleichbarkeit hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Therapietreue.

Hexal

Neben den formalen aut idem Kriterien (u.a. Darreichungsform, Applikationsart und Anwendungsgebiet), dargestellt in § 40c Abs. 1 AM-RL, ist für die Auswahl an austauschbaren Arzneimitteln der jeweilige Zulassungsstatus ein weiteres Kriterium. Der Beschlussentwurf zu § 40c Abs. 3 AM-RL sieht entsprechend vor, dass ein Austausch zwischen einem im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilar) und dem jeweiligen Referenzarzneimittel erfolgen kann. Ebenso soll ein Austausch zwischen den jeweiligen Biosimilars untereinander, die auf dasselbe Referenzarzneimittel bezugnehmend zugelassen sind, möglich sein. Die Position B2 fordert zusätzliche Evidenz für die Unbedenklichkeit in Bezug auf den Mehrfachswitch zwischen Referenzarzneimittel und Biosimilar sowie in Bezug auf die ein- oder mehrmalige Ersetzung von Biosimilars untereinander.

Wir schließen uns klar der Position B2 an – die Unbedenklichkeit einer automatischen (nicht-ärztlichen) Umstellung von einem Biosimilar auf ein alternatives Biosimilar ist auf Basis der vorliegenden Studienlage nicht ausreichend belegt.

Der systematische Review von Tolonen et. al. von 2021 [152] zeigt auf, dass die Forschungsevidenz und Erfahrungslage zur automatischen Substitution von Biologika begrenzt und von geringer bis mäßiger Qualität ist. Die Autoren betrachteten 27 Studien aus Europa,

151 Halimi V et al. (2020): Clinical and Regulatory Concerns of Biosimilars: A Review of Literature. Int J Environ Res Public Health;17(16).

152 Tolonen HM et al. (2021): Is There Any Research Evidence Beyond Surveys and Opinion Polls on Automatic Substitution of Biological Medicines? A Systematic Review. BioDrugs;35(5):547-61.

Nordamerika, Australien, Pakistan, Tunesien, Lateinamerika, Kanada und Asien, in denen die Erwartungshaltung von verschiedenen Teilnehmern (verordnenden Ärzten, Apothekern, Patienten und Kostenträgern) zu einem automatischen Biosimilar-Switch untersucht wurden. Nur circa ein Drittel der Studien (8/27) wurde in Ländern durchgeführt, in denen eine automatische Substitution auf Apotheken-Ebene unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt war oder die Substitution zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht ausdrücklich verboten war. Es zeigte sich, dass in einem Großteil der Studien (18/27) der Switch mit einer negativen Erwartungshaltung der Teilnehmer einherging [152] und diese Wahrnehmungen den „Nocebo-Effekt“ verstärken können. Passend dazu gaben in einer amerikanischen Studie 85% der befragten Patienten zu einem Biosimilar-Switch an, über eine Abnahme der Wirksamkeit des Biosimilars besorgt zu sein. 83% der Befragten befürchteten zudem, dass das Biosimilar zu einem Anstieg der Nebenwirkungen führen würde [153].

In der dänischen DANBIO-Studie wurde eine automatische Umstellung des Originators von Etanercept auf ein Biosimilar bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen untersucht. Die Krankheitsaktivität in der Switch-Gruppe war drei Monate vor und nach dem Switch stabil, jedoch war die 1-Jahres-Retentionsrate bei den umgestellten Patienten niedriger als die Rate einer historischen Referenz-Kohorte des Referenzprodukts (95% CI: 79% bis 87% vs. 88% bis 92%). Da im Laufe des Follow-Ups eine Untergruppe der umgestellten Patienten wieder zurück auf das Referenzprodukt wechselte, ohne dass bei diesen Patienten klinisch messbare Veränderungen festgestellt werden konnten, wurde der Grund des Zurückwechselns auf das Referenzprodukt dem sogenannten „Nocebo-Effekt“ zugeschrieben [154].

Die maßgebliche Evidenz im Kontext der Umstellung von einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar beschreibt allerdings ausschließlich die **Umstellung unter ärztlicher Aufsicht**. Die Ergebnisse z.B. der NOR-SWITCH [155], der ADACCESS [147] oder auch der EGALITY-Studien [156] zeigen, dass Biosimilars und ihr jeweiliges Referenzprodukt ohne belegbare Nachteile bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit unter ärztlicher Aufsicht und Therapiebegleitung gewechselt werden können. Für eine ausführlichere Diskussion der genannten Studien sei ergänzend auf unsere Stellungnahme vom 19. Mai 2022 hingewiesen.

Abseits der Tatsache einer unzureichenden Evidenzlage zu den Auswirkungen einer automatischen Substitution in der Apotheke ohne ärztliche Rücksprache liegt bis heute keine spezifische Studienlage vor, die einen Switch unter ärztlicher Kontrolle oder auch im Sinne einer apothekerlichen aut idem Substitution von einem Biosimilar auf ein weiteres Biosimilar untersucht hat [152, 156, 157, 158, 159, 160].

153 Teeple A et al. (2019): Physician attitudes about non-medical switching to biosimilars: results from an online physician survey in the United States. *Curr Med Res Opin*;35(4):611-7.

154 Glinborg B et al. (2019): To switch or not to switch: results of a nationwide guideline of mandatory switching from originator to biosimilar etanercept. One-year treatment outcomes in 2061 patients with inflammatory arthritis from the DANBIO registry. *Ann Rheum Dis*;78(2):192-200.

155 Jørgensen KK et al. (2017): Switching from originator infliximab to biosimilar CT-P13 compared with maintained treatment with originator infliximab (NOR-SWITCH): a 52-week, randomised, double-blind, non-inferiority trial. *Lancet*;389(10086):2304-16.

156 Griffiths CEM et al. (2017): The EGALITY study: a confirmatory, randomized, double-blind study comparing the efficacy, safety and immunogenicity of GP2015, a proposed etanercept biosimilar, vs. the originator product in patients with moderate-to-severe chronic plaque-type psoriasis. *Br J Dermatol*;176(4):928-38.

157 Cohen SB et al. (2019): Long-term safety, efficacy, and immunogenicity of adalimumab biosimilar BI 695501 and adalimumab reference product in patients with moderately-to-severely active rheumatoid arthritis: results from a phase 3b extension study (VOLTAIRE-RAext). *Expert Opin Biol Ther*;19(10):1097-105.

158 Emery P et al. (2017): Long-term efficacy and safety in patients with rheumatoid arthritis continuing on SB4 or switching from reference etanercept to SB4. *Ann Rheum Dis*;76(12):1986-91.

159 Yoo DH et al. (2017): Efficacy and safety of CT-P13 (biosimilar infliximab) in patients with rheumatoid arthritis: comparison between switching from reference infliximab to CT-P13 and continuing CT-P13 in the PLANETRA extension study. *Ann Rheum Dis*;76(2):355-63.

160 Park W et al. (2017): Efficacy and safety of switching from reference infliximab to CT-P13 compared with maintenance of CT-P13 in ankylosing spondylitis: 102-week data from the PLANETAS extension study. *Ann Rheum Dis*;76(2):346-54.

Medice

Der gesetzliche Auftrag in § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V bezieht sich originär auf die Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln und nicht auf den Austausch von Biosimilars untereinander. Die Umstellung von einem Biosimilar auf ein anderes Biosimilar kann auch beim selben Referenzarzneimittel medizinisch kritisch sein und die Patientensicherheit gefährden. Insofern begrüßen wir die im Beschlusstext gewählte Überschrift des §40c (neu), der „Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken“ gibt. Dieser Überschrift sollte im Verlauf des Beschlusses auch gefolgt werden.

[...] Sowohl das von MEDICE ausgetobene Epoetin alfa (Abseamed®) als auch das zu einem späteren Zeitpunkt eingeführte Epoetin zeta sind mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel (Erypo®) mit dem Wirkstoff Epoetin alfa zugelassen. Epoetin zeta hat jedoch nicht ohne Grund eine abweichende Wirkstoffbezeichnung erhalten. Eine Umstellung aus nicht medizinischen Gründen zwischen Epoetin alfa- und Epoetin zeta-Biosimilars ist problematisch, denn eine hinreichende Vergleichbarkeit ist nicht gegeben.

Während des Zulassungsverfahrens wird immer nur die Vergleichbarkeit zwischen dem Referenzprodukt (Originator) und dem im Zulassungsverfahren betrachteten Biosimilar geprüft, und in keiner Weise die Vergleichbarkeit mit einem anderen Biosimilar. Die Vergleichbarkeit zweier biologischer Arzneimittel (innerhalb spezifischer Grenzwerte) mit demselben Referenzarzneimittel erlaubt allerdings schon aus statistischen Gründen keine Rückschlüsse auf die Bioäquivalenz der beiden biologischen Arzneimittel. Angenommen, Produkt A (Biosimilar A) wurde auf Basis nicht-klinischer und/oder klinischer Prüfungen eine Bioäquivalenz am unteren Rand des vorgegebenen Vertrauensbereichs des Originators (Produkt B) zugelassen, während Produkt C (Biosimilar B) nach den entsprechenden Prüfungen aufgrund einer Bioäquivalenz am oberen Rand der vorgegebenen Spezifikationen mit dem Originator (Produkt B) zugelassen wurde. In diesem Beispiel kann zwischen Biosimilar A und Biosimilar C nicht zwingend eine Bioäquivalenz angenommen werden, da sich die Produkteigenschaften der beiden Biosimilars trotz jeweiliger Vergleichbarkeit mit dem Originator mit großer Wahrscheinlichkeit nicht innerhalb des Bioäquivalenzmargins bewegen. Eine Bioäquivalenz kann somit aus statistischen Erwägungen nur für Wirkstoffe angenommen werden, für die diese auch tatsächlich in entsprechenden Prüfungen dargestellt worden ist.

[...] Die Betrachtung der beiden Zulassungsverfahren (Epoetin alfa Biosimilar und Epoetin zeta) legt nahe, dass Biosimilars nicht zwangsläufig als einander bioäquivalent angesehen werden können, auch wenn sie auf gleiche biologische Arzneimittel referenzieren. Insofern muss hier deutlich hinterfragt werden, inwieweit zwei biologische Arzneimittel untereinander austauschbar sein sollen, wenn die Bioäquivalenz der beiden Arzneimittel in klinischen Studien nicht untersucht wurde. Die in der Zulassungsdokumentationen dargestellten Unterschiede hinsichtlich des Dosisbedarfs bzw. der Wirksamkeit wurden in einer großen retrospektiven Beobachtungsstudie in mehr als 14.000 deutschen Dialysepatienten bestätigt.

Wenn eine Zulassungsbehörde trotz des identischen Referenzarzneimittels auf einer abweichenden Wirkstoffbezeichnung besteht, darf eine - wirkstoffübergreifende - automatische Substitution hier nach unserem Verständnis nicht geregelt werden. Epoetin alfa und zeta sind weder wirkstoffgleich noch im Wesentlichen gleich, sonst wäre die abweichende Wirkstoffbezeichnung entbehrlich gewesen.

Es besteht die Gefahr, dass der Patient/ die Patientin in eine anämische Situation gerät, die erst mit Verzögerung bei der üblicherweise einmal im Quartal stattfindenden Kontrolle der Blutwerte auffällt und entsprechende Folgekosten zum erneuten Erreichen der wünschenswerten hämatologischen Zielgröße verursacht, ganz zu schweigen von einer Verschlechterung des Gesundheitszustands.

[...] Wir folgen insofern der Position B2, dass für eine Austausch zunächst Evidenz vorliegen

muss, die die Unbedenklichkeit der ein- oder mehrmaligen Ersetzung der Biosimilars untereinander belegt.

Merck

Merck begrüßt die in Position B2 ausgeführte Regelung in Absatz 3, dass bei mehrmaliger Ersetzung erst Evidenz für die Unbedenklichkeit der mehrfachen Ersetzung vorliegen muss [...].

Da der Patient seine Verschreibungen nicht zwingend in derselben Apotheke einlöst, hat die aufgesuchte Apotheke keine Kenntnis über die Häufigkeit des Austausches. Insofern sollte der verschreibende Arzt zwingend den Überblick über den Therapiewechsel behalten, auch um Mehrfachwechsel identifizieren zu können.

Novartis

Der Satz 3 des Artikels 40c impliziert die Möglichkeit des mehrfachen Austausches aus nicht-medizinischen Gründen sowohl zwischen einem Referenzarzneimittel und seinem Biosimilar oder umgekehrt als auch von Biosimilars untereinander. Hierzu fehlt zum großen Teil die medizinische Evidenz (insbesondere langfristige Beobachtungen) auch in extrapolierten Indikationen, so dass Position B2 folgerichtig ist. Die Biosimilarität zwischen im Wesentlichen gleichen biologisch hergestellten Arzneimitteln und dem Referenzarzneimittel ist nur von der Substanz her zulassungsbedingt gegeben, nicht aber über Indikationen hinweg oder gar zwischen Biosimilars untereinander. Dies führt zu Risiken im Bereich Patientensicherheit und Therapieerfolg sowie Pharmakovigilanz.

Die Patientensicherheit kann durch einen nicht mit dem behandelnden Arzt abgestimmten, mehrfachen Wechsel gefährdet werden. So müssen zum Beispiel bei Xolair® und Omlyclo® die ersten drei Injektionen gemäß Fachinformation durch medizinisches Fachpersonal oder unter Aufsicht erfolgen [33, 34]. Dies ist unumgänglich, um sich konform zur Fachinformation zu verhalten. Bei einer Substitution in der Apotheke ist nicht automatisch gewährleistet, dass diese Vorgabe eingehalten wird – insbesondere, wenn Patienten ein neues Präparat erhalten, das sie zuvor nicht kannten. Dies widerspricht regulatorischen Anforderungen und untergräbt die Therapiesicherheit. Die Notwendigkeit eines Hinweises in der Apothekensoftware, der basierend auf der anzupassenden Anlage VIIa erstellt wird, wäre eine mögliche Minimallösung, um die Patientensicherheit sicherzustellen und ein Vorgehen entsprechend den Vorgaben der Fachinformation zu gewährleisten. Der Mehrfachaufwand in der Arztpraxis – welcher ohne jegliche medizinische Rationale entsteht – kann nicht vermieden werden.

Novo Nordisk

Der abgebenden Apotheke ist das zugrunde liegende Referenzarzneimittel eines bezugnehmend zugelassenen Biosimilars in der Regel nicht bekannt, da es anhand der verfügbaren Informationen aus der Fachinformation und der ABDA-Datenbank nicht direkt ersichtlich oder nachvollziehbar ist. Die im Wesentlichen gleiche biotechnologische Herstellungsweise ist der Apotheke zum einen mit den standardmäßig verfügbaren Informationen nicht bekannt und zum anderen fehlt es an eindeutigen Kriterien, in welchem Fall es sich um eine im Wesentlichen gleiche biotechnologische Herstellungsweise handelt. Die Beurteilung dieser in Bezug auf den eingesetzten Organismus und daraus resultierende Effekte auf den biologischen Wirkstoff sind komplex und in keiner Weise mit der Situation chemisch-synthetisch hergestellter „small molecules“ im Generika-Markt zu vergleichen. Novo Nordisk verweist an dieser Stelle auf den Wirkstoff Liraglutid, welcher u. a. Gegenstand eines Stellungnahmeverfahrens zur AM-RL/Anlage VII ist, zu welchem Novo Nordisk separat Stellung nimmt. Bei dem Originalprodukt Victoza® handelt es sich beispielsweise um ein biotechnologisch hergestelltes komplexes Peptid dessen Sekundär- und Tertiärstruktur klinisch relevant ist [161, 162]. Bei dem bezugnehmenden Produkt Diavic® handelt es sich um ein voll-

161 Fachinformation Victoza. Stand November 2024.

162 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM): Advice meeting concerning Liraglutide. 2020.

synthetisch hergestelltes Produkt, bei dem Unterschiede in der Reinheit, d.h. dem Verunreinigungsprofil, und höchstwahrscheinlich auch in der Neigung zur Protein-Fibrillation sowie im Ausmaß der Proteine mit hohem Molekulargewicht (HMWP-Level) zu erwarten sind [162, 163]. An dieser Stelle weist Novo Nordisk darauf hin, dass der Wortlaut von § 40c (neu) Absatz 1 Satz 1 lediglich den Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln vorsieht und damit die rechtliche Grundlage für den Austausch eines biotechnologisch hergestellten Arzneimittels gegen ein voll-synthetisch hergestelltes Arzneimittel im Bereich der Biosimilars nicht gegeben ist.

Die therapierelevante Einordnung der im Wesentlichen gleichen biotechnologischen Herstellungsweise liegt und sollte auch zukünftig bei den verordnenden Ärzt:innen liegen.

Novo Nordisk spricht sich an dieser Stelle für die **Position B2** aus. Für eine mehrmalige Ersetzung aus nicht-medizinischen Gründen sieht Novo Nordisk mindestens einen Bedarf für das Vorliegen von Evidenz zur Unbedenklichkeit des mehrmaligen Austausches im Sinne der Patientensicherheit in der Arzneimitteltherapie mit biologischen Arzneimitteln. Im Rahmen der Zulassung wird lediglich die Vergleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel eines bezugnehmen Biosimilars geprüft [44]. Der zu erwartende Therapieerfolg bei mehrfachem Wechsel von Referenzarzneimitteln und Biosimilars ist unklar und bislang nicht wissenschaftlich belegt. Novo Nordisk spricht sich gegen eine mehrmalige Substitution aufgrund der nicht absehbaren Folgen für die Arzneimitteltherapiesicherheit der Patient:innen aus.

Außerdem weist Novo Nordisk daraufhin, dass bei mehrfacher Ersetzung eines biologischen Arzneimittels zwangsweise unbekannte Therapiehistorien in der Apotheke zu erwarten sind, da nicht sichergestellt werden kann, dass bei einem Wechsel der aufgesuchten Apotheke eindeutig nachvollzogen werden kann, welches Präparat im letzten Therapiezyklus angewendet wurde. Auch eine bislang freiwillige Dokumentation in der elektronischen Patientenakte ist für die Apotheke nicht einsehbar. Somit besteht für die Apotheke keine Prüfmöglichkeit, ob es sich um eine erste oder mehrfache Ersetzung zum Zeitpunkt der Arzneimittelabgabe in der Apotheke handelt und ein besonderer Beratungs- und Informationsbedarf zur Aufklärung der Patient:innen besteht.

Der Austausch der Biosimilars untereinander, welche jeweils in Bezug auf das zu ermittelnde Referenzarzneimittel zugelassen sind, ist bislang nicht untersucht und nicht Gegenstand der Beurteilung der Bioäquivalenz im Rahmen der Zulassung von Biosimilars. Die therapeutische Vergleichbarkeit verschiedener Biosimilars untereinander ist dementsprechend bislang nicht untersucht und auch nicht von den Zulassungsbehörden geprüft. Die Wahl des biologischen Arzneimittels sollte nicht in der Apotheke erfolgen, sondern zwischen Ärzt:innen und Patient:innen im individuellen Gespräch. Absatz 3 erweitert außerdem die Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln auf „im Wesentlichen gleich[.] biotechnologisch hergestellte[.] biologische[.] Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilars) [..] die mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel wie das Verordnete zugelassen [..]“ sind. Hiermit ist der Austausch der Biosimilars untereinander vorgesehen, für den zum einen keine Evidenz vorliegt und der zum anderen im eindeutigen Widerspruch zu § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V steht. Außerdem bestehen auch hier die oben genannten Bedenken bezüglich der Komplexität einer im Wesentlichen gleichen biotechnologischen Herstellungsweise sowie der fehlenden eindeutigen Kriterien zur Einstufung dieser.

Wir [...] plädieren an dieser Stelle nochmals für die Notwendigkeit des Vorliegens von Evidenz für die Unbedenklichkeit der mehrmaligen Substitution von biologischen Arzneimitteln, insbesondere von Biosimilars untereinander aus den oben genannten Gründen. Wir möchten auch deutlich machen, dass Novo Nordisk einer mehrmaligen Ersetzung von Biosimilars

untereinander an sich keinesfalls zustimmt. Aus Sicht von Novo Nordisk sind die Risiken des Verlustes der Therapieadhärenz und der Patient:innen-Compliance stärker zu gewichten als die ggf. zu erreichenden monetären Einsparungen.

Die Verunsicherung von, in der Regel, pädiatrischen Patient:innen und deren Angehörigen durch Krankversicherungs-bedingte Produktwechsel konnte explizit für Wachstumshormon-Präparate bei pädiatrischen Patient:innen gezeigt werden [164]. Die Untersuchung zeigte auch mögliche Konsequenzen wie eine reduzierte Wirksamkeit der Arzneimitteltherapie und Therapietreue, die letztendlich zu einem ungünstigeren Nutzen-Risiko-Verhältnis für Patient:innen, einem erhöhten Arbeitsaufwand für die Endokrinologie-Praxis und dem Verlust von Langzeit-Follow-Up-Daten für die Wachstumshormone-Register führen. Novo Nordisk vertritt die Auffassung, dass sich diese Erkenntnisse auch auf andere Produkte und Anwender:innen der hochsensiblen Therapie mit biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln übertragen lassen und dass die Bedürfnisse einzelner Patient:innen berücksichtigt werden sollten.

ABDA, AMK

Wir begrüßen die Maßgabe nach Position B2, wonach eine mehrmalige Umstellung aus nichtmedizinischen Gründen auf ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes Arzneimittel (Biosimilar) erst erfolgen darf, wenn Evidenz für die Unbedenklichkeit der mehrfachen Ersetzung vorliegt. Diese Forderung nach Evidenz ist insofern gerechtfertigt, als dass der mehrfache Therapiewechsel von einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar und zurück bisher nur vereinzelt untersucht worden ist und somit grundsätzliche Bedenken bezüglich der Sicherheit und Effektivität eines solchen (Mehrfach-)Austausches bestehen.

Gleichwohl wir diese Bedenken teilen und mehrfache, rabattvertragsgesteuerte Therapiewechsel, v. a. im Sinne der Adhärenz und Persistenz, zu vermeiden sind, liegen dem Apotheker oder der Apothekerin keinerlei valide Informationen zur Verifizierung eines mehrfachen Therapiewechsels aufgrund medizinischer Notwendigkeit vor.

Die Positionen A und B1 bzgl. der Umstellung im Verhältnis wesentlich gleicher biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel untereinander, sofern diese mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind, wird abgelehnt.

Da der einfache und mehrfache Therapiewechsel von Biosimilars untereinander bisher nicht hinreichend untersucht worden ist, schlagen wir vor, die Umstellung nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 von im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln untereinander erst dann zu erwägen, wenn ausreichende Evidenz vorliegt, die die Unbedenklichkeit bei Umstellung untereinander belegt. Diese Informationen sollten in den in Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) abgebildeten Zusammenhängen der in Deutschland zugelassenen Referenzarzneimitteln und im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilars) berücksichtigt werden.

ADKA

Die ADKA lehnt die Position A + B1 ab und begrüßt, dass ein etwaiger Austausch von einem verordneten Arzneimittel auf ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel zu erfolgen hat – mit der Maßgabe, dass eine mehrmalige Ersetzung aus nicht-medizinischen Gründen nur evidenzbasiert auf Basis einer belastbaren Sicherheitsdatenlage zulässig ist.

Allerdings ist die derzeitige Studienlage zur Sicherheit mehrfacher nicht-medizinisch begründeter Switches zwischen Biosimilars insgesamt als unzureichend zu bewerten. Es bedarf

164 Grimberg A et al. (2012): Consequences of brand switches during the course of pediatric growth hormone treatment. Endocr Pract;18(3):307-16.

dringend weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen und Post-Marketing-Daten, um die potenziellen Risiken für Patientinnen und Patienten valide bewerten zu können.

Zudem ist es unerlässlich, dass diese Evidenz den Apotheken in strukturierter, verbindlicher und aktuell gehaltener Form zur Verfügung gestellt wird – idealerweise über die Anlage VIIa hinaus. Nur so kann eine rechtssichere Umsetzung der vorgesehenen Austauschregelungen in der Praxis gewährleistet werden.

BPI

[...] Zumindest aber wäre aus Gründen der Patientensicherheit und zur Reduktion des Haftungsrisikos des Arztes der Vorzug zu geben, die vorsieht, dass eine Substitution in der Apotheke jeweils erst dann vom G-BA in den nach §129 Abs. 1a S. 5 SGB V zu formulierenden Hinweisen zugelassen wird, wenn Evidenz für die Unbedenklichkeit der ein- oder mehrfachen Ersetzung aus nichtmedizinischen Gründen vorliegt.

Pharma Deutschland

Pharma Deutschland befürwortet Position B2 in Absatz 3 und den damit verbundenen Grundsatz des § 70 SGB V, dass Leistungserbringer und Krankenkassen eine Versorgung nur entlang des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse erbringen bzw. übernehmen dürfen. Für den mehrmaligen Austausch der Biosimilar untereinander fehlt es an ausreichender Evidenz hinsichtlich der Unbedenklichkeit. Durch Therapiewechsel ohne Kenntnis des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin würde zudem die Aussagekraft von Registern, die bei Biosimilars üblicherweise Teil der geforderten Datenerhebung in Risk-Management-Plänen sind, geschwächt, da beobachtete Effekte nicht mehr eindeutig einem Arzneimittel zugeordnet werden können. [...]

vfa

Ein mehrfacher Wechsel des Präparats während der Behandlung sollte generell vermieden werden, um die Therapieadhärenz bestmöglich zu gewährleisten. Der vfa unterstützt die Position B2 auch aus Erwägungen bezüglich der Sicherheit bei mehrfachem Wechsel, die noch nicht ausreichend belegt ist. Die Unbedenklichkeit eines ein- oder mehrmaligen Wechsels sollte anhand geeigneter Evidenz belegt werden und explizit Voraussetzung für einen Wechsel sein.

Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ)

Des Weiteren ist der auf S. 7 der „Tragenden Gründe“ unter B2 dargestellten Position zuzustimmen, dass es keine ausreichende Evidenz dafür gibt, dass ein mehrfacher Therapiewechsel (der bei chronischen Erkrankungen sehr wahrscheinlich ist), langfristig unbedenklich ist. Unserer Kenntnis nach gibt es hierzu immer noch unzureichende Studien, mit meist geringer Beobachtungszeit bzw. der Untersuchung nur eines Biosimilars im Vergleich zum Biooriginator. Das multiple Wechseln war bislang selten Gegenstand der Forschung.

Deshalb sollte zumindest sichergestellt werden, dass bei einer Abgabe eines preisgünstigeren Präparates diese Therapie anschließend beibehalten wird, um den Betroffenen ständige Wechsel von Applikationsform, Handhabung etc. zu ersparen. Dies könnte durch Dokumentation in der Apotheke erfolgen. Hierzu sei angemerkt, dass diese Information zentral gespeichert werden müssten (z.B. über die elektronische Patientenakte), da Apothekenwechsel deutlich häufiger erfolgen, als beispielsweise Wechsel der behandelnden Ärztinnen/Ärzte.

3.3.3 Weitere Einwände

Bayer Vital GmbH (Bayer)

Besonders hinweisen möchten wir auf den Änderungsbedarf bezüglich § 40c Absatz 3. In den Tragenden Gründen zu Absatz 3 heißt es wörtlich: „Die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander ist grundsätzlich nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung und wird durch die Ergänzung der AM-RL sowie die vorliegende Anlage VIIa nicht

weiter konkretisiert“. Diese Aussage ist konsistent mit den Tragenden Gründen zum G-BA-Beschluss über eine Änderung der AM-RL § 40a (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln vom 20. August 2020, wo es heißt: „Der Regelungsauftrag in § 129 Absatz 1a Satz 3 SGB V erstreckt sich auf den Austausch von Referenz-Arzneimittel und den entsprechenden Biosimilars; die Umstellung von Originalarzneimitteln untereinander ist nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung und wird durch die Ergänzung der Arzneimittel-Richtlinie nicht weiter konkretisiert“.

Wir sind der Auffassung, dass nicht nur in den Tragenden Gründen zu § 40c Absatz 3 AM-RL zu erwähnen ist, dass die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung ist, sondern dass dies unmittelbar in § 40c Absatz 3 selbst zu regeln ist. Ansonsten sind Fehlinterpretationen bezüglich einer Austauschbarkeit zu erwarten.

Celltrion

Da im Rahmen der automatischen Substitution nicht sichergestellt ist, dass nur ein einmaliger Wechsel erfolgt, sondern im Gegenteil mehrfache, nicht ärztlich gesteuerte Wechsel zu erwarten sind, bedarf es auch einer expliziten Evidenzgrundlage zur Unbedenklichkeit solcher Mehrfachwechsel. Ohne eine solche Evidenz kann der G-BA die gesetzlich verlangte Bewertung der therapeutischen Vergleichbarkeit nicht mit hinreichender Sicherheit vornehmen.

Der Vergleich mit anderen evidenzbasierten Bewertungsverfahren des G-BA – etwa im Rahmen der Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V oder bei Richtlinienentscheidungen zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren – verdeutlicht, dass auch die Bewertung der Austauschbarkeit biotechnologischer Arzneimittel denselben methodischen Anforderungen genügen muss. Eine pauschale Feststellung der Austauschbarkeit ohne belastbare Evidenz zur Unbedenklichkeit mehrfacher Substitution würde den Bewertungsstandard unterlaufen, den sich der G-BA in seiner Verfahrensordnung selbst gesetzt hat.

Dort heißt es in § 5 Absatz 2 ausdrücklich, der G-BA „ermittelt den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin“. Dieser Maßstab gilt ausnahmslos – auch für die Bewertung der Austauschbarkeit –, und er erfordert insbesondere bei mehrfach möglichen Produktwechseln eine fundierte Beurteilung der therapeutischen Vergleichbarkeit hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Therapietreue.

Lilly

Bei einem Biosimilar handelt es sich um ein Arzneimittel mit physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften, das einem anderen biologischen Arzneimittel (Referenzarzneimittel), welches bereits in der Europäischen Union vermarktet wird, sehr ähnlich, aber nicht identisch ist [62]. Trotz der hohen Ähnlichkeit zum Referenzarzneimittel können Abweichungen aufgrund der natürlichen Variabilität der biologischen Quelle und des biopharmazeutischen Herstellungsverfahrens auftreten. Zudem besteht bei biologischen Arzneimitteln eine gewisse Chargenvariabilität. Aufgrund ihrer differenzierten Zusammensetzung und molekularen Größe besteht die Möglichkeit einer unerwünschten Immunreaktion, welche sich auf die Wirksamkeit und Sicherheit des Biosimilars auswirken kann. Die in den Tragenden Gründen aufgeführte Position B2 beschreibt, dass einfache und mehrfache Therapiewechsel von Biosimilars untereinander bisher nicht untersucht wurden. Daher kann eine mögliche Ersetzung von Biologika durch Biosimilars erst dann hinreichend berücksichtigt werden, wenn ausreichend Evidenz zum Austausch der Biosimilars untereinander vorliegt. Vor dem Hintergrund der Arzneimittelsicherheit sieht Lilly eine automatische und regelhafte Substitution in Apotheken ohne medizinische Begründung daher als äußerst kritisch. Diese sollte erst erfolgen, wenn ausreichend Evidenz, welche die Unbedenklichkeit der Umstellung belegt, vorliegt.

Novo Nordisk

Novo Nordisk möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich § 129 Absatz 1a

Satz 5 SGB V auf die Austauschbarkeit biologischer Referenzarzneimittel bezieht. Der Gesetzgeber hat hier die mit § 40c implizierte Austauschbarkeit von Biosimilars untereinander nicht vorgesehen.

Pfizer

Soweit in dem vorgeschlagenen § 40c Abs. 3 (neu) vorgesehen ist, dass auch **Biosimilars untereinander** ausgetauscht werden können bzw. müssen, wenn diese jeweils mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen wurden (Position A + B1), ist dies **nicht mit Inhalt und Grenzen des gesetzlichen Regelungsauftrags vereinbar** und daher anzupassen. Dies gilt im Ergebnis auch für einen einmaligen Austausch eines Biosimilars aus nicht-medizinischen Gründen bei Vorhandensein entsprechender Evidenz (Position B2), selbst wenn diese Auffassung im Vergleich zur Position A + B1 zumindest in der Sache deutlich plausibler erscheint.

Nach § 129 Abs. 1a Satz 5 SGB V wurde dem Gemeinsamen Bundesausschuss der Auftrag erteilt, in seiner Arzneimittel-Richtlinie „Hinweise zur **Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln** durch Apotheken“ zu geben. Daran anknüpfend wird in § 129 Abs. 1 Satz 12 SGB V angeordnet, dass für solche Biosimilars, für die der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Arzneimittel-Richtlinie „eine **Austauschbarkeit in Bezug auf ein biologisches Referenzarzneimittel**“ festgestellt hat, die bisher geltenden Substitutionsregelungen für Generika entsprechend gelten sollen. In beiden Fällen geht es nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut des Gesetzes allein um den **Austausch eines biologischen Referenzarzneimittels**, also dem erstmals zugelassenen biologischen Originalarzneimittel (vgl. § 129 Abs. 1a Satz 3 SGB V i. V. m. Artikel 10 Abs. 4 der Richtlinie 2001/83/EG).

Nach dem Gesetz ist damit – nach vorheriger Feststellung der Austauschbarkeit durch den Gemeinsamen Bundesausschuss – **allein ein Austausch des biologischen Referenzarzneimittels durch Biosimilars erlaubt (oder in die umgekehrte Richtung)**. Ein Austausch zwischen Biosimilars untereinander ist nicht vorgesehen. Dies wird auch durch die zugrundeliegende Gesetzesbegründung bestätigt. So heißt es bereits in der Begründung des ursprünglichen Gesetzesentwurfs wörtlich wie folgt:

„Die Regelungen zur Ersetzung eines wirkstoffgleichen Arzneimittels („aut idem“) finden bislang keine Anwendung auf im Wesentlichen gleiche biologische Arzneimittel (Biosimilars). Biosimilars im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG sind dem Originalpräparat in ihrer Zusammensetzung zwar ähnlich, aber nicht gleich. Deshalb erfüllen sie nicht die Definition eines Generikums. Dennoch können diese in vielen Fällen **an Stelle des Originalpräparates** abgegeben oder angewendet werden.“ (BT-Drucksache 19/8753 vom 27. März 2019, Seite 63; Hervorhebung von uns)

Gleiches geht aus der Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages hervor (BT-Drucksache 19/10681 vom 5. Juni 2019). Während im ursprünglich vorgeschlagenen Gesetzestext noch pauschal von der Austauschbarkeit von „im Wesentlichen gleichen biologischen Arzneimitteln im Sinne des Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG“ gesprochen wurde, wurde durch den Gesundheitsausschuss aus Klarstellungsgründen im Wortlaut der Vorschriften **explizit eine Beschränkung auf biologische Referenzarzneimittel** beschlossen. Dies wurde so auch parlamentarisch verabschiedet. Zur Begründung heißt es in der genannten Bundestagsdrucksache:

„Zudem wird klargestellt, dass es um die Beurteilung der Austauschbarkeit von Biosimilars **zum jeweiligen Referenzarzneimittel** geht.“ (Seite 86; Hervorhebung von uns).

Sowohl nach dem Wortlaut des Gesetzes als auch der zugrundeliegenden Entstehungsgeschichte ist daher das in §§ 129 Abs. 1a Satz 5, Abs. 1 Satz 12 SGB V Austauschregime von vornherein **nur bei der Verordnung von biologischen Referenzarzneimitteln bzw. deren Biosimilars** einschlägig. Ausgetauscht werden kann immer nur ein verordnetes

Referenzarzneimittel durch ein Biosimilar oder ein verordnetes Biosimilar durch das zugrundeliegende Referenzarzneimittel. Ein Austausch von Biosimilars untereinander ist hiervon nicht gedeckt.

Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Vorgaben bedarf der vorgeschlagene § 40c (neu) in der Arzneimittel-Richtlinie einer zwingenden Anpassung:

Die gesetzliche Beschränkung des Austausches von biologischen Referenzarzneimitteln durch Biosimilars kommt zwar noch in der Überschrift des § 40c (neu) zutreffend zum Ausdruck, die in gleicher Weise auch im Inhaltsverzeichnis der Arzneimittel-Richtlinie aufgeführt werden soll („§ 40c Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken nach § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V“). Dieser Überschrift läuft allerdings die in § 40c (neu) Abs. 3 vorgesehene Regelung zuwider: Nach der Position A+ B1 ist ausdrücklich vorgesehen, dass **auch Biosimilars untereinander** ausgetauscht werden können, wenn diese jeweils mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen wurden. Dies ist nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut des Gesetzes sowie der zugrundeliegenden Gesetzesbegründung nicht zulässig. Die Erstreckung der automatischen Substitution auf Biosimilars untereinander würde nicht nur dem Wortlaut, sondern auch dem Ausnahmecharakter der eng auszulegenden gesetzlichen Regelung widersprechen (**Substitutionsverbot mit Erlaubnisvorbehalt**).

Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass es auch in der Sache gute Gründe dafür gibt, grundsätzlich allein einen Austausch des biologischen Referenzarzneimittels durch Biosimilars oder von Biosimilars durch das biologische Referenzarzneimittel für zulässig zu erachten. Dies kommt nicht zuletzt auch in der Position B2 zum Ausdruck, wonach ein Austausch von Biosimilars untereinander aus nicht-medizinischen Gründen nur einmalig und erst dann erfolgen soll, wenn Evidenz vorliegt, die die Unbedenklichkeit der Umstellung belegt. Aber auch hier gilt: Diese sehr nachvollziehbaren Eingrenzungen können nichts daran ändern, dass nach geltender Gesetzeslage ein Austausch von Biosimilars untereinander **per se nicht vorgesehen** ist. Für das weiterhin bestehende Verbot einer automatischen Substitution bei Biologika wird in diesem Fall keine abweichende Erlaubnis gesetzlich angeordnet.

All dies gilt umso mehr, als es bei Fertigarzneimitteln – anders als bei den in § 40b AM-RL enthaltenen Hinweisen zum Austausch von biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken bei parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung – eine **relevante Gefahr für einen möglichen Nocebo-Effekt** existiert. Dies gebietet es bereits aus Gründen der Versorgungssicherheit und Verhältnismäßigkeit, einen Austausch auf das gesetzlich vorgesehene Maß zu begrenzen und insoweit die entsprechenden Vorschriften patientenfreundlich auszulegen.

Pharma Deutschland

Pharma Deutschland spricht sich darüber hinaus dafür aus, dass die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander grundsätzlich nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung ist und dies durch die Ergänzung der AM-RL sowie die vorliegende Anlage VIIa nicht weiter konkretisiert wird. Zudem ist der Wortlaut des § 129 Absatz 1a SGB V diesbezüglich eindeutig, indem **Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln** (nicht: zur Austauschbarkeit in Bezug auf Referenzarzneimittel!) zu erstellen sind. Dies sollte klarstellend im Beschlusstext aufgenommen werden. Schlussfolgernd sollten alle Wirkstoffe mit Arzneimitteln, zu denen ausschließlich mehrere Original-/Referenzarzneimittel aber keine Biosimilar zugelassen sind, aus Anlage VIIa gestrichen werden. Es sollte zudem festgehalten werden, dass Verträge nach § 130a Absatz 8 SGB V nicht den Hinweisen zur Austauschbarkeit entgegenstehen dürfen, insbesondere, da die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander grundsätzlich nicht Gegenstand der Arzneimittel-Richtlinie ist.

Pro Generika

Im vorliegenden Entwurf der Arzneimittel-Richtlinie legt der G-BA die gesetzliche Vorgabe zur automatischen Substitution biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel durch Apotheken als eine wechselseitige Austauschbarkeit sämtlicher biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel mit Bezug auf dasselbe Referenzprodukt aus – einschließlich des Austauschs von Biosimilar zu Biosimilar sowie vom Biosimilar zurück zum Referenzpräparat. Diese Interpretation widerspricht dem klaren Wortlaut des § 129 Abs. 1a SGB V.

§ 129 Abs. 1 Satz 12 SGB V stellt ausdrücklich klar, dass die Übertragbarkeit der in Satz 1 normierten Substitutionsregelungen für wirkstoffgleiche Generika auf biotechnologisch hergestellte biologische Fertigarzneimittel voraussetzt, dass der GBA eine Austauschbarkeit im Verhältnis zu einem biologischen Referenzarzneimittel festgestellt hat.

Im Gesetzgebungsverfahren wurde die ursprünglich vorgesehene Formulierung von „im Wesentlichen gleichen biologischen Arzneimitteln im Sinne des Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG“ auf biologische Referenzarzneimittel beschränkt. Zur Begründung heißt es: „Zudem wird klargestellt, dass es um die Beurteilung der Austauschbarkeit von Biosimilars zum jeweiligen Referenzarzneimittel geht.“

*Hieraus ergibt sich mit hinreichender Deutlichkeit, dass die gesetzliche Substitutionsbefugnis **ausschließlich den Austausch vom Referenzarzneimittel zu einem Biosimilar** erfasst. Ein Austausch in umgekehrter Richtung (vom Biosimilar zum Referenzarzneimittel) oder zwischen verschiedenen Biosimilars ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen und daher nicht von der Ermächtigungsgrundlage gedeckt.*

*Vor diesem Hintergrund ist die vom G-BA nun vorgenommene Auslegung in der AM-RL als **rechtsfehlerhaft** zu bewerten. Sie widerspricht nicht nur dem Gesetzeswortlaut, sondern ignoriert auch die gesetzgeberische Entscheidung, die Austauschbarkeit bewusst auf eine bestimmte Konstellation zu beschränken, um seinerzeit in erster Linie die Marktdurchdringung von Biosimilars zu befördern. Wir fordern daher, den Richtlinienentwurf entsprechend anzupassen und die Substitution auf den vom Gesetzgeber vorgesehenen Anwendungsbereich zu beschränken – den Austausch vom Referenzarzneimittel zu einem therapeutisch vergleichbaren Biosimilar.*

vfa

Aus Sicht des vfa sollte folgende Aussage nicht nur in den Tragenden Gründen aufgeführt sein, sondern zwingend in den Beschluss überführt werden: „Die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander ist grundsätzlich nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung und wird durch die Ergänzung der AM-RL sowie die vorliegende Anlage VIIa nicht weiter konkretisiert.“ Hierdurch wird richtigerweise klargestellt, dass sich die Vorgaben nicht auf eine Austauschbarkeit von Original-/Referenzarzneimitteln untereinander beziehen.

VZA

Absatz 3 Satz 1 ist an den gesetzlichen Regelungsauftrag des G-BA anzupassen. Aus § 129 Abs. 1a Satz 5 SGB V geht hervor, dass sich der G-BA nur mit der Austauschbarkeit von „Referenzarzneimitteln“ durch Apotheken zu befassen hat. Ein Austausch zwischen Biosimilars untereinander oder zurück vom verordneten Biosimilar zum Referenzarzneimittel gehört nicht zum Regelungsauftrag des G-BA.

§ 40c Absatz 3 Satz 1 ist entsprechend anzupassen und könnte rechtskonform lauten: „Ein Austausch erfolgt nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 zwischen dem verordneten Referenzarzneimittel und einem im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel, wenn dieses ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilar) zu dem verordneten Referenzarzneimittel ist.“

Der zweite Spiegelstrich in den Positionen A + B1 sowie die darüber hinausgehenden Ausführungen der Position B2 sind zu verwerfen. Auch die nur einmalige Umstellung von einem ärztlich verordneten preisgünstigen Biosimilar auf ein anderes Biosimilar hat der Gesetzgeber nicht in die Kompetenz des G-BA gestellt. Grund dafür ist, wie zur Begründung der Position B2 ausgeführt wird, dass es für einen entsprechenden Wechsel keine wissenschaftliche Evidenz gibt.

DGVS, gemeinsam mit Kompetenznetz Darmerkrankungen e. V. und bng

Zu den [...] verschiedenen Positionen ist zu sagen, dass [...] ein Austausch von Biologika in der Apotheke grundsätzlich abzulehnen ist, da der Austausch nur durch einen Arzt ausgeführt werden sollte. Konkret auf den Beschlussentwurf beziehend ist Position A+B1 abzulehnen. Es fehlt weiterhin an einer breiteren Evidenz, welcher die Sicherheit beim mehrfachen Wechsel zwischen Biosimilars belegt – besonders beim Austausch in der Apotheke. Zur Feststellung der Unbedenklichkeit der automatischen Substitution in der Apotheke, bedarf es daher entsprechender Umstellungsstudien für die jeweiligen Biologika.

Mehrfache Umstellungen zwischen Biologika bergen weiterhin das Risiko, die Arzneimitteltherapiesicherheit, die Therapieadhärenz und das allgemeine Patientenwohl zu gefährden.

Bewertung zu den Einwänden 3.3.2 bis 3.3.3:

Es wird vorgebracht, dass nach dem Wortlaut des § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V und § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V – nach vorheriger Feststellung der Austauschbarkeit durch den G-BA – allein der Austausch eines biologischen Referenzarzneimittels (an Stelle des Originalpräparates) erlaubt sei. Die Ausweitung der automatischen Substitution auf Biosimilars untereinander würde nicht nur dem Wortlaut, sondern auch dem Ausnahmecharakter der eng auszulegenden gesetzlichen Regelung widersprechen (Substitutionsverbot mit Erlaubnisvorbehalt).

Da sich der gesetzliche Auftrag originär auf die Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln und grundsätzlich nicht auf den Austausch von Biosimilars untereinander beziehe, wird von Stellungnehmenden auch der einmalige Austausch aus nicht-medizinischen Gründen selbst bei Vorhandensein entsprechender Evidenz (Position B2) abgelehnt. Es sei zudem Aufgabe des G-BA, die geforderte Evidenz aufzuarbeiten und daraus verbindliche Schlüsse in seiner AM-RL zu ziehen. Gleichzeitig wird angezweifelt, ob es solche Evidenz mit ausreichender Robustheit überhaupt geben könne. Zum Gesetzauftrag siehe auch Bewertung zu Einwand 3.6.1.

Die Stellungnehmenden lehnen den Austausch von Biosimilars untereinander ab, da es weiterhin grundsätzlich an Evidenz fehle, die die Sicherheit beim mehrfachen Wechsel zwischen Biosimilars – insbesondere beim Austausch in der Apotheke – belege. In den jeweiligen Zulassungsstudien werde zwar Sicherheit, Wirksamkeit und Immunogenität gegenüber dem Referenzarzneimittel im einfachen oder auch mehrfachen Switch untersucht, allerdings nicht der Austausch zwischen mehreren Biosimilars derselben INN. Eine Vergleichbarkeit verschiedener Biosimilars untereinander sei damit nicht Gegenstand der arzneimittelrechtlichen Zulassung. Die Zulässigkeit einer Extrapolation im Sinne einer generellen Austauschbarkeit werde kontrovers diskutiert.

Ein Stellungnehmer führt an, dass die Daten aus Umstellungsstudien zwar nahelägen, Biosimilars könnten ohne nachweisbare Nachteile bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit ausgetauscht werden, man aber berücksichtigen müsse, dass diese Studien an freiwilligen Teilnehmern durchgeführt würden, die jederzeit die Studie beenden und ihre gewohnte Therapie fortsetzen könnten. Daher sei die Übertragung dieser Evidenzbasis auf eine automatische Substitution nicht sachgerecht und zweckmäßig. Dazu siehe auch Bewertung zu Einwand 3.6.3.

Es wird weiterhin ausgeführt, dass bei zwei biologischen Arzneimitteln mit demselben

Referenzarzneimittel nicht zwangsläufig auch Bioäquivalenz angenommen werden könne. Befänden sich beide Biosimilars bezüglich der Mikroheterogenität jeweils am äußeren Rand des Intervalls des einzuhaltenden spezifischen Grenzwerts im Vergleich zum Referenzarzneimittel, seien diese mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr bioäquivalent.

Umstellungen aus wirtschaftlichen, nicht-medizinischen Gründen sowie generell mehrfache Wechsel stellten aus Sicht der Stellungnehmer eine Verunsicherung für Patientinnen und Patienten dar, die sich negativ auf Arzneimitteltherapiesicherheit und Therapieadhärenz auswirken und so den Therapieerfolg maßgeblich behindern könnten. Die mehrfache Substitution von Arzneimitteln führe darüber hinaus dazu, dass die Therapiehistorie nicht mehr nachvollzogen werden könne mit Folgen für die Pharmakovigilanz. Dazu siehe auch Bewertung der Einwände zum Absatz 4 und zum Einwand 3.6.8.

Die Substitution in der Apotheke greife zudem in die Therapiehoheit des Arztes ein und setze diesen dadurch Haftungsrisiken aus. Dazu siehe auch Bewertung zu Einwand 3.6.7.

Ein Wechsel auf Apothekenebene sei insbesondere ohne Kenntnis des individuellen Krankheitsverlaufs und der Besonderheiten der Patientinnen und Patienten nicht möglich. Zudem wird darauf hingewiesen, dass anhand der Verordnung nicht bekannt sei, ob es sich um den erstmaligen Austausch eines Biologikums, wie in Position B2 gefordert, handele.

Den Stellungnehmern kann nicht darin zugestimmt werden, dass die Umsetzung des Regelungsauftrags nicht von der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage gedeckt wäre. Der Gesetzauftrag zielt darauf, „den Austausch biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel sowie wirkstoffgleicher biologischer Arzneimittel“ auf Grundlage ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit zu regeln (BT-Drucks. 19/8753, S. 63).

Nach Auffassung des G-BA lässt sich aus dem Wortlaut des Gesetzauftrags nichts anderes ableiten. Insbesondere lässt sich aufgrund der Inbezugnahme des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG keine Einschränkung der Regelungsbefugnis des G-BA hinsichtlich der Feststellung der Austauschbarkeit von einem Referenzarzneimittel im Verhältnis zu seinen Biosimilars generell ableiten. Vielmehr dient die Referenzierung auf Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG der Konturierung des Begriffes „im Wesentlichen gleicher biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel“ in Abgrenzung zum Begriff des „Generikums“ hin zur Begrifflichkeit des Biosimilars, die allgemein den Regelungen des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unterfallen (BT-Drucks. 19/8753, S. 61 und 63). Aufgabe des G-BA ist es demnach zu beurteilen, ob auf Grundlage einer entsprechenden Zulassung nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG an Stelle des Originals (in der Regel Referenzarzneimittel) auch dessen Biosimilar angewendet werden kann.

Insoweit hat der G-BA im Rahmen des gesetzlichen Regelungsauftrags von seinem Gestaltungsspielraum sachangemessen Gebrauch gemacht, indem er eine Austauschbarkeit von Biosimilars für möglich erachtet, soweit die jeweiligen Biosimilars beziehungsweise auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind.

Eine engere Auslegung des gesetzlichen Auftrags ist aus mehreren Gesichtspunkten nicht geboten: Zum einen würde eine enge Auslegung zu dem widersinnigen Ergebnis führen, dass in dem Fall, in dem ein im Verhältnis zu seinen Biosimilars günstigeres Referenzarzneimittel existiert und aufgrund der therapeutischen Vergleichbarkeit ein Austausch von Referenzarzneimittel zu Biosimilar möglich sein soll, die Rückumstellung – bei enger Wortlautauslegung – jedoch nicht mehr möglich wäre.

Zum anderen ist die Apotheke bei Verfügbarkeit mehrerer in Frage kommender preisgünstiger Arzneimittel grundsätzlich frei in der Auswahl. Sind also mehrere Biosimilars (Biosimilar A und B) zu einem Referenzarzneimittel auf dem Markt, könnte ausgehend von einer Verordnung über das Originalarzneimittel bei entsprechender Preisgünstigkeit einmal Biosimilar A und ein anderes Mal bei gleichlautender Verordnung das Biosimilar B abgegeben werden. Bei immer gleicher Voraussetzung könnte also selbst bei einer eingeschränkten Regelung (Austausch nur

zwischen Referenzarzneimittel und Biosimilar) im Ergebnis ein Austausch von einem Biosimilar zum anderen erfolgen.

Unbenommen davon erfüllt der G-BA auch im Kern den gesetzlichen Regelungsauftrag dahingehend, die vom Gesetzgeber beabsichtigte und noch einmal klargestellte „Austauschbarkeit von Biosimilars zum jeweiligen Referenzarzneimittel“ festzustellen (BT-Drucks. 19/10681, S. 86), denn zur Voraussetzung eines Austausches von Biosimilars untereinander wird wiederum – maßgebliche Voraussetzung für einen Austausch nach § 129 Abs. 1 Satz 12 SGB V ist die „Austauschbarkeit in Bezug auf ein biologisches Referenzarzneimittel“ – die Referenzierung auf dasselbe (Original-)Arzneimittel gemacht. Dies begründet sich darin, dass wenn und soweit Biosimilars in Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind, schon die entsprechende Prüfung der Zulassungsbehörden eine ausreichende Grundlage dafür darstellt, eine hinreichende Ähnlichkeit sowohl zum Referenzarzneimittel als auch der Biosimilars untereinander festzustellen. Dieses Verständnis des G-BA wird nicht zuletzt durch das Statement der EMA zur Interchangeability [59] gestützt.

Auch ist es dem Arzt in den Fällen, in denen Biosimilars in Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind, unterschiedslos möglich auf die jeweiligen Biosimilars unter Beachtung einer wirtschaftlichen Ordnungsweise umzustellen; unter diesen Umständen erschließt sich eine grundsätzliche Unterscheidung auf der weiteren Ebene hinsichtlich der Ersetzung von Biosimilars untereinander nicht.

Die Prüfung der Sachgerechtigkeit einer Ersetzung im Einzelfall bleibt hiervon unberührt. Die Möglichkeit die Ersetzung bei Verordnung auszuschließen ergibt sich dabei aus § 40c Absatz 1; die Möglichkeit der Apotheke von einer Ersetzung abzusehen ergibt sich aus § 40c Absatz 5.

Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits im Stellungnahmeverfahren zum Beschluss vom 15. Juni 2023 zur Ergänzung des § 40b (neu) in der AM-RL befasst. Es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in der Zusammenfassenden Dokumentation zum entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/>).

Zur Berücksichtigung von weiteren Produkteigenschaften oder bestimmten Therapiebereichen siehe auch Bewertung zu den Einwänden 3.1.6 und 3.6.9.

Zur Anlage VIIa siehe Bewertung zu Einwand 3.3.4.

Es wird in Stellungnahmen angeregt im Beschlusstext klarzustellen, dass die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander nicht Gegenstand der Regelung ist. Dieser Vorschlag wird abgelehnt, da er an dieser Stelle keine Regelungslücke füllt und ohne zusätzlichen Regelungsgehalt ist. Entsprechende Vorgaben ergeben sich weder aus § 40c AM-RL noch aus Anlage VIIa, was im Kontext des Richtlinien texts auch nachvollziehbar ist; eine Klarstellung findet sich darüber hinaus in den Tragenden Gründen.

In Bezug auf den Einwand unter Bezugnahme auf den Wirkstoff Liraglutid, dass keine rechtliche Grundlage für einen Austausch eines biotechnologisch hergestellten Arzneimittels gegen ein bezugnehmend zugelassenes, vollsynthetisch hergestelltes Arzneimittel bestünde, ist zu entgegnen, dass der G-BA gemäß § 129 Absatz 1a SGB V Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG durch Apotheken zu geben hat. Die Ersetzung eines biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittels gegen ein chemisch-synthetisch hergestelltes Arzneimittel ist daher grundsätzlich nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung, sondern unterfällt den allgemeinen Bestimmungen des § 129 SGB V. Die in Anlage VIIa aufgeführten Zusammenhänge dienen im Kontext weiterer Informationsquellen wie der Apothekensoftware bzw. den Preis- und Verzeichnisdiensten als Grundlage zur Abgabeentscheidung und können aufgrund weitergehender Informationsmöglichkeiten des

G-BA bei den zuständigen Bundesoberbehörden für Apotheken Sicherheit bei der Ersetzung begründen.

3.3.4 Einwände zu Anlage VIIa

Bayer

Vor dem Hintergrund, dass sich die Vorgaben in den §§ 40a, 40b sowie dem neuen § 40c AM-RL korrekterweise ausschließlich auf die Austauschbarkeit von Referenzarzneimitteln und den entsprechenden Biosimilars (bzw. auch Biosimilars untereinander) beziehen, sind wir weiterhin der Auffassung, dass keine Rechtsgrundlage besteht, welche die Auflistung von Wirkstoffen rechtfertigt, zu denen mehr als ein Originalarzneimittel, aber kein Biosimilar zugelassen ist (siehe auch Stellungnahme Bayer Vital GmbH zur Änderung der AM-RL: Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) – Erstfassung, vom 8. Juni 2021).

Folglich müssen Wirkstoffe, zu denen ausschließlich mehrere Originalarzneimittel zugelassen sind, zwingend aus der Anlage VIIa gestrichen werden. Dies betrifft insbesondere die von uns vertriebenen in Anlage VIIa aufgeführten Arzneimittel Betaferon® (Interferon beta-1b) und Kovaltry® (Octocog alfa). Biosimilars zu diesen Originalen sind für den deutschen Markt nicht zugelassen und entsprechend auch nicht verfügbar.

Biogen

Hier sei darauf hingewiesen, dass Anlage VIIa der AM-RL in ihrer jetzigen Form nicht als Entscheidungsgrundlage für eine automatische Substitution in Apotheken herangezogen werden kann. Die Anlage weist selbst darauf hin, dass sie keine Aussage über die Übereinstimmung der Anwendungsgebiete gibt.

Hexal

Dem gesetzlichen Regelungsauftrag könnte der G-BA nur durch Berücksichtigung produktspezifischer Eigenarten gerecht werden [...]. Dementsprechend wären, bevor eine automatische Substitution in der Apotheke erfolgen kann, in Anlage VIIa bzw. auch in Anlage VII weitere Gesichtspunkte als nur die bezugnehmenden Zulassungen und die zugelassenen Applikationsarten zu berücksichtigen, und zwar durch Aufnahme einer wirkstoff- und produktspezifischen Positivliste.

Die Problematik der intendierten Generalregelung in Form einer pauschalisierenden Austauschbarkeit von biologischen Arzneimitteln sowie die Unzulänglichkeit der Anlage VIIa zur Bewertung der therapeutischen Vergleichbarkeit zeigt sich am Fallbeispiel Epoetin. [...]

Lilly

Gemäß der vom G-BA ausgewiesenen Auflistung der zu substituierenden Original- bzw. Referenzarzneimittel und der im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln in der Anlage VIIa zum Abschnitt M der Arzneimittel-Richtlinie, gibt es für einzelne aufgelistete Originalarzneimittel, wie beispielsweise unserem Produkt Humatrope® mit dem Wirkstoff Somatotropin, aktuell kein zugelassenes Biosimilar im deutschen Markt. Zudem wird gemäß der Fachinformation von Humatrope® darauf hingewiesen, dass eine Diagnose und Therapie mit Humatrope® von Ärzten begonnen und überwacht werden sollte, die über eine angemessene Qualifikation und Erfahrung in der Diagnose und Behandlung von Patienten mit Wachstumshormon-Mangel verfügen [165]. Lilly schlägt angesichts der Gefahr, dass Apotheker nicht eindeutig unterscheiden können, zu welchen Originalarzneimitteln Biosimilars nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilars) im deutschen Markt zugelassen sind und bei welchen Arzneimitteln dies nicht der Fall ist, vor, diese betreffenden Arzneimittel von der genannten Liste der zu substituierenden Originalarzneimittel zu streichen, um ausreichend Transparenz für Apotheken für den Fall einer

potenziellen Substitution zu schaffen.

Medac

Die Nutzung der Anlage VIIa als Grundlage für eine Substitution in der Apotheke ist unzureichend. Dieser Übersicht kann nicht entnommen werden, ob und inwieweit die aufgeführten Arzneimittel in ihren zugelassenen Anwendungsgebieten übereinstimmen. Ferner fehlen alle grundlegenden Informationen zur zugelassenen Darreichungsform, ggf. der Vergleichbarkeit der Darreichungsformen, unterschiedlichen Dosierungen und Wirkstoffkonzentrationen, sowie einer Unterscheidung in Fertigarznei- und Zubereitungsarzneimittel. Dabei ist insbesondere zu betonen, dass gleiche Applikationswege keineswegs gleiche oder als austauschbar festgesetzte Darreichungsformen sind. Zur grundsätzlichen Kritik von medac an der Anlage VIIa sei auf unsere Stellungnahme im entsprechenden Stellungnahmeverfahren 2021 verwiesen.

Es ist für die Sicherheit der Versicherten wichtig, dass Ärzte- & Apothekerschaft die individuelle Situation von Patientinnen und Patienten zum Beispiel bezüglich bekannter Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Handhabungsproblematiken bei der Abgabe von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln sachgerecht berücksichtigen können.

Medice

Der Verweis auf Anlage VIIa sollte an dieser Stelle entfallen. Anlage VIIa ist eine Ergänzung des § 40a, richtet sich also an den Arzt / die Ärztin und ist auch unter dieser Maßgabe beschlossen worden sowie in Kraft getreten. Sie bietet den Apotheken keine Hilfestellung bei der Beantwortung der Frage, welche Biologika nun tatsächlich austauschbar sind, da sie in puncto Austausch Kriterien (Anwendungsgebiete etc.) nicht abschließend ist. Austauschbare Arzneimittel werden dem Apotheker / der Apothekerin automatisch über seine Software angezeigt, sofern eine Substitution zulässig und alle Substitutionskriterien erfüllt sind. Insofern ist es unnötig und irreführend, die Anlage VIIa als Liste für die Apotheken zu etablieren. Sinnvoll wäre die Anpassung der Anlage 1 zum Rahmenvertrag.

Merck

[...] Zudem ist es notwendig, die Kennzeichnung in Anlage VIIa anzupassen, um klarzustellen, dass ein Austausch zwischen Multidosis- und Monodosis-Pens nicht vereinbar ist, um bei Abgabe der gleichen Wirkstärke und Packungsgröße die verschriebene Dosis applizieren zu können.

Novartis

In § 40c Abs. 3 Satz 2 AM-RL wird auf Anlage VIIa hingewiesen, in der die substituierbaren Arzneimittel aufgeführt werden. Tatsächlich werden dort jedoch lediglich die Zulassungszusammenhänge dokumentiert. Eine wirkstoffspezifische Bewertung, ob bei diesem konkreten biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel eine Substitution medizinisch vertretbar ist, erfolgt nicht. Dies ist unzulässig. Die Gesetzesbegründung zu § 129 Abs. 1, 1a SGB V setzt für die Austauschbarkeit voraus, dass der G-BA „zuvor in seinen Richtlinien die Austauschbarkeit für das betreffende Arzneimittel bewertet“ (BT-Drucks. 19/8753, S. 72); eine Bewertung setzt aber voraus, dass wirkstoffspezifisch geprüft wird, ob eine Austauschbarkeit auch bei diesem Biologikum vertretbar ist. Die bloße Listung von Produkten und ihren Zulassungszusammenhängen in Anlage VIIa AM-RL erfüllt diese Voraussetzung nicht und verlagert Sicherheitsrisiken einseitig auf den Patienten. Um den vielfältigen bereits genannten Problematiken Sorge zu tragen, stellt die Bildung einer Substitutionsausschlussliste aus Sicht von Novartis eine gangbare Lösung dar.

Sollte die Bildung einer Substitutionsausschlussliste nicht erfolgen, so müssen zumindest folgende Anpassungen an der Anlage VIIa durchgeführt werden, um produktspezifische Charakteristika darzulegen:

- Die Beobachtungen zum Einfluss unterschiedlicher Applikationstechniken erfordert eine

genaue und übersichtliche Beschreibung der Referenzarzneimittel und ihrer im Wesentlichen gleichen Biologika mit Angabe ihrer Dosisstärke und der jeweiligen Darreichungsform mit Hinweis und Differenzierung auf die Nicht-Austauschbarkeit produktspezifischer Applikationssysteme.

- Die jeweils zugelassenen Anwendungsgebiete und somit die genaue Therapiebreite aller Biologika müssen transparent aufgeführt und die übereinstimmenden Anwendungsgebiete gekennzeichnet werden. Die Biosimilar-Indikationen sollen klar unterscheidbar sein in jene, für die klinische Studien vorliegen, und solche ohne klinische Evidenz.
- Weiterhin sollten Biosimilars ohne Studienevidenz zu unbedenklichen Umstellungen – auch hinsichtlich Darreichungsformen – nicht in der Anlage VIIa aufgeführt und von der automatischen Substitution ausgeschlossen werden. Dies umfasst Therapiewechsel zwischen Originator und Biosimilar, sowie zwischen Biosimilar und Biosimilar.
- Des Weiteren sollten spezifische Voraussetzungen der Fachinformation, die bei einer Neueinstellung zu beachten sind, abgebildet werden.

Novo Nordisk

Anlage VIIa führt lediglich theoretisch austauschbare Produkte eines biopharmazeutischen Wirkstoffes ohne weiterführende Informationen bezüglich der Anwendungsgebiete, der Darreichungsform, der Applikationsart, den relevanten weiteren Inhaltsstoffen, Dosierungen und Wirkstoffkonzentrationen auf. Anlage VIIa lässt somit keine Einschätzung des Effektes eines Austausches auf die therapeutische Vergleichbarkeit zu. Die zulassungskonforme Grundlage für die gruppierte Darstellung der biopharmazeutischen Wirkstoffe ist aus unserer Sicht nicht gegeben. Die Zulassung eines Biosimilars erfolgt [...] in Bezugnahme auf das jeweilige Referenzarzneimittel. Die Vergleichbarkeit der Biosimilars untereinander wird weder durch die Hersteller noch durch die Zulassungsbehörden geprüft. Die Einstufung hiervon sollte nicht bei der Apotheke liegen, sondern bestenfalls evidenzbasiert wissenschaftlich belegt werden.

Pfizer

In dem vorgeschlagenen § 40c (neu) Abs. 3 ist in Satz 2 eine Verweisung auf die Anlage VIIa vorgesehen, die wir aus mehreren Gründen für problematisch erachten. [...]

Wie sich aus den Tragenden Gründen des Beschlusses entnehmen lässt, sollen auf diese Weise die in der Anlage VIIa gelisteten biologischen Referenzarzneimittel durch die dort genannten Biosimilars auch auf Apothekenebene austauschbar werden. Nach dem Verständnis des Gemeinsamen Bundesausschusses wird auch im Kontext der Substitution der lediglich informative Charakter der Anlage VIIa beibehalten, was bedeuten soll, dass diese Anlage **keinen abschließenden Charakter** hat. Die Idee ist offenbar, dass bei Markteinführung von neuen Biosimilars die Apotheken unabhängig von einer Einbeziehung in die Anlage VIIa nach § 40c (neu) zur Ersetzung eines Präparates verpflichtet sein können. [...]

Die beschriebene Funktionsweise der Anlage VIIa im Kontext der Substitution von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken ist **nicht gesetzeskonform** und bedarf dringend einer Anpassung:

[...] Der seit dem 16. August 2022 geltende Mechanismus in § 129 Abs. 1 Satz 12, Abs. 1a Satz 5 SGB V [führt] zu einer Umkehrung des bisher bei Generika geltenden Regel-Ausnahme-Verhältnisses. Während bei generischen Arzneimitteln bei Einhaltung der insoweit vorgesehenen Voraussetzungen eine Substitutionserlaubnis mit Verbotsvorbehalt besteht, gilt bei biologischen Referenzarzneimitteln das Gegenteil. § 129 Abs. 1 Satz 12 SGB V sieht sinngemäß vor, dass die Regelungen zur automatischen Substitution von wirkstoffgleichen Arzneimitteln gemäß § 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, § 129 Satz 2-8 SGB V „entsprechend“ gelten für biologische Arzneimittel,

„für die der Gemeinsame Bundesausschuss [...] eine Austauschbarkeit in Bezug auf ein

biologisches Referenzarzneimittel festgestellt hat.“

*Insoweit hat sich der Gesetzgeber für ein sozialrechtliches **Substitutionsverbot mit Erlaubnisvorbehalt** entschieden, bei dem erst nach vorheriger Feststellung der Austauschbarkeit eines biologischen Referenzarzneimittels gegen ein Biosimilar durch den Gemeinsamen Bundesausschuss eine Substitution in Betracht kommt.*

*Aus diesem Grund ist gesetzlich ausgeschlossen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss eine Art „**Blankettermächtigung**“ in § 40c (neu) verankert, indem eine in Bezug genommene nicht abschließende Präparate- und Wirkstoffliste – hier: die Anlage VIIa in ggf. veränderter Form – die Apothekensubstitution stützen soll. Die vorherige Feststellung der Austauschbarkeit ist nach dem Gesetz **mit Blick auf das konkrete biologische Referenzarzneimittel und bestimmte Biosimilars** zu treffen. Eine generelle Ermächtigung der Apotheken, hiervon unabhängig biologische Referenzarzneimittel durch Biosimilars (wenn auch unter bestimmten Bedingungen) auszutauschen, würde das beschriebene Substitutionsverbot mit Erlaubnisvorbehalt geradezu „auf den Kopf“ stellen.*

*Insofern bedarf es einer klaren und ausdrücklichen Regelung in § 40c (neu), wonach nur solche biologischen Referenzarzneimittel durch bestimmte Biosimilars ausgetauscht werden können, die nach entsprechender vorheriger Bewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss auf einer **gesonderten Anlage** der Arzneimittel-Richtlinie **abschließend** aufgeführt werden.*

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die jetzige Anlage VIIa nicht dazu geeignet ist, als eine solche Positivliste bei der Apothekensubstitution zu fungieren. Dies schon deswegen, weil nach dem bisherigen Stand die Anlage VIIa nicht der oben dargestellten Prüfungstrias entspricht, also u. a. nicht die zugelassenen Anwendungsgebiete der biologischen Referenzarzneimittel und ihrer Biosimilars zueinander bewertet hat. Dies wäre jedoch nach dem oben Gesagten zwingend zur Feststellung der Austauschbarkeit eines biologischen Referenzarzneimittels gegen ein Biosimilar Voraussetzung – im Übrigen selbst nach der im Beschluss als Position A bezeichneten weiten Auffassung („für ein gleiches Anwendungsgebiet“).

*All dies gilt umso mehr, als bei dem Austausch von Fertigarzneimitteln ein **möglicher Nocebo-Effekt** die Therapieziele erheblich gefährden kann. Aus diesem Grund bedarf es dringend einer **einzelfallbezogenen positiven Bewertung und Feststellung** seitens des Gemeinsamen Bundesausschusses hinsichtlich des jeweils als austauschfähig angesehenen Wirkstoffs.*

*[...] Vor dem Hintergrund [...] ist es aus unserer Sicht zwingend erforderlich, dass der Gemeinsame Bundesausschuss unter Anpassung des § 40c (neu) eine **gesonderte Anlage** in seiner Arzneimittel-Richtlinie schafft, die unter Beachtung der oben genannten **Prüfungstrias** präparate- und wirkstoffsspezifisch feststellt, ob und welche biologischen Referenzarzneimittel durch welche Biosimilars auf Apothekenebene ohne Gefährdung der Arzneimitteltherapie-sicherheit ausgetauscht werden können.*

[...] Zudem sollte die bisherige Aufnahme von Referenzarzneimitteln in die Anlage VIIa ersatzlos gestrichen werden, zu denen bisher keine Biosimilars verfügbar sind, wie dies z. B. bei unserem BeneFIX® der Fall ist. Das erscheint uns nicht nur rechtlich zweifelhaft, sondern kann auch zu Missverständnissen bei den angesprochenen Vertragsärzten und Apothekern führen.

Roche

Die Substitutionsliste muss Anwendungsgebiet sowie jeweilige Applikations- und Darreichungsform enthalten.

ABDA, AMK

Bislang ist die Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) einzig anhand der EU-weit geltenden regulatorischen Zusammenhänge konzipiert und daher für die notwendigen pharmakotherapeutischen und medizinischen Fragestellungen weitestgehend ungeeignet; zumal die Auflistung keinen abschließenden Charakter besitzt.

Der Hinweis, dass mit Eintreten von Biosimilars auf den Markt für die Apotheken auch unabhängig von der Listung in Anlage VIIa die Pflicht zur Ersetzung unter Berücksichtigung der Vorgaben unter Absatz 1 bis 3 besteht, verdeutlicht die unzureichende Informationslage für Apotheken, um Rechtssicherheit in der Substitutionspraxis zu erlangen.

BPI

Die Anlage VIIa eignet sich aus unserer Sicht nicht als belastbare Grundlage für einen automatischen Austausch biotechnologisch hergestellter Arzneimittel in der Apotheke. Sie enthält keine Angaben zur konkreten Indikationsgleichheit, obwohl gerade diese für den Austausch entscheidend ist – wie bereits in § 40b AM-RL ausdrücklich gefordert.

Darüber hinaus führt die Liste auch Originalarzneimittel ohne Biosimilar-Konkurrenz, was nicht nur nicht notwendig, sondern irreführend ist. Die Darstellung sogenannter „potenzieller Referenzarzneimittel“ suggeriert eine Austauschbarkeit, die nicht besteht. Ebenso problematisch ist die Aufnahme von Arzneimitteln, die in Deutschland nicht erhältlich sind und nur als kostenintensive Einzelimporte beschafft werden können – ein Widerspruch zur Intention wirtschaftlicher Verordnungen.

Die Anlage erfüllt somit nicht die Anforderungen aus § 129 Abs. 1a S. 5 SGB V und ist auch nicht vereinbar mit § 40c Abs. 3 Satz 3 AM-RL, wonach nur Arzneimittel mit vorhandener Biosimilar-Konkurrenz gelistet sein sollen. Bereits im ursprünglichen Stellungnahmeverfahren wurde auf diese systematischen Mängel hingewiesen.

Ein Rückgriff auf die Anlage VIIa zur Durchführung eines Apothekenaustauschs ist daher fachlich unzumutbar und rechtlich problematisch.

Pharma Deutschland

Die mit der Änderung der Arzneimittel-Richtlinie vorgesehenen Angaben in der Anlage VIIa sind nicht geeignet, entsprechende Ableitungen hinsichtlich der Übereinstimmung von Applikationsarten austauschbarer Arzneimittel zu treffen. Der Applikationsweg (subkutan, intravenös etc.) bildet nicht die Applikations- und selbstverständlich nicht die Darreichungsart ab. Hierzu benötigt es für eine automatische Substitution eindeutig mehr Angaben für den Apotheker.

[...] Aus Sicht von Pharma Deutschland benötigt es weitere Informationen in den Anlagen der AM-RL, die über den Zulassungsstatus hinausgehen, z. B. Nennung der Indikationen, der Applikationsform, -art, Devices etc. Nur so können Hinweise für eine Austauschbarkeit, insbesondere vor dem Hintergrund der Patientensicherheit und Compliance, sinnvoll den Apothekern bereitgestellt werden.

[...] Die Hinweise zur Austauschbarkeit haben bindenden Charakter für die abgebende Apotheke i. V. m. mit den entsprechenden Regelungen des § 129 Absatz 2 SGB V. Wie bereits erwähnt, reicht die aktuelle Datenstruktur (Veröffentlichung der Anlage als PDF) als auch die Inhalte der Anlage VIIa nicht aus, um einen Austausch auf Apothekenebene abzubilden. Die Aktualisierung der Anlage VIIa muss damit zwingend mit den Veröffentlichungszyklen der Preis- und Produktinformationen nach § 131 Absatz 4 SGB V, z.Zt. 14-tägig, erfolgen. Gemäß Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V sind allein die Preis- und Produktinformationen nach § 131 Absatz 4 SGB V entscheidend für die Abgabe bzw. den Austausch in der Apotheke. Dies betrifft zudem die korrekte Berücksichtigung von Verträgen nach § 130a Absatz 8 SGB V.

Pro Generika

Der Verweis auf Anlage VIIa der Arzneimittel-Richtlinie im vorliegenden Entwurf ist in der aktuell vorgesehenen Form nicht geeignet, die zur sicheren Durchführung einer Substitution erforderliche Transparenz herzustellen. Zwar ist vorgesehen, künftig Hinweise zur Zulassung im Hinblick auf die Applikationsarten aufzunehmen. Dies ist ein erster sinnvoller Schritt, greift jedoch zu kurz, da weiterhin keine Angaben zur Übereinstimmung der zugelassenen Anwendungsgebiete gemacht werden.

Die Anlage VIIa verweist ausdrücklich darauf, dass ihr nicht entnommen werden kann, ob die dort aufgeführten Arzneimittel hinsichtlich ihrer zugelassenen Anwendungsgebiete übereinstimmen. Diese Information ist jedoch grundlegend für die rechtssichere Beurteilung der Austauschbarkeit. Ein Verweis auf die Anlage VIIa in ihrer derzeitigen Struktur kann daher irreführend wirken und suggeriert eine Substitutionsmöglichkeit, die im konkreten Fall nicht gegeben sein muss. Hieraus können versorgungsbezogene wie haftungsrechtliche Risiken entstehen – insbesondere bei einer Abgabe außerhalb des Zulassungsrahmens.

Soll die Anlage VIIa künftig als tragfähige Entscheidungsgrundlage für Apotheken dienen, ist es aus unserer Sicht zwingend erforderlich, sie um verlässliche Informationen zur Zulassung hinsichtlich beider Dimensionen – Applikationsarten und Anwendungsgebiete – zu ergänzen.

vfa

[...] Es ermangelt damit weiterhin, wie bereits seit der Erstfassung von Anlage VIIa, an einer Rechtsgrundlage, welche die Auflistung von Wirkstoffen rechtfertigt, zu denen mehr als ein Originalarzneimittel, aber kein Biosimilar zugelassen ist. In der Konsequenz sollten daher alle Wirkstoffe und Arzneimittel, zu denen ausschließlich mehrere Original-/Referenzarzneimittel, aber keine Biosimilars zugelassen sind, aus der Anlage VIIa gestrichen werden bzw. dort zukünftig nicht aufgenommen werden.

Generell wird Anlage VIIa in der vorliegenden Fassung den Anforderungen des neuen § 40c AM-RL nicht gerecht und ist daher als Grundlage für eine Austauschbarkeit in der Apotheke nicht belastbar. Dies gilt zwar bereits für die Anforderungen an die §§ 40a und 40b AM-RL, wiegt bei der geplanten Ergänzung durch § 40c allerdings umso schwerer, da die Konsequenzen für die Versorgung erheblich weitreichender wären. Aufgrund der bloßen Listung von Produkten und ihren Zulassungszusammenhängen, ohne Angaben zur konkreten Übereinstimmung der zugelassenen Anwendungsgebiete, die für den Austausch entscheidend ist, ist die Anlage VIIa als Grundlage für die Substitution derzeit ungeeignet.

VZA

Absatz 3 führt in Satz 2 zum Inhalt der Anlage VIIa aus.

Nicht nachvollziehbar ist, warum der G-BA dazu in den Tragenden Gründen auf Seite 8 u.a. wie folgt ausführt:

„Es besteht somit eine Informationsgrundlage zu den regulatorischen Hintergründen. Die Zusammenstellung hat keinen abschließenden Charakter. Mit Eintreten von Biosimilars auf den Markt besteht für die Apotheken auch unabhängig von der Listung in Anlage VIIa die Möglichkeit einer Ersetzung unter Berücksichtigung der Vorgaben unter Absatz 1 bis 3. Die generellen Vorgaben zur Ersetzung wirkstoffgleicher / im Wesentlichen gleicher biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel nach § 40c Absatz 1 bis 3 bleiben von den Angaben in der Anlage VIIa unberührt.“

Es ist nicht die Aufgabe des G-BA, lediglich eine „Informationsgrundlage zu den regulatorischen Hintergründen“ zu schaffen. Den Apothekern ist bei Vorlage des Fertigarzneimittelrezepts die zur Substitution berechtigende Indikation nicht bekannt. Sie müssen sich daher auf die Anlage VIIa des G-BA verlassen können, aus der für eine rechtssichere Substitution hervorgehen muss, welches Referenzarzneimittel durch welches Biosimilar bei Übereinstimmung der Anwendungsgebiete und der Applikationsarten substituiert werden darf.

Die Apotheken können mangels Kenntnis der konkreten Indikation des Patienten demgemäß auch nicht „mit Eintreten von Biosimilars auf den Markt“ unabhängig von der Listung nach der Anlage VIIa zur „Ersetzung unter Berücksichtigung der Vorgaben unter 1 bis 3“ verpflichtet sein.

Der G-BA verkennt – wie schon im Zuge der Biosimilarsubstitution im Rahmen der parenteralen

Zubereitungen –, dass nicht jede einzelne Apotheke die wissenschaftlichen und pharmakologischen Fragen zum Austausch eines Referenzarzneimittels gegen ein Biosimilar selbst bewerten und entscheiden soll, sondern ihm diese Aufgabe bezogen auf den Austausch von Referenzarzneimitteln zu Biosimilar zukommt. Nur wenn der G-BA eine Austauschbarkeit eines Referenzarzneimittels positiv in einer Liste festgelegt hat, ist die Apotheke befugt, einen Austausch eines verordneten Referenzarzneimittels gegen ein – dann gelistetes – Biosimilar vorzunehmen. Gibt es eine wissenschaftliche Prüfung und Festlegung durch den G-BA nicht oder noch nicht, ist die Apotheke nicht befugt, eine Ersetzung der ärztlichen Verordnung zu erwägen. Es bleibt ohne verbindliche Regelung seitens des G-BA immer bei der therapeutischen Entscheidung des Arztes in Absprache mit dem Patienten.

Der Erstellung einer verbindlichen Liste, die einen Austausch von einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar beinhaltet, kann sich der G-BA auch nicht durch Verweis auf die an die Ärzte gerichteten Hinweise in der Anlage VIIa entziehen. Es ist seine ihm gesetzlich mit § 129 Abs. 1a Satz 5 SGB V zugewiesene Kernaufgabe, neben den Hinweisen an die Ärzte zur Festlegung der biotechnologischen Arzneimitteltherapie eine spezifische Liste zu erstellen, die es den Apotheken – neben den Ärzten – auch noch erlaubt, ein Referenzarzneimittel durch ein Biosimilar zu ersetzen.

Im Bereich der Substitution der Biologika in parenteralen Zubereitungen hat sich – wie gesagt – schon dieselbe Thematik gestellt. Angesichts dessen, dass der G-BA auch hier keine verbindliche Substitutionsliste für die Apotheken erstellt hat, haben die Verhandlungspartner der Anlage 3 zur Hilfstaxe diese Lücke geschlossen und vereinbaren nun fortlaufend eine verbindliche Austauschliste für die herstellenden Apotheken.

Wir fordern den G-BA auf, seiner Verantwortung im Rahmen der Normgebung wahrzunehmen.

Bewertung:

Die Stellungnehmenden tragen vor, dass die beschriebene Funktionsweise der Anlage VIIa im Kontext der Substitution von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken nicht gesetzeskonform sei. Stattdessen müsste eine gesonderte und abschließende Anlage zur AM-RL durch den G-BA erstellt werden. Dies schon deswegen, da Anlage VIIa keine Aussagen zur therapeutischen Vergleichbarkeit – wie im GSAV gefordert – der in einer Zeile zusammengefassten Präparate zulasse, sondern alleinig regulatorische Zulassungszusammenhänge abbilde und ihr zudem nicht entnommen werden könne, ob und inwieweit die aufgeführten Arzneimittel in ihren Anwendungsgebieten übereinstimmen. Dies werde auch unter der im Beschluss als Position A bezeichneten weiten Auffassung („für ein gleiches Anwendungsgebiet“) als notwendig angesehen.

Für die Sicherheit der Versicherten wird als wichtig erachtet, dass Ärzte- und Apothekerschaft die individuelle Situation von Patientinnen und Patienten zum Beispiel bezüglich bekannter Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Handhabungsproblematiken bei der Abgabe von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln sachgerecht berücksichtigen können. Dazu fehlten der Listung der Anlage alle grundlegenden Informationen zum Applikationsweg, der Vergleichbarkeit der Darreichungsformen (mit Hinweis und Differenzierung auf die Nicht-Austauschbarkeit produktspezifischer Applikationssysteme), unterschiedlichen Dosierungen und Wirkstoffkonzentrationen, Formulierungen, Lagerungsbedingungen, Patientenbegleitprogrammen sowie einer Unterscheidung in Fertigarznei- und Zubereitungsarzneimittel.

Aus Sicht eines Stellungnehmers richtet sich Anlage VIIa als Ergänzung des § 40a an den Arzt bzw. die Ärztin. Sie biete den Apotheken keine Hilfestellung, da sie in puncto Austausch Kriterien nicht abschließend sei. Da austauschbare Arzneimittel in Apotheken automatisch über die Software angezeigt würden, sofern eine Substitution zulässig und alle Substitutionskriterien erfüllt seien, sei die Anlage VIIa für die Apotheken unnötig. Als sinnvoll werde dagegen die Anpassung der Anlage 1 zum Rahmenvertrag erachtet.

Die Stellungnehmer bemängeln, dass Anlage VIIa nur als Informationsgrundlage zu den regulatorischen Hintergründen ohne abschließenden Charakter diene, die Apotheken hingegen zur „Ersetzung unter Berücksichtigung der Vorgaben unter 1 bis 3“ mit Eintreten von Biosimilars auf den Markt unabhängig von einer Listung in Anlage VIIa verpflichtet sein sollten. Damit werde aus Sicht der Stellungnehmer den Apotheken die Verantwortung auferlegt, die sich stellenden wissenschaftlichen und pharmakologischen Fragen selbst zu lösen.

Es wird vorgeschlagen Produkte mit bestehenden Rabattverträgen, festbetragsregelte Arzneimittel und Originalarzneimittel ohne verfügbare Biosimilars auf dem Markt in der Anlage VIIa zu streichen.

Zur Prüfung der Voraussetzungen nach § 40c Absatz 3 werden in Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) für Wirkstoffe, die biotechnologisch hergestellt werden und zu denen mehrere Originalarzneimittel oder mindestens ein Biosimilar verfügbar sind, die Zusammenhänge der in Deutschland zugelassenen Referenzarzneimittel und im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilars) abgebildet.

Kriterium für die Aufnahme in die Anlage ist eine arzneimittelrechtliche Zulassung, eine Listung in Anlage VIIa setzt nicht das Inverkehrbringen in Deutschland voraus. Insofern enthält die Anlage auch Arzneimittel, die zwar zugelassen sind, aber in Deutschland nicht vertrieben werden. Bei Zusammenstellung der Arzneimittel findet keine Überprüfung statt, inwiefern die Arzneimittel für dieselben Anwendungsgebiete zugelassen sind. Es besteht somit eine Informationsgrundlage zu den u. a. für eine Ersetzung in der Apotheke gemäß §§ 40b und 40c AM-RL relevanten regulatorischen Hintergründen der in Deutschland zugelassenen Referenzarzneimittel und Biosimilars.

Die in Anlage VIIa aufgeführten Zusammenhänge dienen im Kontext weiterer Informationsquellen wie der Apothekensoftware bzw. den Preis- und Verzeichnisdiensten als Grundlage zur Abgabeentscheidung und können aufgrund weitergehender Informationsmöglichkeiten des G-BA bei den zuständigen Bundesoberbehörden für Apotheken Sicherheit bei der Ersetzung begründen. Die Zusammenstellung hat keinen abschließenden Charakter. Mit Eintreten von Biosimilars auf den Markt besteht für Apotheken auch unabhängig von der Listung in Anlage VIIa die Möglichkeit einer Ersetzung unter Berücksichtigung der Vorgaben unter Absatz 1 bis 3. Die generellen Vorgaben zur Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel nach § 40c Absatz 1 bis 3 bleiben von den Angaben in der Anlage VIIa unberührt.

Auf Verlangen erhält der G-BA nach § 129 Absatz 1a Satz 7 SGB V Einsicht in die Zulassungsunterlagen bei der zuständigen Bundesoberbehörde. Das Nähere zum Austausch mit den zuständigen Bundesoberbehörden wurde mit Beschluss vom 17. Februar 2022 in der Verfahrensordnung des G-BA (VerfO) geregelt. Der G-BA strebt an, neu zugelassene Biosimilars zeitnah in die Anlage VIIa aufzunehmen.

Anlage VIIa gliedert sich in drei Spalten: in der ersten Spalte sind biotechnologisch hergestellte Wirkstoffe aufgeführt, in der zweiten Spalte die Handelsnamen der zugelassenen Original-/Referenzarzneimittel mit dem jeweiligen Wirkstoff, gegebenenfalls ergänzt um die in dem Arzneimittel enthaltene Proteinvariante oder die Applikationsart als Klammerzusatz. In der dritten Spalte werden in der jeweiligen Zeile der Original-/Referenzarzneimittel die Biosimilars aufgeführt, bei deren Zulassung nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG jeweils auf diese Arzneimittel Bezug genommen wurde. Sofern für einen Wirkstoff Referenzarzneimittel oder Biosimilars auf Grundlage derselben Zulassung bzw. einer entsprechenden Zulassungserweiterung mit identischen Handelsnamen, aber für abweichende Applikationsarten (z. B. „subkutan“, „intravenös“, „intravitreal“) vertrieben werden, werden diese Arzneimittel in der Anlage jeweils mit einem entsprechenden Klammerzusatz sowie in getrennten Zeilen aufgeführt. Dies trifft derzeit auf die Wirkstoffe Infliximab, Natalizumab, Rituximab, Tocilizumab, Trastuzumab und Ustekinumab zu. Eine Austauschbarkeit durch

Apotheken besteht bei identischer Wirkstoffbezeichnung grundsätzlich nur innerhalb einer Zeile. Der G-BA erachtet den Aufbau und die Beschriftung der Anlage VIIa als hinreichend klar. Die Bedenken einer fälschlicherweise verstandenen Austauschbarkeit von Referenzarzneimitteln werden nicht geteilt. Die Angaben zur Anwendung des Arzneimittels und zu den Sicherheitsanforderungen der Fach- und Gebrauchsinformationen sind darüber hinaus grundsätzlich zu beachten.

Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits in den Stellungnahmeverfahren zu den Beschlüssen vom 19. November 2021 zur Erstfassung der Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) und vom 15. Juni 2023 zur Ergänzung des § 40b (neu) in der AM-RL befasst. Es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in den Zusammenfassenden Dokumentationen zu den entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/5132/> und <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/>).

3.4 Einwände zum Absatz 4

3.4.1 Unterstützung von Position A + B1

AkdÄ

Die AkdÄ spricht sich bezüglich Absatz 4 Satz 1 für Position A + B1 aus.

Die Verpflichtung zur Beratung durch Apotheken bei Abgabe von Arzneimitteln ist bereits im § 20 der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) rechtlich implementiert. Gemäß § 20 ApBetrO muss die Beratung die notwendigen Informationen über die sachgerechte Anwendung des Arzneimittels umfassen und es ist durch Nachfrage festzustellen, inwieweit gegebenenfalls weiterer Informations- und Beratungsbedarf besteht.

Damit besteht bereits eine Verpflichtung zur Beratung durch Apotheken bei Abgabe von Arzneimitteln, sodass der Hinweis zur Beratung, der ergänzend in die AM-RL übernommen wurde, um deren grundsätzliche Bedeutung bei Biologika-Verordnungen zu verdeutlichen, aus Sicht der AkdÄ ausreichend ist.

[...] Die AkdÄ schließt sich der Position A + B1 bezüglich Absatz 4 Satz 1 an.

3.4.2 Unterstützung von Position B2

Amgen

Amgen lehnt die Positionen A + B1 ab und unterstützt die in Position B2 formulierten Regelungsvorschläge.

Eine Konkretisierung der Informations- und Beratungsaufgabe der Apotheken bei der Substitution ist gerade für § 40c der AM-RL besonders begrüßenswert. Durch § 40c sind solche biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel betroffen, die durch die Patient:innen selbst angewendet werden. Daher muss eine bestmögliche Information und Aufklärung der Patient:innen erfolgen, um negative Effekte einer Substitution wie eine fehlerhafte Anwendung, ein Nocebo-Effekt oder eine verschlechterte Adhärenz zum Biosimilar im Vergleich zum Referenzarzneimittel zu vermeiden.

Die Information und Aufklärung der Patient:innen kann allerdings nur partiell in der Apotheke erfolgen und liegt in der Hauptsache in den Händen des behandelnden Arztes / der behandelnden Ärztin. Die fundierteste Einschätzung darüber, welches Arzneimittel und welche Handhabung der Applikation am besten für die Patientin bzw. den Patienten geeignet ist, kann nur durch den Arzt bzw. die Ärztin vorgenommen werden [166]. Denn die verschiedenen Handhabungsformen wie Fertigspritzen und unterschiedlichste Arten von Auto-Injektoren (Einweg-Auto-Injektoren, Zweikammer-Auto-Injektoren, nachfüllbare (Mehrweg-) Auto-

166 Braun J et al. (2020): Biosimilars und der Nocebo-Effekt. Zeitschrift für Rheumatologie;79(3):267-75.

injektoren, Smart-Auto-Injektoren, Fertigspritzen, Pen-System (z. B. Push-on vs. Button vs. Klick), etc.) unterscheiden sich in der Handhabung für den Patienten bzw. die Patientin, in ihrer Nachhaltigkeit oder auch in der Möglichkeit, zusätzlich digitale Anwendungen damit zu koppeln. Eine Substitution, die eine Änderung der selbst durchgeführten Applikation für die Patient:innen bedeutet und nicht ärztlich begleitet wird, führt daher zur Verunsicherung der Patient:innen und in der Folge zu Anwendungsfehlern sowie möglichen Nocebo-Effekten und gefährdet die Therapieadhärenz.

Aus diesem Grund sind die unter Abschnitt 2 dieser Stellungnahme diskutierten mehrfachen Wechsel von Arzneimitteln durch die Apotheke allein kritisch zu sehen und die Beratungsaufgaben der Apotheken möglichst konkret zu formulieren.

Ebenso begrüßt Amgen den Vorschlag in Position B2, in dem die Bedeutung der Information über eine Substitution an den verordnenden Arzt / die verordnende Ärztin verdeutlicht werden soll. Nur bei einer exakten Information über die erfolgte Substitution von Fertigarzneimitteln, die von den Patient:innen selbst appliziert werden, kann sichergestellt werden, dass der / die Verschreibende der Pflicht zur Meldung von unerwünschten Arzneimittelreaktionen nachkommen kann (u. a. Chargennummer) und über die Therapiehistorie informiert bleibt.

Bereits die Formulierung des 2. Abschnitts von Position B2 gibt einen Hinweis darauf, dass der Informationsfluss über in der Apotheke erfolgte Substitutionen weiterhin nicht hinreichend geregelt ist. Die Notwendigkeit einer aktiven Einwilligung der Patient:innen zur Weitergabe der Information über die Substitution an den verordnenden Arzt / die verordnende Ärztin stellt eine Hürde dar, die Pharmakovigilanzmaßnahmen erschwert. Auch die Einführung der elektronischen Patientenakte in ihrer jetzigen Form wird das Problem des mangelnden Informationsaustauschs zwischen abgebender Apotheke und verordnendem Arzt / verordnender Ärztin nicht ausreichend lösen. Dieser mangelnde Informationsaustausch ist bei den von den Patient:innen selbst applizierten Fertigarzneimitteln verschärft problematisch, da zu einer lückenlosen Nachverfolgung von Sicherheitsereignissen nicht nur der Arzneimittelname, sondern auch die Chargennummer zu dokumentieren wäre. Diese Art der Dokumentation wird gerade bei selbst applizierten Arzneimitteln im Regelfall ausbleiben bzw. lückenhaft erfolgen. Folglich stehen alltagstaugliche Lösungen zur Pharmakovigilanz von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln weiterhin aus.

Biogen

Die in den Tragenden Gründen formulierte Erwartung, dass Apotheken im Rahmen der automatischen Substitution biotechnologisch hergestellter Arzneimittel eine umfassende Beratung gemäß § 20 ApBetrO leisten, ist grundsätzlich nachvollziehbar und explizit erwünscht. Auch Position B2 unterstreicht zu Recht, dass eine adäquate Aufklärung, Schulung und Beratung durch die Apotheker erforderlich sind, um Anwendungsfehler, Verunsicherung und Nocebo-Effekte zu vermeiden und die Therapieadhärenz zu fördern.

Der Nocebo-Effekt – also das Auftreten negativer Erwartungen, die zu einer Verschlechterung der Symptome oder zu Nebenwirkungen führen können – ist ein bekanntes, aber oft unterschätztes Phänomen [167]. Gerade im Zusammenhang mit Biologika/Biosimilars ist der Nocebo-Effekt besonders relevant, insbesondere beim Wechsel vom Referenzbiologikum zu einem Biosimilar. Gründe sind oft Fehlvorstellungen und mangelndes Vertrauen bei medizinischem Fachpersonal und Patienten. Dies kann zu wahrgenommenen negativen Behandlungsergebnissen, vermehrten Nebenwirkungen und einem frühen Therapieabbruch

167 Stahmann A et al. (2025): MS treatment trends before, during, and after the COVID-19 pandemic: insights from the German MS Register. J Neurol;272(4):294.

führen [167, 168, 169]. Ein aktueller Fall aus einer Londoner Klinik zeigt, dass die automatische Umstellung aller MS-Patienten auf ein Natalizumab-Biosimilar ohne ärztliche Begleitung zu schweren Nebenwirkungen führte. Dies erforderte eine Rückumstellung auf das Referenzpräparat [170].

Der Nocebo-Effekt tritt insbesondere dann auf, wenn ein Wechsel ohne ärztliche Begleitung oder ohne ausreichende Patientenaufklärung erfolgt. Studien zeigen, dass die Häufigkeit von Nocebo-Effekten bei begleiteten Wechseln bei etwa 13 % liegt [154, 171, 172], bei unbegleiteten Wechseln jedoch deutlich höher ausfallen kann [173]. Dies unterstreicht nochmals die hohe Anforderung an die Beratung in der Apotheke bei automatischer Substitution ohne Kenntnis des verschreibenden Arztes.

Die oben beschriebenen Anforderungen sind in der Praxis mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Anders als bei klassischen Generika unterscheiden sich Biologika/Biosimilars häufig in der Handhabung, insbesondere durch unterschiedliche Injektionshilfen [...]. Ein Wechsel zwischen solchen Produkten erfordert eine individuelle Einweisung der Patienten – insbesondere bei chronisch Erkrankten, älteren Menschen, Kindern oder Personen mit geistigen Einschränkungen oder eingeschränkter Beweglichkeit [8, 9, 167, 168, 169, 174, 175].

Apotheken sind laut § 20 ApBetrO verpflichtet aufklärend zu beraten, jedoch ist das im Apothekenalltag häufig nicht allumfassend umsetzbar, wenn es keinen geeigneten Raum und keine Zeit gibt, um diese Schulungen und Beratungen in der gebotenen Tiefe durchzuführen. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass insbesondere Online-Apotheken häufig keine persönliche Beratung vor Ort anbieten können.

Hinzu kommt, dass die Zahl der öffentlichen Apotheken in Deutschland seit Jahren rückläufig ist. 2024 wurde mit 17.041 Apotheken der niedrigste Stand seit den 1970er-Jahren erreicht [176]. Zudem würde eine automatische Substitution erfordern, dass alle Apotheken kurzfristig mit Schulungsmaterialien oder Demo-Devices sämtlicher Biologika/Biosimilars ausgestattet werden müssen – eine Voraussetzung, um die notwendige Qualität der Beratung sicherzustellen.

Weiter ist zu beachten, dass alle Biologika/Biosimilars mit einem verpflichtenden Risikomanagementplan zugelassen werden. Es ist offensichtlich, dass die Kenntnis des verordnenden Arztes über einen etwaig stattgefundenen Austausch in der Apotheke notwendige Voraussetzung dafür ist, seinen vertragsärztlichen Pflichten hinsichtlich Therapiemonitoring nach Umstellung von biologischen Arzneimitteln sowie der Pharmakovigilanz gem. § 6 der Musterberufsordnung-Ärzte nachzukommen.

Auch wenn Apotheker hier ebenfalls eine Verpflichtung zur Dokumentation haben, ist unklar,

168 Kristensen LE et al. (2018): Non-pharmacological Effects in Switching Medication: The Nocebo Effect in Switching from Originator to Biosimilar Agent. *BioDrugs*;32(5):397-404.

169 Car E et al. (2024): Mitigating the Nocebo Effect in Biosimilar Use and Switching: A Systematic Review. *Pharmaceut Med*;38(6):429-55.

170 Smolen JS et al. (2021): Treatment journey in rheumatoid arthritis with biosimilars: from better access to good disease control through cost savings and prevention of nocebo effects. *RMD Open*;7(2).

171 Mahase E et al. (2025): Multiple sclerosis: Investigation into side effects of switching patients to natalizumab biosimilar. *BMJ*;388:r403.

172 Müskens WD et al. (2020): One-year results after transitioning from etanercept originator to biosimilar in a setting promoting shared decision-making in rheumatology. *Rheumatol Adv Pract*;4(2):rkaa042.

173 Wetwittayakhlang P et al. (2024): Clinical efficacy and nocebo effect following non-medical biosimilar switch in patients with inflammatory bowel disease: A prospective observational study. *Dig Liver Dis*;56(1):35-42.

174 Cooksey R et al. (2022): Real-world use of an etanercept biosimilar including selective versus automatic substitution in inflammatory arthritis patients: a UK-based electronic health records study. *Rheumatol Adv Pract*;6(2):rkac056.

175 Dutt K et al. (2022): The Nocebo Effect in a Non-Medical Switching Program from Originator to Biosimilar Infliximab in Inflammatory Bowel Disease. *BioDrugs*;36(5):639-44.

176 St Clair-Jones A et al. (2020): Understanding and Minimising Injection-Site Pain Following Subcutaneous Administration of Biologics: A Narrative Review. *Rheumatol Ther*;7(4):741-57.

ob Patienten relevante Informationen wie Nebenwirkungen oder Anwendungsprobleme primär dem Apotheker oder dem behandelnden Arzt mitteilen. Dies erschwert die Rückverfolgbarkeit und kann die Qualität der Pharmakovigilanz beeinträchtigen.

[...] Zusammenfassend lässt sich zu Absatz 4 sagen, dass aus Gründen der Patientensicherheit, Therapieadhärenz und Nachvollziehbarkeit Position B2 ausdrücklich gestützt wird: Eine automatische Substitution darf nur dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die betroffenen Patienten sachgerecht über das neue Präparat informiert und geschult werden können – einschließlich der Handhabung, Lagerung und potenzieller Unterschiede zum bisherigen Arzneimittel. Andernfalls drohen Anwendungsfehler, Therapieabbrüche und ein Vertrauensverlust in die Versorgung. Darüber hinaus ist es unerlässlich, dass die Apotheke den verordnenden Arzt über das konkret abgegebene Präparat informiert, analog zur französischen Regelung. Der G-BA ist gefordert, über allgemeine Beratungsverpflichtungen hinaus konkrete Vorgaben zu machen, wie die dargestellten praktischen Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich Schulungsressourcen, räumlicher Ausstattung und Rückmeldung an den Arzt in der Versorgungspraxis bewältigt werden sollen.

Celltrion

Die in Absatz 4 formulierte Position B2 zur vorgesehenen Verpflichtung zur Information des behandelnden Arztes über eine in der Apotheke erfolgte Substitution eines biotechnologisch hergestellten Arzneimittels ist aus fachlicher, regulatorischer und haftungsrechtlicher Sicht zwingend erforderlich. Sie bildet die unverzichtbare Grundlage dafür, dass der Arzt seinen gesetzlichen und berufsrechtlichen Pflichten nachkommen kann.

Fresenius Kabi

Die in „Position B2“ vorgesehene Verpflichtung zur Information des behandelnden Arztes über eine in der Apotheke erfolgte Substitution eines biotechnologisch hergestellten Arzneimittels ist aus fachlicher, regulatorischer und haftungsrechtlicher Sicht zwingend erforderlich. Sie bildet die unverzichtbare Grundlage dafür, dass der Arzt seinen gesetzlichen und berufsrechtlichen Pflichten nachkommen kann.

Alle Biosimilars werden mit einem verpflichtenden Risikomanagementplan zugelassen. Es ist offensichtlich, dass die Kenntnis des verordnenden Arztes über einen etwaig stattgefundenen Austausch in der Apotheke notwendige Voraussetzung dafür ist, seinen vertragsärztlichen Pflichten hinsichtlich Therapiemonitoring nach Umstellung von biologischen Arzneimitteln sowie der Pharmakovigilanz gem. § 6 der Musterberufsordnung-Ärzte nachzukommen. Wenn dem Arzt nicht klar ist, welches Präparat der Patient wirklich erhält, weil ein Austausch in der Apotheke vorgenommen wurde, ist es weder dem Arzt noch den Zulassungsinhabern möglich, die Verpflichtungen zur gezielten Erfassung bestimmter Nebenwirkungen adäquat zu erfüllen. Wiederholte, nicht protokollierte Produktwechsel werden unweigerlich zu Problemen bei der Zuordnung von Nebenwirkungen führen, insbesondere wenn diese erst im späteren Therapieverlauf auftreten.

Darüber hinaus können sich Folgeprobleme bei der lückenlosen Dokumentation der ärztlichen Therapie in der Patientenakte und haftungsrechtliche Abgrenzungsprobleme im Schadensfall ergeben. Unter dem Gesichtspunkt des § 62 Abs. 2 Satz 4 AMG ist die erforderliche Dokumentation bei einem Austausch in der Apotheke unterbrochen, denn der Arzt erhält keine Informationen darüber, welches Arzneimittel der Patient tatsächlich erhalten hat. Wir halten es daher ebenfalls, wie auch die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, für dringend geboten, IT-gestützte robuste Lösungen zu realisieren, die die Dokumentation des Handelsnamens des abgegebenen Arzneimittels sowie der jeweiligen Herstellungsladung im Sinne einer eindeutigen Rückverfolgbarkeit bei Meldung von Arzneimittelrisiken zu ermöglichen.

Hexal

Im Beschlussentwurf zu § 40c Abs. 4 AM-RL bleiben maßgebliche ausführungsrelevante

Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Pharmakovigilanz wie z.B. notwendige Kommunikationsanforderungen beim Austausch ungeklärt. Allein die Position B2 fordert, dass bei einem Austausch auf ein anderes als das verordnete Präparat die Apotheke den verordnenden Arzt über das konkret ausgehändigt Präparat informieren soll, soweit der Patient oder die Patientin in die Weitergabe der personenbezogenen Patientendaten an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin ausdrücklich einwilligt. Position A und B1 äußern sich nicht dazu, wie die Vorschriften zur Pharmakovigilanz im Falle eines Austauschs eingehalten werden können.

Wir schließen uns klar der Forderung von B2 an. Eine zwischen allen beteiligten Parteien lückenlose und systematische Dokumentation zur Gewährleistung der Pharmakovigilanz und Wahrung der Arzneimitteltherapiesicherheit muss eine zwingende und prozessual obligatorisch sicherzustellende Voraussetzung sein, dass eine Ersetzung von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln durch Apotheken gemäß § 40c erfolgen kann. Der G-BA muss diese Anforderung vor Implementierung einer entsprechenden Substitutionsregelung zu einer konkreten Ausführungsbedingung machen.

Denn Stand heute sind die Prozess- und Telematikinfrastukturgestützten Systemanforderungen zur Sicherstellung dieser „end-to-end-Dokumentation“ im deutschen Gesundheitssystem weiterhin nicht erfüllt. Zwar ist am 15. Januar 2025 die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) im sogenannten Opt-out-Verfahren in ersten Modellregionen gestartet. Ein verpflichtender und flächendeckender Roll out ist aber nicht vor Q4 2025 geplant und wurde zuletzt gesetzlich auch mehrfach verschoben. Die ePA ist dabei als digitale „Datendrehscheibe“ grundsätzlich geeignet, über die Einspielung von Daten aus der elektronischen Medikationsliste (eML) bzw. digitalen eRezepten institutionsübergreifend arzneimittelsicherheitsrelevante Datenfelder wie die Charge und den Produktnamen von Arzneimitteln systematisch zu erfassen. Die eML enthält wichtige Informationen zur Medikation eines Versicherten wie Handelsname, Wirkstoff, Wirkstärke und Dosierung und kann Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern die sektorenübergreifende Abstimmung und Information zur Medikation erleichtern. Mit Blick auf die derzeitigen Nutzungszahlen und funktionalen technischen Anbindungen der Leistungserbringer an die ePA ist dieses Ziel Stand heute aber immer noch ein Zukunftsszenario, dessen Realisierung über die verschiedenen Institutionen hinweg erst praktisch vollzogen werden muss.

Lilly

[...] Des Weiteren erfordert jeder Wechsel eines Produktes eine neuerliche sorgfältige Unterweisung des Patienten, vor allem hinsichtlich der Darreichungsform, der Handhabung, des Applikationsvorganges, des Injektionsvolumens sowie der Lagerung. Diese Aspekte können sich von Präparat zu Präparat erheblich unterscheiden. Wie eingangs bereits beschrieben, können im Rahmen einer automatischen Substitution patientenindividuelle und erkrankungsspezifische Aspekte häufig nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Einbindung des Patienten in die Therapieentscheidung stellt sich als unzureichend dar. Betreffend unseres Produktes Forsteo® ist es unbedingt notwendig, dem Patienten die richtige Injektionstechnik zu erklären, um einen Therapieerfolg gewährleisten zu können [177]. In Bezug auf die Therapie mit Humalog® und Lyumjev® wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Patienten vor der Anwendung in der korrekten Anwendung und Injektionstechnik geschult werden müssen [100, 102], insbesondere vor dem Hintergrund der Arzneimittelsicherheit und möglichen Schäden des Patienten bei einer Fehlanwendung. Eine Demonstration der Handhabung der Applikation des ausgetauschten Arzneimittels durch geschultes Fachpersonal, wie z.B. durch den abgebenden Apotheker, ist daher aus der Sicht von Lilly unverzichtbar (Position B2).

[...] Die Verlagerung der Therapieauswahl auf die Apotheken im Rahmen der Substitution

bedeutet für das Fachpersonal erheblichen zusätzlichen Beratungsaufwand. Durch die Information, Aufklärung, Beratung sowie Schulung des Patienten bei der Abgabe von Arzneimitteln zu substitutionsbedingt relevanten Aspekten in Apotheken wird das Fachpersonal zusätzlich zeitintensiv belastet. Laut der jährlichen Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit, welche zuletzt im Mai 2025 für das Jahr 2024 veröffentlicht wurde, zeigte sich unter Apothekern und Pharmazeuten in allen Bundesländern, in denen Daten ausgewiesen wurden, ohnehin schon ein Fachkräfteengpass. Zudem ist zu hinterfragen, ob die Demonstration anhand eines Musters für jeden individuellen Patienten praktikabel und umsetzbar ist, sodass Anwendungsfehler in diesem Zusammenhang und die Gefährdung des Therapieerfolgs ausgeschlossen werden können.

[...] Zudem sollte zwingend gewährleistet werden, dass der verordnende Arzt über die Ersetzung des verordneten Arzneimittels und über das ausgegebene Präparat informiert wird (Position B2). Inwieweit und in welcher Form eine eindeutige Identifizierung und Rückverfolgung der verordneten Biosimilars umsetzbar ist, insbesondere für den Fall, dass der Patient in die Weitergabe der personenbezogenen Patientendaten an den behandelnden Arzt nicht ausdrücklich einwilligt, bleibt offen. In dem beschriebenen Fall ist fraglich, ob eine regelhafte Information über eine Substitution in der Apotheke und das tatsächlich abgegebene Arzneimittel an den Arzt erfolgen kann. Nachfolgend kann durch den Arzt die rechtlich vorgeschriebene produktgenaue Dokumentation nicht gewährleistet werden. Im Falle eines Verdachtsfalls einer Nebenwirkung wäre für den behandelnden Arzt nicht sofort und eindeutig erkennbar, welches Produkt sowie welche Charge an den Patienten abgegeben wurde. Bei einem Produktwechsel ohne ausreichende Dokumentation wäre die Zuordnung von Nebenwirkungen zu einem Produkt unmöglich und die Arzneimittelsicherheit gefährdet, vor allem dann, wenn unerwünschte Ereignisse erst im späteren Verlauf der Therapie auftreten.

Medice

Ebenso wie die Position B2 halten wir es aus Gründen der Patientensicherheit und Adhärenz für erforderlich, dass der Patient / die Patientin für die Eigenanwendung mit der Handhabung der Applikation des neuen Arzneimittels vertraut gemacht wird. Erfolgen die Ersetzung und Unterweisung nicht in der Arztpraxis, so muss in logischer Konsequenz die Apotheke zur Übernahme dieser Aufgabe verpflichtet sein.

Im Falle eines Austauschs zwischen Epoetin alfa und Epoetin zeta kommt zudem ein neuer Wirkstoff ins Spiel. Hier müsste ggf. auch der Medikationsplan angepasst werden, um keine Verunsicherung bei der Eigenanwendung zu verursachen.

[...] Es bleibt unklar, auf welchem Wege die Information der verordnenden Ärzte bzw. Ärztinnen erfolgen und wie dies dokumentiert werden muss, sie ist jedoch auch aus unserer Sicht unerlässlich, damit die Verordner die Auswirkungen eines Wechsels zeitnah beurteilen können, z.B. indem sie Blutwerte engmaschiger kontrollieren als sonst üblich.

Wir folgen auch hier der Position B2, dass die Aussagekraft von Registern geschwächt und die Versorgungsforschung manipuliert würde, wenn beobachtete Effekte nicht mehr eindeutig einem Arzneimittel zugeordnet werden können.

An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass Folgekosten und Haftungsrisiken entstehen, insbesondere auch durch das datenschutzkonforme Einholen des Einverständnisses der Patienten und Patientinnen. Mehrausgaben durch Aufklärungs-, Dokumentations- und Informationspflichten der Apotheken würden die Krankenversicherungen unmittelbar belasten, sofern die Apotheken nicht bereit sind, den Mehraufwand unentgeltlich zu schultern, sondern es z.B. auf einen zusätzlichen Aufschlag im Rahmen der Arzneimittelpreisverordnung hinausläuft.

Bei Nicht-Einwilligung des Patienten fließt die Information an den Verordner nicht, was wiederum zu der oben skizzierten Problematik führt.

Merck

Merck begrüßt die in Position B2 ausgeführte [...] Regelung in Absatz 4, dass bei Abgabe eines anderen als das verordnete Präparat die Apotheke den verordneten Arzt über das konkret ausgehändigte Präparat zu informieren hat.

Da der Patient seine Verschreibungen nicht zwingend in derselben Apotheke einlöst, hat die aufgesuchte Apotheke keine Kenntnis über die Häufigkeit des Austausches. Insofern sollte der verschreibende Arzt zwingend den Überblick über den Therapiewechsel behalten, auch um Mehrfachwechsel identifizieren zu können. Wie in den tragenden Gründen zu Absatz 4 ausgeführt, sollen Nebenwirkungen vom behandelnden Arzt an entsprechende Register gemeldet werden. Dies setzt eine Kenntnis des behandelnden Arztes zwingend voraus, nicht zuletzt auch um die Haftung beim verschreibenden Arzt zu belassen.

Eine reine Information an den verordnenden Arzt ist nach Aushändigung des Präparats jedoch zu kurzgefasst. Zum einen kann der Arzt einen Mehrfachwechsel nicht rechtzeitig identifizieren und Therapien zur Selbstapplikation [...] wurden womöglich bereits vom Patienten appliziert, sodass der Therapieerfolg sowie die Patientensicherheit gefährdet wird. Folglich sollte die Apotheke mit dem verordnenden Arzt vor Abgabe des konkreten Präparats Rücksprache halten.

Merck schlägt die Anpassung des Formulierungsvorschlags B2 wie folgt vor, um die verpflichtende Weitergabe der Informationen von der Apotheke an den Arzt zu verdeutlichen:

„[...] Wenn ein anderes als das verordnete Präparat abgegeben wird, hat die Apotheke mit dem verordneten Arzt oder der verordneten Ärztin vor Abgabe des konkreten ausgehändigten Präparats (Handelsname) Rücksprache zu halten, soweit der Patient oder die Patientin in die Weitergabe der personenbezogenen Patientendaten an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin ausdrücklich einwilligt.“

Novartis

Die Umstellung auf ein anderes Arzneimittel in der Apotheke birgt verschiedene Risiken wie Anwendungsfehler, Non-Compliance, und den Nocebo-Effekt. Damit die bei einem Biosimilar-Austausch immanenten Risiken zumindest reduziert werden, ist die Position B2 zwingend erforderlich.

Novo Nordisk

Novo Nordisk lehnt die Position A + B1 ab und begrüßt die besondere und explizite Informations- und Beratungsanforderung der Apotheke gegenüber Patient:innen, die in **Position B2** gesehen wird. Novo Nordisk sieht die Informationsweiterleitung an die behandelnden Ärzt:innen als unabdingbar an, um den Therapieverlauf mit einem biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel adäquat zu begleiten und Aspekte der Pharmakovigilanz und Therapiesicherheit berücksichtigen zu können. Als problematisch sehen wir die aktuell nicht gegebene Infrastruktur für einen solch aufwendigen Informationsaustausch zwischen Ärzt:innen und Apotheken an, sodass aus unserer Sicht dieser Verpflichtung nicht nachgekommen werden kann.

Pfizer

In § 40c (neu) Abs. 4 ist vorgesehen, dass die gesetzlichen Regelungen zur Information und Beratung in Apotheken bei Abgabe von Arzneimitteln auch zu substitutionsbedingt relevanten Aspekten, u.a. mit dem Ziel der Reduzierung eines möglichen Nocebo-Effektes, unberührt bleiben. Ungeachtet der Unterschiede zwischen der Position A + B1 sowie Position B2 basiert dies auf der gemeinsamen Annahme, dass die Information und Beratung ein wichtiger Teil der Therapie ist, um insbesondere Effekte wie einen möglichen Nocebo-Effekt zu reduzieren. Dies ist grundsätzlich richtig, verkennet jedoch die **Unterschiede zwischen der apothekerlichen und ärztlichen Beratung und Aufklärung**:

Gerade aufgrund eines Mehrfachwechsels sinkt die Therapieadhärenz und tritt die Gefahr einer Destabilisierung der Therapie ein. Hiermit eng zusammen hängt der sog. Nocebo-Effekt.

Dieser Effekt ist definiert durch eine Verschlechterung von Symptomen durch eine negative Erwartungshaltung des Patienten beim Umstellen vom Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar. Zwar ist die gängige Auffassung, dass der Nocebo-Effekt sich durch umfassendes Informieren und Aufklärung des Patienten minimieren lässt. Im Gegensatz zum einfachen Therapiewechsel von einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar ist der mehrfache Therapiewechsel von einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar und zurück bisher nur wenig untersucht worden und Bedenken bezüglich der Sicherheit und Wirksamkeit bestehen weiterhin. Insbesondere beziehen sich diese Studien **lediglich auf die ärztlich begleitete Umstellung, nicht auf die automatische Substitution**. Der mehrfache Therapiewechsel von Biosimilars untereinander ist bisher nicht untersucht. Um die Therapieadhärenz nicht unnötig zu gefährden und Nocebo-Effekte möglichst nicht hervorzurufen, sollten mehrfache Therapiewechsel demnach möglichst nur aufgrund medizinischer Notwendigkeit erfolgen. Da sich die einzelnen Arzneimittel zudem hinsichtlich der Injektionsvolumina, der Handhabung und der Packungsausstattung unterscheiden können, steht zu befürchten, dass mehrfache Therapiewechsel darüber hinaus Anwendungsfehler und Nicht-Adhärenz begünstigen können.

Es gibt nach unserem Kenntnisstand **keine evidenzbasierte Grundlage** für die Annahme, dass eine entsprechende **Beratung durch die Apotheken** einem Nocebo-Effekt entgegenwirken können. Wie die Bundesärztekammer und die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 4. April 2019 festgestellt haben, gibt es jedoch klinische Daten zu Nocebo-Effekten bei Umstellung auf ein Biosimilar. Wörtlich heißt es dort:

„In vielen klinischen Studien werden sog. Nocebo-Effekte durch die Umstellung der Therapie mit einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar berichtet. Unter Nocebo-Effekten werden die negativen Effekte bei der Anwendung eines Arzneimittels verstanden, die auf der Basis von Wissen und Erwartungen des Patienten und des behandelnden Arztes über die schädlichen Auswirkungen einer Therapie entstehen. Sie treten in offenen Studien häufiger als in doppelblinden Studien auf und führen zu frühzeitigen Therapieabbrüchen aufgrund von häufig nicht objektivierbarem Wirkverlust oder Nebenwirkungen. Solche negativen Effekte können nur durch ausführliche Information und Beratung durch den behandelnden Arzt begrenzt bzw. vermieden werden.“

Für Annahme des Gemeinsamen Bundesausschuss gibt es daher **keinerlei Evidenz**. Im Gegenteil haben die Bundesärztekammer und die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 4. April 2019 auf Grundlage klinischer Studien vor einem Nocebo-Effekt gewarnt und darauf hingewiesen, dass solche negativen Effekte allenfalls durch ausführliche Information und Beratung **durch den behandelnden Arzt** begrenzt bzw. vermieden werden könnten. Der Apotheker kann nicht das vertrauensvolle Gespräch der Arzt-Patienten-Beziehung ersetzen.

Insofern ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn in § 40b (neu) Abs. 4 die Position B2 vorsieht, dass die Apotheker gewährleisten müssen, dass bei einer Ersetzung der Verordnung die Ärzte über das ausgegebene Präparat informiert werden, soweit die Patienten in die Weitergabe ihrer personenbezogenen Patientendaten ausdrücklich eingewilligt haben.

Diesem Vorschlag liegen die besonderen pharmakovigilanzrechtlichen Pflichten bei Biologika zugrunde. Da die allermeisten Biosimilars der zusätzlichen Überwachung unterliegen (sog. schwarzes Dreieck), soll auf diese Weise gewährleistet werden, dass die Ärzte hierüber in Kenntnis gesetzt werden und etwaige Nebenwirkungen entsprechend beobachten und zuordnen können. Es kommt diesbezüglich zu Problemen, wenn in Folge eines Austausches der Arzt nicht darüber im Bilde ist, welches Präparat abgegeben wurde.

Allerdings gibt es keine rechtliche Grundlage dafür, dass der Gemeinsame Bundesausschuss derartige Pflichten der Apotheken in seiner Arzneimittel-Richtlinie regelt. Dies gilt umso mehr, als die in § 129 Abs. 1a Satz 5 SGB V enthaltene Befugnis lediglich die Feststellung der Austauschbarkeit vom biologischen Referenzarzneimittel betrifft, nicht jedoch **nachgelagerte**

Pflichten der Apotheken nach einem Austausch. So sehr daher eine Lösung dieses Problems erforderlich ist, so wenig kann diese Lösung im Rahmen der Arzneimittel-Richtlinie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss getroffen werden. Vielmehr bedarf es hierzu einer parlamentsgesetzlichen Regelung, die weiter fehlt.

Roche

Ein mehrfacher Wechsel des Präparats (Switch) während der Behandlung eines Patienten sollte vermieden werden, um die Therapieadhärenz und die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Daher ist eine Informations- und Dokumentationspflicht substituierender Apotheken für Behandler bezüglich ausgegebener Präparate unerlässlich.

Ein Therapiewechsel ohne Kenntnis des behandelnden Arztes schwächt die Aussagekraft von Registern, die oft Teil von Risikomanagementplänen für Biosimilars sind. Beobachtete Effekte könnten keinem spezifischen Arzneimittel eindeutig zugeordnet werden. Daher ist eine Informations- und Dokumentationspflicht substituierender Apotheken für Behandler bezüglich ausgegebener Präparate unerlässlich [...].

[...] Biosimilars [stehen] von Seiten der Zulassungsbehörden bezüglich der Pharmakovigilanz unter zusätzlicher Überwachung. Um mögliche Nebenwirkungen dem entsprechenden Präparat korrekt zuordnen zu können, müssen Apotheken nach einem Austausch gewährleisten, dass der behandelnde Arzt über das konkret ausgegebene Präparat (Handelsname) für jeden Patienten nachverfolgbar informiert wird. Dies ermöglicht es dem Arzt zudem, sich an entsprechende Register zu melden.

[...] Satz [„der Patient oder die Patientin ... ausdrücklich einwilligt“] ist zu streichen, Information muss zwingend weitergegeben werden.

[...] Im Falle einer Substitution sollte in jedem Fall eine ausführliche Beratung durch die Apotheke erfolgen, um die Adhärenz und Arzneimitteltherapiesicherheit zu gewährleisten. Hier ist zu Absatz 4 Position B2 zu bevorzugen.

Sanofi

Im aktuellen Entwurf ist keine Information der Verordner:innen über einen erfolgten Austausch in der Apotheke vorgesehen. Damit wird die Patient:innensicherheit reduziert, da eine Zuordnung und Nachverfolgung möglicher Arzneimittelnebenwirkungen nicht mehr möglich ist. Die Regelung sollte dahingehend erweitert werden, dass Verordner:innen über einen Austausch zeitnah informiert werden, damit sie ihren Dokumentationspflichten nachkommen können. Letztlich können Verordner:innen nur so Ihrem Auftrag gemäß § 40a der AM-RL nachkommen und Patient:innen über die Gründe der Umstellung (zumindest im Nachgang) zu informieren. In diesem Zusammenhang wird eine Erweiterung des § 40a als sinnvoll erachtet, die die Ärztin oder den Arzt verpflichtet, die Patient:innen darüber zu informieren, dass ein Austausch / eine Umstellung durch die Apotheke erfolgen kann. Dies muss mit Inkrafttreten des §40c AM-RL implementiert werden und nicht erst in ferner Zukunft durch mögliches Zusammenspiel von E-Rezept und EPA (elektronische Patientenakte). Daher unterstützt Sanofi die Position B2 in Absatz (4).

BPI

Ein automatischer Austausch ohne Wissen des Arztes erschwert die eindeutige Zuordnung von Nebenwirkungen zu einem konkreten Arzneimittel, da die lückenlose Dokumentation in Registern gefährdet wird. Die Position B2, die eine Arztinformation durch die Apotheke vorsieht, greift diesen Aspekt auf und wird daher grundsätzlich unterstützt.

Die Apothekerberatung kann die Sicherheit von Patientinnen und Patienten bei der Versorgung mit biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln (Original/Referenzprodukt oder im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel) erhöhen, die Adhärenz stärken und den wichtigen Informationsfluss zwischen Apotheke-Patient/Patientin-Ärztin/Arzt unterstützen.

Das Delta bei der Arztaufklärung im Substitutionsfall kann diese Regelung aber nicht gänzlich schließen, da Apotheken in der Regel weder über klinisches Begleitwissen noch über rechtliche Absicherungen verfügen – insbesondere bei Nebenwirkungen oder mangelhafter Wirkung nach einem Substitutionswechsel. Zudem können Applikationssysteme wie z. B. Injektionspens infolge abweichender Füllmengen und Minimaldosen nicht nur in der Anwendungsweise, sondern auch in Reichweite und Einzeldosisoptionen signifikant voneinander abweichen. Eine Substitution auf Apothekenebene ohne Kenntnis des ärztlichen Behandlungsplans (Einzeldosen, Anwendungsdauer) würde somit weitere Risiken bergen.

Gleichzeitig erhöht sich der bürokratische Aufwand weiter und der Versuch, Informationslücken zu schließen, hat Limitationen dadurch, dass die Arztinformation durch Apotheken an die ausdrückliche Einwilligung der Patienten gebunden und daher nicht verlässlich umsetzbar ist.

Pro Generika

Die in Position B2 vorgesehene Verpflichtung zur Information des behandelnden Arztes über eine in der Apotheke erfolgte Substitution eines biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittels ist aus fachlicher, regulatorischer und haftungsrechtlicher Sicht zwingend erforderlich. Sie bildet die unverzichtbare Grundlage dafür, dass der Arzt seinen gesetzlichen und berufsrechtlichen Pflichten nachkommen kann.

vfa

Der vfa begrüßt ausdrücklich, dass in Position B2 die Apotheker:innen insbesondere auch die Handhabung der Applikation des neuen Arzneimittels demonstrieren müssen. Dies ist gerade bei Biopharmazeutika, die von Patient:innen selbst appliziert werden, von ausgesprochen hoher Relevanz zur Vermeidung von Adhärenzverlust und Nocebo-Effekten sowie für die Sicherstellung des Therapieerfolgs. Denn mit jedem Wechsel eines selbst zu verabreichenden Biopharmazeutikums geht auch ein Wechsel des Devices einher. Auch über die Information zu den Devices und deren Anwendung hinaus sind Biopharmazeutika beratungsintensiv, denn es gibt Unterschiede zwischen den Produkten im Hinblick auf u.a. die zugelassenen Anwendungsgebiete, Formulierungen und Applikationsarten.

Im Beschlussentwurf ist keine systematische Information der verordnenden Ärzt:innen über einen vorgenommenen Austausch in der Apotheke vorgesehen. Auf diese Weise wird die Patientensicherheit gefährdet, da eine Nachverfolgung und Zuordnung möglicher Arzneimittelnebenwirkungen nicht mehr möglich ist. Zu diesem Punkt führt Position B2 in den Tragenden Gründen weiter aus, denn Biosimilars stehen von Seiten der Zulassungsbehörden bezüglich der Pharmakovigilanz unter zusätzlicher Beobachtung. Um mögliche Nebenwirkungen dem entsprechenden Präparat korrekt zuordnen zu können, müssen Apotheken nach einem Austausch gewährleisten, dass Behandler:innen über das ausgegebene Präparat (Handelsname) informiert sind. Die verordnenden Ärzt:innen müssen über einen Austausch zeitnah informiert werden, damit sie ihren gesetzlichen und berufsrechtlichen Dokumentationspflichten nachkommen können. Ein Wechsel, ohne dass Behandler:innen Kenntnis darüber erlangen, schwächt auch die Aussagekraft von Registern, die oftmals Bestandteil von Risikomanagementplänen sind. Denn eine lückenlose Dokumentation der Biopharmazeutika, die die Patient:innen erhalten, ist nicht gewährleistet. Eine eindeutige Zuordnung von beobachteten Effekten zu einem konkreten Arzneimittel ist so nicht möglich.

AkdÄ

Bezüglich Absatz 4 Satz 2 spricht sich die AkdÄ für Position B2 aus unter der Voraussetzung, dass die Formulierung geändert wird. Es wird geregelt, dass die abgebende Apotheke bei einer Ersetzung den verordnenden Arzt über das ausgegebene Präparat zu informieren hat, soweit der Patient in die Weitergabe der personenbezogenen Patientendaten an den behandelnden Arzt ausdrücklich einwilligt. Grundsätzlich ist es u. a. mit Blick auf die Pharmakovigilanz als sinnvoll zu erachten, dass der verordnende Arzt über das abgegebene Biologikum informiert

wird. Allerdings ist für den Arzt die Information über das abgegebene Arzneimittel allein nutzlos. Vielmehr wäre zudem die Weitergabe der jeweiligen Chargenbezeichnung sinnvoll.

Ein integraler Bestandteil der Pharmakovigilanz biologischer Arzneimittel ist die genaue Identifizierung und die gesicherte Rückverfolgbarkeit bei Meldungen von Nebenwirkungen unter der Anwendung biologischer Arzneimittel. Referenzbiologika und Biosimilars tragen denselben „International Nonproprietary Name“ (INN), weisen aber geringe Unterschiede z. B. in der Struktur auf, die eventuell eine veränderte Immunogenität nach sich ziehen können. Die Bandbreite der unerwünschten Reaktionen aufgrund einer veränderten Immunogenität reicht von einer Antikörperbildung gegen das Arzneimittel ohne klinische Bedeutung bis hin zu schweren, lebensbedrohlichen Unverträglichkeitsreaktionen. Solche Nebenwirkungen können auch durch Änderungen des Herstellungsverfahrens entstehen, die bereits beschrieben wurden. Somit können sie bei der Zulassung eines Biologikums nicht ausgeschlossen werden, weil sie auch zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe des Lebenszyklus eines Arzneimittels erstmalig auftreten können.

Meldungen vermuteter Nebenwirkungen allein unter der Wirkstoffbezeichnung (INN) können nicht klar einem Fertigarzneimittel zugeordnet werden. Für biologische Arzneimittel – Referenzarzneimittel wie Biosimilars – bedeutet dies, dass neben der üblichen Angabe vom Wirkstoff auch der Handelsname sowie nach Möglichkeit die Chargenbezeichnung zu dokumentieren sind. Die Europäische Kommission hat die Mitgliedsstaaten verpflichtet, u. a. durch geeignete Methoden zur Informationssammlung sicherzustellen, dass bei Berichten über vermutete Nebenwirkungen durch biologische Arzneimittel diese eindeutig zu identifizieren sind, wobei der Handelsname des Arzneimittels und die Chargenbezeichnung genau angegeben werden sollten [178]. Diese Verpflichtung gilt für alle Biologika – Referenzarzneimittel und Biosimilars – und hat mittlerweile Einzug in die Fachinformation neu zugelassener biologischer Arzneimittel gefunden. Unter dem Punkt 4.4 „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ wird unter „Rückverfolgbarkeit“ folgendes angegeben: „Um die Rückverfolgbarkeit biologischer Arzneimittel zu verbessern, müssen die Bezeichnung des Arzneimittels und die Chargenbezeichnung des angewendeten Arzneimittels eindeutig dokumentiert werden“. Da die Fachinformation für die Angehörigen der Fachkreise gedacht ist, sind die Adressaten dieser Verpflichtung eindeutig Ärzte und Apotheker.

Zur Erreichung dieses Ziels wäre daher die Information zur Chargenbezeichnung erforderlich, die dem Arzt durch die Apotheken zur Verfügung gestellt werden könnte. Denn nur so können aufgetretene unerwünschte Reaktionen einem bestimmten Arzneimittel, Herstellungsort und -verfahren bzw. einer bestimmten Charge zugeordnet werden. Eine solche Vorgehensweise würde die von der europäischen Gesetzgebung klar geforderte Rückverfolgbarkeit bei Meldungen von Nebenwirkungen sicherstellen. Im Fall einer schweren Nebenwirkung ließe sich sofort erkennen, welches Biologikum der Patient genau erhalten hat. Nur wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, kann aber die Behandlung patientenindividuell angepasst werden.

Zudem weist die AkdÄ darauf hin, dass es einer klaren Vorgabe bzw. eines Verweises auf bestehende Vorgaben diesbezüglich bedarf, wie die Patienteneinwilligung einzuholen und dann datenschutzkonform in der Apotheke aufzubewahren ist. Es muss eine Standardisierung der Informationsweitergabe vorgegeben werden, damit die wesentlichen Informationen den Arzt datenschutzkonform erreichen und der administrative Aufwand in der Apotheke sowie in der Arztpraxis so gering wie möglich gehalten wird.

[...] Die AkdÄ schließt sich der B2 bezüglich Absatz 4 Satz 2 unter folgender Änderung des Satzes 4 an:

178 Richtlinie 2010/84/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2010 zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel hinsichtlich der Pharmakovigilanz.

„Wenn ein anderes als das verordnete Präparat abgegeben wurde, hat die Apotheke den verordnenden Arzt oder die verordnende Ärztin über das konkret ausgehändigte Präparat (Handelsname) sowie seine Chargenbezeichnung zu informieren, soweit der Patient oder die Patientin in die Weitergabe der personenbezogenen Patientendaten an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin ausdrücklich einwilligt.“

DGVS, gemeinsam mit Kompetenznetz Darmerkrankungen e. V. und bng

[...] Wenn überhaupt eine Substitution von Biologika als Fertigarzneimitteln in der Apotheke diskutiert würde –[...] dann wäre am ehesten Position B2 zu unterstützen. Wenn es in der Apotheke zum Austausch eines Biologikums kommen sollte, muss dringend gewährleistet werden, dass der Patient davor bestmöglich informiert und beraten wird. Nur so kann der Gefahr durch Nocebo-Effekt und Verlust der Therapieadhärenz entgegengewirkt werden. Das Patientenwohl muss im Mittelpunkt jeglicher Entscheidungen des G-BA stehen – besonders bei chronisch-kranken Patienten, die mitunter Jahre benötigen, um eine stabile Therapie zu finden.

DRFZ

Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass im Falle eines Austauschs in der Apotheke die Ärztin oder der Arzt informiert wird, welches Produkt abgegeben wurde. Dies muss entweder durch die Apotheken selbst gewährleistet werden oder – im Falle einer erfolgreichen Erprobung – durch die Patient:innen. Es ist die zwingende Voraussetzung für korrekte ärztliche Meldungen im Rahmen der Pharmakovigilanz an das BfArM bzw. an die Pharmakovigilanzabteilungen der jeweiligen Firmen und an die Register.

Im Interesse der Patientensicherheit und aus wissenschaftlichen Gründen empfehlen wir, die automatische Substituierung für weitere drei Jahre auszusetzen, um a) die o.g. patientenbezogenen Daten in die Entscheidung einzubeziehen und evtl. geeignete Maßnahmen entwickeln zu können, um vulnerable Gruppen besser vor Medikationsproblemen zu schützen, b) genügend Erfahrung mit der Dokumentation der Handelsnamen durch Patient:innen gewonnen zu haben oder c) ein verbindliches Meldesystem der Apotheken an die Ärzte etabliert zu haben. Bis dahin sollte die aktuelle Regelung beibehalten werden.

3.4.3 Weitere Einwände

Biocon

[...] Zur Frage der Therapieadhärenz ist festzuhalten, dass die Herausforderungen für einen nicht medizinisch indizierten Medikamentenwechsel bei einer biologischen Subkutan-Therapie außerhalb der ärztlichen Praxis, z. B. in einer Apotheke, vielfältig sind und die Anforderungen von anderen Applikationsformen, z. B. Tabletten deutlich übersteigen.

So ergäbe sich durch die Substitution ein erhöhter Zeitaufwand für die Aufklärung bezüglich des Therapieerfolgs und den zu erwartenden Nebenwirkungen, die zum Teil deutlich umfangreicher sein können als bei anderen Applikationsformen. Neben dem erhöhten zeitlichen Aufwand bei der Betreuung dieser Patienten müsste sich der Apotheker zusätzlich Kenntnisse über das Nebenwirkungsmanagement - inklusive Nocebo-Effekte - aneignen, damit ein adäquates Nebenwirkungsmanagement durchgeführt werden könnte. Ob dies allein durch Fortbildungen vermittelbar ist, oder ob nicht praktische Erfahrungen mit den unterschiedlichen Präparaten notwendig sind, wie sie z.B. im Rahmen einer Facharztausbildung vermittelt werden, ist aktuell unklar.

Diese Art der ausführlichen Betreuung und Aufklärung setzt spezielle Kenntnisse über die verschiedenen Applikationsformen und die Möglichkeit voraus einzuschätzen, ob der individuelle Patient den entsprechenden Applikationsformen gewachsen ist. Die Leitlinie der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung beschreibt den aktiven Austausch zwischen Patient und Apotheker, um dem Apotheker die Chance zu geben die individuellen Bedürfnisse des Patienten einzuschätzen. Eine Vertraulichkeit dieser Apotheker-Patientenberatung ist dafür zwingend erforderlich.

Weiterhin beinhalten unterschiedliche Präparate mit identischem Wirkstoff auch unterschiedliche Hilfsmittelformen, welche bei einigen Präparaten beigelegt sind, aber bei anderen Präparaten gesondert verordnet werden müssen. Dazu zählen unter anderem Injektionspistolen und Spritzenpumpen. Diese Tatsache kann den Prozess der Substitution noch einmal zusätzlich verkomplizieren. Hier würde unter Umständen ein regelmäßiger zusätzlicher Aufwand bei der Verordnung von Hilfsmittelrezepten sowohl auf den Apotheker als auch auf den Facharzt zukommen.

Darüber hinaus müssten, ähnlich wie in einer Arztpraxis, auch in der Apotheke gewisse räumliche Voraussetzungen gegeben sein. Bei lokalen Injektionsnebenwirkungen, z.B. Rötungen an der Einstichstelle, bestünde das nachvollziehbare Bedürfnis des Patienten, diese dem Apotheker auch zu demonstrieren. Dazu müssten die entsprechenden Räumlichkeiten mit Sicht- und (aus Datenschutzgründen selbstverständlich) auch Hörschutz ausgestattet sein. Die Verkaufsräume in vielen Apotheken erfüllen diese Kriterien zur Zeit nicht, und sind damit ungeeignet. Würden diese baulichen Gegebenheiten als Bedingung vorausgesetzt, besteht die Gefahr, dass sich nicht alle Apotheker an der Substitution beteiligen könnten. Dies würde insbesondere ein Problem für die wenig mobilen Patienten mit chronisch-entzündlichen Systemerkrankungen darstellen. Wie diese höheren zeitlichen und räumlichen Anforderungen sich in der Budgetierung der pharmazeutischen Dienstleistungen auswirken würden, ist aktuell nicht klar.

Weiterhin müsste eine Klärung bezüglich des primär verantwortlichen Ansprechpartners bei Komplikationen, z. B. bei Reaktionen an der Einstichstelle, und eine Regelung der Medikamentenrücknahme bei Komplikationen/fehlender Bereitschaft des Patienten das Präparat weiter einzunehmen, erfolgen. Eine weitere Herausforderung wäre, dass der Patient nach der Information durch seinen Apotheker wahrscheinlich regelhaft zusätzlich eine erneute Konsultation durch seinen Arzt suchen würde, was zu einer Ausweitung der Ressourcen führen könnte. Außerdem bestünde das Risiko, dass Patienten mit zwei verschiedenen Ansprechpartnern konfrontiert wären, was ein zusätzliches Konfliktpotential birgt. Dieser Konflikt zwischen verschiedenen Meinungen hat das Potential die Therapieadhärenz herabzusetzen [179].

Die beschriebenen Szenarien legen außerdem nahe, dass es zu einer zusätzlichen Beanspruchung der knappen Ressource des Facharztes kommen könnte, was die ohnehin bestehende Versorgungslücke nur weiter vergrößern würde. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang unklar, ob eine zeitnahe fachärztliche Vorstellung überhaupt möglich wäre. Falls dies in der Praxis nicht umgesetzt werden kann, würde sich das Risiko von Medikamentenpausen erhöhen und dadurch ein Adhärenzverlust entstehen. Das wiederum kann die Prognose der Erkrankung erheblich verschlechtern und steigert die Kosten für das Gesundheitssystem in einem nicht unerheblichen Maß [180].

[...] Eine Umstellung eines Biosimilars auf ein anderes Biosimilar von einem Arzt ist für den Patienten in Ordnung, aber nicht die Umstellung eines vom Arzt verordneten und ihm in jeder Hinsicht erläuterten Biosimilars durch die Apotheke auf ein anderes Biosimilar - Stichwort Compliance. Bei der Substitution durch die Apotheke zur Selbstapplikation durch den Patienten besteht kein Arztkontakt mehr und der Nocebo-Effekt ist somit maßgeblich verschärft. Dies widerspricht sämtlichen fachlichen Vorgaben zur ärztlichen Überwachung nach Substitution, die in zahlreichen Fachquellen belegt ist [...].

Hier wäre jedenfalls eine maßgebliche Aufklärungsarbeit seitens der Apotheke zu leisten, die diese in der Form zum aktuellen Stand jedenfalls nicht bringen kann. Als Beispiel sei wiederum Hulio genannt - wenn der Arzt dem Patienten Hulio verordnet und ihn diesbezüglich aufklärt,

179 Seehausen M, Hänel P (2011): Arzt-Patienten-Kommunikation: Adhärenz im Praxisalltag effektiv fördern. Deutsches Ärzteblatt 43. Deutsches Ärzteblatt International;7724-80.

180 Der Arzneimittelbrief: Zehn Vorschläge zur Verbesserung der Adhärenz in der Arzneimitteltherapie. Jahrgang 48 (5). 2014.

stellt die Arzthelferin den Patienten auf dieses Device ein, dann geht er zur Apotheke und erhält Hyrimoz, zu dem er überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Hier stellt sich die Frage nach der Schulung und die Frage, ob jedes Mal bei der Umstellung neu geschult wird und wer dies wie leistet. Dies ist ein maßgebliches Compliance Thema, denn der Patient muss ja wissen, was er wie einnimmt – wenn dieses neue System nicht reibungslos funktioniert sind letztlich keine Kostenersparnisse zu erwarten und stattdessen wird das bestehende Biosimilar-System, das funktioniert und massive Einsparnisse erbringt [181], in Frage gestellt – auf der Ebene der Selbstverwaltung, entgegen der Entscheidungen auf politischer Ebene – bevor die Fehler der Vergangenheit auf politischer und gesetzgeberischer Ebene korrigiert werden können.

[...] Dabei ist zu beachten, dass bei Umsetzung der Substitution von Biopharmazeutika diese zwingend mit der arzneimittelrechtlichen Verpflichtung zur Pharmakovigilanz vereinbar gestaltet werden muss.

So stellt sich die Frage, wie im Rahmen der Pharmakovigilanz bestimmte Symptome dokumentiert werden sollen. Hier müsste die Dokumentation durch den Ersterfasser, also durch den Apotheker erfolgen, um eine verlässliche Dokumentation zu gewährleisten. Zusätzlich wäre eine Kommunikation mit den Verordnern erforderlich. Die dafür notwendige Infrastruktur müsste erst geschaffen werden.

Im Rahmen der Regelung des Absatzes 4 könnte die Position B2 als Möglichkeit verstanden werden, hier zu einer Lösung zu führen, in dem danach der Apotheker oder die Apothekerin gewährleisten muss, dass bei einer Ersetzung der verordnende Arzt oder die verordnende Ärztin über das ausgegebene Präparat informiert wird, soweit der Patient oder die Patientin in die Weitergabe der personenbezogenen Patientendaten an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin ausdrücklich einwilligt. Auch dieser Vorschlag erfüllt allerdings nicht die vorhandenen Pharmakovigilanz-Anforderungen.

Hexal

Im geplanten § 40c Abs. 4 AM-RL wird die Vermeidung der Nocebo-Effekte und die Förderung von Therapieadhärenz in allen Positionen (A, B1+B2) als Zielsetzung genannt. Zum Hintergrund des Nocebo-Effekts und Diskussion der umfassenden Evidenz verweisen wir erneut auf unsere Stellungnahme vom 19. Mai 2022.

In § 40a AM-RL ist die ärztliche Informationspflicht bei der Umstellung einer Biologika-Therapie explizit mit aufgenommen worden. Die adäquate ärztliche Aufklärung und Beratung werden als wesentlicher Bestandteil in der Vermeidung von Nocebo-Effekten und der Stärkung der Therapieadhärenz betont. Damit wurden durch den G-BA die besonderen Umstände bei Biologika-Verordnungen anerkannt und die Notwendigkeit der Aufklärung insbesondere bei Umstellungen aus nicht-medizinischen Gründen. Die Diskussion des Nocebo-Effekts und die Unsicherheit darüber, wie dieser bei einer automatischen Substitution von Fertigarzneimitteln in der Apotheke zu verhindern ist, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die automatische Substitution vom Gesetzgeber zeitlich aufgeschoben und mit der Einschränkung auf die zunächst zu regelnde Substitution von biologischen Fertigarzneimitteln von parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung konkretisiert wurde. Den Bedenken hinsichtlich des Nocebo-Effekts, der insbesondere bei der Therapieanwendung durch den Patienten außerhalb der Arztpraxen auftreten kann, wird durch die Regelung im § 40b entsprechend nachgekommen, da der Arzt weiterhin aktiv in die Therapiebetreuung des Patienten eingebunden und der Patient nicht im Kontakt mit dem eigentlichen Arzneimittel ist.

Die genannten Hintergründe zur Einstellung des ursprünglichen Stellungnahmeverfahrens um § 40b im Dezember 2022 bestehen allerdings weiterhin. Einerseits eignen sich potenzielle Erfahrungen aus der Umsetzung der automatischen Substitution im Bereich der parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung nicht, um die Auswirkungen einer

automatischen Substitution von Fertigarzneimitteln zur patienteneigenen Anwendung auf mögliche Nocebo-Effekte zu beurteilen. Eingangs haben wir bereits diskutiert, dass derzeit keine Evaluation der Auswirkungen von § 40b öffentlich zugänglich ist. Andererseits gibt es keine wissenschaftlichen Studien, die den Erfolg von Strategien zur Vermeidung von Nocebo-Effekten im Rahmen der automatischen Substitution in der Apotheke untersucht. Zwar analysiert eine aktuelle systematische Literaturreview Strategien zur Minimierung des Nocebo-Effekts [169]. Allerdings sind sämtliche identifizierten (Kommunikations-)Strategien durch den Arzt anzuwenden. Im Fazit wird empfohlen, eine Kombination von verschiedenen Ansätzen zur Mitigierung des Risikos für einen Nocebo-Effekt einzusetzen, und zwar **vor** der Umstellung im Rahmen der partizipativen Entscheidungsfindung, **während** der Umstellung und im **Follow-up** der Anwendung.

Unter der derzeit geplanten Regelung des § 40c AM-RL wird es die Situation geben, dass das vom behandelnden Arzt verschriebene Arzneimittel automatisch ausgetauscht wird. Dadurch wird **erstens** die bereits geleistete **Beratungs- und Aufklärungsarbeit durch den behandelnden Arzt** nutzlos. Alle beratenden Informationen des behandelnden Arztes beziehen sich naturgemäß auf das verordnete Arzneimittel. Informationen zu produktspezifischen Eigenschaften des Arzneimittels gelten mitunter nicht mehr vollumfänglich, sobald das Arzneimittel in der Apotheke ausgetauscht wurde. Dies kann den Patienten im weiteren Therapieverlauf verunsichern und beeinträchtigen. Zudem verwendet der behandelnde Arzt Ressourcen für eine ärztliche Leistung, die im Nachgang durch die automatische Substitution in der Apotheke konterkariert werden.

Zweitens wird das **Patientenaufklärungsgespräch** gemäß § 630c Abs. 2 BGB, das die wesentlichen Aspekte der Behandlung abdecken soll, erneut notwendig und **auf die Apotheker übertragen**. Eine Beratung auf der Ebene, wie sie im ärztlichen Therapiegespräch zwischen Arzt und Patient stattfindet, ist jedoch in der Apotheke nicht möglich. Der Arzt hat bei der Therapiewahl den ganzheitlichen Blick auf den Patienten, mit allen weiteren Begleittherapien, Komorbiditäten, Vorerkrankungen, Allergien und Unverträglichkeiten. Die Informationsgrundlage der Apotheker ist diesbezüglich unzureichend, um eine valide Entscheidung für oder gegen einen automatischen Austausch zu treffen. Es wäre durch den Apotheker eine Anamnese bei dem Patienten durchzuführen, um die molekül-, produkt- und patientenindividuellen Faktoren, die zu der Therapieentscheidung geführt haben, nachvollziehen zu können. Weder erlegt der G-BA dem Apotheker eine entsprechende Prüfpflicht auf noch wäre diese mit dem Verbot der Ausübung der Heilkunde vereinbar. Es bleibt eine Lücke in der adäquaten Prüfung der therapeutischen Sachlage, wenn es zu einem generalistischen Austausch in der Apotheke kommt.

Erschwerend kommt hinzu, dass im Kontext einer stetig sinkenden Anzahl an Vor-Ort-Apotheken die Versandapotheken an Bedeutung gewinnen. Für 2024 zählt die ABDA in der aktuellen Ausgabe ihres Statistischen Jahrbuchs 530 weniger Apotheken (-3%) als noch in 2023. Gegenüber 2015 sind es sogar 3.208 Apotheken weniger (-16%). Der Anteil von Versandapotheken an den GKV-Arzneimittelausgaben ist zwar noch gering (ca. 1%), ist allerdings 2024 gegenüber 2023 um knapp 60% gestiegen. Mit Anlaufen des E-Rezepts und aggressiveren Kommunikationsstrategien ist ein weiterer Anstieg zu erwarten. Im Bereich der Selbstmedikation haben die Versandapotheken 2024 bereits einen Marktanteil von knapp 23% (Umsatz effektive Verkaufspreise) mit einer Veränderung von +11,5% gegenüber 2023, während die öffentlichen Apotheken umsatzbasiert nur um 2,6% wachsen. Offen bleibt die Frage, in welchem Umfang die erforderliche Beratungsleistung vor allem beim Wechsel auf ein Produkt mit einer anderen Handhabung sichergestellt werden kann. Auch für Versandapotheken gilt die Verpflichtung gemäß § 20 Apothekenbetriebsordnung, eine ausreichende Beratung für die Patienten durch pharmazeutisches Personal zu garantieren. Allerdings ermöglicht § 17 Abs. 2 S. 6 Apothekenbetriebsordnung eine Beratung im Wege der Telekommunikation, wodurch aber z.B. die Demonstration oder Schulung eines spezifischen Fertigpens oder Fertigspritze massiv erschwert ist, weil die Nutzung nicht haptisch durch den

Patienten erfolgt. Beratungsangebote sind darüber hinaus mitunter nur eingeschränkt erreichbar, wie dies z.B. die Verbraucherzentrale auf ihrer Homepage beschreibt.

Das Fazit bleibt: Eine partizipative Therapieentscheidung sowie Therapiebetreuung unter Einbeziehung des Arztes, der das individuelle Krankheitsbild und Prädisposition des Patienten als zentrale und beständige Vertrauensperson kennt, ist unabdingbar. Mit einer automatischen Substitution in der Apotheke wird die Therapieentscheidung und sämtliche darauf aufbauende Beratung durch den Arzt hinfällig und verlagert die Patientenbedürfnisse in einer komplexen Therapiesituation auf eine Ebene, die diesen nicht vollumfänglich gerecht werden kann.

Sanofi

Der Verweis auf die gesetzlichen Regelungen zu Information und Beratung in Apotheken bei Abgabe von Arzneimitteln ist zur Aufrechterhaltung der Therapiesicherheit in diesem Zusammenhang sicherlich unzureichend. Es ist gängige und notwendige Praxis im Rahmen der Initiierung einer Therapie mit biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen, die von den Patient:innen alleine appliziert werden sollen, dass die Handhabung der Applikation den Patient:innen von den behandelnden Ärzt:innen (oder vom medizinischen Fachpersonal) demonstriert werden, um eine nachfolgend korrekte häusliche Selbstapplikation sicherzustellen (AM-RL § 40a). Diese Praxis sollte auch bei Einführung des geplanten § 40c AM-RL weiterhin sichergestellt sein, insbesondere da diese Fertigarzneimittel mittlerweile in einer Vielzahl verschiedener Fertigspritzen (mit unterschiedlichen Sicherheitssystemen) angeboten werden. Überdies greifen viele Hersteller auf Ihre eigenen automatisierten Fertigpens (Autoinjektoren) zurück, deren Handhabung stets individuell ist und deren Applikationsvorbereitung und Verwendung einer Schulung bedarf. Auch bei der durch die Apotheken initiierten Substitution bedarf es demnach einer Demonstration der Handhabung des neuen Arzneimittels durch die Ärzt:innen (oder das medizinische Fachpersonal).

ABDA, AMK

Grundsätzlich hielten wir eine Austauschbarkeit von Biosimilars nach Festlegung durch den G-BA in den Apotheken für möglich. Da jedoch unsere bislang vorgetragene Kritik zu den Richtlinienentwürfen aus unserer Sicht nicht ausreichend gewürdigt wurde, sehen wir uns weiterhin zu einer **Ablehnung der Austauschverpflichtung von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln nach Festlegung durch den G-BA in den Apotheken veranlasst.**

Ungeachtet der engen Zulassungskriterien der EMA, ist die Anzahl der Studien zum Austausch von Biosimilars (Häufigkeit, Arzt-induziert, nicht Arzt-induziert) weiterhin sehr gering; zu einem rabattvertragsinduzierten Austausch in öffentlichen Apotheken sind uns keine Studien bekannt. [...]

Die vorgesehene Änderung vom bislang geltenden Austauschverbot von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln hin zu einer grundsätzlichen Austauschverpflichtung in Apotheken, geht mit einem deutlich über das übliche Maß hinausgehenden Beratungsaufwand einher, der – nach näherer Festlegung in der Arzneimittelpreisverordnung oder im Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V – adäquat vergütet werden muss.

In den darüber hinausreichenden, spezifischen Festlegungen zur Regelung der Information und Beratung in Apotheken, insbesondere von weitreichenden Dokumentations- und Informationspflichten gegenüber den verordnenden Ärzten und unter Berücksichtigung patientenseitiger Einwilligungserklärungen zur Weitergabe personenbezogener Daten, erkennen wir eine Überschreitung des gesetzgeberischen Auftrags an den G-BA, der allein wirkstoffspezifische Hinweise zur Austauschbarkeit zu geben hat.

Aussagen zu von den Apotheken bei der substitutionsbedingten Abgabe von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln zu erbringenden Zusatzleistungen überschreiten die durch den Gesetzgeber übertragene Kompetenz des G-BA und werden strikt

abgelehnt. Der guten Ordnung halber weisen wir schon hier darauf hin, dass diese Zusatzleistungen keinesfalls ohne entsprechendes zusätzliches Entgelt erbracht werden könnten.

[...] Die ABDA erachtet eine adäquate Patientenschulung im Sinne einer wirksamen, sicheren und verträglichen Therapie und zur Gewährleistung der Patienten- und Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS), der Therapietreue (Adhärenz) sowie Pharmakovigilanz als unabdingbar.

Die durch Position B2 vertretene Konkretisierung von Beratungs- und Dokumentationspflichten der Apotheken wird hingegen abgelehnt. Hier werden Forderungen nach Zusatzleistungen der Apotheken im Rahmen der substitutionsbedingten Abgabe von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln formuliert. Wie vorab ausgeführt, überschreitet der G-BA hiermit seine Zuständigkeit.

Nach § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V soll der G-BA in der Arzneimittelrichtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken geben. Dies umfasst – in Modifizierung der grundsätzlichen Austauschregelungen nach § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V – einzelne Kriterien betreffend das Verhältnis von verordnetem und abzugebendem Arzneimittel.

Vom Auftrag an den G-BA nicht erfasst sind weitere Leistungen der Apotheken. Die Leistungen der Apotheken werden an verschiedenen Stellen der einschlägigen apotheken- und sozialrechtlichen Gesetze und Verordnungen näher beschrieben. Dieses Leistungsportfolio kann nicht ohne gesetzlichen Auftrag durch eine untergesetzliche Norm wie die Arzneimittelrichtlinie erweitert werden.

Gegebenenfalls kann der G-BA eine Substitution ausschließlich unter dem Vorbehalt erlauben, dass anderweitig entsprechende besondere Informations- und Beratungspflichten der Apotheken festgelegt werden.

Der guten Ordnung halber weisen wir schon hier darauf hin, dass Zusatzleistungen im Bereich der Patientenschulung und Dokumentations- und Informationspflichten, einschließlich datenschutzrechtlicher Aspekte mit erheblichem Zusatzaufwand verbunden sind und dementsprechend von den Apotheken keinesfalls ohne angemessenes Entgelt erbracht werden können.

Das Patientenkollektiv, welches eine Therapie mit biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln bedarf, ist jedoch häufig komplex, schwerstkrank und u. U. körperlich sowie kognitiv nicht in der Lage, den Anforderungen der Handhabung einer Applikation des neuen Arzneimittels zu entsprechen. Besondere Umstände der Patienten in Betreuungseinrichtungen, wie z. B. Pflege- und Altenheimen, sind hinsichtlich des besonderen Beratungs- und Schulungsaufwandes der Apotheken zudem gesondert zu berücksichtigen und zu honorieren.

Darüber hinaus haben die genannten Leistungen, die Apothekerinnen und Apotheker im Rahmen der substitutionsbedingten Abgabe von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln leisten sollen, in einem persönlichen Rahmen – unter Wahrung der Vertraulichkeit sowie unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen – stattzufinden („abgetrennter Raum“). In der Gesamtschau bedingen diese Prämissen eine persönliche Beratung und Schulung der Patienten, d. h. ‚face-to-face‘. Neben weiteren Gründen schließt dies den Versandhandel mit diesen Arzneimitteln aus.

Die pauschal geforderten Dokumentations- und Informationspflichten der Apotheke an den verordnenden Arzt oder die verordnende Ärztin, lehnen wir strikt ab. Hier werden die notwendigen Verantwortlichkeiten im Sinne der Gewährleistung der Pharmakovigilanz einseitig den Apotheken übertragen, in Verbindung mit einer verpflichtenden Einwilligungserklärung zur Weitergabe personenbezogener Daten. Diese Forderung (Position B2) ist somit auch logisch nicht haltbar, setzt sie doch die patientenseitige Zustimmung einer Gewährleistungspflicht der Apotheken voran.

Ergänzend verweisen wir erneut auf die unbedingten Erfordernisse eines robusten, IT-unterstützten Rahmens, der einen automatisierten Informationsaustausch zwischen Apotheke und Arzt ermöglicht.

ADKA

Die vorgeschlagene Position B2 wird insbesondere in Bezug auf die vorgesehenen Informationspflichten der Apotheken an die verordnenden Ärztinnen und Ärzte im Falle der Abgabe eines ausgetauschten Präparates von der ADKA abgelehnt.

Ein solcher Informationsaustausch kann im Grundsatz nur dann sinnvoll sein, wenn er im Umfeld der Telematikinfrastruktur erfolgt – automatisiert, standardisiert und datenschutzkonform. Nicht konkretisierte, manuelle oder papiergebundene Prozesse sind weder praxistauglich noch sicher und würden die Abläufe in der Apotheke und bei den verordnenden Ärztinnen und Ärzten zusätzlich belasten.

Pharma Deutschland

Der explizite Bezug auf die nach § 20 Apothekenbetriebsordnung genannten Regeln zur Information und Beratung sind insofern nachvollziehbar, dass die Austauschbarkeit von Biosimilar besonderen Rahmenbedingungen unterliegt. Eine jeweilige Information des Arztes über den Austausch ist nach derzeitigem Stand nur elektronisch über die jeweiligen Chargen-/Dispensierinformationen des E-Rezeptes i. V. m. der elektronischen Patientenakte in der Versorgung umsetz- und abbildbar. Dieser Weg sollte jedoch aus Sicht von Pharma Deutschland genutzt werden, ob die immer noch fehlende Evidenz insbesondere bei einem Mehrfachwechsel, bspw. über das Forschungsdatenzentrum Gesundheit, zu erheben.

VZA

Die Pflichten der Apotheken in Sachen Beratung ergeben sich schon aus § 20 ApBetrO. Sie müssen und können von vornherein nicht gesondert in der AM-RL des G-BA geregelt werden. Der G-BA hat keinerlei Kompetenz, die Pflichten aus der ApBetrO neu oder anders zu fassen. Auf die Regelung in Absatz 4 ist daher schon aus Gründen mangelnder Kompetenz zu verzichten.

Die angestrebte Regelung geht zudem über die Anforderungen in § 20 ApBetrO hinaus und wird in die Nähe einer gesonderten Schulung der Patienten und erweiterten Medikationsberatung gerückt. Das verwundert in der Sache nicht, berücksichtigt man, dass mitunter 8 oder mehr unterschiedliche Applikationssysteme (Devices) für einen biologischen Wirkstoff auf dem Markt sind. Das Aufklärungs- und Erklärungsaufkommen in den Apotheken wird zwangsläufig immens sein. Es stellt sich insoweit zwangsläufig die unbeantwortete Frage nach der Vergütung für die erweiterten Leistungen der Apotheken.

Es ist zudem sinnvoll und aus Gründen der Pharmakovigilanz auch geboten, dass die behandelnden Ärzte im Falle einer Substitution eines verordneten Referenzarzneimittels durch ein bestimmtes Biosimilar davon IT-gestützt und verlässlich erfahren, um die entsprechenden Informationen in ihrer Therapiekontrolle zu berücksichtigen, zu ihrer ärztlichen Dokumentation nehmen und ggf. ihren Meldepflichten nachkommen zu können.

Würde sich der G-BA auf seinen Regelungsauftrag begrenzen, den Austausch von einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar verbindlich zu regeln, wären die damit verbundenen Fälle überschaubar und handhabbar. Angesichts des Zulassens unbeschränkte Mehrfachsubstitutionen von Biosimilar zu Biosimilar erwarten wir eine strukturelle Pharmakovigilanzlücke, die durch die untergesetzliche Normgebung des G-BA geschaffen wird.

Derzeit fehlt es an einer gesetzlichen Vorgabe für einen sicheren automatisierten Informationsaustausch zwischen abgebender Apotheke und verordnender Arztpraxis. Jedenfalls führt auch der G-BA dazu in seinen Tragenden Gründen nichts aus.

DGRh

Somit ist davon auszugehen, dass ein solcher Präparatewechsel in Apotheken bei vielen Patientinnen und Patienten Verunsicherung und zusätzlichen Beratungsbedarf hervorruft. Es ist daher unabdingbar, dass im Falle eines Präparatewechsels durch die Apotheke die verordnenden Ärztinnen und Ärzte routinemäßig – schriftlich oder mündlich – über den neuen Handelsnamen des abgegebenen Arzneimittels informiert werden. Diese Information muss dokumentiert werden.

Entsprechend § 20 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) sind Apotheken zur Beratung verpflichtet. Außerdem sieht § 17 Abs. 5 ApBetrO vor, dass die Apotheke bei Vorliegen von Bedenken und unter Berücksichtigung der individuellen Patientensituation von einer Substitution absehen kann. An die Erfüllung dieser Beratungspflicht und an die Wahrnehmung dieser Möglichkeit werden daher besondere Anforderungen gestellt.

[...] Der Unterschied zwischen einem kontrollierten, ärztlich begleiteten Wechsel und einem nicht dokumentierten, apothekengesteuerten Austausch, wie auch der Wechsel zwischen multiplen Präparaten sind daher aus Sicht der DGRh zentrale Risikofaktoren der neuen Regelung und müssen in der Abwägung explizit berücksichtigt werden.

DGVS, gemeinsam mit Kompetenznetz Darmerkrankungen e. V. und bng

[...] Die weitergehende Patientenaufklärung zu den Gründen und verschiedenen Applikationsformen mit verschiedenen Pens oder Fertigspritzen ist in Apotheke schlecht in dem notwendigen vertraulichen Umfeld, der erforderlichen Diskretion bei dem Gespräch und mit der notwendigen Fachkenntnis durchzuführen, da verständlicherweise in der Apotheke nicht die entsprechende Spezialisierung auf solche speziellen Beratungen im Hinblick auf Biologika vorliegen kann, wie dies in den Fachpraxen mit zusätzlich qualifiziertem Assistenzpersonal (CED-Fachassistenz) der Fall ist.

[...] Eine mögliche Diskussion, um einen Austausch anhand von klaren Regeln in der gastroenterologischen Praxis in Verbindung mit der Beratung und Anleitung durch eine speziell weitergebildete CED-Fachassistenz im Rahmen einer Delegation innerhalb der Praxis, wodurch die Individualität und fachliche Qualität der Beratung im Gegensatz zur offenen Offizin einer Apotheke gewährleistet wäre, könnte aus unserer Sicht in der Gesamtbeurteilung unter Berücksichtigung der genannten Aspekte dementsprechend auch anders ausfallen, wenn eben die Substitution unter Einbindung der Patienten von ärztlicher Seite fachlich qualifiziert begleitet erfolgen würde.

Bewertung zu den Einwänden 3.4.1 bis 3.4.3:

Ein Großteil der Stellungnehmenden erachtet die Beratung und Schulung der Patienten als wichtigen Baustein zur Vermeidung von Verunsicherung, Anwendungsfehlern und Nocebo-Effekten sowie zur Förderung der Therapieadhärenz. Für die Beratung und Aufklärung seien spezielle Kenntnisse über die verschiedenen Injektionshilfen/Devices – teilweise als Hilfsmittel separat verordnet – nötig. Des Weiteren gebe es zu berücksichtigende Unterschiede zwischen den Produkten im Hinblick auf die zugelassenen Anwendungsgebiete, die Formulierungen sowie die Lagerungsbedingungen. Zur Berücksichtigung von Darreichungsformen, Anwendungsgebieten und Produkteigenschaften siehe Bewertung zu den Einwänden 3.1.2, 3.1.4 und 3.1.6.

Sowohl in schriftlichen Stellungnahmen als auch im Rahmen der mündlichen Anhörung wird darauf hingewiesen, dass die Demonstration anhand eines Musters zwar sinnvoll wäre, dafür allerdings sämtliche Apotheken zeitnah entsprechende Demo-Devices benötigen. Aus der Sicht von Stellungnehmenden müsse bei der Demonstration der Handhabung des Arzneimittels zudem die Vertraulichkeit und der Schutz persönlicher Daten gewährleistet werden. Da die Beratung im Rahmen einer Ersetzung biologischer Arzneimittel folglich über den „normalen“ Beratungsaufwand hinausgehe, wird von Stellungnehmenden eine zusätzliche Vergütung gefordert. Die Vergütung von pharmazeutischer Beratung liegt nicht im Regelungsbereich der AM-RL bzw. des G-BA. Ergänzend wird an dieser Stelle auf den aktuellen

Referentenentwurf zum Gesetz zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz – ApoVWG) [182] hingewiesen, wonach vorgesehen ist, eine weitere pharmazeutische Dienstleistung „Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Autoinjektoren“ einzuführen.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass auch nach den Regelungen in § 40a AM-RL bei Umstellung eine Beratung sowie die Demonstration der Handhabung der Applikation des Arzneimittels durch den Arzt vorgeschrieben sei. Viele Stellungnehmende erachten eine adäquate Beratung zu den konkreten Präparaten und deren Nebenwirkungen nur auf ärztlicher Ebene (mit Unterstützung der Fachassistenz) als möglich. Informationen zum speziellen Krankheitsverlauf, den individuellen Krankheitsmerkmalen sowie die Einstellung der Betroffenen zur Erkrankung und zu den unterschiedlichen Behandlungsmaßnahmen seien nur den Behandelnden bekannt. Insofern könne nur ärztlicherseits am besten eingeschätzt werden, mit welchem Arzneimittel bzw. welcher Applikationshilfe am besten umgegangen werden könne.

Es wird vorgebracht, dass sich Apotheker zusätzlich Kenntnisse über das Nebenwirkungsmanagement – inklusive Nocebo-Effekte – aneignen müssten, damit ein adäquates Nebenwirkungsmanagement durchgeführt werden könne. Außerdem sei unklar, wer Ansprechpartner bei Komplikationen, z. B. bei Reaktionen an der Einstichstelle sei. Dazu ist zu entgegnen, dass die grundsätzliche Meldeverpflichtung von Nebenwirkungen für Ärzte und Apotheker auch bislang schon für Biologika besteht. Vor diesem Hintergrund ist auch grundsätzlich davon auszugehen, dass durch denjenigen Heilberuf eine Meldung zur Nebenwirkung erfolgt, der im konkreten Fall Kenntnis davon erlangt.

Zusammenfassend wird einerseits in Stellungnahmen gefordert konkrete Vorgaben in Bezug auf die Beratungsverpflichtungen in der Regelung vorzusehen. Dagegen sieht eine Stellungnehmerin die Beratungspflicht durch Apotheken bei Abgabe von Biologika bereits im § 20 ApBetrO als umfasst an, sodass der Hinweis auf die Information und Beratung in Position A + B1 zur Verdeutlichung ausreiche.

Weitere Stellungnehmer sehen wiederum die weitreichenderen Regelungen der Position B2 zur Information, Beratung und Anwendungsschulung als nicht von der Regelungszuständigkeit des G-BA umfasst an.

Information und Beratung sind auch bei der Abgabe von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln sowie insbesondere bei deren Ersetzung ein wichtiger Teil der Therapie, um einerseits die Therapieadhärenz zu fördern sowie Verunsicherung, Anwendungsfehler oder subjektive Effekte wie einen möglichen Nocebo-Effekt zu reduzieren.

Nach Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen ist der G-BA weiterhin der Auffassung, dass diese Faktoren durch adäquate Aufklärung über die Ersetzung durch ein Biologikum vermindert oder sogar vermieden werden können und nicht dazu führen müssen, die Ersetzung zu unterlassen. Diese substitutionsbedingt relevanten Aspekte der Informations- und Beratungspflichten sollten daher bei der Abgabe in der Apotheke besondere Berücksichtigung finden.

Die Verpflichtung zur Beratung durch Apotheken bei Abgabe von Arzneimitteln besteht schon nach § 20 der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO). Gemäß § 20 ApBetrO muss die Beratung die notwendigen Informationen über die sachgerechte Anwendung des Arzneimittels umfassen und es ist durch Nachfrage festzustellen, inwieweit gegebenenfalls weiterer Informations- und Beratungsbedarf besteht.

182 Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz – ApoVWG), Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit vom 20. Oktober 2025, verfügbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/RefE_Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz.pdf

Die ausdrückliche Hervorhebung durch eine Regelung soll die Apotheken für den Beratungsbedarf sensibilisieren und ist zugleich Aufforderung diesem fachgerecht zu begegnen. Dazu wird Position A + B1 zu Absatz 4 in die AM-RL übernommen.

Im Übrigen sind durch Apotheken die Angaben zur Anwendung des Arzneimittels und zu den Sicherheitsanforderungen der Fach- und Gebrauchsinformationen grundsätzlich zu beachten.

Soweit trotz erfolgter Aufklärung, Schulung und Beratung durch die Apotheke bei einzelnen Patientinnen oder Patienten eine Gefährdung des Therapieerfolgs durch Nicht-Adhärenz oder Anwendungsfehler nicht vermieden werden kann, kann ein Absehen von einer Ersetzung durch die Apotheke gerechtfertigt sein. Die Möglichkeit der Apotheke von einer Ersetzung abzusehen, ergibt sich dabei aus § 40c Absatz 5. Siehe auch Bewertung der Einwände zum Absatz 5.

In den Stellungnahmen wird begrüßt, dass bei einem Austausch von Biologika in der Apotheke sichergestellt werden müsse – wie auch in Position B2 vorgesehen –, dass der Verordner oder die Verordnerin über das tatsächlich abgegebene Arzneimittel informiert wird. Nur so könnten die Anforderungen der Zulassungsbehörden an die Pharmakovigilanz (zusätzliche Überwachung, schwarzes Dreieck) gewährleistet, die Verpflichtungen zur gezielten Erfassung bestimmter Nebenwirkungen adäquat erfüllt und die Dokumentation des Therapieverlaufs in den entsprechenden Registern weiterhin ermöglicht werden.

Aus Sicht einer Stellungnehmerin wäre die Regelung einer Weiterleitung der Informationen zum abgegebenen Arzneimittel bei Austausch in der Apotheke nur sinnvoll, wenn auch die Charge mitgemeldet würde. Auch bei der Regelung zur Substitution biologischer Arzneimittel durch Apotheken in Frankreich sei die Dokumentation der Charge verpflichtend. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Vorgaben und Regelungen anderer Länder nicht für die Arzneimittelversorgung in Deutschland einschlägig sind. Zu den Regelungen anderer Länder siehe auch Bewertung zum Einwand 3.6.4.

Es wird darauf hingewiesen, dass bislang noch keine Struktur für eine sichere Datenkommunikation zwischen Arztpraxis und Apotheke bestünde. Das Erfordernis der expliziten Einwilligung in die Weitergabe der personenbezogenen Daten der Versicherten wird von Stellungnehmenden als Hürde und damit als Gefahr einer unzureichend abgesicherten und in der Konsequenz lückenhaften Pharmakovigilanz angesehen.

Es wird zudem vorgebracht, dass auch bei den Vorgaben in § 40a AM-RL auf die Bedeutung und Notwendigkeit ärztlicher Überwachung bei Umstellung hingewiesen werde. In § 6 der Musterberufsordnung-Ärzte seien zudem die vertragsärztlichen Pflichten hinsichtlich Therapiemonitoring und Pharmakovigilanz nach Umstellung von biologischen Arzneimitteln geregelt.

In einer Stellungnahme wird angeregt in den Regelungen des § 40a AM-RL eine Verpflichtung zur Information über die Möglichkeit der Ersetzung durch die Apotheke aufzunehmen. Dem Vorschlag wird nicht gefolgt.

Des Weiteren wird auf haftungsrechtliche Abgrenzungsprobleme im Schadensfall hingewiesen, da die gemäß § 62 Abs. 2 Satz 4 AMG erforderliche Dokumentation bei einem Austausch in der Apotheke unterbrochen werde. Zu Fragen der Haftung siehe auch Bewertung zum Einwand 3.6.7.

Einige Stellungnehmer sehen keine rechtliche Grundlage für derartige Regelungen zur Weiterleitung der Informationen an die Praxis durch den G-BA. Gemäß § 129 Abs. 1a Satz 5 SGB V solle lediglich die Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln festgestellt werden.

Der durch die EMA regelhaft festgelegte höhere Monitoringbedarf (*additional monitoring*, Kennzeichnung durch schwarzes Dreieck) für neu zugelassene Biologika steht einer Ersetzung von Biologika grundsätzlich nicht entgegen. Die Zulassung von Biosimilars erfolgt, wenn die

zuständige Zulassungsbehörde im jeweiligen Zulassungsverfahren zu dem Ergebnis kommt, dass diese jeweils ein vergleichbares Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil mit den entsprechenden Referenzarzneimitteln aufweisen.

Durch die in § 40c vorgesehenen Regelungen zur Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel entsteht keine neue Situation in der Apotheke, da auch bislang schon bei jeder Abgabe biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel aufgrund der Mikroheterogenität und möglichen Unterschieden zwischen einzelnen Chargen desselben Arzneimittels die Chargenbezeichnungen dokumentiert werden müssten. Seit kurzem können Apotheken regelhaft u. a. Handelsname und Chargenbezeichnung abgegebener Arzneimittel in die elektronische Medikationsliste (eML) übertragen.

Auch bei der Abgabe des verordneten Arzneimittels durch Apotheken sind ggf. entsprechende Abläufe zur Rückmeldung bzw. Weiterleitung der Daten an die Verordner notwendig.

Dem Einwand, es bestünde keine Struktur für eine sichere Datenkommunikation zwischen Arztpraxis und Apotheke, ist entgegenzuhalten, dass bislang schon u. a. zur Abklärung unklarer Verordnungen gemäß § 17 Abs. 5 ApBetrO eine derartige Kommunikation stattfinden muss. Generell wird davon ausgegangen, dass jeder Austausch zu vertraulichen Patientendaten über eine sichere Datenkommunikation erfolgt.

Sofern es zu einer Ersetzung von Biologika durch Apotheken kommt, ist davon auszugehen, dass dieser entsprechend dokumentiert wird und ggf. durch Nachfrage der Ärztinnen und Ärzte bei den Versicherten – solange die elektronische Patientenakte (ePA) dafür noch nicht vollständig nutzbar ist – Unklarheiten in Bezug auf das konkret angewendete Arzneimittel beseitigt werden können.

Regelhaft kann eine Dokumentation von Handelsnamen und Charge des zur Anwendung kommenden biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittels darüber hinaus durch den Arzt oder die Ärztin in den Fällen selbst vorgenommen werden, bei denen die Arzneimittel unmittelbar ärztlich appliziert werden.

Der G-BA gibt auf Grundlage seines Regelungsauftrags Hinweise zur Umstellung durch Ärzte sowie zur Ersetzung der verordneten Biologika durch Apotheken; die Konkretisierung der Vorgaben zum Informationstransfer insbesondere bei einer Ersetzung durch Apotheken sind jedoch nicht Gegenstand des Regelungsauftrags. Ein zusätzlicher Satz zur Dokumentationspflicht in Absatz 4 ist vor diesem Hintergrund entbehrlich und wird nicht in die AM-RL übernommen. Daraus ist nicht abzuleiten, dass die Bedeutung der notwendigen Dokumentation zur Gewährleistung von Pharmakovigilanz nicht gewürdigt wird. Aus Sicht des G-BA ist dies aber keine Voraussetzung für eine Ersetzung von Biologika durch Apotheken wie sie § 40c vorsieht. Zur Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit siehe auch Bewertung zum Einwand 3.6.8.

Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits im Stellungnahmeverfahren zum Beschluss vom 15. Juni 2023 zur Ergänzung des § 40b (neu) in der AM-RL befasst. Es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in der Zusammenfassenden Dokumentation zum entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/>).

3.5 Einwände zum Absatz 5

AbbVie

Die detaillierte Auflistung von patientenindividuellen Gründen, unter denen sich Apotheker gegen die automatische Substitution entscheiden können, ist zu begrüßen (siehe Tragende Gründe zum Beschlussentwurf). Schließlich ist der Apotheker, nach dem verordnenden Arzt, die nächste Anlaufstelle, die sich mit dem Patienten und dessen Belangen direkt auseinandersetzt. Es muss dem Ermessen des Arztes und des Apothekers vertraut werden, chronisch-kranken

Patienten die passende Biologika-Therapie und das dafür passende Arzneimittel zu verordnen und abzugeben. Dies darf nicht zum Regress, bzw. Retax führen.

Amgen

Der Hinweis auf die Möglichkeit für Apotheken, Substitutionen nicht durchzuführen, wird grundsätzlich von Amgen begrüßt. Allerdings sind die Möglichkeiten der Ablehnung einer Substitution in Apotheken eingeschränkt. Zudem nutzen Patient:innen vermehrt Online-Apotheken, bei denen die Nutzung dieser Möglichkeit noch unwahrscheinlicher sein dürfte. Grundsätzlich dient die Möglichkeit der Ablehnung einer Substitution durch die Apotheke nicht dazu, die Sinnhaftigkeit einer Substitution für die Therapie der Patient:innen zu prüfen. Die Therapieentscheidung sowie die Verantwortung für die Therapie liegt in den Händen der Ärzteschaft und die Regelungen der Substitution von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln muss so gestaltet werden, dass der behandelnde Arzt / die behandelnde Ärztin die vollständige Kontrolle über die Therapie behält. In verschiedenen Phasen der Therapie von z. B. chronischen Erkrankungen wie Einstellung oder Umstellung auf eine neue Therapie oder Therapieeskalation ist dies besonders wichtig, auch wenn die Therapieeinstellung oder -umstellung mehrere Monate dauert. Für diese Therapiephasen bedeutet die vorgeschlagene Regelung, dass der behandelnde Arzt / die behandelnde Ärztin regelhaft die Substitution ausschließen müsste. Dies entspricht nicht der gesetzlichen Regelung zum Substitutionsausschluss, die sich nur auf medizinisch begründete Ausnahmefälle bezieht.

Biogen

Die in Absatz 5 vorgesehene Möglichkeit, bei Vorliegen sonstiger Bedenken von einer automatischen Substitution abzusehen, ist aus Sicht der Patientensicherheit und Versorgungsqualität zwingend erforderlich und wird ausdrücklich begrüßt. Apotheken müssen in der Lage sein, patientenindividuelle Risiken zu erkennen und entsprechend zu handeln. Insbesondere dann, wenn die Verordnung unklar ist oder konkrete Bedenken hinsichtlich der Anwendung bestehen. In der Praxis ist dies jedoch erschwert, da Apotheker in der Regel keinen Zugriff auf die vollständige Abgabehistorie eines Patienten haben. Ohne diese Informationen ist es kaum möglich, potenziell risikobehaftete Wechsel zu erkennen, wie etwa bei mehrfachen Substitutionen innerhalb kurzer Zeit oder bei bekannten Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Hilfsstoffen. Eine fundierte Entscheidung über das Absehen von der Substitution setzt jedoch genau diese Kontextinformationen voraus.

Die Bezugnahme auf § 17 Absatz 5 ApBetrO ist sachgerecht, da dieser bereits heute vorsieht, dass Arzneimittel nicht abgegeben werden dürfen, wenn die Verschreibung unleserlich ist, einen erkennbaren Irrtum enthält oder sonstige Bedenken bestehen. Diese Regelung muss im Kontext biotechnologisch hergestellter Arzneimittel besonders ernst genommen werden, da hier – anders als bei klassischen Generika – produktspezifische Unterschiede in Formulierung, Handhabung und Applikation bestehen, die erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit und Wirksamkeit der Therapie haben können.

Ein Absehen von der Substitution ist insbesondere dann gerechtfertigt, wenn in der Vergangenheit Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Allergien im Zusammenhang mit bestimmten Arzneimitteln aufgetreten sind. Ebenso ist Zurückhaltung geboten, wenn eine instabile Therapiesituation vorliegt, die eine Umstellung potenziell riskant macht. Auch Zweifel an der sicheren Anwendung durch den Patienten – etwa aufgrund eingeschränkter Feinmotorik, kognitiver Beeinträchtigungen oder fehlender Schulung – können ein triftiger Grund sein, von der Substitution abzusehen. Darüber hinaus spielen produktspezifische Unterschiede eine Rolle, wie beispielsweise abweichende Injektionsvolumina, eine komplizierte Handhabung oder besondere Packungseigenschaften, etwa bei der Notwendigkeit zur Rekonstitution. In all diesen Fällen ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich, um die Sicherheit der Therapie zu gewährleisten und Anwendungsfehler oder Therapieabbrüche zu vermeiden.

Diese differenzierte Betrachtung ist notwendig, um Therapieabbrüche, Anwendungsfehler und eine Gefährdung des Behandlungserfolgs zu vermeiden. Die Verantwortung der Apotheke, in solchen Fällen im Sinne der Patientensicherheit zu entscheiden, muss jedoch durch eine klare Schutzformulierung flankiert werden. Apotheker dürfen nicht dem Risiko ausgesetzt sein, bei berechtigtem Absehen von der Substitution regressrechtlich belangt zu werden. Eine entsprechende Absicherung sollte explizit in die Richtlinie aufgenommen werden.

Abschließend wird zu Absatz 5 gefordert, dass der G-BA in der finalen Fassung des § 40c AM-RL eine rechtssichere und praxistaugliche Regelung schafft, die Apotheken Handlungsspielräume bei begründeten Bedenken einräumt. Gleichzeitig muss geklärt werden, wie Apotheker einen sinnvollen Einblick in die Verschreibungshistorie der Patienten bekommen können, um ihrer Verantwortung im Rahmen der Arzneimitteltherapiesicherheit nachkommen zu können, ohne dass eine Verlagerung ärztlicher Verantwortung auf die Apotheke entsteht.

Lilly

Lilly begrüßt die mit Absatz 5 eingeräumte Möglichkeit für Apotheker, bei sonstigen Bedenken nach § 17 Absatz 5 der Apothekenbetriebsordnung von einer verpflichtenden Ersetzung abzusehen. Dies unterstreicht die in den meisten Fällen gelebte Umsetzung einer umfassenden patientenorientierten Beratung in den Apotheken durch das dortige Fachpersonal. Nichtsdestotrotz bleibt aus Sicht von Lilly offen, inwiefern die erforderliche Beratungszeit bei dem bereits angesprochenen Fachkräftemangel in den Apotheken immer vorhanden ist oder aus anderen Gründen patientenindividuelle Aspekte, die gegen eine Ersetzung sprechen, immer identifiziert werden können. Auch wirtschaftliche Gründe, wie beispielsweise Regressangst, können dazu führen, dass Apotheken von der Möglichkeit, auf eine Ersetzung zu verzichten, nicht Gebrauch machen.

Lilly merkt daher an, dass auch das Einfügen des § 40c (5) nicht geeignet ist, Arzneimittelsicherheit und Patientenschutz im erforderlichen Maße zu gewährleisten.

ABDA, AMK

Die Maßgabe, wonach die Apotheke bei Vorliegen sonstiger Bedenken nach § 40 Absatz 3 Satz 2 dieser Richtlinie auch unter Würdigung patientenindividueller Aspekte von einer Ersetzung absehen kann, hat insofern die Komplexität und Besonderheiten der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel gegenüber chemisch definierten Arzneimitteln zu berücksichtigen, als dass auch eine konsequente Nutzung seitens der Apotheken kein Risiko zur Beanstandung und Retaxation seitens der Krankenkassen nach sich ziehen darf. Dies sollte im Richtlinienentwurf klargestellt werden.

BPI

Die vorgesehene Regelung in § 40c Abs. 5 AM-RL bleibt mit der pauschalen Formulierung „bei sonstigen Bedenken“ deutlich zu unbestimmt, um Apotheken eine rechtssichere und praktikable Entscheidungsgrundlage bei der Substitution biotechnologisch hergestellter Arzneimittel zu bieten. In der Praxis besteht für Apotheken die reale Gefahr von Retaxationen, wenn sie aus Sorge um die Patientensicherheit vom Austausch absehen – ohne dass hierfür im Gesetzestext eine tragfähige Begründung vorgesehen ist.

Gerade bei hochkomplexen biologischen Arzneimitteln, deren Anwendung mit individuellen Anforderungen und Risiken verbunden ist, ist eine präzise Regelung zum Umgang mit patientenspezifischen Einschränkungen unabdingbar. Die in den Tragenden Gründen genannten Beispiele – etwa bekannte Unverträglichkeiten, Allergien, Nebenwirkungen, Probleme mit Applikationshilfen, Injektionsvolumina oder eingeschränkte Motorik – sind klinisch relevant und sollten nicht nur im Begründungstext, sondern direkt im Richtlinienentwurf (§ 40c Abs. 5) als konkretisierende Kriterien aufgenommen werden.

Zudem wird im Entwurf nicht ausreichend berücksichtigt, dass Apothekerinnen und Apotheker bei der Abgabe häufig erstmals mit der tatsächlichen konkreten Darreichungsform und

Packung eines Produkts konfrontiert sind. Damit haben sie in vielen Fällen einen besseren Einblick in die praktische Eignung und Anwendbarkeit als die verordnende ärztliche Person – gerade, wenn eine Verordnung wirkstoffbezogen erfolgt ist.

Vor diesem Hintergrund fordern wir eine verbindliche Konkretisierung des § 40c Abs. 5 AM-RL um die in den Tragenden Gründen beispielhaft genannten patientenindividuellen Faktoren. Nur so kann sichergestellt werden, dass Apotheken im Sinne der Patientensicherheit und unter Wahrung der Therapieadhärenz sachgerecht agieren können – ohne dabei wirtschaftliche Risiken durch Retaxationen eingehen zu müssen.

Pharma Deutschland

Pharma Deutschland spricht sich grundsätzlich von einer entsprechenden gesetzlichen Klarstellung aus, die mögliche Retaxationen und Regresse auf Apotheken- und Arztebene mit Blick auf die Verordnung und Abgabe von Biosimilar unterbindet.

VZA

Die Regelung in Absatz 5 ist angesichts des Vorgehens einiger Krankenkassen im Wege der Nullretaxation bei geringsten Anlässen für die Apotheken in der Praxis nicht umsetzbar.

Der G-BA muss zur Kenntnis nehmen, dass es die Krankenkassen schlichtweg nicht akzeptieren werden, wenn die Apotheke patientenindividuelle Aspekte anführen würde. Wir gehen davon aus, dass den Apotheken in solchen Fällen nichts Anderes übrigbleibt, als den behandelnden Arzt um das Setzen eines Aut-idem-Kreuzes im Interesse seines Patienten zu bitten.

AkdÄ

Die AkdÄ begrüßt diesen expliziten Hinweis, dass Apotheken bei patientenindividuellen Aspekten bzw. Konstellationen auch bei Biologika sonstige Bedenken nach § 17 Absatz 5 der ApBetrO geltend machen können, um patientenindividuelle Aspekte zu würdigen, indem sie von der Substitution absehen.

Bewertung:

Die Stellungnehmenden begrüßen die Möglichkeit für Apotheken aus patientenindividuellen Gründen von einer Ersetzung des verordneten Arzneimittels absehen zu können. Gleichzeitig wird vielfach angeregt, eine detaillierte Auflistung der u. a. bereits in den Tragenden Gründen zum Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens genannten Konstellationen im Normtext vorzugeben oder die Regelung selbst dahingehend anzupassen, dass eine Sicherheit vor Retaxation bei Anwendung der sog. „pharmazeutischen Bedenken“ gewährleistet werde.

Den Stellungnahmen ist im Ausgangspunkt zuzustimmen, dass ein Ausschluss der Ersetzung von Arzneimitteln aufgrund patientenindividueller und erkrankungsspezifischer Aspekte in erster Linie vom Vertragsarzt im Rahmen seiner Verordnungsentscheidung zu beurteilen ist. Unter Berücksichtigung der konkreten Patientensituation kann durch diesen ein Absehen von der Ermöglichung einer Ersetzung durch Apotheken insofern gerechtfertigt sein, wenn der aus wirtschaftlichen Gründen zu erwägende Austausch für die jeweilige Patientin oder den jeweiligen Patienten aus medizinischen und therapeutischen Gründen nicht zumutbar ist. Abhängig von der konkreten Behandlungssituation können unter Würdigung patientenindividueller und erkrankungsspezifischer Aspekte medizinische Gründe oder eine besondere Therapiesituation dagegensprechen. Medizinische Aspekte, die gegen die Ermöglichung einer Ersetzung durch ein preisgünstiges biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel sprechen, sind unter anderem in der Vergangenheit aufgetretene Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Allergien sowie eine instabile Therapiesituation der Patientin oder des Patienten.

Gemäß der Regelung in § 40a Absatz 5 AM-RL muss die Erwägung, von einer Umstellung abzusehen, immer medizinisch bzw. therapeutisch begründbar sein. Arzneimittel, die über das Maß des Notwendigen hinausgehen oder unwirtschaftlich sind, weil sie gegenüber gleich

geeigneten, ausreichenden und erforderlichen Mitteln teurer sind, sind aus dem Leistungskatalog der GKV grundsätzlich ausgeschlossen; dies ergibt sich bereits aus den allgemeinen Anforderungen des Wirtschaftlichkeitsgebots. Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit bedingt im Sinne des Minimalprinzips den Beleg, dass bei Existenz verschiedener gleich zweckmäßiger und notwendiger Behandlungsmöglichkeiten die Kosten für den gleichen zu erwartenden Erfolg geringer oder zumindest nicht höher sind. Daraus folgt, dass Annehmlichkeiten oder Gewohnheiten beispielsweise in der Arzneimittelanwendung keinen Sachgrund darstellen, von den Vorgaben des Wirtschaftlichkeitsgebots abzuweichen. Durch das Setzen eines „aut idem“-Kreuzes stellt der Arzt insofern diese bewusste Verordnungsentscheidung gegen eine Umstellung auch für Apotheken mit Blick auf die Frage einer Ersetzung des Arzneimittels klar. Zum Ausschluss der Ersetzung bei Verordnung durch den Arzt siehe auch Bewertung zu Einwand 3.1.7.

Ungeachtet der konkreten Verordnungsentscheidung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes für oder gegen die Ermöglichung einer Ersetzung des Arzneimittels, ist allerdings auch die Apotheke zur Beachtung von Sicherheitsanforderungen aufgrund der Fach- und Gebrauchsinformationen verpflichtet. In diesem Rahmen können sich auch für die Apotheke bestimmte patientenindividuelle Aspekte als relevant darstellen, die für die Ärztin oder den Arzt in Unkenntnis des konkreten, abzugebenden biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittels noch nicht berücksichtigt werden konnten. Patientenindividuell relevante Abweichungen der Arzneimittel hinsichtlich der Injektionsvolumina (z. B. Schmerzen bei größeren Volumina), der Handhabung (z. B. eingeschränkte Feinmotorik) und der Packungsausstattung (z. B. vorherige Rekonstitution der Injektionslösung) können beispielsweise einer Ersetzung entgegenstehen, soweit durch die Apotheke eine patientenindividuelle Gefährdung des Therapieerfolgs durch Nicht-Adhärenz oder Anwendungsfehler nicht vermieden werden kann. Grundsätzlich können bei entsprechender Kenntnis aber auch in der Vergangenheit aufgetretene Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Allergien der oder des Versicherten (z. B. Stammkunden mit Medikationshistorie) von der Apotheke Berücksichtigung finden. Soweit bei einzelnen Versicherten trotz erfolgter Aufklärung, Schulung und Beratung durch die Apotheke dennoch eine Gefährdung des Therapieerfolgs durch Nicht-Adhärenz oder Anwendungsfehler nicht vermieden werden kann, soll mit dem Hinweis in Absatz 5 explizit klargestellt werden, dass dann ein Absehen von einer Ersetzung durch die Apotheke gemäß § 17 Absatz 5 ApBetrO gerechtfertigt ist.

Allein die Tatsache, dass diese patientenindividuellen Aspekte bereits bei Verordnung berücksichtigt werden (können), steht einer Regelung durch den G-BA nicht entgegen. Die Vorgaben der ApBetrO stellen einen Bestandteil der gesetzlichen Vorgaben für die Arzneimittelversorgung dar und können vom G-BA in seinen Richtlinien berücksichtigt werden; dies insbesondere um gesetzliche Regelungen in einen bestimmten Kontext einzubetten.

Der G-BA sieht von einer Aufzählung konkreter Aspekte im Normtext ab; mit Blick auf die ebenfalls geforderte Sicherheit bei Geltendmachung der sog. „pharmazeutischen Bedenken“ wird so auch der Eindruck eines abschließenden Charakters vermieden. Die Ausgestaltung der Vertragsbedingungen ist zwischen den Beteiligten des Rahmenvertrags zur Arzneimittelversorgung zu definieren und liegt nicht in der Regelungszuständigkeit des G-BA. Bei entsprechender Begründung durch die Apotheke hat der G-BA grundsätzlich davon auszugehen, dass das Absehen von der Ersetzung eines Arzneimittels im Ergebnis ohne Beanstandung bleibt.

3.6 Weitere Einwände

3.6.1 Mangelnde Umsetzung bzw. Überschreitung des gesetzlichen Regelungsauftrags

Amgen

Amgen weist darauf hin, dass es zumindest fragwürdig ist, ob für die vom G-BA geplante Ergänzung der AM-RL um den § 40c die explizite gesetzliche Grundlage in § 129 SGB V vorliegt. Es wird zwar nicht verkannt, dass der G-BA nach Inkrafttreten des GSAV gemäß § 129 Abs. 1a Satz 3 SGB V für die ärztliche Verordnung und gemäß § 129 Abs. 1a Satz 5 SGB V für Apotheken Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel zu geben hat. Der Gesetzgeber hat jedoch diesen Regelungshinweis mit dem Inkrafttreten des GKV-FinStG nur dahingehend konkretisiert, dass mit dem ergänzten § 129 Abs. 1a Satz 6 SGB V die Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Arzneimitteln zunächst ausschließlich auf parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patient:innen beschränkt worden sind (vgl. BT-Drs. 20/3448, S. 40). Die zeitnahe Ausweitung der Austauschbarkeit auf biologische Fertigarzneimittel durch die Apotheke lässt sich aus Sicht von Amgen weder aus dem Gesetz noch aus der Gesetzesbegründung direkt ableiten.

Des Weiteren lässt Anlage VIIa aktuell keine Rückschlüsse zur Austauschbarkeit zu. Aufgrund dessen ist die alleinige Einführung von § 40c AM-RL nicht ausreichend für die Austauschbarkeit von biologischen Arzneimitteln.

Darüber hinaus hat Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Beschluss für das GKV-FinStG noch seine Erwartungshaltung geäußert, dass nach dem Inkrafttreten der automatischen Substitution von Biopharmazeutika in der Apotheke vom Gesetzgeber die weitere Entwicklung kritisch begleitet und die Regelungen in Bezug auf die Patient:innensicherheit und die möglichen Risiken für die Versorgung engmaschig evaluiert sowie die Evaluationsergebnisse zeitnah veröffentlicht werden sollen (vgl. BT-Drs. 366/22, S. 28 u. 29). Auch wenn diese Erwartungshaltung des Bundesrates gesetzlich nicht bindend ist, ist eine solche Evaluation zur Patient:innensicherheit grundsätzlich sinnvoll, da aus dem Nicht-Bekanntwerden von möglichen Problemen nicht automatisch geschlussfolgert werden kann, dass es keine möglichen Risiken für die Versorgung gibt.

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht von Amgen das laufende Verfahren zur Änderung der AM-RL vom G-BA so lange zu unterbrechen, bis die gesetzlichen Voraussetzungen für den neuen § 40c der AM-RL geschaffen sind und entsprechende – vor allem systematisch erhobene – Evaluationsberichte zur Patient:innen- und Versorgungssicherheit in Bezug auf die automatische Substitution von Biologika durch die Apotheke vorliegen (vgl. u.a. BT-Drs. 366/22, S. 28f.).

Biocon

Die Interpretation des GBA ist gesetzeswidrig und widerspricht dem klaren Wortlaut des § 129 Abs. 1a SGB V sowie den Vorgaben in § 84 SGB V. Insofern schließen wir uns der Stellungnahme der AG pro Biosimilars vollumfänglich an.

Rechtsgrundlage für den vorliegenden Entwurf zur Änderung der Arzneimittelrichtlinie ist das bereits am 15. August 2019 in Kraft getretene „Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)“.

Bei der beabsichtigten Substitution durch die Apotheke besteht zur bisherigen Substitution von Parenteralia seit 2019 der entscheidende Unterschied, dass Parenteralia von der Apotheke erstellt und an Fachkreise abgegeben werden, die diese den Patienten applizieren. Bei der jetzigen Substitution von Biosimilars sollen hingegen vom Arzt verordnete Präparate in der Apotheke substituiert und an den Patienten zur Selbstapplikation abgegeben werden.

[...] Seit Inkrafttreten des GSAV im August 2019 ist die gesetzliche Regelung einer umfassenden, grundsätzlichen und breit getragenen Kritik ausgesetzt, die nicht ignoriert werden darf. Die geplante automatische Substitution von Biologika in der Apotheke birgt erhebliche Risiken und ist als Instrument von Einsparungen für die gesetzliche Krankenversicherung denkbar ungeeignet, da sie die Qualität und Sicherheit der Versorgung gefährdet. Die beabsichtigte Regelung auf der untergesetzlichen Ebene der Selbstversorgung wiederholt nicht nur die Fehler der Vergangenheit, sie ist zudem rechtswidrig und ungeeignet, sondern steht über dies in klarem Widerspruch zum Pharmapaket und der aktuellen politischen Zielrichtung.

[...] Vor diesem Hintergrund verstößt der Entwurf in der vorliegenden Form in mehrfacher Hinsicht gegen den gesetzlichen Rahmen und die diesem zugrundeliegenden medizinischen Erkenntnisse.

Der Entwurf sieht im Gegensatz zur gesetzlichen Regelung defacto eine automatische Austauschbarkeit für Biologika auf Apothekenebene vor. Die vom Gesetzgeber intendierte medizinisch-pharmazeutisch differenzierte Umsetzung lässt der Entwurf vermissen. Eine vom Gesetzgeber erwartete Sammlung und Bewertung von Erfahrungen aus der Versorgungspraxis liegt nicht vor und ist auch nicht vorgesehen.

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG (GSK)

Forderungen zur Gewährleistung der Therapiesicherheit

1. **Ärztlicher Substitutionsausschluss:** Die Möglichkeit, den Austausch ärztlich auszuschließen, muss verbindlich und einfach umsetzbar sein.
2. **Transparente Patientenaufklärung:** Patient:innen müssen vor jedem Austausch in geeigneter Weise (z.B. Aufklärung durch Apotheker:in oder behandelnde Ärzt:in) informiert und in die Entscheidung einbezogen werden.
3. **Pharmakovigilanz und Monitoring:** Die Auswirkungen mehrfacher Substitutionen müssen in Versorgungsrealität systematisch wissenschaftlich erfasst und evaluiert werden.
4. **Digitale Infrastruktur:** Schnittstellen zwischen Arztpraxis, Apotheke und ePA müssen ausgebaut werden.
5. **Fortbildung und Ressourcen:** Apotheken müssen mit ausreichend Zeit und Fortbildungsmöglichkeiten ausgestattet werden, um dieser komplexen Aufgabe gerecht zu werden.

Die Änderung der AM-RL (§ 40c), die den automatischen Austausch von biologischen Fertigarzneimitteln auf Apothekenebene erleichtern soll, birgt aus medizinischer und praktischer Sicht erhebliche Risiken für Patient:innen, insbesondere für schwer chronisch Kranke mit Multimedikation. Die aktuell verfügbare wissenschaftliche Evidenz fordert eine vorsichtige, patientenzentrierte Umsetzung mit klaren Schutzmechanismen, um die Therapiesicherheit und Patientenzufriedenheit nicht zu gefährden.

Hexal

§ 129 Abs. 1 Satz 5 SGB V ermächtigt den G-BA, in Richtlinien gemäß 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken zu geben. Diese gesetzliche Vorgabe legt der G-BA dahingehend aus, dass das Referenzprodukt und die darauf bezugnehmenden Biosimilars jeweils wechselseitig austauschbar seien und desgleichen die entsprechenden Biosimilars untereinander. Für diese Auslegung könnte zunächst sprechen, dass gemäß § 129 Abs. 1 Satz 12 SGB V die Regelungen über eine Austauschbarkeit für preisgünstige Arzneimittel nach Satz 1 Nummer 1 und den Sätzen 2 bis 7 entsprechend für im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel gelten, für die der G-BA in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 eine Austauschbarkeit in Bezug auf ein biologisches Referenzarzneimittel festgestellt hat. Sofern eine Austauschbarkeit in Bezug auf ein biologisches

Referenzarzneimittel festgestellt wird, dürfte dies vom Wortlaut her sowohl den Austausch von Referenzarzneimittel durch Biosimilars als auch den Austausch von Biosimilars durch das Referenzarzneimittel und durch andere Biosimilars umfassen. Jedoch erlaubt § 129 Abs. 1a S. 5 SGB V dem G-BA lediglich, in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln (nicht: zur Austauschbarkeit in Bezug auf Referenzarzneimittel!) durch Apotheken zu geben. Dem eindeutigen Gesetzeswortlaut zufolge soll nur das Referenzarzneimittel austauschbar sein und nur für diesen Sachverhalt ist es dem G-BA von Gesetzes wegen aufgegeben, Hinweise zur Austauschbarkeit zu geben.

Dies entspricht auch der Zielsetzung des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV), durch das in § 129 SGB V dessen Absatz 1a neu aufgenommen wurde. Zielsetzung war die Förderung der Verordnung und Abgabe von Biosimilars. So heißt es in der Gesetzesbegründung: „Zur Förderung der Verordnung und Abgabe von Biosimilars werden in § 129 SGB V Regelungen zur Austauschbarkeit und zur Festlegung von Wirtschaftlichkeitszielen in den Arznei- und Heilmittelvereinbarungen nach § 84 SGB V geschaffen“ [183].

Vor diesem Hintergrund ist die vom G-BA nun intendierte Umsetzung des § 129 SGB V Abs. 1a Satz 5 durch den geplanten § 40c AM-RL als rechtsfehlerhaft zu bewerten. Sie widerspricht dem Gesetzeswortlaut sowie der Intention des Gesetzgebers. Wir fordern daher, die Substitution auf den vom Gesetzgeber vorgesehenen Anwendungsbereich zu beschränken – den Austausch des Referenzarzneimittels durch ein therapeutisch vergleichbares Biosimilar.

[...] Biosimilars, also biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel, die nach dem Verfahren des Art. 10 Abs 4 der Richtlinie 2001/83/EG zugelassen wurden, sind – anders als Generika – bekanntlich nicht wirkstoffgleich zu ihrem Referenzarzneimittel, es sei denn es handelt sich um sogenannte Bioidenticals, also wirkstoffidentische biotechnologisch hergestellte Arzneimittel (wie in Anlage 1 zum Rahmenvertrag gemäß § 129 Abs. 2 SGB V genannt).

Vor diesem Hintergrund und aufgrund weiterer Besonderheiten von Biologika gab der Gesetzgeber es dem G-BA in § 129 Abs. 1a SGB V auf, Hinweise in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel unter Berücksichtigung deren therapeutischer Vergleichbarkeit vorzunehmen [Hervorhebung durch die Verf.].

Der G-BA hält auch im vorliegenden Beschlussentwurf über die Einfügung des § 40c in die AM-RL an seiner bereits in den §§ 40a und 40b AM-RL zum Ausdruck gebrachten pauschalisierenden Betrachtungsweise weitgehend fest und möchte nunmehr allein mögliche Unterschiede in den Applikationsarten berücksichtigen. Darüber hinaus wird in § 40c Absatz 3 AM-RL von einer generellen Austauschbarkeit ausgegangen, sofern zu einem Referenzprodukt mindestens ein Biosimilar im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG vorliegt.

Anders als § 40a AM-RL hat § 40c (wie auch schon § 40b) AM-RL konstitutive Bedeutung, d.h. ein aut idem Austausch auf Apothekenebene darf überhaupt nur unter den darin normierten Voraussetzungen erfolgen. Gerade in Bezug auf den Austausch auf Apothekenebene wäre es zwingend erforderlich, dass Hinweise des G-BA gemäß § 129 Abs. 1a Satz 5 SGB V die therapeutische Vergleichbarkeit der jeweiligen biotechnologisch hergestellten Referenzprodukte und der auf sie bezugnehmenden Biosimilars in den Blick nehmen und berücksichtigen.

183 Bundesrat Drucksache 53/19: Stellungnahme des Bundesrates. Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung.

[...] Somit ist es möglicherweise auch einer immer noch unzureichenden oder unzureichend ausgewerteten Datenlage und Evidenz speziell für Deutschland geschuldet, dass der G-BA auch für die generelle aut idem Substitution von Biologika (weiterhin) einen pauschalisierenden Ansatz verfolgt. Dass dies nicht der Intention des Gesetzgebers gerecht wird, zeigt bereits die Gesetzesbegründung zum GSAV: Darin wird als Voraussetzung für einen aut idem Austausch eines Biologikums die Feststellung der Austauschbarkeit für das betreffende Arzneimittel durch den G-BA in seinen Richtlinien genannt. Einen pauschalisierenden Ansatz hatte der Gesetzgeber gerade nicht im Sinn.

Vor allem aber wird dieser Ansatz nicht den Besonderheiten von Biologika bzw. Biosimilars gerecht. Dem gesetzlichen Regelungsauftrag könnte der G-BA nur durch Berücksichtigung produktspezifischer Eigenarten gerecht werden [...]. Dementsprechend wären, bevor eine aut idem Substitution in der Apotheke erfolgen kann, in Anlage VIIa bzw. auch in Anlage VII [...] weitere Gesichtspunkte als nur die bezugnehmenden Zulassungen und die zugelassenen Applikationsarten zu berücksichtigen, und zwar durch Aufnahme einer wirkstoff- und produktspezifischen Positivliste.

[...] Der vorliegende Regulierungsentwurf lässt therapie- und wirkstoffbezogene Aspekte als gesetzlich geforderte Grundlage für eine Austauschbarkeit von Biologika auf Apothekenebene komplett außer Acht und überträgt durch fehlende Konkretisierungen bei Austauschkriterien oder Pharmakovigilanzanforderungen die damit verbundenen Ausführungsrisiken an die Leistungserbringer und Patienten. Im Vergleich zum Frühjahr 2022, als die automatische Substitution von biologischen Fertigarzneimitteln in der Apotheke zuletzt im G-BA diskutiert wurde, hat sich an der grundlegenden Argumentation nichts Wesentliches geändert. Der neu vorgebrachte Beschlussentwurf bringt **keinerlei Lösungsvorschläge** oder **neue Evidenz** für die damals wie heute diskutierten Risiken und Einwände und trägt der breit geführten Diskussion vor allem hinsichtlich des Nocebo-Effekts in keiner Weise Rechnung.

Eine Regelung zur Substitution von biologischen Fertigarzneimitteln in der Apotheke mit dem übergeordneten Ziel der Förderung von Biosimilars muss die **Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln** auf die bezugnehmend zugelassenen Biosimilars eingrenzen und im Gegensatz zu einer pauschalisierenden Regelung eine molekülspezifische Bewertung mit Blick auf die **therapeutische Vergleichbarkeit** vornehmen. **Insbesondere bei diesen beiden Aspekten verlässt der G-BA mit dem vorgelegtem Beschlussentwurf den vom Gesetzgeber klar definierten Regelungsrahmen.**

Pfizer

Für die Bewertung des vom Gemeinsamen Bundesausschusses zur Stellungnahme gestellten § 40c (neu) sind produktübergreifend vor allem **Inhalt und Grenzen des gesetzlichen Regelungsauftrags** maßgeblich.

[...] Eine zentrale Frage des vorliegenden Beschlusses ist, welche Voraussetzungen an die vom Gemeinsamen Bundesausschuss vorzunehmende Feststellung der Austauschbarkeit eines biologischen Referenzarzneimittels zu Biosimilars zu knüpfen sind. In der Sache geht es darum, wann zwischen einem biologischen Referenzarzneimittel und seinen Biosimilars aus sozialrechtlicher Perspektive von einer **hinreichend gleichen Wirksamkeit und Unbedenklichkeit** ausgegangen werden kann, die eine automatische Substitution durch Apotheken unter dem **Gesichtspunkt der Arzneimitteltherapiesicherheit** als vertretbar erscheinen lässt.

In dieser Hinsicht ist von vornherein der **gesetzliche Austauschmechanismus bei Biologika** zu beachten: Der zum 16. August 2022 in Kraft getretene § 129 Abs. 1 Satz 12 SGB V sieht sinngemäß vor, dass die Regelungen zur automatischen Substitution von wirkstoffgleichen Arzneimitteln gemäß § 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, § 129 Satz 2-8 SGB V „entsprechend“ gelten für biologische Arzneimittel, „für die der Gemeinsame Bundesausschuss [...] eine Austauschbarkeit in Bezug auf ein biologisches Referenzarzneimittel festgestellt hat.“ Die für

Generika geltende automatische Substitution durch Apotheken wird also nicht einfach auf biologische Arzneimittel übertragen. Stattdessen sieht der Gesetzgeber eine **Umkehrung des für Generika geltenden Regel-Ausnahme-Verhältnisses** vor:

- Während generische Arzneimittel bei Vorliegen bestimmter Austauschkriterien (identische Wirkstärke und Packungsgröße, gleiches Anwendungsgebiet, gleiche oder austauschbare Darreichungsform) grundsätzlich ausgetauscht werden können bzw. müssen, wenn ihr Austausch nicht vom Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 129 Abs. 1a Satz 1 SGB V ausdrücklich ausgeschlossen wurde (**Substitutionserlaubnis mit Verbotsvorbehalt**), soll bei Biologika ein Austausch nur dann möglich sein, wenn zuvor der Gemeinsame Bundesausschuss die Austauschbarkeit eines bestimmten biologischen Referenzarzneimittels durch andere Biologika ausdrücklich festgestellt hat (**Substitutionsverbot mit Erlaubnisvorbehalt**).
- Für diejenigen biologischen Referenzarzneimittel, deren Austauschbarkeit zuvor vom Gemeinsamen Bundesausschuss positiv festgestellt wurde, sollen im Übrigen die Substitutionsregelungen für Generika nur „entsprechend“ gelten. Das bedeutet rechtsmethodisch, dass die in Bezug genommenen gesetzlichen Aut-idem-Regelungen (§ 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Sätze 2-7 SGB V) nur insoweit herangezogen werden können, als dies mit den Besonderheiten von biologischen Arzneimitteln sachgerecht und vereinbar ist.

Dieser gesetzliche **Ausnahmecharakter** muss sich daher auch in den Hinweisen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken nach § 129 Abs. 1a Satz 5 SGB V spürbar niederschlagen. Das bedeutet nicht zuletzt, dass die parlamentsgesetzlichen Vorgaben vom Gemeinsamen Bundesausschuss – wie bei jedem Ausnahmeregime – **eng und strikt am Wortlaut orientiert** auszulegen und anzuwenden sind.

Zu beachten ist auch: Aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit wird eine Substitution durch Apotheken u. a. von der Bundesärztekammer (BÄK), der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) sowie verschiedenen Patientenorganisationen (Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V., Deutscher Psoriasis Bund (DPB) e. V., Deutsche Rheuma Liga (DRL) e.V., Deutsche Leukämie- und Lymphom-Hilfe (DLH) e.V.) von vornherein abgelehnt. Dies liegt daran, dass aus einer **Austauschbarkeit auf Arzteebene**, die durch eine therapeutische Gleichwertigkeit begründet wird, **keine automatische Substituierbarkeit auf Apothekenebene** folgt, zumal in den bisherigen Switch-Studien die Information, Beratung und Umstellung **immer durch Ärzte erfolgt** ist [184]. Auf eine automatische Substitution ohne ärztliche Beteiligung kann diese Evidenz nicht übertragen werden.

In Anbetracht dieser gewichtigen Einwände gegen eine automatische Substitution und aufgrund des grundsätzlichen Substitutionsverbotes mit (bloßem) Erlaubnisvorbehalt halten wir eine **strenge „Prüfungstrias“** für erforderlich, die an die Feststellung der Austauschbarkeit auf Apothekenebene angelegt werden sollte:

- **Erstens:** Angesichts der Besonderheiten bei biologischen Arzneimitteln halten wir es für zwingend erforderlich, dass das jeweilige Biosimilar **über alle zugelassenen Anwendungsgebiete** wie das auszutauschende biologische Referenzarzneimittel verfügt [...]
- **Zweitens:** Darüber hinausgehend ist erforderlich, dass in denjenigen Fällen, in denen ein Biosimilar über alle Anwendungsgebiete eines biologischen Referenzarzneimittels verfügt, die **Zulassung aller dieser Anwendungsgebiete auch jeweils auf klinischen Vergleichsstudien**, nicht jedoch lediglich ganz oder teilweise auf einer Extrapolation von

184 Deutscher Psoriasis Bund (DPB), Deutsche Rheuma-Liga (DRL), Deutsche Morbus Crohn/Colitis Ulcerosa Vereinigung (DCCV), Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe (DLH). Gemeinsames Schreiben Patientenvertretungen (DPB, DRL, CDDV und DLH) zur automatischen Substitution von Biopharmazeutika, März 2022.

vorgelegten Daten beruht [...].

- **Drittens:** Der Gemeinsame Bundesausschuss muss sich überzeugen, dass es bei dem biologischen Referenzarzneimittel bzw. den jeweiligen Biosimilars keine sonstigen medizinisch-therapeutischen Gründe gibt, die einer regelhaften Substitution entgegenstehen können [...].

[...] Soweit in dem vorgeschlagenen § 40c Abs. 1 (neu) vorgesehen ist, dass die Apotheken bei Abgabe verordneter biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel zur Ersetzung durch ein Arzneimittel „verpflichtet“ sind, ist dies **nicht gesetzeskonform und daher anzupassen**.

[...] Der Regelungsauftrag des Gemeinsamen Bundesausschuss bezieht sich allein auf die für die Austauschverpflichtung relevante Vorfrage, ob ein biotechnologisch hergestelltes Fertigarzneimittel gegen ein anderes Referenzarzneimittel auf Apothekenebene medizinisch-pharmazeutisch austauschbar ist. Dies ist im Sinne einer Positivliste vorab festzustellen [...]. Ob dagegen ein vom Gemeinsamen Bundesausschuss als austauschbar befundenes Arzneimittel tatsächlich durch die Apotheken auszutauschen ist und eine entsprechende Austauschpflicht besteht, richtet sich gemäß § 129 Abs. 1 Satz 12 SGB V allein nach den Vorschriften des § 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Sätze 2-7 SGB V. Danach sind die Apotheken allein **nach Maßgabe des Rahmenvertrags nach § 129 Abs. 2 SGB V zum Austausch verpflichtet**.

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat daher allein die Kompetenz, produktbezogen über die medizinisch-pharmazeutische Austauschbarkeit zu befinden, nicht jedoch zu regeln, in welchen Fällen die Apotheken tatsächlich eine Pflicht zum Austausch trifft. Dies ist vielmehr **alleinige Sache der Rahmenvertragspartner nach § 129 Abs. 2 SGB V** in Verbindung mit den Vorschriften des § 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Sätze 2-7 SGB V. Dies erkennt der Gemeinsame Bundesausschuss auch in den Tragenden Gründen des Beschlussentwurfs an, wenn er dort darauf hinweist, dass es Sache der Rahmenvertragspartner nach § 129 Abs. 2 SGB V ist, Bestimmungen zur Auswahl eines preisgünstigen Arzneimittels zu regeln.

[...] Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Vorgaben bedarf der vorgeschlagene § 40c (neu) in der Arzneimittel-Richtlinie einer zwingenden Anpassung. Eine Pflicht der Apotheken zur Ersetzung kann und darf dort nicht geregelt werden. Dies liegt in der alleinigen Zuständigkeit der Rahmenvertragspartner nach § 129 Abs. 2 SGB V.

BPI

Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in § 129 Abs. 1a S. 3 SGB V setzt § 40c Abs. 3 der AM-RL eine etwaige Substitution ausschließlich für ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilar) zu dem verordneten Referenzarzneimittel um. Zutreffend führen die Tragenden Gründe zum Beschlussentwurf auf S. 8 aus: „Die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander ist grundsätzlich nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung und wird durch die Ergänzung der AM-RL sowie die vorliegende Anlage VIIa nicht weiter konkretisiert.“

Aus menschlichem Blutplasma hergestellte Arzneimittel wie z. B. Immunglobuline (Blutplasmapräparate) sind biologische Arzneimittel, die nicht biotechnologisch hergestellt werden. Es handelt sich nicht um Biosimilars im o. g. Sinne und entsprechend kann auch § 40c nicht auf Blutplasmapräparate anwendbar sein.

Wir verstehen die Ausführungen des G-BA an der zitierten Stelle auf S. 8 in den Tragenden Gründen als Klarstellung auch insoweit und begrüßen ausdrücklich, dass auch der G-BA aufgrund der dargestellten, klaren Rechtslage keine gesonderten ausdrücklichen Regelungen bzgl. der Nicht-Anwendbarkeit des § 40c auf Blutplasmapräparate, insbesondere Immunglobuline, für notwendig erachtet.

Dennoch regen wir zur Vermeidung von Missverständnissen folgende Klarstellung auf S. 8 der Tragenden Gründe an: „Die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander ist grundsätzlich nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung und wird durch die Ergänzung der AM-RL sowie die vorliegende Anlage VIIa nicht weiter konkretisiert. **Ebenfalls keine Anwendung finden die vorgenannten Regelungen auf – nicht biotechnologisch hergestellte – biologische Arzneimittel. Entsprechend gelten die Regelungen u. a. nicht für Blutplasmapräparate untereinander, insbesondere Immunglobuline.“**

[...] Zudem ist der G-BA aufgefordert, klarzustellen, dass **Blutplasmaprodukte als Biologika** ausdrücklich von der automatischen Substitution in Apotheken **auszunehmen** sind. Humanes Blutplasma ist ein einzigartiger, biologischer Ausgangsstoff menschlichen Ursprungs, der nicht synthetisch oder biotechnologisch reproduzierbar ist. Die therapeutische Wirkung plasmabasierter Arzneimittel hängt wesentlich von Spendervariabilität, Herstellungsverfahren sowie der Zusammensetzung des Endprodukts ab. Da es für diese Präparate keine im Wesentlichen gleichen Arzneimittel im Sinne der Biosimilar-Definition (Art. 10 Abs. 4 RL 2001/83/EG) gibt, ist ein Austausch nicht mit geltenden wissenschaftlichen und sicherheitsrelevanten Standards vereinbar. Die AM-RL muss deshalb eindeutig festlegen, dass plasmabasierte Arzneimittel von der Substitutionsregelung auszuschließen sind.

Pharma Deutschland

Der G-BA ist gemäß § 129 Absatz 1a SGB V beauftragt in den Richtlinien Hinweise zur Austauschbarkeit von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken zu geben. Der Entwurf ist insofern nicht am Wortlaut des Gesetzes orientiert, wenn anstatt der „Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel“ von „Ersetzung“ oder „Austausch“ in Analogie zum § 129 Absatz 1 SGB V die Rede ist. Grundsätzlich ist § 129 Absatz 1a SGB V als speziellere Regelung im Verhältnis zu § 129 Absatz 1 SGB V zu sehen. Beispielsweise greift die nach § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V festgelegte Pflicht zur Abgabe preisgünstiger Arzneimittel nicht, wenn diese den Vorgaben der Arzneimittel-Richtlinie entgegenstehen. Ähnliche Normenrangverhältnisse und Einschränkungen des § 129 Absatz 1 SGB V gibt es beispielsweise bei der sog. Substitutionsausschlussliste. Pharma Deutschland spricht sich daher für eine entsprechende Klarstellung im Richtlinien-Entwurf aus.

Pro Generika

Die vom Gesetzgeber geforderte Berücksichtigung der therapeutischen Vergleichbarkeit der zu reglementierenden Arzneimittel ist im Beschlussentwurf an keiner Stelle erkennbar. Vielmehr wird in § 40c Absatz 3 AM-RL von einer grundsätzlich vorhandenen Austauschfähigkeit von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln ausgegangen. Noch im Stellungnahmeverfahren zum GSAV hat der G-BA nachdrücklich darauf verwiesen, dass er „die dringende Notwendigkeit sieht, zur Regelung der Austauschbarkeit wirkstoffgleicher biologischer Arzneimittel Auskünfte der zuständigen Bundesoberbehörden einholen zu können. Ohne hinreichende Kenntnis über Ausgangsstoffe und den Herstellungsprozess von Originalpräparat und biosimilarem Arzneimittel sowie über die Beurteilung der Bundesoberbehörden zu ggf. ergänzend vorzulegenden Unterlagen ist eine Regelung zur Austauschbarkeit nur schwer möglich.“. Mit der vorgeschlagenen Ausgestaltung des § 40c AM-RL und der Nichtberücksichtigung der therapeutischen Vergleichbarkeit kommt der G-BA weder dem gesetzlichen Auftrag nach, noch wird er seinen eigenen Anforderungen an eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung gerecht.

[...] Vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgesehenen Bewertungsverantwortung des G-BA ist die belastbare Evidenz zur therapeutischen Vergleichbarkeit auch bei mehrfacher Substitution eine zwingende Voraussetzung für die Feststellung der Austauschbarkeit. Ausdrücklich betont der Gesetzgeber, dass „keine automatische Austauschbarkeit geregelt“ würde. Vielmehr benannte er als „wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der aut-idem-Regelung auf

Apothekenebene, dass der G-BA zuvor in seinen Richtlinien die Austauschbarkeit für das betreffende Arzneimittel bewertet und festgestellt hat“.

Die Formulierung des Gesetzgebers impliziert nicht lediglich eine formale Feststellung, sondern eine bewertende, evidenzbasierte Prüfung, die den Maßstäben der evidenzbasierten Medizin im Sinne des § 2 Abs. 1 SGB V sowie der Entscheidungspraxis des G-BA genügen muss.

Dieser Anforderung ist der G-BA bislang nicht nachgekommen. Dies wäre durch die Forderung der „Position 2b“ nach Evidenz für die Unbedenklichkeit des mehrfachen Austausches zumindest in Teilen heilbar.

Die gesetzlich verankerte Forderung nach therapeutischer Vergleichbarkeit ist dabei nicht mit der bloßen Zulassung als Biosimilar gleichzusetzen. Vielmehr fokussiert die Forderung auf die Frage, ob und unter welchen Bedingungen – insbesondere im Falle mehrfacher Produktwechsel – klinisch relevante Unterschiede, Adhärenzprobleme oder immunologische Effekte zu erwarten sind, die die Sicherheit oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten.

Da im Rahmen der automatischen Substitution nicht sichergestellt ist, dass nur ein einmaliger Wechsel erfolgt, sondern im Gegenteil mehrfache, nicht ärztlich gesteuerte Wechsel zu erwarten sind, bedarf es auch einer expliziten Evidenzgrundlage zur Unbedenklichkeit solcher Mehrfachwechsel. Ohne eine solche Evidenz kann der G-BA die gesetzlich verlangte Bewertung der therapeutischen Vergleichbarkeit nicht mit hinreichender Sicherheit vornehmen.

Besonders kritisch ist die pauschale Einbeziehung neu eingeführter biosimilarer Wirkstoffe oder Präparate in die automatische Substitutionsregelung nach § 129 Abs. 1a SGB V zu bewerten. Ohne klarstellende Vorgaben, Übergangsfristen oder eine belastbare Evidenz- und Datengrundlage – etwa zur therapeutischen Vergleichbarkeit oder zur praktischen Umsetzbarkeit – entsteht erhebliche Rechts- und Anwendungsunsicherheit. Dies gilt insbesondere dann, wenn die fristgerechte Aufnahme in Anlage VIIa des Arzneimittelverzeichnis fehlt. Eine solche Regelung birgt nicht nur potenzielle Haftungs- und Retaxationsrisiken für die abgebenden Apotheken, sondern erschwert auch die sachgerechte Programmierung und Umsetzung von Austauschalgorithmen in Praxissoftware und Warenwirtschaftssystemen. Vor diesem Hintergrund erscheint ein differenzierteres Vorgehen dringend geboten. Gemäß den tragenden Gründen zum Beschluss besteht mit Eintreten von Biosimilars auf den Markt für die Apotheken auch unabhängig von der Listung in Anlage VIIa die Möglichkeit einer Ersetzung unter Berücksichtigung der Beschlussvorgaben unter Absatz 1 bis 3. Der allein rechtlich bindende Richtlinienbeschluss selbst macht eine Listung in Anlage VIIa ebenfalls zu keiner notwendigen Voraussetzung für einen apothekerlichen Austausch. Damit gibt es offensichtlich für neue biosimilare Wirkstoffe/Präparate überhaupt keine inhaltliche bzw. medizinisch-wissenschaftliche Überprüfung und Bewertung einer Austauschbarkeit, die der Gesetzgeber aber obligatorisch als Entscheidungsgrundlage fordert. Durch diese Regelungsunklarheit des Richtlinienbeschlusses entsteht zudem faktisch eine rechtlich unzulässige Delegation der normgebenden Verantwortung an die ausführenden Organe innerhalb der Leistungserbringer und Selbstverwaltung, die diese nicht ausüben können und dürfen.

Der Vergleich mit anderen evidenzbasierten Bewertungsverfahren des G-BA – etwa im Rahmen der Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V oder bei Richtlinienentscheidungen zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren – verdeutlicht, dass auch die Bewertung der Austauschbarkeit biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel denselben methodischen Anforderungen genügen muss. Eine pauschale Feststellung der Austauschbarkeit ohne belastbare Evidenz zur Unbedenklichkeit mehrfacher Substitution würde den Bewertungsstandard unterlaufen, den sich der G-BA in seiner Verfahrensordnung selbst gesetzt hat.

Dort heißt es in § 5 Absatz 2 ausdrücklich, der G-BA „ermittelt den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin“. Dieser Maßstab gilt ausnahmslos – auch für die Bewertung der Austauschbarkeit –, und er erfordert insbesondere bei mehrfach möglichen Produktwechseln eine fundierte Beurteilung der therapeutischen Vergleichbarkeit hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Therapietreue.

vfa

Der vfa empfiehlt daher Begriffe wie „Ersetzung“ und „Austausch“ in geeigneter Weise durch Begriffe wie „Abgabe“ und „Austauschbarkeit“ – wie u.a. im Titel von § 40b und § 40c (neu) AM-RL verwendet – abzulösen.

[...] Ebenfalls sollte im Beschluss oder zumindest in den Tragenden Gründen (S. 8) klargestellt werden, dass nicht biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel nicht von der Regelung erfasst werden. Entsprechend gelten die Regelungen eines vorgesehenen § 40c u.a. nicht für Blutplasmapräparate untereinander, insbesondere aus menschlichem Blutplasma hergestellte Arzneimittel wie z.B. Immunglobuline. Diese sind biologische Arzneimittel, die jedoch nicht biotechnologisch hergestellt werden.

Bewertung:

Den Stellungnehmern kann nicht darin zugestimmt werden, dass die Umsetzung des Regelungsauftrags nicht von der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage gedeckt wäre. Der Gesetzesauftrag zielt darauf, „den Austausch biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel sowie wirkstoffgleicher biologischer Arzneimittel“ auf Grundlage ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit zu regeln (BT-Drucks. 19/8753, S. 63).

Nach Auffassung des G-BA lässt sich aus dem Wortlaut des Gesetzesauftrags nichts anderes ableiten. Insbesondere lässt sich aufgrund der Inbezugnahme des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG keine Einschränkung der Regelungsbefugnis des G-BA hinsichtlich der Feststellung der Austauschbarkeit von einem Referenzarzneimittel im Verhältnis zu seinen Biosimilars generell ableiten. Vielmehr dient die Referenzierung auf Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG der Konturierung des Begriffes „im Wesentlichen gleicher biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel“ in Abgrenzung zum Begriff des „Generikums“ hin zur Begrifflichkeit des Biosimilars, die allgemein den Regelungen des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unterfallen (BT-Drucks. 19/8753, S. 61 und 63). Aufgabe des G-BA ist es demnach zu beurteilen, ob auf Grundlage einer entsprechenden Zulassung nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG an Stelle des Originals (in der Regel Referenzarzneimittel) auch deren Biosimilar angewendet werden kann.

Insoweit hat der G-BA im Rahmen des gesetzlichen Regelungsauftrags von seinem Gestaltungsspielraum sachangemessen Gebrauch gemacht, indem er eine Austauschbarkeit von Biosimilars für möglich erachtet, soweit die jeweiligen Biosimilars beziehungsweise auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind.

Eine engere Auslegung des gesetzlichen Auftrags ist aus mehreren Gesichtspunkten nicht geboten: Zum einen würde eine enge Auslegung zu dem widersinnigen Ergebnis führen, dass in dem Fall, in dem ein im Verhältnis zu seinen Biosimilars günstigeres Referenzarzneimittel existiert und aufgrund der therapeutischen Vergleichbarkeit ein Austausch von Referenz zu Biosimilar möglich sein soll, die Rückumstellung – bei enger Wortlautauslegung – jedoch nicht mehr möglich sein.

Zum anderen ist die Apotheke bei Verfügbarkeit mehrerer in Frage kommender preisgünstiger Arzneimittel grundsätzlich frei in der Auswahl. Sind also mehrere Biosimilars (Biosimilar A und B) zu einem Referenzarzneimittel auf dem Markt, könnte ausgehend von einer Verordnung über das Originalarzneimittel bei entsprechender Preisgünstigkeit einmal Biosimilar A und ein anderes Mal bei gleichlautender Verordnung das Biosimilar B abgegeben werden. Bei immer gleicher Voraussetzung könnte also selbst bei einer eingeschränkten Regelung (Austausch nur

zwischen Referenzarzneimittel und Biosimilar) im Ergebnis ein Austausch von einem Biosimilar zum anderen erfolgen.

Unbenommen davon erfüllt der G-BA auch im Kern den gesetzlichen Regelungsauftrag dahingehend die vom Gesetzgeber beabsichtigte und noch einmal klargestellte „Austauschbarkeit von Biosimilars zum jeweiligen Referenzarzneimittel“ festzustellen (BT-Drucks. 19/10681, S. 86), denn zur Voraussetzung eines Austausches von Biosimilars untereinander wird wiederum – maßgebliche Voraussetzung für einen Austausch nach § 129 Abs. 1 Satz 12 SGB V ist die „Austauschbarkeit in Bezug auf ein biologisches Referenzarzneimittel“ – die Referenzierung auf dasselbe (Original-)Arzneimittel gemacht. Dies begründet sich darin, dass wenn und soweit Biosimilars in Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind, schon die entsprechende Prüfung der Zulassungsbehörden eine ausreichende Grundlage dafür darstellt, eine hinreichende Ähnlichkeit sowohl zum Referenzarzneimittel als auch der Biosimilars untereinander festzustellen.

Nach der Zulassung kann es auch innerhalb eines Arzneimittels zu Änderungen kommen (Mikroheterogenität durch z. B. Änderungen in der Herstellung wie Wechsel der Zelllinie für die Produktion), die jeweils durch die zuständige Zulassungsbehörde geprüft und freigegeben werden. Bei größeren Änderungen kann sich ein ähnliches Verhältnis zwischen neuer und vorhergehender Version des Referenzarzneimittels wie zwischen Biosimilar und Referenzarzneimittel ergeben, so dass es auch beim Ausbleiben einer Ersetzung durch Apotheken zu „Umstellungen“ kommen kann. Auch über diese „Umstellungen“ werden die Patienten letztendlich nicht informiert. Die EMA beschreibt in ihrem Leitfaden für medizinische Fachkräfte die bei Biologika bestehende Mikroheterogenität und kommt zu dem Schluss, dass durch die Kontrollen der Zulassungsbehörden die Variabilität zwischen Chargen gering ist und Sicherheit und Wirksamkeit nicht beeinträchtigt sind [46]. Daraus lässt sich aus Sicht des G-BA in Analogie die Sicherheit bei Ersetzungen durch Apotheken zwischen Referenzarzneimitteln und Biosimilars sowie Biosimilars (mit identischem Referenzarzneimittel) untereinander ableiten. Die Prüfung der Sachgerechtigkeit einer Ersetzung im Einzelfall bleibt hiervon unberührt.

Auch ist es dem Arzt in den Fällen, in denen Biosimilars in Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind, unterschiedslos möglich auf die jeweiligen Biosimilars unter Beachtung einer wirtschaftlichen Ordnungsweise umzustellen; unter diesen Umständen erschließt sich eine grundsätzliche Unterscheidung auf der weiteren Ebene hinsichtlich der Ersetzung von Biosimilars untereinander nicht.

Es liegt zudem im normgeberischen Ermessen des G-BA diese „Hinweise“ abstrakt generell durch die Vorgaben zur wirtschaftlichen Abgabe durch Apotheken mit § 40c AM-RL zu regeln und Anlage VIIa zur AM-RL mit Informationen zu den Zulassungszusammenhängen einzubeziehen. Siehe ergänzend auch Bewertung der Einwände zu den Absätzen 1 bis 5.

In Stellungnahmen wird zudem angeregt, in § 40c AM-RL die Begriffe „Ersetzung“ und „Austausch“ durch „Abgabe“ oder „Austauschbarkeit“ zu ersetzen sowie klarzustellen, dass nicht-biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel (z. B. Blutplasmapräparate) nicht von den Regelungen erfasst wären. Dem Vorschlag zur Anpassung des Begriffes „Ersetzung“ wird vor dem Hintergrund, dass der G-BA die in § 129 SGB V angelegte Systematik („Ersetzung“ gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1b), Absatz 1 Satz 3 ff. SGB V) auf den Bereich der Biologika überträgt und diese in seinen Regelungen in § 40c umsetzt, nicht gefolgt. Auch dem Vorschlag zur Klarstellung wird nicht gefolgt, da insoweit nach § 40c Absatz 1 Satz 1 AM-RL eine Ersetzung durch Apotheken „bei der Abgabe verordneter biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel an Versicherte“ geregelt wird. Eine zusätzliche Klarstellung zu nicht-biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln an dieser Stelle füllt keine Regelungslücke; sie ist ohne zusätzlichen Regelungsgehalt und damit redundant.

Die Einwände beziehen sich nicht ausschließlich auf die zur Stellungnahme gestellte Regelung in § 40c AM-RL, sondern betreffen auch die Regelungen in § 40a und § 40b AM-RL sowie die Anlage VIIa. Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits in den Stellungnahmeverfahren zu den Beschlüssen zur Ergänzung der AM-RL um § 40a (vom 20. August 2020) und § 40b (vom 15. Juni 2023) sowie zum Beschluss vom 19. November 2021 zur Erstfassung der Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) zur AM-RL befasst; es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in den Zusammenfassenden Dokumentationen zu den entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/4430/>, <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/> und <https://www.g-ba.de/beschluesse/5132/>).

3.6.2 Substitution in Apotheken bei Biopharmazeutika kein adäquates Mittel

AbbVie

In ganz besonderem Maße ist bei chronisch erkrankten Patienten für den langfristigen Therapieerfolg eine engmaschige ärztliche Begleitung erforderlich, auch um Nocebo-Effekte zu vermeiden. Bei der Umstellung zwischen wirkstoffähnlichen Biologika versteht man unter dem Nocebo-Effekt das Ausbleiben oder die Abschwächung des gewünschten therapeutischen Effekts – ohne, dass dies medizinisch erklärbar ist. Biologika sind in einem gestuften Therapieschema keine so genannten Erstlinientherapeutika, sondern werden erst nach Versagen diverser Basistherapeutika eingesetzt. Viele Patienten haben einen jahrelangen Weg hinter sich, bis ein Therapieerfolg überhaupt erreicht werden konnte. Nur der behandelnde Arzt kann die für die Substitution relevanten medizinischen Aspekte adäquat berücksichtigen und den Patienten hierüber gründlich informieren und begleiten. Viele Studien zeigen, wie wichtig diese Beratung ist, um Nocebo-Effekte zu verhindern und Therapieabbrüche durch den Patienten aufgrund von subjektiv empfundener Abnahme der Wirksamkeit und/oder Nebenwirkungen zu vermeiden [185].

Biocon

Bereits jetzt besteht bei den Apotheken eine angespannte Situation und die Zahl der Apotheken ist deutlich rückläufig. Gleichzeitig besteht bereits jetzt ein eklatanter Fachärztemangel und es fehlen deutschlandweit 5000 Hausärzte. Es ist daher nicht realistisch, dass die in Deutschland noch bestehenden Apotheken und ihre Mitarbeiter ausreichend über alle Biosimilars in jeder Molekülform geschult sind bzw. geschult werden können, damit die geplante Substitution des ärztlich verordneten Biosimilars durch die Apotheke zur Abgabe an den Patienten zur Selbstapplikation überhaupt therapeutisch sinnvoll funktionieren kann. Es besteht die berechtigte Sorge, dass das System bereits jetzt am Rande des Belastbaren arbeitet und jede zusätzliche Aufbürdung von Bürokratie, einen Kollaps zu Lasten der Gesellschaft insgesamt und jedes einzelnen Patienten führen wird. Die jetzt geplante Substitution durch die Apotheken zur Abgabe an Patienten ist in keiner Weise vergleichbar mit der bereits eingeführten Substitution der Parenteralia zur Abgabe an Fachkreise.

Stand 18.06.2025 gibt es in Deutschland bereits jetzt 76 Biosimilars mit 21 unterschiedlichen Wirkstoffen von 25 Wettbewerbern. Jedes dieser Biosimilars ist in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit mit seinem Referenzprodukt vergleichbar. Jedes dieser Produkte weist aber auch Unterschiede in der Zusammensetzung der Hilfsstoffe, im Design der Pen- oder PFS-Ampullen, in den Lagerungsbedingungen usw. auf, die der Arzt bei der Auswahl des für seinen Patienten am besten geeigneten Präparates berücksichtigt. Diese bereits bestehende Substitution durch den Arzt ist sinnvoll und erbringt bereits jetzt enorme Kostenersparnisse für das Gesundheitssystem.

Eine allgemeine Substitution des vom Arzt zusammen mit dem Patienten ausgewählten

185 Pouillon L et al. (2018): The nocebo effect: a clinical challenge in the era of biosimilars. Expert Rev Clin Immunol;14(9):739-49.

Biosimilars durch die Apotheke, wie dies jetzt vom G-BA geplant ist, gefährdet hingegen das bestehende, funktionierende System des Biosimilar Marktes und weitergehende wirtschaftliche Einspareffekte werden letztlich nicht erzielt werden können.

Die Substitution durch die Apotheken erhöht beispielsweise das Risiko einer unvollständigen oder fehlerhaften Injektion und dies wiederum erhöht das Risiko einer Verschlimmerung der Erkrankung und weiterer Kosten für Interventionen (z. B. Krankenhausbesuche, Operationen, Lebensqualität usw.) [186].

Einige der mit Biosimilars behandelten Erkrankungen sind akut, viele sind chronisch und erfordern während der gesamten Lebensdauer des Patienten Injektionen in Abständen von 1 bis 4 Wochen. Eine fortgesetzte Substitution würde daher das Risiko von Anwendungsfehlern auf Grund unterschiedlicher Verabreichungssysteme oder Nebenwirkungen auf Grund unterschiedlicher Hilfsstoffe für die Patienten nur noch verstärken, das mit der Zeit zunimmt, und unkalkulierbare zusätzliche Kosten für das Gesundheitssystem mit sich bringen, die etwaige kurzfristige Einsparungen schnell ausgleichen und ins Gegenteil verkehren.

[...] Für diese Präparate muss die Achtung der Arzt-Patienten-Beziehung bei der Diagnose und Behandlung dieser lebensbedrohlichen oder chronischen Erkrankungen an erster Stelle stehen.

Bei dem bestehenden Hausarzt- und Fachärztemangel und der derzeitigen politisch/gesellschaftlich brisanten Situation ohne Not das Experiment einer Substitution von Biosimilars durch die Apotheke zur Abgabe an Patienten zu starten, erscheint gewagt und kontraproduktiv und stellt keine Lösung für die bestehenden finanziellen Probleme unseres Gesundheitssystems dar.

[...] Hinzu kommt die äußerst angespannte Marktsituation der Apotheken, die aufgrund der Marktverhältnisse eine stark rückläufige Anzahl verzeichnen und im europäischen Vergleich der Apotheken mit 21 pro 100.000 Einwohner nur mehr im unteren Drittel liegen. Zum Ende des Jahres 2024 gab es noch 17.041 Apotheken. Die Vergütungssituation der Apotheken ist gleichermaßen angespannt. Im Koalitionsvertrag wurde zwar eine Erhöhung auf 9,50 € angekündigt, um das Apothekensterben zu stoppen, wobei die zum Überleben fehlenden 3,00 € über pharmazeutische Dienstleistungen und Unterstützung bei der Prävention erwirtschaftet werden sollen, wovon bislang jedoch noch unzureichend Gebrauch gemacht wurde, aufgrund fehlender Zeit. Dies führt unverändert zur Unterfinanzierung und zu weiteren Schließungen. Vor diesem Hintergrund durch die geplante Substitution von Biologicals den Apotheken eine zusätzliche herausfordernde und zeitintensive Aufgabe ohne Vergütung zuzumuten, ist davon auszugehen, dass dies in der Praxis nicht funktionieren wird.

Aktuell werden, um der schlechten wirtschaftlichen Lage der Apotheken gerecht zu werden und den erforderlichen Zeitaufwand zu vergüten, bei der Umstellung seitens der Apotheke bei onkologischen Tabletten der Apotheke hierfür einen Pauschalsatz von EUR 90,00 vergütet, fürs Blutdruck messen einen Pauschalsatz von EUR 11,00 und fürs Impfen ein Pauschalsatz von EUR 11,00. Wenn die Umstellung der Biosimilars durch die Apotheke entsprechend vergütet würde, könnte es sein, dass diese die Leistung ggfls. erbringen könnten. Dann stellt sich aber wiederum die Frage, warum man das bestehende, funktionierende System mit zahlreichen Wettbewerbern nicht erhält, weil Sinn und Zweck, kurzfristige Einspareffekte, dann schon wieder fraglich sein dürften. Zudem existieren nur mehr 17.000 Apotheken landesweit, um diese Zusatzleistung überhaupt zu erbringen.

Die Anzahl der zu erwartenden ärztlichen Rücksprachen, die zudem mit Fachärzten gehalten werden müssten, da Biologicals grundsätzlich vom Facharzt verordnet werden, der bei der Apothekensubstitution nicht involviert ist, ist eine zusätzliche Belastung für die Apotheke, den Arzt sowie für den Patienten. Die erforderliche Dokumentation der Substitution, die Kontrolle

186 Tolonen HM et al. (2019): Medication safety risks to be managed in national implementation of automatic substitution of biological medicines: a qualitative study. BMJ Open;9(10):e032892.

der Mehrfachsubstitution sowie die Rückmeldung nach Einverständnis des Patienten ist für die deutsche Apotheke in der bestehenden Marktsituation nicht umsetzbar.

[...] Am Beispiel der aktuellen S2e-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) zur Therapie der rheumatoiden Arthritis mit krankheitsmodifizierenden Medikamenten wird deutlich, dass das erste übergeordnete Therapieprinzip eine gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Behandler und Patient ist [187]. Somit sind Änderungen der Behandlung ohne das Einverständnis des Patienten nach dieser Leitlinie nicht vorgesehen. Hintergrund dieser Empfehlung ist die Erfahrung, dass nur im Rahmen einer gemeinsamen Entscheidungsfindung eine adäquate Therapieadhärenz erreicht werden kann, die wesentlich für das Erreichen des Therapieerfolges ist.

- Vergleichbare Aussagen finden sich in Statements der European League Against Rheumatism (EULAR), die explizit auf den Einsatz von biosimilaren Biologika (bsD-MARD) bei der Behandlung von entzündlich-rheumatischen Systemerkrankungen eingehen [188].
- Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieser Empfehlungen ist, dass kein Wechsel ohne vorherige Aufklärung des Patienten und ohne Einbeziehung des behandelnden Arztes erfolgen sollte [188]. Weiterhin wird in diesen Leitlinien empfohlen, dass aufgrund der geringeren Erfahrungswerte ein gehäufter Wechsel von bsDMARD bzw. Originalpräparaten wissenschaftlich im Rahmen von Kohortenstudien und/oder Patientenregistern begleitet werden sollte [189]. Solche Studien werden durch qualifiziertes Fachpersonal mit entsprechender Infrastruktur durchgeführt und dokumentiert. Aktuell liegt die erwartete Sammlung und Bewertung von Erfahrungen aus der Versorgungspraxis (noch) nicht vor.
- Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) erläutert zwar, dass die Entscheidung darüber, ob ein Austausch oder eine Substitution des Referenzarzneimittels mit dem Biosimilar erlaubt ist, auf nationaler Ebene getroffen wird. Dennoch lässt die EMA eine Präferenz für den Wechsel auf Basis einer individuellen Entscheidung des Arztes erkennen: „Eine Entscheidung über den Wechsel sollte der verschreibende Arzt im Gespräch mit dem Patienten und unter Berücksichtigung aller in dem Land geltenden Richtlinien in Bezug auf die Verschreibung und Anwendung von biologischen Arzneimitteln treffen.“ [46]

Daraus folgt, dass die Therapieentscheidung und -umstellung vom Arzt ausgehen muss und nicht auf Apothekenebene geregelt werden sollte.

[...] Unter einem Placebo-Effekt wird eine positive Verstärkung bezüglich der Medikamentenwirksamkeit aufgrund einer positiven Erwartungshaltung bei einem Präparat verstanden, während unter dem Nocebo-Effekt eine Verschlechterung der Medikamentenwirksamkeit, aber auch eine Verstärkung von (vermeintlichen) Nebenwirkungen, aufgrund einer negativen Erwartungshaltung des Patienten zu dem Präparat verstanden wird [168, 190, 191, 192]. Es konnte in zahlreichen Studien gezeigt werden, dass eine negative Erwartungshaltung den Nocebo-Effekt verstärkt, während eine positive Erwartungshaltung den Placebo-Effekt begünstigen kann [...]. Es konnte darüber

187 Fiehn C et al. (2018): S2e guideline: treatment of rheumatoid arthritis with disease-modifying drugs. Z Rheumatol;77(Suppl 2):35-53.

188 Smolen JS et al. (2020): EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2019 update. Ann Rheum Dis;79(6):685-99.

189 Braun J et al. (2018): Revised version of the statement by the DGRh on biosimilars-update 2017. Z Rheumatol;77(1):81-90.

190 Enck P et al. (2013): The placebo response in medicine: minimize, maximize or personalize? Nat Rev Drug Discov;12(3):191-204.

191 Bingel U et al. (2011): The effect of treatment expectation on drug efficacy: imaging the analgesic benefit of the opioid remifentanyl. Sci Transl Med;3(70):70ra14.

192 Petrie KJ et al. (2019): Psychobiological Mechanisms of Placebo and Nocebo Effects: Pathways to Improve Treatments and Reduce Side Effects. Annu Rev Psychol;70:599-625.

hinaus gezeigt werden, dass sowohl der Placebo- als auch der Nocebo-Effekt konditioniert werden können [...]. Unter Konditionierung versteht man eine Beeinflussung einer Reaktion durch externe Faktoren, welche nicht mit der eigentlichen Ursachenfolge, z. B. im biochemischen Sinne bei einer Arzneimittelapplikation, zusammenhängen.

Die Einbeziehung des Patienten in die Entscheidung zur Umstellung ist daher von großer Relevanz. So kann der Nocebo-Effekt – wie auch der Placebo-Effekt – als Resultat aus der Arzt-Patienten-Kommunikation im Zusammenhang mit der Erwartungshaltung des Patienten an die Behandlung auftreten und den Therapieerfolg entscheidend beeinflussen [193].

Der Nocebo-Effekt ist zudem in der Rheumatologie schon seit Längerem im praktischen Alltag ein bekanntes Problem [...]. So führen negativ formulierte Vorsichtsmaßnahmen des am häufigsten eingesetzten Präparats Methotrexat zu einer negativen Erwartungshaltung bei den Patienten und damit zu einem verstärkten Nocebo-Effekt, welches den Einsatz dieses Präparates deutlich erschwert [166, 194]. Vielfach werden auch hier Informationen aus externen Quellen herangezogen. Das Erzeugen von negativen Erwartungshaltungen gegenüber einem Medikament oder einer Medikamentengruppe stellt deshalb eine reale Gefahr bezüglich des Therapieerfolges in dieser Patientengruppe dar. Es existieren zwar Empfehlungen zur Beeinflussung des Placebo- und Nocebo-Effektes [195], aber diese sind aktuell in der rheumatologischen Behandlungspraxis nicht fest etabliert und nicht Teil der Behandlungsleitlinien.

Zusammengefasst lässt sich eine reduzierte Medikamentenpersistenz nach einem nicht medizinisch indizierten Wechsel zum einen durch den Nocebo-Effekt, zum anderen aber auch durch Beschwerden, welche durch den Präparate-Wechsel selbst bedingt sein können, erklären. Dazu zählen z.B. Reaktionen wie vermehrtes Brennen an der Einstichstelle, z.B. bedingt durch andere Zusatzstoffe in der neuen Injektionslösung oder durch Schwierigkeiten mit der Handhabung des neuen Pens.

Biogen

Die Biogen GmbH begrüßt grundsätzlich die Zielsetzung den Zugang zu biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln durch die Förderung von Biosimilars zu verbessern und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu stärken. Als forschendes biopharmazeutisches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Biologika und Biosimilars unterstützt die Biogen GmbH grundsätzlich Maßnahmen, die eine qualitativ hochwertige, sichere und nachhaltige Patientenversorgung ermöglichen.

Gleichzeitig sieht die Biogen GmbH die im Entwurf vorgesehene automatische Substitution biotechnologisch hergestellter Arzneimittel in Apotheken sehr kritisch. Der Austausch komplexer Biologika/Biosimilars ohne ärztliche Einbindung birgt aus Sicht des Unternehmens erhebliche Risiken für die Patientensicherheit, die Therapiekontinuität sowie die Nachvollziehbarkeit und Qualität der Versorgung. Die Biogen GmbH ist überzeugt, dass ein Wechsel zwischen Biologika/Biosimilars – insbesondere bei chronisch erkrankten Patienten – stets individuell begleitet, medizinisch begründet und sorgfältig dokumentiert erfolgen muss.

Vor diesem Hintergrund hält die Biogen GmbH es für erforderlich, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) den aktuellen Entwurf des § 40c AM-RL an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zurückverweist, um eine grundlegende Neubewertung dieses Teils des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) zu ermöglichen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Regelung den hohen Anforderungen an

193 Hansen E et al. (2019): Nocebo Effects and Negative Suggestions in Daily Clinical Practice - Forms, Impact and Approaches to Avoid Them. Front Pharmacol;10:77.

194 Arnold MH et al. (2016): Nocebo effects in practice: methotrexate myths and misconceptions. Med J Aust;205(10):440-2.

195 Evers AWM et al. (2018): Implications of Placebo and Nocebo Effects for Clinical Practice: Expert Consensus. Psychother Psychosom;87(4):204-10.

Patientensicherheit, Therapietreue und Versorgungsqualität gerecht wird.

[...] Die Austauschbarkeit innerhalb einer Gruppe ähnlicher Biologika wurde im Hinblick auf Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung nachgewiesen und von zuständigen Behörden wie der EMA und der FDA anerkannt. In diesem Zusammenhang haben die EMA und die HMA eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die auf allen verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und den erfolgreichen Erfahrungen mit Biosimilars in der klinischen Praxis basiert. Darin wird bestätigt, dass in der EU zugelassene Biosimilars mit ihrem Referenzarzneimittel oder einem gleichwertigen Biosimilar austauschbar sind [59].

Im Gegensatz zu klassischen Generika handelt es sich bei Biosimilars jedoch nicht um wirkstoffgleiche Arzneimittel. Biologische Arzneimittel sind hochkomplexe Moleküle, deren Herstellung und Charakterisierung deutlich aufwändiger ist. Biosimilars sind dem Referenzprodukt lediglich ähnlich, nicht jedoch identisch [46]. Daher ist eine vollständige Austauschbarkeit wie sie bei Generika gegeben ist bei Biosimilars kritisch zu betrachten. Diese Unterschiede müssen bei der Bewertung der Austauschbarkeit berücksichtigt werden.

Auch wenn der austauschbare Einsatz von Biosimilars sicherlich dazu beitragen kann, mehr Patienten den Zugang zu lebenswichtigen biologischen Arzneimitteln – etwa zur Behandlung chronischer und lebensbedrohlicher Erkrankungen wie immunvermittelter entzündlicher Erkrankungen (IMIDs) – zu ermöglichen und gleichzeitig erhebliche Einsparungen für die Gesundheitssysteme zu erzielen, müssen mehrere wichtige Aspekte berücksichtigt werden, um eine sichere und wirksame Umsetzung des Austauschs sicherzustellen [8].

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass der Wechsel vom Referenzbiologikum zu einem Biosimilar oder zwischen verschiedenen Biosimilars einen kritischen Moment im Behandlungsverlauf eines Patienten darstellt. Die Umstände, unter denen dieser Wechsel erfolgt, sind entscheidend für die sachgerechte Anwendung des Arzneimittels und die sichere Fortführung der Behandlung. In der Tat beschreibt das IQWiG in seiner Gesundheitsinformation zu Biologika/Biosimilars nach dem Wechsel zu einem Biosimilar die Notwendigkeit einer engmaschigen Überwachung eines Patienten wie zu Beginn der Anwendung mit einem Biologikum. Auch die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) empfiehlt in ihrem Leitfaden zu Biosimilars den Wechsel nur unter ärztlicher Begleitung und Information des Patienten [65].

Vor diesem Hintergrund spricht sich diese Stellungnahme für einen verantwortungsvollen und individuell begleiteten Austausch von Biologika/Biosimilars aus. Eine automatische Substitution in der Apotheke ohne ärztliche Einbindung wird daher unter anderem aus Gründen der Patientensicherheit und Therapiekontinuität kritisch bewertet.

[...] Die [...] Unterschiede zwischen biotechnologisch hergestellten Fertigarzneimitteln hinsichtlich sonstiger Bestandteile und Hilfsstoffen, Applikationshilfen, Lagerbedingungen und produktspezifischer Risiken verdeutlichen, dass eine automatische Substitution in der Apotheke nicht pauschal erfolgen kann. Vielmehr bedarf es einer differenzierten Betrachtung der jeweiligen Produkteigenschaften, um Patientensicherheit, Therapietreue und eine sachgerechte Anwendung zu gewährleisten. Eine klare Kennzeichnung substituierbarer Produkte sowie eine transparente Kommunikation über Unterschiede in Handhabung und Lagerung sind essenziell, um Risiken zu minimieren und die Versorgungsqualität zu sichern.

[...] Viele Fachleute betonen, dass ein Wechsel zwischen Biologika/Biosimilars grundsätzlich wie eine Neueinstellung begleitet werden sollte – mit entsprechender ärztlicher Aufklärung, Überwachung und Dokumentation. Eine automatische Substitution in der Apotheke lässt diese begleitenden Maßnahmen jedoch nicht zu und steht damit im Widerspruch zu etablierten Standards der Versorgung.

Zwar sind Herausforderungen durch Präparatewechsel nicht grundsätzlich neu und auch bei Generika ist ein gewisses Maß an Schulung erforderlich. Doch bei Biologika/Biosimilars ist die Problematik aufgrund der komplexeren Anwendung und der sensibleren Patientengruppen

potenziell gravierender. Wenn biologische Arzneimittel in bestehende Substitutionssysteme aufgenommen werden sollen, wäre es daher sinnvoll, eine Begrenzung der Wechselhäufigkeit einzuführen. Dies könnte helfen, Therapieunterbrechungen zu vermeiden, die Patientensicherheit zu erhöhen und die Belastung durch häufige Produkthanpassungen zu reduzieren [8].

[...] Mehrere internationale und nationale wissenschaftliche Fachgesellschaften betonen die zentrale Bedeutung der gemeinsamen Entscheidungsfindung, das sogenannte Shared-Decision-Making, insbesondere beim Einsatz von Biologika/Biosimilars. So empfehlen die EULAR-Leitlinien zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis (2022) sowie auch im Update von 2025, die auf dem EULAR Kongress vorgestellt wurde, dass die Therapie auf eine bestmögliche Versorgung abzielen und auf einer gemeinsamen Entscheidung zwischen Patient und Rheumatologe basieren sollte [196]. Ebenso betonen die EULAR-Leitlinien zur medikamentösen Behandlung der Psoriasis-Arthritis (2023), dass die Therapieentscheidung unter Berücksichtigung von Wirksamkeit, Sicherheit, Patientenpräferenzen und Kosten gemeinsam getroffen werden muss [197]. Auch die American College of Rheumatology (ACR) spricht sich in ihrer Stellungnahme zu Biosimilars (2022) für patientenzentrierte Leitplanken bei erzwungenen Wechseln zwischen Biosimilars aus, um ein gesundes Marktumfeld zu fördern, die Nutzung von Biosimilars zu steigern und so sowohl Kosten zu senken als auch den Zugang zu wirksamen Therapien zu verbessern [24]. Die Leitlinien der European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) zur Therapie des Morbus Crohn (2024) unterstreichen ebenfalls, dass die gemeinsame Entscheidungsfindung im interdisziplinären Team grundlegend für eine patientenzentrierte Versorgung ist [198]. Ein vergleichbares Vorgehen empfehlen auch die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN). Demnach sollte die Therapieentscheidung im Sinne einer Shared-Decision-Making gemeinsam von Arzt und Patienten getroffen werden. Dabei werden die Vor- und Nachteile einer krankheitsmodifizierenden Therapie (DMT) ausführlich besprochen. Die Wahl der Therapie folgt somit zunehmend einem personalisierten Ansatz [199].

Celltrion

Die geplante Regelung darf nicht zu einer impliziten Verlagerung ärztlicher Verantwortung auf die Apotheke führen. Apothekern fehlen regelmäßig zentrale Informationen wie die verordnungsbegründende Indikation oder individuelle klinische Besonderheiten, die für eine therapeutisch verantwortbare Substitution biologischer Arzneimittel erforderlich wären.

Eine Substitution kann daher nicht auf eine eigenständige Bewertung durch die Apotheke gestützt werden, sondern bedarf klarer, regelgebundener Voraussetzungen. Die pharmazeutische Zuständigkeit endet dort, wo ärztliche Therapieentscheidungen betroffen sind.

Die gesetzlich verankerte Forderung nach therapeutischer Vergleichbarkeit ist dabei nicht mit der bloßen Zulassung als Biosimilar gleichzusetzen. Vielmehr fokussiert die Forderung auf die Frage, ob und unter welchen Bedingungen – insbesondere im Falle mehrfacher Produktwechsel – klinisch relevante Unterschiede, Adhärenzprobleme oder immunologische Effekte zu erwarten sind, die die Sicherheit oder Wirksamkeit beeinträchtigen könnten.

Fresenius Kabi

196 Smolen JS et al. (2025): EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis - 2025 Update. Wien: Präsentation auf dem EULAR-Kongress 2025.

197 Smolen JS et al. (2023): EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2022 update. Ann Rheum Dis;82(1):3-18.

198 Gossec L et al. (2024): EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2023 update. Ann Rheum Dis;83(6):706-19.

199 Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) e.V.: S2k-Leitlinie Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose, Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen und MOG-IgG-assoziierten Erkrankungen. 2025.

Der Therapieerfolg beim Einsatz von so hochpreisigen und hocheffektiven Arzneimitteln, wie biotechnologisch hergestellte Arzneimittel sie darstellen, sollte nicht durch eine Verlagerung der ärztlichen Verantwortung auf die Apotheke gefährdet werden. In der Apotheke liegen entscheidende Informationen wie verordnungsbegründende Indikation oder individuelle klinische Besonderheiten des Patienten im Regelfall nicht vor. Daher darf sich eine verantwortungsvolle Substitution biologischer Arzneimittel nicht allein auf den Ermessensspielraum des einzelnen Pharmazeuten stützen. Hier bedarf es klar definierter Bewertungsregeln und einer verpflichtenden, regelgebundenen Kommunikation und Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure in der Patientenversorgung.

GSK

Biologika und Biosimilars unterscheiden sich grundlegend von klassischen Generika. Aufgrund ihrer komplexen molekularen Struktur und der biologischen Produktionsweise sind auch bei hoher Übereinstimmung minimale Unterschiede in Proteinstruktur, Glykosylierung oder Aggregationsverhalten unvermeidlich. Diese können die Immunogenität beeinflussen und potenziell klinisch relevante immunologische Reaktionen hervorrufen.

- *Weise et al. (2014) heben hervor, dass Immunogenität bei biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln ein komplexes, multifaktorielles Thema bleibt, das unter anderem durch die Applikationsart, das Behandlungsschema sowie patienten- und krankheitsbezogene Faktoren beeinflusst wird. Die Autor:innen machen deutlich, dass die Extrapolation von Immunogenitätsdaten zwischen Indikationen keineswegs selbstverständlich ist, sondern jeweils einer überzeugenden wissenschaftlichen Begründung bedarf. Besonders relevante Unterschiede im immunologischen Risikoprofil – etwa in Bezug auf Komedikation, Komorbiditäten oder Immunstatus – müssen dabei berücksichtigt werden [200].*
- *Cohen et al. (2018) bestätigen, dass trotz fehlender signifikanter Unterschiede in der Mehrzahl der Studien ein engmaschiges Monitoring bei Substitution empfohlen wird, insbesondere bei Patientengruppen, bei denen Sicherheit und Wirksamkeit besonders sorgfältig beobachtet werden müssen. Einzelne Berichte über verstärkte Immunantworten oder Wirkverlust unterstreichen die Notwendigkeit eines vorsichtigen Vorgehens bei wiederholtem Austausch [201].*

Patient:innen mit chronischen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder onkologischen Indikationen sind häufig multimorbid und in komplexe Medikationsregime eingebunden. In dieser vulnerablen Gruppe können Wechsel von bekannten Arzneimitteln zu neuen Produkten erhebliche psychologische Belastungen hervorrufen.

- *Burnier (2024) betont, dass chronisch erkrankte Patient:innen stark auf Kontinuität in ihrer Medikation angewiesen sind. Jeder nicht indizierte Wechsel – etwa im Rahmen einer Apothekensubstitution – kann zu Verunsicherung, Misstrauen gegenüber der Behandlung und erhöhter Angst vor Nebenwirkungen führen. Solche psychischen Reaktionen gelten als bedeutender Risikofaktor für Therapieabbrüche und eine reduzierte Einnahmetreue [202].*
- *Claxton et al. (2001) zeigen, dass selbst geringfügige Veränderungen in der Medikation – etwa beim Aussehen, Handelsnamen oder der Applikationsform – das Vertrauen in die Therapie erheblich mindern können. Dies betrifft besonders ältere oder kognitiv eingeschränkte Patient:innen, bei denen Medikationspläne ohnehin schwer zu*

200 Weise M. et al. (2014): Biosimilars: the science of extrapolation. Blood 2014, 124(22):3191-3196.

201 Cohen HP et al. (2018): Switching Reference Medicines to Biosimilars: A Systematic Literature Review of Clinical Outcomes. Drugs;78(4):463-78.

202 Burnier M (2024): The role of adherence in patients with chronic diseases. European Journal of Internal Medicine;119:1-5.

überblicken sind [203].

- *D'Amico et al. (2021) beschreiben, dass negative Erwartungen im Zusammenhang mit einem Wechsel auf ein Biosimilar das Auftreten subjektiver Nebenwirkungen verstärken und die empfundene Wirksamkeit verringern können. Dies ist insbesondere bei Patient:innen mit langjährig stabiler Einstellung relevant [204].*
- *In der Praxis berichten Krankenhaus-Apotheker:innen von deutlichem Mehraufwand, Vertrauensverlust und Verunsicherung bei Patient:innen, wenn Biosimilars automatisch und ohne adäquate Aufklärung substituiert werden. Eine qualitative Analyse von Pawłowska et al. (2019) zeigen, dass dreiviertel der befragten Apotheker:innen einen automatisierten Austausch ohne ärztliche Rücksprache kritisch sehen, da sie sich nicht in der Lage fühlen, den Wechsel ohne Irritation der Patient:innen durchzuführen. Zusätzlich gaben 88 % der Teilnehmenden an, dass sie Biosimilars nicht als identisch zum Referenzarzneimittel wahrnehmen – ein Vorbehalt, der in der Versorgungspraxis häufig zu längeren Beratungsgesprächen, Rücksprachen mit den verschreibenden Ärzt:innen („aut idem erlaubt?“) und nicht selten zur Abgabe des Originalpräparats mit Sonder-PZN führt, um die Therapietreue aufrechtzuerhalten [205].*

[...] Die Umsetzung des automatischen Austauschs bringt erhebliche praktische Herausforderungen mit sich. Apotheker:innen müssen geeignete Austauschpräparate auswählen, die Abgabe dokumentieren und Patient:innen umfassend aufklären – meist ohne Zugriff auf vollständige Krankengeschichte oder Laborwerte. Aus dem Berufsalltag berichten Apotheker:innen immer wieder, dass sie bei automatischer Substitution zunehmend mit komplexen Fragestellungen konfrontiert sind – ohne Zugriff auf vollständige Therapieinformationen. Dies erschwert eine fundierte Beratung und fördert Rückfragen bei Ärzt:innen, insbesondere wenn Unsicherheit über die Substitutionsfreigabe besteht.

- *Arnet et al. (2021) identifizieren in einer multinationalen Umfrage unter Apotheker:innen erhebliche Wissenslücken und Unsicherheiten im Umgang mit Biosimilars. Mehr als die Hälfte der Befragten fühlte sich nicht ausreichend vorbereitet auf die Substitution biologischer Arzneimittel. Viele äußerten den Wunsch nach klaren Richtlinien und zusätzlicher Schulung, um Substitutionen sicher durchführen und Patient:innen angemessen beraten zu können. Die Autor:innen betonen, dass ohne fundierte Informationen und standardisierte Abläufe die sichere Umsetzung in der Offizinpraxis erschwert ist [206].*
- *In der Praxis stellt sich der automatische Austausch von Biosimilars häufig als zeit- und beratungsintensiv dar – insbesondere, wenn Patient:innen über das geänderte Präparat nicht vorinformiert wurden.*
- *Eine praxisnahe ABDA-Umfrage unter rund 1.100 Apotheken zeigt, dass bei bis zu 40 % der E-Rezepte technische Probleme auftreten – etwa fehlende Signaturen oder verzögerte Freigabe. Dieser Umstand führt zu Verzögerungen, erhöhtem Beratungsbedarf und zusätzlichen Rückfragen bei Ärzt:innen. Zudem ist die elektronische Patientenakte (ePA) noch nicht ausreichend in den Apothekenalltag integriert, was die sichere Umsetzung weiter erschwert.*

[...] Biosimilars unterscheiden sich mitunter in Verpackung, Handelsnamen, Applikationshilfen oder Handhabung. Gerade bei älteren, multimorbiden oder kognitiv eingeschränkten

203 Claxton AJ et al. (2001): A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. *Clinical Therapeutics*;23(8):1296-310.

204 D'Amico F et al. (2020): Nocebo effect and biosimilars in inflammatory bowel diseases: what's new and what's next? *Expert Opinion on Biological Therapy*;21(1):47-55.

205 Pawłowska I et al. (2019): Perspectives of Hospital Pharmacists Towards Biosimilar Medicines: A Survey of Polish Pharmacy Practice in General Hospitals. *BioDrugs*;33(2):183-91.

206 Arnet I et al. (2021): Community pharmacists' preparedness for substituting biologics and dispensing biosimilars – Lessons learned from a multinational survey. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*;4.

Patient:innen führen diese Unterschiede zu Unsicherheit, Applikationsfehler und erhöhter Non-Compliance.

- Dutcher et al. (2020) zeigen, dass Real-World-Daten zur Bewertung von Biosimilar-Wechseln bislang methodisch limitiert sind – insbesondere fehlen häufig Informationen zur ärztlichen Kommunikation oder zu patientenrelevanten Outcomes wie Adhärenz oder Medikationssicherheit. Die Autor:innen betonen, dass solche Daten jedoch essenziell sind, um potenzielle Risiken wie Unsicherheit oder Therapieabbrüche in der Praxis besser zu erfassen [207].
- Wiederholte Wechsel ohne nachvollziehbare Begründung schwächen das Vertrauen in die Therapie und in das Gesundheitssystem. Gerade in der Langzeitversorgung ist dieses Vertrauen ein zentraler Erfolgsfaktor für die Therapie.

Lilly

Biopharmazeutika kommen in der Regel in hochkomplexen Krankheitssituationen, häufig bei schweren chronischen Erkrankungen, zum Einsatz. Eine enge ärztliche Betreuung des therapiebedürftigen Patienten ist daher für den Therapieerfolg essenziell. Ein unnötiger Therapiewechsel infolge der automatischen Substitution in der Apotheke, insbesondere da der Austausch außerhalb des gewohnten Arzt-Patienten-Verhältnisses stattfindet, beeinflusst die Therapieadhärenz des Patienten negativ. Auch ist davon auszugehen, dass, in Abhängigkeit von der Anzahl der im Markt verfügbaren Biosimilars je biotechnologisch hergestelltem Referenzarzneimittel, der Anzahl der nach 130a Absatz 8 SGB V rabattierten Präparate, der Lieferfähigkeit der jeweiligen Produkte oder auch der Vorratshaltung der gerade durch den Patienten aufgesuchten Apotheke, Patienten häufig von Präparat-Umstellungen betroffen sein werden. Der Wechsel eines dem Patienten bereits bekannten und gut eingestellten Produktes kann Verunsicherungen bei diesem verursachen und zu einem Nocebo-Effekt beitragen. Für den Patienten entsteht dadurch eine zusätzliche Belastung in der bereits bestehenden schwierigen Krankheitssituation. Aus Sicht von Lilly ist davon auszugehen, dass die Ersetzung von Referenzarzneimitteln durch Biosimilars durch Apotheken im Bereich der biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel die Therapieadhärenz deutlich stärker beeinflusst als im Bereich der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel, welche in parenteralen Zubereitungen eingesetzt werden, da sie vom Patienten selbst angewendet werden und i.d.R. kein weiterer Arztkontakt stattfindet.

[...] Die automatische und regelhafte Substitution von Biopharmazeutika durch Biosimilars in Apotheken ist aufgrund vielfältiger Gesichtspunkte als kritisch einzustufen:

Ein Therapiewechsel ohne medizinische Begründung sowie ohne die Berücksichtigung von krankheitsspezifischen und patientenindividuellen Aspekten in den zumeist schwerwiegenden Krankheitssituationen führt nicht nur hin zu einer allein ökonomisch basierten Steuerung der Verordnungen, sondern stellt einen erheblichen Eingriff in die medizinisch fundierte Therapiewahl des Arztes dar. Dies verschiebt die Verantwortung zum Austausch und zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Anwendung durch die Patienten auf das Fachpersonal in den Apotheken, das ohnehin bereits aufgrund fehlender personeller Kapazitäten belastet ist und dieses auch fachlich nicht immer gewährleisten kann. Die Abstimmung zwischen Arzt und Patient ist insgesamt als essenziell für den Therapieerfolg anzusehen.

Eine eindeutige Identifizierung und Rückverfolgung der verordneten und abgegebenen Biopharmazeutika bzw. Biosimilars fördert die Transparenz und dient der Arzneimittelsicherheit. Dies ist besonders wichtig dahingehend, dass zwar eine Ähnlichkeit besteht, aber aufgrund der Unterschiede auf molekularer Ebene und im Herstellungsprozess Biologika und Biosimilars nicht identisch sind.

207 Dutcher SK et al. (2019): Using real-world data to evaluate biosimilar switching. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*;29(7):814-6.

Der bereits bestehende Wettbewerb im biopharmazeutischen Markt ist durch den Eintritt neuer Biosimilars sowie angesichts der steigenden Marktdurchdringung von Biosimilars von einer großen Dynamik geprägt und umfangreiche Einsparungen werden bereits generiert. Das Eingreifen der Politik durch weitere Maßnahmen, wie der geplanten automatischen Substitution in der Apotheke, ist in diesem Zusammenhang nicht erforderlich, sondern als kontraproduktiv anzusehen.

Aufgrund der genannten Aspekte hinsichtlich bereits bestehender Einsparinstrumente, der Notwendigkeit einer durch eine vorliegende Evidenz belegten Unbedenklichkeit der Umstellung sowie einer stetigen Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit im Kontext einer ausreichenden Patientenschulung und Nachverfolgbarkeit des abgegebenen Arzneimittels, ist es aus Sicht von Lilly unverzichtbar, mindestens Regularien gemäß der Position B2 aufzustellen. Im Sinne der Arzneimittelsicherheit und des Patientenschutzes ist weiterhin zu empfehlen, biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel, für die das Wirtschaftlichkeitspotential durch Rabattverträge nach § 130a Absatz 8 SGB V oder durch Gültigkeit von Festbetragsregelungen im Sinne des § 35 Abs. 5 SGB V bereits ausgeschöpft ist, grundsätzlich von der Ersetzung durch Apotheken auszunehmen.

Medac

Biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel unterscheiden sich von niedermolekularen Wirkstoffen durch den komplexen Herstellungsprozess in lebenden Organismen. Anders als bei herkömmlichen Arzneimitteln kommt es nach dem Patentablauf nicht zur Markteinführung von Generika, sondern von Biosimilars nach einem europaweiten eigenständigen Zulassungsverfahren.

Ihr Einsatz zur Bekämpfung unter anderem vieler chronischer Krankheiten erfolgt oftmals über lange Behandlungszeiträume hinweg. Das heißt, eine hohe Adhärenz ist hier unabdingbar für einen therapeutischen Erfolg, insbesondere bei chronischen Erkrankungen wie beispielsweise der Rheumatoider Arthritis, Morbus Crohn oder Psoriasis. (Wiederholte) Umstellungen des therapeutisch verordneten Biologicals tragen zur Steigerung mangelnder Adhärenz beim Patienten bei und sind daher unter Beachtung der medizinischen Wirksamkeit und Sicherheit sowie des Patientenwohls, letztlich aber auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen abzulehnen.

Daher ist mit guten Gründen in vielen europäischen Ländern die automatische Substitution nicht erlaubt und wird von vielen ärztlichen und pharmazeutischen Organisationen abgelehnt. medac plädiert dafür, dass der Wechsel von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln allein durch die behandelnde Ärztin oder Arzt erfolgen muss. Dies soll aus medizinischen Gründen nicht in der Apotheke erfolgen dürfen.

Merck

Merck spricht sich gegen die Ausweitung der automatischen Substitution von Biopharmazeutika in der Apotheke auf Arzneimittel zur Selbstapplikation aus. Diese ergänzende Steuerung des Biosimilar-Einsatzes ist bei Selbstapplikation nicht sinnvoll umsetzbar. Der G-BA sollte auf die Aufnahme dieser Applikationsart in § 40c in der Arzneimittel-Richtlinie verzichten. Therapiewechsel aus rein wirtschaftlichen Gründen ohne Beteiligung der behandelnden Ärzte können selbstapplizierende Patienten massiv verunsichern, die Therapieadhärenz und den Therapieerfolg beeinträchtigen. Dadurch verlagert sich die Therapiehoheit zunehmend zur Apotheke, die Haftung jedoch verbleibt beim Arzt.

Novartis

Novartis sieht durch die vom Gesetzgeber vorgegebene Einführung der automatischen Substitution von Biologika in Apotheken grundsätzlich keinen Vorteil in der Patientenversorgung. Vielmehr konterkariert der geplante § 40c zur AM-RL und seine implizite Referenz zur Anlage VIIa die Vorgaben der ärztlichen Aufklärung und Verordnung nach § 40a und die vom Gesetzgeber gewünschte Erhöhung der Patientensicherheit nach dem GSAV und

impliziert eine riskante Vergleichbarkeit des Austausches wie bei Generika.

[...] Neben den wirtschaftlichen Aspekten sieht Novartis ferner einen enormen Mehraufwand auf administrativer und logistischer Ebene für Apotheken und Arztpraxen in einem bereits sehr stark belasteten System. Ein Beispiel hierfür ist der stark erhöhte Schulungsbedarf auf Seiten der Apotheken bei einer Vielzahl an unterschiedlichen Krankheitsgebieten und Applikationssystemen. Aus Gründen der verpflichtenden Rückverfolgbarkeit besteht ein stark erhöhter Aufwand hinsichtlich Chargendokumentation im Sinne der produktspezifischen Risikomanagementpläne. Außerdem werden aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster Produkte hohe Ressourcen hinsichtlich Lagerung und Kühlung in Apotheken und Praxen benötigt.

Novo Nordisk

Biopharmazeutika kommen i.d.R. in sehr komplexen Erkrankungs- und Therapiesituationen zum Einsatz. Aus diesem Grund ist es sachgerecht die Therapieentscheidung allein bei Ärzt:innen zu verankern. Ärzt:innen sollten die Therapieentscheidung unter der Gesamtbetrachtung der vorliegenden Evidenz, auf Basis medizinischer Überlegungen, sowie wissenschaftlicher Belege und unter Berücksichtigung der individuellen Situation der Patient:innen treffen. Die Beachtung der Wirtschaftlichkeit und entsprechende produktspezifische Dokumentation ist hierbei Teil des Prozesses. Ein patientenindividueller Austausch in Apotheken ist nicht möglich, da Apotheken weder die Anamnese noch die Diagnose der Patient:innen kennen. Gerade die sensible Anwendung biologischer Arzneimittel durch Patient:innen außerhalb der ärztlichen Überwachung sollte nicht ungewollten und unvorhergesehenen Einflüssen unterliegen, die Ärzt:innen nicht mit ihren Patient:innen besprechen können. Hierbei sind insbesondere mögliche Unverträglichkeitsreaktionen sowie allergische Reaktionen zu nennen, die durch die unterschiedliche Immunogenität der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel bedingt sein können. Des Weiteren kommt bei der Anwendung eines biotechnologisch hergestellten Arzneimittels durch die Patient:innen der Applikationsart und der Darreichungsform ein besonderer Stellenwert in der Arzneimitteltherapiesicherheit zu.

Biotechnologisch hergestellte Arzneimittel sind komplexe und injizierbare Arzneimittel, die nicht mit Arzneimitteln mit sogenannten „small molecule“-Wirkstoffen, wie im Fall der Generika gleichzusetzen sind. Aus diesem Grund sollten Instrumente, die den Generika-Markt regeln nicht eins-zu-eins auf den Markt der biotechnologisch hergestellten Fertigarzneimittel übertragen werden. Instrumente zur wirtschaftlichen Verordnungssteuerung sind bereits zahlreich vorhanden und weitreichend wirksam.

Für die Patient:innen unvorhersehbare Arzneimittelwechsel in der Apotheke aus rein wirtschaftlichen Gründen können diese stark verunsichern und damit die Therapieadhärenz und den Therapieerfolg gefährden. Eine Falsch-Anwendung des biologischen Arzneimittels insbesondere durch Patient:innen ohne ärztliche Überwachung kann zu lebensbedrohlichen, arzneimittelsicherheitsrelevanten Risiken führen. Diese Risiken können sich durch die vermehrte Nutzung der online-Apotheken mit der Etablierung des e-Rezeptes noch einmal vergrößern, wenn es auf Apothekenebene zu einem Wechsel des Arzneimittels kommt. Hier sind keine adäquaten Möglichkeiten der Schulung der Handhabung und Anwendung von Injektionsgeräten gegeben.

Novo Nordisk warnt deshalb ausdrücklich davor, Therapiewechsel aus wirtschaftlichen Gründen im hochsensiblen Bereich der Patient:innen-Anwendung von Biopharmazeutika durch Apotheken zu erlauben bzw. zu forcieren.

[...] Dem ist hinzuzufügen, dass auch die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft zu dem Schluss kommt, dass trotz weniger Vorteile, wie die Sicherung der Arzneimittelversorgung und Kostenreduktion im Gesundheitssystem die Entscheidung zur Substitution von biologischen Arzneimitteln bei den Ärzt:innen liegen sollte. Nach Einschätzung der AkdÄ bedarf

es bei Neu- oder Ersteinstellungen von Biosimilars einer „[...] besonderen ärztlichen Information und Aufklärung der Patient:innen [...]“ [65].

Ratiopharm

Biologika unterscheiden sich grundlegend von klassischen, chemisch-synthetisierten Arzneimitteln, für die Generika entwickelt werden. Während Generika exakte Kopien eines Wirkstoffs darstellen und vergleichsweise einfach zu reproduzieren sind, handelt es sich bei Biologika um hochkomplexe, oft großmolekulare Substanzen, die in lebenden Zellsystemen hergestellt werden. Bereits geringfügige Änderungen in Herstellungsprozessen oder Zelllinien können relevante Auswirkungen auf die Wirksamkeit, Immunogenität und Sicherheit des Endprodukts haben.

Biosimilars sind deshalb keine identischen Kopien, sondern nur „hochähnliche“ Nachfolgeprodukte. Sie müssen im Rahmen eines deutlich aufwändigeren Zulassungsverfahrens umfassende Vergleichsdaten zur Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität liefern. Dieser Prozess ist mit einem erheblich höheren wissenschaftlichen und regulatorischen Aufwand verbunden als bei Generika.

Auch die Entwicklungskosten spiegeln diese Komplexität wider: Während die Entwicklung eines Generikums in der Regel im einstelligen Millionenbereich liegt, belaufen sich die Kosten für ein Biosimilar häufig auf mehrere hundert Millionen Euro – unter anderem aufgrund langwieriger präklinischer Studien, klinischer Prüfungen und analytischer Charakterisierungen.

Trotz regulatorisch definierter Biosimilarität ist daher ein automatischer Austausch in der Apotheke nicht mit der etablierten Generikapraxis vergleichbar. Die Gleichsetzung von Biosimilars mit Generika untergräbt die tatsächliche Komplexität der Moleküle, ihrer Herstellung und der klinischen Überwachung. Eine solche Vereinfachung birgt erhebliche Risiken für die Versorgungsqualität und das Vertrauen in biopharmazeutische Therapien.

[...] Ein automatischer Austausch von Biologika in der Apotheke birgt erhebliche Risiken für die Therapietreue („Adhärenz“) und damit für den langfristigen Therapieerfolg – insbesondere bei chronischen Erkrankungen wie Rheuma, entzündlichen Darmerkrankungen oder Krebs. Patienten, die sich bereits auf ein bestimmtes Präparat eingestellt haben, können durch einen nicht erwarteten oder nicht erklärten Wechsel in der Apotheke verunsichert werden.

Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang der Nocebo-Effekt – also das Auftreten negativer Wirkungen oder das Nachlassen der Therapieakzeptanz infolge negativer Erwartungen oder Misstrauen gegenüber einem neuen Präparat. Studien [208] zeigen, dass dieser Effekt bei Biosimilar-Umstellungen ohne gezielte ärztliche Aufklärung deutlich stärker ausgeprägt sein kann. Das Risiko ist besonders hoch, wenn der Austausch nicht durch den behandelnden Arzt initiiert und begleitet wird, sondern überraschend im Apothekenkontext erfolgt.

Auch Unterschiede in Applikationshilfen, Injektionssystemen oder Schulungsmaterialien können zu Ablehnung, Anwendungsfehlern oder sogar Therapieabbrüchen führen – mit potenziell schwerwiegenden klinischen Folgen.

Der automatische Austausch ohne ärztliche Einbindung kann daher unbeabsichtigt dazu führen, dass sich die Versorgungssituation der Patienten verschlechtert, statt – wie intendiert – verbessert zu werden.

[...] Biotechnologisch hergestellte Arzneimittel werden in der Regel bei chronischen Erkrankungen, die schwierig zu therapieren und somit sehr belastend für die Patienten sind, eingesetzt. Eine echte ursächliche Therapie ist bei multifaktoriell bedingten Erkrankungen, wie z. B. aus dem chronisch-entzündlichen Bereich, oft nicht möglich, so dass sich die Behandlung

208 Rezk MF et al. (2017): Treatment Outcomes with Biosimilars: Be Aware of the Nocebo Effect. Rheumatol Ther;4(2):209-18.

auf die bestmögliche Eindämmung der Symptome konzentrieren muss. Oft geht der Therapie eine jahrelange Leidensgeschichte voraus, die für die Patienten auch psychisch sehr belastend ist. Stress und psychische Belastungen gelten bei Autoimmunerkrankungen wie z. B. Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa als ein möglicher Auslöser für Entzündungsschübe. Somit ist davon auszugehen, dass das Vertrauen in die Therapie und das Vertrauensverhältnis zum Arzt wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Therapie sind.

Ein automatischer Austausch eines verordneten Arzneimittels in der Apotheke schränkt zum einen die ärztliche Kontrollmöglichkeit und die Therapiehoheit ein, denn der Arzt erhält keine Kenntnis davon, welches Präparat der Patient in der Apotheke ausgehändigt bekommt. Er hat keine Möglichkeit, den Patienten über das ausgetauschte Medikament aufzuklären und zu informieren. Der Patient erfährt erst in der Apotheke, dass er nicht sein bekanntes und gewohntes Medikament bekommt, was zu mangelnder Adhärenz bzw. einem Nocebo-Effekt führen kann [66].

Im Leitfaden Biosimilars der Arzneikommission der Ärzteschaft (2. Auflage von Januar 2021) wird empfohlen, den Patienten nach einer Umstellung – wohlgemerkt durch den Arzt – „engmaschig wie bei einer Neueinstellung“ zu überwachen [65]. Weiterhin wird eine ausführliche Information und Beratung im Falle einer Umstellung empfohlen, damit die Adhärenz und der therapeutische Erfolg nicht gefährdet werden [65].

Ein automatischer Austausch konterkariert diesen Empfehlungen und beeinträchtigt im ungünstigsten Fall den langfristigen therapeutischen Erfolg.

Bei den Apotheken wiederum liegen nicht notwendigerweise Informationen zur Verschreibungshistorie vor. Der Patient bekäme so im Extremfall für jede Behandlung ein Medikament von einem anderen Hersteller mit den o.g. Risiken für die Therapie.

[...] Biologika sind hochwirksame, aber erklärungsbedürftige Arzneimittel. Ein respektvoller, transparenter Umgang mit der Therapieentscheidung – gemeinsam zwischen Arzt und Patient – ist entscheidend für den Therapieerfolg. Ein automatischer Austausch in der Apotheke untergräbt dieses Prinzip und gefährdet so eine stabile, vertrauensvolle und informierte Behandlung.

[...] Die vorgesehene Ergänzung des § 40c SGB V zur Einführung eines automatischen Austauschs von Biologika in der Apotheke birgt aus unserer Sicht erhebliche medizinische, patientenbezogene und versorgungspraktische Risiken. Anders als bei Generika handelt es sich bei Biologika um komplexe Arzneimittel mit herstellungstechnisch und klinisch relevanten Besonderheiten, die einen automatischen Austausch ohne ärztliche Einbindung problematisch machen.

Die Gefahr von Adhärenzverlust, Nocebo-Effekten und unvollständiger Rückverfolgbarkeit ist hoch und widerspricht der ärztlich begleiteten Versorgungspraxis in Deutschland sowie den europäischen Empfehlungen der EMA und der Europäischen Kommission.

Wir sprechen uns klar gegen die Einführung einer automatischen Apothekensubstitution von Biologika aus und plädieren für eine ärztlich gesteuerte Umstellung im individuellen Dialog mit dem Patienten – im Sinne der Arzneimitteltherapiesicherheit, Versorgungskontinuität und des Vertrauens in unser Gesundheitssystem.

Stadapharm

Mit dem Inkrafttreten des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes im November 2022 wurde der gesetzliche Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) um eine neue Komponente ergänzt: Gemäß § 129 Absatz 1a Satz 6 SGB V soll der G-BA zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung geben. Zur Umsetzung wurde der neue § 40b in die Arzneimittel-Richtlinie aufgenommen.

Die Entscheidung wurde auf Basis eines umfangreichen Stellungnahmeverfahrens gefällt, das

sowohl schriftliche als auch mündliche Beiträge einschloss. Es nahmen zahlreiche pharmazeutische Unternehmen, Fachgesellschaften und Apothekerverbände teil. Die Auswertung der Stellungnahmen verdeutlicht, dass weiterhin große Bedenken gegen eine automatische Substitution von Biologika bestehen – insbesondere hinsichtlich der Definition der Preisgünstigkeit, der Verfügbarkeit der Präparate, der Anforderungen an die Übereinstimmung der Anwendungsgebiete sowie der praktischen Umsetzbarkeit.

Zentrale Kritikpunkte betrafen unter anderem:

- Die fehlende Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Preisgünstigkeit im Rahmen der Hilfstaxe.
- Die mangelnde Verfügbarkeit bestimmter Biosimilars im Markt trotz Zulassung.
- Die Gefahr von Off-Label-Anwendungen, wenn Apotheken Präparate abgeben, die nicht für die konkrete Indikation zugelassen sind.
- Unzureichende Klarheit hinsichtlich Verantwortung, Dokumentation und Haftung bei Substitution durch Apotheken.
- Medizinische Unterschiede, da Biosimilars zwar hochgradig ähnlich zum Originalprodukt, aber nicht identisch sind. Geringfügige Unterschiede in der Zusammensetzung oder Herstellung können bei sensiblen Patienten zu unterschiedlichen Wirkungen oder Nebenwirkungen führen.
- Adhärenz: Ein Wechsel zwischen Original und Biosimilar kann die Behandlungskontinuität stören, insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Patienten, die auf ein bestimmtes Präparat eingestellt sind, könnten durch einen Wechsel Unsicherheiten oder Änderungen in der Wirkung erleben (sg. „Nocebo Effekt“).
- Immunogenität: Biosimilars können ein leicht unterschiedliches Immunogenitätsprofil haben. Ein Wechsel könnte das Risiko für immunologische Reaktionen (z. B. Antikörperbildung) erhöhen, was die Wirksamkeit oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Patientenaufklärung und Akzeptanz: Ein Austausch ohne Rücksprache mit dem Patienten kann das Vertrauen des Patienten in die Therapie beeinträchtigen, besonders wenn der Patient Unterschiede in der Verpackung, Darreichungsform oder Wirkung bemerkt.

Fazit: Ein Austausch durch den Apotheker ist problematisch, da es medizinische, rechtliche und patientenbezogene Risiken birgt.

Diese aktuellen Entwicklungen bestätigen und verstärken die Argumente, die sich bereits aus früheren Verfahren gegen die automatische Substitution ergeben haben. Eine gesetzlich verankerte Substitution von Biologika durch Apotheken ohne direkte ärztliche Steuerung birgt erhebliche Risiken für Patientensicherheit, Therapietreue, Versorgungsstabilität und Arzneimitteltherapiesicherheit. Die vorliegende Stellungnahme berücksichtigt diese neuen regulatorischen Entwicklungen und stützt sich auf die detaillierte Auswertung der Dokumentation des G-BA vom 15. Juni 2023 (§ 40b AM-RL).

[...] Im Gegensatz zu klassischen, chemisch-synthetischen Arzneimitteln, die exakt reproduzierbar sind, handelt es sich bei Biologika um hochkomplexe Moleküle, die in lebenden Zellen produziert werden. Diese Herstellungsweise führt zwangsläufig zu einer gewissen Variabilität zwischen verschiedenen Chargen – beim Originatorprodukt und bei Biosimilars. Biosimilars dürfen laut regulatorischer Definition „keine klinisch relevanten Unterschiede“ im Vergleich zum Referenzarzneimittel aufweisen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie identisch sind.

Die Unterschiede zwischen Biologika und Biosimilars können sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren:

1. **Herstellungsprozess:** Jeder Hersteller entwickelt einen eigenen Herstellungsprozess. Da dieser streng geschützt ist, muss ein Biosimilar-Produzent eigene Zelllinien etablieren und

Produktionsbedingungen neu definieren. Selbst kleine Unterschiede im Herstellungsprozess können die Molekülstruktur beeinflussen, z.B. bei Glykosylierungsmustern.

2. **Formulierung/ Zusammensetzung:** Unterschiede bestehen häufig in Hilfsstoffen, Pufferlösungen, Konservierungsmitteln oder Applikationssysteme. Diese Unterschiede können Auswirkungen auf die Verträglichkeit, Haltbarkeit und Schmerzempfinden bei der Injektion haben.
3. **Applikationssysteme:** Biosimilars können sich in Injektionsvolumen, Nadeldurchmesser, aber auch beispielsweise Formulierungen mit oder ohne Citrat sowie die Verfügbarkeit von Fertiggins oder Fertigspritzen unterscheiden. Diese Faktoren beeinflussen nicht nur die Handhabung, sondern auch das Schmerzempfinden und die Verträglichkeit – insbesondere bei langfristiger Selbstmedikation. Eine automatische Substitution verschiedener Devices schürt Unsicherheit in diesen prekären Patientenpopulationen und forciert Nocebo-Effekte, die vermeidbar wären.
4. **Immunogenität:** Kleine strukturelle Unterschiede können die Immunantwort des Körpers beeinflussen. Während die EMA hohe Anforderungen an die Bewertung der Immunogenität stellt, ist eine vollständige Gleichheit nicht garantiert. Unterschiede im Trägermaterial können z. B. zu Neutralisierungsreaktionen führen. Ein (numerischer) Unterschied in der Immunogenität zwischen Biosimilars, aber auch Originator ist nicht unüblich, der Unterschied darf nur nicht den Anspruch an die Biosimilarität beeinflussen. Bestimmte Patientengruppen könnten hiervon profitieren, wenn der Verschreibende die Therapiefreiheit behält.

Diese Variabilitäten sind auch innerhalb eines Biologikums vorhanden – man spricht hier von Mikroheterogenität. In der Zulassung wird sichergestellt, dass diese Schwankungen im akzeptierten Bereich liegen. Bei einem Wechsel zu einem Biosimilar entstehen jedoch zusätzliche Unsicherheiten, da zwei voneinander unabhängige Produktionssysteme aufeinandertreffen.

[...] Wie aus Studien und praktischer Erfahrung bekannt ist, können nicht-medizinisch begründete Wechsel zu Unsicherheiten bei den Patienten führen, die sich in Therapieabbrüchen oder einer verringerten Adhärenz äußern. Die Abbruchraten nach Umstellung auf Biosimilars variieren in Real-Life-Studien zwischen 3 % und 30 % [66, 67]. Als Hauptursachen werden Nocebo-Effekte, Unsicherheit, Unterschiede in Devices und Handhabung sowie mangelnde Adhärenz benannt. Der Verlust des Vertrauens in das Arzneimittel, insbesondere wenn mehrfach ohne nachvollziehbaren Grund ein Wechsel erfolgt, kann zu einer Unterbrechung oder Beendigung der Therapie führen – mit negativen gesundheitlichen und potenziell auch volkswirtschaftlichen Folgen. Auch die bisher vorliegenden kontrollierten klinischen Daten sowie die real-world-Studien können keine ausreichende Einschätzung zum Risiko der Therapieabbrüche und Adhärenz liefern im Szenario einer automatischen Substitution und dem damit einhergehenden „multiple switching“.

So spielt auch die Erfahrung, die Patienten mit der Injektion sammeln, eine entscheidende Rolle für die Therapietreue (Adhärenz). In Deutschland beenden etwa 50 % der Patientinnen und Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA), ankylosierender Spondylitis (AS) und Psoriasis-Arthritis (PsA) die Therapie mit dem ersten Biologikum bereits innerhalb eines Jahres. Bei Patientinnen und Patienten mit rheumatoider Arthritis wird nach einer mangelnden Wirksamkeit (40,8 %) insbesondere eine negative Erfahrung mit der Injektion (18,4 %) als zweiter Hauptgrund für einen Therapieabbruch angegeben [209].

Studien zeigen, dass strukturierte Patientenprogramme – etwa mit persönlicher Betreuung, Schulungsmaterialien und einer medizinischen Hotline – die Adhärenz signifikant verbessern können. So konnte in einer Studie zu Adalimumab-Patienten in diversen immunologischen Erkrankungen gezeigt werden, dass die Therapietreue bei Patienten mit entzündlich-

209 Bolge SC et al. (2015): Reasons for discontinuation of subcutaneous biologic therapy in the treatment of rheumatoid arthritis: a patient perspective. Patient Prefer Adherence;9:121-31.

rheumatischen Erkrankungen durch ein begleitendes Patientenprogramm um 14 % gesteigert wurde [210]. Programme helfen, Ängste abzubauen, Fragen zeitnah zu klären und die Selbstwirksamkeit der Patienten zu stärken – ein zentraler Faktor für die langfristige Therapietreue.

Allerdings werden solche Programme nicht von allen Herstellern angeboten, da sie mit einem erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden sind. Unter dem zunehmenden Kostendruck im Gesundheitswesen kann es daher vorkommen, dass Patientinnen und Patienten nach einem automatischen Wechsel auf ein anderes Präparat ohne begleitendes Serviceangebot dastehen. In solchen Fällen fehlt ihnen eine klare Anlaufstelle für Fragen oder Unsicherheiten – was das Risiko für Therapieabbrüche zusätzlich erhöht.

Diese Risiken werden durch die automatische Substitution noch verstärkt, da der Wechsel dann eben nicht unter ärztliche Aufklärung begleitet wird. Eine patientenzentrierte Versorgung ist unter diesen Bedingungen nicht gewährleistet. Die Verantwortung für die Auswahl des Arzneimittels sollte daher weiterhin bei der ärztlichen Therapiehoheit liegen.

Die dargestellten Risiken machen deutlich, dass eine automatische Substitution im Bereich der Biosimilars weitreichende medizinische Implikationen hat, die in der bisherigen Bewertung nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit, der individuellen Versorgungskontinuität und des Patientenschutzes ist von einer automatischen Substitution dringend abzuraten.

[...] Darüber hinaus wurde in der Literatur bei der Ein- oder Umstellung auf ein Biosimilar ein sogenannter Nocebo-Effekt beschrieben. Der Nocebo-Effekt ist das Gegenteil des Placebo-Effektes und bezeichnet negative Auswirkungen, die aus negativen Erwartungen resultieren. Dies kann sich in unerwünschten Ereignissen oder einer Verschlechterung der Krankheit äußern, die nicht auf die spezifische Therapie zurückzuführen sind [65].

Mögliche Auslöser des Nocebo-Effektes sind [65]:

- Mangelndes Wissen der Patienten über die Wirksamkeit und Sicherheit von Biosimilars
- Ängste im Zusammenhang mit dem Wechsel von einem Originalpräparat zu einem Biosimilar
- Das Gefühl, dass Biosimilars nur aus wirtschaftlichen Gründen verschrieben werden
- Widersprüchliche Informationen für den Patienten

Der Nocebo-Effekt beeinträchtigt die Lebensqualität der Patienten und die Therapietreue, was indirekt die Behandlungseffektivität reduzieren kann. Studien deuten darauf hin, dass der Nocebo-Effekt die Akzeptanz von Biosimilars beeinflussen kann, wobei die Abbruchraten in offenen Studien höher sind als in doppelblinden Studien [65, 211].

Im Juli 2018 erkannte die europäische "NOCE-BIO Consensus Group" an, dass alle Gesundheitsfachkräfte, die Patienten mit Biosimilars behandeln, sich des Nocebo-Effektes bewusst sein und Strategien zur Minimierung entwickeln sollten. Auch Pflegekräfte spielen dabei eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Verbesserung des Wissens der Patienten über CED und Biosimilars sowie bei der Bereitstellung spezifischer Informationen über das verwendete Biosimilar, einschließlich des Nebenwirkungsmanagements [211]. Auch die AkdÄ empfiehlt eine transparente und ausführliche Aufklärung der Patienten [65].

Der Nocebo-Effekt ist wissenschaftlich gut dokumentiert und tritt insbesondere dann auf, wenn Patientinnen und Patienten das Gefühl haben, einer Therapie ausgeliefert zu sein, deren Rahmenbedingungen sie nicht nachvollziehen können. Im Kontext von Biosimilar-Wechseln

210 Rubin DT et al. (2017): Impact of a Patient Support Program on Patient Adherence to Adalimumab and Direct Medical Costs in Crohn's Disease, Ulcerative Colitis, Rheumatoid Arthritis, Psoriasis, Psoriatic Arthritis, and Ankylosing Spondylitis. J Manag Care Spec Pharm;23(8):859-67.

211 D'Amico F et al. (2020): Multidisciplinary management of the nocebo effect in biosimilar-treated IBD patients: Results of a workshop from the NOCE-BIO consensus group. Dig Liver Dis;52(2):138-42.

bedeutet dies: Erfolgt eine Substitution ohne vorherige ärztliche Aufklärung, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten dem neuen Präparat skeptisch gegenüberstehen. Diese Skepsis kann sich in subjektiv wahrgenommenem Wirkverlust, neuen oder verstärkten Nebenwirkungen sowie in einer sinkenden Therapieadhärenz äußern.

Die Angst von Patienten vor einem Qualitätsverlust beim Wechsel auf ein Biosimilar kann einen Nocebo-Effekt auslösen. Studien zeigen, dass in offenen (Open-Label-) Studien die Abbruchraten und Nebenwirkungen deutlich höher sind als in doppelblinden Studien – ein Hinweis auf die Bedeutung des Nocebo-Effekts [67].

Eine gezielt positive Kommunikation („positives Framing“) im Aufklärungsgespräch erhöht die Wechselbereitschaft der Patienten und steigert die wahrgenommene Wirksamkeit des Biosimilars. Umgekehrt verstärkt negatives Framing die Ablehnung und den Nocebo-Effekt.

Der Nocebo-Effekt kann die Lebensqualität und die Therapietreue (Adhärenz) der Patienten senken. Dies führt nicht selten dazu, dass eigentlich wirksame Therapien abgebrochen oder wieder auf das Originalpräparat gewechselt werden, was die erhofften Kosteneinsparungen durch Biosimilars gefährdet [212]. Ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis und eine wissenschaftlich fundierte, ausgewogene Information sind entscheidend, um den Nocebo-Effekt zu minimieren und die Akzeptanz von Biosimilars zu verbessern.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) fordert für alle neuen (auch biologischen) Arzneimittel einen Risikomanagementplan (RMP), der u.a. Informationsmaterialien und eine gezielte ärztliche Aufklärung vorsieht. Ein persönliches Aufklärungsgespräch ist daher verpflichtend, um Risiken zu minimieren und die Patientensicherheit zu gewährleisten [46].

Der automatische Austausch an der Apotheke untergräbt genau diese Kommunikation, da die Entscheidung ohne unmittelbare Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erfolgt.

Der Nocebo-Effekt ist nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern auch ein psychosoziales Phänomen. Insbesondere chronisch erkrankte Menschen entwickeln im Verlauf ihrer Erkrankung eine Bindung an ihr Medikament, das mit dem Gefühl von Stabilität, Kontrolle und Sicherheit verbunden ist. Häufige Präparatewechsel – besonders ohne ausreichende Erklärung – führen zu Verunsicherung, Kontrollverlust und damit einhergehender Unzufriedenheit mit der Therapie.

Aus Perspektive der Patientenkommunikation und -bindung ist die automatische Substitution kontraproduktiv. Sie untergräbt das Vertrauen in die medizinische Versorgung und stellt einen Rückschritt im Hinblick auf patientenzentrierte Versorgung dar. Besonders betroffen sind vulnerable Gruppen wie ältere Menschen, chronisch Kranke mit langjähriger Medikation sowie Patienten mit psychischen Komorbiditäten.

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Nocebo-Effekt ein realer und relevanter Risikofaktor im Zusammenhang mit der automatischen Substitution von Biosimilars ist. Die psychosozialen Auswirkungen dürfen in der Bewertung medizinischer Interventionen nicht vernachlässigt werden. Eine Umstellung ohne direkte Einbindung des behandelnden Arztes erhöht die Wahrscheinlichkeit von subjektiven Verschlechterungen, Therapieabbrüchen und dem Verlust von Therapieerfolgen – und sollte daher aus verantwortungsethischer Perspektive vermieden werden.

[...] Die Verordnung eines Biologikums erfolgt im Rahmen eines ärztlich kontrollierten, oft langwierigen Diagnose- und Entscheidungsprozesses. Der behandelnde Arzt wählt dabei ein Präparat aus, das auf die individuellen Bedürfnisse, Begleiterkrankungen, Applikationspräferenzen und bisherigen Erfahrungen des Patienten abgestimmt ist. Ein unkommentierter Wechsel in der Apotheke konterkariert diese sorgfältige Auswahl und nimmt dem Arzt die Möglichkeit, auf Sorgen oder Fragen einzugehen, die mit dem Präparatewechsel

verbunden sein könnten.

Gerade bei chronischen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Morbus Crohn oder Psoriasis ist die Kommunikation zwischen Arzt und Patient entscheidend. Die Therapietreue ist hier eng mit dem Vertrauen in die ärztliche Empfehlung und die Stabilität der medikamentösen Versorgung verknüpft. Wird der Austausch des Medikaments ohne ärztliche Rücksprache vorgenommen, untergräbt dies das Vertrauensverhältnis und erzeugt Unsicherheit auf Seiten der Patienten.

[...] Ein automatischer Austausch durch die Apotheke ohne Rücksprache mit Arzt und Patient widerspricht auch dem Prinzip der informierten Patientenentscheidung. Patienten sollten die Möglichkeit haben, sich umfassend über Gründe, Alternativen und potenzielle Auswirkungen eines Wechsels zu informieren. Nur so kann die individuelle Therapietreue gesichert und eine partizipative Entscheidungsfindung gefördert werden.

Fazit: Die automatische Substitution von Biosimilars gefährdet die Therapietreue und schwächt das Arzt-Patienten-Verhältnis. Eine informierte, ärztlich begleitete Umstellung ist aus medizinischer, ethischer und versorgungstechnischer Sicht unverzichtbar. Das Ziel einer sicheren und wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung lässt sich nicht durch das Untergraben des Vertrauens der Patienten erreichen, sondern nur durch eine patientenzentrierte Steuerung mit dem Arzt als zentralem Koordinator der Therapie.

[...] Die Regelung der automatischen Substitution basiert auf § 129 Absatz 1a SGB V und der Arzneimittel-Richtlinie (§ 40a AM-RL), jedoch fehlt es an einer bundesweit einheitlichen Umsetzung und Überwachung. Unterschiedliche Interpretationen in der Praxis, etwa bei der Frage der Austauschbarkeit bei bestimmten Indikationen, können zu erheblichen Unsicherheiten führen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie mit Patienten umzugehen ist, die die Substitution ablehnen oder aus medizinischen Gründen nicht auf ein anderes Präparat eingestellt werden können. Ohne klare Ausnahmeregelungen und transparente Kommunikationsstrukturen besteht das Risiko einer regelhaften Übersteuerung individueller medizinischer Entscheidungen durch wirtschaftlich motivierte Mechanismen.

[...] Die jüngsten Auswertungen des G-BA zeigen deutlich, dass in vorherigen Verfahren zentrale Dissenspunkte bestehen geblieben sind, die auch im aktuellen Verfahren zum § 40c AM-RL berücksichtigt wurden. [...]

Ein rein regulatorisch definierter Austausch ohne eine gesicherte klinische Evidenz der Unbedenklichkeit in der konkreten Indikation ist aus medizinischer Sicht nicht vertretbar. Die Verantwortung darf nicht durch wirtschaftliche Erwägungen auf Kosten der Patientensicherheit verschoben werden. Zudem kann eine unzureichende Prüfung der zugelassenen Anwendungsgebiete zu Off-Label-Substitutionen führen – ein Risiko, das aus ethischer wie rechtlicher Perspektive nicht zu verantworten ist.

Diese zusätzlichen Anforderungen verdeutlichen erneut die Komplexität des Austauschs biotechnologischer Arzneimittel. Sie stützen das übergeordnete Argument dieser Stellungnahme: Die automatische Substitution von Biologika ist weder medizinisch noch organisatorisch ausreichend abgesichert. Nur eine ärztlich kontrollierte, indikationsspezifisch begründete Umstellung kann den Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit, Patientenschutz und Therapiekontinuität gerecht werden.

[...] Nur unter strengen klinischen, rechtlichen und versorgungspraktischen Voraussetzungen kann überhaupt über eine Form der Substitution diskutiert werden. Die automatische, apothekengesteuerte Umstellung erfüllt diese Voraussetzungen in keiner Weise.

[...] Aus diesen Gründen empfiehlt die STADAPHARM GmbH:

1. **Verzicht auf eine automatische Substitution** von Biosimilars durch Apotheken zugunsten ärztlich gesteuerter Wechselentscheidungen.

2. **Ausbau von Aufklärung und Fortbildung** für Ärzte, Apotheker und Patienten über die sichere Anwendung von Biosimilars.
3. **Stärkung bestehender Steuerungsmechanismen**, insbesondere die Open-House Rabattverträge unter ärztlicher Kontrolle.
4. **Förderung evidenzbasierter Forschung** zu multiplen Biosimilar-Wechseln unter kontrollierten Bedingungen.
5. **Rechtssichere Klärung der Haftungsfragen**, um alle Beteiligten im Versorgungssystem zu schützen.

Nur durch eine verantwortungsvolle, datengestützte und patientenzentrierte Steuerung kann die langfristige Akzeptanz und der nachhaltige Einsatz von Biosimilars im Sinne einer hochwertigen und wirtschaftlichen Versorgung sichergestellt werden.

ABDA, AMK

Im Einvernehmen mit der AMK fordert die ABDA, die vorgesehene rabattvertragsgesteuerte, automatische Substitution von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln in Apotheken weiter auszusetzen.

[...] Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) lehnt aus Gründen der Patienten- und Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) sowie der Pharmakovigilanz eine durch gesetzliche oder untergesetzliche Vorgaben uneingeschränkt zu erfolgende „automatische Substitution“ verordneter Biologika/Biosimilars in öffentlichen Apotheken ab.

ADKA

Die geplante Einführung einer automatischen, rabattvertragsgesteuerten Substitution von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln in Apotheken wird aus Sicht der ADKA kritisch bewertet. Auch wenn grundsätzlich eine Austauschbarkeit von Biosimilars unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, bestehen Bedenken hinsichtlich der Umsetzbarkeit, Rechtssicherheit und Patientensicherheit.

Gerade bei parenteral anzuwendenden Biologika handelt es sich häufig um hochspezialisierte Arzneimittel für schwerkranke Patientinnen und Patienten. In diesem versorgungssensiblen Bereich ist jede Umstellung mit einem erhöhten Risiko für Verunsicherung, Adhärenzprobleme sowie potenzielle Medikationsfehler verbunden – Risiken, die durch automatisierte, arzneimittelpreisorientierte Austauschmechanismen noch verstärkt werden könnten.

Zudem besteht die Gefahr, dass Rabattverträge zu einer marktgesteuerten Konzentration führen und so – wie bereits im Generikamarkt beobachtet – die Versorgungssicherheit gefährden. Die ADKA sieht daher mit Sorge, dass rein wirtschaftliche Steuerungsinstrumente für den Einsatz von Biologika die Patientensicherheit und Versorgungssicherheit in relevantem Maße beeinträchtigen.

BPI

Der G-BA beabsichtigt mit § 40c (neu) der Arzneimittelrichtlinie die Ausweitung der automatischen Substitution biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel in Apotheken. Obwohl das Ziel einer wirtschaftlichen Versorgung grundsätzlich nachvollziehbar ist, lässt die geplante Regelung wichtige medizinische, rechtliche und patientenbezogene Belange unzureichend gewürdigt, gleichzeitig berührt sie grundlegende industriepolitische Fragen. Insbesondere birgt sie Risiken für die Patientensicherheit, die Therapietreue sowie die sichere Versorgung mit diesen hochkomplexen Wirkstoffen, indem sie die ärztliche Therapieverantwortung konterkariert, damit die Pharmakovigilanz erschwert und trägt zur Erosion der wirtschaftlichen Grundlage des Produktionsstandorts Deutschland und Europa für biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel bei.

Wie bereits in den vorangegangenen Stellungnahmen dargelegt, erachten wir die bestehenden Vorgaben zur Förderung der wirtschaftlichen Verordnung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel als ausreichend [(so lag der Versorgungsanteil mit

Adalimumab-Biosimilars in Deutschland im Jahr 2024 inzwischen bei 80 %)] und vor allem mit Blick auf die Sicherstellung der ärztlichen Information über das abgegebene Arzneimittel im Sinne der Patientensicherheit als sachgerecht. Der beabsichtigten Ergänzung der AM-RL bedarf es nach unserem Dafürhalten daher nicht.

Besonders schwer wiegt, dass mit der beabsichtigten Freigabe der Substitution biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel in der Apotheke die zuvor implementierten Vorgaben in §40a der AM-RL konterkariert werden, indem die Therapiekontinuität ohne medizinischen Grund bzw. ohne ärztliche Anleitung und ärztliches Monitoring systematisch unterbrochen wird.

Damit ist die "Substitutionstrias" aus §40a, §40b und §40c (neu) der AM-RL auch regelungssystematisch zu beanstanden. Die Intention des Gesetzgebers kann eigentlich nur so verstanden werden, dass die Substitution biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel im Sinne eines Prozesses schrittweise ausgeweitet werden sollte. Bei Fortbestehen aller umsetzenden untergesetzlichen Regelungen entstehen jedoch insbesondere Interdependenzen zwischen §40c (neu) dem Regelungsziel in §40a der AM-RL.

[...] Bei der Frage der automatischen Substitution eines biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittels (Original/Referenzprodukt oder im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel) in Apotheken durch ein Preisgünstiges ist die Dynamik im Biosimilarmarkt zu bedenken: Beispielsweise wurden seit 2023 zwei Nachahmerprodukte des monoklonalen Antikörpers Tocilizumab – ein Medikament gegen Rheumatoide Arthritis – zur Vermarktung in Europa durch die EU-Kommission zugelassen, Ende 2024 hatte der Versorgungsanteil fast 30 Prozent der Tagestherapiedosen (Rheinland Pfalz, 38,5 Prozent, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit fast 33 Prozent). Diese Marktdynamik wird bestehen bleiben, was zum einen die Konkurrenzsituation und somit die Preiseentwicklung zugunsten der wirtschaftlichen Ressourcen des Gesundheitssystems beeinflussen wird. Zum anderen wird es je nach Indikationsgebiet in kurzen Zeitabständen immer wieder neue Nachahmerprodukte geben, die einem Patienten beziehungsweise einer Patientin automatisch dispensiert werden. Die Folge wäre ein dauerhafter, nicht durch den verordnenden Arzt oder die verordnende Ärztin steuerbarer Mehrfachwechsel für Patientinnen und Patienten, für deren Unbedenklichkeit oftmals keine belastbare Evidenz vorliegt. Dieses „Präparate-Hopping“ ohne ärztliche Steuerung ist auch aus weiteren medizinischen Gründen (Adhärenz, Nocebo-Effekte, Pharmakovigilanz, Ärztin/Arzt-Patient/Patientin-Kommunikation) abzulehnen. Daher plädiert der BPI dafür, dass sogenannte Switches (Ersetzung von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln durch im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln) allein durch den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin zu erfolgen hat und nicht in der Apotheke erfolgen darf.

[...] Der BPI fordert: **Verzicht auf eine automatische Substitution durch Apotheken**, da sie das medizinische Risiko für Patientinnen und Patienten erhöht (Adhärenz, Nocebo-Effekt), die Therapieverantwortung der Ärzteschaft untergräbt und zu einem verstärkten Verlust Europas technologischer Souveränität bei der Biopharmazeutika-Produktion (Versorgungssicherheit!) beiträgt.

Wenn § 40c AM-RL umgesetzt wird, dann nur

- **bei Vorliegen belastbarer Evidenz hinsichtlich der Unbedenklichkeit mehrfacher Wechsel und mit verpflichtender ärztlicher Rücksprache sowie mit der Beschränkung auf zugelassene Anwendungsgebiete (B1+B2) zur Wahrung der Arzneimitteltherapiesicherheit.**
- **mit klareren Kriterien und Ausnahmeregelungen**, insbesondere zur Handhabung, Patientencompliance und ärztlichen Dokumentationspflicht.
- **mit Reform der Anlage VIIa** mit vollständiger, indikationsgenauer und vertriebsbezogener Aufstellung zugelassener Biologika und Biosimilars.

Besondere Beachtung sollte im weiteren Verfahren der **Verantwortungszuordnung im Kontext von Pharmakovigilanz und Komedikation** gelten. Bei Kombinationstherapien mit biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln entstehen nicht nur komplexe Wechselwirkungen, sondern auch haftungsrechtlich relevante Konstellationen. Der G-BA muss sicherstellen, dass die Regelungen zur automatischen Substitution so ausgestaltet sind, dass die Nachvollziehbarkeit der abgegebenen Arzneimittel, die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen und der Rechtsschutz der pharmazeutischen Unternehmer in Bezug auf Nebenwirkungen und Produkthaftung gewahrt bleiben.

Pro Generika

[...] Die geplante Regelung darf nicht zu einer impliziten Verlagerung ärztlicher Verantwortung auf die Apotheke führen. Apothekern fehlen regelmäßig zentrale Informationen wie die verordnungsbegründende Indikation oder individuelle klinische Besonderheiten, die für eine therapeutisch verantwortbare Substitution biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel erforderlich wären.

Eine Substitution kann daher nicht auf eine eigenständige Bewertung durch die Apotheke gestützt werden, sondern bedarf klarer, regelgebundener Voraussetzungen. Die pharmazeutische Zuständigkeit endet dort, wo ärztliche Therapieentscheidungen betroffen sind.

vfa

Für den Therapieerfolg ist eine engmaschige Begleitung erforderlich, auch um Nocebo-Effekte zu vermeiden. Viele dieser Arzneimittel werden auch für die Selbstanwendung mithilfe von Applikationshilfen (Devices) entwickelt. Bei einem Produktwechsel kommt es hierbei unweigerlich auch zu einem Wechsel des Devices und damit oft zu Verunsicherungen bei Patient:innen aufgrund der veränderten Anwendung. Für das Erreichen des Therapieerfolgs und zur Vermeidung von Medikationsfehlern ist die ärztliche Aufklärung von entscheidender Bedeutung. Um einer Abnahme der Therapietreue (Adhärenz) vorzubeugen, sollte jedwede Verunsicherung auf Seiten der Patient:innen entsprechend minimiert werden. Produktwechsel ohne Beteiligung der behandelnden Ärzt:innen können Patient:innen massiv verunsichern und die Therapieadhärenz und den Therapieerfolg beeinträchtigen.

Der vfa spricht sich deshalb gegen die Ausweitung der automatischen Substitution von Biopharmazeutika in der Apotheke aus. Diese dritte Stufe der ergänzenden Steuerung des Biosimilar-Einsatzes nach dem GSAV ist gegenwärtig nicht sinnvoll umsetzbar. Der G-BA sollte auf die Einfügung des neuen § 40c in der Arzneimittel-Richtlinie verzichten.

VZA

Der Gesetzgeber hat grundsätzlich entschieden, dass in Apotheken Referenzarzneimittel gegen darauf Bezug nehmend zugelassene Biosimilars substituiert werden dürfen, wenn der G-BA dazu eine verbindliche, pharmakotherapeutisch fundierte Entscheidung in der Arzneimittel-Richtlinie getroffen hat.

Der nunmehr vorgelegte Entwurf des G-BA geht über diesen Auftrag weit hinaus und ist mit der Ermächtigungsgrundlage nicht vereinbar. Der bisherige Entwurf will den Apotheken die Pflicht zur Substitution nicht nur eines Referenzarzneimittels, sondern auch eines ärztlich verordneten preisgünstigen Biosimilars aufgeben.

Im Sinne der Arzneimitteltherapiesicherheit und dessen praktischer Bedeutung für die Versicherten sollte der Auftrag aus § 129 Abs. 1a S. 5 SGB V restriktiv gehandhabt werden, sollte er angesichts der ohnehin bestehenden ärztlichen Verpflichtung zur Verordnung eines preisgünstigen Biosimilars in § 40a AM-RL nicht ohnehin als überholt angesehen werden.

AKdÄ

Biosimilars können einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Patienten mit Biologika und

zur Kostenreduktion in einem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem leisten. Die Entscheidung zum Einsatz eines Biosimilars sollte aus Sicht der AkdÄ aber weiterhin ausschließlich vom behandelnden Arzt getroffen werden und nicht im Rahmen einer verpflichtenden Substitution in der Apotheke erfolgen. Ein Austausch biologischer Arzneimittel in der Apotheke sollte nur unter genau vorgegebenen, eng gefassten Rahmenbedingungen möglich sein, die rechtlich so zu gestalten sind, dass insbesondere die Patientenadhärenz und Therapietreue und damit der Behandlungserfolg nicht negativ beeinflusst werden. Ein wesentlicher Punkt beim Austausch biologischer Arzneimittel in der Apotheke muss die ausführliche Information und Beratung der Patienten sein, um negative Effekte wie z. B. Nocebo-Effekte zu begrenzen bzw. zu vermeiden. Zudem ist insbesondere im Interesse der Pharmakovigilanz die Rückverfolgbarkeit des vom Patienten eingenommenen Biosimilars sicherzustellen.

Dem ist auch bei der aktuell vorgelegten Änderung der AM-RL Rechnung zu tragen. Die Regelungen des § 40c der AM-RL (neu) dürfen nicht ärztliche Verordnungsentscheidungen in Frage stellen und müssen einen ausreichenden Spielraum für evidenzbasierte, zweckmäßige Therapie mit Biologika und Biosimilars sowie die Rückverfolgbarkeit im Interesse der Pharmakovigilanz gewährleisten. Nur so kann sichergestellt werden, dass patientenindividuelle Faktoren und Risiken, darunter auch Komedikation und Komorbidität, berücksichtigt werden können und die Arzneimittelsicherheit auch für Biosimilars weiterhin gewährleistet ist.

Psoriasis-Praxisnetz Süd-West

Das Psoriasis-Praxisnetz Süd-West e.V. lehnt einen unabhängig von der ärztlichen Verordnung erfolgenden Austausch von Referenzarzneimitteln gegen Biosimilars oder von Biosimilars untereinander – im Sinne einer automatischen Substitution – ab.

Von wissenschaftlicher Seite ist belegt, dass Biosimilars in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit keine relevanten Unterschiede zu ihren Referenzarzneimitteln aufweisen. Biosimilars und Referenzarzneimittel sind daher therapeutisch gleichwertig ("interchangeable"). Das impliziert aber nicht, dass sie auch automatisch untereinander substituierbar sind.

Zwar legen die Daten aus Umstellungsstudien, den sogenannten Switch-Studien nahe, dass Biosimilars ohne nachweisbare Nachteile bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit ausgetauscht werden können. Es muss aber berücksichtigt werden, dass diese Studien an freiwilligen Teilnehmern durchgeführt wurden, die jederzeit die Studie beenden und wieder in Ihre gewohnte Therapie zurückkehren konnten. Daher ist die Übertragung dieser Evidenzbasis auf eine automatische Substitution nicht sachgerecht und zweckmäßig. Ganz im Gegenteil werden in vielen klinischen Studien sogenannte Nocebo-Effekte durch die Umstellung der Therapie von einem Referenzarzneimittel auf ein- oder mehrere Arzneimittel verschiedener Hersteller berichtet. Dieser Punkt erscheint uns für die Verordnungspraxis sehr wichtig.

DDG, gemeinsam mit Hautnetz Deutschland e. V. und BVDD

Aus der wissenschaftlichen und klinischen Sicht der deutschen Dermatologinnen und Dermatologen lehnen wir [...] die diskutierte Substitution von Biosimilars in Apotheken ohne Absprache mit dem/der verordnenden Arzt/Ärztin für den Bereich der Immuntherapien, insbesondere in unseren Themenbereichen bei entzündlichen Hautkrankheiten, allergischen, rheumatischen und weiterhin immunologisch bedingten Erkrankungen in der vorgelegten Form weiterhin ab.

Bekanntermaßen werden mit den Biosimilars Nachahmerpräparate von Original-Biologika bezeichnet, deren Prüfung und Zulassung zunächst durch die EMA reguliert wird. In der Dermatologie wie auch in anderen Fächern, die Immunerkrankungen behandeln, wurden diese Präparate frühzeitig nach Einführung geprüft und liegt inzwischen ein großer klinischer

Erfahrungsschatz vor [213, 214]. Wenngleich dadurch eine weitgehende Übereinstimmung in den biologischen und klinischen Eigenschaften der Biosimilars besteht, so liegen hier keine identischen Merkmale hinsichtlich Wirkungen und Nebenwirkungen vor. Dadurch verbleiben Restrisiken insbesondere bei multiplen Präparatewechseln. Verfechter der freien Substitution führen gelegentlich an, dass selbst bei den Originatoren Interchargen-Variabilitäten vorkommen. Dies ist richtig, sie entkräftet aber nicht das Argument, dass multiple Wechsel zwischen den Biosimilars bisher weder hinreichend untersucht noch in den Auswirkungen absehbar sind. Auch könnten deren Auswirkungen bei verschiedenen Indikationen eine unterschiedliche immunologische Konsequenz haben. Der Einsatz dieser Biosimilars muss deswegen unter konsequenter klinischer Indikationsstellung und Kontrolle durch den behandelnden Arzt/Ärztin erfolgen. Biologika/Biosimilars unterscheiden sich in dieser Hinsicht grundlegend von Generika.

In der klinischen Praxis hat sich in größeren, zum Teil bereits publizierten Fallserien gezeigt, dass entgegen der theoretischen Annahme durch den Wechselvorgang selbst negative sekundäre Effekte auftreten können. Diese betreffen sowohl eine verminderte Wirksamkeit, wie auch ein erhöhtes Aufkommen an berichteten und beobachteten Nebenwirkungen. So fand sich in einer Fallserie von 100 Patienten mit schwerer Hidradenitis suppurativa (Acne inversa), die von Humira als Originator auf ein Biosimilar umgestellt wurden, eine Rate von fast 30% Patienten mit nachfolgender Verschlechterung in der Wirksamkeit und im Nebenwirkungsspektrum. Die aus multiplen Wechseln entstehende Unsicherheit ist sogar noch größer und kann nicht vertreten werden.

[...] Aus ethischer Sicht ist es unververtretbar, dass die ärztliche Therapiefreiheit durch den nicht abgesprochenen, nicht bekannt gegebenen Wechsel eines Präparates unterminiert wird. Die Frage der organisatorischen und medizinischen Verantwortung für das Medikament wird zudem außer Acht gelassen.

[...] In der Gesamtschau stellt die Einführung einer Substitution von Biosimilars durch Apotheken eine unnötige Erschwernis der Versorgung, eine unmittelbare Gefährdung der Patienten und eine Einschränkung der Versorgungsqualität dar, die weder mit ökonomischen noch mit anderen Argumenten zu rechtfertigen ist. Vor diesem Hintergrund erwarten die Unterzeichnenden, dass der Gemeinsame Bundesausschuss eine Regelung trifft, mit der die Biologika in der Immuntherapie chronisch-entzündlicher Erkrankungen (im vorliegenden Fall derzeit insbesondere: TNF-Alpha-Inhibitoren, Ustekinumab) grundsätzlich von einer Substitution durch die Apotheke ausgeschlossen sind.

DGVS, gemeinsam mit Kompetenznetz Darmerkrankungen e. V. und bng

Patient*innen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (Colitis ulcerosa und Morbus Crohn) sind lebenslang von den entsprechenden Krankheiten betroffen. Sie zeigen häufig ein wechselndes Muster von immer wieder auftretender Aktivität und auch (zeitweisen) Remissionsphasen. Diese gehen allerdings mit ausgeprägten Beeinträchtigungen einerseits körperlicher Beschwerden und der Leistungsfähigkeit der Patient*innen sowie andererseits auch einer Einschränkung der Lebensqualität und Teilhabestörungen mit Beeinträchtigungen im psychosozialen Bereich einher. Das wesentliche Behandlungsziel ist deshalb die Einleitung und Erhaltung einer steroidfreien klinischen Remission, sowie möglichst auch einer endoskopischen Remission mit Mukosaheilung. Darüber hinaus soll eine weitgehende Normalisierung der Lebensqualität erreicht werden.

Zum Erreichen dieser Therapieziele spielen bei einem relevanten Anteil dieser Patienten auch biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel (Biologika) oder „small molecules“ eine

213 Radtke MA et al. (2014): Biosimilars bei Psoriasis: Was können wir erwarten? JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft;12(4):306-14.

214 Gerdes S et al. (2018): Biosimilars in der Dermatologie – Theorie wird Realität. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft;16(2):150-62.

nicht wegzudenkende Rolle. In prospektiven, populationsbasierten Studien konnte z.B. für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gezeigt werden, dass jeweils etwa 50% der Morbus Crohn- und Colitis ulcerosa-Patient*innen solche chronisch aktiven Verlaufsformen zeigen, die dann eben auch einer solchen weitergehenden Therapieeskalation auf Biologika bedürfen können (IBSEN-Studie) [215, 216].

Die durch die Biologika bedingten Therapiekosten sind allerdings nicht unerheblich. Durch die Einführung von Biosimilars hat sich hier aber ein erhebliches Potential für Kosteneinsparungen für die Kostenträger entwickelt. In den Biosimilar-Zulassungsstudien für den EMA-Prozess [61] wurden diese zunächst in einem Bereich der sensitivsten Indikationen, nämlich in der Rheumatologie oder bei Psoriasis im Vergleich zu den Originalprodukten getestet. Die Biosimilars zeigten dabei keinen Unterschied in der Effektivität oder bei den Nebenwirkungen. Später erfolgten auch hierzu entsprechende Untersuchungen bei Patient*innen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die ebenso sowohl eine vergleichbare Effektivität als auch Nebenwirkungsprofile zeigten. Die NOR-SWITCH-Studie aus Norwegen legte als erste prospektive Studie bei verschiedenen Indikationen aus der Rheumatologie und bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen dar, dass ein Austausch der Therapie mit dem Infliximab-Originator in der Phase einer Remission auf einen Infliximab-Biosimilar ohne einen Wirkungsverlust möglich ist. Daraus wurde gefolgert, dass ein Wechsel vom Infliximab-Originalpräparat zum Biosimilar auch aus nichtmedizinischen Gründen möglich ist [155]. Allerdings wurden in dieser Studie keine multiplen Wechsel zwischen Biosimilars und Originalpräparaten durchgeführt und die Wechsel nur auf wenige Substanzen beschränkt.

[...] Die Hauptpunkte dieser hier vorliegenden gemeinsamen Stellungnahme vom DGVS, Kompetenznetz Darmerkrankungen und Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands (bng) zum möglichen Austausch von Biologika als Fertigarzneimittel auf Apothekenebene sind im Folgenden zusammengefasst:

- Es ist festzustellen, dass aus den unten näher beschrieben Gründen ein Austausch von Biologika als Fertigarzneimittel in der Apotheke grundsätzlich abzulehnen ist, da der Austausch nur durch einen Arzt ausgeführt werden sollte.
- Es fehlt weiterhin an einer breiteren Evidenz, die die Sicherheit beim mehrfachen Wechsel zwischen Biosimilars belegt – besonders beim Austausch in der Apotheke. Zur Feststellung der Unbedenklichkeit der automatischen Substitution in der Apotheke, bedarf es daher entsprechender Umstellungsstudien für die jeweiligen Biologika.
- Ein Austausch darf nur erfolgen, wenn das Austauschpräparat auch für das den Patienten betreffende Anwendungsgebiet zugelassen ist
- Das „aut idem-Kreuz“ kann nicht zur breitflächigen Verhinderung eines Biologika-Austausches auf Apothekenebene verwendet werden, da dann dem verordnenden Arzt fälschlicherweise die Wirtschaftlichkeitsverantwortung übertragen würde
- Verordnete rabattierte Biologika dürfen prinzipiell nicht auf Apothekenebenen ausgetauscht werden können.
- Bei vollständiger Vergleichbarkeit hinsichtlich Wirksamkeit, Verträglichkeit und Darreichungsform darf eine einmalige Umstellung auf ein anderes Biologikum erfolgen. Ein mehrfacher Wechsel ist aufgrund fehlender ausreichender Evidenz für diese Situation potentiell negativ für den Patienten.
- Die notwendigen Informationen zu einem potentiellen Austausch-Biologikum können nicht in der Apotheke, sondern nur in der vertrauten Arzt-Patienten-Beziehung, ggf. unter zusätzlicher Delegation an eine Fachassistenz in der notwendigen Qualität unter Berücksichtigung der persönlichen Krankheitsbesonderheiten durchgeführt werden
- Es darf keine Veränderung der Applikationswege zwischen Pen und Fertigspritze beim

215 Hoivik ML et al. (2012): Patients with Crohn's disease experience reduced general health and vitality in the chronic stage: ten-year results from the IBSEN study. J Crohns Colitis;6(4):441-53.

216 Hoivik ML et al. (2013): Work disability in inflammatory bowel disease patients 10 years after disease onset: results from the IBSEN Study. Gut;62(3):368-75.

- Austausch vorgenommen werden.
- Bei einem geplanten Biologika-Austausch müssen die Patienten auch über mögliche Begleiteffekte durch unterschiedlichen Hilfsstoffe, z.B. in subkutanen Präparationen informiert werden
- Der Biologika-Austausch auf Apothekenebene kann durch eine dadurch möglicherweise bedingte unvollständige Information des behandelnden Arztes zu Problemen bei der Pharmakovigilanz führen

[...] In der real-world Umsetzung einer potentiellen Substitution in der Apotheke ergeben sich aber weitere Diskussionspunkte und potentielle Probleme mit zusätzlichen Fragen in der weitergehenden realen Behandlungssituation der Patienten. EMA und FDA nehmen zur prinzipiellen Austauschbarkeit der jeweiligen Substanz („Interchangeability“) Stellung, aber es wird auch betont, dass die Frage der Substitution direkt in der Apotheke dieses über das jeweilige Länderecht zusätzlich geregelt werden muss. Hier spielen dann ganz wesentlich die Punkte der Umsetzung der Substitution, die jetzt in der Apotheke und nicht in der Arztpraxis geplant ist, mit den Aspekten der Patientenaufklärung, der Verabreichung der Substanz durch den Patienten (Pens und Fertigspritzen), sowie die Erwartungshaltung der Patienten (z.B. potentieller Nocebo Effekt) und die Beeinflussung der Adhärenz der Patienten eine wesentliche, auch zu berücksichtigende Rolle.

[...] In diesem Zusammenhang muss auch der sog. Nocebo Effekt berücksichtigt werden. Der Nocebo-Effekt beschreibt eine Verschlechterung von Symptomen oder das Auftreten von Nebenwirkungen, die allein durch negative Erwartungen, Angst oder den Glauben an eine schädliche Wirkung der Patienten entstehen – und nicht durch einen tatsächlichen Wirkstoff oder eine tatsächliche Behandlung verursacht werden. Dieser Nocebo Effekt trat in einer Studie aus 2024 zum Biosimilar Switch bei 13% der Patienten auf [217, 218]. Dies muss unbedingt auch berücksichtigt werden, da solche zahlenmäßig relevanten Beeinträchtigungen auch zu einer entsprechenden Verschlechterung der Adhärenz im Hinblick auf die Biologika Therapie führen können.

[...] Es wird klar darauf verwiesen, dass eine Substitution unter den geplanten Bedingungen mit der Substitution in der Apotheke [...] abgelehnt und für nicht zielführend für die Behandlungsqualität und Versorgung der Patienten mit Biologika angesehen wird.

Bewertung:

Nach dem am 15. August 2019 in Kraft getretenen Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) gibt der G-BA gemäß § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken. Damit soll für biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften ein eigener Regelungsrahmen zur Austauschbarkeit durch den G-BA festgelegt werden, der für die übrigen Arzneimittel nicht besteht. Mit Umsetzung des GSAV sollen Kosteneinsparungen im Bereich der Biologika erreicht werden. Der Regelungsauftrag besteht unabhängig vom Anteil von Biosimilars an den Verordnungen und den bereits erzielten Einsparungen im Bereich der Biologika. Der gesetzgeberische Wille besteht darin, sowohl die Verordnung als auch die Abgabe preisgünstigerer Arzneimittel zu fördern, um auch generell bei Biologikaverordnungen Kosten zu sparen.

Wenn eingewendet wird, dass durch die Substitution von Biologika in der Apotheke die Therapiefreiheit der Ärztinnen und Ärzte sowie die Partizipation der Patientinnen und

217 Hagege O et al. (2025): Evaluation of the nocebo effect after switching from etanercept or adalimumab originator to a biosimilar: a retrospective study of patients with inflammatory rheumatism. Clin Exp Rheumatol;43(1):87-95.

218 Van Poecke WHA et al. (2025): Impact of switching from the originator adalimumab to a biosimilar: a retrospective cohort study. BMC Immunol;26(1):44.

Patienten bei der Arzneimittelauswahl eingeschränkt werde, ist zu erwidern, dass der Patient und die Patientin im Rahmen der Vorgaben des SGB V – insbesondere des Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 12 SGB V – und den Vorgaben der AM-RL in die Therapieentscheidung gemäß §§ 630a ff. BGB einzubinden ist.

Bei Zulassung eines Biosimilars nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG wird durch die zuständige Zulassungsbehörde festgestellt, dass dieses ein jeweils vergleichbares Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil im Verhältnis zu dem Referenzarzneimittel aufweist. Sind verschiedene biotechnologisch hergestellte Arzneimittel mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen, ist zudem davon auszugehen, dass mit Blick auf die Anforderungen zur Zulassung eines Biosimilars im Verhältnis zu einem Referenzarzneimittel durch die Inbezugnahme desselben Referenzarzneimittels eine hinreichende Vergleichbarkeit auch der Biosimilars gegeben ist.

Nach der Zulassung kann es auch innerhalb eines Arzneimittels zu Änderungen kommen (Mikroheterogenität durch z. B. Änderungen in der Herstellung wie Wechsel der Zelllinie für die Produktion), die jeweils durch die zuständige Zulassungsbehörde geprüft und freigegeben werden. Bei größeren Änderungen kann sich ein ähnliches Verhältnis zwischen neuer und vorhergehender Version des Referenzarzneimittels wie zwischen Biosimilar und Referenzarzneimittel ergeben, so dass es auch beim Ausbleiben einer Ersetzung durch Apotheken zu „Umstellungen“ kommen kann. Auch über diese „Umstellungen“ werden die Patienten letztendlich nicht informiert. Die EMA beschreibt in ihrem Leitfaden für medizinische Fachkräfte die bei Biologika bestehende Mikroheterogenität und kommt zu dem Schluss, dass durch die Kontrollen der Zulassungsbehörden die Variabilität zwischen Chargen gering ist und Sicherheit und Wirksamkeit nicht beeinträchtigt sind [46]. Daraus lässt sich aus Sicht des G-BA in Analogie die Sicherheit bei Ersetzungen durch Apotheken zwischen Referenzarzneimitteln und Biosimilars sowie Biosimilars (mit identischem Referenzarzneimittel) untereinander ableiten. Die Prüfung der Sachgerechtigkeit einer Ersetzung im Einzelfall bleibt hiervon unberührt.

Entsprechend § 40a Absatz 5 kann in Einzelfällen von Umstellungen abgesehen und gemäß § 40c Absatz 1 die Ersetzung durch Apotheken vom Arzt oder der Ärztin ausgeschlossen werden. Gemäß § 40c Absatz 5 i. V. m. § 17 Absatz 5 ApBetrO ergibt sich auch für die Apotheke die Möglichkeit bei Vorliegen sonstiger Bedenken unter Berücksichtigung patientenindividueller Aspekte von einer Ersetzung abzusehen.

Siehe ergänzend auch Bewertung der Einwände zu den Absätzen 1 bis 5 sowie zu den weiteren Einwänden 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 und 3.6.8.

Die Einwände beziehen sich nicht ausschließlich auf die zur Stellungnahme gestellte Regelung in § 40c AM-RL, sondern betreffen auch die Regelungen in § 40a und § 40b AM-RL sowie die Anlage VIIa. Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits in den Stellungnahmeverfahren zu den Beschlüssen zur Ergänzung der AM-RL um § 40a (vom 20. August 2020) und § 40b (vom 15. Juni 2023) sowie zum Beschluss vom 19. November 2021 zur Erstfassung der Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) zur AM-RL befasst; es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in den Zusammenfassenden Dokumentationen zu den entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/4430/>, <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/> und <https://www.g-ba.de/beschluesse/5132/>).

3.6.3 Fehlende Evidenz zur nicht-ärztlichen Umstellung und zu multiplen Wechseln von Biopharmazeutika

AbbVie

Studien zu Biologika-Umstellungen beim Arzt existieren in großer Anzahl. Allerdings untersuchen diese eine komplett andere Fragestellung, indem die klinische Äquivalenz von Referenz-Biologikum und Biosimilar in parallel angelegten Vergleichsstudien für eine mögliche

Switch-Option geprüft wurde. Die Wirksamkeit und Sicherheit einer Behandlung mit Biologika auf der Basis einer Abfolge von mitunter multiplen Wechseln zwischen Referenz und biosimilaren Wirkstoffen wurde bisher nicht eingehend untersucht, so dass die Ergebnisse aus den erwähnten Studien nicht auf den Austausch von Biologika in der Apotheke übertragen werden dürfen.

Das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und behandelndem Arzt ist mitentscheidend für den Therapieerfolg. Ärzte müssen den Patienten die Therapie ausführlich erläutern und deren Anwendung – teilweise mit unterschiedlichen Applikationshilfen – erklären. Dies muss und in einem vertrauensvollen Verhältnis und geschützten Raum stattfinden. Inwiefern Patienten durch die automatische Substitution des für sie bestimmten Biologika in der Apotheke verunsichert werden, muss näher untersucht werden, um eine Gefährdung der Adhärenz zu verhindern. Dies gilt sowohl für neue als auch für therapieerfahrene Biologika-Patienten. Ebenfalls muss dabei berücksichtigt werden, welche Auswirkungen fehlende oder unzureichende Informationen beim Austausch in der Apotheke haben können.

[...] Biosimilars werden als klinisch äquivalent zu den Originatoren betrachtet. Ein einmaliger, vom Arzt durchgeführter, Therapiewechsel von Original auf Biosimilars ist zudem inzwischen gut untersucht. Dagegen fehlt jedoch weiterhin Evidenz zur Äquivalenz von Biosimilars untereinander, oder gar für multiple Wechsel zwischen Biosimilars in der Apotheke [219]. Zulassungsbehörden fordern diese Evidenz bislang nicht ein – auch wenn die EMA eine Austauschbarkeit bereits regulatorisch entschieden hat. Folglich gibt es keine gesicherte wissenschaftliche Evidenz, die einen Wechsel zwischen Biosimilars untersuchen. Auch die derzeitigen Empfehlungen der Fachgesellschaften oder Leitlinien weltweit geben keinerlei Empfehlungen dazu. Dies kann vor dem Hintergrund der aktuellen Beschlussvorlage nicht ignoriert werden. Denn, besteht zur Wirksamkeit und Sicherheit der Biologika-Therapie mit Blick auf den Austausch von Original und Biosimilar beim Arzt aufgrund der nachgewiesenen Äquivalenz bereits eine breite klinische Erfahrung auf Populationsniveau, so weisen aktuelle Arbeiten eindringlich darauf hin, dass trotz inzwischen bestehender substanzieller Evidenz zur Wirksamkeit und Sicherheit biosimilarer Wirkstoffe weiterhin ein hoher Anspruch an die regulatorische Aufmerksamkeit unter anderem über den vermehrten Einsatz fortgeschrittener Analysemethoden in der Therapieüberwachung nach Markteinführung besteht [220]. Dies erscheint insbesondere mit Blick auf die bisher noch nicht abschließend untersuchte langfristige Immunogenität gerade bei multiplen Wechseln von Biosimilars in der Behandlung mit Biologika dringend erforderlich, um zukünftig mit Biologika assoziierte immunogene Risiken zu minimieren.

Es bedarf einer wissenschaftlichen Risikobewertung durch den G-BA, welche direkten und indirekten Kosten im Gesundheitssystem entstehen würden, sollte es zu Nocebo-Effekten, Therapieadhärenzverlust oder weiteren negativen Folgen durch die automatische Substitution kommen. Es müssen dabei nicht nur irreversible Gesundheitsschäden betrachtet werden, die zwangsläufig bei zahlreichen Anwendungsgebieten zu erwarten wären, sondern auch die indirekten Folgen wie psychische Belastung der Patienten, Arbeitsausfälle (körperlich & psychisch bedingt) oder Folgebehandlungen bei Wirkverlust.

Amgen

[...] Da zudem derzeit noch keine ausreichende Evidenz aus Anwendungsdaten von vielen Biosimilars vorliegt [219, 221], ist ein vollständig freier Austausch von Biosimilars durch Apotheken nicht empfehlenswert. Vielmehr sollten, wie von der EMA empfohlen,

219 Mysler E et al. (2021): Biosimilar-to-Biosimilar Switching: What is the Rationale and Current Experience? *Drugs*;81(16):1859-79.

220 Aljahili SS et al. (2025): Safety of Switching from a Reference Biologic to Its Biosimilar: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Biologics*;5(1).

221 Ribaldone DG et al. (2021): Switching from Biosimilar to Biosimilar Adalimumab, Including Multiple Switching, in Crohn's Disease: A Prospective Study. *J Clin Med*;10(15).

Substitutionen von Arzneimitteln bestenfalls vom behandelnden Arzt / von der behandelnden Ärztin in Absprache mit den Patient:innen erfolgen [46]. So kann eine optimale Aufklärung der Patient:innen erfolgen und negative Phänomene wie der Nocebo-Effekt [68] bei der Substitution hoffentlich vermieden werden.

Biogen

Schon heute kann es in Ausnahmesituationen vorkommen, dass Patienten gelegentlich das Arzneimittel wechseln müssen – etwa aufgrund von Verfügbarkeitsproblemen oder weil das im Krankenhaus verwendete Präparat nicht mit dem vom niedergelassenen Arzt verordneten Medikament übereinstimmt. Zusätzliche automatische Substitutionen auf Apothekenebene könnten die Zahl der Wechsel deutlich erhöhen, insbesondere bei Menschen, die sich in einer Langzeitbehandlung befinden. Wie zu Absatz 2 ausgeführt, wäre laut dem aktuellen Entwurf zu § 40c AM-RL sogar ein mehrfacher Wechsel zwischen verschiedenen Biosimilars möglich. Bei quartalsweisen Rezeptverschreibungen könnten so bis zu vier Präparatewechsel pro Jahr erfolgen – ein Rhythmus, der zunehmend als zu häufig angesehen wird [8].

Die derzeitige Evidenzlage zur Sicherheit und Wirksamkeit bei wiederholten Präparatewechsel ist jedoch begrenzt. Bisher wurden Wechsel zwischen Biologika/Biosimilars ausschließlich unter ärztlicher Aufsicht untersucht. Ob häufige, unbegleitete Wechsel bei komplexen Biologika/Biosimilars das Risiko für Therapieabbrüche erhöhen oder den Behandlungserfolg beeinträchtigen, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Mehrere Patientenorganisationen und Fachgesellschaften haben zudem Bedenken geäußert, dass wiederholte Wechsel zu Verwirrung und Anwendungsfehlern führen können, da sich Patienten in kurzer Zeit mit unterschiedlichen Geräten, Formulierungen oder Handhabungen vertraut machen müssen. Dieses Risiko ist besonders hoch bei chronisch erkrankten Menschen, die mehrere austauschbare Biologika/Biosimilars anwenden – etwa bei Diabetes –, da bereits kleine Unterschiede in der Anwendung zu Fehlanwendungen oder mangelnder Therapietreue führen können [8].

Fresenius Kabi

Im GSAV wurde für das Inkrafttreten des Austausches von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln durch Apotheken eine Vorlaufzeit von 3 Jahren vorgesehen. In diesem Zeitraum (2019 - 2022) durfte ein Austausch auf der Grundlage der Hinweise des G-BA nur auf Arztebene unter der Verantwortung des behandelnden Arztes erfolgen und es sollten wissenschaftliche Erkenntnisse über die Austauschbarkeit von Biosimilars und Erfahrungen mit der Versorgungspraxis von Biosimilars gesammelt und bewertet werden.

Dieser Ansatz, dass wissenschaftliche Erkenntnisse über die Austauschbarkeit von Biosimilars und Erfahrungen mit der Versorgungspraxis von Biosimilars gesammelt und bewertet werden sollten, war zu begrüßen. Die Sammlung dieser Erkenntnisse und Erfahrungen hätte systematisch erfolgen und die Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden müssen, damit sie Ärzten und Patienten zur Verfügung stehen können. Dies ist nach unserer Kenntnis jedoch nicht erfolgt. Wir bitten deshalb den G-BA, bezüglich der Sammlung wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Austauschbarkeit von Biosimilars und Erfahrungen mit der Versorgungspraxis von Biosimilars, vom Gesetzgeber eine verbindliche Regelung im SGB V zu verlangen und diese zunächst zu verankern. Dazu eignen sich Auswertungen der Abrechnungsdaten nach § 300 SGB V der gesetzlichen Krankenversicherung besonders gut, weil sie nicht zusätzlich erhoben werden müssen.

Hexal

Der auf idem Austausch auf Apothekenebene ist den Hinweisen zur wirtschaftlichen Verordnung auf Arztebene aus guten Gründen um inzwischen bereits mehrere Jahre nachgelagert: In diesem Zeitraum sollten weitere Erkenntnisse zur Austauschbarkeit von Biosimilars – insbesondere inwieweit jeweils eine Überwachung des Präparatewechsels durch

einen Arzt erforderlich ist [222] – gesammelt werden, wie sich bereits der Gesetzesbegründung zum Entwurf des GSAV entnehmen lässt [183].

Auch die Tatsache, dass dem G-BA durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz aufgegeben wurde, zunächst Hinweise zum aut idem Austausch für parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung zu erlassen, dürfte vor allem dem Zweck geschuldet gewesen sein, zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen, auch wenn sich der Gesetzesbegründung hierzu nichts entnehmen lässt. Inzwischen hat – in Umsetzung dieser Anforderung – § 40b Eingang in die AM-RL gefunden.

Aussagekräftige Studien und Untersuchungen zur Frage, unter welchen Voraussetzungen – und bei welchen Produkten/Wirkstoffen – ein aut idem Austausch von Biologika vertretbar erscheint, liegen jedoch immer noch nicht vor, und erst recht nicht in der bereits im Jahre 2019 von BÄK und AkdÄ geforderten systematischen Sammlung von Ergebnissen und dessen öffentlicher Zugänglichmachung. Seit dem systematischen Review von Tolonen et. al. aus dem Jahre 2021, demzufolge die Forschungsevidenz und Erfahrungslage zur automatischen Substitution von Biologika als begrenzt und von geringer bis mäßiger Qualität eingeschätzt wurde [152], sind diesbezüglich keine wesentlich neuen Daten öffentlich verfügbar gemacht worden.

Ob sich aus dem nun seit 15. März 2024 erfolgenden aut idem Austausch von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung gemäß § 40b AM-RL in Zukunft weitreichende Erkenntnisse ergeben für die Frage, welchen Problemen ein genereller, nicht nach Produktspezifika differenzierender Austausch auf Apothekenebene möglicherweise begegnet, lässt sich allerdings bezweifeln. Denn aufgrund der Beschränkung auf Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung stellt sich gar nicht erst die Frage, ob ein aut idem Austausch im Einzelfall zwingend durch einen Arzt begleitet werden müsste. Insbesondere eventuelle Nocebo-Effekte dürften in dieser besonderen Konstellation von deutlich geringerer Relevanz sein.

Die vorgesehene Regelung ermöglicht regelmäßige, nicht-angezeigte Wechsel zwischen verschiedenen Biosimilars oder dem Referenzprodukt. Diese "Multiple Switching"-Szenarien sind bislang weder umfassend noch langfristig wissenschaftlich untersucht.

- **Cohen et al. (2018)** fassen die bisherige Literatur zum Wechsel von Referenzarzneimitteln auf Biosimilars zusammen. Sie weisen darauf hin, dass nahezu alle Studien sich auf einen einmaligen, geplanten Wechsel beziehen. Aussagen zur Sicherheit wiederholter Wechsel fehlen weitgehend [201].
- Die Frage der Versorgungssicherheit bei mehrfachen Biosimilar-Substitutionen ist insbesondere bei chronisch kranken Patient:innen mit eingeschränkter Therapiereserve von zentraler Bedeutung. Zwar zeigen systematische Übersichten wie **Herndon et al. (2023)**, dass bei einmaligem Wechsel zwischen Biosimilar und Referenzpräparat keine Unterschiede in der Sicherheit oder Immunogenität festgestellt wurden. Allerdings betonen die Autor:innen zugleich, dass Studien mit mehreren Wechseln („multiple switching“) seltener durchgeführt wurden und häufig methodische Einschränkungen aufweisen. Diese Lücken in der Evidenzlage erschweren belastbare Aussagen zur Langzeitsicherheit und Therapietreue in besonders vulnerablen Patientengruppen [223].

Pfizer

Der Gesetzgeber hat dem Gemeinsamen Bundesausschuss mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz nicht ohne Grund aufgegeben, im ersten Schritt nur Hinweise zur

222 Lietz C, Zumdick U: Das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung. Pharmazeutische Zeitung Recht. 2019. 493.

223 Teran E et al. (2023): Safety outcomes when switching between biosimilars and reference biologics: A systematic review and meta-analysis. Plos One;18(10).

Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten zu geben. Auf diese Weise sollte eine **kritische Begleitung in Bezug auf die Patientensicherheit und eine engmaschige Evaluation möglicher Versorgungsrisiken** ermöglicht werden. Insofern verweisen wir auf die entsprechende Forderung der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft aus Dezember 2022, in der es wörtlich heißt:

„Nach dem Inkrafttreten der automatischen Substitution für diese Zubereitungen in der Apotheke soll die weitere Entwicklung kritisch begleitet und die Regelungen in Bezug auf die Patientensicherheit und die möglichen Risiken für die Versorgung engmaschig evaluiert werden.“

Insofern sollte vor einer vorschnellen Fortschreibung und Ausdehnung der automatischen Substitution auf Fertigarzneimittel eine **gründliche und datengestützte Evaluation des § 40b AM-RL** stehen.

Uns ist nicht bekannt, dass eine solche datengestützte Evaluation vom Gemeinsamen Bundesausschuss durchgeführt worden wäre; in den Tragenden Gründen des vorliegenden Beschlusssentwurfs vom 11. Juni 2025 ist davon auch keine Rede. Zumal wir in Zweifel ziehen, dass entsprechende aussagekräftige Daten überhaupt vorliegen. Ohnehin stellt sich die Frage, inwieweit aus dem Austausch von biologischen Fertigarzneimitteln bei parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung Erfahrungen gewonnen werden könnten, die auf die Versorgung mit biologischen Fertigarzneimitteln übertragbar wären, zumal es in diesen Fällen aufgrund der unmittelbaren ärztlichen Anwendung zu keinem vergleichbaren Nocebo-Effekt kommt. Auch unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit sind die mittel- bis langfristigen Folgen bei parenteralen Zubereitungen bisher unklar. Es handelt sich um einen in anderer Weise geregelten Markt mit einer nicht vergleichbaren Ausgestaltung der Austauschbarkeit.

Stadapharm

Die medizinischen Risiken, die sich aus einer automatischen Substitution von Biosimilars ergeben, sind vielfältig und betreffen insbesondere Aspekte der Therapiekontinuität und Sicherheit auf Grund von Nocebo-Effekten [66, 67]. Ein zentraler Kritikpunkt ist das Fehlen ausreichender Evidenz für die Sicherheit sogenannter multipler Wechsel – also mehrmaliger, nicht ärztlich gesteuerter Substitutionen zwischen verschiedenen Biosimilars. Hierbei handelt es sich um einen entscheidenden Unterschied der Biosimilars zu wirkstoffgleichen Nachfolgeprodukten („Generika“).

Während die einmalige Umstellung von einem Originator auf ein Biosimilar durch klinische Studien gestützt ist, fehlen valide Daten für wiederholte Wechsel – insbesondere sind die vorhandenen Studien, die mehrfache Switches untersuchen [147], nicht dafür geeignet, die Auswirkungen auf die Patientenadhärenz und den Therapieerfolg zu evaluieren, wenn die Umstellung in der Apotheke – im Sinne einer automatischen Substitution ohne Wissen des behandelnden Arztes – erfolgen soll.

Die G-BA-Dokumentation zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (§ 40a AM-RL) weist explizit darauf hin, dass für multiple Wechsel eine unzureichende Datenlage besteht und dass insbesondere bei immunvermittelten Erkrankungen das Risiko für Therapieversagen und Nebenwirkungen steigt [147]. Bei den vorgelegten Studien handelt es sich zudem häufig um nicht verblindete, offene Designs, die verzerrungsanfällig sind.

So wird im Review von Numan S. et al. (2018) „Non-medical Switching from Originator Tumor Necrosis Factor Inhibitors to Their Biosimilars: Systematic Review of Randomized Controlled Trials and Real-World Studies“ die Qualität der derzeitigen Beweislage zu nicht-medizinischen Switches bemängelt. Die Abbruchraten variierten in den Studien erheblich (0–87 %), was auf eine Heterogenität und fehlende Eindeutigkeit der aktuellen Evidenz zu Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität hindeutet – insbesondere auf Ebene des einzelnen Patienten.

Diese Aussagen zeigen die methodischen Schwächen der bisherigen und verdeutlichen die Notwendigkeit individualisierter Entscheidungen durch die behandelnden Ärzte.

Auch in der Evaluation zu aktuellen „Evidenzanforderungen für die Substitution von Biosimilars“ durch Bleß et al, wird hervorgehoben, dass für den multiplen Medikationswechsel zwischen verschiedenen Biosimilars untereinander bislang keine Studien verfügbar sind, welche die Auswirkungen hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Adhärenz von Patienten untersuchen [224].

Hinzu kommt, dass bei mehrfachem Wechsel, jeweils eine neue Information/Schulung des Patienten erforderlich wäre. Ein mehrfacher Wechsel birgt zudem das Risiko einer verminderten Therapieadhärenz der Patienten, die vorhandenen Studien hierzu erlauben keine klare Risikoeinschätzung.

ADKA

Die ADKA plädiert nachdrücklich dafür, Wissen und Verständnis zu den wissenschaftlichen Grundlagen des Biosimilar-Einsatzes gezielt zu fördern und strukturiert bereitzustellen. Eine verpflichtende automatische Substitution durch Apotheken würde zwangsläufig zu mehrfachen Wirkstoffwechseln führen – für die jedoch bislang bei den meisten biologischen Arzneimitteln belastbare klinische Daten fehlen, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit solcher Mehrfach-Switches zwischen verschiedenen Biosimilars eines Referenzpräparats. Ohne fundierte Evidenz birgt die automatische Substitution erhebliche Risiken für die Arzneimitteltherapie- und Patientensicherheit. Um diese Wissenslücken zu schließen, braucht es gezielte Post-Marketing-Studien im Versorgungsalltag – wie etwa die NOR-SWITCH-Studie aus Norwegen zeigt.

Pharma Deutschland

Darüber hinaus spricht sich Pharma Deutschland dafür aus, dass vor der Umsetzung weiterer Regelungen, eine Evaluation der bisherigen Regelungen zu parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung abgewartet wird. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die auf diesen Regelungen aufbauende Rabattverträge erst jetzt ihre Wirkung entfalten. Es wäre wichtig, dass ein entsprechendes Evaluationskonzept entwickelt wird, wie die hier vorliegenden Regelungen begleitet werden sollen und welche Endpunkte analysiert werden sollen. Neben Patientensicherheit, Medikationsfehler, Rückmeldungen der Apotheken zu den Beratungen, die Verhältnismäßigkeit zu den bislang vorhandenen Instrumenten (z. B. Biosimilar - Quoten) und Lieferfähigkeiten wären wesentliche Parameter innerhalb einer Evaluation.

Pro Generika

Die Forderung nach Evidenz zur therapeutischen Vergleichbarkeit biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel bezieht sich insbesondere auf kontrollierte Studien unter idealisierten Bedingungen. Etliche versorgungsrelevante Faktoren werden hierbei nur unzureichend abgebildet.

Gerade im Rahmen einer automatischen, nicht ärztlich gesteuerten Substitution sind jedoch wiederholte Produktwechsel zu erwarten. Die potenziellen Auswirkungen auf Therapietreue, Wirksamkeit und Sicherheit in der Versorgungspraxis sind bislang nicht systematisch untersucht. Um diese Lücke zu schließen, ist eine strukturierte Begleitforschung notwendig, die reale Substitutionsprozesse abbildet, die Perspektive der Versicherten einbezieht und insbesondere vulnerable Patientengruppen berücksichtigt.

Eine solche Begleitforschung kann wesentlich dazu beitragen, die Bewertung der Austauschbarkeit auf eine breitere Evidenzgrundlage zu stellen und somit den gesetzlich

224 Bleß H et al. (2020): Evidenzanforderungen für die Substitution von Biosimilars. Monitor Versorgungsforschung;13(02/2020):66-72.

verankerten Anspruch auf eine sichere und qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung im Rahmen von G-BA-Richtlinienentscheidungen zuverlässig zu gewährleisten.

vfa

Vor dem Hintergrund der breiten Kritik im Rahmen der Ergänzung von § 40b AM-RL sollten die Entwicklungen in diesem sensiblen Bereich erst evaluiert werden, ehe eine pauschale Erweiterung der Vorgaben für Biopharmazeutika, über die parenteralen Zubereitungen zur unmittelbar ärztlichen Anwendung hinaus, stattfindet. Eine solche Evaluation ist bisher nicht erfolgt und sollte erst abgewartet werden.

DGRh

Bisher wurde in der Literatur überwiegend der einmalige Wechsel von einem Originatorpräparat auf ein Biosimilar untersucht und die pharmakologische und biologische Unbedenklichkeit gezeigt. Für den TNF-Inhibitor Adalimumab liegt eine methodisch hochwertige Evidenz aus einer Phase-3-Studie vor, in der ein mehrfacher Wechsel (sogenanntes multiples Switching) zwischen dem spezifischen Biosimilar Adalimumab-afzb und dem Originator Humira hinsichtlich Pharmakokinetik, Immunogenität und Sicherheit untersucht wurde [225]. Einschränkend ist jedoch anzumerken, dass diese Studie ausschließlich ein ärztlich kontrolliertes mehrfaches Wechselmodell zwischen genau zwei definierten Präparaten im Rahmen einer klinischen Studie untersuchte. Ein Wechsel zwischen mehreren unterschiedlichen Biosimilars oder ein Wechsel ohne ärztliche Einbindung, wie er durch die vorgesehene gesetzliche Regelung mit Apotheken möglich wäre, war bisher nicht Gegenstand von Untersuchungen. Zudem war die Beobachtungszeit auf 32 Wochen begrenzt.

Für (intravenöses) Infliximab existieren in der Indikation Morbus Crohn ebenfalls Daten, die die Unbedenklichkeit multipler Wechsel stützen – beispielsweise berichtet eine prospektive Kohortenstudie über ein effektives und sicheres multiples Switching [226].

Die DGRh hält es daher für wichtig, klarzustellen, dass die in der Phase III-Studie [225] gezeigte Unbedenklichkeit nicht ohne Weiteres auf das geplante „Apothekenswitching“, insbesondere nicht auf wiederholte, nicht ärztlich begleitete Wechsel zwischen verschiedenen Rabattpräparaten, übertragen werden kann. Zum einen ist eine höhere Rate eines sekundären Wirkverlustes letztlich noch nicht auszuschließen, da diese Fragestellung bei multiplem Switchen zwischen mehreren biosimilaren, subkutan zu applizierenden Präparaten noch nicht ausreichend untersucht wurde. Darüber hinaus ist die subjektive Reaktion der Patientinnen und Patienten bei Präparatewechseln im Vergleich zu den biologischen und pharmakologischen Effekten weniger gut untersucht. Dazu zählen beispielsweise mögliche Nocebo-Effekte und deren Auswirkung auf die Adhärenz.

DGVS, gemeinsam mit Kompetenznetz Darmerkrankungen e. V. und bng

Zunächst betrifft dies die Austauschbarkeit des Originalpräparat mit den verschiedenen Biosimilars im Hinblick auf die klinische Wirksamkeit, das Auftreten von Nebenwirkungen und die möglicherweise auftretenden vermehrten Antikörperbildungen unter dem einmaligen oder mehrfachen Wechsel innerhalb des jeweiligen Biologikums. Hierzu gibt es in den letzten Jahren eine zunehmende Evidenz aus der Literatur auch aus RCTs mit deren Langzeitverfolgungen, wie

225 Fleischmann RM et al. (2023): Multiple switching between the biosimilar adalimumab PF-06410293 and reference adalimumab in patients with active rheumatoid arthritis: a phase 3, open-label, randomised, parallel-group study. *Lancet Rheumatol*;5(9):e532-e41.

226 Hanzel J et al. (2022): Multiple Switches From the Originator Infliximab to Biosimilars Is Effective and Safe in Inflammatory Bowel Disease: A Prospective Multicenter Cohort Study. *Inflamm Bowel Dis*;28(4):495-501.

PLANETAS bei AS [227], PLANETRA bei RA [228, 229] und NOR-SWITCH bei AS, RA, CD und UC [155, 230, 231] und systemischen Reviews [232, 233], die keine Hinweise für eine verminderte Wirksamkeit, vermehrte Nebenwirkungen oder vermehrte Antikörperbildung [221, 234] unter einem Switch zwischen Originalpräparat und Biosimilar zeigen. Dies bezieht sich vermehrt auf Daten zu einem nur einzelnen Switch. Diese Daten sind zwar auch für einen mehrfachen Switch vorhanden, hier ist die Datendichte aber deutlich geringer [221, 234] und lässt noch Raum für zukünftige prospektive Studien zum multiplen Switch, um auch diese Situation in der gleichen Evidenzstärke abzusichern. Auf Grund dieser vorhandenen Daten haben die EMA [43, 59] und die FDA [235] in Ihren Statements zur „Interchangeability“ jeweils den einfachen und auch den mehrfachen Wechsel im Hinblick auf die oben genannten Kriterien als sicher und bedenkenlos erklärt.

In diesem Zusammenhang muss aber noch einmal betont werden, dass für den multiplen Wechsel nicht in gleicher Weise wie für den einfachen „Switch“-Daten zur Unbedenklichkeit vorliegen. Hier sollten noch entsprechende weitere prospektive Studien zum multiplen Switch folgen und es ist auch anzumerken, dass diese beschriebenen Switch-Daten überwiegend nicht aus Studien mit Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stammen, sondern eher aus der Rheumatologie und Dermatologie kommen. Aufgrund der Vorerfahrungen ist aber davon auszugehen, dass man diese Daten auf Patienten mit chronischen entzündlichen Erkrankungen hier untereinander übertragen kann, was EMA und FDA auch entsprechend getan haben.

GKJR

Gerade da die Kinder und Jugendliche auf die Fürsorge durch die Erwachsenen angewiesen sind, sollte berücksichtigt werden, dass Daten für multiple Wechsel nicht zur Verfügung stehen.

Bewertung:

Den Stellungnehmenden wird dahingehend zugestimmt, dass bereits Studien zum Wechsel von Referenzarzneimittel und Biologika vorliegen und in diesen Studien auch teilweise ein mehrfacher Wechsel untersucht wird.

Aus den Studien ergeben sich keine Hinweise, die gegen einen mehrfachen Wechsel oder eine Rückumstellung sprechen.

227 Park W et al. (2013): A randomised, double-blind, multicentre, parallel-group, prospective study comparing the pharmacokinetics, safety, and efficacy of CT-P13 and innovator infliximab in patients with ankylosing spondylitis: the PLANETAS study. *Ann Rheum Dis*;72(10):1605-12.

228 Yoo DH et al. (2013): A randomised, double-blind, parallel-group study to demonstrate equivalence in efficacy and safety of CT-P13 compared with innovator infliximab when coadministered with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: the PLANETRA study. *Ann Rheum Dis*;72(10):1613-20.

229 Ye BD et al. (2019): Efficacy and safety of biosimilar CT-P13 compared with originator infliximab in patients with active Crohn's disease: an international, randomised, double-blind, phase 3 non-inferiority study. *Lancet*;393(10182):1699-707.

230 Goll GL et al. (2019): Long-term efficacy and safety of biosimilar infliximab (CT-P13) after switching from originator infliximab: open-label extension of the NOR-SWITCH trial. *J Intern Med*;285(6):653-69.

231 Jørgensen KK et al. (2020): Efficacy and Safety of CT-P13 in Inflammatory Bowel Disease after Switching from Originator Infliximab: Exploratory Analyses from the NOR-SWITCH Main and Extension Trials. *BioDrugs*;34(5):681-94.

232 Cohen HP et al. (2022): Switching from One Biosimilar to Another Biosimilar of the Same Reference Biologic: A Systematic Review of Studies. *BioDrugs*;36(5):625-37.

233 Cohen HP et al. (2024): Additional Data in Expanded Patient Populations and New Indications Support the Practice of Biosimilar-to-Biosimilar Switching. *BioDrugs*;38(3):331-9.

234 Gros B et al. (2023): Multiple infliximab biosimilar switches appear to be safe and effective in a real-world inflammatory bowel disease cohort. *United European Gastroenterol J*;11(2):179-88.

235 Food and Drug Administration (FDA): Draft Guidance: Considerations for Demonstrating Interchangeability with a Reference Product: Update. 2024.

Es ist zudem nicht von einem permanenten Wechsel zwischen verschiedenen Arzneimitteln auszugehen, da die entsprechenden Verträge nach § 130a Absatz 8 SGB V für eine Dauer von zwei Jahren geschlossen werden sollen. In den Vereinbarungen sind zudem die Vielfalt der Anbieter und die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Versicherten zu berücksichtigen. Von diesen Grundsätzen soll auch bei sog. Open House Verträgen nicht abgewichen werden; diese sehen zudem keine Eingrenzung der Anbieter vor und definieren lediglich Teilnahmebedingungen. Bei Open-House-Verträgen hängt sowohl die Teilnahme wie auch die Dauer der Vertragspartnerschaft maßgeblich von den sich beteiligenden pharmazeutischen Unternehmen ab. Die Vertragsinhalte vereinbaren die Vertragsparteien (Krankenkassen oder ihre Verbände – pharmazeutische Unternehmer) und unterliegen damit nicht der Regelungszuständigkeit des G-BA.

Nach der Zulassung kann es auch innerhalb eines Arzneimittels zu Änderungen kommen (Mikroheterogenität durch z. B. Änderungen in der Herstellung wie Wechsel der Zelllinie für die Produktion), die jeweils durch die zuständige Zulassungsbehörde geprüft und freigegeben werden. Bei größeren Änderungen kann sich ein ähnliches Verhältnis zwischen neuer und vorhergehender Version des Referenzarzneimittels wie zwischen Biosimilar und Referenzarzneimittel ergeben, so dass es auch beim Ausbleiben einer Ersetzung durch Apotheken zu „Umstellungen“ kommen kann. Auch über diese „Umstellungen“ werden die Patienten letztendlich nicht informiert. Die EMA beschreibt in ihrem Leitfaden für medizinische Fachkräfte die bei Biologika bestehende Mikroheterogenität und kommt zu dem Schluss, dass durch die Kontrollen der Zulassungsbehörden die Variabilität zwischen Chargen gering ist und Sicherheit und Wirksamkeit nicht beeinträchtigt sind [49]. Daraus lässt sich aus Sicht des G-BA in Analogie die Sicherheit bei Ersetzungen durch Apotheken zwischen Referenzarzneimitteln und Biosimilars sowie Biosimilars (mit identischem Referenzarzneimittel) untereinander ableiten. Dies begründet sich darin, dass bei Zulassung eines Biosimilars nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG durch die zuständige Zulassungsbehörde festgestellt wird, dass dieses ein jeweils vergleichbares Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil im Verhältnis zu dem Referenzarzneimittel aufweist. Sind verschiedene biotechnologisch hergestellte Arzneimittel mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen, ist davon auszugehen, dass mit Blick auf die Anforderungen zur Zulassung eines Biosimilars im Verhältnis zu einem Referenzarzneimittel durch die Inbezugnahme desselben Referenzarzneimittels eine hinreichende Vergleichbarkeit auch der Biosimilars gegeben ist. Dieses Verständnis des G-BA wird nicht zuletzt durch das Statement der EMA zur Interchangeability [65] gestützt. Die Prüfung der Sachgerechtigkeit einer Ersetzung im Einzelfall bleibt hiervon unberührt. Die Möglichkeit die Ersetzung bei Verordnung auszuschließen ergibt sich dabei aus § 40c Absatz 1; die Möglichkeit der Apotheke von einer Ersetzung abzusehen ergibt sich aus § 40c Absatz 5.

Eine engere Auslegung des gesetzlichen Auftrags ist aus mehreren Gesichtspunkten nicht geboten: Zum einen würde eine enge Auslegung zu dem widersinnigen Ergebnis führen, dass in dem Fall, in dem ein im Verhältnis zu seinen Biosimilars günstigeres Referenzarzneimittel existiert und aufgrund der therapeutischen Vergleichbarkeit ein Austausch von Referenz zu Biosimilar möglich sein soll, die Rückumstellung – bei enger Wortlautauslegung – jedoch nicht mehr möglich wäre.

Zum anderen ist die Apotheke bei Verfügbarkeit mehrerer in Frage kommender preisgünstiger Arzneimittel grundsätzlich frei in der Auswahl. Sind also mehrere Biosimilars (Biosimilar A und B) zu einem Referenzarzneimittel auf dem Markt, könnte ausgehend von einer Verordnung über das Originalarzneimittel bei entsprechender Preisgünstigkeit einmal Biosimilar A und ein anderes Mal bei gleichlautender Verordnung das Biosimilar B abgegeben werden. Bei immer gleicher Voraussetzung könnte also selbst bei einer eingeschränkten Regelung (Austausch nur zwischen Referenzarzneimittel und Biosimilar) im Ergebnis ein Austausch von einem Biosimilar zum anderen erfolgen.

Auch ist es dem Arzt in den Fällen, in denen Biosimilars in Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind, unterschiedslos möglich auf die jeweiligen Biosimilars unter Beachtung einer wirtschaftlichen Ordnungsweise umzustellen; unter diesen Umständen erschließt sich eine grundsätzliche Unterscheidung auf der weiteren Ebene hinsichtlich der Ersetzung von Biosimilars untereinander nicht.

Siehe ergänzend auch Bewertung der Einwände zu den Absätzen 1 bis 5 sowie zu den weiteren Einwänden 3.6.1, 3.6.2, 3.6.5, 3.6.6 und 3.6.8.

Wenn eingewendet wird, dass es einer wissenschaftlichen Risikobewertung zu direkten und indirekten Kosten im Gesundheitssystem in Folge einer automatischen Substitution durch den G-BA bedarf, ist entgegenzuhalten, dass eine Evaluation der Kosten durch den G-BA gesetzlich nicht vorgesehen und zudem nicht Aufgabe des G-BA ist. Der G-BA geht im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeitsbewertung von Arzneimitteln grundsätzlich von einem Vergleich der Kosten gemessen am Apothekenabgabepreis sowie ggf. der den Krankenkassen tatsächlich entstehenden (direkten) Kosten aus. Nach 4. Kapitel § 10 Absatz 1 VerfO sind aufgrund der Fach- und Gebrauchsinformation bestehende regelhafte Unterschiede bei der notwendigen Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung oder bei der Verordnung sonstiger Leistungen und die damit verbundenen Kostenunterschiede zu berücksichtigen. Eine weitergehende Kosteneffektivität unter Einbeziehung indirekter Kosten bleibt insofern regelhaft außer Betracht.

Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits im Stellungnahmeverfahren zum Beschluss vom 15. Juni 2023 zur Ergänzung der AM-RL um § 40b befasst; es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in der Zusammenfassenden Dokumentation zu dem entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/>).

3.6.4 Regelungen der automatischen Substitution in anderen Ländern

AbbVie

In den wenigen Ländern, in denen eine automatische Substitution erlaubt ist, gelten strenge Voraussetzungen, unter welchen der Austausch in der Apotheke stattfinden darf. Allerdings gibt es hier keine einheitlichen Kriterien, sondern unterschiedliche Ansätze. Alle Ansätze haben gemein, dass mit äußerster Vorsicht vorgegangen wird, um die Therapie der Patienten nicht zu gefährden.

Die Therapiesicherheit der Patienten gilt als höchstes Gut innerhalb der Gesundheitsversorgung. Daher muss sichergestellt werden, dass eine langfristige Patienten- und Arzneimittelsicherheit gewährt werden kann. Ein Blick auf die europäischen Länder zeigt, dass automatische Substitution mehrheitlich nicht angewandt wird. Da es an Erfahrungswerten fehlt, sollte Deutschland dem Konsens seiner Nachbarländer folgen, um die Patientensicherheit der eigenen Patienten nicht zu gefährden.

Amgen

Unbenommen der hier beschriebenen Risiken für Patient:innenwohl, Versorgungssicherheit und Standort, ist es essenziell, die Versorgung von Patient:innen sicher zu stellen, um eine Situation, wie sie aktuell im Generikamarkt besteht (u. a. Lieferengpässe) zu vermeiden. Hierzu ist es aus Sicht von Amgen essenziell, für die vom G-BA geplante Substitution der biologischen Fertigarzneimittel weitere Kriterien aufzunehmen, wie sie auch in anderen Ländern enthalten sind:

- *Die zukünftigen Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V sollten weiterhin nicht-exklusiv sein und nach dem norwegischen Vorbild zusätzlich zu mindestens 30 % Klima- und Umweltfaktoren berücksichtigen.*
- *Nach finnischem Vorbild darf eine Substitution nur bei der Erstverordnung und danach frühestens alle 6 Monate nach einer entsprechenden ärztlichen Überprüfung erfolgen*

[236].

- Außerdem darf – ähnlich zum finnischen Vorbild – die Substitution von biologischen Fertigarzneimitteln nicht bereits direkt nach Patentablauf mit Markteintritt von preisgünstigeren Biosimilars erfolgen. Stattdessen sollte die Substitution erst nach Ablauf von entsprechenden Schutzfristen von mindestens 1 bis 3 Jahren gestaffelt erfolgen.

Die operative Umsetzung des § 40c AM-RL obliegt zwar letztendlich den Krankenkassen, allerdings sind solche zusätzlichen Kriterien aus Sicht von Amgen durch den Gesetzgeber erforderlich, um eine langfristige Planungssicherheit sowie Versorgungssicherheit für die Patient:innen zu gewährleisten.

Biogen

In Frankreich ist die Apothekensubstitution biologischer Arzneimittel nur unter strengen Auflagen erlaubt. Dort ist der Apotheker verpflichtet, die abgegebene Charge zu dokumentieren und sowohl den behandelnden Arzt als auch den Patienten über den Austausch zu informieren. Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass ein Wechsel zwischen Biologika/Biosimilars insbesondere ohne ärztliche Einbindung mit Risiken für die Patientensicherheit, die Therapietreue und die Pharmakovigilanz verbunden sind.

Frankreich erkennt damit an, dass die automatische Substitution hochkomplexer Biologika/Biosimilars nicht mit der Substitution klassischer Generika gleichgesetzt werden kann. Die dortige Regelung stellt sicher, dass Transparenz, Rückverfolgbarkeit und ärztliche Verantwortung gewahrt bleiben – Aspekte, die auch im deutschen Versorgungskontext von zentraler Bedeutung sind. Die französische Praxis zeigt, dass eine differenzierte und verantwortungsvolle Umsetzung von Substitutionsregelungen möglich ist – allerdings nur unter klaren Voraussetzungen und mit flankierenden Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgungsqualität.

Ratiopharm

In vielen europäischen Ländern ist der automatische Austausch von Biologika auf Apothekenebene entweder gar nicht zugelassen oder wird bewusst restriktiv gehandhabt. Stattdessen ist der ärztlich gesteuerte Wechsel (sog. „Switching“) der international etablierte Standard – ein Ansatz, der sich durch Transparenz, medizinische Steuerung und Rückverfolgbarkeit auszeichnet.

Dies entspricht auch der europäischen regulatorischen Leitlinie, wie sie u. a. in den gemeinsamen Empfehlungen der European Medicines Agency (EMA) und der Europäischen Kommission festgehalten ist.

In ihrem Leitfaden „Biosimilars in der EU: Leitfaden für medizinische Fachkräfte“ [46] erklären EMA und EU-Kommission eindeutig:

„Eine Entscheidung über einen Wechsel sollte der verschreibende Arzt im Gespräch mit dem Patienten und unter Berücksichtigung aller in dem Land geltenden Richtlinien in Bezug auf die Verschreibung und Anwendung von biologischen Arzneimitteln treffen.“

Diese Position spiegelt sich auch in der Praxis vieler europäischer Mitgliedstaaten wider, in denen Substitution ausschließlich unter ärztlicher Kontrolle erfolgt oder gänzlich untersagt ist. Ein deutscher Alleingang, der eine automatische Apothekensubstitution erlaubt, würde gegen den europäischen Konsens verstoßen und damit Unsicherheit in der Versorgungspraxis schaffen – sowohl bei medizinischem Personal als auch bei Patienten. Darüber hinaus könnten Hersteller und Zulassungsbehörden in der EU gezwungen sein, länderspezifische Risikominimierungsmaßnahmen (RMM) und Schulungssysteme zu entwickeln, was zu einer

236 Fimea: Information for health care professionals. 2025. <https://fimea.fi/en/current-events/substitution-of-biological-medicines/information-for-health-care-professionals>

Fragmentierung der Versorgung und regulatorischer Inkonsistenz führen würde.

Die geplante Regelung in § 40c SGB V läuft damit der europäischen Praxis zuwider und könnte sich langfristig negativ auf die Stabilität des deutschen Gesundheitssystems auswirken.

Stadapharm

In einigen europäischen Ländern wurde die automatische Substitution von Biosimilars in Apotheken eingeführt oder zumindest erlaubt und es gibt valide Hinweise darauf, dass diese Länder ihre Politik überdenken oder angepasst haben.

1. Frankreich: Frankreich war eines der ersten Länder in Europa, das 2014 die automatische Substitution von Biosimilars für therapienaive Patienten erlaubte, sofern der Arzt die Verordnung nicht als „nicht substituierbar“ kennzeichnet. Der Apotheker muss den Arzt informieren, und nach einer Substitution darf kein weiterer Austausch erfolgen. Zurzeit wird über die praktische Umsetzung diskutiert, da die Akzeptanz bei Ärzten und Patienten begrenzt bleibt und die Substitution in der Praxis selten angewendet wird. Ärzte bevorzugen oft die Kontrolle über die Therapieentscheidung, und die Komplexität der Regelungen (z. B. Information des Arztes) hat die Anwendung eingeschränkt.

2. Niederlande: In den Niederlanden ist die Substitution von Biosimilars unter bestimmten Bedingungen erlaubt, jedoch nur, wenn der Patient informiert wird und die Substitution medizinisch überwacht wird. Sowohl Arzt als auch Apotheker müssen beteiligt sein, um die Entscheidung sorgfältig zu treffen. In den Niederlanden gilt mittlerweile als akzeptiert, dass unkontrollierte Substitution vermieden werden soll, was eine vorsichtige Haltung unterstreicht. Die Beteiligung von Ärzten und die medizinische Überwachung zeigen, dass die Niederlande mittlerweile eine „regulierte“ und keine automatische Substitution mehr verfolgen, was als Reaktion auf mögliche Risiken interpretiert werden kann.

Pro Generika

In Frankreich ist die Apothekensubstitution von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln nur unter strikten Auflagen zulässig: Der Apotheker ist verpflichtet, die abgegebene Charge zu dokumentieren und sowohl den behandelnden Arzt als auch den Patienten zu informieren. Dieses Vorgehen entspricht den verbindlichen Anforderungen der Pharmakovigilanz, sichert die ärztliche Nachverfolgbarkeit und vermeidet Risiken für Adhärenz und Wirksamkeit der Therapie. Demnach ist die Substitution von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln in der Apotheke ausschließlich beim ersten Behandlungszyklus eines Patienten und nur unter der Bedingung zulässig, dass die Apotheke die Substitution in der Patientenakte dokumentiert und unverzüglich den verschreibenden Arzt informiert. Durch die explizite Forderung der Haute Autorité de Santé (HAS), dass sowohl Arzt als auch Patient bei einer Substitution informiert werden müssen, wird das Ziel verfolgt die Transparenz des Therapieregimes sicherzustellen und die Pharmakovigilanz durch eine belastbare Rückverfolgbarkeit von Produkt und Charge zu gewährleisten.

Diese Regelungen unterstreichen, dass die therapeutische Verantwortung im Rahmen der Anwendung von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln eine koordinierte Kommunikation zwischen Arzt, Apotheker und Patient voraussetzt.

In der Schweiz sind Apotheker ebenfalls gesetzlich verpflichtet, sowohl Patienten als auch verordnende Ärzte über die Substitution eines Biologikums zu informieren, um Therapiesicherheit und Nachvollziehbarkeit im Medikationsprozess sicherzustellen. Zusätzlich wird empfohlen, die Substitution einschließlich der Chargennummer zu dokumentieren.

Auch in Norwegen besteht für Apotheker die Pflicht, sowohl Patienten als auch Ärzte über eine erfolgte Substitution zu informieren. Die abgegebene Charge ist dabei verpflichtend zu dokumentieren. Diese klare Informations- und Dokumentationspraxis stellt sicher, dass Therapieentscheidungen nachvollziehbar bleiben und unerwünschte Ereignisse korrekt zugeordnet werden können.

Die so geschaffene Transparenz sorgt dafür, dass alle Beteiligten über Präparatewechsel informiert sind und im Fall von Wirksamkeitsproblemen oder Nebenwirkungen schnell und gezielt reagieren können. Zentrales Qualitätsmerkmal ist dabei eine lückenlose Rückverfolgbarkeit– insbesondere bei der Anwendung komplexer biologischer Arzneimittel.

Übertragen auf den Deutschen Kontext lässt sich festhalten: Eine Informationspflicht der Apotheke gegenüber dem behandelnden Arzt ist nicht lediglich fachlich sinnvoll, sondern zwingend notwendig. Fehlt diese Information, besteht nicht nur ein Risiko für die Patientensicherheit, sondern auch eine strukturelle Lücke im System der Arzneimittelüberwachung und -verantwortung.

In den Vereinigten Staaten ist die Apothekensubstitution von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln grundsätzlich nur zulässig, wenn die US-amerikanische Arzneimittelbehörde U.S. Food and Drug Administration (FDA) das betreffende Biosimilar gemäß § 351(k)(4) des Public Health Service Act als „interchangeable“ eingestuft hat. Diese Einstufung setzt voraus, dass bei einem Wechsel zwischen Referenzprodukt und Biosimilar keine zusätzlichen Risiken hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit zu erwarten sind.

Auf Ebene der Bundesstaaten wurde die Substitution durch entsprechende Gesetze konkretisiert. Inzwischen haben sämtliche Bundesstaaten rechtliche Regelungen zur Substitution erlassen. Dabei zeigt sich ein weitgehender Konsens über die Notwendigkeit der ärztlichen Information bei einer Substitution durch die Apotheke.

Konkret ist in 45 von 51 US-Jurisdiktionen eine gesetzlich verpflichtende Benachrichtigung des verschreibenden Arztes vorgesehen. In der Regel muss der Apotheker innerhalb von drei bis fünf Werktagen nach der Abgabe den Produktnamen und Hersteller elektronisch übermitteln – etwa durch Eintrag in ein interoperables Medikationssystem. In weiteren drei Jurisdiktionen bestehen optionale oder empfohlene Verfahren.

Flankierend sehen zahlreiche Bundesstaaten zusätzlich Anforderungen an die Dokumentation und Rückverfolgbarkeit vor. So müssen Apotheken häufig Produktdetails im Rezeptsystem hinterlegen und die Daten über mehrere Jahre aufbewahren. In vielen Fällen ist auch die Information des Patienten verpflichtend, teils mit der Möglichkeit, eine Substitution abzulehnen [237].

Insgesamt macht auch die US-amerikanische Gesetzeslage deutlich, dass die ärztliche Nachvollziehbarkeit, Patientenaufklärung und Rückverfolgbarkeit des Präparats als unerlässliche Voraussetzungen für eine Substitution biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel gelten. Die systematische Benachrichtigung des Arztes ist dabei keine rein formale Maßnahme, sondern sichert die Grundlage für Pharmakovigilanz, ärztliche Verlaufskontrolle und eine kontinuierliche Bewertung von Wirksamkeit und Verträglichkeit im Therapieverlauf.

Bewertung:

Dem ist zu entgegnen, dass die Vorgaben und Regelungen anderer Länder nicht für die Arzneimittelversorgung in Deutschland einschlägig sind.

3.6.5 Ziele des GSAV bereits erreicht / Weitere Mechanismen zur Hebung von Wirtschaftlichkeitsreserven

Amgen

Zusammengefasst lehnt Amgen die automatische Substitution ab, da die bestehenden Marktregularien effektiv sind und bereits heute eine Kostenregulierung darstellen.

237 Sacks CA et al. (2021): Assessment of Variation in State Regulation of Generic Drug and Interchangeable Biologic Substitutions. JAMA Intern Med;181(1):16-22.

Biocon

Eine solche weitreichende Regelung einer umfassenden Substitution ist weder erforderlich noch notwendig, da der mit der Regelung angestrebte Zweck auch durch ein gleichermaßen geeignetes, aber weniger belastendes Mittel erreicht werden kann.

Bereits durch die Neuregelung in § 129 SGB V und die Verpflichtung der Ärzte, ein wirtschaftliches und möglichst preisgünstiges Präparat zu verordnen, wird dem vom Gesetzgeber verfolgten Zweck der Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven vollumfänglich Rechnung getragen. Zudem haben die Kassen bisher durch den Preisabstand zwischen Referenzarzneimittel/Originalpräparat und den Biosimilars erhebliche Einsparungen generiert. Aufgrund der flächendeckend vorhandenen sogenannten Open-House-Verträge kommen weitere erhebliche finanzielle Vorteile in den jeweiligen Wirkstoffgruppen hinzu.

Biogen

Die wirtschaftliche Steuerung der Arzneimittelversorgung über Rabattverträge und automatische Substitution stellt ein etabliertes Instrument zur Kostendämpfung dar. Im Bereich der Biosimilars zeigt sich jedoch, dass dieses Instrument – insbesondere im Rahmen von Open-House-Verträgen – bereits in großem Umfang genutzt wird: Schätzungen zufolge sind rund 90 % der verfügbaren Biosimilars in entsprechende Vertragsmodelle eingebunden. Biosimilars müssen gemäß den regulatorischen Anforderungen grundsätzlich günstiger als ihre Referenzpräparate angeboten werden. Die daraus resultierenden Einsparungen für das Gesundheitssystem sind erheblich – seit 2015 insgesamt 9.51 Milliarden Euro.

Das aktuell vorherrschende Open-House-Modell erlaubt eine Rabattierung aller Produkte ohne die bei Exklusivverträgen notwendige Begrenzung auf wenige Anbieter. Dies vermeidet unnötige, häufige Wechsel in der laufenden Therapie und fördert langfristig den Wettbewerb.

Fresenius Kabi

Wie der Gesetzgeber richtig erkannt – und daher auch in seiner Gesetzesbegründung zum GSAV formuliert – hat, bedeutet allein der Einsatz von Biosimilars im Vergleich zu Originalpräparaten ein enormes Einsparungspotential bei gleichzeitiger Risikoarmut.

Daher war es nur konsequent, durch eine Anpassung des § 84 SGB V den Einsatz von Biosimilar durch die Etablierung von Ordnungsquoten in den Arzneimittelvereinbarungen zu fördern. Diese Praxis ist erfolgreich, da sie mit dem Mittel der Wirtschaftlichkeitsprüfung genug Nachdruck hat, aber dennoch im geschützten Rahmen einer Arzt-Patienten-Beziehung stattfindet und eine indikations- und therapiegerechte Steuerung zulässt. Das dadurch eröffnete Potential wird noch nicht flächendeckend in vollem Umfang ausgeschöpft.

Zudem stehen viele Biosimilars schon seit Jahren unter Rabattvertrag und belaufen sich heute auf knapp 90% der abgegebenen Biosimilar. Damit werden enorme zusätzliche Einsparungen für die Krankenkassen generiert. Die Kombination aus Steuerung der ärztlichen Verordnung durch Biosimilarquoten und bestehenden Rabattverträgen sollte weiterhin effektiv genutzt beziehungsweise ausgebaut werden. Dann bedarf es einer dem Arzt-Patienten-Kontakt nachgelagerten Steuerung in der Apotheke mit all ihren Unsicherheiten und rechtlichen Problemen nicht.

Lilly

Lilly weist weiterhin darauf hin, dass bereits seit einigen Jahren ein ausgedehnter Wettbewerb zwischen Referenz-Biologicals und Biosimilars, insbesondere angesichts des starken Wachstums von Biosimilars im Markt, besteht. Die Marktanteile der Biosimilars sind für viele Wirkstoffe bereits hoch. So betragen die Biosimilar-Anteile gemessen in Tagesdosen (DDD [defined daily doses]) beispielsweise betreffend der Wirkstoffe Rituximab 93,3 %, Filgrastim 87,3 %, Etanercept 83,3 % und Adalimumab 78,3 %. Zukünftig wird erwartet, dass aufgrund des Patentauslaufs weiterer umsatzstarker Biopharmazeutika die Marktdurchdringung von Biosimilars zunimmt und sich deren Verfügbarkeit auf weitere Wirkstoffe und zusätzliche

Indikationen ausweitet.

Des Weiteren werden längst erhebliche Einsparungen auf Biopharmazeutika durch bereits bestehende Rabattverträge zwischen pharmazeutischen Unternehmen und den Gesetzlichen Krankenkassen nach § 130a Absatz 8 SGB V realisiert und ermöglichen es, durch ihren bilateralen Charakter Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben. Betreffend unserer Produkte Humalog®, Lyumjev® und Abasaglar® werden bereits Rabatte auf Grundlage von Rabattverträgen nach § 130a Absatz 8 SGB V für nahezu alle gesetzlich Versicherten in Deutschland realisiert.

[...] Auch durch die Festbetragsregelung im Sinne von § 35 Abs. 5 SGB V, die durch den G-BA regulatorisch umgesetzt wird, konnten bereits in der Vergangenheit und können zukünftig Ersparnisse für die Gesetzliche Krankenversicherung generiert werden. Forsteo® und Huminsulin® beispielsweise fallen bereits unter die Festbetragsregelungen im Sinne von § 35 Abs. 5 SGB V.

Auf Grundlage der bereits vorliegenden sowie zukünftig erwarteten Situation im Arzneimittelmarkt sowie den aktuell bestehenden Einsparinstrumenten wird die Verordnung von Biopharmazeutika sowie von Biosimilars bereits in erheblichem Maße beeinflusst. Es werden bereits umfassende Rabatte durch pharmazeutische Unternehmer wie Lilly gewährt und die daraus resultierenden Einsparungen leisten einen bedeutsamen Beitrag zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit im deutschen Gesundheitswesen. Daher bedarf es aus der Sicht von Lilly für die betreffenden Produkte keiner weiteren gesetzgeberischen Interventionen, wie der geplanten automatischen Substitution von Biopharmazeutika durch Biosimilars in der Apotheke.

Medice

Das Feld der biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel ist sehr heterogen. Es gibt Wirkstoffe, bei denen bereits ein ausgeprägter biosimilarer Wettbewerb besteht und diverse Preisregulierungsmechanismen greifen. Erythropoetin befindet sich beispielsweise in folgendem Spannungsfeld:

- Erythropoietin (Epoetin) steht auf der Liste versorgungsrelevanter Wirkstoffe des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), ist also für die Gesamtbevölkerung relevant (Stand: 28.04.2025).*
- Regelmäßige Festbetragsabsenkungen haben zu sinkenden Listenpreisen geführt, so zuletzt zum 1. Juli 2022.*
- Bioidentische Epoetine dürfen bereits seit über 13 Jahren im Rahmen der Anlage 1 zum Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V in der Apotheke ausgetauscht werden.*
- Durch eine Vielzahl von Importpräparaten hat sich in Verbindung mit den Regeln des Rahmenvertrags nach § 129 Absatz 2 SGB V („Vier-Preisgünstigste-Regel“ in § 12) bereits ein Preisdruck aufgebaut. Eine Abgabefähigkeit in der Apotheke besteht für zahlreiche PZN daher nur über den Abschluss von Rabattverträgen nach § 130a Absatz 8 SGB V.*
- Eine weitere Hebelwirkung erlangten die Rabattverträge 2020 über die Regelungen des § 40a AM-RL und die Verpflichtung der Ärzteschaft, bevorzugt rabattierte biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel zu verordnen. Durch die hier zur Stellungnahme stehende Regelung der automatischen Substitution auf Apothekenebene kommt es folglich erneut zu einer Doppelregulierung. Wenn doch die ärztliche Verordnung schon vorrangig mit Rabattvertragspräparaten erfolgen muss, erscheint eine weitere Vorgabe zum Austausch auf rabattierte Arzneimittel verbunden mit einer Verlagerung der therapeutischen Verantwortung auf die Apotheke verzichtbar.*
- Der GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlichen jährlich Rahmenvorgaben zur Förderung von biosimilaren Epoetin, die als Grundlage für die auf Landesebene zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und den gesetzlichen Krankenkassen zu schließenden Zielvereinbarungen dienen. In allen 17 KVen finden sich Quoten zu biosimilar verfügbaren Epoetinen, teilweise und zunehmend*

ebenfalls mit einer positiven Berücksichtigung von Rabattverträgen. Beispielhaft möchten wir hier die KV Bayern sowie die KV Westfalen-Lippe nennen.

- Der Biosimilar-Anteil betrug bei Epoetin alfa im Dezember 2024 knapp 90% nach Absatz auf Basis DDD, hinzu kommt mit 100% das ausschließlich biosimilar verfügbare Epoetin zeta, dessen Referenzarzneimittel ebenfalls ein Epoetin alfa ist. Knapp 89% (Epoetin alfa) bzw. sogar fast 99% (Epoetin zeta) der im 4. Quartal 2024 zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung abgegebenen Packungen waren unter Rabattvertrag. So decken sowohl Epoetin alfa Hexal® als auch Epoetin zeta (Handelsname Retacrit® bzw. Silapo®) exakt übereinstimmend 73.468.141 GKV-Versicherte ab.

Dem Einbezug des Referenzarzneimittels Erypo® in einen Austausch auf Apothekenebene kann man folglich ein gewisses Einsparpotential unterstellen, da zu Erypo® derzeit keine Rabattverträge bestehen. Erypo® spielt jedoch im ambulanten Sektor eine untergeordnete Rolle (MAT 2025.05: 4,3% der Gesamt-Verordnungen von Epoetin alfa und Epoetin zeta). Die Rabattvertragsabdeckung der Epoetin alfa- und Epoetin zeta-Biosimilars ist jedoch identisch. Ein Austausch zwischen Epoetin alfa- und Epoetin zeta-Biosimilars birgt demzufolge kein zusätzliches Einsparpotential.

Novartis

Maßnahmen zur wirtschaftlichen Versorgung mit Biosimilars sind bereits mannigfach implementiert. Zu nennen sind hier diverse Regulierungen (z. B. allgemeine sowie spezifische Biosimilar-Quotierung, Leitsubstanzvorgaben oder Festbetragsgruppen) auf regionaler und Bundesebene, welche schon heute Einfluss auf die Verordnungspraxis haben.

Neben den bestehenden Regulierungen ist eine hohe Rabattvertragsabdeckung mittlerweile auch über viele Biologika-Märkte, auch bei Originalen, üblich. Für Novartis sind in diesem Zusammenhang ganz konkret folgende Abdeckungen zu nennen: im Ophthalmologie-Bereich und dort konkret im aVEGF-Markt liegt die Rabattvertragsabdeckung von Lucentis® als PFS (Prefilled Syringe) bei 99 %, als Vial bei 77 %. Eylea® bietet eine GKV-Rabattvertragsabdeckung von 92 %. Demgegenüber laufen für Ranibizumab-Biosimilars (im Gegensatz zum Originator) teilweise keine oder nur sehr wenige Verträge (z. B. Ranivisio® 23 %, Rimmyrah® 27 %, Byooviz® 27 %). Eine Substitution auf Apothekenebene würde entsprechend in diesem Markt keine Wirtschaftlichkeitsreserven erschließen lassen und Steuerungsmechanismen hin zu Originalen mit sich bringen, die ggf. nachrangigen KV-Quotenregelungen widersprechen können. Ähnlich gestaltet es sich bei Xolair®. Hier liegt eine GKV-Rabattvertragsabdeckung von knapp 80 % vor.

[...] Eine Einführung der Substitution auf Apothekenebene fügt der Steuerung ein weiteres Instrument hinzu, was die Komplexität weiter erhöht und die Wirksamkeit der einzelnen Steuerungsinstrumente in einem System mit mehrfachen Regulierungen weiter verwischt, ohne dabei einen Vorteil für Patienten zu generieren.

Pro Generika

Die pauschale Gleichsetzung von Wirtschaftlichkeit mit dem Abschluss eines Rabattvertrags ist fehlgeleitet, da mit der Regelung des GSAV der Einsatz von Biosimilars gefördert werden soll und nicht der Einsatz rabattierter Arzneimittel.

Diese gesetzlich intendierte Förderung von Biosimilars als Steuerungsziel zeigt sich zunächst direkt im Regelungsauftrag des Gesetzgebers an den G-BA, Hinweise zur Austauschbarkeit von Referenzarzneimitteln durch Biosimilars zu erarbeiten. Die Gesetzesbegründung verdeutlicht: „**Zur Förderung der Verordnung und Abgabe von Biosimilars** werden in § 129 SGB V Regelungen zur Austauschbarkeit und zur Festlegung von Wirtschaftlichkeitszielen in den Arznei- und Heilmittelvereinbarungen nach § 84 SGB V geschaffen“.

Mit dem gleichen Gesetz wurde der § 84 SGB V dahingehend angepasst, dass nunmehr „Verordnungsanteile für Generika und im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel“ zu vereinbaren seien. Als Begründung wird ausgeführt: „Die

Verordnung von Generika und im Wesentlichen gleichen biologischen Arzneimitteln (Biosimilars) statt eines Originalpräparats ist in der Regel wirtschaftlicher als die Verordnung des Originalpräparates.“

Die Definition der Wirtschaftlichkeit erfolgt nach Auffassung des Gesetzgebers somit über die Biosimilarität und nicht über das Vorliegen eines Rabattvertrages.

§ 130a Abs. 8 SGB V enthält keine Grundlage dafür, Wirtschaftlichkeit allein durch das Vorliegen eines Rabattvertrags zu begründen. Im Gegensatz dazu regelt beispielsweise § 35 Abs. 5 SGB V, dass Festbeträge so festzusetzen sind, dass sie eine wirtschaftliche Versorgung gewährleisten. § 35 SGB V ist somit ein Beispiel dafür, wie der Gesetzgeber Wirtschaftlichkeit ausdrücklich an ein gesetzlich normiertes Preisbildungsinstrument knüpft – eine Regelung, die in § 130a SGB V bewusst fehlt.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die verbindlichen Biosimilar-Quoten gemäß § 84 SGB V und ihre Rolle in der Wirtschaftlichkeitsprüfung auf der ärztlichen Möglichkeit zur Ein- oder Umstellung auf Biosimilars basieren. Die vorgesehene automatische Substitution durch Apotheken fördert jedoch den Austausch auf Grundlage rabattierter Verträge, ohne dass Leistungserbringer oder Versicherte die konkreten wirtschaftlichen Bedingungen kennen. Vor dem Hintergrund, dass bereits heute der Großteil der Biologika unter Rabattvertrag steht, ist ein Austausch durch Apotheken ohne Kenntnis der vertraglichen Konditionen ökonomisch widersinnig und konterkariert die in § 84 SGB V eingeführte Steuerung des ärztlichen Ordnungsverhaltens.

Dieser strukturelle Zielkonflikt zwischen den §§ 84 und 129 SGB V ergibt sich dabei allein aus der vorgesehenen Auslegung des § 129 SGB V durch den G-BA: Während § 84 SGB V auf eine indikations- und therapiegerechte Steuerung durch die ärztliche Verordnung abstellt, würde nach der vom G-BA vorgesehenen Umsetzung des § 129 SGB V eine nachgelagerte, rabattvertragsbasierte Apothekensubstitution erfolgen – unabhängig von medizinischen Kontextfaktoren. Diese parallelen Steuerungsmechanismen wirken nicht komplementär, sondern konkurrierend – und stehen damit im offensichtlichen Widerspruch zur Intention des Gesetzgebers. Hingegen harmonisieren die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der Substitution und die Steuerung über verbindliche Biosimilar-Quoten in Arzneimittelvereinbarungen nach § 84 SGB V grundsätzlich reibungslos miteinander – vorausgesetzt, der gesetzliche Rahmen wird zutreffend ausgelegt und die Austauschbarkeit auf die ausdrücklich vorgesehene Konstellation beschränkt.

vfa

Der Biopharmazeutika-Markt ist zudem durch einen funktionierenden Wettbewerb geprägt und hat bereits – auch aufgrund der hohen Rabattvertragsabdeckung sowie der bestehenden Festbetragsgruppen – zu signifikanten Einsparungen im Gesundheitssystem geführt.

Unabhängig davon ist die wirtschaftliche Verordnung ebenfalls längst gewährleistet. Ärzt:innen werden durch die Krankenkassen über vorliegende Rabattverträge informiert und beachten diese im Rahmen ihrer Verordnungen. Zudem haben Ärzt:innen die weiteren, zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen regional vereinbarten Vorgaben, wie z.B. Quoten, zu berücksichtigen. Diese sowie weitere Instrumente heben umfassend das Einsparpotenzial der Biopharmazeutika. Eine zusätzliche Steuerung durch eine nachgelagerte automatische Substitution in der Apotheke ist weder sachgerecht noch zielführend.

VZA

Wir sehen angesichts der heute schon bestehenden Verpflichtung der Vertragsärzte, preisgünstige Biosimilars gem. § 40a AM-RL zu verordnen und eine Reihe daran anknüpfender Steuerungsmechanismen unter keinem Gesichtspunkt einen Regelungsauftrag oder auch nur eine Regelungsnotwendigkeit für eine Substitution verordneter Biosimilars auf der Apothekenebene.

DDG, gemeinsam mit Hautnetz Deutschland e. V. und BVDD

Aus gesundheitsökonomischer Sicht lässt sich der zusätzliche Nutzen der Regelung zur Substitution durch Apotheken nicht nachvollziehen. Ökonomisch sinnvolle Maßnahmen wie die Nutzung von Rabattverträgen, Biosimilar-Quoten, Arzneimittelverträgen und fokussierten regionalen Regulationen können auch ohne Substitution auf Apothekenlevel realisiert werden. Die Unwägbarkeiten der vorgenannten multiplen Nachteile stellen hingegen ein erhebliches ökonomisches Risiko dar und übertreffen den Zusatznutzen aus unserer Sicht bei weitem.

DGRh

Nach aktuellen Zahlen betrug der Biosimilar-Anteil an den Verordnungen biologischer DMARDs im Jahr 2024 für Adalimumab 80,1 %, für Etanercept 85,3 %, für Infliximab 90,3 % und für Rituximab 93,3 %. Die genannten Substanzen wurden bereits im Zeitraum 2015–2018 patentfrei, sodass seitdem Biosimilars für diese Wirkstoffe zur Verfügung stehen. Neu hinzugekommen sind 2023 Tocilizumab (Biosimilar-Anteil im Jahr 2024: 23.1%) und 2024 Ustekinumab (5,5 %). 89 % dieser Verordnungen entfallen auf rabattierte Produkte. Die Gesamteinsparung durch den Einsatz von Biosimilars wurde in Deutschland fächerübergreifend im Jahr 2024 auf 1,96 Mrd. Euro geschätzt.

Es ist vorstellbar, dass durch den geplanten eigenständigen Austausch von Biologika in der Apotheke zugunsten rabattierter Präparate weitere Einsparungen möglich werden könnten. Allerdings zeigen die genannten Zahlen, dass Ärztinnen und Ärzte bereits jetzt durch ihre wirtschaftliche Verordnungsweise den größten Teil möglicher Einspareffekte erzielt haben.

KKNMS

Ich kann gesundheitswirtschaftlich nachvollziehen, dass Sie diese sogenannte Autosubstitution erwägen, um unserem gemeinnützigen Gesundheitssystem Kosten zu ersparen. Demgegenüber steht nach meiner Erfahrung, dass zumindest der Hersteller Biogen hier in Nordrhein-Westfalen flächendeckende Rabattverträge anbietet, die eine wirtschaftliche Verordnung sicherstellen und somit keine zusätzlichen Kosten in diesem Bundesland hervorrufen würden. Ich räume allerdings ein, dass Sie als GBA für die gesamte Bundesrepublik wahrscheinlich einen deutlich besseren Überblick haben, ob die Angaben der Firma Biogen mit einer bundesdeutsch flächendeckenden Rabattvertragsversorgung korrekt sind. Die wirtschaftliche Verordnung liegt natürlich auch mir im Sinne der MS-Patienten Deutschlands sehr am Herzen.

Psoriasis-Praxisnetz Süd-West

Die Einführung von Biosimilars vor mehr als acht Jahren in der Substanzklasse der TNF alpha Inhibitoren hat zu einer deutlichen Preisreduktion auf dem Markt und damit zu einer sehr begrüßenswerten Verbesserung in der Versorgung unserer schwer betroffenen Patienten mit diesen stark wirksamen Substanzen geführt. Seit April 2021 wurde zudem bei den TNF alpha Inhibitoren eine Festbetragsregelung eingeführt, sowie Quotenregelungen in verschiedenen KV-Bezirken. Nun ist bereits das noch einmal wirksamere und nebenwirkungsärmere IL 12/23 Präparat Ustekinumab als Biosimilar verfügbar. Für dieses Produkt sind bereits sieben Biosimilar-Anbieter gelistet; Der Preisverfall beträgt kurz nach Einführung der Biosimilars bereits um die 50% zum Original. Ein weiterer Preisrückgang ist aufgrund der gegenüber TNF alpha geringen Produktionskosten bei nur vier Injektionen pro Jahr zu erwarten, ebenso wie eine Festbetragsregelung.

Das weitere Sparpotential in der Dermatologie durch einen Austausch in der Apotheke erscheint uns dementsprechend gering.

Zudem ist zu bedenken, dass über die größeren Betriebskrankenkassen und die Ersatzkassen Selektivverträge abgeschlossen wurden (auch mit AOKen in anderen Fachbereichen), die rabattierte Biologika in der Verordnung hervorheben. D.h. hier wird in der Praxis zwingend Kassen- und Substanzspezifisch „aut idem“ verordnet, um ganz bewusst das rabattierte

Biologikum zu erhalten und den Austausch auf einen dann letztendlich teureren z. B. Reimport (AVP günstiger) in der Apotheke zu verhindern.

Bewertung:

Nach dem am 15. August 2019 in Kraft getretenen Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) hat der G-BA gemäß § 129 Absatz 1a Satz 3 SGB V Hinweise für die ärztliche Verordnung zur Austauschbarkeit von biotechnologisch hergestellten biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit sowie gemäß § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken zu geben. Mit dem am 12. November 2022 in Kraft getretenen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) wurde der Regelungsauftrag gemäß § 129 Absatz 1a Satz 6 SGB V dahingehend konkretisiert, dass der G-BA zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben soll. Damit soll i. V. m. § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V für biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften ein eigener Regelungsrahmen zur Austauschbarkeit durch den G-BA festgelegt werden, der für die übrigen Arzneimittel nicht besteht. Ziel des GSAV ist aber gleichwohl eine wirtschaftliche Versorgung mit Biologika. Der Regelungsauftrag besteht unabhängig von dem Anteil von Biosimilars an den Verordnungen und den bereits erzielten Einsparungen im Bereich der Biologika.

Zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags wurde bereits in Abschnitt M der AM-RL § 40a eingefügt und eine Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) ergänzt. Hieraus ergeben sich zunächst für die Ärzte Hinweise für eine wirtschaftliche Verordnung (Einstellung und Umstellung) von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln. Mit § 40b wurden die Vorgaben zur Ersetzung von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Sätze 2 bis 7 i. V. m. Satz 12 und Absatz 1a Satz 6 SGB V für die Gruppe der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel in Bezug auf parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung konkretisiert.

Mit Ergänzung des § 40c werden nun die Vorgaben zur Ersetzung von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Sätze 2 bis 7 und Absatz 1a Satz 5 SGB V für die Gruppe der biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel konkretisiert.

Zutreffend ist, dass in der Arzneimittelversorgung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung generell verschiedene Instrumente zur Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebots auf verschiedenen Ebenen ineinandergreifen und auf diese Weise insgesamt zur Realisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven beitragen. Bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken zu geben, orientiert sich der G-BA an den in § 129 SGB V von Gesetzes wegen vorgesehenen Instrumenten zur Versorgungssteuerung und überträgt die dort angelegte Systematik in § 40c Absatz 2 AM-RL auf den Bereich der Biologika. Darüber hinaus sind auch in diesem Bereich die weiteren, von Gesetzes wegen vorgesehenen Instrumente zur Versorgungssteuerung zu berücksichtigen.

Siehe ergänzend auch Bewertung der Einwände zu Absatz 2 sowie zu den weiteren Einwänden 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 und 3.6.6.

Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits im Stellungnahmeverfahren zum Beschluss vom 15. Juni 2023 zur Ergänzung der AM-RL um § 40b befasst; es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in der Zusammenfassenden Dokumentation zu dem entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g->

3.6.6 Gefährdung der Versorgungssicherheit

Amgen

Aktuell bieten die Krankenkassen allen Anbietern biotechnologisch hergestellter Arzneimittel in gleicher Weise die Möglichkeit, sich an Open-House Rabattverträgen zu beteiligen und somit den Ärztinnen und Ärzten eine wirtschaftliche Verordnung ihrer Produkte nach § 40a AM-RL zu ermöglichen.

Es ist zu erwarten, dass mit der Freigabe der Substitution biotechnologisch hergestellter Fertigarzneimittel in der Apotheke die Krankenkassen für umsatzstarke Wirkstoffe mit mehreren Marktteilnehmern exklusive Rabattvertragsmodelle ausschreiben werden. Dieses Vorgehen wird sich insbesondere dann durchsetzen, wenn für § 40c Abs. 2 AM-RL i. V. m. § 40c Abs. 3 Position A1 + B1 AM-RL Eingang in die AM-RL finden sollte.

Exklusive Tender, bei denen ausschließlich der niedrigste Preis für den Zuschlag ausschlaggebend ist, bewirken jedoch durch den Ausschluss der unterlegenen Anbieter eine Marktkonzentration, eine Behinderung des Wettbewerbs und steigern zudem das Risiko von Lieferengpässen, da sie Hersteller von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln unter einen rasant zunehmenden Preisdruck setzen. Hierbei handelt es sich nicht um ein hypothetisches Szenario, sondern um ein realistisch zu erwartendes Ereignis, das sich bereits anhand vergangener Liefer- und Versorgungsengpässe bei Generika in Europa seit 2011 belegen lässt, wie Dranitsaris et al. (2017) und Shukar et al. (2021) zeigen konnten [238, 239]. Insbesondere Ausschreibungssysteme mit Zuschlägen an ausschließlich einen Anbieter, wurden in Übersichtsarbeiten von Dave et al. (2018) und Kanavos et al. (2009) als Hauptursache für Lieferengpässe von Generika in einkommensstarken Ländern wie Deutschland identifiziert [240, 241]. Auch für biotechnologisch hergestellte Zubereitungen kommt es in Abhängigkeit des Anbieters bereits jetzt zu Liefer- bzw. Versorgungsengpässen im Krankenhaus, wie sich dies anhand der Wirkstoffe Bevacizumab (Zirabev®) und Trastuzumab belegen lässt.

Diese Engpässe müssen bereits jetzt durch andere Hersteller kurzfristig überbrückt werden. Bei exklusiven Tendern wird dies, aufgrund der zu erwartenden Reduktion von Anbietern, nicht mehr möglich sein. Denn die Herstellung von Biosimilars erfordert erheblich aufwendigere Anlagen, qualifiziertes Fachpersonal und strengere Qualitätsprüfungen und folglich mehr Zeit als die Herstellung generischer Arzneimittel. Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass sich europäische Anbieter mittel- bis langfristig aus der Produktion zurückziehen werden.

Als Konsequenz wird die Verlagerung und Konzentration auf wenige Produktionsstandorte und Anbieter analog zur Entwicklung im Generikamarkt die Folge sein. Zudem kann die Nachhaltigkeit der gewünschten Kosteneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden [242]. Dies zeigen Erfahrungsberichte aus Ländern wie Dänemark und Kanada, in denen beispielsweise die Biologika Adalimumab und Trastuzumab vom gleichen Hersteller nicht lieferbar waren, da die Priorisierung des Tenderzuschlags der Biosimilars allein durch den Preis erfolgt, jedoch ohne hinreichende Sicherstellung der Versorgung. Auch in Großbritannien

238 Dranitsaris G et al. (2017): Drug tendering: drug supply and shortage implications for the uptake of biosimilars. Clinicoecon Outcomes Res;9:573-84.

239 Shukar S et al. (2021): Drug Shortage: Causes, Impact, and Mitigation Strategies. Front Pharmacol;12:693426.

240 Dave CV et al. (2018): Predictors of Drug Shortages and Association with Generic Drug Prices: A Retrospective Cohort Study. Value Health;21(11):1286-90.

241 Kanavos P et al. (2009): Tender systems for outpatient pharmaceuticals in the European Union: evidence from the Netherlands, Germany and Belgium. <https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/02/Tender-systems-for-outpatient-pharmaceuticals-in-the-EU.pdf>

242 Vulto AG et al. (2020): Sustainability of Biosimilars in Europe: A Delphi Panel Consensus with Systematic Literature Review. Pharmaceuticals (Basel);13(11).

und Australien waren Biosimilar-Hersteller durch entsprechende Kostenregulierungsmaßnahmen und einem einhergehenden Preisverfall gezwungen, ihre Produkte – vor allem Onkologika wie Trastuzumab und Rituximab – vom Markt zu nehmen.

Dass diese aufgeführten Lieferengpässe keine Einzelfälle sind, lässt sich aus der EMA-Plattform zum Lieferengpass-Management entnehmen. So betrafen im Jahr 2023 etwa 60 % der in Europa gemeldeten Lieferengpässe biologische Arzneimittel (European Shortages Monitoring Platform), wobei etwa 30 % der von der EMA verzeichneten Arzneimittelengpässe in 2023 durch Nachfrageschübe verursacht wurden. Diese Zahlen spiegeln sich auch merklich in der Arzneimittelversorgung in Europa wider. Eine repräsentative Umfrage unter 2.136 Krankenhausapotheken in 39 Ländern im Jahr 2019 von Miljković et al. ergab, dass 95 % dieser Apotheken mit Arzneimittellieferengpässen konfrontiert und Onkologika am zweithäufigsten davon betroffen waren [243]. Als Ursache hatte bereits im Jahr 2013 die EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) berichtet, dass mehr als die Hälfte (52,4 %) der Arzneimittellieferengpässe auf die eingeschränkte Anzahl von lieferfähigen Herstellern zurückzuführen ist. Diese Lieferengpässe waren zwar nur vorübergehend, konnten jedoch dabei ausschließlich durch multiple Anbieter vermieden werden. Diese Resilienz würde bei exklusiven Tendern systematisch abgebaut werden.

Es ist zu erwarten, dass der Trend steigender Lieferengpässe anhalten wird, da durch untragbare Preis- und Erstattungsregularien in diversen europäischen Ländern, zu der auch wie bereits zuvor beschrieben Tender mit Einpartner-Modellen sowie sinkende Festbeträge bzw. Erstattungsgrenzen gehören, Anbieter aus dem Markt gedrängt werden.

In der Gesamtschau ist festzuhalten, dass der Arzneimittelmarkt der Biologika bereits durch die zahlreichen Preis-, Erstattungs- und Abgabevorgaben, die bis heute vermehrt zu Lieferengpässen geführt haben und immer noch führen, stark reglementiert wird. Die automatische Substitution von Biologika auf Apothekenebene durch preisgünstige Biologika bzw. Biologika mit Rabattverträgen nach § 130a Abs. 8 SGB V, wie der G-BA sie in der vorgeschlagenen Fassung für § 40c Abs. 2 der AM-RL vorsieht, wird die jetzt schon kritische Lieferengpass-situation von biologischen Arzneimitteln in Zukunft noch verschärfen. Dies kann aus Sicht von Amgen jedoch nicht Wille des Gesetzgebers gewesen sein, der mit den vergangenen Gesetzesänderungen wie dem ALBVVG und dem Medizinforschungsgesetz die Versorgung der Patient:innen stärken wollte.

Darüber hinaus werden über 100 Biopharmazeutika bis zum Jahr 2032 ihre Marktexklusivität in Europa verlieren, wodurch sich für die Kostenträger bereits ein Einsparpotenzial durch den Markteintritt von Biosimilars ergäbe. Sollten aufgrund von unattraktiven und unwirtschaftlichen Markt- sowie Erstattungsbedingungen Biosimilars nicht auf den Markt kommen oder gar nicht erst entwickelt werden, ginge dieses Einsparpotenzial verloren.

[...] Eine Regelung, die vorrangig auf kurzfristige Kosteneinsparungen und preisgetriebene Ausschreibungsmodelle setzt, widerspricht zudem dem im Koalitionsvertrag formulierten Ziel, Deutschland zum international führenden Biotechnologie-Standort zu entwickeln und die vorhandenen Kompetenzen und Entwicklungspotenziale in diesem Bereich zu stärken. Zudem werden Bemühungen auf EU-Ebene, Europas pharmazeutische Versorgung resilienter zu gestalten und Produktionskapazitäten zu stärken (im Wesentlichen das EU-Pharmapaket und der Critical Medicines Act), konterkariert.

Biocon

Insbesondere auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist daher zwingend von einer Substitution von Biosimilars durch Apotheken abzusehen.

Hier werden kurzfristige Einsparpotenziale in den Vordergrund gerückt und langfristige Risiken vollständig verdrängt. Biosimilars ermöglichen den Zugang zu modernen Therapien zu

243 Miljkovic N et al. (2020): Results of EAHP's 2019 Medicines Shortages Survey. Eur J Hosp Pharm;27(4):202-8.

geringen Kosten, bei identischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Der Wettbewerb, den sie schaffen, senkt die Therapiekosten direkt zur Markteinführung im Schnitt um 30-40 %, im Einzelfall sogar um noch mehr. Schon heute erzielen viele dieser Präparate hohe Verordnungsquoten. Der aktuelle G-BA-Entwurf stellt diese Errungenschaften infrage. Zukünftig entscheiden nicht mehr Ärzte, sondern Apotheken, welches Präparat ein Patient erhält, und zwar jenes, für das es einen Rabattvertrag zwischen Krankenkasse und Hersteller gibt. Hierbei gewinnt ein Hersteller die Ausschreibung und alle anderen sind draußen. Damit wird der Wettbewerb, der aktuell existiert und den funktionierenden Markt der Biosimilars mit seinen bestehenden immensen Kosteneinsparungen bedingt, ohne Not zerstört. Mit den aktuellen Plänen des G-BA werden Hersteller von Biosimilars auf Neueinführungen verzichten, da dies nicht mehr interessant ist.

Biosimilars sind Nachahmerprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln. Im Gegensatz zu Generika, die chemisch identisch zum Original sind, handelt es sich bei Biosimilars um hochkomplexe, gentechnisch hergestellte Arzneistoffe. Ihre Entwicklung ist aufwendig, langwierig und teuer. Ihre Produktion erfordert kostspielige Anlagen, gut ausgebildetes Fachpersonal und einen immensen zeitlichen und finanziellen Spielraum, da aufgrund des komplexen Prozesses längst nicht alle Produkte auch Marktreife erlangen.

[...] Zutreffend ist hier die Stellungnahme von Walter Rohrer, dem Vorsitzenden der AG pro Biosimilars:

„Die Bundesregierung will mehr Versorgungssicherheit – und der G-BA läutet das „Hauptsache-billig“-Prinzip bei Biosimilars ein. Die automatische Substitution bei Biosimilars droht nicht nur ein funktionierendes System aus dem Gleichgewicht zu bringen – sie gefährdet auch Produktion und Entwicklung am Standort Deutschland. Der Schritt, den der G-BA jetzt offenbar einleiten will, hat einzig das Ziel, den Krankenkassen exklusive Rabattverträge zu ermöglichen. Das aber hat schon bei den Generika die Versorgung destabilisiert. Die Folgen – Abwanderung der Produktion, Lieferengpässe und eine bröckelnde Versorgung – bekommen Patientinnen und Patienten täglich in den Apotheken zu spüren. Dieser Fehler soll nun bei den deutlich komplexeren und aufwändiger zu produzierenden Biosimilars wiederholt werden. Dabei stehen hier Medikamente im Fokus, die für schwerkranke Menschen mit Krebs, Rheuma oder chronisch-entzündlichen Erkrankungen lebenswichtig sind. Engpässe in diesem Bereich hätten fatale Folgen. Gesundheitsministerin Warken hat Versorgungssicherheit zu ihrer politischen Priorität erklärt. Jetzt gilt es, diesen Anspruch auch gegenüber der Selbstverwaltung zu verteidigen. Der angekündigte Pharmadialog bietet die Chance, hier Leitplanken zu setzen – im Sinne der Patient:innen und eines sinnvoll global diversifizierten und starken Produktionsstandorts Europa. Unser Appell: Keine Schnellschüsse zulasten der Versorgung. Eine nachhaltig finanzierte Arzneimittelversorgung verdient durchdachte Lösungen – und keine kurzsichtigen Adhoc-Maßnahmen.“

[...] Der jetzige G-BA-Beschluss konterkariert auf der untergesetzlichen Ebene der Selbstverwaltung sowohl das auf EU-Ebene beschlossenen Pharmapaket, das ein innovationsfreundliches Umfeld schaffen soll, als auch die deutsche Pharmastrategie, den nationalen Pharmastandort zu stärken.

Auch im Koalitionsvertrag ist beschlossen, Deutschland zu dem weltweit innovativsten Pharma- und Biotechnologiestandort zu machen. Die industrielle Gesundheitswirtschaft wird als Leitwirtschaft anerkannt und in den Mittelpunkt der politischen Agenda gerückt. Damit steht der jetzige Beschluss des G-BA gänzlich in Widerspruch.

[...] Zutreffend stellt die AG pro Biosimilars fest, dass der Gesetzgeber bereits 2023 mit dem Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) anerkannt hat, dass eine dauerhaft auf minimale Preise ausgerichtete Vergütungspolitik nachteilige gesellschaftliche Folgen hat. Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Erkenntnis im Bereich der Biosimilars nun ignoriert werden soll. Vielmehr müsste die regulatorische Behandlung biotechnologischer Arzneimittel deren Versorgungs- und Industriepolitik

gleichermaßen berücksichtigen. Eine differenzierte Marktordnung, die den biotechnologischen Produktionsaufwand sowie die Rolle von Biosimilars für Versorgungssicherheit, Preisstabilität und Standortattraktivität einbezieht, ist zwingend erforderlich und politisch gewünscht.

[...] Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die geplante Regelung in erheblicher Weise den Erfolg gefährden kann, den Biosimilars bislang dem deutschen Gesundheitssystem und dessen Kostenträger im Sinne von Anbietervielfalt, Liefersicherheit und Wirtschaftlichkeit bieten. Folgerichtig hat die Wirtschaftsministerkonferenz der Länder bereits im Juni 2021 beschlossen: „Die bei Generika durch die bisherige Preisgestaltung mitverursachte Entwicklung sollte bei den biologischen bzw. biotechnisch hergestellten Wirkstoffen unbedingt vermieden werden.“. Nichts desto trotz soll nun die Substitution durch die Apotheken eingeführt werden.

Der Beschluss des G-BA konterkariert die EU-Pharmastrategie, das deutsche Pharmapaket und die auf politischer Ebene beschlossene Standortstärkung, um Deutschland zu dem weltweit innovativsten Pharma- und Biotechnologiestandort zu machen. Mit den aktuellen Plänen des G-BA werden Hersteller von Biosimilars auf Neueinführungen verzichten, da dies nicht mehr interessant ist, und neue Unternehmen werden nicht Deutschland als Standort wählen.

Es ist nicht auszuschließen, dass die zuvor genannten Herausforderungen noch verschärft werden, wenn Krankenkassen die Austauschbarkeit von Biologika für exklusive Wirkstoff-ausschreibungen zum Abschluss von Rabattverträgen nach § 130a Absatz 8 SGB V nutzen. Die in diesem Zusammenhang zu erwartenden Marktkonzentration mit allen ihren negativen Auswirkungen hat für den wesentlich wettbewerbsintensiveren Generika-Markt das im März 2019 vom Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie veröffentlichte Gutachten „Zehn Jahre Arzneimittel-Rabattverträge – Wird der Leistungsanspruch des Patienten noch erfüllt?“ belegt.

Dieses Gutachten untersucht den Einfluss der Rabattverträge ab 2008. 2008 ist deshalb als Vergleichsmaßstab entscheidend, weil ab diesem Jahr die Verknüpfung der Rabattverträge mit einer entsprechenden Substitutions-Pflicht ihre volle Wirkung entfaltet hatte, also der gleichen Regelung, wie sie jetzt für den Biosimilar-Markt geplant ist.

Danach entfielen 10 Jahre nach Einführung dieser Regelung, also im Jahr 2017, 71% aller Umsätze von rabattierten Arzneimitteln auf lediglich 10 Unternehmen. Zudem hatten in dem Jahr die Produktgruppen mit einer hohen Konzentration einen Marktanteil von 89,3%, während dieser Anteil noch im Jahr 2008 lediglich 63,3% betrug.

Daher wäre es für eine gesicherte und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit biologischen Arzneimitteln erforderlich, für den Fall einer Rabattvertragsausschreibung zur Vermeidung dieser Konsequenz ein Mehrfachzuschlagsystem vorzugeben, soweit es im Hinblick auf die Angebotssituation als notwendig erscheint.

Hier ist ein Vergleich zu den negativen Auswirkungen der Ausschreibungen für Impfstoffe wegweisend. Seinerzeit führte die anfängliche Ausschreibung nach einer sehr schnellen Reduktion der Anbieterzahl zu einem allgemeinen Verbot von Rabattverträgen bei Impfstoffen. Da die Anzahl der Anbieter von Biosimilars hiermit aktuell als vergleichbar anzusehen ist, ist auch bei Biosimilars mit einem vergleichbaren Rückgang zu rechnen. Die Folge läge nicht nur in einer verschlechterten allgemeinen Versorgung, sondern auch in einem Rückgang weiterer Neueinführungen. Hinzukommt, dass Produktneueinführungen nach Patentablauf den höchsten Einspareffekt bringen, so dass von kurzfristigen Einsparungen abgesehen, mehr als zweifelhaft ist, dass die „automatische Substitution“ mittel- und langfristig Kostenersparnisse bringt und nicht vielmehr sogar eine Verteuerung der Arzneimittelkosten zur Folge hätte. Dann hätte man jedoch das derzeit bestehende gut funktionierende System der Biosimilars zerstört und den Wettbewerb, wie bei den Generika seinerzeit, dezimiert. Vor diesem Hintergrund, dass zahlreiche Wettbewerber schlicht vom Markt verschwinden, darf die Hoffnung, dass durch den direkten Wettbewerb infolge der Austauschbarkeit die Versorgung der Versicherten künftig günstiger wird unter Einbezug aller Möglichkeiten definitiv in Frage gestellt werden.

[...] Als Negativbeispiel sei die schon jetzt als durchaus angespannte Situation bei der Versorgung der Diabetiker mit Insulin genannt, der allgemeinen Verfügbarkeit von Erstanbieter wie Biosimilar, dem Wegfall von Humaninsulin, der Marktauswirkungen durch die Abnehmspritze und der bereits jetzt angespannten preislichen Situation, die Deutschland im internationalen sowie im europäischen Vergleich, als Niedrigpreisland darstellt, mit entsprechenden verheerenden Auswirkungen für Pateinten und die Gesellschaft. Die Konsequenz ist schon jetzt eine nachrangige problematische Versorgung.

Biogen

Die Entwicklung und Zulassung von Biologika/Biosimilars ist deutlich aufwändiger als bei Generika: Während Generika mit einem Investitionsvolumen von 2–3 Mio. USD innerhalb von 2–3 Jahren entwickelt werden können, erfordert ein Biologikum/Biosimilar typischerweise 8–9 Jahre Entwicklungszeit und Investitionen von 100–200 Mio. USD [196]. Diese strukturellen Unterschiede machen das Geschäftsmodell der Generika nicht auf Biologika/Biosimilars übertragbar. So zeigt die Betrachtung der Markteintritte in Deutschland, dass viele Biosimilars nicht direkt zum sogenannten „Day 1“ nach Patentablauf auf den Markt kommen. Anders als bei Generika, die häufig unmittelbar nach Patentablauf verfügbar sind, kommen Biosimilars aufgrund ihrer komplexen Entwicklung und regulatorischen Anforderungen oft deutlich verzögert auf den Markt. Die beigefügte Übersicht (Abbildung 8) zeigt exemplarisch, dass bei Wirkstoffen wie Adalimumab, Etanercept oder Trastuzumab zwischen Patentablauf und tatsächlichem Markteintritt einzelner Biosimilars mehrere Jahre liegen können.

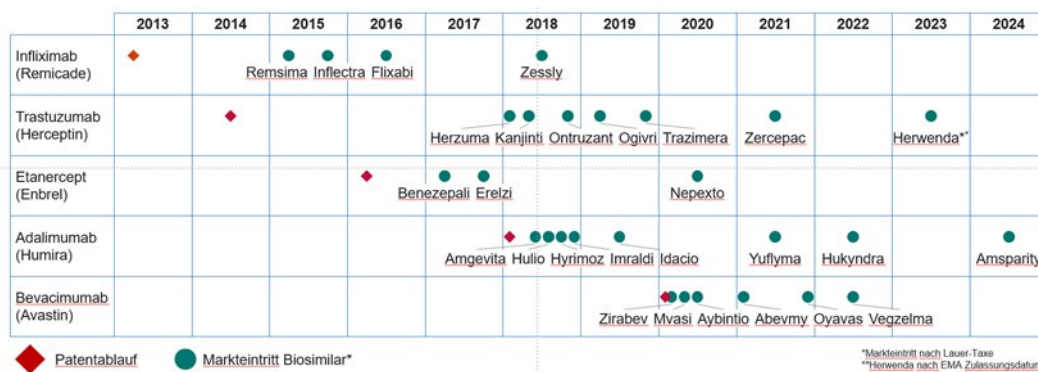


Abbildung 8: Patentabläufe ausgewählter Biologika und Markteintritte entsprechender Biosimilars, nach Lauer-Taxe.

Wenn Rabattverträge, wie bei Generika üblich, kurz nach Patentablauf ausgeschrieben und exklusiv vergeben werden, besteht die Gefahr, dass später zugelassene Biosimilars vom Markt ausgeschlossen werden, obwohl sie möglicherweise kostengünstiger oder besser verfügbar wären. Eine automatische Substitution auf Basis bestehender Verträge kann somit innovationshemmend wirken, den Wettbewerb verzerren und die Versorgungssicherheit gefährden. Dieses strukturelle Problem sollte bei der Ausgestaltung von Absatz 2 dringend berücksichtigt werden.

Die Entwicklung auf dem Generikamarkt zeigt, dass ein übermäßiger Fokus auf Rabattverträge zudem unbeabsichtigte Folgen für die Versorgungssicherheit haben kann. Ausschreibungen mit hohem Preisdruck können Hersteller dazu veranlassen, sich aus dem Markt zurückzuziehen oder ihre Produktion in kostengünstigere Regionen zu verlagern. Dies birgt das Risiko von Lieferengpässen – ein Problem, das sich bereits heute deutlich zeigt: Am 3. Juli 2025 listete das Bundesministerium für Gesundheit 611 Arzneimittel mit Lieferengpässen, darunter 72 mit versorgungskritischen Wirkstoffen wie Insulin, Fluorouracil oder Liraglutid. Die Erfahrungen aus dem Generikamarkt zeigen, dass ein zu starker Preisdruck zu einer Konzentration der Produktion auf wenige Anbieter und Standorte führt – mit erhöhter Anfälligkeit für Störungen in der Lieferkette.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein zusätzlicher Substitutionsdruck tatsächlich

notwendig ist oder ob dadurch lediglich kurzfristige Einsparpotenziale auf Kosten langfristiger Versorgungssicherheit und Marktstabilität realisiert werden.

Die zu Absatz 2 dargestellten Aspekte zur Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit legen nahe, dass die automatische Abgabe rabattierter oder preisgünstiger Biologika/Biosimilars nicht allein unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet werden sollte. Biosimilars leisten bereits heute einen erheblichen Beitrag zur Kosteneinsparung im Gesundheitswesen, sodass zusätzlicher Substitutionsdruck nur begrenzt weiteren Nutzen bringt. Gleichzeitig können Ausschreibungen mit starker Substitutionsverpflichtung zu Marktverzerrungen, einem Rückzug von Anbietern und letztlich zu Lieferengpässen führen.

Celltrion

Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass Celltrion grundsätzlich Maßnahmen zur Stärkung einer wirtschaftlichen und dennoch patientenzentrierten Arzneimittelversorgung in Deutschland begrüßt. Die im Entwurf zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie angedachten Anpassungen stellen aus unserer Sicht jedoch ein großes Risiko dar, das hohe Qualitäts- und Versorgungsniveau in Deutschland zu gefährden.

Die automatische Substitution von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln in der Apotheke gefährdet nicht nur die Arzneimittelsicherheit der Patienten, sondern unterminiert perspektivisch die nachhaltige Sicherstellung einer funktionierenden Gesundheitsversorgung in Deutschland.

Bereits im Stellungnahmeverfahren zum Austausch von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln zur parenteralen Zubereitung wurde hinlänglich auf den besonderen Herstellungsprozess von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln hingewiesen. Lieferausfälle unterschiedlichster Ursache bei einzelnen Herstellern können zu Engpässen in der Versorgung führen, da größere Mengen aufgrund des komplexen Herstellprozesses nicht ohne weiteres von anderen Herstellern kompensiert werden können. Alle angestrebten Maßnahmen sollten voraussetzen, dass substituierbare Präparate verlässlich verfügbar sind.

Formycon AG

Bei der von Ihnen geplanten Änderung der Arzneimittel-Richtlinie befürchten wir, dass Deutschland mit der automatischen Substitution in der Apotheke einen Weg beschreitet, der mittel- bis langfristig Schaden anrichten wird. Dabei geht es nicht nur um die mehrfach und ausführlich beschriebenen Sicherheitsrisiken für Patientinnen und Patienten, es geht auch um Stellenwert und Qualität des deutschen Gesundheitssystems.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungen für die Anbieter patentfreier Arzneimittel in Deutschland durch Maßnahmen des Gesetzgebers deutlich verschlechtert. Das hat teils gravierend negative Folgen für die Versorgung der Patientinnen und Patienten: Lieferengpässe, Lieferausfälle, Marktverengung durch Rückzug von Anbietern, Abhängigkeit von Lieferanten aus Asien, insbesondere China. Noch werden die meisten Biosimilars in Europa produziert.

Wir können daher nicht nachvollziehen, warum Sie angesichts dieses Befundes für Biosimilars vergleichbare Rahmenbedingungen schaffen wollen wie für Generika. Warum wollen Sie die Fehler, die bei Generika gemacht wurden, wiederholen? Das ist vollkommen unverständlich vor dem Hintergrund, dass zur Zeit versucht wird diese Fehler zu korrigieren und z.B. die Produktion von Generika wieder nach Europa zurückzuholen, um die Versorgungssicherheit zu verbessern.

Durch unsere regulatorische Arbeit sind wir weltweit im engen Austausch mit Behörden und anderen Akteuren der jeweiligen Gesundheitssysteme. Sie alle sehen Biosimilars einerseits als Chance, wissen aber andererseits auch genau um die Besonderheiten dieser Produktgruppe. Entsprechend hoch sind die Anforderungen bei Entwicklung, Herstellung und Vermarktung; entsprechend vorsichtig und sensibel ist der Umgang mit den Präparaten in der

therapeutischen Praxis.

Eine automatische Substitution in der Apotheke, die damit verbundene Absenkung der Sicherheitsstandards, die mögliche Gefährdung des Therapieerfolgs – all das lässt sich damit nicht vereinbaren.

Natürlich gibt es Substitution auch in anderen Märkten. Aber – hier wären als Beispiele Frankreich oder die USA zu nennen - sie ist an Sicherheitsvorkehrungen geknüpft, sie erfolgt vorsichtig und sensibel. Vor allem: Ärzte behalten dabei ihre therapeutisch zwingend notwendige Schlüsselrolle. Das ist aus unserer Sicht ein ganz zentrales Kriterium!

Global gesehen beginnt der Siegeszug der Biosimilars gerade erst. Auch für Deutschland besteht großes Potential. Bis 2032 werden mehr als 40 biopharmazeutische Blockbuster, also Präparate mit einem weltweiten Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar, ihre Marktexklusivität verlieren.

Das sind mehr als 40 zusätzliche Chancen, Versorgung sowohl zu verbessern als auch effizienter, also kostengünstiger zu machen. Unternehmen wie wir stehen bereit, diese Chancen mit unserer Expertise in der technologischen und regulatorischen Entwicklung zu realisieren. Wir haben als deutsches Unternehmen natürlich besonders Deutschland und Europa im Fokus für die Produktion unserer Produkte aber auch als Absatzmärkte. Wir stehen aber als global operierendes Unternehmen, sowohl was die Produktionsstandorte also auch die Absatzmärkte anbelangt, in Konkurrenz mit immer stärker werdenden Akteuren.

Durch die Einführung einer automatischen Substitution in der Apotheke würde Deutschland für Unternehmen, die Biosimilars produzieren und vermarkten, an Stellenwert verlieren. Somit könnten Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte und nicht zuletzt Krankenkassen viele Chancen für eine bessere, effizientere und sichere Versorgung verpassen.

Wir bitten Sie deshalb dringend, bei der Substitution von Biologika in der Apotheke die Hinweise und Forderungen z. B. der AG Pro Biosimilars zu berücksichtigen. Für „Automatismen“ sind die Produkte zu komplex, die Therapien zu anspruchsvoll und - nicht zuletzt - die Erkrankungen zu schwerwiegend.

Novartis

Sollte sich der Biosimilars-Markt von Open House hin zu exklusiven Rabattverträgen/Tendern entwickeln, sieht Novartis ein Risiko in der Patientenversorgung. Eine solche Entwicklung muss bei Biologika als noch kritischer angesehen werden als bei chemisch synthetisierten Arzneimitteln. Die Produktion von Arzneimitteln, die mittels Biotechnologie hergestellt werden, ist im Unterschied zu chemisch-synthetisierten Arzneimitteln um ein Vielfaches komplizierter und aufwändiger. Diese hochmolekularen Wirkstoffe werden mittels lebender Organismen meist in Zellkulturen produziert. Ihre Produktion lässt sich entsprechend nicht schnell hoch- und runterfahren. Die knappen Vorlaufzeiten in exklusiven Rabattverträgen/Tendern könnten zu Lieferengpässen, einer Konsolidierung des Marktes und auf Dauer zu erhöhten Abhängigkeiten von einzelnen Produzenten führen. Es besteht somit mindestens die Gefahr der Verschlechterung der Patientenversorgung.

[...] Darüber hinaus hat sich bereits im Generikamarkt gezeigt, dass eine durch Rabattverträge getriebene einseitige Konzentration auf preisgünstige Produktion und damit Produktionsstandorte in Ländern mit niedrigen Lohnkosten zu erheblichen Versorgungsengpässen geführt hat. In einer Zeit erhöhter globaler politischer Spannungen könnte ein ähnliches Prinzip im Biosimilars-Markt die Versorgungssicherheit für deutsche Patienten gefährden und den Pharma- und Biotechnologiestandort Deutschland erheblich schwächen.

Pfizer

Die geplante Substitution auf Apothekenebene kann die bisher funktionierende Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Biologika gefährden. Dass diese Sorge berechtigt ist, sieht man aktuell bei vielen generischen Wirkstoffen, die in Deutschland nicht mehr lieferfähig sind.

Fehler im Generikamarkt sollten nicht wiederholt werden. Die mittelfristigen Risiken für die Versorgungssicherheit bei Biologika wären angesichts der geringeren Anzahl an Herstellern deutlich höher einzustufen als im Generikamarkt. Für die betroffenen Patientinnen und Patienten ist die zuverlässige Liefer- und Versorgungssicherheit essenziell; die derzeitige Herstellerdiversität sowie die Produktionsstandorte Deutschland und Europa sind dafür eine entscheidende Voraussetzung. Um robuste Lieferketten zu gewährleisten, wird ein Teil der Biologika bzw. ihrer Wirkstoffe von Pfizer in Deutschland hergestellt.

Es muss berücksichtigt werden, dass Biologika nicht mit chemisch-synthetischen Arzneimitteln gleichzusetzen sind, deren Produktion schnell initiiert bzw. hochskaliert werden kann. Werden Biologika aus dem Markt gedrängt, hinterlassen sie eine Lücke, die nur mit Verzug wieder geschlossen werden kann. Patientinnen und Patienten könnte der Zugang zu hochwirksamen Therapien verwehrt bleiben, was gerade bei onkologischen Erkrankungen fatale Folgen haben kann.

[...] Die geplante Substitution auf Apothekenebene würde die bisher **funktionierende Versorgung Patienten mit biologischen Fertigarzneimitteln gefährden**, weswegen Pfizer für die Streichung oder Aussetzung des § 129 Abs. 1a Satz 6 SGB V plädiert. Dass diese Sorge berechtigt ist, sieht man aktuell bei vielen generischen Wirkstoffen, die aufgrund des enormen Preisdrucks in Deutschland nicht mehr lieferfähig sind. Es kommt hinzu: Die mittelfristigen Risiken für die Versorgungssicherheit bei Biosimilars wären angesichts der geringeren Anzahl an Herstellern **deutlich höher einzustufen als im Generikamarkt**.

Die Substitution in der Apotheke konterkariert darüber hinaus das erklärte Ziel der Bundesregierung, Deutschland zum international führenden Biotechnologie-Standort zu machen und Lieferengpässe entschieden zu bekämpfen (s. Koalitionsvertrag und Nationale Pharmastrategie). Ein starker Produktionsstandort ist eine entscheidende Voraussetzung für Liefer- und Versorgungssicherheit, Investitionen und Innovationen. Um robuste Lieferketten zu gewährleisten, stellt Pfizer einen Teil seiner Biologika in Deutschland / Europa her. Die dafür in Deutschland / Europa vorhandenen Kapazitäten und Expertisen dürfen nicht fahrlässig durch kurzfristig angelegte Sparmaßnahmen geschwächt werden. Überzogene Kostendämpfung wird sich nachteilig auf den weiteren Ausbau und die Neuansiedlung biopharmazeutischer Produktionskapazitäten in Deutschland / Europa auswirken und eine Abhängigkeit von der Produktion in Asien nach sich ziehen, wie sie in der Generikabranche heute bereits existiert.

In Anbetracht der katastrophalen Auswirkungen einer fehlgeleiteten Preisregulierung bei Generika lehnt Pfizer die vorgesehenen Anpassungen für Biosimilars und Biologicals grundsätzlich ab. Die Regelungen dienen weder dem Patientenwohl, noch respektieren sie den funktionalen Wettbewerb im Bereich der Biologika.

Roche

Der geplante §40c der Arzneimittel-Richtlinie konterkariert das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV), welches die Qualität und Sicherheit der Versorgung verbessern sollte. Ähnlich wie bereits bei §40b droht § 40c das Gegenteil zu bewirken und die Patientensicherheit sowie die Nachverfolgbarkeit der Therapie zu gefährden. Wir bitten den G-BA, unsere Bedenken bei der Ausgestaltung des §40c zu berücksichtigen, um eine sichere und qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung für Patienten in Deutschland zu gewährleisten.

Sanofi

Liefer- und Versorgungssicherheit von Biologika sind langfristig zu sichern. Die am starken Produktionsstandort Deutschland vorhandenen Kapazitäten und Expertisen - am Standort Frankfurt-Höchst decken bei Sanofi rund 3.500 Mitarbeitende die gesamte Insulin-Wertschöpfungskette von der Herstellung bis zum Vertrieb ab – dürfen nicht fahrlässig durch kurzfristig angelegte Sparmaßnahmen nachhaltig geschwächt werden. Schon heute sind Biologika wie Insuline von Lieferausfällen betroffen. Die Einführung der Substitution auf

Apothekenebene wird mittelfristig zu einer Reduktion der Anzahl der Anbieter und damit zu einem erhöhten Risiko der Patientenversorgung führen – so wie im Generikabereich.

Stadapharm

Die Versorgung mit Biologika stellt aufgrund der aufwendigen biotechnologischen Herstellung und der begrenzten Produktionskapazitäten hohe Anforderungen an Planungssicherheit und Stabilität der Lieferketten. Eine automatische Substitution könnte die bestehenden Strukturen empfindlich stören und unbeabsichtigte ökonomische sowie versorgungstechnische Folgen nach sich ziehen.

Im Zuge der Substitution durch das jeweils günstigste verfügbare Präparat könnten einzelne Biosimilar-Hersteller innerhalb kürzester Zeit mit unerwartet hoher Nachfrage konfrontiert werden. Da die Produktionsprozesse bei Biologika komplex und zeitaufwändig sind, kann eine kurzfristige Ausweitung der Kapazitäten nicht ohne weiteres erfolgen. Dies birgt das Risiko von Lieferengpässen und gefährdet die kontinuierliche Versorgung der Patienten.

Ein solcher Effekt wurde bereits bei anderen Arzneimittelgruppen beobachtet, bei denen marktverzerrende Preisregulierungen oder selektive Vertragsabschlüsse zu Konzentrationen auf wenige Anbieter führten. Die Folge: Instabile Lieferketten, Lieferrückstände und therapeutische Unsicherheiten. Bei hochspezifischen Arzneimitteln wie Biologika wäre ein solcher Ausfall besonders kritisch.

Die automatische Substitution erhöht den Preisdruck unter den Herstellern erheblich. Während Wettbewerb grundsätzlich dort zu begrüßen ist, wo er zu neuen und besseren Produkten führt, birgt ein durch die automatische Substitution erzwungener Preisverfall mittelfristig die Gefahr, dass kleinere, spezialisierte und deutsche oder europäische Anbieter aus dem Markt gedrängt werden. Insbesondere ist zu beachten, dass nicht-europäische (meist asiatische) Hersteller gegenüber deutschen oder europäischen Herstellern (wie STADA) etliche Vorteile haben wie beispielsweise niedrigere Arbeitskosten, staatliche Unterstützungen, Skaleneffekte, regulatorische Flexibilität, Dominanz in der Wirkstoffproduktion und integrierte Lieferketten. Diese Vorteile können wir in Europa nicht kompensieren.

Dadurch sinkt die Angebotsvielfalt, was wiederum zu einer erhöhten Abhängigkeit von wenigen großen nicht-europäischen Herstellern führt.

Ein verengter Markt ist besonders im Kontext von Biologika kritisch, da die Qualitätssicherung und Versorgungssicherheit auf mehreren, unabhängigen Produktionslinien beruhen sollte. Ein Konzentrationsprozess im Markt kann somit das Gegenteil dessen bewirken, was eigentlich intendiert ist: eine sichere, breit verfügbare und bezahlbare Versorgung.

Länder wie Belgien oder Österreich, die bei der Erstattung von Biosimilars auf automatische Substitution verzichten und beispielsweise auf Price-Linkage Ansätze zurückgreifen sichern damit ein breites Angebot von Anbietern und vermeiden die Abhängigkeit von einigen wenigen und damit die Risiken für Lieferprobleme.

Ein weiterer ökonomischer Aspekt ist die potenzielle Doppelbelastung für Hersteller, die bereits Rabattverträge mit Krankenkassen geschlossen haben. Werden diese Präparate zusätzlich automatisch substituiert, verlieren Rabattverträge an Attraktivität, da der wirtschaftliche Vorteil durch Substitution jederzeit umgangen werden kann. Dies schwächt bestehende Steuerungsinstrumente im Arzneimittelmarkt und könnte langfristig zu einem Rückgang der Vertragsbereitschaft führen.

Zudem bedeutet eine zusätzliche Substitutionspflicht einen erhöhten administrativen Aufwand für Apotheken, Krankenkassen und Hersteller. Insbesondere der Umgang mit wechselnden Präparaten, Schulungen und Reklamationen verursacht nicht zu unterschätzende indirekte Kosten.

Fazit: Die automatische Substitution von Biosimilars mag kurzfristig Einsparpotenziale versprechen, gefährdet jedoch mittel- bis langfristig die Versorgungssicherheit, die

Marktvelfalt und die Funktionsweise bewährter Steuerungsinstrumente. Ein stabiles, planbares Versorgungssystem erfordert kalkulierbare Rahmenbedingungen, die durch eine automatische Substitution infrage gestellt würden.

[...] Im Bereich der Generika hat eine intensive Regulierung, die sich nur auf den niedrigsten Preis konzentriert, zu einer Verlagerung von Produktionskapazitäten aus Deutschland und einem gefährlichen Herstellungsmonopol innerhalb nicht-europäischer Länder wie China und Indien geführt. Biosimilars sind in Deutschland stark gewachsen und bereits schnell verfügbar. Damit funktioniert der Wettbewerb und bedarf keiner weiteren politischen Eingriffe, wie etwa einer automatischen Substitution in Apotheken. Unabhängig davon sollten medizinisch sinnvolle Ersteinstellungen/Switches am Patienten immer möglich sein. Ärzte sollen auch weiterhin in der Lage sein, den Wirkstoff in ein Produkt mit patientenrelevanten Vorteilen (verbesserter Verabreichungsweg, reduzierte anwendungsbedingte Nebenwirkungen) zu überführen ohne ein inflationäres Setzen von Aut-idem Kreuzen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Rabattverträge im Generikamarkt vielfach zu einer Marktverengung geführt haben, die die Versorgung im Falle von Lieferengpässen anfällig werden lässt. Hier hat sich gezeigt, dass der Erhalt von Anbietervielfalt für die Versorgung wichtig ist. Exklusive Rabattverträge mit den gesetzlichen Krankenversicherungen in Folge der automatischen Substitution gefährden die Versorgungssicherheit und sorgen für eine Marktverengung in allen Produktionsstufen.

Denn wenn nur ein einziger Hersteller die Versorgung sichert, wird die Liefersicherheit fragil. Dies kann enorme Auswirkungen auf einen Markt haben, dieser bereits wenig Hersteller – im Vergleich zu Generika – umfasst und die Lieferketten komplexer und länger sind als bei Generika. Daher ist es angeraten die Open-House Modelle beizubehalten.

[...] Eine zu erwartende Marktverengung, verbunden mit steigendem Preisdruck, wird voraussichtlich auch zu einer Verlagerung der Produktion von Biosimilars außerhalb Europas führen. Derzeit werden sämtliche unserer Biosimilars in Europa produziert, was durch kurze Lieferwege eine hohe Effizienz gewährleistet. Zwei unserer Biosimilars werden in einer modernen Produktionsstätte auf Island hergestellt, wobei 100 % der für die Produktion benötigten Energie aus erneuerbaren Energien gewonnen werden.

Dieser Nachhaltigkeitsaspekt, ebenso wie die Liefersicherheit, könnte jedoch im Zuge der Einführung der automatischen Substitution gefährdet sein und möglicherweise wegfallen.

ABDA, AMK

Die ABDA sieht weiterhin das Risiko, dass durch die vorgesehene Möglichkeit des Austauschs von Biologika in einem versorgungssensiblen Bereich der Einsatz von Rabattverträgen zur Steuerung der Versorgung durch die gesetzlichen Krankenkassen befördert wird. Es drohen negative Konsequenzen für die Breite und die Verlässlichkeit des Angebots, wie sie zunehmend schon im ‚klassischen‘ Generikabereich anzutreffen sind.

[...] Vielmehr sind die (zunächst) geltenden Regelungen nach § 40b zum „Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken bei parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung“ in Bezug auf die Patientensicherheit und die möglichen Risiken für die Versorgung engmaschig und kritisch zu begleiten und zu evaluieren.

[...] Die AMK mahnt, die **Versorgungs- und Liefersicherheit** für Patientinnen und Patienten im Bereich der Biologika/Biosimilars nicht aufgrund einer Rabattvertragsgesteuerten Marktkonzentration sowie nachgelagerter Adaptionsprozesse (z. B. Verlagerung von Produktionskapazitäten in das außereuropäische Ausland) zu gefährden.

BPI

Rabattverträge haben sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen der Arzneimittelversorgung als effektives Steuerungsinstrument zur kurzfristigen Kostendämpfung

etabliert. Gleichzeitig haben sie jedoch nachhaltig zur Marktverengung beigetragen, da sie systematisch Anbieter ausschließen, Preiswettbewerb auf ein Minimum reduzieren und wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle – insbesondere für kleinere oder spezialisierte Hersteller – stark unter Druck setzen.

Gerade im Bereich der komplexen biotechnologischen Wirkstoffe, deren Herstellung hohe regulatorische, technische und logistische Anforderungen stellt, birgt eine Konzentration auf wenige, durch Rabattverträge begünstigte Anbieter ein hohes Versorgungsrisiko.

In Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen, gestörter globaler Lieferketten und politischer Bestrebungen nach geostrategischer Autonomie und europäischer Versorgungssouveränität steht dieser Mechanismus im klaren Widerspruch zu den Zielen einer resilienten und diversifizierten Gesundheitswirtschaft. Die Förderung biopharmazeutischer Produktionskapazitäten in Europa – wie sie politisch auf EU- und Bundesebene wiederholt betont wurde – kann durch ausschließende Rabattvertragspolitik konterkariert werden.

Der automatische Austausch auf Apothekenebene – gepaart mit einer daraus folgenden Rabattvertragsdynamik – verstärkt diesen Trend und könnte zu einer weiteren Verdrängung innovativer Anbieter, eingeschränkter Marktvielfalt und letztlich zu systemischer Abhängigkeit von wenigen Produzenten führen. Diese Entwicklung steht in direktem Konflikt zu den Lehren aus der COVID-19-Pandemie, in der die Bedeutung standortnaher, strategisch abgesicherter Produktionskapazitäten schmerzhaft deutlich wurde.

Pro Generika

Die geplante unkontrollierte automatische Substitution von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln in der Apotheke birgt erhebliche Risiken und ist als Instrument von Einsparungen für die gesetzliche Krankenversicherung denkbar ungeeignet, da sie die Qualität und Sicherheit der Versorgung gefährdet.

Zudem überträgt die geplante Substitution von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheker ein generikabezogenes Modell der Kostensenkung auf biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel, das mit den Besonderheiten dieser Produktgruppe nicht vereinbar ist. Anders als bei Generika handelt es sich bei Biosimilars um komplexe Arzneimittel, deren Herstellung, Qualitätssicherung und regulatorische Entwicklung hohe technologische Anforderungen stellen. Ein Preis- und Substitutionsdruck nach generischem Vorbild gefährdet nicht nur die Investitionsbereitschaft in die biotechnologische Entwicklung und Produktion, sondern schafft wirtschaftliche Fehlanreize, die mittelfristig zu Marktverengungen, Produktionsverlagerungen ins Ausland und einem Rückbau industrieller Kapazitäten in Deutschland und Europa führen können.

Der Gesetzgeber hat mit dem Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) bereits 2023 anerkannt, dass eine dauerhaft auf minimale Erstattungsbeträge ausgerichtete Vergütungspolitik im generischen Bereich zu Versorgungsrisiken führt – etwa durch die Abwanderung der Produktion versorgungsrelevanter Arzneimittel in Drittländer. Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Erkenntnis im Bereich der Biosimilars nun ignoriert werden soll. Vielmehr müsste die gesetzliche Regulierung biotechnologischer Arzneimittel die damit einhergehenden versorgungs- und auch industriepolitischen Implikationen aktuell in besonderem Maße berücksichtigen. Eine differenzierte Marktordnung, die den biotechnologischen Produktionsaufwand sowie die Rolle von Biosimilars für Versorgungssicherheit, verlässliche Preisentwicklung und Standortattraktivität einbezieht, ist u.E. zwingend erforderlich.

Auch wenn die gesetzliche Grundlage selbst nicht Gegenstand des laufenden G-BA-Verfahrens ist, halten wir es für notwendig, die vielfach geäußerten Bedenken bei der Ausgestaltung der Regelung sehr ernst zu nehmen.

vfa

Biopharmazeutika sind aufgrund ihrer Herstellung spezielle Arzneimittel und unterscheiden sich damit grundlegend von chemisch-synthetischen Arzneimitteln – weshalb Biosimilars keinesfalls mit Generika gleichgesetzt werden können. Instrumente, die den Biosimilar-Markt regeln sollen, dürfen deshalb nicht vom Generika-Bereich übernommen werden.

Ein Wandel hin zu exklusiven Rabattverträgen/Tendern, wie im Generika-Markt heute üblich, kann insbesondere im biopharmazeutischen Markt als weitaus kritischer angesehen werden. Die Produktion von Arzneimitteln, die mittels Biotechnologie hergestellt werden, ist um ein Vielfaches komplizierter. Diese Wirkstoffe werden mittels lebender Organismen meist in Zellkulturen produziert. Ihre Produktion lässt sich entsprechend nicht schnell hoch- und herunterfahren. Die knappen Vorlaufzeiten in Exklusivrabattverträgen können zu Lieferengpässen und auf Dauer zu einer ungewünschten Marktkonzentration mit erhöhter Abhängigkeit von einzelnen Produzenten führen. Instrumente zur Regulierung des Arzneimittelmarktes und auch des biopharmazeutischen Segments sind außerdem bereits reichlich vorhanden und führen bei den gesetzlichen Krankenkassen schon heute zu erheblichen Einsparungen. Die möglichen Risiken für die Versorgungssicherheit, die mit einer Ausweitung der Substitution auf Apothekenebene einhergehen, stehen aus Sicht des vfa in keinem annehmbaren Verhältnis zu weiteren möglichen Einsparungen in diesem Bereich. Die Zielsetzung eines starken Biotechnologiestandorts in Deutschland wird dadurch konterkariert.

Ein starker Produktionsstandort ist eine entscheidende Voraussetzung für Liefer- und Versorgungssicherheit sowie für Investitionen und Innovationen. Die dafür in Deutschland vorhandenen Kapazitäten und Expertisen dürfen nicht fahrlässig durch unbedachte Sparmaßnahmen nachhaltig geschwächt werden. Überzogene Kostendämpfung dürfte sich nachteilig auf den weiteren Ausbau und die Neuansiedlung biopharmazeutischer Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa auswirken und eine Abhängigkeit von der Produktion in Asien nach sich ziehen, wie sie in der Generikabranche heute bereits Realität ist.

VZA

Unsere Verbandsmitglieder haben mittlerweile Erfahrungen mit der Biosimilarsubstitution bei parenteralen Zubereitungen gesammelt. Feststellen können wir für diesen Bereich, dass durch die Substitution und das Nebeneinander verschiedener Preissenkungsmechanismen (Abschläge nach der Anlage 3 zur Hilfstaxe, Herstellerrabatte nach § 130a Abs. 1 SGB V, Rabattverträge nach § 130a Abs. 8c SGB V) höchster Preisdruck herrscht, der mittlerweile zur Anhebung der Apothekeneinkaufspreise führt. Zudem sehen wir eine Marktverengung und Wettbewerbseinschränkung, d.h. es kommen nur noch wenige Biosimilars neu auf den Markt. Zu einigen patentfrei werdenden Originalen werden gar keine Biosimilars mehr gelauncht.

Im Bereich der biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel wird es infolge der Substitution innerhalb kurzer Zeit – das ist vorauszusehen – in Verknüpfung mit voraussichtlich exklusiven Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V ebenfalls maximalen Preisdruck geben. Wir haben große Sorge, dass es im Biosimilarmarkt ähnlich dem Generikamarkt zu Marktaustritten von Herstellern und zur Verhinderung von Markteintritten neuer Biosimilarhersteller bzw. neuer Biosimilars kommen wird. Das wird sich nachteilig auf die Versorgungssicherheit auswirken, vermehrt kostenintensive Importe in Mangelsituationen und damit verbunden sehr viel Beschaffungsaufwand und frustrane Bemühungen um die Patientenversorgung in den Apotheken nach sich ziehen. Angesichts der Bemühungen des Gesetzgebers mit dem Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes aus 2023 die Probleme im Generikamarkt in den Griff zu bekommen, ist nicht verständlich, warum der G-BA nunmehr eine weitreichende, von der gesetzlichen Ermächtigungsnorm nicht getragene Biosimilarsubstitution für die Fertigarzneimittel aufruft.

Bewertung:

Nach dem am 15. August 2019 in Kraft getretenen Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) hat der G-BA gemäß § 129 Absatz 1a Satz 3 SGB V Hinweise

für die ärztliche Verordnung zur Austauschbarkeit von biotechnologisch hergestellten biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit sowie gemäß § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken zu geben. Mit dem am 12. November 2022 in Kraft getretenen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) wurde der Regelungsauftrag gemäß § 129 Absatz 1a Satz 6 SGB V dahingehend konkretisiert, dass der G-BA zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben soll. Damit soll i. V. m. § 129 Absatz 1 Satz 12 SGB V für biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften ein eigener Regelungsrahmen zur Austauschbarkeit durch den G-BA festgelegt werden, der für die übrigen Arzneimittel nicht besteht. Ziel des GSAV ist aber gleichwohl eine wirtschaftliche Versorgung mit Biologika. Der Regelungsauftrag besteht unabhängig von dem Anteil von Biosimilars an den Verordnungen und den bereits erzielten Einsparungen im Bereich der Biologika sowie unabhängig von gesetzgeberischen Bestrebungen einer (Rück-)Verlagerung von Produktionsstandorten nach Europa.

Zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags wurde bereits in Abschnitt M der AM-RL § 40a eingefügt und eine Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) ergänzt. Hieraus ergeben sich zunächst für die Ärzte Hinweise für eine wirtschaftliche Verordnung (Einstellung und Umstellung) von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln. Mit § 40b wurden die Vorgaben zur Ersetzung von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Sätze 2 bis 7 i.V.m. Satz 12 und Absatz 1a Satz 6 SGB V für die Gruppe der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel in Bezug auf parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung konkretisiert.

Mit Ergänzung des § 40c werden nun die Vorgaben zur Ersetzung von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Sätze 2 bis 7 und Absatz 1a Satz 5 SGB V für die Gruppe der biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel konkretisiert.

Bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken zu geben, orientiert sich der G-BA an den in § 129 SGB V von Gesetzes wegen vorgesehenen Instrumenten zur Versorgungssteuerung und überträgt die dort angelegte Systematik in § 40c Absatz 2 AM-RL auf den Bereich der Biologika.

Es werden Bedenken geäußert, dass durch die Einführung der Substitution biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel durch Apotheken exklusive Rabattverträge ermöglicht würden. In Folge komme es zu einer Marktkonzentration, die den Wettbewerb einschränken und das Auftreten von Lieferengpässen erleichtern könne, und die Herstellung sich ins (außereuropäische) Ausland verlagere. Dem ist zu entgegnen, dass in den entsprechenden Verträgen nach § 130a Absatz 8 SGB V die Vielfalt der Anbieter und die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Versicherten zu berücksichtigen sind; der Gefahr einer Marktkonzentration soll insoweit über die Vorgaben des § 130a Absatz 8 SGB V bereits begegnet werden. Darüber hinaus sollen zur Sicherstellung einer diversifizierten Versorgung gemäß den Vorgaben des § 130a Absatz 8a SGB V pharmazeutische Unternehmer, die für die Herstellung der Arzneimittel in der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes produzierte Wirkstoffe verwenden, in den Verträgen gesondert Berücksichtigung finden. Von diesen Grundsätzen soll auch bei sog. Open-House-Verträgen nicht abgewichen werden; diese sehen zudem keine Eingrenzung der Anbieter vor und definieren lediglich Teilnahmebedingungen. Bei Open-House-Verträgen hängt sowohl die Teilnahme wie auch die Dauer der Vertragspartnerschaft maßgeblich von den sich beteiligenden pharmazeutischen Unternehmern ab. Die Vertragsinhalte vereinbaren die Vertragsparteien (Krankenkassen oder ihre Verbände – pharmazeutische Unternehmer) und

unterliegen damit nicht der Regelungszuständigkeit des G-BA.

Siehe ergänzend auch Bewertung der Einwände zu Absatz 2 sowie zu den weiteren Einwänden 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4 und 3.6.5.

Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits im Stellungnahmeverfahren zum Beschluss vom 15. Juni 2023 zur Ergänzung der AM-RL um § 40b befasst; es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in der Zusammenfassenden Dokumentation zu dem entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/>).

3.6.7 Haftungs- und Patentrechtsansprüche

AbbVie

Im deutschen Gesundheitssystem trägt allein der Arzt die Therapieverantwortung und Verordnungsentscheidung. Ihm obliegt es, den Patienten eine angemessene und wirtschaftliche Behandlung zu verordnen. Dabei haftet der Arzt für den Eingriff in die körperliche Integrität des Patienten.

Bei komplexen Therapien dürfen verordnete Arzneimittel nicht ohne das Wissen des Arztes durch die Apotheke ausgetauscht werden. Ein Wechsel des Arzneimittels gefährdet den Therapieerfolg und unterläuft die ärztliche Therapiefreiheit.

[...] Von noch größerer Relevanz für Ärzte ist die Tatsache, dass [...] Apotheken den rechtlichen Pflichtenkreis der verordnenden Ärzte einseitig erweitern, wenn sie das verordnete Original gegen ein Biosimilar austauschen würden, das unter zusätzlicher Überwachung steht. Weitere haftungsrechtliche Konsequenzen können nicht ausgeschlossen werden.

Eingehend wurde bereits die einseitige Erweiterung der Überwachungspflicht von Ärzten beleuchtet. Dies klärt jedoch nicht, wer bei möglichen Gesundheitsschäden der Patienten im Falle der automatischen Substitution zu haften hat.

Nach aktueller Gesetzeslage wäre nicht klar, wer bei Gesundheitsschäden haftet, die auf den Austausch von Biologika in der Apotheke zurückzuführen sind. Demnach würden unbekannte Risiken beim Einsatz von Biosimilars daher zulasten des geschädigten Patienten gehen, der keine Ansprüche geltend machen könnte.

Der G-BA würde nur dann haften, wenn der Geschädigte nachweisen könnte, dass der Gemeinsame Bundesausschuss mit der Feststellung der automatischen Substitution den medizinischen Standard unterschreitet. Dies wäre der Fall, wenn nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin von Unterschieden zwischen Original-Biologika und Biosimilars auszugehen ist, die im Fall eines Austauschs nicht nur bei Vorliegen patienten-individueller Besonderheiten, sondern regelmäßig oder für Indikationsgebiete oder relevante Patientengruppen mindestens zu Gesundheitsgefährdungen führen können. Nicht bekannte Risiken gehen ausschließlich zulasten der Patienten. Ein Anspruch gegen den G-BA fällt zudem gegen den des Arztes zurück, wenn dieser im Einzelfall wegen von ihm zu erkennender Risiken die Substitution hätte ausschließen müssen.

Eine Haftung der Apotheker scheidet regelhaft aus, da sie bindende rechtliche Vorgaben umsetzen. Hiervon wäre nur dann abzuweichen, wenn für sie ein besonderes Gesundheitsrisiko bei einem Patienten durch die Substitution erkennbar wäre.

Das theoretisch größte Haftungsrisiko liegt beim Arzt, wenn er sich bei einer Verordnung nicht dazu entscheidet, das aut-idem-Kreuz zu setzen und damit den Austausch in der Apotheke zu verhindern. Der Arzt dürfte wegen der G-BA-Entscheidung pro automatische Substitution allerdings davon ausgehen, dass ein Austausch im Regelfall dem medizinischen Standard entspricht. Er haftet jedoch für die Beurteilung der erkennbaren Besonderheiten im Einzelfall.

Alexion

Ist die Voraussetzung [übereinstimmender Anwendungsgebiete] nicht gegeben, besteht das Risiko, dass es im Rahmen eines Austausches in der Apotheke zu einem Off-Label-Einsatz kommt. Darüber hinaus könnte dies in Einzelfällen zu Verletzungen von Marktexklusivitätsrechten führen.

Zur Verdeutlichung des Unterschieds bei den Zulassungsumfängen biotechnologisch hergestellter Arzneimittel und deren Biosimilars ist anzumerken, dass für einzelne Indikationen bestimmter Originalpräparate Marktexklusivitätsrechte gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 bestehen. Diese Exklusivrechte können einer Zulassung oder dem Austausch von Biosimilars in diesen seltenen Indikationen entgegenstehen. Biosimilars, die für andere Indikationen zugelassen sind, verfügen nicht automatisch über die Zulassung oder entsprechende Marktexklusivitätsrechte für diese speziellen Anwendungsgebiete.

Biocon

Der G-BA hat [...] nicht undifferenziert alle Wirkstoffe und deren Indikationen in die Regelungen zur Substitution einzubeziehen, sondern nur insofern, als keine andere Möglichkeit vorhanden ist, den Regelungszweck der Substitution zu erfüllen. Eine entsprechende Abwägung ist nicht erkennbar und Regelungsalternativen sind nicht geprüft worden. Dies gilt umso mehr, als dass die Regelung gemäß § 129 Abs. 1a SGB V massiv in die Rechte und geschützten Rechtspositionen der pharmazeutischen Hersteller eingreift [244].

Dies führt in letzter Konsequenz zur Rechtswidrigkeit der entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen und eröffnet den betroffenen pharmazeutischen Unternehmen Haftungsansprüche im Hinblick auf die Verletzung ihrer Rechte.

[...] Eine weitere Herausforderung bei der Umstellung von biologischen Arzneimitteln sind nicht zuletzt haftungsrechtliche Aspekte. In diesem Zusammenhang verpflichtet § 630c Abs. 2 Satz 1 BGB die Verordner zu einer angemessenen Kommunikation mit den Patienten: „Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen.“ Die Umstellung eines biologischen Arzneimittels ist eine wesentliche Änderung einer laufenden Therapie im Sinne des § 630c BGB und erfordert daher eine ärztliche Erläuterung. Eine eingehende Beratung ist bei der Umstellung von biologischen Arzneimitteln in ganz besonderem Maße erforderlich, weil biologische Arzneimittel weitreichende Wirkungen auf das Immunsystem entfalten. Auch sozialrechtliche Anforderungen, hier die Umstellung auf ein preisgünstigeres Biologikum, entbindet die Verordner nicht von ihrer Sorgfaltspflicht und somit auch nicht von ihrer Haftung [245, 246].

Lilly

Bislang bleibt aus Sicht von Lilly zudem weiterhin offen, wie die Verantwortlichkeiten im Falle von Haftungsfragen nach einer automatischen Substitution gestaltet sind.

Medac

Wie eingangs erwähnt ist medac auch pharmazeutischer Unternehmer von Arzneimitteln, die als Komedikation von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln zugelassen und/oder vorgeschrieben sind. Beispielhaft seien hier nur die sogenannten TNFα-Hemmer wie Infliximab, Etanercept oder Adalimumab in Kombination mit Methotrexat gegen Rheumatoide Arthritis angeführt. Allesamt sind sehr wirksame Medikamente, die Kombination erst recht. So

244 Gaßner M: Verwendungsrechte im Darknet der GKV gefangen: zu den Konsequenzen der systematischen Verletzung geistigen Eigentums durch die Gesetzliche Krankenversicherung. PharmR 2021.

245 Neu J: Haftungsfragen. Saarländisches Ärzteblatt 2013; 8:11-14

246 Schirmer HD., Hübner M.: Ärztliche Dokumentationspflichten: Das Ende der Fahnenstange. Dtsch Arztebl 2009; 106(48): A-2408 / B-2073 / C-2013.

kommt es als Folge auch zu Nebenwirkungsmeldungen und leider gelegentlich auch zu haftungsrechtlichen Fragestellungen.

medac fordert deshalb den Gemeinsamen Bundesausschuss auf, die Regeln über einen Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln durch Apotheken so festzulegen, dass sowohl die Anbieter von Biologika/Biosimilars als auch unser pharmazeutisches Unternehmen als pharmazeutischer Unternehmer vielfältiger Komedikation einerseits die gesetzlichen und behördlichen Pflichten erfüllen und andererseits im strittigen Fall auch die unternehmerischen Rechte wahren kann.

Stadapharm

Die Einführung einer automatischen Substitution von Biosimilars wirft eine Reihe regulatorischer Fragen auf, die bisher weder rechtlich noch praktisch hinreichend beantwortet sind. Diese Unsicherheiten betreffen sowohl die Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen als auch Haftungsfragen und den Umgang mit Abweichungen im Versorgungsgeschehen.

Im bisherigen Versorgungssystem liegt die Verantwortung für die Auswahl und Verordnung eines Arzneimittels beim behandelnden Arzt. Mit der automatischen Substitution verschiebt sich ein Teil dieser Entscheidungskompetenz auf die Apotheke, ohne dass eine neue, klare Zuweisung der Verantwortung erfolgt. Dies führt zu einer Fragmentierung der Verantwortung: Der Arzt verliert die Kontrolle über das konkret abgegebene Präparat, bleibt aber potenziell haftbar für die Gesamttherapie.

Zugleich werden Apotheker mit einer Verantwortung konfrontiert, für die sie weder ausreichend medizinisch ausgebildet sind noch über die vollständigen Informationen zur Patientengeschichte verfügen oder ausreichend Zeit und Ressourcen besitzen. Auch haftungsrechtlich ist nicht abschließend geklärt, wer im Falle eines Medikationsfehlers oder Therapieversagens bei einem durch die Apotheke vorgenommenen Wechsel zur Verantwortung gezogen wird.

BPI

Eine Substitution ohne die Übereinstimmung der Anwendungsgebiete birgt auch hier die Gefahr, dass der Patentschutz für Arzneimittel mit mehreren (noch geschützten) Indikationen allgemein als auch die durch die im Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden garantierte Marktexklusivität unterminiert wird ("wilde Substitution"). Für derartige Fallgestaltungen muss also der G-BA auch mit Blick auf die hierzu ergangene Rechtsprechung (vergl. [247]) Sorge dafür tragen, dass eine Substitution in den geschützten Indikationen ausgeschlossen wird.

DDG, gemeinsam mit Hautnetz Deutschland e. V. und BVDD

Es ist zu bedenken, dass die Anwendungsbereiche und die damit verbundenen Sicherheitsdaten zwischen den Präparaten nicht identisch sind und auch daher die Patientensicherheit in Frage gestellt ist. Sollte es zu Komplikationen kommen, deren Ursache in einem nicht mit dem verordnenden Arzt abgestimmten Austausch des Biosimilars liegen könnte, so ist auch die Haftungsfrage nicht geklärt. Unstrittig ist, dass der Apotheker nicht die notwendigen individuellen klinischen Patienten-Informationen hat, um das Risiko einer Substitution hinreichend einzuschätzen und die medizinischen Konsequenzen zu tragen.

Bewertung:

In mehreren Stellungnahmen wird auf mögliche Haftungsprobleme hingewiesen, sollte es bei Patienten und Patientinnen zu Gesundheitsschäden kommen, die kausal auf den Austausch

eines biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittels zurückzuführen sind. Thematisiert werden u. a. eine Haftung der pharmazeutischen Unternehmer, des verordnenden Arztes/der verordnenden Ärztin und der Apotheken. Für mögliche Haftungsansprüche von Patienten gegen die pharmazeutischen Unternehmer, die verordnenden Ärzte/Ärztinnen und/oder die Apotheken ist aufgrund der Parallelität der Sachverhalte auf die Rechtsprechung und Grundsätze einer Haftung beim „Off-Label-Use“ (OLU) zurückzugreifen. Haftungsansprüche sind denkbar, wenn ein Patient oder eine Patientin ein Biosimilar erhält, das für die der Verordnung zugrunde liegenden Indikation gar nicht zugelassen ist und der Patient oder die Patientin deswegen einen Gesundheitsschaden erleidet.

Der Einwand aus den Stellungnahmen, eine Haftung der pharmazeutischen Unternehmer nach § 84 AMG (Gefährdungshaftung) scheide bei einer indikationsüberschreitenden Anwendung, zu der es beim Austausch auf Apothekenebene dann kommen kann, wenn lediglich ein übereinstimmendes Anwendungsgebiet Voraussetzung für einen Austausch ist, grundsätzlich aus, ist in dieser Pauschalität nicht zutreffend. Zutreffend ist, dass für eine Haftung nach § 84 AMG ein sog. „bestimmungsgemäßer Gebrauch“ des Arzneimittels Tatbestandsvoraussetzung für die verschuldensunabhängige Haftung ist. Ein OLU ist dann bestimmungsgemäßer Gebrauch, wenn der pharmazeutische Unternehmer die indikationsüberschreitende Anwendung „duldet“, z. B. weil aufgrund der Verordnungszahlen erkennbar ist, dass Verordnungen außerhalb des In-Label erfolgen.

Auch in Bezug auf eine Haftung des Arztes wegen eines gebotenen Nichtsetzens des „aut idem“-Kreuzes, ist auf die bestehenden Grundsätze zurückzugreifen. Kann der Arzt oder die Ärztin Risiken für den Patienten oder die Patientin im Zusammenhang mit einer Arzneimittelsubstitution nicht ausschließen, ist er/sie berufsrechtlich verpflichtet, Gefahren durch Aufklärung oder Ausschluss der Substitution abzuwehren (Wille, in: PharmR 2009, 365 (369) m. w. N.). Bei einem indikationsübergreifenden Einsatz eines Arzneimittels ist entscheidend für die Frage der Haftung des verordnenden Arztes oder der verordnenden Ärztin, ob der OLU-Einsatz dem „medizinischen Standard“ entspricht. Das ist der Fall, wenn Forschungsergebnisse vorliegen, die erwarten lassen, dass das insoweit Off-Label eingesetzte Arzneimittel für einschlägige Anwendungsgebiete zugelassen werden könnte und der zulassungsüberschreitende Gebrauch des Arzneimittels insoweit anerkannt ist (König/Müller, in: MedR 2008, 190 (199)). Die Aufklärungs- und Beratungspflichten im Zusammenhang mit der Verordnung eines Arzneimittels bestehen davon unabhängig und obliegen der Ärztin oder dem Arzt entsprechend der bereits etablierten aut-idem-Regelungen. Die Substitution biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel in den Apotheken hat aus Haftungsgesichtspunkten keinen maßgeblichen Einfluss auf ebendiese Pflichten aus dem Behandlungsvertrag.

Die Haftung wird auch nicht auf den ausgebenden Apotheker oder die ausgebende Apothekerin verlagert, so dass auch diesem Einwand nicht gefolgt wird. Die Verantwortung des Arztes für die Auswahl des Wirkstoffes, der Wirkstärke und Packungsgröße sowie bei Nichtaustauschbarkeit der Darreichungsform bleibt bestehen (KassKomm/Hess, 118. EL März 2022, SGB V § 129 Rn. 7a, 8). Zutreffend wird in den Stellungnahmen außerdem erkannt, dass eine Haftung auf Apothekenebene ausscheidet, da hier rechtlich bindende Vorgaben umgesetzt werden. Davon unberührt bleiben die allgemeinen Grundsätze, nach denen Haftung auch der Apotheke bei grober Verletzung der Pflichten aus § 20 ApBetrO und § 17 Absatz 4 ApBetrO bestätigt sein kann (z. B. OLG 5 U 92/12, Urteil vom 07.08.2013; grundsätzlich hierzu: Bel/Fritsch, in: MedR 2020, 556ff.), die aber durch das Substitutionsgebot von Biologika keine Verschärfung erfahren.

Mehrere Stellungnehmer befürchten aufgrund des Austauschgebots biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel eine Gefahr patentrechtlicher Auseinandersetzungen. Grundsätzlich ist den Stellungnehmern darin zuzustimmen, dass eine Patentrechtsverletzung bei einem indikationsüberschreitenden Einsatz eines Arzneimittels, das in den

Anwendungsgebieten mit dem Referenzarzneimittel nicht deckungsgleich ist, jedenfalls dann nicht ausgeschlossen ist, wenn die Patentrechtsverletzung auf einer Handlung des pharmazeutischen Unternehmers beruht (vgl. hierzu z. B. LG HH, 327 O 67/15, Urteil v. 02.04.2015, Revision OLG Hamburg – 3 U 65/15, das eine Patentrechtsverletzung von Generika-Herstellern, die im Rahmen eines Beitritts zu einem Rabattvertrag eine patentgeschützte indikationsüberschreitende Anwendung des generischen Arzneimittels nicht verhindert haben, bestätigt). Die Vermeidung von Patentrechtsverletzungen liegt im Verantwortungsbereich der pharmazeutischen Unternehmer. Diese haben keinen Anspruch darauf, dass die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen unverändert bleiben und deswegen z. B. neue Regelungen zur Sicherung des Wirtschaftlichkeitsgebotes des § 12 SGB V mit mittelbaren Auswirkungen auf den Patentschutz durch den Gesetzgeber geschaffen werden. Der Austausch von Biologika auf Ebene der Apotheken folgt gesetzlichen Regelungen.

Vor dem Hintergrund der haftungsrechtlichen Zusammenhänge besteht insoweit kein Anpassungsbedarf zu den vorgesehenen Regelungen zur Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel.

3.6.8 Pharmakovigilanz, Sicherstellung der Nachverfolgung

AbbVie

Eine Konsequenz der automatischen Substitution von Biologika besteht darin, dass die langfristige Arzneimittelsicherheit und Pharmakovigilanz von biologischen Arzneimitteln und damit die Patientensicherheit nicht in der jetzigen Form aufrechterhalten werden können.

Die Sicherheitsprofile neuartiger Arzneimittel und Biologika werden nach Markteintritt über mehrere Jahre mit Hilfe von Registern erfasst, indem der behandelnde Arzt die Wirksamkeit und Sicherheit des verordneten Biologikums beobachtet und dokumentiert. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Nebenwirkungen vom Arzt eindeutig einem Arzneimittel zugeordnet werden können. Im Falle der automatischen Substitution könnte es zur Situation kommen, dass nicht eindeutig zu verifizieren ist, welches Arzneimittel mögliche Nebenwirkungen überhaupt verursacht hat.

Der Gemeinsame Bundesausschuss kommt selbst zur Feststellung, dass Register eine große Relevanz in der Arzneimittelsicherheit spielen. In der zusammenfassenden Dokumentation zum Beschluss des § 40a AM-RL schreibt der Gemeinsame Bundesausschuss: „Aus Sicht des G-BA sind Beobachtungsstudien bzw. Register zur Gewinnung von Daten zur Arzneimittelsicherheit neben dem Spontanmeldesystem von Bedeutung“. Des Weiteren erklärt er, dass bei einer Umstellung von Biologika in der Apotheke die Chargenbezeichnung entsprechend dokumentiert werden würde. Allerdings wird im aktuellen Beschlussentwurf nicht näher darauf eingegangen, von wem und in welchem System die Chargenbezeichnung dokumentiert werden soll. Unabhängig davon existiert weiterhin die Problematik der nicht geklärten Verantwortung bei Nebenwirkungsmeldungen.

Alternative technische Lösungsansätze, wie etwa die elektronische Patientenakte (ePA), können Register nicht ersetzen. Dies liegt unter anderem daran, dass sie aktuell nicht von allen Patienten genutzt wird. Dadurch kann keine lückenlose Dokumentation von Chargennummer und/oder Nebenwirkungen über technische Wege sichergestellt werden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss erkennt die Relevanz von langfristiger Patienten- und Arzneimittelsicherheit, die mit Hilfe von Registern sichergestellt wird. Mit der Einführung der automatischen Substitution von Biologika in der Apotheke wird die bewährte Funktion von Registern bei der langfristigen Beurteilung der Sicherheit von Arzneimitteln in ihrer Grundstruktur aufgeweicht. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker lehnt in ihrem Positionspapier die automatische Substitution aufgrund der Patienten- und Arzneimittelsicherheit entschieden ab und begründet dies ausführlich. Zu einer analogen Einschätzung gelangt auch der IFPMA in seiner kürzlich publizierten Stellungnahme.

Seit 2013 werden Arzneimittel, die unter zusätzlicher Überwachung stehen, in allen EU-Mitgliedstaaten mit dem sogenannten schwarzen Dreieck gekennzeichnet. Hierdurch wird der zusätzliche Bedarf an Überwachung deklariert, der dadurch entsteht, dass für die betreffenden Arzneimittel noch nicht ausreichend Informationen über deren Sicherheit zur Verfügung stehen. Die regulatorische Verpflichtung zur besonderen Überwachung dient der Patientensicherheit.

Eine vollständige Auflistung aller Arzneimittel (inkl. Biologika und Biosimilars) stellt die European Medicines Agency auf Ihrer Webseite zur Verfügung. Darin wird ersichtlich, dass es bei Biologika zu regulatorischen Unterschieden kommt: Bei zahlreichen Wirkstoffen fallen die Original-Biologika und deren wirkstoffähnlichen Biosimilars vereinzelt nicht unter die Regelung des schwarzen Dreiecks. Produkte, die unter diese Regelung fallen, stehen unter einer vorgeschriebenen erhöhten Überwachung. Dieser regulatorische Unterschied zwischen wirkstoffähnlichen Produkten muss bei Überlegungen zur automatischen Substitution von Biologika beachtet werden. Die Rechtslage zur beschriebenen Situation ist dabei aktuell völlig ungeklärt.

Grundsätzlich ist nicht geklärt, wer für die Meldung von unerwünschten Nebenwirkungen verantwortlich wäre, sollte die automatische Substitution von Biologika in der Apotheke erlaubt werden. Die Therapieentscheidung liegt beim behandelnden Arzt. Folgerichtig lässt sich ableiten, dass ihm die Verantwortung obliegt, Nebenwirkungen hauptverantwortlich zu melden.

Im Fall von wirkstoffähnlichen Produkten, bei denen nur manche mit dem schwarzen Dreieck versehen sind und andere nicht, ergeben sich weitere rechtliche Fragestellungen. Verordnet ein Arzt ein Biologikum, welches nicht unter besonderer Beobachtung steht, kann es dazu kommen, dass in der Apotheke ein Biologikum abgegeben wird, welches hingegen unter besonderer Beobachtung steht. Diese Konstellation würde dazu führen, dass der Arzt mögliche Nebenwirkungen dem falschen Produkt zuordnet, da er nicht wissen kann, welches Produkt der Patient erhalten hat.

Amgen

Mehrfache Substitutionen von Arzneimitteln durch Apotheken im Therapieverlauf führen außerdem dazu, dass die Therapiehistorie nicht mehr nachvollzogen werden kann. Tritt während der Therapie ein unerwünschtes Ereignis auf, kann der behandelnde Arzt / die behandelnde Ärztin nicht nachvollziehen, in welchem Zusammenhang und mit welchem Arzneimittel das Ereignis aufgetreten ist. Pharmakovigilanzmaßnahmen wären entsprechend nicht mehr für einzelne Arzneimittel, sondern nur für Wirkstoffgruppen möglich. Als Konsequenz wären Datensammlungen für Pharmakovigilanz (z. B. Register wie „deutsches Psoriasis-Register PsOBest“ (<https://www.psobest.de/>) oder „deutsches Register zur Langzeitbeobachtung der Therapie mit Biologika, Biosimilars und Januskinase (JAK)-Inhibitoren RABBIT“ (<https://biologika-register.de/>)) nicht mehr vollumfänglich zielführend.

Zudem würde sich das [...] Problem der mangelnden vergleichenden Evidenz zwischen verschiedenen Biosimilars noch verschärfen, da durch die fehlende Nachvollziehbarkeit der Therapiehistorie keine verwertbaren Anwendungsdaten für Biosimilars generiert würden.

Biocon

[...] Ferner müssen Reaktionen auf Arzneimittel genau dokumentiert werden, was bei einer Substitution durch die Apotheke aus nachfolgenden Erwägungen schwierig umzusetzen ist:

- Wenn Meldungen allein unter der Wirkstoffbezeichnung erfolgen, sind sie **nicht eindeutig** einem Fertigarzneimittel **zuzuordnen**.
- Für biologische Arzneimittel – Original wie Biosimilar – bedeutet dies, dass neben der Angabe des Wirkstoffs auch der **Handelsname** sowie die **Chargenbezeichnung** zu dokumentieren sind.
- Wer dokumentiert den Wechsel bei einer Substitution? Wie soll die **Dokumentation**

rechtskräftig dokumentiert werden.

[...] Die European Medicines Agency (EMA) veröffentlicht mit ihrer „Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)“ eine Reihe von Maßnahmen, die ausgearbeitet wurden, um die Durchführung der Pharmakovigilanz in der Europäischen Union (EU) zu erleichtern. Die GVP gelten für Zulassungsinhaber, die EMA und Arzneimittelzulassungsbehörden in den EU-Mitgliedstaaten. Sie umfassen zentral über die Agentur zugelassene Arzneimittel sowie auf nationaler Ebene zugelassene Arzneimittel.

Am 15. August 2016 hat die EMA ihre „Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Product- or Population-Specific Considerations II: Biological medicinal products“ veröffentlicht. Diese Richtlinie trifft Aussagen zur Rückverfolgbarkeit von Produkten („product traceability“) sowie zur Meldung von Nebenwirkungen („reporting of adverse reactions“).

Hierbei betont die Leitlinie, dass es für die Pharmakovigilanz von Biologika im Vergleich und Gegensatz zu chemisch synthetisierten Arzneimitteln aufgrund einer größeren inhärenten Variabilität der Produkteigenschaften als Folge der Herstellungsvariabilität eine Schlüsselanforderung sei, eine kontinuierliche Produkt- und Chargenrückverfolgbarkeit bei der klinischen Verwendung sicherzustellen. Nur so können neu auftretende und produktspezifische Sicherheitsbedenken schnell erkannt und während eines Produktlebenszyklus bewertet werden. (Abschnitt P.II.A.1.4., „product traceability“, S. 8)

Die Mitgliedstaaten stellen hierbei durch die Sammlung von Informationen und erforderlichenfalls durch die Weiterverfolgung von Meldungen über vermutete Nebenwirkungen sicher, dass alle geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die in ihrem Gebiet verschriebenen, abgegebenen oder verkauften biologischen Präparate mit dem Namen des Arzneimittels und der Chargennummer zu erfassen, die Gegenstand der Verdachtsmeldung einer Nebenwirkung sind. (Abschnitt P.II.C.1.2.2. „Reporting of adverse reactions“, S. 18).

Insofern erfasst dieses System alle Teile der Versorgungskette, angefangen vom Zulassungsinhaber, dem pharmazeutischen Unternehmen, dem verordnenden Arzt, der abgebenden Apotheke und dem Patienten.

Zugleich macht die Richtlinie klar, dass die Ausgestaltung dieser Chargenrückverfolgbarkeit der Regelungskompetenz des einzelnen Mitgliedsstaates unterliegt. (Abschnitt P.II.A.1.4. „product traceability“, S. 8)

Die Ausgestaltung eines solchen Pharmakovigilanz-Systems ist in Deutschland in § 62ff des Arzneimittelgesetzes (AMG) geregelt.

Hiernach müssen sämtliche biopharmazeutischen Arzneimittel bei Verdacht auf Nebenwirkungen anhand des Namens des Arzneimittels sowie der Nummer der Herstellungscharge eindeutig identifizierbar sein (§ 62 Abs. 2 Satz 4 AMG). Dies steht auch in Zusammenhang mit der „zusätzlichen Überwachung“, denen Biopharmazeutika zulassungsrechtlich unterliegen. Hierfür werden Biopharmazeutika mit einem auf der Spitze stehenden schwarzen Dreieck versehen, das Ärzte und Patienten in besonderem Maße dazu auffordert, jeglichen Verdacht auf mögliche Nebenwirkungen zu melden.

Mit Einführung der Substitution sind die Produktbezeichnungen der verordneten bzw. ausgehändigten Arzneimittel in Apotheken- und Arztsoftware allerdings nicht mehr identisch, so dass die Gefahr der Falschzuordnung von Nebenwirkungen besteht. Um eine funktionierende patientenbezogene Dokumentation von Arzneimittelname und Herstellungscharge zu gewährleisten, müsste diese künftig in der Apotheke bei der Abgabe erfolgen und dem behandelnden Arzt zeitnah kommuniziert werden.

Wenn dem Arzt nicht klar ist, welches Präparat der Patient wirklich erhält, weil ein Austausch in der Apotheke vorgenommen wurde, ist es dem Arzt nicht möglich, die Verpflichtungen zur gezielten Erfassung bestimmter Nebenwirkungen adäquat zu erfüllen. Dadurch wird es dem Arzt zudem nicht möglich sein, die Nebenwirkung als solche sowie ihren Umfang und ihre

Schwere zu erkennen, was für die den medizinischen Erkenntnissen entsprechende Fortsetzung der Therapie erforderlich ist.

Die Zuordnung von z. B. Nebenwirkungen, die ggf. auch erst später im Verlauf der Therapie auftreten können, ist nach einer Substitution in der Apotheke nicht mehr hinreichend sichergestellt. Denn Ärztinnen und Ärzte haben unter den aktuell gültigen Bedingungen der Informationsweitergabe keine regelhafte Information über eine Substitution in einer Apotheke und damit über das tatsächlich abgegebene Arzneimittel. Eine hierzu erforderliche Übermittlung im Rahmen der Telematikinfrastruktur steht nicht zur Verfügung.

Dies führt darüber hinaus auch zu Folgeproblemen bei der lückenlosen Dokumentation der ärztlichen Therapie in der Patientenakte und könnte im Schadensfall haftungsrechtliche Probleme zur Folge haben.

Die inhärente Chargenvariabilität bei Biopharmazeutika erfordert es daher, dass zur Umsetzung der Pharmakovigilanz-Anforderungen vor der Einführung der Substitution auf Apothekenebene für Biologika ein entsprechendes System zur Informationsübermittlung von Apotheker zum Arzt implementiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, stellt dies ein Umsetzungshindernis für die in § 40c (neu) der AM-RL vorgesehenen Regelungen dar.

Biogen

Biologika/Biosimilars erfordern eine sorgfältige Nachverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette, um die Patientensicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu gewährleisten. Derzeit erfolgen alle Wechsel zwischen Referenzbiologika und Biosimilars auf Verordnungsebene. Das heißt, der Arzt weiß genau, welches Biologikum der Patient in der Apotheke erhält. Dies ermöglicht es dem medizinischen Fachpersonal, die Häufigkeit von Wechseln zu dokumentieren und nachzuverfolgen. Sollte die Substitution jedoch auf Apothekenebene erfolgen, wäre diese Transparenz erheblich eingeschränkt [8].

Darüber hinaus ermöglichen gut etablierte Pharmakovigilanzsysteme die kontinuierliche Überwachung von Nebenwirkungen im Rahmen der Anwendung von Biologika/Biosimilars im Versorgungsalltag. Eine gute Pharmakovigilanz erfordert, dass spezifische Produkt- und Chargeninformationen dokumentiert und in Nebenwirkungsmeldungen aufgenommen werden. Automatische Substitutionen könnten diese Praxis untergraben, wenn der Arzt nicht weiß, wann, wo oder wie ein Austausch erfolgt ist – insbesondere dann, wenn keine elektronische Patientenakte vorliegt. Daher sind Maßnahmen zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und zur eindeutigen Identifikation des in der Apotheke abgegebenen biologischen Arzneimittels von großer Bedeutung.

Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang die Kennzeichnung mit dem sogenannten „schwarzen Dreieck“, das in der EU seit 2013 Arzneimittel kennzeichnet, die einer zusätzlichen Überwachung unterliegen [219]. Diese Kennzeichnung bedeutet nicht, dass das Arzneimittel unsicher ist, sondern dass es z. B. aufgrund begrenzter Datenlage oder neuer Zulassung besonders engmaschig beobachtet wird. Zu den betroffenen Wirkstoffen zählen unter anderem Ranibizumab, Adalimumab und Natalizumab. Eine automatische Substitution solcher Arzneimittel ohne ärztliche Rückmeldung kann die Nachverfolgbarkeit von Nebenwirkungen erheblich erschweren und die regulatorisch geforderte zusätzliche Überwachung unterlaufen. Gerade bei diesen Präparaten ist eine lückenlose Dokumentation der abgegebenen Charge und des konkreten Produkts essenziell für die Bewertung von Nutzen und Risiko im Versorgungsalltag.

Ein weiterer kritischer Aspekt im Zusammenhang mit der automatischen Substitution von Biologika/Biosimilars betrifft die Dokumentation und Nachverfolgbarkeit im Rahmen von Registerstudien, welche insbesondere für chronische Krankheitsbilder eine hohe Bedeutung haben und Erkenntnisse jenseits des Zeithorizonts klinischer Studien liefern. So ist es bereits heute für medizinisches Fachpersonal essenziell, genau zu dokumentieren, welches spezifische Biologikum/Biosimilar ein Patient erhält – insbesondere im Hinblick auf die Erfassung von

Langzeitdaten zu Wirksamkeit, Sicherheit und Nebenwirkungen. Wenn Präparatewechsel regelmäßig auf Apothekenebene erfolgen, ohne dass der behandelnde Arzt direkt involviert ist, wird diese Dokumentation unmöglich.

Dies betrifft insbesondere etablierte Register wie das MS-Register (REGIMS) der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), ein Immuntherapieregister zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit der MS-Therapie. Ziel dieses Registers ist es, einen von der EMA empfohlenen Mindestdatensatz zu implementieren, um belastbare Aussagen zur Sicherheit und Effizienz von MS-Therapien treffen zu können. Die Gesamtzahl der Menschen mit Multipler Sklerose in Deutschland wird auf etwa 280.000 geschätzt. Seit seiner Einführung im Jahr 2001 hat die DMSG Daten von mehr als 80.000 MS-Patienten in Deutschland erfasst und deckt damit rund 29 % der geschätzten Gesamtzahl ab. Die Teilnahme am Register ist zudem Voraussetzung für die Zertifizierung als MS-Zentrum, MS-Schwerpunktzentrum oder MS-Rehabilitationszentrum.

Eine automatische Substitution von TYSABRI i.v. durch das i.v.-Natalizumab-Biosimilar durch Apotheken gefährdet jedoch die Integrität und Qualität dieser Datenerhebung. Wenn der behandelnde Arzt nicht mehr eindeutig nachvollziehen kann, welches Präparat dem Patienten tatsächlich verabreicht wurde. Bei einem Wechsel zwischen Referenzbiologikum und Biosimilar wird die Zuordnung von spezifischen Nebenwirkungen wie PML, neutralisierenden Antikörpern (NABs), immunogenen Reaktionen oder weiteren unerwünschten Ereignissen erschwert. Bei einer automatischen Substitution in der Apotheke fehlt häufig die direkte Rückmeldung an den behandelnden Facharzt, die für eine valide klinisch-wissenschaftliche Auswertung der Registerdaten erforderlich wäre. Real-World Daten, u. a. aus Registern, spielen eine wichtige Rolle in der medizinischen Forschung und Versorgung, indem sie Informationen aus der Routineversorgung sammeln und so Einblicke in die Praxis ermöglichen, die über klinische Studien hinausgehen.

Diese Problematik betrifft nicht nur die MS-Therapie, sondern auch andere Indikationsgebiete wie Rheumatologie, Gastroenterologie oder Dermatologie. Register wie RABBIT (für Rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew und Psoriasis Arthritis), CEDUR (für chronisch entzündlichen Darmerkrankungen), PsoBest (für Psoriasis), BiKeR (für Kinder/Jugendliche mit Juveniler Idiopathischer Arthritis (JIA)) oder JuMBO (für JIA bei jungen Erwachsenen) sind auf eine lückenlose Dokumentation angewiesen. Es sei hier darauf hingewiesen, dass eine automatische Substitution in der Apotheke die Nutzung solcher Register erheblich behindern kann.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie eine verlässliche Therapiedokumentation und Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden kann, wenn die Entscheidung über das abgegebene Präparat nicht mehr beim behandelnden Arzt liegt. Ohne klare Mechanismen zur Rückmeldung und Dokumentation droht ein Verlust an Datenqualität – insbesondere für Langzeitdaten – der nicht nur die Versorgungsforschung beeinträchtigt, sondern auch die Übertragbarkeit von Studienergebnissen in die klinische Praxis gefährdet.

Celltrion

Biologische Arzneimittel unterliegen aufgrund ihrer komplexen Herstellung und potenziell immunogenen Struktur besonders strengen Anforderungen an das Sicherheitsmonitoring. Die europäische Guideline on Good Pharmacovigilance Practices (GVP Module VI) fordert explizit ein engmaschiges Monitoring und Tracking für Biologika – sichtbar gemacht durch das sogenannte „schwarze Dreieck“ in der Fachinformation. Dies schließt insbesondere eine lückenlose Dokumentation der abgegebenen Charge ein [63].

Nur wenn dem behandelnden Arzt die erfolgte Substitution und die konkret abgegebene Charge bekannt sind, kann er seiner Verantwortung im Rahmen der Pharmakovigilanz sowie der medizinischen Verlaufskontrolle – insbesondere nach Wechseln – nachkommen. Dies ist auch berufsrechtlich geboten: Nach § 6 der (Muster-) Berufsordnung für Ärzte (MBO-Ä)

besteht eine Meldepflicht hinsichtlich unerwünschter Arzneimittelwirkungen.

Die medizinische Notwendigkeit der ärztlichen Überwachung und Aufklärung bei Umstellungen auf Biosimilars ist in zahlreichen Fachquellen belegt:

- Das IQWiG empfiehlt in seiner Patienteninformation zu Biologika eine engmaschige Überwachung „wie bei einer Neueinstellung“ nach Umstellung auf ein Biosimilar.
- Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) formuliert identisch: Nach einer Umstellung sei eine Überwachung „wie bei einer Neueinstellung“ erforderlich [65].
- Der Bundesrat betont in seiner Stellungnahme zum GSAV die Komplexität biopharmazeutischer Therapien und empfiehlt dringend eine „adäquate Einbeziehung von Arzt und Patient“ bei jeder Umstellung [183].
- Der gemeinsam von der EMA und der Europäischen Kommission erstellte Leitfaden für medizinische Fachkräfte betont, dass ein Wechsel einhergehen soll mit einem Gespräch des verschreibenden Arztes mit dem Patienten [46].
- Auch weitere Fachquellen kommen zu vergleichbaren Schlussfolgerungen. So betonen etwa die Konsensus-Empfehlungen einer internationalen Task Force zum Einsatz von Biosimilars bei rheumatischen Erkrankungen, dass Therapieentscheidungen im Rahmen einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patient erfolgen sollten. Ein Wechsel auf oder zwischen Biosimilars darf demnach nicht ohne vorherige Information des Patienten und des behandelnden Arztes vorgenommen werden [6].

Hexal

Neben der Gefährdung der Versorgungssicherheit aufgrund negativer Konsequenzen durch die Substitution in der Apotheke stellt die Sicherstellung der Pharmakovigilanz unverändert ein ungelöstes Problem dar. Pharmakovigilanz beschreibt die Identifizierung von unerwünschten Ereignissen während der routinemäßigen klinischen Anwendung eines Arzneimittels und ist für die Gewährleistung der Patientensicherheit von wesentlicher Bedeutung [248].

Biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel verfügen grundsätzlich über ein immunogenes Potential, das je nach Wirkstoff unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Zudem unterliegen sie aufgrund der Besonderheiten des Herstellungsprozesses einer strukturellen Variabilität (Mikroheterogenität) in definierten Grenzen. Unabhängig davon, ob es sich um ein Referenzprodukt, ein Biosimilar oder ein verwandtes Produkt handelt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass verschiedene Produkte mit demselben Wirkstoff leicht unterschieden und rückverfolgt werden können, damit neu auftretende und produktspezifische Sicherheitsbedenken sowie die Immunogenität während des gesamten Produktlebenszyklus rasch erkannt und bewertet werden können und die Lieferung gegebenenfalls bis zu den Standorten und Patienten nachvollzogen werden kann. Dementsprechend werden an biotechnologische Arzneimittel besonders hohe gesetzliche und behördliche Anforderungen an die Sicherstellung der Pharmakovigilanz angelegt. Eine der wichtigsten Anforderungen ist dabei die Notwendigkeit, die kontinuierliche Rückverfolgbarkeit von Produkten und Chargen in der klinischen Anwendung sicherzustellen („Traceability“). Biologika unterliegen dem Status einer besonderen Überwachung zur Wahrung der dauerhaften klinischen Sicherheit. Da ein bestimmtes Produkt auch nach einer wesentlichen Änderung des Herstellungsprozesses denselben Produktnamen behält, ist die Rückverfolgbarkeit der Chargen ein wichtiger Aspekt, der u.a. bei allen damit verbundenen Aktualisierungen der Risikomanagementpläne zu berücksichtigen ist.

Mit der Richtlinie 2010/84/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2010 zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel hinsichtlich der Pharmakovigilanz hat die

248 Felix T et al. (2019): Current state of biologic pharmacovigilance in the European Union: improvements are needed. Expert Opin Drug Saf;18(3):231-40.

Europäische Kommission die Mitgliedsstaaten verpflichtet, u. a. durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass bei Berichten über vermutete Nebenwirkungen durch biologische Arzneimittel diese eindeutig zu identifizieren sind, wobei der Name des Fertigarzneimittels und die Herstellungscharge exakt angegeben werden sollen [178]. Gemäß der aktuellen EMA-Guideline zur Guten Pharmakovigilanzpraxis muss die Rückverfolgbarkeit vollständig in verschiedene Einrichtungen und Infrastrukturen des Gesundheitswesens integriert werden, z. B. in die Infrastruktur für die elektronische Datenaufzeichnung oder auch bestehende Register mit dem Ziel, Daten aus dem praktischen Versorgungsalltag lückenlos zu erfassen. Der Produktname und die Chargennummer eines verabreichten biologischen Arzneimittels sind von den Angehörigen der Gesundheitsberufe aufzuzeichnen und dem Patienten mitzuteilen. Die zuständigen Behörden haben durch die Methoden zur Sammlung von Informationen und erforderlichenfalls durch die Weiterverfolgung von Meldungen über vermutete Nebenwirkungen sicherzustellen, dass alle geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um jedes verschriebene, abgegebene oder verkaufte biologische Arzneimittel, das Gegenstand einer Meldung über vermutete Nebenwirkungen ist, eindeutig zu identifizieren, wobei der Name des Arzneimittels und die Chargennummer anzugeben sind (§62 Absatz 2 AMG). Verordnende Ärzte haben unabhängig davon eine berufsrechtliche und haftungsrelevante Verpflichtung zur Meldung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen.

Lilly

[...] Im Weiteren weist Lilly darauf hin, dass eine Rückverfolgung auf das angewendete Arzneimittel zur Gewährleistung einer Meldung von Nebenwirkungen im Rahmen der Pharmakovigilanz wesentlich ist. Betreffend unserer Produkte Humalog®, Lyumjev®, Huminsulin®, Abasaglar® sowie Forsteo® und Humatrope® wird in der jeweiligen Fachinformation darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung des biologischen Arzneimittels und die Chargenbezeichnung des angewendeten Arzneimittels eindeutig dokumentiert werden müssen [100, 101, 102, 165, 177, 249].

Novartis

Neben dem Therapieerfolg ist die Pharmakovigilanz von hoher Bedeutung. Die automatische Substitution in der Apotheke ist auch einem langfristigen Evidenzaufbau hinsichtlich Umstellungen von Biosimilar zu Biosimilar oder zwischen Referenzarzneimittel und Biosimilar und umgekehrt nicht dienlich und kann auch per Anwendungsgebiet nicht erfolgen. Weder kann die gesetzliche Pflicht der Pharmakovigilanz ungetrübt und solide aufrechterhalten werden – auch nicht über elektronische Mittel – noch können weitere anwendungsbegleitende Daten zum Erkenntnisgewinn solcher multiplen Therapieumstellungen systematisch gewonnen werden. Für die Erhebung der Wirkung und Verträglichkeit sowie der Therapieadhärenz ist eine verlässliche Dokumentation unerlässlich, die nur vom Behandelnden persönlich bei der Verordnung selbst und bei Nachfolgeterminen in der Patientenakte aufgezeichnet werden kann. Dies ist insbesondere zu fordern bei den – komplexen – Antikörperpräparaten, die eine unzureichende Umstellungs-Evidenz aufweisen, insbesondere auch bei erst kürzlich zugelassenen Biosimilars oder denjenigen Biopharmazeutika, die an besonders vulnerablen Stellen wie dem Auge injiziert werden. Bei schwerem allergischem Asthma werden individuelle Dosen bis zu 600 mg verabreicht. Um diese Dosis zu erreichen, müssen mehrere Spritzen verabreicht werden. Sollten hier mehrere Chargen oder Packungen z. B. unterschiedlicher Hersteller vermischt werden, erschwert dies im Falle von Nebenwirkungen die Ursachenzuordnung und gefährdet die Patientensicherheit [33].

Ratiopharm

Eine funktionierende Pharmakovigilanz ist essenziell, um die Sicherheit biologischer Arzneimittel langfristig zu gewährleisten. Biologika unterliegen aufgrund ihrer Komplexität und Herstellung in lebenden Zellsystemen besonderen Anforderungen an die Überwachung

von Nebenwirkungen, Immunreaktionen und Chargenvariabilitäten.

Ein häufiger, nicht ärztlich gesteuerter Austausch von Biologika in der Apotheke erschwert die Rückverfolgbarkeit im Falle unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW) erheblich. Zwar sind Biosimilars nach der Zulassung als ähnlich zugelassen, jedoch können Unterschiede in Formulierung, Hilfsstoffen, Applikationssystemen oder Immunogenitätsprofil bestehen.

Der behandelnde Arzt ist die zentrale Instanz für eine strukturierte, konsistente Dokumentation der Therapie – inklusive:

- exakter Präparatsbezeichnung (inkl. Herstellername und Handelsname),
- Chargenbezug,
- Therapiedauer und
- beobachteten Nebenwirkungen.

Nur wenn die ärztliche Behandlung die volle Kontrolle über die eingesetzten Präparate behält, kann eine konsequente Pharmakovigilanz sichergestellt werden. Wird der Austausch in die Apotheke verlagert – möglicherweise ohne Rückmeldung an die ärztliche Praxis – drohen Lücken in der Dokumentation, was wiederum eine erschwerte Ursachenklärung bei UAW und verzögerte Maßnahmen zur Risikominimierung nach sich ziehen kann.

Zudem besteht die Gefahr, dass Patienten selbst nicht in der Lage sind, zwischen den verschiedenen Präparaten zu unterscheiden oder diese korrekt zu benennen – insbesondere, wenn sich Handelsnamen, Verpackung oder Applikationssysteme ändern.

Die ärztliche Steuerung der Biologika-Therapie ist daher nicht nur medizinisch sinnvoll, sondern auch regulatorisch notwendig für eine robuste Arzneimittelsicherheit.

Stadapharm

Ein zentrales Element der Arzneimitteltherapiesicherheit ist die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Präparate. Sie ist essenziell, um im Falle von Nebenwirkungen oder Wirkverlusten die zugrundeliegenden Ursachen nachvollziehen und ggf. regulatorische Maßnahmen ergreifen zu können. Gerade bei Biologika, bei denen immunologische Reaktionen nicht auszuschließen sind, ist die genaue Zuordnung von Ereignissen zu bestimmten Chargen, Herstellern oder Produktversionen von höchster Relevanz.

Im Rahmen der ärztlichen Verordnung ist die Rückverfolgbarkeit in der Regel durch die Dokumentation in der Patientenakte und die Nennung des verordneten Produktnamens sichergestellt. Bei einer automatischen Substitution entfällt diese Kontrolle: Die Apotheke gibt ein anderes, wenn auch als austauschbar gelistetes Präparat ab – häufig ohne Kenntnis des verordnenden Arztes und ohne Eintrag in die Patientenakte. Die Folge ist eine Unterbrechung der lückenlosen Dokumentationskette, was insbesondere bei auftretenden Nebenwirkungen zu einer erschwerten Ursachenzuordnung führt. Die lückenlose Rückverfolgbarkeit im Falle der automatischen Substitution durch den Apotheker wäre mit einem enormen administrativen Aufwand verbunden.

Langzeitregister wie RABBIT (für rheumatologische Erkrankungen) oder BIOREG (für dermatologische Biologikatherapien) erfassen die Langzeiteffektivität und -sicherheit biopharmazeutischer Therapien. Voraussetzung für die Aussagekraft dieser Register ist jedoch die genaue Kenntnis darüber, welches Präparat der Patient erhalten hat – inklusive Chargennummer, Handelsname und Hersteller.

Bei häufigen und unkontrollierten Wechseln, wie sie im Rahmen einer automatischen Substitution auftreten können, wird die Qualität dieser Daten erheblich beeinträchtigt. Nebenwirkungen, Therapieversagen oder Wirksamkeitseinbußen können nicht mehr eindeutig einem bestimmten Produkt zugeordnet werden. Dies unterminiert nicht nur die Aussagekraft wissenschaftlicher Erhebungen, sondern behindert auch regulatorische Rückruf- oder Anpassungsmaßnahmen.

Eine fehlende Rückverfolgbarkeit stellt auch ein Problem der Patientensicherheit dar. Im Fall schwerwiegender Nebenwirkungen oder Produktionsmängel ist es entscheidend, schnell identifizieren zu können, welches Arzneimittel ein Patient konkret erhalten hat. Bei nicht dokumentierten Substitutionen ist dies im Nachhinein oft nicht möglich.

Hinzu kommen haftungsrechtliche Fragen: Wenn die Substitution nicht vom Arzt, sondern durch die Apotheke erfolgt, stellt sich die Frage, wer im Schadensfall haftet – insbesondere wenn der behandelnde Arzt von dem Austausch nichts wusste und diesen nicht dokumentieren konnte.

Fazit: Die Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln ist eine grundlegende Voraussetzung für Patientensicherheit, wissenschaftliche Aussagekraft und rechtliche Klarheit. Eine automatische Substitution gefährdet diese Rückverfolgbarkeit und unterminiert damit zentrale Prinzipien der Arzneimittelüberwachung und Qualitätskontrolle.

[...] Ein zentrales Qualitätsmerkmal jeder therapeutischen Maßnahme ist die Möglichkeit zur Evaluation und Rückmeldung. Bei einer automatischen Substitution entfällt eine gezielte Rückkopplung an die verordnende Stelle. Unerwünschte Wirkungen, Therapieversagen oder Probleme in der Anwendung könnten unentdeckt bleiben oder zu spät erkannt werden, weil eine kontinuierliche Kontrolle durch den Arzt erschwert wird.

Ein Qualitätssicherungssystem, das ohne Rückbindung an die ärztliche Betreuung auskommt, riskiert eine Abnahme der Behandlungsqualität. Gerade bei komplexen Therapien, wie sie mit Biologika einhergehen, ist dies nicht hinnehmbar.

Fazit: Die regulatorischen Rahmenbedingungen für eine automatische Substitution sind derzeit unzureichend definiert. Eine Verschiebung von Verantwortung ohne klare juristische und organisatorische Absicherung gefährdet die Rechtssicherheit, die Patientensicherheit und die Qualität der Versorgung. Vor einer Einführung müssen verbindliche Regelungen, Verantwortungsstrukturen und haftungsrechtliche Klarstellungen geschaffen werden.

BPI

Bei der Anwendung biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel sind häufig Kombinationstherapien (Komedikationen) vorgesehen oder erforderlich. In solchen Fällen können Wechselwirkungen, Nebenwirkungen oder immunologische Reaktionen auftreten, die nicht ausschließlich einem einzelnen Wirkstoff zugeordnet werden können. Dies betrifft sowohl die Pharmakovigilanzverantwortung als auch haftungsrechtliche Fragestellungen – insbesondere, wenn es durch die automatische Substitution in der Apotheke zu einer Änderung des ursprünglich ärztlich vorgesehenen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittels kommt.

Der G-BA sollte daher bei der Ausgestaltung der Regelungen nach § 40c AM-RL sicherstellen, dass auch bei Substitutionen auf Apothekenebene eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der abgegebenen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel erhalten bleibt und die Verantwortlichkeiten der beteiligten pharmazeutischen Unternehmer – sowohl der Anbieter der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel/Biosimilars als auch der Hersteller der Komedikationen – eindeutig zuordenbar bleiben.

Zudem ist es notwendig, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen so gefasst werden, dass pharmazeutische Unternehmer sowohl ihre gesetzlichen Pharmakovigilanzpflichten verlässlich erfüllen als auch im haftungsrechtlichen Streitfall ihre unternehmerischen Rechte wahren können. Dies ist insbesondere im Hinblick auf Produkthaftungsfragen, wissenschaftliche Bewertung von Nebenwirkungsmeldungen und regulatorische Anforderungen essenziell.

Eine automatische Substitution darf daher nicht zu einer Unklarheit bei der Kausalitätszuordnung von Nebenwirkungen oder zu einer Aufweichung bestehender Verantwortlichkeitsstrukturen führen. Der G-BA ist aufgerufen, diese komplexe Problematik bei der Regelung der Substitution zwingend zu berücksichtigen.

ABDA, AMK

Der Pharmakovigilanz kommt ein hoher Stellenwert beim Einsatz von Biologika/Biosimilars zu. Alle Biologika/Biosimilars unterliegen für mindestens 5 Jahre nach der Zulassung einer zusätzlichen Überwachung. Nebenwirkungen können zudem aufgrund bestehender Variabilitäten chargenspezifisch auftreten. Die europäische Pharmakovigilanz-Richtlinie fordert daher, dass bei Berichten zu vermuteten Nebenwirkungen neben dem Namen des Arzneimittels die Nummer der Herstellungscharge angegeben werden soll. Die Meldebögen für Nebenwirkungen sehen zwar den Eintrag der Chargennummern vor, jedoch ist diese v. a. den verordnenden Ärztinnen und Ärzten selten bekannt bzw. nur mit hohem Aufwand zu eruieren. Die Einführung einer „automatischen Substitution“ von Biologika/Biosimilars in der öffentlichen Apotheke aggraviert diese Limitation.

Die AMK hält es daher für dringend notwendig, IT-unterstützte robuste Lösungen zu realisieren, um die Dokumentation des Handelsnamens des abgegebenen Arzneimittels sowie der jeweiligen Herstellungscharge im Sinne einer eindeutigen Rückverfolgbarkeit bei Meldung von Arzneimittelrisiken, beispielsweise durch automatisierte Hinterlegung in der elektronischen Patientenakte, zu ermöglichen.

Pro Generika

Biotechnologisch hergestellte biologische Fertigarzneimittel unterliegen aufgrund ihrer komplexen Herstellung und potenziell immunogenen Struktur besonders strengen Anforderungen an das Sicherheitsmonitoring. Die europäische Guideline on Good Pharmacovigilance Practices fordert explizit ein engmaschiges Monitoring und Tracking für Biologika – sichtbar gemacht durch das sogenannte „schwarze Dreieck“ in der Fachinformation. Dies schließt insbesondere eine lückenlose Dokumentation der abgegebenen Charge ein.

Nur wenn dem behandelnden Arzt die erfolgte Substitution und die konkret abgegebene Charge bekannt sind, kann er seiner Verantwortung im Rahmen der Pharmakovigilanz sowie der medizinischen Verlaufskontrolle – insbesondere nach einer oder mehrfachen Substitution(en) – nachkommen. Dies ist auch berufsrechtlich geboten: Nach § 6 der (Muster-)Berufsordnung für Ärzte (MBO-Ä) besteht eine Meldepflicht hinsichtlich unerwünschter Arzneimittelwirkungen.

Die medizinische Notwendigkeit der ärztlichen Überwachung und Aufklärung bei Umstellungen auf Biosimilars ist in zahlreichen Fachquellen belegt:

- Das IQWiG empfiehlt in seiner Patienteninformation zu Biologika eine engmaschige Überwachung „wie bei einer Neueinstellung“ nach Umstellung auf ein Biosimilar.
- Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) formuliert identisch: Nach einer Umstellung sei eine Überwachung „wie bei einer Neueinstellung“ erforderlich [65].
- Der Bundesrat betont in seiner Stellungnahme zum GSAV die Komplexität biopharmazeutischer Therapien und empfiehlt dringend eine „adäquate Einbeziehung von Arzt und Patient“ bei jeder Umstellung [183].
- Der gemeinsam von der European Medicines Agency (EMA) und der Europäischen Kommission erstellte Leitfaden für medizinische Fachkräfte betont, dass ein Wechsel einhergehen soll mit einem Gespräch des verschreibenden Arztes mit dem Patienten [46].
- Auch weitere Fachquellen kommen zu vergleichbaren Schlussfolgerungen. So betonen etwa die Konsensus-Empfehlungen einer internationalen Task Force zum Einsatz von Biosimilars bei rheumatischen Erkrankungen, dass Therapieentscheidungen im Rahmen einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patient erfolgen sollten. Ein Wechsel auf oder zwischen Biosimilars darf demnach nicht ohne vorherige Information des Patienten und des behandelnden Arztes vorgenommen werden [6].

VZA

Die mit den Ärzten nicht abgestimmte und damit unkontrollierte, ggf. mehrfache rabattvertragsinduzierte Substitution entsprechender Fertigarzneimittel in der Apotheke unterläuft die ärztliche Therapieentscheidung und -verlaufskontrolle, führt zu einer strukturellen Pharmakovigilanzlücke und bürdet den Apotheken enorme Beratungs- und Haftungsrisiken auf, ohne dass der G-BA die ihm gesetzlich übertragene Aufgabe ausreichend wahrnimmt. Die davon betroffenen Patienten werden das Nachsehen haben. Das halten wir nicht für verantwortlich.

DDG, gemeinsam mit Hautnetz Deutschland e. V. und BVDD

Nicht nur aus der ungeklärten Immunogenität bei multiplen Wechseln, sondern auch aus der durch Substitution verhinderten Arzneimittel–Pharmakovigilanz durch die wissenschaftlichen Register entstehen zusätzliche Risiken für die Arzneimittelsicherheit. Die klinischen Biologika-Register wie Rabbit in der Rheumatologie und PsoBest in der Dermatologie tragen wesentlich zum Erkenntnisgewinn über die Sicherheit, Wirkungen und Risiken der Biologika bei. Sie sind in ihrer Breite und Differenzierung allen anderen Formen der Pharmakovigilanz weit überlegen. Diese Registerforschung wird unmöglich, wenn durch den nicht berichteten und nicht abgesprochenen Austausch in der Apotheke andere Präparate als vom Arzt dokumentiert ausgegeben werden.

DRFZ

In den „Tragenden Gründen“ auf S. 8 [wird] unter Position B1 und B2 korrekt dargestellt, dass die Möglichkeiten der Register, Aussagen zu spezifischen Biosimilars zu machen und diese untereinander und mit dem Referenzprodukt zu vergleichen, durch einen automatischen Austausch in der Apotheke gefährdet sind. Weder können dann die Anforderungen der Risikomanagementpläne, die einen eindeutigen Bezug auf das jeweilige Produkt fordern, erfüllt werden, noch können die Register eventuelle substanzspezifische Unterschiede in der Sicherheit, Handhabbarkeit oder Compliance aufdecken.

Wir arbeiten an einer Lösung, um diese Information zukünftig korrekt in den Registern darstellen zu können. So wurde ein einheitliches Dokumentationssystem in der Rheumatologie (RheDAT) etabliert, das den Anschluss von Patienten-Apps ermöglicht. Die Umstellung unserer Register auf dieses System erfolgt sukzessiv und ist für die Kerndokumentation und RABBIT-SpA bereits umgesetzt. Zurzeit erfolgt die Dokumentation der Handelsnamen durch die rheumatologische Einrichtung. Eine Möglichkeit, die Handelsnamen auch bei automatischer Substitution in der Apotheke zu erfassen, bestünde darin, dass die Betroffenen selbst in einer App den Handelsnamen manuell eingeben bzw. den Barcode (inklusive PZN) einscannen und dies an die behandelnden Ärzte weitervermittelt wird. In einem vom BMBF finanzierten Teilprojekt des Forschungsverbundes TARISMA (Förderkennzeichen 01EC1902A) haben wir bereits die erfolgreiche Anbindung und korrekte Erfassung der Medikation durch die Patient:innen über eine App nachgewiesen [250]. Die Umsetzung einer Anbindung der Medikations-App an RheDAT wird noch ca. zwei Jahre dauern.

Psoriasis-Praxisnetz Süd-West

Die Europäische Kommission hat die Mitgliedsstaaten verpflichtet, u.a. durch geeignete Methoden zur Informationssammlung sicherzustellen, dass bei Berichten über vermutete Nebenwirkungen durch biologische Arzneimittel diese eindeutig zu identifizieren sind, wobei der Handelsname des Arzneimittels und die Chargenbezeichnung durch den meldenden Arzt genau angegeben werden sollen. Im Fall einer automatischen Substitution ist die Kenntnisnahme durch den Arzt deutlich erschwert. Damit wäre die geforderte Rückverfolgbarkeit bei Meldungen von Nebenwirkungen nicht mehr sichergestellt.

250 Regierer A et al. (2025): Integration of a medication reminder app into the RABBIT-SpA disease registry to record patient data on daily drug usage. GMS Med Inform Biom Epidemiol;21(Doc06).

Bewertung:

Die Stellungnehmenden weisen auf den durch die EMA regelhaft festgelegten höheren Monitoringbedarf (*additional monitoring*, Kennzeichnung durch schwarzes Dreieck) für neu zugelassene Biologika, der auch für Biosimilars gelte, hin. Dieser höhere Monitoringbedarf steht einer Ersetzung von Biologika jedoch grundsätzlich nicht entgegen. Die Zulassung von Biosimilars erfolgt, wenn die zuständige Zulassungsbehörde im jeweiligen Zulassungsverfahren zu dem Ergebnis kommt, dass diese jeweils ein vergleichbares Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil mit den entsprechenden Referenzarzneimitteln aufweisen.

Durch die in § 40c vorgesehenen Regelungen zur Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel entsteht keine neue Situation in der Apotheke, da auch bislang schon bei jeder Abgabe biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel eine Dokumentation (ggf. Rückmeldung bzw. Weiterleitung) der Charge – auf die Mikroheterogenität der Chargen eines biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittels wird in den Stellungnahmen ebenfalls hingewiesen – erfolgen müsste. Darüber hinaus ist in Apotheken – wenn auch in geringem Maße – bereits ein Austausch biotechnologisch hergestellter Arzneimittel, die in Anlage 1 des Rahmenvertrags nach § 129 Absatz 2 SGB V aufgeführt sind, ohne Rücksprache mit dem Arzt möglich; in diesen Fällen unterscheidet sich neben der Charge zudem der Handelsname des abgegebenen Arzneimittels. Seit kurzem können Apotheken regelhaft u. a. Handelsname und Chargenbezeichnung abgegebener Arzneimittel in die elektronische Medikationsliste (eML) übertragen.

Sofern es zu einer Ersetzung von Biologika durch Apotheken kommt, ist davon auszugehen, dass dieser entsprechend dokumentiert wird und ggf. durch Nachfrage der Ärztinnen und Ärzte bei den Versicherten – solange die elektronische Patientenakte (ePA) dafür noch nicht vollständig nutzbar ist – Unklarheiten in Bezug auf das konkret angewendete Arzneimittel beseitigt werden können. Regelhaft kann eine Dokumentation von Handelsnamen und Charge des zur Anwendung kommenden biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittels durch den Arzt oder die Ärztin in den Fällen selbst vorgenommen werden, bei denen die Arzneimittel unmittelbar ärztlich appliziert werden.

Die grundsätzliche Meldeverpflichtung von Nebenwirkungen für Ärzte und Apotheker, bei der auch die Angabe des konkreten Arzneimittels sowie bei Biologika zusätzlich der Chargenbezeichnung erfolgen soll, besteht auch bislang schon für Biologika. Vor diesem Hintergrund ist auch grundsätzlich davon auszugehen, dass durch denjenigen Heilberuf eine Meldung zur Nebenwirkung erfolgt, der im konkreten Fall Kenntnis davon erlangt. Bei Unklarheiten oder Unkenntnis zu erforderlichen Angaben für die entsprechenden Meldeformulare – wie etwa der konkrete Handelsname oder die Charge des angewendeten Arzneimittels – zum Meldezeitpunkt können diese zunächst soweit möglich auch durch Nachfrage bei der meldenden Person selbst behoben werden.

Darüber hinaus gibt der G-BA auf Grundlage seines Regelungsauftrags Hinweise zur Umstellung durch Ärzte sowie zur Ersetzung der verordneten Biologika durch Apotheken; die Konkretisierung der Vorgaben zum Informationstransfer insbesondere bei einer Ersetzung durch Apotheken sind jedoch nicht Gegenstand des Regelungsauftrags.

Es wird befürchtet, dass ein mehrfacher Austausch durch Apotheken die Aussagekraft von Registern schwächen würde, da beobachtete Effekte nicht einem Arzneimittel zugeordnet werden könnten. Aus Sicht des G-BA sind Beobachtungsstudien bzw. Register zur Gewinnung von Daten zur Arzneimittelsicherheit neben dem Spontanmeldesystem von Bedeutung.

Sofern es zu einem Austausch von Biologika durch Apotheken kommt, ist davon auszugehen, dass dieser entsprechend dokumentiert wird und ggf. durch Nachfrage der Ärztinnen und Ärzte bei den Versicherten – solange die Telematikinfrastuktur dafür noch nicht vollständig

nutzbar ist – Unklarheiten in Bezug auf das konkret angewendete Arzneimittel beseitigt werden können. Aus Sicht des G-BA ist dies aber keine Voraussetzung für eine Ersetzung von Biologika durch Apotheken, wie sie § 40c vorsieht. Die therapeutische Vergleichbarkeit leitet sich aus der Zulassung der Biosimilars mit Bezug auf das jeweilige Referenzarzneimittel ab. Siehe hierzu auch die Bewertung der Einwände zum Absatz 3.

In der Regel wird es auch nicht zu einem ständigen Austausch kommen (siehe hierzu auch die Bewertung der Einwände zu den Absätzen 2 und 4 sowie zum Einwand 3.6.6), insofern sollten aus den Registerdaten auch weiterhin Erkenntnisse zu den einzelnen Arzneimitteln ableitbar sein. Auch bei Abgabe des verordneten Arzneimittels durch Apotheken müssen aufgrund der Mikroheterogenität und möglichen Unterschieden zwischen einzelnen Chargen die Chargenbezeichnungen dokumentiert werden. Siehe auch Bewertung der Einwände zu den Absätzen 3 und 4 sowie zu den weiteren Einwänden 3.1.2, 3.6.1 und 3.6.2.

Zu Fragen der Haftung siehe auch Bewertung zum Einwand 3.6.3.

3.6.9 Ausnahmen für bestimmte Therapiebereiche / Kinder, Jugendliche, ältere Patienten

Lilly

Für unsere Produkte Humalog®, Abasaglar® sowie Humatrope® bestehen Zulassungen zur Behandlung bei Kindern [100, 165, 249]. Inwieweit die Substitution in Apotheken auch Patienten im Kindes- und Jugendalter einschließt, blieb bislang offen. Aus Sicht von Lilly gelten Kinder und Jugendliche als eine besonders schutzbedürftige Gruppe, daher sollten diese aufgrund der bereits genannten Risiken in Bezug auf die Arzneimittelsicherheit grundsätzlich von der Substitution in Apotheken ausgeschlossen werden. Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass das Bundesministerium für Gesundheit bereits in der Vergangenheit auf die Schutzbedürftigkeit von Kindern, insbesondere im Bereich von Diabetes mellitus, im Zuge der Verfahren des G-BA (Beschluss des G-BA über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie in Anlage 10: Kurzwirksame Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 vom 21. Februar 2008; Beschluss des G-BA über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie in Anlage 10: Kurzwirksame Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 vom 10. April 2008) über die Rechtsaufsicht hingewiesen hat.

Merck

Die Pflicht zum Austausch auf Apothekenebene bei einer verpflichtend bestehenden anteiligen Kostenbeteiligung durch den Versicherten von 50% darf nicht bestehen, da sie mit dem Versicherungsprinzip nicht vereinbar ist.

Das Kinderwunschpaar trägt einen sehr großen Teil der Therapiekosten selbst, da nur ein gesetzlicher Anspruch auf Kostenübernahme von 50% der Behandlungskosten. Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich – sofern keine individuelle Satzungsleistung zur künstlichen Befruchtung besteht – gemäß SGB V § 27a „Richtlinien über künstliche Befruchtung“ lediglich an 50% der Kosten für maximal 3 Therapiezyklen einer in-vitro Fertilisation. Ab dem 4. Therapiezyklus handelt es sich um eine reine Privatleistung, die das Kinderwunschpaar finanziell vollumfänglich zu tragen hat.

Das Versicherungsprinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beruht auf der solidarischen Risikoübernahme, um die finanziellen Belastungen für den Einzelnen im Krankheitsfall zu minimieren. Bei einer pauschalen Beteiligung der Patienten an den Behandlungskosten ist es entscheidend, dass die Entscheidungsautonomie sowohl des Arztes als auch des Patienten in Bezug auf die Wahl des Arzneimittels gewahrt bleibt.

Die Abwägung zwischen wirtschaftlichen und medizinischen Aspekten der Arzneimittelauswahl wird bereits durch den behandelnden Arzt berücksichtigt, der die individuellen Bedürfnisse und wirtschaftlichen Umstände des Patienten kennt. Ein zusätzlicher Mechanismus in der Apotheke, der diese Entscheidungsfindung ignoriert, ist nicht notwendig

und mit einer verpflichtenden Kostenbeteiligung nicht vereinbar.

Novartis

Um einen Therapieerfolg zu erreichen, ist die Einhaltung einer konstanten Wirkstoffverfügbarkeit in hochsensiblen Medikationsplänen unumgänglich. Ein mehrfacher Wechsel zwischen Originalen und Biosimilars sowie Biosimilars und Biosimilars gefährdet diesen Erfolg aufgrund von abweichender Bioäquivalenz der unterschiedlichen Arzneimittel. Im Fall von Lucentis® führt zum Beispiel eine zu geringe Verfügbarkeit auf der einen Seite zu einer potenziell folgenden Krankheitsprogression [251]. Eine zu hohe Verfügbarkeit auf der anderen Seite kann die Nebenwirkungsrate erhöhen (insbesondere Entzündungen des Auges, die zu nicht reversiblen Sehverlust führen). Blut- und Kammerwasseranalysen zeigen in verschiedenen Studien eine Bandbreite an Bioäquivalenz (80–120%) [252]. Dadurch ergibt sich, dass keine genaue Aussage über die Bioverfügbarkeit am Ort der Wirkung im Auge gemacht werden kann, die aber für den Erhalt des Visus bzw. das Verhindern von ophthalmologischen und systemischen Nebenwirkungen notwendig ist [251].

Novo Nordisk

Nach Meinung von Novo Nordisk bestehen gravierende Unterschiede zwischen dem Originalprodukt und den Biosimilars, die gegen eine automatische Substitution in der Apotheke sprechen. NovoRapid® könnte z. B. bei einem Kind im Alter von einem Jahr auf Apothekenebene durch das Biosimilar Insulin Aspart Sanofi® ersetzt werden. Hier liegt keine Vergleichsstudie zur Pharmakokinetik bei Kindern mit Typ 1 Diabetes vor. Die Studie mit Erwachsenen ergab Unterschiede hinsichtlich der Pharmakokinetik [253]. Auch bezüglich Kirsty® wurden pharmakologische und klinische Daten nur bei Erwachsenen erhoben. Klinische Daten zum Austausch von NovoRapid® mit Kirsty® existieren nicht. Die Pharmakokinetik von Kindern ist aufgrund des anderen, für Kinder typischen Verteilungsvolumens nochmal anders [254, 255]. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Unterschiede in der Pharmakokinetik den Therapieerfolg beeinträchtigen und die Arzneimitteltherapiesicherheit gefährden könnten.

Das hier aufgeführte Beispiel zeigt zum einen den großen Beratungs- und Aufklärungsbedarf hinsichtlich der hochwirksamen biologischen Arzneimittel und zum anderen die Risiken, die mit einer automatischen Substitution auf Apothekenebene einhergehen.

Ein den Patient:innen unbekanntes Arzneimittel kann durch fehlende Therapieadhärenz und mangelnde Kenntnis der Anwendung sowie der Handhabungsweise zu einem potenziell lebensbedrohlichen Risiko werden. Eine ungenaue Dosierung der Insuline beispielsweise kann schnell zu einer hypo- oder hyperglykämischen Entgleisung führen. Insbesondere im Hinblick auf die Verlagerung der Arzneimittelversorgung durch Versandapotheken kann die notwendige Beratung und Aufklärung nicht hinreichend sichergestellt werden. Auch der Nocebo-Effekt sollte insbesondere für durch Patient:innen eigenständig angewandte Arzneimitteltherapien beachtet werden [68].

Bundesverband Deutscher Ophthalmochirurgen e. V.

[...] Dies bedeutet, dass vom Apotheker verlangt wird, allein auf Kenntnis der Zulassung, eine Entscheidung zu treffen, bei der die therapeutische Wirksamkeit und das Risiko für die Patienten des Arzneimittels außer Betracht bleibt.

251 Ota H et al. (2025): Efficacy of switching from existing anti-vascular endothelial growth factor drugs to ranibizumab biosimilar in neovascular age-related macular degeneration. Jpn J Ophthalmol.

252 EMA: Guideline on the investigation of bioequivalence. 2010.

253 Kapitza C et al. (2020): Single-Dose Euglycemic Clamp Study Demonstrating Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Similarity Between SAR341402 Insulin Aspart and US- and EU-Approved Versions of Insulin Aspart in Subjects with Type 1 Diabetes. Diabetes Technol Ther;22(4):278-84.

254 Greiner C (2011): Verteilungsvolumen – Wie sich Substanzen im Körper verteilen. https://www.unimedizin-mainz.de/fileadmin/kliniken/ps/Dokumente/Klinische_Pharmazie/verteilungsvol.pdf

255 O'Hara K (2016): Paediatric pharmacokinetics and drug doses. Aust Prescr;39(6):208-10.

Dies führt gerade für den Einsatz von VEGF-Hemmern in der operativen Augenheilkunde zu Medikationsfehlern mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Patientensicherheit, da sich die therapeutische Wirksamkeit der wirkstoffgleichen VEGF-Hemmer häufig deutlich unterscheidet. Der Grund dafür ist, dass unterschiedliche VEGF-Hemmer unterschiedliche Adhärenz zu den Subgruppen des VEGF haben und damit unterschiedliche Wirksamkeit. In der operativen Injektionstherapie mit VEGF-Hemmern (Intravitreale Operative Medikamentengabe, IVOM) wechseln Augenärzte seit Jahren zwischen den verfügbaren biologischen Arzneimitteln, insbesondere weil dies eine Therapieverbesserung bei den Patienten in Aussicht stellt, die sich im Laufe der Therapie zu sog. Non-Respondern entwickeln, also bei denen die therapeutische Wirksamkeit eines Präparats nach mehreren Injektionen nachlässt. Die Versorgungspraxis hat gezeigt, dass solche Wechsel von VEGF-Hemmern therapeutische Effekte erzielen können.

Entscheidende Berücksichtigung muss deshalb die praktische Evidenz im einzelnen Behandlungsfall haben, da nur dadurch die therapeutische Wirksamkeit beurteilt werden kann.

[...] Bei den Augenerkrankungen, bei denen derzeit Biologika und auch Biosimilars eingesetzt werden, handelt es sich im Wesentlichen um chronische Erkrankungen, die einer fortdauernden und meist lebenslangen operativen Injektionstherapie mit VEGF-Hemmern bedürfen. Hierbei empfehlen die augenärztlichen Fachgesellschaften patientenindividuell festzulegende Therapiekonzepte (z.B.: CATT, IVAN, PRN, Treat and Extend). Der Augenoperator entscheidet in jedem Einzelfall, mit welchem Therapieschema und mit welchem Medikament der Patient behandelt wird. Wir erwarten, dass auch zukünftig aus vorgenannten medizinischen Gründen die Therapiefreiheit durch den Arzt uneingeschränkt ausgeübt werden kann.

In der Therapie wird die Wirkung des VEGF-Hemmers fortlaufend u.a. durch OCT-Aufnahmen der Netzhaut (Verlaufskontrollen) überwacht. Sobald die Wirkung eines VEGF-Hemmers abnimmt, wechselt der Augenarzt ganz bewusst auf einen anderen VEGF-Hemmer. Dabei erfolgt die Entscheidung über das einzusetzende Medikament durch den Augenarzt aufgrund des individuellen Befundes beim Patienten in Abhängigkeit von der Morphologie (u.a. post-hoc Analysen zur subretinalen Flüssigkeit). Jahrelange weltweite Behandlungen haben in vielen Studien und evidenzbasiert gezeigt, dass so ein sonst eintretender Wirkungsverlust reduziert und der fortschreitende Sehverlust bis zur drohenden Erblindung aufgehalten werden kann. Diese ärztliche Entscheidung kann und darf der Apotheker nicht treffen. Da dieser nicht in die patientenindividuelle Therapie eingebunden ist, kann er nicht selbst „switchen“ – schon gar nicht bei jeder Verordnung.

Vor diesem Hintergrund muss deshalb von einer automatischen Substitution von Referenzarzneimitteln durch Biosimilars abgesehen werden.

Die Zulassung von Biosimilars gibt den Augenärzten eine weitere Therapieoption in die Hand, deren Auswirkung auf konkrete Behandlungen zu untersuchen ist. Das begrüßen wir. Allerdings bedarf es der Überwachung und Beobachtung der Umstellung der Therapie von Referenzarzneimitteln auf Biosimilars. Dies ist allein ärztliche Aufgabe und von Apothekern nicht zu leisten.

DRFZ

Wir unterstützen die in den „Tragenden Gründen“ dargelegte Auffassung, dass Therapieadhärenz ein wichtiger Teil des Therapieerfolges ist und diese durch Verunsicherung in der Anwendung unterschiedlicher Applikationsweisen gefährdet werden kann. Wir vermuten, dass besonders ältere Patient:innen eine diesbezüglich vulnerable Gruppe darstellen. In dem vom Innovationsausschuss von 2025-2028 geförderten Projekt AER-COMED (Förderkennzeichen: 01VSF24019) untersuchen wir in Teilprojekt 6 mit Hilfe qualitativer Interviews patientenseitige Einflussfaktoren auf die Therapieadhärenz und –sicherheit bei

älteren an rheumatoider Arthritis Erkrankten. Folgende Fragen wurden aufgenommen: „Haben Sie schon erlebt, dass Sie in der Apotheke das gleiche Medikament, aber von einem anderen Hersteller bekommen haben, zum Beispiel mit einem anderen Pen oder anderer Verpackung? Wie war das für Sie? Ist es Ihnen wichtig, immer den gleichen Pen zu bekommen oder kommen Sie auch gut zurecht, wenn der Pen mal anders aussieht oder sich anders bedienen lässt? Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie das Medikament gut wiedererkennen? Wie (bzw. durch wen) wurden Sie über den Wechsel informiert?“

Wir gehen davon aus, dass dieses Forschungsprojekt wichtige Informationen dazu erbringen wird, wie aus Sicht der Patient:innen eine automatische Substitution der Therapie durch Apotheken zu bewerten ist, ob eine Gefährdung des Patientenwohls zu befürchten ist und welche Maßnahmen ggf. ergriffen werden sollten, um Medikationsprobleme zu verhindern.

GKJR

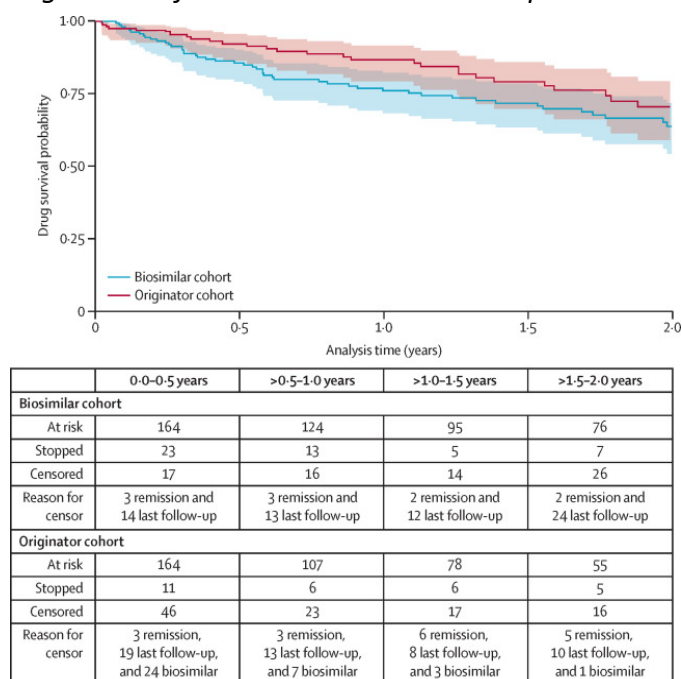
In der Therapie der Kinder und Jugendlichen mit rheumatologischen Erkrankungen sind biotechnologisch hergestellte Arzneimittel (Biologika) heute ein wichtiger und integrativer Bestandteil der Therapie der rheumatischen Erkrankungen.

Grundsätzlich finden Biosimilars flächendeckend Einsatz in der Kinder- und Jugendrheumatologie. Auch in der 2020 veröffentlichten Stellungnahme der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie befürworten wir die Therapie mit Biosimilars. Biosimilars werden auch in der Kinder- und Jugendrheumatologischen Therapie breit eingesetzt.

Dennoch sehen wir als Behandler von Kindern und Jugendlichen mit rheumatischen Erkrankungen Gründe gegen den automatischen Austausch von Biosimilars in der Apotheke, da eine Gefährdung des Therapieerfolges nicht ausgeschlossen ist. Dies betrifft derzeit die Anwendung von Arzneimitteln mit den Inhaltstoffen Infliximab, Adalimumab, Tocilizumab und Etanercept.

Aus unserer Sicht sollten vor allem auch die Daten aus der Untersuchung: Outcomes after anti-tumour necrosis factor originator to biosimilar switching in children and young people with juvenile idiopathic arthritis in the UK: a national cohort study (2024) berücksichtigt werden. Hierbei wurde Verlauf von 224 Kinder in Großbritannien mit Biologikum untersucht. Dabei wurde die Wirkungen und der Verlauf Biosimilar versus Originator verglichen.

Hierbei zeigte sich bei identischer Wirksamkeit, dass mit bereits einmaligem Wechsel vom Originator auf einen Biosimilar die Therapieadhärenz stetig abnimmt.



Mit reduzierter Therapieadhärenz verringert sich die Krankheitskontrolle, potentiell muss auf andere, ggf. noch teurere Basismedikamente gewechselt werden, das Risiko für Spätschäden nimmt zu und das Risiko für die Entwicklung von Antidrugautoantikörpern steigert sich.

Die Fachgesellschaft empfiehlt eine sorgfältige Überwachung der Therapie mit Biologika mit initial engeren Intervallen, zumindest monatlich, später dann 3-monatlichen Intervallen.

Dies wurde in den Protokollen zur Klassifikation, Überwachung und Therapie in der Kinderrheumatologie (PRO-KIND): Polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis der Fachgesellschaft fixiert. Nun ist bei einem häufigeren Wechsel des Präparates auch häufiger ein engere Überwachung erforderlich mit mehreren Nachteilen sowohl für das kranke Kind (seine es häufiger Untersuchungen oder gar Blutuntersuchungen) und häufigeren Termin, die in der Versorgung mit Terminknappheit kaum zu leisten sind und konsekutiv auch höheren Kosten.

Bewertung:

Die Stellungnehmenden tragen vor, dass Kinder, Jugendliche und Ältere von den Regelungen der Ersetzung biologischer Arzneimittel in Apotheken ausgenommen werden sollten. Die Wirkung und Sicherheit von Arzneimitteln könnten sich wirkstoff- und formulierungsbedingt zwischen Kindern und Erwachsenen unterscheiden. Altersgerechte Formulierungen zur sicheren Dosierung müssten berücksichtigt werden.

Für den Bereich der Augenerkrankungen wird eingewendet, dass sich geringe Abweichungen der Bioäquivalenz der unterschiedlichen Arzneimittel unmittelbar auf Nebenwirkungsprofil und Therapieerfolg auswirken. Bei einer Therapie mit VEGF-Hemmern werde fortlaufend die Wirkung durch den Facharzt überwacht und bei deren Abnahme erfolge bewusst die Verordnung eines anderen Arzneimittels. Trotz Beibehaltung des Wirkstoffs könne durch den Wechsel erneut eine gesteigerte Wirkung erzielt werden.

Gemäß den Regelungen in § 40 Absatz 3 sowie § 40a Absatz 5 AM-RL muss die Erwägung, von einer Umstellung abzusehen, immer medizinisch bzw. therapeutisch begründbar sein. Arzneimittel, die über das Maß des Notwendigen hinausgehen oder unwirtschaftlich sind, weil sie gegenüber gleich geeigneten, ausreichenden und erforderlichen Mitteln teurer sind, sind aus dem Leistungskatalog der GKV grundsätzlich ausgeschlossen; dies ergibt sich bereits aus den allgemeinen Anforderungen des Wirtschaftlichkeitsgebots. Der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin kann abgesehen von der Preisgünstigkeit gemäß § 40c Absatz 1 Satz 5 in medizinisch begründeten Einzelfällen von einer Ersetzung durch Apotheken absehen und dennoch einer wirtschaftlichen Verordnungsweise entsprechen, soweit unter Würdigung patientenindividueller und erkrankungsspezifischer Aspekte die Verordnung eines spezifischen Fertigarzneimittels vorzuziehen ist. Dies kann insoweit auch bei Arzneimitteln in Frage kommen, die durch den Arzt angewendet werden. Zum Ausschluss der Ersetzung bei Verordnung durch den Arzt siehe auch Bewertung zu Einwand 3.1.7.

Die Prüfung der Sachgerechtigkeit einer Ersetzung im Einzelfall bleibt hiervon unberührt. Die Notwendigkeit von Information und Beratung zu substitutionsbedingt relevanten Aspekten sowie zur korrekten Anwendung wird nicht infrage gestellt. Die Vermeidung von Fehlern bei der Applikation, die auch unabhängig von einer Ersetzung wirkstoffgleicher Biologika auftreten können, ist neben der ärztlichen Beratung auch ein wichtiger Teil der Beratung in der Apotheke. Die Möglichkeit der Apotheke von einer Ersetzung abzusehen, ergibt sich aus § 40c Absatz 5. Zur Berücksichtigung weiterer Produkteigenschaften siehe auch Bewertung zum Einwand 3.1.6.

Hinsichtlich des Austausches biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel zur Herbeiführung einer Schwangerschaft, für die nach § 27a Absatz 3 Satz 3 SGB V durch die Krankenkasse 50 vom Hundert der Kosten übernommen werden, gelten entgegen der Auffassung der Stellungnehmerin die allgemeinen Bedingungen des Biologika-Austausches nach § 129 SGB V und § 40c. Das Wahlrecht der Versicherten nach § 129 Absatz 1 Satz 6 SGB V

und § 40c Absatz 2 bezieht sich hier lediglich auf die von Seiten der Kasse zu übernehmenden 50 vom Hundert der Kosten des verordneten oder abzugebenden Arzneimittels.

Mit den Einwänden hat der G-BA sich in Teilen bereits im Stellungnahmeverfahren zum Beschluss vom 15. Juni 2023 zur Ergänzung der AM-RL um § 40b befasst; es wird ergänzend auf die Auswertung der Stellungnahmen in der Zusammenfassenden Dokumentation zu dem entsprechenden Verfahren verwiesen (verfügbar unter <https://www.g-ba.de/beschluesse/6045/>).

3.7 Stellungnahmen nicht stellungnahmeberechtigter Organisationen

Am 9. Juli 2025 ist eine Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Ophthalmochirurgen e. V. (BDOC) eingegangen, aus der sich keine weiteren Aspekte ergeben haben.

Mündliche Anhörung

gemäß § 91 Absatz 9 Satz 1 SGB V zur Änderung der
Arzneimittel-Richtlinie

des Gemeinsamen Bundesausschusses

**§ 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten
biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken**

Videokonferenz im Hause des Gemeinsamen Bundesausschusses in Berlin

am 11. November 2025

von 10:00 Uhr bis 11:25 Uhr

– Stenografisches Wortprotokoll –

Angemeldete Teilnehmende der Firma **AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG**:

Herr Rath

Frau Erhardt

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Alexion Pharma Germany GmbH**:

Frau Dr. Salmen

Frau Aurig-Schramm

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Amgen GmbH**:

Frau Camdere

Frau Friederich

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Bayer Vital GmbH**:

Herr Roskamp

Frau Mauss

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Biocon Biologics Germany GmbH**:

Herr Ganz

Herr Koch

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Biogen GmbH**:

Herr Röhrer

Frau Weiß

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Celltrion Healthcare Deutschland GmbH**:

Herr Berthold

Frau Woitschell

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Formycon AG**:

Frau Dr. Freudensprung

Herr Dr. Seidl

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Fresenius Kabi Deutschland GmbH**:

Herr Kogler

Herr Dr. Schmidt-Rimpler

Angemeldete Teilnehmende der Firma **GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG**:

Herr Dr. Karl

Frau Seidel

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Hexal AG**:

Herr Dr. Kirsch

Herr Dr. Müller

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Lilly Deutschland GmbH**:

Frau Baudisch

Frau Pfarr

Angemeldeter Teilnehmender der Firma **medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH:**

Herr Bahr

Angemeldete Teilnehmende der Firma **MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG:**

Frau Kahl

Herr Dr. Dr. Ammer

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Merck Healthcare Germany GmbH:**

Frau Kirst

Frau Giesl

Angemeldete Teilnehmende der Firma **MSD Sharp & Dohme GmbH:**

Frau Kadow

Frau Frénoy

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Novartis Pharma GmbH:**

Herr Stark

Herr Liegmann

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Novo Nordisk Pharma GmbH:**

Frau Dr. Kretzschmar

Frau Dr. Meckes-Ferber

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Pfizer Pharma GmbH:**

Frau Schubert

Frau Wörner

Angemeldete Teilnehmende der Firma **ratiopharm GmbH:**

Herr Brosch

Frau Radke

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Roche Pharma AG:**

Frau Dr. Roske

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH:**

Herr Gebhardt

Herr Dr. Bornholdt

Angemeldete Teilnehmende der Firma **STADAPHARM GmbH:**

Herr Fister

Herr Numrich

Angemeldeter Teilnehmender der **Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA), Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK):**

Herr Dr. Said

Angemeldete Teilnehmende des **Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e. V.:**

Herr Kretzschmar

Herr Jürgens

Angemeldete Teilnehmende des **Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI):**

Frau Lietz

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Pharma Deutschland e. V.:**

Frau ten Haaf

Angemeldete Teilnehmende der Firma **Pro Generika e. V.:**

Herr Bretthauer

Herr Wittkemper

Angemeldete Teilnehmende des **Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (vfa):**

Frau Melchior

Angemeldete Teilnehmende des **Verbandes der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker e. V. (VZA):**

Herr Feth

Frau Müller

Angemeldeter Teilnehmender der **Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ):**

Herr Prof. Dr. Mühlbauer

Angemeldete Teilnehmende der **Dermatologischen Gesellschaft (DDG) + Hautnetz Deutschland e. V.:**

Herr Prof. Dr. Augustin

Herr Dr. von Kiedrowski

Angemeldeter Teilnehmender der **Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e. V. (DGRh):**

Herr Prof. Dr. Fiehn

Angemeldete Teilnehmende der **Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen (DGVS) + Kompetenznetz Darmerkrankungen e. V.:**

Frau Prof. Dr. Siegmund

Angemeldete Teilnehmende des **Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin (DRFZ):**

Frau Prof. Dr. Strangfeld

Angemeldeter Teilnehmender der **Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR):**

Herr Dr. Urban

Angemeldeter Teilnehmender des **Krankheitsbezogenen Kompetenznetzes Multiple Sklerose (KKNMS)**:

Herr Prof. Dr. Gold

Angemeldeter Teilnehmender des **Psoriasis-Praxisnetzes Süd-West e. V.**:

Herr Prof. Dr. Termeer

Beginn der Anhörung: 10:00 Uhr

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen im Unterausschuss Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses! Wir haben uns hier zusammengefunden, um die mündliche Anhörung mit Blick auf eine angedachte Änderung des § 40c Arzneimittel-Richtlinie zu diskutieren und diese mündliche Anhörung durchzuführen. Es hat ein schriftliches Stellungnahmeverfahren gegeben, in dem drei Varianten – eine Position A, eine Position B1 und eine Position B2 – zur Stellungnahme gestellt worden sind.

In diesem Anhörungsverfahren sind fast 40 Stellungnahmen eingegangen. Ich muss an dieser Stelle zu Protokoll geben, wer eine Stellungnahme abgegeben hat. Ich mache das in alphabetischer Reihenfolge. Es sind Stellungnahmen eingegangen von: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Amgen GmbH, Alexion Pharma Germany GmbH, Bayer Vital GmbH, Biocon Biologics Germany GmbH, Biogen GmbH, Celltrion Healthcare Deutschland GmbH, Formycon AG, Fresenius Kabi Deutschland GmbH, GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Hexal AG, Lilly Deutschland GmbH, medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Merck Healthcare Germany GmbH, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis Pharma GmbH, Novo Nordisk Pharma GmbH, Pfizer Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, Roche Pharma AG, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, STADAPHARM GmbH, von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V., der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, dem Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e.V., dem Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V., von Pharma Deutschland e.V., Pro Generika e.V., dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V., dem Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker e.V., der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft gemeinsam mit dem Hautnetz Deutschland e.V., der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e.V., der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen gemeinsam mit dem Kompetenznetz Darmerkrankungen e.V., vom Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin, von der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie, vom Krankheitsbezogenen Kompetenznetz Multiple Sklerose und vom Psoriasis-Praxisnetz Süd-West e.V.

Wir führen die Anhörung dergestalt durch, dass ich zunächst die wesentlichen Einwände, die erhoben worden sind, vortrage, nachdem ich die Anwesenheit der angemeldeten Stellungnehmer überprüft habe. In dieser mündlichen Anhörung wird ein Wortprotokoll geführt. Wir haben die schriftlichen Stellungnahmen bereits ausgewertet. Wir haben uns damit beschäftigt. Das werden Sie sehen, wenn ich den Inhalt der Einwendungen vortrage, sodass die erste Runde in der Anhörung dergestalt ablaufen wird, dass die Bänke oder die Patientenvertretung die Möglichkeit haben, Fragen zu Ihren Stellungnahmen zu stellen. Ich möchte Sie darum bitten, auch die Bänke, dass jeweils ein Stellungnehmer adressiert wird, wenn eine Frage gestellt wird – wir haben heute über 68 Teilnehmer –, damit nicht jedes Mal 68 Personen zum gleichen Sachverhalt ausführen. Es sollte gezielt ein Stellungnehmer angesprochen werden.

Nach der Fragerunde der Bänke schauen wir, wie viel Zeit noch ist, ob wir möglicherweise zumindest den hauptbetroffenen Verbänden kurz die Möglichkeit geben, holzschnittartig ihre Positionen, die, wie gesagt, diskutiert und besprochen wurden, hier zu Gehör zu bringen.

Die externen Teilnehmer bitte ich darum, im Chat jeweils ein X zu setzen. Wir haben zwar einige Kacheln vor uns, aber wenn jemand winkt oder seine Hand hebt, dann können wir das nicht ordnungsgemäß nachverfolgen. Uns liegt sehr daran, dass die Anhörung heute formal ordnungsgemäß abläuft.

Ich werde also zunächst für das Wortprotokoll die Anwesenheit feststellen und dann den wesentlichen Inhalt der Einwendungen vortragen. Das geht wieder in alphabetischer Reihenfolge, damit ist keine Wertung in irgendeiner Form verbunden. Für AbbVie Deutschland müssten anwesend sein Herr Rath und Frau Erhardt, für Alexion Pharma Germany Frau Dr. Salmen und Frau Aurig-Schramm, für Amgen Frau Camdere und Frau Friederich, für Bayer Vital Herr Roskamp und Frau Mauss, für Biocon Biologics Germany Herr Ganz und Herr Koch, für Biogen Herr Röhrer und Frau Weiß, für Celltrion Healthcare Deutschland Herr Berthold und Frau Woitschell, für Formycon Frau Dr. Freudensprung und Herr Dr. Seidl, für Fresenius Kabi Deutschland Herr Kogler und Herr Dr. Schmidt-Rimpler, für GlaxoSmithKline Herr Dr. Karl und Frau Seidel, für Hexal Herr Dr. Kirsch und Herr Dr. Müller, für Lilly Deutschland Frau Baudisch und Frau Pfarr – fehlt –, für medac Herr Bahr, für MEDICE Arzneimittel Pütter Frau Kahl und Herr Dr. Dr. Ammer, für Merck Healthcare Germany Frau Kirst und Frau Giesl, für MSD Sharp & Dohme Frau Kadow und Frau Frénoy, für Novartis Pharma Herr Stark und Herr Liegmann, für Novo Nordisk Pharma Frau Dr. Kretzschmar und Frau Dr. Meckes-Ferber, für Pfizer Pharma Frau Schubert und Frau Wörner, für ratiopharm Herr Brosch und Frau Radke, für Roche Pharma Frau Dr. Roske, für Sanofi-Aventis Deutschland Herr Gebhardt und Herr Dr. Bornholdt, für STADAPHARM Herr Fister und Herr Numrich, für die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker Herr Dr. Said, für den Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker Herr Kretzschmar und Herr Jürgens, für den Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie Frau Lietz, für Pharma Deutschland Frau ten Haaf, für Pro Generika Herr Bretthauer und Herr Wittkemper, für den vfa Frau Melchior, für den Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker Herr Feth und Frau Müller, für die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft Herr Professor Dr. Mühlbauer – fehlt –, für die Deutsche Dermatologische Gesellschaft und das Hautnetz Deutschland Herr Professor Dr. Augustin – fehlt – und Herr Dr. von Kiedrowski, für die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie Herr Prof. Dr. Fiehn, für die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten und das Kompetenznetz Darmerkrankungen Frau Professor Dr. Siegmund, für das Deutsche Rheuma-Forschungszentrum Frau Professor Dr. Strangfeld, für die Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie Herr Dr. Urban, für das Krankheitsbezogene Kompetenznetz Multiple Sklerose Herr Professor Dr. Gold sowie für das Psoriasis-Praxisnetz Süd-West Herr Professor Dr. Termeer. Ist noch jemand in der Leitung, der nicht aufgerufen wurde? – Das ist erkennbar nicht der Fall.

Ich will kurz einführen, was in den Stellungnahmen im Wesentlichen vorgetragen worden ist: Bezogen auf § 40c Abs. 1, Allgemeine Bestimmungen zur Ersetzung, wird vorgetragen, dass der Begriff „preisgünstig“ zu unbestimmt sei; zudem wären dazu die Bestimmungen des Rahmenvertrags einschlägig.

Arzneimittel mit abweichenden Behältnissen, zum Beispiel Fertigpens, Fertigspritzen könnten trotz gleicher Darreichungsformbezeichnung nicht ausgetauscht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Hinweise in Anlage VII zu austauschbaren Darreichungsformen bislang fehlten. Der Begriff „Applikationsart“ sei zu unbestimmt.

Ein weiterer Einwand bezieht sich darauf, dass weitere Unterschiede der Arzneimittel bei Hilfsstoffen, Formulierungen, Injektionsvolumina, Lagerung, Haltbarkeit und Handhabung in der Regelung berücksichtigt werden müssten.

Ein wesentlicher Punkt ist die Übereinstimmung der Anwendungsgebiete. Hier wird darauf hingewiesen, dass der Austausch von Arzneimitteln mit nur einem gleichen Anwendungsgebiet, Position A, den Regelungen in § 40a für Ärzte und § 40b zur Ersetzung parenteraler Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln widersprechen würde. Diese Regelungen seien zudem eine Begünstigung für den OLU. Hierdurch würde die Patientensicherheit gefährdet, und es könne zu Nocebo-Effekten sowie sinkender Therapieadhärenz kommen.

Zu den Positionen B1 und B2 wird ausgeführt, dass mindestens übereinstimmende Anwendungsgebiete der Arzneimittel die Unterschiede im Zulassungsverfahren im Vergleich zu Generika am besten abbilden würden. Diese Regelung würde zudem die Therapiehoheit des Arztes erhalten. Bezogen auf die Ermöglichung des ärztlichen Ausschlusses der Ersetzung wird darauf hingewiesen, dass diese Regelung sinnvoll sei, aber das Wirtschaftlichkeitsrisiko und die Wirtschaftlichkeitsverantwortung einseitig auf Ärztinnen und Ärzte verlagere.

Zum § 40c Abs. 2, Bestimmungen zur Preisgünstigkeit, Vorrang von Rabattarzneimitteln, wird vorgetragen, dass der G-BA keine Befugnis zur Regelung der Preisgünstigkeit habe. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vorrang von Rabattarzneimitteln problematisch sei, da hierdurch häufig Umstellungen forciert würden, die unter anderem die Pharmakovigilanz erschweren.

Rabattvereinbarungen könnten die Gefahr von Anbietermonopolen befördern und dazu führen, dass es solche Monopole gebe und damit die Liefer- und Versorgungssicherheit gefährden. Es wird darauf hingewiesen, dass Vereinbarungen nach § 130c SGB V und festbetragsgeregelte Arzneimittel bei der Regelung der Preisgünstigkeit ebenso berücksichtigt werden.

In § 40c Abs. 3, Austauschverhältnisse, Zulassungszusammenhänge, wird ausgeführt, dass die Evidenzbasis für den Austausch von Biosimilars untereinander durch die Zulassung mit Bezug auf das Referenzarzneimittel bestünde. Dass bei solch einer Ersetzung aber vermehrt negative Effekte aufträten, sei weder belegt noch zu erwarten. Durch die sogenannte Mikroheterogenität bestünden Unterschiede zwischen Chargen eines Arzneimittels, sodass es bei Beibehaltung desselben Arzneimittels zu „Umstellungen“ komme.

Es wird vorgetragen: Eine Ersetzung von Biosimilars untereinander überschreite den gesetzlichen Regelungsauftrag. Eine hinreichende Vergleichbarkeit von Biosimilars untereinander sei nicht immer gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit der Ersetzung erst bei Vorliegen von Evidenz, Position B2, unrealistisch sei, da so der Apotheke unerlaubt die Beurteilung und Deutung der Daten auferlegt werde. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass zur mehrfachen Ersetzung wenig Evidenz vorläge und nur unter ärztlicher Aufsicht Aktivitäten entfaltet werden sollten. Mehrfache Umstellungen würden zudem die Aussagekraft von Registern schwächen.

Ein weiterer Einwand ist, dass ein einmaliger Wechsel zudem nicht umsetzbar sei, da Rabattarzneimittel wechseln, bei Lieferengpässen ein Ausweichen gestattet sein müsse und der Apotheke grundsätzlich keine Informationen über die Verordnungshistorie vorlägen.

Ein weiterer Einwand bezieht sich darauf, dass der Bezug auf Anlage VIIa für die Regelung auf Apothekenebene ungeeignet sei. Die Art der Darstellung und der fehlende Informationsgehalt zur therapeutischen Vergleichbarkeit führten zur Unklarheit hinsichtlich der Austauschbarkeit und erforderten mindestens eine Klarstellung. Sie müsste zudem abschließenden Charakter im Sinne einer Positivliste haben, um dem gesetzlichen Auftrag zu entsprechen.

Zu § 40c Abs. 4, Information und Beratung durch Apotheken, wird darauf hingewiesen, dass der Hinweis auf den bereits festgelegten Rahmen zur Information und Beratung durch Apotheken genüge. Es wird darauf hingewiesen, dass die Demonstration der Handhabung eines neuen Devices im Rahmen der Aufklärung und Beratung durch Apotheken zur Vermeidung von Anwendungsfehlern und zur Minimierung des Nocebo-Effekts zwingend erforderlich sei.

Des Weiteren kommt der Einwand, dass die Information an den Arzt über eine erfolgte Ersetzung inklusive Angabe des Handelsnamens und der Charge zur Gewährleistung der Pharmakovigilanz unerlässlich sei. Datenschutzkonforme Infrastruktur zur Dokumentation sei jedoch noch nicht vorhanden.

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Zusatzanforderungen zudem die Befugnisse des G-BA übersteigen würden.

Zu § 40c Abs. 5 haben wir den Hinweis zum Aufgreifen der bestehenden Regelungen zu pharmazeutischen Bedenken, dass Ausnahmeregelungen für Apotheken sinnvoll seien, aber ergänzt werden sollten, um mehr Rechtssicherheit für Apotheken zu gewährleisten.

Das sind im Wesentlichen die Punkte, die vorgetragen wurden und mit denen wir uns in der AG beschäftigt haben. Meine erste Frage an die Bänke und die Patientenvertretung: Gibt es von Ihnen konkrete Fragen an einzelne Stellungnehmende? – Herr Clausen, bitte.

Herr Clausen: Ich habe zwei Fragen an die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände und die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker. Ich habe in der Stellungnahme die Ablehnung der Austauschverpflichtung von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln gelesen. Unsere Position ist grundsätzlich dieselbe. Aber wenn es nun trotzdem zur Austauschverpflichtung in der Apotheke kommen sollte, machen wir uns als Deutsche Rheumaliga Sorgen um die sichere Anwendung und die Pflichten im Sinne der Pharmakovigilanz. Der Hintergrund ist, dass in der ärztlichen Verordnung zur Umstellung von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln von 2020 hervorgehoben wurde, dass der Wechsel der Biologika mit einer Information und einer Demonstration der Applikation des neuen ausgetauschten Arzneimittels einhergehen muss.

Meine erste Frage ist: Wie ist Ihre Einschätzung? Werden die Apotheken in Deutschland die Kapazitäten haben, den Betroffenen die andersartigen Pens und Fertigspritzen im Sinne einer sicheren Arzneimittelanwendung und besseren Therapieadhärenz zu demonstrieren?

Die zweite Frage: Da es sich bei den Biologika nicht um wirkstoffgleiche Arzneimittel handelt, wäre nach dem Austausch eine Information an die Ärzte im Sinne der Pharmakovigilanz aus unserer Sicht unumgänglich. Wie sonst sollten die Ärzte eventuelle Nebenwirkungen zuweisen können? Werden die Apotheken diese Informationen in Zukunft an die Ärzte weiterleiten? Können die das leisten? Ist das machbar?

Zusammengefasst: Können und werden die Apotheken in Deutschland diese beiden Aufgaben übernehmen und im Zweifel ohne extra Vergütung? Das sind meine beiden Fragen.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Herr Dr. Said, bitte.

Herr Dr. Said (ABDA + AMK): Vielen Dank an die befragende Position, die ich inhaltlich nur bestätigen kann. Die Notwendigkeit zur Schulung der Patienten ergibt sich in diesem neuen Kontext insbesondere für die Apotheken, da wir in einem neuen System, also weg von einer Austauschbarkeit hin zu einer grundsätzlichen Austauschpflicht gelangen, die entgegen einer vorherigen Schulung beispielsweise auf Verordnerebene nun bei der Apotheke auftritt und durchaus zu nicht konformen Schulungshinweisen aufgrund des rabattvertragsgesteuerten Austauschs hinlaufen. Das führt per se zu einer Verunsicherung.

Die Frage, ob die Apotheken das leisten können: Dass sie es sollten, steht im Sinne der Patientensicherheit außer Frage. Dass sie es können, halte ich für nicht realistisch. Das geht weit über das Maß der in § 20 Apothekenbetriebsordnung üblichen Beratungstätigkeit der Apotheke im üblichen Betrieb hinaus. Wir sprechen hier von intensivierter Schulung der Patienten, auch im Sinne der Anwendung durch den Patienten im Vorfeld letztlich in der Apotheke zuzusichern, dass die Anwendung sicher ist und entsprechend funktioniert.

Das hat auch in einem abgeschlossenen Rahmen stattzufinden, da es doch ein erheblicher Aufwand und Informationsfluss vonseiten der Apotheken in Richtung Patient und vice versa erfolgt. Dieser Rahmen der intensivierten Betreuung, Begleitung und Information der Patienten ist in der jetzigen Situation für Apotheken aus meiner Sicht nicht abbildbar.

Sie haben die Notwendigkeit der Vergütung genannt. Für diesen Rahmenkomplex, für diesen Mehraufwand braucht es entsprechend eine Vergütung. Gleichwohl sehen wir, dass das notwendig ist, das hat Herr Hecken schon vorangeschickt, das ist nicht eine Regelungskompetenz des G-BA. Das muss an der Stelle extra geregelt werden, und die Vergütung muss entsprechend der Beratungsleistung sein.

Der zweite Punkt, den Sie genannt haben, ist genauso richtig. Es braucht aus unserer Sicht den automatisierten IT-gestützten Informationsaustausch der Leistungserbringer, hier Verordner und Apotheker, im Benehmen mit den Patienten. Auch hierfür gibt es gute Gründe, die im Sinne der Pharmakovigilanz, Therapiesicherheit, Adhärenz etc. bestehen. Auch hier müssen wir konstatieren, dass die Rahmenbedingungen noch nicht stehen. Es kann nur auf einer aus unserer Sicht automatisierten IT-gestützten Infrastruktur bedingen. Eine Dokumentationspflicht darf der Apotheke nicht über das Maß aufgebürdet werden. Das muss durch die Abgabe im Warenwirtschaftssystem abgebildet sein und über eine Schnittstelle oder die ePA beispielsweise abgebildete Verbindung an die Verordner gelingen. Nur so kann das funktionieren.

Eine darüberhinausgehende schriftliche, händische, etwaige sonstige Kommunikation ist in der täglichen Arbeit der Apotheke nicht abbildbar. Das ist einfach Fakt. Die Notwendigkeit ist da, aber die Leistung unter den derzeitigen Kautelen nicht realistisch.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Herzlichen Dank, Herr Said. – Herr Clausen, ist die Frage beantwortet?

Herr Clausen: Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke. – Gibt es weitere Fragen? – Frau Sander, bitte.

Frau Dr. Sander: Herr Said, Sie haben sehr ausführlich geantwortet, aber um das konkreter zu machen: Selbst wenn Sie die Möglichkeit hätten, die Sie als schwierig dargestellt haben, diese Beratungstätigkeit, bräuchten Sie Demonstrationspens für jedes Biosimilar. Könnten Sie kurz für die Runde darlegen, wie viel Sie in den Apotheken zum Beispiel allein dafür vorhalten müssten, um für jeden Patienten und jede Patientin beim Austausch diese Demonstration leisten zu können?

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Herr Dr. Said, bitte.

Herr Dr. Said (ABDA + AMK): Das ist ein wichtiger Aspekt. Wir müssen einen Blick in die Lauer-Taxe, in die ABDA-Datenbank werfen, um zu sehen, wie vielfältig das Feld der Biologika, der Biosimilars ist. Eine konkrete Zahl an entsprechenden Dummy-Objekten kann ich nicht nennen, aber das geht in den hohen zweistelligen, niedrigen dreistelligen Bereich an Demonstrationsobjekten, die wir hier vorrätig halten müssten, um nicht nur die Schulung der Patienten objektiv darstellen zu können, sondern sich über die Anwendung durch den Patienten über die Apotheke rückzuversichern. Die Vorratshaltung, Lagerhaltung dieser Dummy-Objekte hätte letztlich jede Apotheke in Deutschland zu leisten, was derzeit in diesem Rahmen nicht üblich ist. Das ist eine weitere Verkomplizierung.

Ich benenne diesen grundlegenden Unterschied zwischen Fertigspritze und Fertigen: eine Selbstauslösung durch den Patienten, die Koordination dieser beiden Präparate ist grundlegend unterschiedlich von der Anwendung, Handhabung, Lagerung, auch die Injektionsvolumina können sich unterscheiden. Es geht um die Frage des Empfindens des Patienten. Das kann man an einem Dummy noch nicht absehen. Wenn sich durch die verschiedenen Applikationssysteme das Injektionsvolumen vergrößert oder die Dauer der Injektion verlängert, ist das über Dummies nicht abbildbar. Das Empfinden, Schmerzempfinden einer Injektion durch den Patienten ist grundsätzlich unterschiedlich.

Das sind Erfahrungswerte, die nur durch engmaschiges Monitoring und Rückversicherung bei der Apotheke im Nachgang zu etablieren sind. Die Begleitung dieser Patienten erfolgt notwendigenfalls und realistischerweise durch die Versorgung in der Apotheke. Das ist ein Aufwand, der mindestens zu berücksichtigen ist.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Herzlichen Dank, Herr Said. – Frau Sander, ist die Frage beantwortet?

Frau Dr. Sander: Ja, herzlichen Dank.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke. – Gibt es weitere Fragen? – Frau Mai, bitte.

Frau Dr. Mai: Der Austauschaspekt kann präparatbezogenen Auswirkungen auf nachgelagerte sicherheitsrelevante Aspekte haben. Im Therapiegebiet der multiplen Sklerose gibt es zum Beispiel einen Wirkstoff, der regelmäßig bestimmte Antikörper-Titer-Testungen zur Abschätzung des PML-Risikos nach sich zieht. Der Test wurde vom Originalhersteller entwickelt und ist an das Präparat gekoppelt. Für das Biosimilar hat der Hersteller seinerseits nach Markteintritt einen Test herausgebracht. Die Tests haben unterschiedliche Sensitivität. Deshalb meine Frage an den Experten vom KKNMS: Wie erfolgt der Ablauf dieses Risikomanagements, wenn es zu einem regelmäßigen Austausch in dieser Indikation kommt? Welche Auswirkungen und Risiken entstehen für den Patienten? Welche Auswirkungen hat es, wenn diese Tests gegebenenfalls immer wieder gewechselt werden?

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Herr Professor Gold, bitte.

Herr Prof. Dr. Gold (KKNMS): Es ist ein nachgelagerter Test, der essenziell ist. Als dieses hochwirksame Medikament Natalizumab vom Originalhersteller auf den Markt gebracht wurde, hatten wir innerhalb weniger Jahre 800 Patienten, bei denen das sogenannte JC-Virus ins Gehirn eindrang und in 70 bis 80 Prozent tödlich verlief. Mit der Einführung des Testes durch den Originalhersteller sank das extrem ab und wurde viel besser beherrschbar. Dieser Test wurde 2015 eingeführt und Stratify genannt. Ich habe keinerlei Eigeninteressen an diesen Tests oder anderen damit verbundenen Forschungsaktivitäten.

Mit dem Aufheben des Testes oder der exklusiven Zulassung für Natalizumab durch das Biosimilar Tyruko hat die Herstellerfirma Sandoz und damit inkorporierte Firmen nun einen eigenen Test, den ImmunoWELL-Test, hervorgebracht. Es gibt in der internationalen Literatur aus England, Frankreich, Niederlande insgesamt sechs völlig unabhängige Publikationen, auch von Professor Ziemssen aus Dresden – da bin ich auch nicht beteiligt –, die klar zeigen, dass dieser neue ImmunoWELL-Test leider doppelt so viele Patienten positiv macht.

Das würde jedes Mal, wenn dieser Test anfängt, eine ganze Reihe von Folgen haben. Man müsste ein Kernspin machen, um auszuschließen, dass es eine PML ist. Man muss Nervenwasser punktieren, ambulant oder stationär, um auszuschließen, dass das Virus im Nervenwasser ist. Man würde damit das Präparat absetzen. Es gibt die Gefahr eines Rebounds, wenn innerhalb von sechs Wochen nicht weiterbehandelt wird. Als MS-Expertin, Sie haben ein viel weiteres Feld, Herr Professor Hecken, hätte ich es für sinnvoll gehalten, wenn man so einen wichtigen Test wie den Stratify-Test vom Hersteller unabhängig als budgetrelevanten Test aufführen könnte, dann könnte jeder mit einem gut etablierten Test agieren, der nachweislich die PML-Zahlen um 80 Prozent gesenkt hat. Man bräuchte für diese Patienten nicht mögliche ständige Umstellungen. Die Engländer mit Dobson, 15 Autoren, Dobson, der erste Autor, Coles, der letzte Autor, Multiple Sclerosis Related Disorders, haben sogar eine nationale Stellungnahme zu diesem Problem veröffentlicht.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Herzlichen Dank, Herr Professor Gold. – Frau Mai, ist die Frage beantwortet, oder haben Sie eine Nachfrage?

Frau Dr. Mai: Ich habe eine Nachfrage: Was bedeutet das konkret für den Patienten? Sie haben die Rebound-Effekte genannt. Wie wird das momentan in der Versorgung gemacht? Was macht das mit den Patienten bei diesem Unwissen, auch, ob die Gefahr, diese PML zu entwickeln – – Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren.

Herr Prof. Dr. Gold (KKNMS): Ich antworte so weit, wie Frau Dr. Mai die Fragen gestellt hat. – MS-Medikamente sind sehr gut, aber auch sehr teuer geworden. Ich bin absoluter Anhänger, generisch umzustellen, wenn die Patente erloschen sind. Die Firma Biogen hat mit Natalizumab über 200.000 Patienten versorgt. Das war sehr wichtig. Patienten werden durch falsch positive Tests verunsichert. Wie schon gesagt, stellen Sie sich vor, in Ihrer Familie ist jemand, der plötzlich ein – –

(Tonausfall)

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Herr Professor Gold, Ihr Ton ist weg. Sie sind stummgeschaltet.

Herr Prof. Dr. Gold (KKNMS): Patienten werden verunsichert, da sie glauben, dass sie eine Gefahr haben können, das Virus mit 80 Prozent Todes- oder hoher Behinderungsrate in sich zu bringen und in sich zu haben. Das zieht Folgekosten für die Patienten nach sich. Das führt zu einer Verunsicherung der Therapie. Wir haben mit der modernen MS-Therapie Gott sei Dank eine normale Lebenserwartung unserer Patienten. Ich plädiere klar dafür: Die sinnvollste Lösung wäre, Generika beibehalten, aber einen belastbaren Test in ein gesondertes Zulassungsverfahren zu geben. Dann ist er für alle verfügbar, wird vom gesetzlichen Gesundheitssystem oder den privaten Kassen bezahlt. Dann ist dieses Problem zumindest aus meiner einfachen Sicht als Neurologe behoben. Wir bekommen mit dem ImmunoWELL-Test des Generikums leider doppelt so viele Positive mit den beschriebenen Folgen für die Patienten.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Vielen Dank, Herr Gold. – Frau Mai, bitte.

Frau Dr. Mai: Vielen Dank.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Frau Sander, bitte.

Frau Dr. Sander: Wir haben schon ein wenig aufgeklappt, was das zukünftig für die Versorgung bedeuten würde. Ich möchte zu dem Thema zurückgehen, dass die Handhabung der Patientinnen und Patienten nicht so adäquat geschult werden kann und die Kliniker, die wir vor Ort haben, also die Rheumatologen oder Gastroenterologen, fragen: Was würde es bedeuten, wenn die Patienten mit Pens oder Spritzen nach Hause gehen und diese nicht adäquat bedienen können und das Medikament entsprechend – – Wir reden hier, das haben wir schon festgestellt, nicht von preiswerten Medikamenten. Was würde das für die Versorgung bedeuten, und wie würde man damit in der Versorgung umgehen?

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Wir gehen die Fachgesellschaften der Reihe nach durch. Ich bitte darum, dass Sie Ihre grundsätzliche Position kurz zum Ausdruck bringen, wenn Sie diese Frage beantworten. Danach gebe ich Pro Generika die Möglichkeit, weil die eine sehr umfängliche Stellungnahme abgegeben haben, insgesamt zu diesem Verfahren etwas zu sagen. Für die Deutsche Dermatologische Gesellschaft Herr von Kiedrowski, bitte.

Herr Dr. von Kiedrowski (DDG): Was bedeutet das für die Patienten? Sie haben es indirekt beschrieben. Wenn die Applikation nicht funktioniert, habe ich entweder eine Fehlinjektion oder nur Teilinhalte der Lösung appliziert. Die Patienten sind verunsichert. Letztlich wird damit die Therapieadhärenz, aber auch die Wirkung von zum Teil repetitiv zu gebenden Medikamenten gefährdet. Wir kennen das. Im Endeffekt ist es so: Ich habe es gerade von den Apotheken gehört, es ist sehr schön, wenn dort alles vorgehalten werden muss und sogar für die Schulung gegebenenfalls Honorar gezahlt wird.

In der Dermatologie, in der Praxis, das gilt auch für Herrn Professor Termeer, haben wir das. Aber wir weisen persönlich in das beabsichtigte Biosimilar ein. Wir setzen auch Biosimilar ein. Das ist nicht die Frage. Aber wenn der Patient die Praxis verlässt, hat er dieses Applikationsmodul selber, und zwar in der Regel im Verum. Das heißt, wir stellen mit dem Medikament ein, um die Schmerzhaftigkeit, Reaktionen auf andere Volumen und so etwas beobachten zu können. Dann erst wird der Patient in die Heimbehandlung entlassen. Das ist ein geordneter Vorgang. Er muss zusätzlich bei uns eine Chargendokumentation weiterführen, um in der Folgezeit selbst bei ein und demselben Medikament über die Chargenkontrolle eine entsprechende Vigilanzprüfung zu haben.

Von daher kann ich nur sagen, eine automatische Substitution, abgesehen von der Verantwortung für mich als verordnender Arzt, ist undenkbar. Das ist die Position der DDG, des BVDD und der Dermatologie ganz allgemein.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr von Kiedrowski. – Für die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie Herr Professor Dr. Fiehn, bitte.

Herr Prof. Dr. Fiehn (DGRh): Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie hat sich die Meinung gebildet, dass Substitution prinzipiell möglich sein könnte und dass es möglich wäre. Aber das hängt daran – das habe ich bei allen im Berufsverband abgefragt –, dass die Apotheken in der Lage sind, die Schulung zu übernehmen. Bei uns Rheumatologen ist es in unserer Versorgungssituation so, dass wir unmöglich zwischendrin noch große Mengen an Patienten auf andere Pens umschulen müssen. Es müsste aus unserer Sicht entweder eine Standardisierung der Pens geben, das ist aber vielleicht in weiter Zukunft, dass sie alle gleich sind, oder ein Commitment der Apotheken, die Schulungen in adäquater Weise zu machen, was bei der Informationspflicht der Apotheken möglicherweise gegeben sein könnte.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Professor Fiehn. – Für die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten zusammen mit dem Kompetenznetz Darmerkrankungen, Frau Professor Dr. Siegmund, bitte.

Frau Prof. Dr. Siegmund (DGVS + Kompetenznetz Darmerkrankungen): Unsere Position ist klar. Es kann eine einmalige Umstellung auf ein Biosimilar erfolgen. Man sollte aber dann bei diesem Biosimilar bleiben. Die Schulung erfolgt bei uns. Wir haben ausgebildete CED-Fachkräfte aus der Pflege, die diese Schulungen durchführen, die für die Patientinnen und Patienten im Verlauf Ansprechpartner/-partnerinnen sind, wenn es zu Problemen kommen sollte, wenn die Patientinnen und Patienten die Medikamente zu Hause selber applizieren.

Ich erachte es als absolut notwendig, dass man als Arzt/Ärztin nachvollziehen kann, welches Präparat gegeben wird, weil es auch zu lokalen Reaktionen kommen kann. Man kann dann unter Umständen noch einmal wechseln oder ist sogar gezwungen, auf das Originalpräparat zurückzugehen. Aber ich glaube, hier eine enge Kommunikation mit dem Patienten und ein vertrauensvolles Arzt/Patient-Verhältnis ist hier essenziell. Sonst haben die Patienten das Gefühl, sie haben kein Vertrauen mehr in das Medikament, das sie nehmen. Das kann problemlos auch für die Biosimilars etabliert werden. Aber ich glaube, deshalb muss man bei einem Präparat bleiben, A und B, und die Patientinnen und Patienten dafür adäquat schulen.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Vielen Dank, Frau Professor Dr. Siegmund. – Für das Deutsche Rheuma-Forschungszentrum Berlin Frau Professor Strangfeld, bitte.

Frau Prof. Dr. Strangfeld (DRFZ): Ich kann mich dem im Wesentlichen anschließen, was gesagt wurde. Ich bin der Meinung, dass es bei älteren Patientinnen und Patienten – diese Subgruppe kam noch nicht zur Sprache – besonders wichtig ist, dass man eine Kommunikation erhält und das Vertrauensverhältnis bestärkt. Gerade hier sehen wir große Adhärenzprobleme. Gerade für diese Patientinnen und Patienten ist es schon bei unterschiedlichen Tabletten schwierig, aber bei unterschiedlichen Pens, Fertigspritzen und sonst etwas wird es dann ganz schwierig.

Ein zweiter Punkt ist: Die Nachvollziehbarkeit, die Dokumentation in den Registern halte ich für extrem wichtig; denn wir sehen, bereits jetzt gibt es unterschiedliche Begleitterscheinungen. Bei dem einen Präparat ist es ein Brennen, bei dem anderen Präparat eine Rötung, bei wieder einem anderen ist es ein Schmerz, der vielleicht nach einer gewissen Zeit weggeht, aber erst einmal da ist. Das sind alles Dinge, die verunsichern und, wie Herr von Kiedrowski sagte, sowohl die Adhärenz als auch die Wirksamkeit beeinträchtigen.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Frau Professor Strangfeld. – Für die Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie Herr Dr. Urban.

Herr Dr. Urban (GKJR): Vonseiten der Kinder- und Jugendrheumatologie vertreten wir, dass die Biologika nicht ausgetauscht werden sollten. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Wenn ich ein ein bis zwei Jahre altes Kind in der Apotheke habe und es soll plötzlich auf ein anderes Device geschult werden, ist das wie ein Überfahren der Kinder oder Patienten mit einem Lkw. Das erfordert Erfahrung und Vertrauen. Ich weiß nicht, ich möchte den Apothekern nicht zu nahe treten, ob sie wirklich in der Lage sind, das für Kinder und

Kleinkinder entsprechend zu schulen und beizubringen. Die Apotheker müssen in sich gehen, ob sie das wirklich für diese jungen Patienten entsprechend leisten können. Grundsätzlich arbeiten wir regelmäßig mit Biologika, aber ein Austausch sollte, denke ich, vom Arzt und einer Vertrauensperson koordiniert sein und bitte nicht automatisch in der Apotheke erfolgen.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Dr. Urban. – Für das Krankheitsbezogene Kompetenznetz Multiple Sklerose Herr Professor Gold, bitte.

Herr Prof. Dr. Gold (KKNMS): Ich sehe im Moment bei den verfügbaren Generika für die Verabreichung kein Problem. Beides sind Infusionen. Ich sehe aber ein nachgeordnetes Sicherheitsproblem in diesem nicht mit der Zulassung verknüpften Test.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Professor Gold. – Für das Psoriasis-Praxisnetz Süd-West Herr Professor Termeer, bitte.

Herr Prof. Dr. Termeer (Psoriasis-Praxisnetzes Süd-West): Den medizinischen Aspekten schließe ich mich vollständig an. Wir möchten die wirtschaftlichen Aspekte anführen. Die sind uns aus praktischer Sicht relativ unklar. Wir haben einen hohen Konkurrenzdruck im Markt. Für jedes unserer Produkte, Biosimilars, die wir haben, sind mindestens sieben Mitbewerber vorhanden. Außerdem haben wir Selektivverträge mit den Krankenkassen, die sogar ein Aut idem für das Originalpräparat einfordern, das dann rabattiert ist. Das heißt, die beste Wirtschaftlichkeit erreichen wir aktuell in der Dermatologie, wenn wir ein vorgegebenes Produkt verordnen und den Patienten daran binden. Das bedeutet die größte Wirtschaftlichkeit für die Kostenträger. Insofern ist uns die Austauschbarkeit aus Wirtschaftlichkeitsaspekten unklar.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Professor Termeer. – Ich gebe jetzt Pro Generika das Wort, weil Sie, wie gesagt, die umfänglichste Stellungnahme abgegeben haben, damit Sie Ihre Sicht der Dinge zu Protokoll geben können. Herr Bretthauer, bitte.

Herr Bretthauer (Pro Generika): Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich möchte im Interesse Ihrer und unser aller Zeit nicht wiederholen, was insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter der Fachgesellschaften qualifizierter, als ich das je kann, vorgetragen haben. Dem schließen wir uns vollumfänglich an. Deshalb sind wir sowohl aus pharmazeutisch-medizinischer Sicht als vor allem auch aus wirtschaftlicher Sicht gegen die automatische Substitution von biologischen Fertigarzneimittel in der Apotheke.

Ich will uns noch einmal kurz in den Regelungskontext holen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, weil sich viel verändert hat. Wir reden von einem gesetzgeberischen Mandat, das aus dem Jahr 2019 kommt. 2019 gab es ein Gesetz, das ausschließlich – meine Vorredner haben das gerade beschrieben – auf die Wirtschaftlichkeit gesetzt hat, nicht auf diversifizierte Lieferketten, nicht auf Standortaspekte, Versorgungssicherheit, sondern Aussicht auf Einsparung. Das wissen Sie.

Es gibt den ersten Schritt bei der Substitution bei den parenteralen Zubereitungen. Ich denke, für unseren Kontext hier ist wichtig, dass es seitdem bei der Gesetzgebung einen politischen Paradigmenwechsel gegeben hat. Lassen Sie mich nur drei Namen von Gesetzen nennen, die stärker auf die Stärkung von Produktion, Stärkung von Versorgungssicherheit und eine stärkere Balance von Einsparung und Versorgungssicherheit setzen: Das ist einmal das ALBVVG, das Sie aus dem Bereich der Generika sicherlich kennen, dann gibt es auf EU-Ebene den Critical Medicines Act und den Biotech Act, die in Kürze verabschiedet werden sollen. Denen ist allen gemein, dass man Standortversorgungssicherheit stärken und Abhängigkeiten reduzieren will.

Deshalb, denken wir, ist der Schritt der automatischen Substitution, der unserer Wahrnehmung nach vor allen Dingen wirtschaftlich motiviert ist, nicht der richtige Schritt, weil wir politisch in einer Zeit leben, in der es viel stärker um einen stärkeren Ausgleich der legitimen Interessen der GKV zur Einsparung, aber vor allen Dingen auch eine sichere und diversifizierte Versorgung geht.

Ich glaube, was wichtig ist, der eine oder die andere von Ihnen bekommen das in den politischen Debatten mit: Meine Wahrnehmung ist: Sollte der G-BA dennoch die automatische Substitution beschließen, gibt es weitgehenden politischen Kontext, dass es einer gesetzgeberischen Begleitregelung bedarf. Herr Dr. Said hat das für die Apothekerinnen und Apotheker angesprochen.

Ich will das hier im Hinblick auf die nötige Übereinkunft der Ziele ansprechen, die insgesamt uneingeschränkt sind. Was wollen wir alle miteinander? Wir wollen vor allen Dingen die Versorgungssicherheit für die Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig soll es höhere Einsparungen für die GKV geben. Es soll aber auch, anders als früher, da haben wir den politischen Paradigmenwechsel, diversifizierte Lieferketten geben, die in Erstattungsregelungen abgebildet werden. Es muss eine rechtssichere Umsetzung geben. Das klingt für Sie, da der eine oder andere Jurist ist, banal, ist aber ein extrem wichtiger Punkt an der Stelle. Es muss ein Modell geben, das sofort von den Krankenkassen rechtssicher ausgerollt werden kann.

Deshalb ist dieser Konsens, dass es für den Fall dringend eine politische Begleitung braucht, sollte der G-BA die automatische Substitution beschließen, aus unserer Sicht absolut wichtig. Es gibt übereinstimmende Ziele. Aus unserer Sicht ist wichtig, dass die beiden Prozesse, also ein möglicher G-BA-Beschluss und eine politische Begleitung desselben, zeitlich miteinander synchronisiert sind. Es gibt einen Vorschlag, den der eine oder andere von Ihnen vielleicht kennt, der auf dem Tisch liegt, den ich abschließend im Hinblick auf unser aller Zeit nicht im Detail erläutern will. Ich habe die Bedenken vom multiplen Switch, vom höheren Beratungsaufwand bei Apothekerinnen und Apothekern bis hin zu der Frage, ob das möglich ist, ob das möglicherweise seinerseits Kosten in Apotheken verursacht, die gesondert abzubilden sind, gehört. Es gibt auch beim Switch immer wieder das Thema, dass es zwischen Apotheken und Ärzteschaft Abstimmungsbedarf gibt, der nicht immer und nicht leicht digital erfolgen kann, wie wir alle wissen. Es gibt den Vorschlag, wie man das alles miteinander übereinander bekommen und umsetzen kann und Nocebo-Effekte vermeidet.

Also insofern ist meine Botschaft vor allen Dingen die, dass es aus unserer Sicht die automatische Substitution nicht braucht, weil wir dort mehr Risiken sehen. Um die Risiken abzufedern, muss für den Fall, sollte das der G-BA doch entscheiden, zeitnah eine politische Begleitgesetzgebung sein, die Versorgungssicherheit und diversifizierte Lieferketten ermöglicht, aber vor allen Dingen den hier in der Anhörung vorgetragenen Anliegen der Fachgesellschaften Rechnung trägt im Hinblick auf: kein multipler Switch, kein höherer Beratungsaufwand für Apothekerinnen und Apotheker. Dieser Vorschlag liegt in Form einer Weiterentwicklung des bestehenden Open-House-Modells auf dem Tisch. – Hier mache ich einen Punkt. Für weitere Nachfragen stehe ich gern zur Verfügung. Aber der Punkt ist mir von Herzen wichtig. Herzlichen Dank.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Herzlichen Dank, Herr Bretthauer. – Herr Clausen von der Patientenvertretung hat sich noch einmal gemeldet. Bitte schön.

Herr Clausen: Ich hatte noch eine zweite Frage, und zwar an das Deutsche Rheuma-Forschungszentrum als Vertreter für die Registerbetreiber. Wir haben auf die Pharmakovigilanz hingewiesen und sehen da Probleme, auch in Bezug auf die Risk-Management-Pläne. Die Frage an Frau Professor Strangfeld ist: Wenn in Zukunft bei unveränderter Telematik-Struktur, wie sie jetzt ist, keine präparatspezifischen Auswertungen der Register mehr möglich sind, konterkariert das nicht die Verträge zwischen der EMA und den pharmazeutischen Unternehmen? Müssen die pharmazeutischen Unternehmen dann ihre Risk-Management-Pläne ändern? Und wie ist das für Sie, weil das RABBIT-Register auch von der pharmazeutischen Industrie gefördert wird? Und wenn die jetzt keine präparatspezifischen Auswertungen mehr bekommen, sehen Sie da Probleme? Droht da ein Verlust eines massiven Pfeilers des Pharmakovigilanz-Systems in Deutschland?

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Frau Professor Strangfeld, bitte.

Frau Prof. Dr. Strangfeld (DRFZ): Ja, dem wäre so. Die Risk-Management-Pläne fordern einen eindeutigen Bezug auf das jeweilige Produkt, und das können wir dann nicht mehr sicherstellen. Man kann, wie ich vorhin sagte, selbst solche leichten Begleiterscheinungen wie Brennen, Rötung usw. dann nicht mehr nachvollziehen. Wir sind dabei, eine Lösung mit App-Anbindung und über das RheDAT-System usw. usf. zu finden, aber das ist alles noch nicht fertig. Irgendwann hoffen wir auf eine datenschutzkonforme Lösung, die das ermöglichen würde. Das Problem der Informationspflicht und Handhabbarkeit würde damit nicht gelöst. Aber wahrscheinlich würden die bessere Dokumentation und die Auswertung in der Pharmakovigilanz verbessert werden.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Herzlichen Dank, Frau Professor Strangfeld. – Ich schaue in die Runde der anderen Stellungnehmenden. Die Fachgesellschaften hatten sich geäußert, Pro Generika hat sich geäußert. Gibt es aus Sicht der anderen Stellungnehmenden noch Dinge, die Sie über das hinaus, was in Ihren Stellungnahmen steht, hier zu Gehör bringen möchten? Oder möchten Sie noch irgendetwas besonders unterstreichen? Die wesentlichen Punkte sind genannt worden.

Frau Kirst (Merck Healthcare): Ich möchte gerne im Gesamtkontext noch einen wichtigen Punkt für die Patienten herausstellen. Anders als bei den anderen Therapien müssen in der Kinderwunschbehandlung, die wirklich eine Kurzzeitbehandlung darstellt, die Paare sowohl die Hälfte der Arzneimittelposten als auch der Arztkosten selber tragen. Daher sollte der Apotheker nicht über den Kopf der Patienten hinweg die Therapieentscheidung des Arztes revidieren. Die klinische Evidenz zeigt auch, dass bei Biosimilars die Lebendgeburtenrate signifikant geringer ist als bei den Originalen. Das heißt, ein erfolgloser Behandlungsversuch bedeutet einen zusätzlichen und potenziell vermeidbaren Therapiezyklus. Das bedeutet enorme Folgekosten für die Kasse und das Paar sowie eine extrem hohe emotionale Belastung für das Paar. Ein Austausch durch die Apotheke ist nicht angebracht, weil es die sorgfältige Therapieauswahl des Arztes für die individuelle Patientin untergräbt. Deshalb spricht sich Merck dafür aus, die Therapien der Reproduktionsmedizin von einer Austauschbarkeit auf Apothekenebene auszuschließen, wie dies beispielsweise in Norwegen und Finnland entschieden wurde.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Frau Kirst. – Herr Kirsch, bitte.

Herr Dr. Kirsch (Hexal): Ich wollte einen Punkt von Herrn Gold kommentieren. Es ist das Thema MS aufgekommen. Wir sind auch Anbieter einer entsprechenden Therapie und haben das Themenfeld in der Stellungnahme problematisiert. Ich glaube, es ist ein sehr geeignetes, darzustellen, dass es doch in vielen Indikationsgebieten therapeutische Besonderheiten gibt, auch in Assoziation mit dem Testökosystem, was sehr wohl Einfluss auf klinische Outcomes, auf Adhärenz oder auch auf immunologische Parameter nehmen kann.

Diesen Grund hat der Gesetzgeber sehr klar formuliert, dass er für die Austauschbarkeit eine produktbezogene und wirklich einzelfallorientierte Bewertung der therapeutischen Vergleichbarkeit fordert, die zur Grundlage einer Substitutionsentscheidung gemacht werden muss. Es gibt andere Bereiche, wir haben sie heute gehört, wie Pädiatrie, Geriatrie, wo das sicherlich gleichermaßen wichtig ist. Das lässt der G-BA in der aktuellen Beschlussfassung schmerzlich vermissen. Das wollte ich noch einmal hervorheben, weil es zu diesem Punkt gehört. Wir haben eher eine generelle Substitutionsvermutung oder einen generellen Automatismus, weil auch die Forderung des G-BA seinerzeit, im GSAV zur Bewertung dieser Zusammenhänge Einblick in die Zulassungsunterlagen zu erhalten, nicht ersichtlich ist, inwiefern das überhaupt erfolgt ist.

Aus unserer Sicht muss diese Regelungslücke dringend geschlossen werden, um den hier vorgetragenen Problemstellungen und Einwänden wirklich im Sinne der Arzneimittelsicherheit Rechnung zu tragen. Das gilt auch und insbesondere für das intensiv von den Fachgesellschaften vorgetragene Thema des problematischen Mehrfachtauses bei Devices. Wir haben eine Situation – das wurde von Ihnen schon erwähnt, Herr Professor

Hecken –, dass wir in diesen Therapien Darreichungsformen im Verhältnis haben. Wir haben aber für die Device-Thematik heute eigentlich keine systematische Lösung, denn in Anlage VII der Arzneimittel-Richtlinie Teil A, haben wir bisher keine Darreichungsformen von biologischen Arzneimitteln als austauschbar gelistet.

Wir können uns heute eigentlich nur am IFA-Kürzel entlanghangeln, aber das hat keinen einheitlichen Bezug zu den maßgeblichen Combined Terms. Wenn die Beschlussfassung so in Kraft tritt, können Situationen entstehen, wo wir am Ende Fertigspritzen mit Pens austauschen müssen. Das wird sozusagen das ganze Thema Devices, das von den Fachgesellschaften kommentiert wurde, völlig ad absurdum führen und dieses Problem maximal vergrößern. Also auch an dieser Stelle besteht Regelungsunklarheit und auch hier insofern noch einmal der Appell: Der G-BA muss bei dieser Thematik Abhilfe schaffen und diese Regelungslücken dringend schließen.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Kirsch. – Frau Meckes-Ferber, bitte.

Frau Dr. Meckes-Ferber (Novo Nordisk): Ich wollte mich dem anschließen und ergänzen, dass es nicht nur um Fertigspritzen und Fertigpens geht, sondern auch um wiederverwertbare Pens, die für die Patienten eine ganz andere Handhabung haben. Wenn die Patienten gewohnt sind, die Pens wegzwerfen und zu Hause vielleicht einen wiederverwendbaren Pen wegwerfen und dann in der Apotheke nur die Ampulle bekommen, um diesen Pen zu befüllen und den Pen nicht mehr haben, könnten da Versorgungslücken auftreten.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Frau Meckes-Ferber. – Herr Wittkemper, bitte.

Herr Wittkemper (Pro Generika): Ich würde gerne noch einmal die mittelfristige Perspektive dieser potenziellen Entscheidung aufzeigen. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich sehen, dass die Arzneimittelkosten inzwischen schon die 60 Milliarden Euro Ausgaben erreichen können, ein Block, der größer ist als die Ausgaben für die gesamte ambulante ärztliche Versorgung, und wir reden von circa 50 Prozent, 30 Milliarden Euro ungefähr durch biotechnologisch hergestellte Arzneimittel, davon wiederum circa 3 Milliarden Euro für die Biosimilars. Wir sehen das Risiko der Substitution vor allem darin, dass damit der Abschluss exklusiver Rabattverträge ermöglicht wird, eine Entwicklung, die, wie wir mittelfristig gesehen haben, auf die Versorgungssicherheit bzw. die technologische Souveränität Einfluss hat und die wir versuchen, jetzt mit Gesetzgebung ein wenig zu heilen und wie Sie vielleicht lesen können, doch mit eher bescheidenem Erfolg. Wir haben bereits Rabattverträge für über 90 Prozent, sogenannte offene Verträge, Open-House-Verträge.

Ich muss noch kurz eine Aussage korrigieren, die hier gekommen ist: Wir haben im Durchschnitt bei Biosimilars 4,4 Biosimilars für ein Referenzprodukt. Das heißt, nur in einzelnen Bereichen können wir von einer sehr großen Anbietervielfalt ausgehen. Bei Generika sehen wir typischerweise eher 10 bis 15 Anbieter nach einem Patentablauf. Wir sehen also, dass hier bereits massive Einsparungen passieren. Wir haben das vom IGES-Institut ausrechnen lassen. Wir haben gesehen, dass im letzten Jahr circa 1,7 Milliarden Euro von diesen 3 Milliarden Euro bereits durch diverse Kosteneinsparungsinstrumente, vor allem den Open-House-Verträgen, aber auch den sonstigen gesetzlichen Rabatten eingespart werden. Das heißt, die Frage des mittelfristigen Kostenanstiegs werden wir bestimmt über die Biosimilars nicht gelöst bekommen. Unsere Sorge ist, dass damit Forschungs- und Entwicklungshemmnisse entstehen, die dafür sorgen, dass in Zukunft weniger Biosimilars auf den Markt kommen, die diesen Wettbewerb, der hier angesprochen wird, nicht mehr ermöglichen und dadurch auch mittelfristig Einsparungen reduzieren.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Wittkemper. – Herr Koch, Frau Schubert und Herr Said. Danach schließe ich die Rednerliste. Herr Koch, bitte.

Herr Koch (Biocon Biologics): Ich möchte ergänzend zu den Aussagen von Herrn Dr. Said darauf hinweisen, ich glaube, das war die erste und wichtigste Frage, die Umsetzung

überhaupt: Herr Dr. Said sagt, Umsetzung nicht realistisch. Das möchte ich unterstreichen. Wir haben in den letzten drei Jahren fast 2.000 Apotheken verloren, und die Anzahl der Apothekenschließungen steigt stark an. Das Apothekenreformgesetz sieht allerdings andere neue Aufgaben für die Apotheken vor, pharmazeutische Dienstleistungen, um dem Rückgang der Hausärzte in der Prävention mit niederschwelligem Zugang entgegenzutreten. Wenn ich die Aufgaben vom Apotheker gemacht haben möchte, sehe ich überhaupt keine Zeit für das eine oder das andere. Die Prävention Impfen in der Apotheke ist zurzeit rückläufig. Den Zeitaufwand in der Apotheke für die Tätigkeit des Austausches sehe ich, um noch einmal zu unterstreichen, was Herr Dr. Said gesagt hat, für die Umsetzung in der Apotheke als vollkommen unrealistisch an.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Koch. – Frau Schubert, bitte. Frau Schubert? – Sie hat Tonprobleme, man hört sie nicht. Dann zunächst Herr Said, bitte.

Herr Dr. Said (ABDA + AMK): Vielen Dank, Herr Professor Hecken, für die Möglichkeit, noch einmal ein Statement zu geben, um es auch in den Kontext – –

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Sie wurden von Herrn Koch direkt angesprochen, dann passt es.

Herr Dr. Said (ABDA + AMK): Ja, genau. Ich kann das nur unterstützen. Herr Koch hat auch diese begleitenden gesetzgeberischen Maßnahmen mit möglichen Dienstleistungen angedeutet, die sich derzeit auf Autoinjektoren – als Wording ungeeignet – für diese Maßgabe hier beziehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte an der Stelle herausstellen, dass wir uns nicht gegen den Austausch von Biosimilars per se stellen, wohl aber für eine verantwortbare und rechtssichere Umsetzung in den Apotheken plädieren, und die – das haben wir heute in diesem Rahmen gehört – ist an vielen Stellen nicht gegeben. Die Apotheken kämpfen ohnehin schon mit ihren personellen, finanziellen und anderen Ressourcenproblemen.

In dem Verfahren der mündlichen Anhörung ist häufiger – ich zitiere – die Kompetenz des Heilberufs Apotheker abgesprochen worden, oder der Apotheker würde sich letztlich über die Maßnahme des Verordners hinwegsetzen. Dem möchte ich begegnen. Es ist so, dass die Apotheke am Ende das umzusetzen hat, was rabattvertragsgesteuert vorgegeben wird. An der Stelle sieht man auch, dass beide Heilberufsgruppen, Apotheker und Ärzte, ohne die notwendige Kommunikation durchaus sehr kritisch auf diesen Aspekt sehen können, nämlich, dass wir uns dann gegenseitig aufgrund dieser Notwendigkeit in der Beratung, in der Patientenbegleitung konterkarierend interpretieren. Ich möchte dem entschieden widersprechen, dass sich die Apotheken über die Köpfe der Ärzte hinwegsetzen würden, sondern sie würden rabattvertragsgesteuerte Substitutionen ausüben müssen.

Sie haben die Möglichkeit, pharmazeutische Bedenken anzumelden. Wir wissen aber auch, dass gerade bei den Hochpreiskern die Retax-Risiken bestehen. Insofern ist das ein Aspekt, der heute in diesem Stellungnahmeverfahren der mündlichen Anhörung herauskam, dass wir uns auf Heilberufsebene durchaus sehr kritisch gegeneinander begleiten, und das ist ein Rand- und Nebenaspekt, den ich auch heute wieder gesehen habe, der durch dieses Verfahren nicht förderlich ist.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Wobei ich sage, dieses Verfahren ist, glaube ich, nicht die Causa für bestimmte Dinge, die insgesamt nicht optimal laufen. Da haben wir in den letzten Wochen unabhängig davon Diskurse gesehen. Also vor diesem Hintergrund, sage ich einmal, ziehe ich mir den Schuh jedenfalls nicht an. – Jetzt bitte Frau Schubert.

Frau Schubert (Pfizer): Ich hoffe, man hört mich jetzt.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Ja, wunderbar.

Frau Schubert (Pfizer): Der Gesetzgeber hatte mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz dem G-BA aufgegeben, im ersten Schritt Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen

Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendungen bei Patientinnen und Patienten zu geben. Auf diese Weise sollten eine kritische Begleitung der Patientensicherheit und eine engmaschige Evaluation möglicher Versorgungsrisiken ermöglicht werden. Aus unserer Sicht muss vor einer Fortschreibung und Ausdehnung der Austauschbarkeit diese datengestützte Evaluation des § 40b Arzneimittel-Richtlinie stehen. Uns ist nicht bekannt, dass es eine solche Evaluation gab, dass eine solche Evaluation durchgeführt worden ist und dass diese Ergebnisse mit dem Gesetzgeber und der Fachöffentlichkeit geteilt wurden.

Insbesondere stellen wir uns bei einer solchen Analyse die Frage, inwieweit die Austauschbarkeit von Fertigarzneimitteln bei parenteralen Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung auf die Versorgung mit Fertigarzneimitteln übertragen werden kann, denn das ist eine unmittelbare ärztliche Anwendung und bei diesen kommt es nicht zu einem vergleichbaren Nocebo-Effekt. Das muss betrachtet werden, und auch der Zeitraum ist sehr knapp. Die Austauschbarkeit bei den Parenteralia wurde erst vor ungefähr einem Jahr scharfgestellt und auch, dass die ersten Rabattverträge ausgeschrieben wurden, das heißt, ein sehr knapper Zeitraum, der betrachtet werden kann, um aussagefähige Daten zu sammeln. Das müssten wir einmal kritisch beleuchten.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön. – Ich kommentiere gemeinhin Stellungnahmen und Äußerungen nicht. Wenn man in diesem Zusammenhang und bezogen auf den heutigen Tag ausgehend von der gesetzlichen Genese von knappen und möglicherweise sogar überraschenden Effekten spricht, dann bin ich dadurch etwas verstört. Wir haben vor vielen Jahren eine weitgehende gesetzliche Regelung gehabt, dann gab es Kommando zurück. Dann haben wir in einem ersten Schritt geregelt, Austausch beim Doktor, was kein Austausch, sondern eine normale ärztliche Therapieentscheidung, Switch ist. Danach haben wir parenterale Zubereitungen diskutiert, da haben wir Teile der heutigen Diskussion schon einmal durchexerziert, nämlich die Frage, wie die Apotheke mit dem Doktor kommuniziert. Liest beim Doktor überhaupt jemand, ob es ausgetauscht worden ist? Kommt es zu massenhaften, schwierigen Problemen? Kann der Arzt oder das ärztliche Fachpersonal jeweils im Einzelfall im Falle des Austausches den Patienten entsprechend informieren? Da geht es nicht um die Applikation, die dann beim Arzt vorgenommen wird.

Die Diskussionen haben wir geführt – Sie erinnern sich vielleicht düster, ich erinnere mich, weil ich seit 14 Jahren hier auf diesem Stuhl verweile –, und damals habe ich gesagt, in zwei Jahren wird der G-BA den nächsten Schritt gehen. Wenn Sie das jetzt einmal hintereinander nehmen, dass zwischen der Beschlussfassung und der dann tatsächlichen Umsetzung der Austauschbarkeit zwischen Apotheke und Arzt wegen diverser Vereinbarungen, die eine gewisse Zeit gebraucht haben, einige Monate lang, sind wir jetzt fast zwei Jahre später. Vor diesem Hintergrund sehe ich die Probleme, die heute vorgetragen worden sind. Die müssen wir abwägen, aber dass hier Hals über Kopf jetzt irgendetwas gemacht wird, das irritiert mich ein klein wenig. Aber sei es drum, es muss auch Dinge geben, die mich irritieren.

Ich bin dankbar dafür, dass von allen auf die Probleme hingewiesen worden ist, die es geben kann, wenn Devices wechseln. Ich sage aber, die Diskussion, die wir hier geführt haben, haben wir so schon 422 Mal bei Festbetragsgruppen im normalen Bereich geführt, wo es zwar nicht um biologische Arzneimittel ging, die mit diesen Devices verabreicht werden, aber wo es auch um wesentliche Unterschiede in den Devices und um die Fragestellung ging, ob es zumutbar ist, in solchen Fällen im Rahmen einer Festbetragsgruppenbildung die Austauschbarkeit herzustellen, wo wir die Beratungsdiskussion geführt haben, wo wir bei diversen Problemen auch leicht unterschiedliche Reaktionsprofile gesehen haben oder bei den Antiasthmatica die Frage, wie viel vom Wirkstoff aufgenommen wird. Also das will ich damit nur zum Ausdruck bringen.

Das sind alles sehr ernstzunehmende Hinweise, die hier gegeben worden sind. Es ist aber aus meiner Sicht relativ nah an vielen anderen Diskussionen, die wir geführt haben, und es ist dankenswerterweise darauf hingewiesen worden, dass der Bereich der biologischen

Arzneimittel zunehmend die Versorgung prägt und wir deshalb zwingend, um auch in Zukunft eine Versorgungssicherheit einfach aus monetären Gesichtspunkten aufrechterhalten zu können, darüber nachdenken müssen, wenn die Produkte generisch werden, wie wir bestimmte Effekte plangemäß erzielen können. Das nur zur Motivation für uns.

Wir machen das nicht, um Sie zu ärgern. Wir machen das nicht, um die Patientenversorgung zu beeinträchtigen, sondern wenn ich mir den Anteil der Biologika auf die Verordnungen anschau, wenn ich mir anschau, dass wenn die Produkte generisch werden, dann die in der Vergangenheit immer eintretenden Einspareffekte nicht mehr in diesem Umfang, weil hier Produktionskosten wesentlich höher sind, automatisch eintreten werden, weil man nicht mehr auf die sehr niedrigen Preise kommt, dann sehe ich hier schon ein legitimes Anliegen, das der Gesetzgeber verfolgt; denn wir sind vom Gesetzgeber beauftragt. Wir laufen nicht durch die Gegend und sagen, wir wollen jetzt irgendetwas machen. Das will ich an der Stelle nur sagen. Jetzt haben wir noch hinreichend Provokationen ausgeübt. – Auf der Rednerliste stehen noch Frau Müller vom VZA, dann Herr Müller von Hexal, Herr Ammer, Herr Rath, Frau ten Haaf, Herr Kirsch und dann Schluss der Rednerliste. Frau Müller, bitte. – Frau Müller ist weg. Dann Herr Müller, Hexal, bitte.

Herr Dr. Müller (Hexal): Ein Punkt, der aus meiner Sicht bis dato in die Diskussion noch nicht wirklich eingebracht wurde, ist die Übereinstimmung der Indikationsgebiete. Aus unserer Sicht kann eine Aut idem-Substitution eigentlich nur unter stringenter Beachtung der Zulassung erfolgen, sprich: das abgegebene Fertigarzneimittel muss mindestens für die Anwendungsgebiete zugelassen sein wie das verordnete Fertigarzneimittel. So ist es bis dato bereits in § 40a und 40b hinterlegt. Grund hierfür wäre auf der einen Seite, dass nicht nur die Arzneimittelzulassung für Biologika verletzt werden würde, sondern auch potenziell Patentrechte des Referenzpräparats, aber auch Aspekte der Arzneimittelsicherheit.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass dieses Zulassungsverfahren von Biosimilars nicht einer automatischen Extrapolation unterliegt. Es gibt immer eine wirtschaftliche Prüfung, eine wissenschaftliche Prüfung, Bewertung anhand eines Zulassungsdossiers, und das muss explizit für jede Indikation eingereicht werden. Als Beispiel wäre hier Rituximab zu nennen, das die Zulassung in der Hämatoonkologie hat und auf der anderen Seite auch bei einer schwer ausgeprägten rheumatoiden Arthritis mit einem anderen Mode of Action. Hier musste zusätzlich noch eine Phase-III-Studie durchgeführt werden.

Ein sehr wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte ist, glaube ich: Wenn eine Indikation fehlt, dann fehlen auch in der Fachinformation sicherheitsrelevante Aspekte, sowohl für den Apotheker als auch letztendlich für den Patienten, nämlich die Angaben bezüglich der Dosierung und der potenziellen Nebenwirkungen. Ist eine Indikation nicht erteilt, findet sich diese Information nicht, wie sie zum Beispiel beim Referenzpräparat hinterlegt ist. Das würde aus unserer Sicht zum einen potenziell den Nocebo-Effekt zusätzlich induzieren, mitunter auch zu Fehldosierungen, zur Verunsicherung der Patienten führen und somit letztendlich die Patientensicherheit negativ beeinflussen und unter Umständen haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb, wie gesagt, fordern wir, wenn eine Substitution erfolgt, dass auf jeden Fall die Übereinstimmung der Indikationsgebiete vorliegt, einfach aufgrund der gerade ausgeführten Punkte.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Müller. – Herr Ammer, bitte.

Herr Dr. Dr. Ammer (MEDICE): In der letzten Stunde haben wir viel über unterschiedliche Applikationsformen diskutiert. Sie haben, Herr Professor Hecken, auch den Vergleich zu den chemischen Strukturen und chemischen Substanzen gebracht. Was aber in der Diskussion noch nicht angesprochen worden ist, sind Biologicals. Wir haben möglicherweise oder sicher die gleiche Primärstruktur, aber die Unterschiede in der Tertiärstruktur, in den Epitopen, in der Glykosylierung sind überhaupt nicht adressiert worden. Jeder hier im Raum möge sich dann fragen, ob er multiple Switches von Biologicals an sich selber erleben möchte, ob ihm die Evidenzbasis gut genug ist oder ob er bezüglich der Immunogenität und der

Antikörperproduktion doch Bedenken hat, die Sie dann bei den chronisch kranken Patienten hier automatisch triggern werden.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Ammer. – Herr Rath, bitte, danach Frau ten Haaf, Herr Kirsch und Frau Frénoy. Dann ist endgültig Schluss. Ich nehme jetzt keine Wortmeldungen mehr an.

Herr Rath (AbbVie): Herr Ammer hat es gut ausgeführt. Die Prozesserfahrung bei jedem Hersteller eines Biologikums ist extrem hoch. Die Chargen werden sehr gut untersucht, dokumentiert. Es gibt auch viele Publikationen dazu, dass sich genau diese molekularen Unterschiede, die Herr Ammer gerade dargestellt hat, in einem Rahmen bewegen, der sehr gering ist. Man hörte eingangs das Argument, dass diese Unterschiede mit verschiedenen Biologika oder verschiedenen Biosimilar desselben Wirkstoffs vergleichbar wären, das ist eine These, die man so eigentlich nicht stehenlassen kann, weil das nicht untersucht ist.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Rath. – Frau ten Haaf, bitte.

Frau ten Haaf (Pharma Deutschland): Mein Kommentar im Chat hat sich nur darauf bezogen, dass Sie immer wieder „generisch“ erwähnt haben. Wir möchten hier um Klarstellung bitten. Es gibt hier „ähnlich“ und „nicht gleich“. Das ist bei Biologika in diesem Zusammenhang so. Sie werden nicht generisch, sie werden biosimilar oder bioidentisch.

Was ich noch erwähnen wollte, waren die Schulungen in den Apotheken. Viele Präparate haben in ihren Pharmakovigilanzdaten und Patientensicherheitsakten, dass die Schulung zwingend beim Arzt erfolgen soll. Ich möchte auch Herrn Said unterstützen. Es ist nicht so, dass die Kompetenz der Apotheker, unsere Ausbildung, das nicht hergeben würde, aber wir haben einfach a) die Kapazität nicht, und b) der Austausch muss durch die Ärzte verfolgt werden können. Das wollte ich hier noch einmal mit anregen.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Frau ten Haaf, vor allem für die sprachliche und rechtliche Klarstellung. Ich bedauere diese unscharfe Formulierung, bitte dann aber zu bedenken, dass Sie bei der Vereinfachung der Zulassungsverfahren für biosimilare Produkte etwas anders argumentieren. Da habe ich von den Pharmaverbänden und den Unternehmen gegenüber der EMA und der Europäischen Kommission eine Argumentation gehört, die nicht so wortscharf war und dazu geführt hat, dass man hier bestimmte Limitationen gelockert hat, die an das anknüpfen, was Sie gerade versucht haben, bei mir sprachlich zu korrigieren. Das möchte ich an dieser Stelle bitte ins Protokoll aufnehmen, damit wir die Veränderungen im Zulassungsprozedere hier im Blick behalten, damit Sie nicht meinen, ich würde keine Zeitung lesen. Das wäre ein falscher Eindruck, dem ich an dieser Stelle ausdrücklich entgegenwirken möchte, um die Reputation des G-BA nicht über Gebühr zu beschädigen. – Danke, Frau ten Haaf. – Herr Kirsch, bitte.

Herr Dr. Kirsch (Hexal): Wenn ich die letzte gute Stunde für mich rekapituliere, dann ist das Thema Multiswitch, Mehrfachswitches eines, das bei einer potenziellen Umsetzung vermeintlich die größten Probleme aufwirft, sowohl für die Apotheken mit Blick auf Pharmakovigilanzanforderungen als auch im therapeutischen Alltag mit Blick auf die gehörten Adhärenz- und Nocebo-Effekte.

Sie haben in Ihrem Statement zuvor den Gesetzesauftrag zitiert, Herr Professor Hecken. Ich möchte zu Protokoll geben, dass dieser multiple Biosimilar-zu-Biosimilar-Austausch gerade nicht durch das gesetzliche Mandat gedeckt ist. Ich habe noch eine schöne Quelle gefunden aus der Antwort der Bundesregierung auf die Stellungnahme des Bundesrates zum seinerzeitigen GSAV vom 15. März 2019 aus der Bundestagsdrucksache 19/8753. Dort liest man auf Seite 102: „Der Gesetzentwurf sieht keine automatische Austauschbarkeit von Biosimilars vor. Biosimilars können jedoch in vielen Fällen anstelle des Originalpräparates abgegeben oder angewendet werden.“ Sowohl die gesetzliche Formulierung als auch die Intention ist hier sehr klar. Wenn wir also – und das für das Protokoll – dem Thema multipler Switch in einer potenziellen Umsetzung begegnen wollen, kann man das sehr einfach, indem

wir an dieser Stelle beim gesetzlichen Mandat bleiben, weil dann der Biosimilar-zu-Biosimilar-Switch nicht abgedeckt wäre.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Herr Kirsch. – Hier sei der Hinweis gestattet, dass der Beschluss des G-BA, in welcher Form er auch ausfallen wird, zum einen einer rechtsaufsichtlichen Prüfung unterliegt – das ist Ihnen hinlänglich bekannt – und zum anderen am Ende des Tages sicherlich auch Gegenstand vielfältigster juristischer Auseinandersetzungen wird. Dann werden wir uns über den gesetzlichen Rahmen sicherlich noch vertieft austauschen können. – Frau Frénoy, bitte.

Frau Frénoy (MSD): Es wurde schon von einem Vorredner darauf hingewiesen, dass abgegebene biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel mindestens in den Anwendungsgebieten des verordneten Arzneimittels übereinstimmen müssen. Wir wollten gerne das Thema Kombinationstherapien ansprechen; denn gerade bei biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln sind solche Kombinationstherapien häufig vorgesehen. Eine klare Evidenz, transparente Dokumentation sind notwendig, um auch in diesen Fällen die Patientensicherheit sicherzustellen. Somit möchten wir ausführen, dass bei freien Kombinationstherapien Studiendaten für Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit wichtig sind und für die ärztliche Steuerung vorliegen sollten.

Herr Prof. Hecken (Vorsitzender): Danke schön, Frau Frénoy, für diesen Hinweis. – Ich schaue noch einmal zu den Bänken. Es gibt keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen zum einen für die umfänglichen Stellungnahmen – da haben wir wirklich sehr viel zu lesen gehabt und sehr viele wichtige Aspekte gesehen –, zum anderen dafür, dass Sie heute unsere Fragen beantwortet und Ihre wesentlichen Punkte noch einmal im Zeitraffer dargestellt haben. Wir werden das intern diskutieren und wägen und dann zu einer Entscheidung kommen, die im Zweifelsfall Gegenstand diverser gerichtlicher Auseinandersetzungen werden wird. Danke, dass Sie uns heute zur Verfügung standen und uns die wertvollen Argumente übermittelt haben. Damit schließe ich diese Anhörung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

Schluss der Anhörung: 11:25 Uhr

D. Anhang der Zusammenfassenden Dokumentation

Inhalt

Bekanntmachung des Beschlusses im Internet

1. Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens
- 1.1 Schriftliches Stellungnahmeverfahren
- 1.2 Mündliche Anhörung (Einladung)

Bekanntmachung

des Gemeinsamen Bundesausschusses über die
Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der
Arzneimittel-Richtlinie:

§ 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten
biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken

Vom 11. Juni 2025

Der Unterausschuss Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2025 beschlossen, ein Stellungnahmeverfahren zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) gemäß § 92 Absatz 3a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) einzuleiten.

Der Beschluss und die Tragenden Gründe können auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de eingesehen werden.

Stellungnahmen zu diesem Entwurf einschließlich Literatur sowie Literatur- bzw. Anlagenverzeichnis sind in elektronischer Form (z. B. per CD/DVD oder per E-Mail) als Word-Datei bzw. die Literatur als PDF-Dateien

bis zum 14. Juli 2025

zu richten an:

Gemeinsamer Bundesausschuss
Abteilung Arzneimittel
Gutenbergstraße 13
10587 Berlin

E-Mail: biosimilars@g-ba.de mit Betreffzeile: „Stellungnahmeverfahren AM-RL – Neufassung § 40c“

Der entsprechende Entwurf zur Änderung der AM-RL wird zu diesem Zweck mit der Bitte um Abgabe sachverständiger Stellungnahmen mit Schreiben vom 16. Juni 2025 an den Stellungnehmerkreis gemäß § 92 Absatz 3a SGB V versendet.

Berlin, den 11. Juni 2025

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Prof. Hecken



Gemeinsamer Bundesausschuss, Postfach 12 06 06, 10596 Berlin

An die
Stellungnahmeberechtigten
nach § 92 Absatz 3a SGB V

per E-Mail

**gemäß § 91 SGB V
Unterausschuss
Arzneimittel**

Besuchsadresse:
Gutenbergstr. 13
10587 Berlin

Ansprechpartner/in:
Abteilung Arzneimittel

Telefon:
030 275838210

Telefax:
030 275838205

E-Mail:
arzneimittel@g-ba.de

Internet:
www.g-ba.de

Unser Zeichen:
SaB/uh

Datum:
16. Juni 2025

Stellungnahmeverfahren über die Änderung der Arzneimittel Richtlinie (AM RL):
§ 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln
durch Apotheken

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Unterausschuss Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2025 beschlossen, ein Stellungnahmeverfahren zur Änderung der Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung einzuleiten. Die Arzneimittel-Richtlinie soll wie folgt geändert werden:

Änderung der Arzneimittel-Richtlinie

- § 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertig-
arzneimitteln durch Apotheken

Im Rahmen Ihres Stellungnahmerechts nach § 92 Absatz 3a SGB V erhalten Sie bis zum

14. Juli 2025

Gelegenheit zur Abgabe Ihrer Stellungnahme. Später bei uns eingegangene Stellungnahmen können nicht berücksichtigt werden.

Bitte begründen Sie Ihre Stellungnahme zum Richtlinienentwurf durch Literatur (z. B. relevante Studien). Die zitierte Literatur ist obligat im Volltext inklusive einem standardisierten und vollständigen Literatur- bzw. Anlagenverzeichnis der Stellungnahme beizufügen. Anbei erhalten Sie das Begleitblatt „Literaturverzeichnis“. Wir weisen darauf hin, dass nur Literatur, die im Volltext vorliegt, berücksichtigt werden kann.

Mit Abgabe einer Stellungnahme erklären Sie sich einverstanden, dass diese in den Tragenden Gründen bzw. in der Zusammenfassenden Dokumentation wiedergegeben werden kann. Diese Dokumente werden jeweils mit Abschluss der Beratungen im Gemeinsamen Bundesausschuss erstellt und in der Regel der Öffentlichkeit via Internet zugänglich gemacht.

Ihre Stellungnahme einschließlich Literatur sowie Literatur- bzw. Anlagenverzeichnis richten Sie bitte in elektronischer Form (z. B. per CD/DVD oder per E-Mail) als Word-Datei bzw. die Literatur als PDF-Datei an:

**Gemeinsamer Bundesausschuss
Unterausschuss Arzneimittel
Gutenbergstraße 13
10587 Berlin
E-Mail: biosimilars@g-ba.de**

Bitte formulieren Sie die Betreffzeile Ihrer E-Mail möglichst wie folgt „Stellungnahmeverfahren AM-RL – Neufassung § 40c“.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

i.A. Dr. Sandra Billig
Referentin

Anlagen

Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Einleitung
eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der
Arzneimittel-Richtlinie:

**§ 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten
biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken**

Vom 11. Juni 2025

Der Unterausschuss Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2025 die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) in der Fassung vom 18. Dezember 2008/22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März 2009), die zuletzt durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom T. Monat JJJJ (BAnz AT TT.MM.JJJJ BX) geändert worden ist, beschlossen:

- I. Die Überschrift „§ 40b Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken nach § 129 Absatz 1a Satz 5 und 6 SGB V“ wird ersetzt durch:

„§ 40b Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken nach § 129 Absatz 1a Satz 6 in Verbindung mit Satz 5 SGB V (parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln)“.

- II. Nach § 40b wird folgender § 40c eingefügt:

„§ 40c Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken nach § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V (Fertigarzneimittel)

- (1) Die Apotheken sind bei der Abgabe verordneter biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel an Versicherte zur Ersetzung durch ein preisgünstiges Arzneimittel verpflichtet. Dabei haben die Apotheken ein Arzneimittel abzugeben, das mit dem verordneten in Wirkstärke und Packungsgröße identisch ist und die gleiche oder eine austauschbare Darreichungsform gemäß § 40 Absatz 1 AM-RL i. V. m. § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V besitzt.

Das abzugebende Arzneimittel muss mindestens für die Applikationsarten des verordneten Arzneimittels sowie

Position A	Position B1 + B2
für ein gleiches Anwendungsgebiet	mindestens für die Anwendungsgebiete des verordneten Arzneimittels

zugelassen sein. Die Pflicht zur Ersetzung des verordneten Arzneimittels gilt nicht, soweit der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin die Ersetzung des Arzneimittels ausgeschlossen hat.

- (2) Die Ersetzung nach Absatz 1 ist vorrangig durch ein Arzneimittel vorzunehmen, für das eine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V mit Wirkung für die Krankenkasse besteht, soweit hierzu in Verträgen nach § 129 Absatz 5 SGB V nichts anderes vereinbart ist.

Besteht keine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V, hat die Apotheke die Ersetzung durch ein preisgünstiges Arzneimittel vorzunehmen.

Das Wahlrecht der Versicherten gemäß § 129 Absatz 1 Satz 6 SGB V gilt entsprechend.

- (3) Ein Austausch erfolgt nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 zwischen dem verordneten Fertigarzneimittel und einem weiteren biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel, wenn

- dieses ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilar) zu dem verordneten Referenzarzneimittel ist, wobei die Ersetzung des Biosimilars mit dem Referenzarzneimittel nicht ausgeschlossen ist

Position A + B1	Position B2
, oder	und bei mehrmaliger Ersetzung aus nicht-medizinischen Gründen erst Evidenz für die Unbedenklichkeit der mehrfachen Ersetzung vorliegen muss, oder

- dieses ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilar) ist, das mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel wie das Verordnete zugelassen ist

Position A + B1	Position B2
.	, und Evidenz vorliegt, die die Unbedenklichkeit der ein- oder mehrmaligen Ersetzung der Biosimilars untereinander belegt.

In Anlage VIIa zu dieser Richtlinie sind biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel als Referenzarzneimittel sowie hierzu im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilars) aufgeführt, sofern mindestens ein Biosimilar bzw. mehr als ein Originalarzneimittel am Markt verfügbar ist.

- (4)

Position A + B1	Position B2
Die gesetzlichen Regelungen zu Information und Beratung in Apotheken bei Abgabe von Arzneimitteln auch zu substitutionsbedingt relevanten Aspekten, unter anderem mit dem Ziel der Reduzierung eines möglichen Nocebo-Effektes sowie der Förderung der Therapieadhärenz, bleiben unberührt.	Die gesetzlichen Regelungen zu Information und Beratung in Apotheken nach § 20 der Apothekenbetriebsordnung bei Abgabe von Arzneimitteln auch zu substitutionsbedingt relevanten Aspekten, wie insbesondere der Handhabung der Applikation des neuen Arzneimittels, unter anderem mit dem Ziel der Reduzierung eines möglichen Nocebo-

	Effektes und möglicher Anwendungsfehler sowie der Förderung der Therapieadhärenz, bleiben unberührt. Wenn ein anderes als das verordnete Präparat abgegeben wurde, hat die Apotheke den verordnenden Arzt oder die verordnende Ärztin über das konkret ausgehändigte Präparat (Handelsname) zu informieren, soweit der Patient oder die Patientin in die Weitergabe der personenbezogenen Patientendaten an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin ausdrücklich einwilligt.
--	--

- (5) Die Apotheke kann bei Vorliegen sonstiger Bedenken nach § 17 Absatz 5 der Apothekenbetriebsordnung auch unter Würdigung patientenindividueller Aspekte von einer Ersetzung absehen.“
- III. In der Anlage VIIa zum Abschnitt M der AM-RL „Biotechnologisch hergestellte biologische Referenzarzneimittel und im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel nach § 129 Absatz 1a Satz 3, 5 und 6 SGB V“ wird in Satz 3 vor der Tabelle nach der Angabe „beziehungsweise gemäß § 40b Absatz 1 Satz 2“ die Angabe „und § 40c Absatz 1 Satz 2“ eingefügt.
- IV. Die Änderungen der Richtlinie treten am [einsetzen: das jeweils frühere Datum des ersten oder fünfzehnten Tages des auf die Veröffentlichung des Beschlusses im Bundesanzeiger folgenden Kalendermonats, frühestens vier Wochen nach Ablauf des Tages seiner Veröffentlichung im Bundesanzeiger] in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 11. Juni 2025

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Prof. Hecken

Tragende Gründe

zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über
die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung
der Arzneimittel-Richtlinie:

§ 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten
biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken

Vom 11. Juni 2025

Inhalt

1.	Rechtsgrundlage.....	2
2.	Eckpunkte der Entscheidung.....	2
2.1	Zu Absatz 1	2
2.2	Zu Absatz 2	7
2.3	Zu Absatz 3	7
2.4	Zu Absatz 4	9
2.5	Zu Absatz 5	10
3.	Verfahrensablauf	11

1. Rechtsgrundlage

Nach dem am 15. August 2019 in Kraft getretenen Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) gibt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) gemäß § 129 Absatz 1a Satz 3 SGB V in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 für die ärztliche Verordnung Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit. In einem weiteren Schritt gibt der G-BA gemäß § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 ebenfalls Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken.

Mit dem am 12. November 2022 in Kraft getretenen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) wurde der Regelungsauftrag an den G-BA gemäß § 129 Absatz 1a Satz 5 SGB V durch Einfügen eines Satzes 6 konkretisiert. Demnach sollte der G-BA zunächst Hinweise zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben, danach auch für die weiteren biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel.

Zur Umsetzung des Regelungsauftrags erhält der G-BA nach § 129 Absatz 1a Satz 7 SGB V auf Verlangen Einsicht in die Zulassungsunterlagen bei der zuständigen Bundesoberbehörde.

2. Eckpunkte der Entscheidung

Zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags in § 129 Absatz 1a Sätze 5 und 6 SGB V, wonach der G-BA Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln durch im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel durch Apotheken geben soll, hat der G-BA mit Beschluss vom 15. Juni 2023 in einem ersten Schritt in Abschnitt M der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) § 40b eingefügt. Mit § 40b wurden die Vorgaben des § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und den Sätzen 2 bis 7 zur Ersetzung von biologischen Referenzarzneimitteln durch Apotheken gemäß § 129 Absatz 1 Satz 12 für die Gruppe der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel in Bezug auf parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung konkretisiert.

In einem weiteren Schritt wird mit dem vorliegenden Richtlinienentwurf in Abschnitt M der AM-RL § 40c eingefügt. Mit § 40c gibt der G-BA Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln in Bezug auf im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Fertigarzneimittel. Mit § 40c werden die Vorgaben zur Ersetzung durch ein im Wesentlichen gleiches Fertigarzneimittel durch Apotheken gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Sätze 2 bis 7 und Absatz 1a Satz 5 SGB V für die Gruppe der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel konkretisiert.

2.1 Zu Absatz 1

Die allgemeinen Vorgaben zur wirtschaftlichen Abgabe in Apotheken, insbesondere die Auswahl eines preisgünstigen Arzneimittels, gelten auch für biotechnologisch hergestellte biologische Fertigarzneimittel, es sei denn der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin hat die Ersetzung des Arzneimittels durch Apotheken ausgeschlossen.

Der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin kann insoweit auch in medizinisch begründeten Einzelfällen einer wirtschaftlichen Verordnungsweise unter Würdigung patientenindividueller und erkrankungsspezifischer Aspekte (z. B. Handhabung eines anderen Devices) entsprechen.

Grundsätzlich muss ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG [1] (Biosimilar) die gleiche Dosierung und den gleichen Verabreichungsweg wie das Referenzarzneimittel aufweisen. Unterschiede sind bei der Zulassung nur gestattet, wenn sie keinen negativen Einfluss auf die Sicherheit und keinerlei Einfluss auf die Wirksamkeit haben, z. B. Unterschiede in der Formulierung des Arzneimittels (Hilfsstoffe), der Darreichungsform (Pulver und Lösungsmittel anstatt einer fertigen Injektionslösung) oder des Verabreichungsweges (Spritze versus Pen). Unterschiedliche Applikationsorte (z. B. systemisch, topisch), unterschiedliche Applikationswege (z. B. oral, parenteral) und unterschiedliche Applikationshäufigkeiten (z. B. begründet durch die Freisetzungskinetik) sind unter Berücksichtigung der aktuell geltenden „Guideline on similar biological medicinal products“ [2] und den darin enthaltenen Grundsätzen zur Zulassung nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG zum jetzigen Zeitpunkt bei Referenzarzneimittel und Biosimilar nicht zu erwarten („The posology and route of administration of the biosimilar must be the same as those of the reference medicinal product“).

Sofern dennoch Zulassungen für unterschiedliche Applikationsarten vorliegen, ist bei einer Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel durch Apotheken darüber hinaus zu gewährleisten, dass das abzugebende Arzneimittel mindestens für die Applikationsarten des verordneten Arzneimittels zugelassen ist. Potentiell austauschbare Fertigarzneimittel nach Maßgabe des Absatzes 3 sind insoweit nicht für eine Ersetzung durch Apotheken vorgesehen, wenn diese nicht mindestens für die Applikationsarten des verordneten Arzneimittels zugelassen sind. Zur Prüfung dieser Voraussetzungen werden in Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) für Wirkstoffe, die biotechnologisch hergestellt werden und zu denen mehrere Originalarzneimittel oder mindestens ein Biosimilar verfügbar sind, die u. a. für eine Ersetzung in der Apotheke gemäß §§ 40b und 40c AM-RL relevanten Zusammenhänge der in Deutschland zugelassenen Referenzarzneimittel und im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG [1] (Biosimilars) abgebildet. Sofern für einen Wirkstoff Referenzarzneimittel oder Biosimilars mit abweichenden Applikationsarten zugelassen sind, werden die Arzneimittel in Anlage VIIa jeweils mit einem entsprechenden Klammerzusatz sowie in getrennten Zeilen aufgeführt. Die Angaben zur Anwendung des Arzneimittels und zu den Sicherheitsanforderungen der Fach- und Gebrauchsinformationen sind darüber hinaus grundsätzlich zu beachten.

Mit § 40c Absatz 1 wird darüber hinaus klargestellt, dass auch für die Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel durch Apotheken Voraussetzung ist, dass das abzugebende Arzneimittel mit dem verordneten in Wirkstärke und Packungsgröße identisch ist sowie die gleiche oder eine austauschbare Darreichungsform gemäß § 40 Absatz 1 AM-RL i. V. m. § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V besitzt. Die Möglichkeit für Apotheken bei Vorliegen sonstiger Bedenken von einer Ersetzung abzusehen bleibt unberührt.

1 Richtlinie 2001/83/EG (Zugriff am 20.5.25)

2 European Medicines Agency: Guideline on similar biological medicinal products, Rev 1, 2015 (Zugriff am 20.5.25)

Ein Biosimilar ist in der Regel für alle Indikationen des Referenzprodukts zugelassen, kann aber in Ausnahmefällen auch weniger Indikationen oder Anwendungsarten haben, z. B. wegen patentrechtlicher Einschränkungen, die in manchen EU-Ländern bestehen. Auch können bei den zugelassenen Anwendungsgebieten Indikationen fehlen, wenn beispielsweise die entsprechende Dosisstärke nicht verfügbar ist (z. B. pädiatrische Indikationen).

Position A	Position B1 + B2
Vor diesem Hintergrund muss das abzugebende biotechnologisch hergestellte biologische Fertigarzneimittel gemäß § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V mindestens für ein gleiches Anwendungsgebiet wie das verordnete Arzneimittel zugelassen sein. Eine Abweichung von der Regelung des § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V, dass mindestens ein gleiches Anwendungsgebiet für den Austausch erforderlich ist, ist vorliegend weder gesetzlich vorgesehen noch aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit geboten. Übereinstimmend dazu weist die EMA mit dem Netzwerk der „Heads of Medicines Agencies“ (HMA) in ihrem im April 2023 publizierten gemeinsamen „Statement on the scientific rationale supporting interchangeability of biosimilar medicines in the EU“ [3] darauf hin, dass für ein in der EU zugelassenes Biosimilar und sein Referenzarzneimittel grundsätzlich eine Austauschbarkeit gegeben ist. Auch Biosimilars, die auf das gleiche Referenzarzneimittel zugelassen sind, sind untereinander austauschbar. In den Q&A zu diesem Statement weist die EMA in Antwort auf die Frage 4 „Does the statement of interchangeability apply to biosimilars that do not have all the indications of the reference or another biosimilar medicine?“ [4] auf die wissenschaftlich basierte Austauschbarkeit der Biosimilars hin, obwohl sie nicht in allen Anwendungsgebieten des Referenzproduktes zugelassen sind. Ebenso gilt diese Austauschbarkeit, wenn	Da die jeweilige für die Arzneimittelverordnung ausschlaggebende Indikation der Apothekerin oder dem Apotheker anhand des vorliegenden Verordnungsblatts bzw. der elektronischen Verordnung nicht bekannt ist, muss aus grundsätzlichen Erwägungen der Arzneimitteltherapiesicherheit das abzugebende Arzneimittel mindestens für dieselben Anwendungsgebiete (Indikationsbereich) wie das verordnete Arzneimittel zugelassen sein. So empfehlen auch die EMA und HMA in ihrem gemeinsamen „Q&A on the Statement on the scientific rationale supporting interchangeability of biosimilar medicines in the EU“ nur dann eine Austauschbarkeit von Biosimilars mit ihrem Referenzarzneimittel oder von Biosimilars untereinander, wenn sie gemäß ihren Fachinformationen die gleichen Anwendungsbedingungen aufweisen [4]. Ein Abgleich der Fachinformationen und eine darauf basierende Bewertung der Ersetzung kann auf Apothekenebene jedoch nicht vollumfänglich gewährleistet werden, da der Apothekerin oder dem Apotheker die für die Verordnung ausschlaggebende Indikation nicht bekannt ist. Deshalb spricht die EMA in diesem Zusammenhang in der Antwort zu Frage 3 auch von einem automatischen Austausch, ohne die aktive therapeutische Entscheidung durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt: „The statement is meant to support Member States that want to allow for biosimilar prescribing, including any national decision on switching done by the prescriber and/or (automatic) substitution at pharmacy level without consulting the prescriber.“

3 European Medicines Agency: Statement on the scientific rationale supporting interchangeability of biosimilar medicines in the EU, Apr 2023 (Zugriff am 20.5.25)

4 European Medicines Agency: Q&A on the Statement on the scientific rationale supporting interchangeability of biosimilar medicines in the EU (Rev. 1), Apr 2023 (Zugriff am 20.5.25)

das Biosimilar bei mehr zugelassenen Anwendungsgebieten eingesetzt werden kann als das Referenzprodukt. Somit besteht auf europäischer Ebene der wissenschaftliche Kerngedanke, dass in der EU zugelassene Biosimilars sowohl mit ihrem Referenzarzneimittel als auch untereinander unter dem Aspekt der Arzneimitteltherapiesicherheit ohne weitere Bedenken austauschbar sind, solange sie analog den Angaben in ihren Fachinformationen angewendet werden.

Das Statement der EMA spiegelt damit auch die Prozesse im arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren wider, nach denen ausdrücklich die Möglichkeit besteht, die Biosimilar-Zulassung zunächst nur für patentfreie Anwendungsgebiete zu beantragen und nachträglich um weitere Anwendungsgebiete des Referenzarzneimittels zu erweitern, wenn der (Verwendungs-)Patentschutz ausläuft. Eine solche nachträgliche Erweiterung um ein zusätzliches Anwendungsgebiet wird gemäß Verordnung (EU) Nr. 1234/2008 [5] als geringfügige Änderung des Typs IB eingestuft. Diese Klassifizierung erfolgt nach Buchstabe C.I.2a der „Leitlinien zu den verschiedenen Kategorien von Änderungen“ [6] in Fällen, in denen das Referenzarzneimittel eine zusätzliche Indikation erhält und das Biosimilar diese zusätzliche Indikation ebenfalls erhalten soll, sofern dazu keine zusätzlichen Daten erforderlich sind.

Zudem ist die Beschränkung einer Ersetzung auf mindestens dieselben Anwendungsgebiete durch die Unterschiede in den Zulassungsvoraussetzungen nach der Richtlinie 2001/83/EG [1] gerechtfertigt. Im Gegensatz zur Zulassung von Generika (Artikel 10), bei denen lediglich auf die stofflichen und pharmazeutischen Eigenschaften des Wirkstoffs abgestellt wird, werden die Zulassungsvoraussetzungen biologischer Arzneimittel, bei denen sich insbesondere Ausgangsstoffe und/oder Herstellungsprozesse des Zweit-arzneimittels von dem des Referenzarzneimittels unterscheiden, nach Artikel 10 Absatz 4 um ausgeprägte Vorlagepflichten eigener Unterlagen des antragstellenden Unternehmers erweitert.

In Anhang I Teil II Ziffer 4 der Richtlinie 2001/83/EG [1] werden die zusätzlichen Angaben im Zusammenhang einer Biosimilar-Zulassung weiter konkretisiert und das Erfordernis der Vorlage weiterer toxikologischer, präklinischer und klinischer Daten entsprechend den einschlägigen wissenschaftlichen Leitlinien bezogen auf den Einzelfall statuiert. Dabei hat die zuständige Behörde im Einzelfall unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale jedes einzelnen Arzneimittels festzulegen, welche zusätzlichen Studien vorzulegen sind. Anhang I Teil II Ziffer 4 Absatz 3 Satz 2 führt dazu aus: *„Hat das zugelassene Originalarzneimittel mehr als eine Indikation, so sind Wirksamkeit und Unbedenklichkeit des diesem angeblich gleichen Arzneimittels zu begründen oder, falls erforderlich, für jede der behaupteten Indikationen einzeln nachzuweisen.“*

Ergänzt werden die Vorschriften mit den von der EMA herausgegebenen „Biosimilar Guidelines“, in denen die deutlich höheren Anforderungen der Zulassung für die Gruppe der biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel aufgegriffen und fallgruppenspezifisch konkretisiert werden. So statuiert z. B. die „Guideline on similar biological medicinal products“ [2] unter

5 Verordnung (EU) Nr. 1234/2008 (Zugriff am 20.5.25)

6 Leitlinien zu den verschiedenen Kategorien von Änderungen (2013/C 223/01): [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0802\(04\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0802(04))

Ausweislich der Hinweise der EMA [7] in „Procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products applications“, Frage 2.9 „How can I update the product information of my similar biological medicinal product after expiry of the patent of the reference medicinal product?“ handelt es sich bei der Angleichung der zugelassenen Anwendungsgebiete des Biosimilars an die zugelassenen Anwendungsgebiete des Referenzarzneimittels um eine geringfügige Änderung des Typs IB nach Verordnung (EU) Nr. 1234/2008 [5]. Es müssen keine zusätzlichen Daten vorgelegt werden, weil die Vergleichbarkeitsprüfung des Biosimilars mit dem Referenzarzneimittel gemäß Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG [1] auf der Grundlage ergänzender Daten bereits durchgeführt worden ist. Verfahrensmäßig hat die zuständige Behörde nach Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1234/2008 [5] die Befugnis innerhalb von 30 Tagen nach Bestätigung des Erhalts einer gültigen Mitteilung einen negativen Bescheid zu übermitteln, wofür es jedoch in dem Fall der Hinzufügung eines neuen Anwendungsgebiets des Referenzarzneimittels zum bereits zugelassenen Biosimilar keinen Anlass gibt. Im Verfahren ist somit regelhaft von einer Genehmigung der Änderung auszugehen. Dies bestätigt auch die Entscheidungspraxis, in der in keinem Fall eine negative Entscheidung der Zulassungsbehörde über eine Angleichung der Anwendungsgebiete erfolgt ist. Das Verfahren zur Erweiterung der Anwendungsgebiete entspricht somit arzneimittelrechtlich dem auch für Generika einschlägigen Verfahren. Daher ist es angemessen, in der Folge auch für Biosimilars die gesetzliche Regelung des § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V anzuwenden.	Ziffer 3.1., Spiegelstrich 11: <i>„If biosimilarity has been demonstrated in one indication, extrapolation to other indications of the reference product could be acceptable with appropriate scientific justification.“</i> Die „Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues“ [8] konkretisiert zudem unter Ziffer 6: <i>„Additional data are required in certain situations, such as</i> <i>1. the active substance of the reference product interacts with several receptors that may have a different impact in the tested and non-tested therapeutic indications</i> <i>2. the active substance itself has more than one active site and the sites may have a different impact in different therapeutic indications</i> <i>3. the studied therapeutic indication is not relevant for the others in terms of efficacy or safety, i.e. is not sensitive for differences in all relevant aspects of efficacy and safety.“</i> Im Zulassungsverfahren ist mit Blick auf die derzeit bestehenden Regelungen und Guidelines demnach nicht von einer bedingungslosen Genehmigung der Extrapolation auf Basis der vorgelegten Daten auszugehen. In der Folge ist es angemessen, wenn für Biosimilars die gesetzliche Regelung des § 129 Absatz 1 Satz 2 SGB V insoweit eingeschränkt wird, dass ein Austausch auf Apothekenebene nur für solche Arzneimittel ermöglicht wird, die mindestens für dieselben Anwendungsgebiete zugelassen sind; in diesem Fall liegt eine entsprechende Prüfung der Sicherheitsdaten durch die Zulassungsbehörde zugrunde.
---	---

7 European Medicines Agency: Procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products applications, 2025 (Zugriff am 20.5.25)

8 European Medicines Agency: Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues, Rev 1, 2014 (Zugriff am 20.5.25)

2.2 Zu Absatz 2

Arzneimittel, für die eine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V mit Wirkung für die jeweilige Krankenkasse der oder des Versicherten besteht, sollen abgegeben werden, soweit hierzu in Verträgen nach § 129 Absatz 5 SGB V nichts anderes vereinbart ist. Ein Vergleich der Arzneimittelkosten erübrigt sich in diesen Fällen, da die Wirtschaftlichkeit insofern über die Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V mit Wirkung für die Krankenkasse hergestellt wird.

Besteht keine Vereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V, soll ein preisgünstiges Arzneimittel abgegeben werden. Im Regelfall wird dies ein im Wesentlichen gleiches biotechnologisch hergestelltes biologisches Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilar) sein. Die Bestimmungen zur Auswahl eines preisgünstigen Arzneimittels regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemeinsam mit der für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker.

Es wird zudem klargestellt, dass die Möglichkeit für Versicherte gemäß § 129 Absatz 1 Satz 6 SGB V gegen Kostenerstattung auch ein anderes Arzneimittel abweichend zu den Absätzen 1 bis 3 zu erhalten, unberührt bleibt.

2.3 Zu Absatz 3

Nach § 40c Absatz 3 kann grundsätzlich eine Ersetzung durch ein biotechnologisch hergestelltes biologisches Fertigarzneimittel im Verhältnis eines Referenzarzneimittels zu seinen im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilars) in Apotheken erfolgen. Ebenso könnte die Ersetzung eines im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilar) durch ein Referenzarzneimittel erwogen werden, sofern dieses preisgünstiger ist.

Position A + B1	Position B2
	Der mehrfache Therapiewechsel zwischen einem Biosimilar und seinem Referenzarzneimittel bzw. dem Referenzarzneimittel und seinem Biosimilar ist bisher nicht gut untersucht. Da bei einer Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel durch Apotheken der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin nicht unmittelbar bei der Anwendung des Arzneimittels beteiligt ist und somit die ärztliche Kontrolle entfällt, ist vor einer mehrfachen Umstellung aus nicht-medizinischen Gründen Evidenz erforderlich, die die Unbedenklichkeit eines mehrfachen Therapiewechsels belegt.

Position A + B1	Position B2
Darüber hinaus kann eine Umstellung im Verhältnis biotechnologisch hergestellter biologischer Fertigarzneimittel untereinander ebenso erfolgen, sofern diese mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind. Sind verschiedene	Wie bereits in den Tragenden Gründen zum Beschluss zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens vom 6. Dezember 2022 zum Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken bei parenteralen Zubereitungen

biotechnologisch hergestellte Fertig-arzneimittel mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen, ist davon auszugehen, dass mit Blick auf die Anforderungen zur Zulassung eines Biosimilars nach Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG im Verhältnis zu einem Referenzarzneimittel durch die Inbezugnahme desselben Referenz-arzneimittels eine hinreichende Vergleichbarkeit auch der Biosimilars gegeben ist.	zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung dargelegt, ist der einfache oder mehrfache Therapiewechsel von Biosimilars desselben Referenzarzneimittel untereinander bisher nicht gut untersucht. Obwohl diese Position abschließend nicht im Richtlinien-text des § 40b AM-RL umgesetzt wurde, wird auch im vorliegenden Verfahren in Bezug auf den Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertig-arzneimitteln durch Apotheken erneut die Position vertreten, dass eine Möglichkeit zur Ersetzung erst berücksichtigt werden kann, wenn gute Evidenz vorliegt, die die Unbedenklichkeit des einfachen oder mehrfachen Therapie-wechsels von Biosimilars untereinander belegt. Dies wird insbesondere deshalb als erforderlich angesehen, da die Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertig-arzneimittel in Apotheken ohne die unmittelbare Beteiligung des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin erfolgen soll. Durch Therapiewechsel ohne Kenntnis des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin würde zudem die Aussagekraft von Registern, die bei Biosimilars üblicherweise Teil der geforderten Datenerhebung in Risk-Management-Plänen sind, geschwächt, da beobachtete Effekte nicht mehr eindeutig einem Arzneimittel zugeordnet werden können.
---	---

Die Ersetzung zwischen Original-/Referenzarzneimitteln untereinander ist grundsätzlich nicht Gegenstand der vorliegenden Regelung und wird durch die Ergänzung der AM-RL sowie die vorliegende Anlage VIIa nicht weiter konkretisiert.

Die Prüfung der Sachgerechtigkeit einer Ersetzung im Einzelfall bleibt hiervon unberührt.

Zur Prüfung der Voraussetzungen nach § 40c Absatz 3 werden in Anlage VIIa (Biologika und Biosimilars) für Wirkstoffe, die biotechnologisch hergestellt werden und zu denen mehrere Originalarzneimittel oder mindestens ein Biosimilar verfügbar sind, die u. a. für eine Ersetzung in der Apotheke gemäß §§ 40b und 40c AM-RL relevanten Zusammenhänge der in Deutschland zugelassenen Referenzarzneimittel und im Wesentlichen gleiche biotechnologisch hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG (Biosimilars) abgebildet. Es besteht somit eine Informationsgrundlage zu den regulatorischen Hintergründen. Die Zusammenstellung hat keinen abschließenden Charakter. Mit Eintreten von Biosimilars auf den Markt besteht für die Apotheken auch unabhängig von der Listung in Anlage VIIa die Möglichkeit einer Ersetzung unter Berücksichtigung der Vorgaben unter Absatz 1 bis 3. Die generellen Vorgaben zur Ersetzung biotechnologisch hergestellter biologischer Fertig-arzneimittel nach § 40c Absatz 1 bis 3 bleiben von den Angaben in der Anlage VIIa unberührt.

Auf Verlangen erhält der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 129 Absatz 1a Satz 7 SGB V Einsicht in die Zulassungsunterlagen bei der zuständigen Bundesoberbehörde. Das Nähere zum Austausch mit den zuständigen Bundesoberbehörden wurde mit Beschluss vom 17. Februar 2022 [9] im 4. Kapitel § 53c der Verfahrensordnung des G-BA (VerfO) geregelt.

2.4 Zu Absatz 4

Die Verpflichtung zur Beratung durch Apotheken bei Abgabe von Arzneimitteln besteht schon nach § 20 der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO). Gemäß § 20 ApBetrO muss die Beratung die notwendigen Informationen über die sachgerechte Anwendung des Arzneimittels umfassen und es ist durch Nachfrage festzustellen, inwieweit gegebenenfalls weiterer Informations- und Beratungsbedarf besteht.

Die Angaben zur Anwendung des Arzneimittels und zu den Sicherheitsanforderungen der Fach- und Gebrauchsinformationen sind grundsätzlich zu beachten.

Der Hinweis zur Beratung wurde ergänzend in die AM-RL übernommen, um deren grundsätzliche Bedeutung bei Biologika-Verordnungen zu verdeutlichen. Auch bei der Abgabe von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln sowie insbesondere bei deren Ersetzung durch ein biotechnologisch hergestelltes biologisches Fertigarzneimittel sind Information und Beratung ein wichtiger Teil der Therapie, um einerseits die Therapieadhärenz zu fördern sowie Verunsicherung, Anwendungsfehler oder subjektive Effekte wie einen möglichen Nocebo-Effekt zu reduzieren.

Position A + B1	Position B2
Diese Faktoren können durch adäquate Aufklärung über die Ersetzung durch ein Biologikum vermindert oder sogar vermieden werden und müssen nicht dazu führen, die Ersetzung zu unterlassen. Diese substitutionsbedingt relevanten Aspekte der Informations- und Beratungspflichten sollten daher bei der Abgabe in der Apotheke besondere Berücksichtigung finden. Die ausdrückliche Hervorhebung sensibilisiert die Apotheken für den Beratungsbedarf und ist zugleich Aufforderung diesem fachgerecht zu begegnen.	Als wirksame Maßnahme gegen den Nocebo-Effekt werden eine adäquate Aufklärung, Schulung und Beratung angesehen. Dies muss durch die ausgebende Apothekerin oder den ausgebenden Apotheker erfolgen. Mittels adäquater Information und Beratung in Apotheken nach § 20 der Apothekenbetriebsordnung zu substitutionsbedingt relevanten Aspekten, wie insbesondere zur Handhabung der Applikation des neuen Arzneimittels, sollen sowohl eine Verunsicherung der Patienten und Patientinnen als auch Anwendungsfehler vermieden sowie die Therapieadhärenz gefördert werden.

Soweit bei einzelnen Patientinnen oder Patienten dennoch eine Gefährdung des Therapieerfolgs, insbesondere unter Berücksichtigung von Aspekten der Arzneimitteltherapiesicherheit, nicht vermieden werden kann, wird auf die Ausnahmeregelung nach Absatz 5 verwiesen.

9 G-BA, Ergänzung eines Titels im 4. Kapitel – Austausch von Biosimilars, Beschluss vom 17. Februar 2022: <https://www.g-ba.de/beschluesse/5288/>

Position A +B1	Position B2
	Die Biosimilars der im Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimittel stehen von Seiten der Zulassungsbehörde bezüglich der Pharmakovigilanz unter zusätzlicher Überwachung. Um hier die Rückmeldung möglicher Nebenwirkungen dem entsprechenden Präparat zuordnen zu können, müssen die Apotheken nach einem Austausch gewährleisten, dass die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt über das ausgegebene Präparat (Handelsname) informiert wird. Dies ermöglicht es der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt zudem, an entsprechende Register zu melden. Die Weitergabe dieser patientenbezogenen Daten an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin durch die Apotheke kann nur erfolgen, wenn der Patient oder die Patientin ausdrücklich in diese eingewilligt hat.

2.5 Zu Absatz 5

Nach § 17 Absatz 5 ApBetrO kann bei Vorliegen sonstiger Bedenken unter Berücksichtigung der konkreten Patientensituation ein Absehen von einer Ersetzung eines biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittels durch die Apotheke gerechtfertigt sein. Für die Apotheke können sich bestimmte patientenindividuelle Aspekte als relevant darstellen, die für den Arzt oder der Ärztin in Unkenntnis des konkreten, verwendeten biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimittels noch nicht berücksichtigt werden konnten. Grundsätzlich können bei entsprechender Kenntnis auch in der Vergangenheit aufgetretene Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Allergien der oder des Versicherten von der Apotheke Berücksichtigung finden.

Soweit trotz erfolgter Aufklärung, Schulung und Beratung durch die Apotheke eine patientenindividuelle Gefährdung des Therapieerfolgs durch Nicht-Adhärenz oder Anwendungsfehler nicht vermieden werden kann, kann ein Absehen von einer Ersetzung durch die Apotheke ebenso gerechtfertigt sein wie bei patientenindividuell relevanten Abweichungen der Arzneimittel hinsichtlich der Injektionsvolumina (z. B. Schmerzen bei größeren Volumina), der Handhabung (z. B. eingeschränkte Feinmotorik) und der Packungsausstattung (z. B. vorherige Rekonstitution der Injektionslösung).

3. **Verfahrensablauf**

Über die Änderung der Arzneimittel-Richtlinie wurde in einer Arbeitsgruppe beraten, die sich aus den von den Spitzenorganisationen der Leistungserbringer benannten Mitgliedern, den vom GKV-Spitzenverband benannten Mitgliedern sowie den Vertretern/Vertreterinnen der Patientenorganisationen zusammensetzt. Diese Arbeitsgruppe hat in ihren Sitzungen über die Änderung von Abschnitt M der Arzneimittel-Richtlinie beraten.

In der Sitzung am 11. Juni 2025 hat der Unterausschuss Arzneimittel die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie abschließend beraten und den Beschlussentwurf zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens konsentiert.

Der Unterausschuss hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2025 nach 1. Kapitel § 10 Absatz 1 Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens einstimmig beschlossen.

Zeitlicher Beratungsverlauf:

Sitzung	Datum	Beratungsgegenstand
AG Nutzenbewertung	17. Februar 2025 17. März 2025 14. April 2025	Beratung über die Änderung der AM-RL
Unterausschuss Arzneimittel	11. Juni 2025	Beratung, Konsentierung und Beschlussfassung zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der AM-RL

Zum Zeitpunkt der Einleitung des Stellungnahmeverfahrens stellen die vorliegenden Tragenden Gründe den aktuellen Stand der Zusammenfassenden Dokumentation dar, welche den stellungnahmeberechtigten Organisationen zur Verfügung zu stellen sind (1. Kapitel § 10 Abs. 2 VerfO).

Als Frist zur Stellungnahme ist ein Zeitraum von 4 Wochen vorgesehen.

Eine Stellungnahme zur Richtlinienänderung ist durch Literatur (z. B. relevante Studien) zu begründen. Die zitierte Literatur ist obligat im Volltext inklusive einem standardisierten und vollständigen Literatur- bzw. Anlagenverzeichnis der Stellungnahme beizufügen. Nur Literatur, die im Volltext beigelegt ist, kann berücksichtigt werden.

Mit Abgabe einer Stellungnahme erklärt sich der Stellungnehmer einverstanden, dass diese in den Tragenden Gründen bzw. in der Zusammenfassenden Dokumentation wiedergegeben werden kann. Diese Dokumente werden jeweils mit Abschluss der Beratungen im Gemeinsamen Bundesausschuss erstellt und in der Regel der Öffentlichkeit via Internet zugänglich gemacht.

Gemäß § 92 Absatz 3a SGB V ist den Sachverständigen der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis sowie den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer, den betroffenen pharmazeutischen Unternehmern, den Berufsvertretungen der Apotheker und den maßgeblichen Dachverbänden der Ärztesellschaften der besonderen Therapierichtungen auf Bundesebene Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Der maßgeblichen Spitzenorganisation der Medizinprodukte-Hersteller wird beschränkt auf Richtlinienänderungen bezogen auf sonstige in die Arzneimittelversorgung einbezogene Leistungen nach § 31 SGB V Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Folgende Organisationen werden angeschrieben:

Organisation	Straße	Ort
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI)	Friedrichstr. 148	10117 Berlin
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (vfa)	Hausvogteiplatz 13	10117 Berlin
Bundesverband der Arzneimittel-Importeure e. V. (BAI)	EurimPark 8	83416 Saaldorf-Surheim
Pharma Deutschland e. V.	Friedrichstr. 134	10117 Berlin
Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland e. V. (BIO Deutschland e. V.)	Am Weidendamm 1a	10117 Berlin
Die Arzneimittel-Importeure e. V.	Im Holzhau 8	66663 Merzig
Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed)	Reinhardtstraße 29b	10117 Berlin
Pro Generika e. V.	Unter den Linden 32 - 34	10117 Berlin
Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft (AkdÄ)	Herbert-Lewin-Platz 1	10623 Berlin
Arzneimittelkommission der Deutschen Zahnärzteschaft (AK-Z) c/o Bundeszahnärztekammer	Chausseestr. 13	10115 Berlin
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA)	Heidestr. 7	10557 Berlin
Deutscher Zentralverein Homöopathischer Ärzte e. V.	Axel-Springer-Str. 54b	10117 Berlin
Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte e. V.	Herzog-Heinrich-Str. 18	80336 München
Gesellschaft für Phytotherapie e. V.	Postfach 10 08 88	18055 Rostock

Die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens wird auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 11. Juni 2025

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Prof. Hecken

Erläuterungen zur Erstellung von Literaturlisten als Anlage Ihrer Stellungnahme

Bitte verwenden Sie zur Auflistung der zitierten Literatur die beigegefügte Tabellen-Vorlage „Literaturverzeichnis“.

Für jede Literaturstelle sind immer 3 Felder (Zeilen) vorgegeben.
Bitte tragen Sie Autoren, Titel und Quellenangabe in die dafür vorgesehenen Zeilen entsprechend des u.a. Musters ein.

<i>Muster</i>	Nr.	Feldbezeichnung	Text
	1.	AU:	(Autoren, Körperschaft, Herausgeber: getrennt durch Semikolon)
		TI:	(Titel)
		SO:	(Quelle: Zeitschrift, Internetadresse, Ort/Verlag/Jahr)

Bitte verwenden Sie diese Tabellenstruktur unverändert inklusive der vorgegebenen Feldbezeichnungen.

Die korrekte Eingabe für unterschiedliche Literaturtypen finden Sie im folgenden Beispiel:

Literaturliste [Institution/Firma] Niereninsuffizienz

	Nr.	Feldbezeichnung	Text
<i>Beispiel für Zeitschriften-artikel</i>	1	AU:	National Guideline Clearinghouse; National Kidney Foundation
		TI:	Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure
		SO:	Am J Kidney Dis / 35/6 Suppl 2 (S1-140) /2000/
<i>Beispiel für Buchkapitel</i>	2	AU:	Druml W
		TI:	Ernährung bei Krankheiten der Niere. In: Stein J, Jauch KW (Ed) . Praxishandbuch klinische Ernährung und Infusionstherapie
		SO:	Berlin: Springer. 2003. S. 521-38
<i>Beispiel für Buch</i>	3	AU:	Stein J; Jauch KW (Eds)
		TI:	Praxishandbuch klinische Ernährung und Infusionstherapie
		SO:	Berlin: Springer. 2003
<i>Beispiel für Internetdoku ment</i>	4	AU:	National Kidney Foundation
		TI:	Adult guidelines. Maintenance Dialysis. Nutritional Counseling and Follow-Up
		SO:	http://www.kidney.org/professionals/doqi/doqi/nut_a19.html
<i>Beispiel für HTA-Doku- ment</i>	5	AU:	Cummins C; Marshall T; Burls A
		TI:	Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) feeding in the enteral nutrition of dysphagic stroke patients
		SO:	Birmingham: WMHTAC.2000

Stellungnahmeverfahren zum Thema AM-RL - § 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken

Literaturliste [Hier Institution / Firma eingeben] Indikation [Hier zutreffende Indikation eingeben]

Nr.	Feldbezeichnung	Text
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	
	AU:	
	TI:	
	SO:	



Gemeinsamer Bundesausschuss, Postfach 12 06 06, 10596 Berlin

Stellungnahmeberechtigte
nach § 91 Absatz 9 Satz 1 SGB V

vorab per E-Mail

**gemäß § 91 SGB V
Unterausschuss
Arzneimittel**

Besuchsadresse:
Gutenbergstr. 13
10587 Berlin

Ansprechpartner/in:
Abteilung Arzneimittel

Telefon:
030 275838210

Telefax:
030 275838205

E-Mail:
arzneimittel@g-ba.de

Internet:
www.g-ba.de

Unser Zeichen:
SaB/uh

Datum:
10. Oktober 2025

Sachverständigen-Anhörung gemäß § 91 Absatz 9 Satz 1 SGB V zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie: § 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach § 91 Absatz 9 Satz 1 SGB V i. V. m. 1. Kapitel § 12 Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses ist vor einer Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie jedem, der berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses Stellung zu nehmen und eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu geben. Der Vorsitzende des zuständigen Unterausschusses Arzneimittel hat demzufolge bezüglich der

Änderung der Arzneimittel-Richtlinie

- § 40c (neu) – Austausch von biotechnologisch hergestellten biologischen Fertigarzneimitteln durch Apotheken

eine mündliche Anhörung anberaumt.

Die Anhörung findet statt:

**am 11. November 2025
um 10:00 Uhr**

**im Hause des Gemeinsamen Bundesausschusses
Gutenbergstraße 13
10587 Berlin**

als eMeeting

Zu dieser Anhörung laden wir Sie hiermit herzlich ein.

An der Anhörung können für jeden mündlich Stellungnahmeberechtigten höchstens jeweils zwei Sachverständige teilnehmen.

Bitte teilen Sie uns bis zum **24. Oktober 2025** per E-Mail (biosimilars@g-ba.de) mit, ob Sie an der mündlichen Anhörung teilnehmen werden und benennen Sie in dem Fall bitte auch die teilnehmenden Personen und deren E-Mail-Adressen.

Es steht Ihnen frei, auf Ihr mündliches Stellungnahmerecht zu verzichten.

Voraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Anhörung ist die Abgabe einer vollständig ausgefüllten Offenlegungserklärung. Bitte prüfen Sie deshalb, ob Sie alle Fragen beantwortet haben und unterschreiben Sie die Offenlegungserklärung mit Datumsangabe zweimalig im dafür vorgesehen Abschnitt auf Seite 3.

Bitte senden Sie Ihre Offenlegungserklärung als Scan oder Foto an arzneimittel@g-ba.de.

- Die mündliche Anhörung dient in erster Linie dazu, die sich aus der schriftlichen Stellungnahme ergebenden Fragen zu klären und neuere Erkenntnisse, die sich zeitlich nach Abschluss des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens ergeben haben, einzubringen.

PowerPoint-Präsentationen sind jedoch leider nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass die mündliche Anhörung in deutscher Sprache stattfindet. Ausführungen in anderen Sprachen werden nicht protokolliert.

Die Einwahldaten erhalten Sie rechtzeitig vor der Sitzung per E-Mail.

- Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen